



**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO**

RAFAEL DOS SANTOS REIS

**PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: A PRODUÇÃO DISCURSIVA
SOBRE PESSOAS SOROPOSITIVAS NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO**

Presidente Prudente-SP
2026



**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO**

RAFAEL DOS SANTOS REIS

**PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: A PRODUÇÃO DISCURSIVA
SOBRE PESSOAS SOROPOSITIVAS NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO**

Tese apresentada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade do Oeste Paulista, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Educação. Área de concentração: Educação.

Orientadora: Prof.^a Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos
Supervisora PDSE:
Profa. Dra. Cristina Pereira Vieira

Presidente Prudente - SP
2026

Catálogo Internacional de Publicação (CIP)

370 R375p	Reis, Rafael dos Santos. Para além dos muros do preconceito: a produção discursiva sobre pessoas soropositivas no processo de escolarização. / Rafael dos Santos Reis. – Presidente Prudente, 2026. 488 f.: il. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, Presidente Prudente, SP, 2026. Bibliografia. Orientadora: Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos 1. Currículo escolar. 2. Educação para a diversidade. 3. Políticas educacionais. I. Título.
--------------	---

Catálogo na fonte – Bibliotecária Renata Maria Moraes de Sá – CRB 8/10234

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

TÍTULO: “PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: A PRODUÇÃO DISCURSIVA SOBRE PESSOAS SOROPositivas NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO”

AUTOR/A: RAFAEL DOS SANTOS REIS

ORIENTADOR/A: Profa. Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos

Aprovado/a como parte das exigências para obtenção do título de DOUTOR/A em EDUCAÇÃO.

Área de Concentração EDUCAÇÃO, pela Comissão Examinadora:

Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos (orientadora) – Unoeste/Universidade do Oeste Paulista

Ademir Henrique Manfré – Unoeste/Universidade do Oeste Paulista

Denner Dias Barros – USP/ Universidade de São Paulo

Marcio Rodrigo Vale Caetano – Universidade Federal de Pelotas

Miriam Abramovay – Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais

Local e data da realização: Presidente Prudente, 13 de março de 2026.

Central de Assinaturas Eletrônicas

Sobre o documento

Assunto: Documento eletrônico
Status do documento: Concluído
Data de criação do documento: 16/03/2026 15:17
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
Número de assinaturas: 5
Solicitante: LUCIANA APARECIDA POLIDO BRAMBILLA (#6453032)

Signatários do documento

ADEMIR HENRIQUE MANFRE (PROFESSOR)

ademirmanfre@yahoo.com.br
Recebido em 16/03/2026 15:17
Assinado em 16/03/2026 15:19
Assinatura Interna UNOESTE
Usando endereço IP: 45.179.0.196
ID da assinatura: 6457430

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (COORDENADOR DE CURSO)

danielle@unoeste.br
Recebido em 16/03/2026 15:17
Assinado em 16/03/2026 15:18
Assinatura Interna UNOESTE
Usando endereço IP: 177.131.33.2
ID da assinatura: 6457429

DENNER DIAS BARROS (USUÁRIO EXTERNO)

denner@icmc.usp.br
Recebido em 16/03/2026 15:17
Assinado em 16/03/2026 17:31
Assinatura Interna UNOESTE
Usando endereço IP: 2804:14d:8084:a57fac3a:a75b:a3f0:fcdf
ID da assinatura: 6457431

MIRIAM ABRAMOVAY (SIGNATÁRIO EXTERNO)

mabramovay@gmail.com
Recebido em 16/03/2026 15:17
Assinado em 17/03/2026 13:37
Assinatura Interna UNOESTE
Usando endereço IP: 2804:14d:5ce0:5b57:284f:2d40:d1f0:ba8
ID da assinatura: 6457433

MÁRCIO RODRIGO VALE CAETANO (SIGNATÁRIO EXTERNO)

mrvcaetano@gmail.com
Recebido em 16/03/2026 15:17
Assinado em 16/03/2026 17:19
Assinatura Interna UNOESTE
Usando endereço IP: 200.17.160.168
ID da assinatura: 6457432

URL do documento: <https://www.unoeste.br/oa/ebd3e708>

Assinatura digital do documento: 40468501e304add8a2716e1316c7a37d1296c1ee648c7925488ddbbab6503a5a

UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista

Mantida pela EPEC - Empresa Prudentina de Educação e Cultura SA

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese a todas as pessoas que exercem a “arte de sorrir, mesmo quando o mundo insiste em dizer não”. Pessoas embebidas pelo espírito crítico, que se movimentam no esforço de escapar aos domínios de governo que dificultam a percepção da relação estrita entre humanidade e diferença.

Dedico, não obstante, às pessoas participantes da pesquisa que, ao aceitarem narrar suas experiências, permitiram que a pesquisa deixasse de ser apenas um exercício acadêmico para tornar-se um encontro. Pessoas soropositivas, estudantes, educadoras e educadores, sujeitos atravessados por discursos, silêncios, medos e resistências, que me ensinaram que toda vida é, uma forma de reinvenção.

Dedico, de modo especial, às pessoas soropositivas, não como objeto de análise, mas como presenças que desestabilizam verdades, interrogam normas e deslocam certezas. Suas narrativas me ensinaram que existir é sempre um gesto, um ato de resistência em um mundo que insiste em produzir exclusões.

Aos estudantes, que diariamente mostram que a escola é mais do que um espaço de transmissão de conteúdos: é um território de disputas, de desejos, de dores e de possibilidades. Que este trabalho possa, de algum modo, devolver-lhes a dignidade de serem reconhecidos/as como sujeitos de experiência, e não apenas como corpos a serem disciplinados ou normalizados.

À educação, em suas contradições, limites e potências. À escola, que tanto pode silenciar quanto possibilitar a emergência de outras formas de existir. Que esta pesquisa não seja lida como uma verdade acabada, mas como convite ao pensamento, à inquietação e à coragem de perguntar de outro modo.

Em diálogo com Foucault, aprendi que não se trata de buscar origens puras, ou verdades universais, mas de compreender como nos tornamos aquilo que somos e como ainda podemos nos tornar outros/as. Esta tese é, também, um exercício de cuidado de si, uma tentativa de pensar a própria formação, os próprios limites e as próprias implicações éticas no ato de pesquisar.

Dedico, por fim, a todas as pessoas que caminharam comigo neste percurso: algumas nomeadas, outras anônimas, mas todas constitutivas deste trabalho.

De modo especial, em memória a meu irmão e toda sua história.

Que estas páginas possam ser lidas não apenas como produção de conhecimento, mas como gesto de escuta, de respeito e de compromisso com vidas que insistem em existir, apesar das injustiças atravessadas pelo desentendimento das diferenças como marca humana que insiste em se posicionar.

AGRADECIMENTOS

Gratidão, primeiramente, a mim por não ter desistido, mesmo quando o cansaço, a dúvida e o medo insistiram em dizer que não seria possível. Por ter seguido, mesmo em silêncio e cansado, acreditando que esta pesquisa poderia, de algum modo, tocar outras vidas e também transformar a minha.

Sou grato a todas as pessoas que participaram direta e indiretamente deste percurso. Às pessoas participantes da pesquisa, que confiaram suas histórias e me ensinaram que nenhuma escrita nasce sem vida. Ao Programa de Pós-graduação, à orientadora, à supervisora, às professoras e aos professores, às funcionárias e aos funcionários, da secretaria às bibliotecárias, que sustentam, muitas vezes invisivelmente o cotidiano acadêmico.

Aos amigos e amigas que permaneceram presentes, ajudando a suportar as angústias políticas e os desabafos da realidade em que pesquisadores e a ciência brasileira passa pelas desvalorizações.

De forma muito especial, agradeço meu pai e minha mãe. Mesmo sem compreender este caminho, estiveram comigo do jeito que sabiam, manifestando amor pela linguagem materializada na comida preparada, no acordar cedo, nos olhares atentos e preocupados.

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (Brasil) CAPES – Código de Financiamento 001” e com financiamento pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, Edital nº 30/2023 - Seleção 2023/2024 – Código de Financiamento 88881.934075/2024-01”.

“E aqueles/as que foram vistos/as dançando foram julgados/as como loucos/as por aqueles/as que não podiam escutar a música.” (Friedrich Nietzsche)

RESUMO

Para além dos muros do preconceito: a produção discursiva sobre pessoas soropositivas no processo de escolarização

Esta tese insere-se no campo das Políticas Públicas em Educação, Processos Formativos e Diversidade, e problematiza o currículo escolar como espaço de produção e gestão das diferenças. A pesquisa investiga os regimes de verdade produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização, tomando como foco as percepções sobre HIV e AIDS no contexto do Ensino Médio do Estado de São Paulo. O objetivo geral consistiu em analisar as vivências escolares de pessoas soropositivas e as percepções sobre HIV e AIDS na formação escolar das diferenças. Para isso, adotou-se uma metodologia mista, articulando procedimentos qualitativos e quantitativos, organizada em três estudos interdependentes, correspondentes aos objetivos específicos da pesquisa e compreendidos como partes de um mesmo percurso analítico. A base teórica fundamenta-se no pensamento foucaultiano e pós-estrutural, por possibilitar a problematização dos regimes de verdade, das relações de poder e dos processos de subjetivação implicados na produção dos discursos sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas. O primeiro estudo, de natureza documental e bibliográfica, analisou produções científicas e não científicas sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas, bem como documentos e diretrizes relacionados ao Ensino Médio no Estado de São Paulo, por meio da arqueologia foucaultiana. Os resultados evidenciaram que a história do HIV e da AIDS foi construída sob regimes de verdade marcados pelo estigma e pelo preconceito e que, no contexto escolar paulista contemporâneo, observam-se limitações no aparecimento do tema nos documentos e materiais utilizados pelas/os estudantes. Uma vez percebida tal limitação, buscou-se compreender a percepção das/os estudantes do Ensino Médio sobre o tema. Assim, no segundo estudo, de abordagem quantitativa e qualitativa, investigaram-se as percepções de estudantes por meio de um questionário on-line. Os dados revelaram percepções superficiais, confusas e pouco fundamentadas sobre HIV, AIDS e vivências soropositivas, indicando lacunas importantes nos processos formativos escolares. Com ambos os conjuntos de dados, interessou saber a partir das percepções das pessoas soropositivas, o papel da escola, tanto na prevenção ao HIV, quanto na compreensão do viver soropositivo.

Nesse sentido, o terceiro estudo, de caráter qualitativo, analisou narrativas de quatro pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando-se a técnica de amostragem em bola de neve. As análises indicaram que a escola não abordou de forma sistemática as temáticas relacionadas ao HIV e à AIDS, favorecendo processos de estigmatização, silenciamento e sofrimento, produzindo experiências de exclusão e de morte simbólica. Os três estudos, articulados, evidenciam que o currículo escolar opera como um dispositivo central na produção, na manutenção e, potencialmente, na transformação dos regimes de verdade sobre o viver soropositivo. Conclui-se que a escola, ao orientar-se pelo cuidado de si como estética da existência, pode contribuir para o rompimento com o preconceito, para o acolhimento das diferenças e para a construção de uma cultura do cuidado, na qual as pessoas soropositivas sejam reconhecidas como sujeitos de direitos, de saberes e de existência, para além dos muros do preconceito.

Palavras-chave: currículo escolar; ensino médio; diversidade; políticas educacionais; educação e saúde.

ABSTRACT

Beyond the walls of prejudice: discursive productions about people living with hiv in the educational process

This thesis is situated within the field of Public Policies in Education, Formative Processes, and Diversity, and problematizes the school curriculum as a space for the production and management of differences. The research investigates the regimes of truth produced about seropositive bodies in the schooling process, focusing on perceptions of HIV and AIDS in the context of high school education in the State of São Paulo. The main objective was to analyze the school experiences of seropositive individuals and perceptions of HIV and AIDS in the educational formation of differences. To achieve this objective, a mixed-methods approach was adopted, combining qualitative and quantitative procedures, organized into three interdependent studies corresponding to the specific objectives of the research and understood as parts of a single analytical trajectory. The theoretical framework is grounded in Foucauldian and post-structural thought, as it enables the questioning of regimes of truth, power relations, and processes of subjectivation involved in the production of discourses about HIV, AIDS, and seropositive individuals. The first study, of a documentary and bibliographic nature, analyzed scientific and non-scientific publications on HIV, AIDS, and seropositive individuals, as well as documents and guidelines related to high school education in the State of São Paulo, using Foucauldian archaeology. The results showed that the history of HIV and AIDS has been constructed under regimes of truth marked by stigma and prejudice and that, in the contemporary school context of São Paulo, the theme appears in a limited way in the documents and materials used by students. Once this limitation was identified, the study sought to understand students' perceptions of the topic. Thus, the second study, combining quantitative and qualitative approaches, investigated students' perceptions through an online questionnaire. The data revealed superficial, confusing, and poorly grounded understandings of HIV, AIDS, and seropositive experiences, indicating significant gaps in school formative processes. Based on both data sets, the focus turned to understanding the role of the school through the perceptions of seropositive individuals, both in HIV prevention and in the comprehension of living with HIV. In this context, the third study, of a qualitative nature, analyzed narratives from four

seropositive individuals who had completed high school, obtained through semi-structured interviews using the snowball sampling technique. The analysis indicated that schools did not systematically address themes related to HIV and AIDS, thereby fostering processes of stigmatization, silencing, and suffering, leading to experiences of exclusion and symbolic death. Taken together, these interconnected studies demonstrate that the school curriculum functions as a central device in the production, maintenance, and potential transformation of regimes of truth about living with HIV. It is concluded that schools, when guided by the care of the self as an aesthetic of existence, can contribute to breaking down prejudice, welcoming differences, and building a culture of care, in which seropositive individuals are recognized as subjects of rights, knowledge, and existence, beyond the walls of prejudice.

Keywords: school curriculum; secondary education; diversity; educational policies; education and health.

LISTA DE SIGLAS

ABIA -	Associação Brasileira Interdisciplinar de aids
AIDS -	Acquired Immune Deficiency Syndrome
BNCC -	Base Nacional Comum Curricular
CEEJA -	Centro Educacional Estadual de Jovens e Adultos
DCNE -	Diretrizes Currículares Nacional da Educação
DST –	Doenças Sexualmente Transmissíveis
EFAPE -	Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
GGB -	Grupo Gay da Bahia
HIV -	Human Immunodeficiency Virus
HPV -	Human Papiloma Virus
HTPC -	Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo
IBGE -	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INEP -	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IST -	Infecção Sexualmente Transmissível
LDBEN -	Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC -	Ministério da Educação e Cultura
OMS -	Organização Mundial da Saúde
ONG -	Organização Não Governamental
PCNs -	Parâmetros Curriculares Nacional da Educação
PDS -	Partido Democrático Social
PEP -	Profilaxia pós exposição
PFL -	Partido de Frente Liberal
PMDB -	Partido Movimento Democrático Brasileiro
PrEP -	Profilaxia pré exposição
PT -	Partido dos Trabalhadores
PTB -	Partido Trabalhista Brasileiro
SEDUC -	Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
SIDA -	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SUS -	Sistema Único de Saúde
TCLE -	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNAIDS -	Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana

LISTA DE QUADROS

Estudo 1

Quadro 1 - Documentos versus número de pessoas com AIDS e escolaridade Brasil e São Paulo.....	208
Quadro 2 - Resultado dos materiais didáticos dos três anos do Ensino Médio....	210
Quadro 3 - Resultados do PSE no contexto do Estado de São Paulo	216
Quadro 4 - Atividades realizadas em 2024	216

Estudo 2

Quadro 5 - Síntese quali-quantitativa do perfil dos/as estudantes	239
Quadro 6 - Síntese quali-quantitativa da categoria conhecimento abrangente.....	240
Quadro 7 - Síntese quali-quantitativa da categoria educação escolar, inclusão e diversidade.....	241
Quadro 8 - Síntese quali-quantitativa da categoria autoconhecimento como ferramenta contra o HIV	242

Estudo 3

Quadro 9 - Material para criação das entrevistas semiestruturadas	280
Quadro 10 - Direcionador para questionar o roteiro das entrevistas semiestruturadas.....	285
Quadro 11- Pessoas participantes da pesquisa	294
Quadro 12- Estrutura dos eixos e análise	299

SUMÁRIO

1	PRIMEIRAS PALAVRAS	18
2	CARTOGRAFIA ESTRUTURAL DA TESE: CAVALETE FOUCAULTIANO	37
2.1	Foucault: nascimento e ressurreição. Sentado à esquerda dos pensamentos.....	38
2.2	Pensamento foucaultiano	41
2.3	Foucault na tessitura analítica da tese	51
2.4	Aproximação e correlação: entre arqueologia, HIV, AIDS e pessoas soropositivas	51
2.5	O fio e a dobra: por uma leitura pós-estrutural.....	64
2.6	Isso não é um manual: retalhos que costuram a colcha de possibilidades dos dados-falantes para o terceiro estudo da pesquisa .	69
3	PRIMEIRO ESTUDO: UMA POSSÍVEL HISTÓRIA SOROPOSITIVA PARA A EDUCAÇÃO	138
3.1	Considerações sobre o que pretendemos com o primeiro estudo	138
3.2	Procedimentos de escavação para o trabalho arqueológico	139
3.3	Uma propedêutica do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas	141
3.4	HIV, AIDS e pessoas soropositivas: uma história de vários nomes, faces e significações	145
3.5	Antes do aparecimento da AIDS e a década de 1980	146
3.6	Década de 1990	168
3.7	Década de 2000	178
3.8	Década de 2010 ao início de 2024	188
3.9	Dos achados algumas considerações para o presente	193
3.10	Artefatos do contexto educacional para o tempo presente.....	197
3.11	Considerações sobre os materiais que compõem a Produção dos dados	199
3.12	Resultados	208
3.13	Materiais didáticos do ensino médio do Estado de São Paulo.....	210
3.14	Discussão com os dados produzidos desta última parte do estudo.....	217
3.15	Considerações finais do primeiro estudo	222
4	SEGUNDO ESTUDO: SILÊNCIOS QUE MATAM, VOZES QUE TRANSFORMAM: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES BRASILEIROS ENTRE MITOS, ESTIGMA E EDUCAÇÃO SOBRE HIV/AIDS E PESSOAS SOROPOSITIVAS.....	229
4.1	Considerações sobre o que pretendemos com o segundo estudo	229
4.2	Processos metodológicos	233
4.3	Procedimentos de análise dos dados.....	238
4.4	Resultados	239
4.5	Eixo 1: Perfil dos/as estudantes.....	239
4.6	Eixo 2: Conhecimento abrangente; Eixo 3 Educação escolar, inclusão e diversidade; Eixo 4 Autoconhecimento como ferramenta contra o HIV.....	240
4.7	Discussão.....	242

4.8	Eixo 1: “Perfil dos/as estudantes”	243
4.9	Eixo 2: “Conhecimento abrangente”	248
4.10	Eixo 3: “Educação escolar, inclusão e diversidade”	253
4.11	Eixo 4: “Autoconhecimento como ferramenta contra o HIV”	260
4.12	Conclusões do segundo estudo: “precisamos falar sobre a SIDA nas escolas”	263
5	TERCEIRO ESTUDO: NARRATIVAS PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO.....	268
5.1	Primeiras palavras que introduzem ao terceiro estudo	268
5.2	Percursos metodológicos	271
5.3	Isso não é uma entrevista com um vampiro: somos soropositiva/o	273
5.4	Do roteiro-coletador a performance-pesquisador: a construção do roteiro e o preparo na atuação nas entrevistas semiestruturadas ...	276
5.5	Encontros como entrevistas semiestruturadas	277
5.6	Elementos para construir o roteiro	279
5.7	Roteiro com as perguntas.....	282
5.8	Um olhar de fora: ver o que não vimos como potência na produção dos dados.....	283
5.9	Performar: uma arte para atuar como pesquisador-entrevistador.....	285
5.10	Psicanálise como aparelho de amplificação da escuta na entrevista semiestruturada	287
5.11	De bola de neve a avalanche de falas a partir de vozes soropositivas..	291
5.12	Entre vozes e falas: quem são as pessoas soropositivas da pesquisa?	292
5.13	Das falas a escrita: uma produção de palavras-vivências	294
5.14	Procedimentos de análise dos eixos falantes.....	297
5.15	Eixo 1: Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?	300
5.16	Eixo 2: Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?...	317
5.17	Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo	342
5.18	Eixo 4: Quando a aula produz medo e não cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS na voz de pessoas soropositivas	363
5.19	Eixo 5: É só o início da sua vida, da sua nova vida: é o que eu sou e vai ser até o dia que eu morrer	387
5.20	Conclusões do terceiro estudo: narrativas soropositivas para o currículo das diferenças	408
6	ÚLTIMAS PALAVRAS	412
	REFERÊNCIAS	434
	ANEXOS -	467
	ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA.....	468
	ANEXO B - PLANO DE GESTÃO DE DADOS (PGD).....	473
	ANEXO C - SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DIRETORIA DE ENSINO	476
	APÊNDICES -.....	477
	APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	

2ª ESTUDO - FAMILIARES DOS ESTUDANTES.....	478
APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO 2ª ESTUDO –	
ESTUDANTES ENSINO MÉDIO	480
APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DOS DADOS DO 2º	
ESTUDO.....	482
APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO	
3º ESTUDO	487



¹As imagens presentes no decorrer do material, foram criadas e geradas por inteligência artificial operada pelo aplicativo Nova, utilizando uma perspectiva surrealista e com palavras-chave referente a cada seção que ela aparece.

1 PRIMEIRAS PALAVRAS

“Viver é o constante fazer-se, como um esboço incerto, incompleto, in-mundo. “Rafael Reis

Das múltiplas histórias que poderiam ser narradas sobre a humanidade, uma delas merece especial atenção por sua tática e por sua rarefação. Trata-se de uma história que se constitui no jogo paradoxal do ser e do não ser, em um movimento que afirma ao mesmo tempo em que nega a própria realidade de existir. A história à qual me refiro é a dos muros.

Em uma simples caminhada, é raro não se deparar com algum deles, nos mais variados modelos, formatos, cores e alturas. A depender da intenção que os sustenta, ora são erguidos para “proteger”, ora para “ornamentar”. Tudo parece operar em uma lógica binária, como o medo e a coragem, a força e a fraqueza. Contudo, mais do que simples delimitações físicas, os muros parecem acenar para uma forma específica de manifestação de poder que se faz presente sem a necessidade de enunciação explícita.

Ainda assim, os muros também sinalizam um certo medo: o que emerge da necessidade de assegurar algo considerado ameaçado ou perigoso, algo que poderia romper a permanência em um espaço que privilegia e garante determinados benefícios. Discursivamente, essa necessidade de proteção pode ser revestida por uma retórica do “bem”, legitimando a exclusão e a separação como práticas naturais ou necessárias.

Isso ocorreu, por exemplo, na Alemanha, em 1961, com a construção do Muro de Berlim, erguido para separar ideologias políticas. Também pode ser observado no caso da Índia e do Paquistão que, em 1974, construíram um muro destinado a separar disputas marcadas por discrepâncias religiosas entre muçulmanos e hindus. No mesmo ano, foi erguido o chamado muro verde, nome atribuído à barreira entre a Turquia e a Grécia, construída com o objetivo de “encerrar” os conflitos existentes entre ambas as regiões em torno da posse do mar Egeu.

Em 1977, foi construído o muro que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, em razão de divergências políticas e ideológicas. Em 1990, um muro foi erigido entre Marrocos e Espanha com a intenção de “barrar” a entrada de imigrantes, mais

especificamente de pessoas africanas, no território espanhol. Não obstante, outro muro foi construído em 1994 entre os Estados Unidos e o México, cuja permanência e fortalecimento se estendem até os dias atuais. Sua justificativa oficial é a construção de uma América supostamente menos criminosa, uma vez que os imigrantes são frequentemente interpretados a partir de uma perspectiva estereotipada por setores que se autodenominam donos do mundo.

Somam-se a esses exemplos o muro construído entre Israel e a Cisjordânia, em 2002, em decorrência de desacordos políticos, religiosos e econômicos, bem como o muro que passou a separar a República Dominicana e o Haiti, em 2022, motivado por questões políticas e econômicas (Almirante, 2022; BBC News, 2022; Pena, [2025]).

Os muros trazem como signo, a separação, a barreira, a delimitação entre o que pode estar dentro e o que deve permanecer fora. A humanidade, classificada a partir de ideias construídas por perspectivas diversas e nada inocentes, passa a operar de modo a transformar o “entre” em um problema a ser resolvido. Nesse movimento, os muros funcionam como dispositivos que impedem determinadas pessoas de acessar espaços aos quais outras já pertencem e cujos privilégios não estão dispostas a abdicar.

Além de barreiras físicas, os muros constituem mecanismos de violência ao inviabilizarem o direito à vida em qualquer território humano. Podem também assumir a forma de pedagogias que reforçam e perpetuam ideias e percepções desumanizadoras. Nesse sentido, a própria escola pode operar como um mecanismo de deportação (Reis, 2020), ao expulsar simbolicamente ou materialmente estudantes que não se encaixam nos moldes normativos previamente estabelecidos para excluí-los.

A realidade à qual nos referimos, embora frequentemente apresentada por meio de números que pouco dizem sobre as vidas que representam, é a de que, apenas em 2024, existiam cerca de 40,8 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. Nesse mesmo ano, registraram-se aproximadamente 1,3 milhão de novas infecções. No recorte etário entre 0 e 14 anos, havia cerca de 1,4 milhão de crianças e adolescentes vivendo com HIV. Além disso, estima-se que 5,3 milhões de pessoas desconheciam seu status sorológico.

No que se refere às mortes, 630 mil pessoas faleceram em 2024 em decorrência da AIDS (UNAIDS, 2024). Desde o início da pandemia de HIV/AIDS, na

década de 1980, mais de 42 milhões de pessoas morreram, configurando-se como a epidemia com o maior número de mortes em um único século. Já no século XXI, estima-se que cerca de 3,5 mil pessoas sejam infectadas pelo HIV diariamente em todo o mundo (UNAIDS, 2025).

Diante desse cenário, torna-se evidente a preocupação com o número de novas infecções. Ademais, a meta global de redução para menos de 250 mil mortes anuais permanece distante de ser alcançada. No Brasil, registrou-se um aumento de 4,5% nos casos de HIV em 2023, totalizando 46.495 novos diagnósticos. Ainda assim, as mortes decorrentes da AIDS apresentaram redução, alcançando a menor taxa da última década (Brasil, 2024a).

De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV e Aids (2024), com dados atualizados até junho de 2024, foram registrados 867 casos de infecção pelo HIV em adolescentes entre 15 e 19 anos, dos quais 610 ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 257 em indivíduos do sexo feminino (Brasil, 2024a).

A Organização Mundial da Saúde (Brasil, 2026a) classifica o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) como um agente que compromete o organismo humano ao atacar o sistema imunológico. Nesse sentido, a OMS destaca que, sem a realização do teste diagnóstico e o início oportuno do tratamento com antirretrovirais (TARV), o HIV pode evoluir para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), estágio avançado da infecção que pode levar à morte.

A transmissão do HIV ocorre principalmente por meio do contato com fluidos corporais, como sangue, sêmen e leite materno. As formas mais comuns de infecção incluem relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de agulhas contaminadas e a transmissão vertical, da mãe para o filho, durante a gestação, no parto ou a amamentação (Manual MSD).

O HIV atua destruindo os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Essa destruição compromete o sistema imunológico, tornando o corpo vulnerável a doenças oportunistas, como a tuberculose e determinados tipos de câncer, que podem ser fatais (Manual MSD, [2020?]).

Os muros a que nos referimos são amplos em seu sentido: podem ser aqueles que cercam fisicamente a escola, assim como os que limitam as percepções sobre o que é o HIV, a AIDS e, sobretudo, sobre as pessoas que vivem HIV.

Ao longo desta pesquisa, adotaremos a expressão pessoas soropositivas para nos referirmos às pessoas que vivem com HIV, por compreendermos que a linguagem possui potência política e simbólica na desconstrução de estereótipos e estigmatizações. Nesse sentido, o termo soropositiva/o é mobilizado como uma marca positiva e afirmativa, em consonância com as recomendações do UNAIDS (2017).

O HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas chegaram até mim por meio de relações com conhecidos e amigos. Ouvir essas pessoas e acompanhar as situações que vivenciaram e que, em muitos casos, ainda vivenciam possibilitou-me desenvolver um olhar mais atento e sensível para essas questões. Todavia, naquele momento, ainda não se configurava como uma provocação para a realização de uma pesquisa.

Ao longo do tempo, em especial durante a realização da pesquisa no mestrado (2018–2020), intitulada “Pessoas de sexualidades e identidades de gênero desviantes no CEEJA: um olhar para a escola de ensino regular frente às experiências de homofobias”, ocorreu uma primeira provocação relacionada as pessoas soropositivas. Nessa investigação, observamos que pessoas que não se enquadravam na heteronormatividade frequentemente abandonavam a escola de ensino regular e, na tentativa de dar continuidade à escolarização, ingressavam em outra instituição de ensino, o CEEJA – Centro Educacional Estadual de Jovens e Adultos.

Os resultados evidenciaram que um dos principais fatores que levavam à saída da escola regular estava relacionado ao fato de essas pessoas serem gays, lésbicas ou trans. Nesse contexto, o CEEJA configurava-se como uma possibilidade para a conclusão do Ensino Médio. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas com três pessoas: uma que se autodenominava gay, um homem trans e uma mulher lésbica, todas/os estudantes do CEEJA.

Em um dos momentos da produção dos dados, uma fala em especial permaneceu marcada, guardada, como em uma “gaveta no armário dos meus pensamentos”. Nessa fala, estabelecia-se a seguinte analogia: “corpos gays são como corpos com HIV, a sociedade não entende”.

Entre os anos de 2014 e 2022, atuei como professor do Ensino Médio pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Foram muitas as escolas pelas quais passei, em decorrência da minha atuação como professor de Filosofia em regime de contratação temporária.

Nessa condição, não havia o direito nem as condições de permanência em uma única unidade escolar. Como professor contratado pela categoria O, a cada encerramento de contrato ou no retorno do/a docente titular que eu substituía perdia as aulas atribuídas e precisava me deslocar para outras escolas, a fim de completar a carga horária semanal de 40 aulas.

Essa dinâmica implicava o trânsito constante entre escolas localizadas tanto no município onde resido quanto em outras cidades da região, percorrendo, em alguns dias, mais de 60 quilômetros, considerando os trajetos de ida e volta.

Esse tempo de deslocamento tornava-se também um espaço de reflexão: sobre o dia vivido, a atuação em sala de aula, a educação e a escola; sobre o direito à indignação diante de jornadas extensas e da baixa remuneração; e sobre as mazelas sustentadas pelo sistema educacional.

Tais vivências conduziram-me a problematizar as funções que a escola e a educação desempenham, sobretudo nos municípios de menor porte, evidenciando os modos como essas instituições operam na produção, manutenção e exclusão de determinados sujeitos.

Nos anos seguintes, fomos assaltadas/os pela pandemia de Covid-19. Os formatos de ensino se transformaram, assim como toda a organização da vida, do trabalho e as próprias concepções de existência e de mundo. Questionamentos como, ainda teremos vida? ou o mundo resistirá? emergiam de forma recorrente, sem que as respostas se esquivassem de sua dureza.

Vivíamos o que Hannah Arendt denomina de “tempos sombrios” e, no curso dos acontecimentos, aquilo que inicialmente se anunciava como ausência de esperança passou a revelar o real das coisas e os modos pelos quais elas efetivamente se produziam (Arendt, 2008).

Banalizava-se a preocupação com a vida, distorcendo-se a urgência de providências efetivas por meio de falas e discursos que negavam as descobertas científicas produzidas em escala global. Produziam-se inverdades como mecanismos de controle sobre as mortes. Vivíamos em uma sociedade pandêmica ou mesmo pandemônica ainda que governada por um “Messias” que, para parcela significativa da população brasileira, assumia a condição de divindade de uma mitologia negacionista.

Esse contexto conduziu-me ao documentário *Cartas para além dos muros do preconceito* (Canto, 2019), escrito, dirigido e produzido por André Canto. A obra

retrata, a partir de registros históricos e de relatos de pessoas envolvidas nos primeiros anos da epidemia² de AIDS no Brasil, as experiências vividas naquele período. Inspirado na obra e nos escritos de Caio Fernando Abreu, o documentário problematiza as relações de discriminação, preconceito e estigmatização que incidem sobre corpos, sexualidades e o HIV.

O lançamento do documentário ocorreu em um momento próximo aos acontecimentos da pandemia de Covid-19. Com o isolamento social e a drástica redução das saídas em razão do *lockdown*, o contexto mostrou-se oportuno para o contato e a reflexão proporcionados pela obra.

Passados alguns meses, em um momento de flexibilização do confinamento, fui passar alguns dias de férias na casa de um amigo, na capital paulista. Alguns dias após minha chegada, ele passou a sentir-se mal e, ao realizar o teste para Covid-19, teve o resultado positivo. Embora ele estivesse positivado para a Covid-19 e eu não apresentasse sintomas, em respeito aos protocolos de saúde, permanecemos em isolamento, cada um em um espaço distinto da residência.

Nesse contexto, memórias e reflexões anteriormente guardadas especialmente aquelas mobilizadas durante a pesquisa de mestrado vieram à tona. Após alguns dias em isolamento, elaborei o projeto que deu origem à pesquisa aqui apresentada.

No período em que o projeto foi sendo elaborado e posteriormente aprovado (Anexo A), no ano de 2021, diversos acontecimentos se desdobraram. Entre eles, destacaram-se os conflitos em torno do uso ou da recusa da máscara como medida de proteção contra a Covid-19.

Observou-se, ainda, um intenso policiamento social dirigido às pessoas diagnosticadas com Covid-19, não orientado por uma ética do cuidado e da proteção coletiva, mas pelo fato de esses corpos passarem a sinalizar o “perigo” da morte diante dos elevados números de óbitos, amplamente difundidos pelos meios de comunicação, que frequentemente desconsideravam as particularidades das experiências individuais.

² Segundo a matéria publicada no jornal da USP (Tiemi, 2023) “O cenário atual da Aids é caracterizado tanto por uma epidemia quanto pandemia, uma vez que a primeira refere-se, especialmente, ao número de casos em uma determinada população em relação ao esperado, e a segunda diz sobre a transmissão comunitária de um agente infeccioso em países de mais de um continente”.

Em contraste com a pandemia de AIDS, marcada historicamente por questionamentos em torno do uso do preservativo, bem como por práticas de perseguição e exclusão das pessoas soropositivas entre outras questões que serão discutidas mais adiante, a justaposição dessas duas pandemias evidenciou importantes semelhanças.

Tais aproximações se dão tanto pelo fato de ambas serem caracterizadas como pandemias quanto pela magnitude das mortes e, em determinados momentos históricos, pela ausência de possibilidades de cura.

Com o prolongamento da pandemia de Covid-19, diversas situações passaram a ser reveladas, como o caso de uma mulher grávida, com suspeita de infecção pelo vírus, que teve sua casa apedrejada³. Também ocorreram ataques de ódio nas redes sociais contra pessoas suspeitas de estarem com Covid-19, além de práticas de exclusão social e violações dos direitos à saúde e à vida, entre outras situações. Os discursos produzidos por meio das *fake news*⁴ passaram a orientar a mentalidade coletiva, colocando pessoas em risco de violência e, em alguns casos, até de morte.

Não obstante, circularam discursos que associavam o uso da vacina contra a Covid-19 ao contágio pelo HIV, evidenciando que determinadas narrativas estigmatizantes se reiteravam historicamente. Tais acontecimentos indicavam que a história, em certos aspectos, se repetia. Esse turbilhão de ideias e provocações possibilitou problematizar as condições sociais do HIV na contemporaneidade.

Observava-se um silenciamento em resposta ao HIV, como se a infecção estivesse superada ou como se já não houvesse novos casos e mortes. Quando o tema emergia no debate público, ocorria, majoritariamente, em contextos específicos, como campanhas pontuais no mês de dezembro, nos períodos carnavalescos ou, ainda, em situações marcadas pelo preconceito e pela discriminação.

³ Metrópoles: <https://www.metropoles.com/distrito-federal/entorno/gravida-que-teve-casa-apedrejada-apos-boatos-de-covid-19-tem-medo>. Pública: <https://apublica.org/2020/04/vitimas-do-coronavirus-sao-alvos-do-odio-digital/>.

⁴ Ressalto que ainda nos dias atuais, continua-se a inseminação de falas e discursos contraditórios ao que a Ciência explica e orienta. Segundo o Jornal Carta Capital, do dia 06 de janeiro de 2022, “O presidente Jair Bolsonaro deu sequência às suas tentativas de dificultar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. A retomada do discurso negacionista ocorre um dia depois de o Ministério da Saúde anunciar a imunização do Brasil” (G1, 6/1/ 2022). Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/01/06/bolsonaro-ataca-vacinacao-infantil-contracovid-e-espalha-desinformacao-sobre-mortes-de-criancas.ghtml>

Assim, passamos a problematizar o que a educação já vinha realizando no contexto do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Nosso trabalho consistiu em uma garimpagem em plataformas de dados de pesquisas e estudos já realizados, com centralidade na área da educação. Nas buscas, pouco ou quase nada foi encontrado (Reis; Santos, 2023a).

Os achados indicavam que as questões relacionadas ao HIV e à AIDS, bem como às pessoas soropositivas, eram privilegiadas no campo biomédico. Tais temas pareciam circunscritos à área da saúde, como se a vida pudesse ser explicada e resolvida exclusivamente no âmbito medicamentoso.

Dessa forma, discussões sobre prevenção, sobre viver com HIV e outras questões que atravessam o horizonte da escola e da educação considerando que jovens e adolescentes estão em processos de descoberta de suas sexualidades, de ingresso nas práticas sexuais e de contato com substâncias ilícitas pareciam não existir no mundo real, como se os muros “impedissem” que esses debates adentrassem o espaço escolar.

Com o rascunho do projeto e as múltiplas anotações que iam emergindo ao longo do processo, o trabalho foi adquirindo estrutura e densidade a partir das experiências vivenciadas e das disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-graduação ao qual estou vinculado, bem como pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UNESP, campus de Presidente Prudente, que me acolheu.

A disciplina Políticas Educacionais Inclusivas e a Abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), ministrada pela Professora Doutora Elisa Schlünzen, contribuiu de modo significativo para a organização estrutural do projeto e para o desenvolvimento da pesquisa. A disciplina Seminários de Pesquisa I, ministrada pela Professora Doutora Elsa Shimazaki, colaborou para os delineamentos metodológicos do estudo.

As disciplinas Teorias e Tendências Educacionais no Brasil, ministradas pelas Professoras Doutoras Carmen Dias e Elisa Schlünzen, possibilitaram um aprofundamento teórico e um mergulho mais consistente da pesquisa no campo educacional. Somou-se a esse percurso formativo a disciplina Seminários Avançados de Educação e Pesquisa e Produção do Conhecimento, ministrada pelo Professor Doutor Cristiano Giorgi, que contribuiu para as discussões e produções no âmbito da pesquisa educacional.

A disciplina Paradigma da Educação para as Diferenças, ministrada pela Professora Doutora Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos, favoreceu reflexões acerca das diferenças e dos processos de inclusão. Entre as disciplinas externas, Colonialidade, Gênero, Relações Étnico-raciais: o ingovernável dos corpos precários, ministrada pelo Professor Divino José da Silva, colaborou para uma leitura crítica atenta às dinâmicas do colonialismo. Por fim, a disciplina Seminário Internacional de Pesquisa III: Diferença, subjetivação e inclusão, sob a responsabilidade do Professor Doutor Pedro Angelo Pagni, contribuíram significativamente por meio das leituras propostas e das discussões estabelecidas com pesquisadores internacionais.

O projeto e a pesquisa foram potencializados com a realização do intercâmbio na Universidade Aberta de Portugal, por meio do Programa de Doutorado-Sanduiche no Exterior - PDSE (2024), no governo do Presidente Inácio Lula da Silva (PT). O contato inicial com a Universidade Aberta foi intermediado pela Professora Doutora Daniela Melaré, que apresentou a Professora Doutora Cristina Pereira Vieira, a qual passou a atuar como minha supervisora no período do intercâmbio. Ambas são docentes da Universidade Aberta.

A partir da supervisão, foi possível participar da disciplina Seminário de Investigação, ministrada pela Professora Doutora Cristina Lopes Vieira, a qual proporcionou o contato com outros exercícios e perspectivas metodológicas. Outro movimento relevante foi o meu ingresso no grupo Estudos Globais das Juventudes, que desenvolve pesquisas voltadas às juventudes, sob a coordenação da Professora Doutora Cristina Lopes Vieira, além da participação em eventos e seminários que contribuíram para a ampliação das reflexões sobre a educação.

Embora não tenha atuado formalmente como supervisora, a Professora Doutora Daniela Melaré colaborou de maneira significativa ao convidar-me para integrar uma pesquisa coletiva com investigadoras e investigadores de Portugal e da África Lusófona – Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, o que ampliou minhas percepções acerca do fazer pesquisa em contextos internacionais (DIGENDER2Palop, 2024-2025).

Assim, a tese resulta de todo o empreendimento desenvolvido desde o primeiro ano da pesquisa até o momento de seu envio à banca avaliadora. A partir do percurso investigativo realizado, organizamos a tese em três estudos, nos quais contemplam as respostas buscadas à pergunta investigativa, bem como ao objetivo

geral do trabalho. Não obstante, cada estudo corresponde a um objetivo específico, sendo desenvolvido com a finalidade de contribuir para a construção do conjunto da tese.

Em cada estudo há um delineamento metodológico próprio e a utilização de técnicas de pesquisa que subsidiaram a produção dos dados, assegurando o rigor, a consistência e o êxito da investigação. A opção por desenvolver a tese por meio de estudos mostrou-se mais “didática”, no sentido de conduzir as pessoas leitoras por cenas articuladas entre si, constituídas a partir de cenários e personagens que atuam na apresentação dos resultados, bem como das problematizações e reflexões que deles decorrem.

Nesse sentido, pode-se sintetizar que o primeiro estudo tem como propósito contextualizar o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, analisando essas questões na realidade contemporânea da educação e da escola, com recorte no Estado de São Paulo. O segundo estudo coloca em cena as/os estudantes do Ensino Médio, buscando compreender suas percepções acerca do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Por fim, o terceiro estudo dedica-se a ouvir as narrativas de pessoas soropositivas, a partir de suas trajetórias de vida e das experiências escolares que atravessaram suas vivências.

Diante dessa sinalização, orientamo-nos a partir da seguinte questão investigativa: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

O interesse em dialogar com pessoas soropositivas decorreu do entendimento de que são elas, mais do que ninguém, que podem narrar, a partir de suas condições de vida e das experiências que atravessaram, se e como a escola desempenha algum papel na produção de saberes relacionados à prevenção e, sobretudo, na possibilidade de viver com HIV.

A partir de suas falas, torna-se possível compreender o papel que a escola pode assumir na aproximação desse universo, seja no incentivo à testagem, na circulação de informações sobre o uso de antirretrovirais que hoje possibilitam que pessoas soropositivas não vivenciem a morte como outrora, seja na difusão de outros conhecimentos que contribuam para o cuidado de si e para a construção de práticas de vida mais informadas e éticas entre as/os estudantes e em relações sorodivergentes.

Uma vez delineada a pergunta investigativa, aquela que continuamente orientou o percurso da pesquisa e o direcionamento da tese fez-se necessária a definição de um objetivo. Assim, estabeleceu-se como objetivo geral analisar as vivências escolares de pessoas soropositivas no que se refere às suas percepções sobre o HIV e a AIDS, considerando a formação escolar para as diferenças. Essas pessoas, a partir de seus lugares de fala, possibilitam acessar o “lado de dentro dos muros”, não apenas da escola, mas também dos espaços sociais nos quais suas vidas se constituíram.

Para que tal objetivo fosse alcançado, a pesquisa foi organizada em três estudos, a partir dos quais se definiram como objetivos específicos que orientaram a produção dos dados. Esses estudos constituíram os meios analíticos necessários para responder à pergunta investigativa e sustentar a defesa da tese.

Com o primeiro objetivo, propôs-se analisar documentos, diretrizes e produções enquadradas como científicas e não científicas⁵ que fundamentam as discussões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no âmbito do Ensino Médio, com recorte no Estado de São Paulo. Para tanto, adotou-se a arqueologia, conforme mobilizada por Foucault (2019) em *A história da loucura*.

A perspectiva arqueológica possibilita olhar para o presente a partir de um problema específico neste caso, identificar se e de que modo e em que condições as questões relativas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas são tratadas nos documentos e materiais que orientam a educação nacional e, especialmente, a educação estadual, buscando compreender tais formulações à luz de suas condições históricas de emergência.

De forma complementar à arqueologia, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental, que subsidiou a análise dos documentos normativos, diretrizes curriculares e materiais educacionais localizados no presente, permitindo articular os achados históricos às práticas e discursos educacionais contemporâneos.

⁵ Ao mencionarmos produções científicas e não científicas, nos amparamos em Foucault (2014), ao refletir que o que faz com que um saber esteja sob o regime de verdade científico não é o teor de cientificidade, mas o poder que autorizará que esse saber possa circular, quem o produziu, quais meios o veiculará. Assim como os não científicos, como os saberes que são produzidos fora dos regimes de verdades. De forma a ilustrar, pensemos na época do regime ditatorial, jornais que não eram permitidos que circulassem, devido ao fato de não seguirem os critérios de verdade que o regime fazia circular. Assim ocorre com documentos e materiais que pouco são explorados para pensar outras narrativas sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas por serem marginas e revelar um “cetro contrapoder”.

É importante destacar que o recorte empírico da pesquisa se concentra no Estado de São Paulo, razão pela qual essa unidade federativa recebe maior ênfase nas análises desenvolvidas. Contudo, tal delimitação não implicou a negligência do contexto nacional nem de movimentos que extrapolam o território brasileiro. Assim, a partir da perspectiva arqueológica, buscou-se compreender como a sociedade produziu discursivamente o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas ao longo da história, de modo a situar essas produções nos contextos contemporâneos da escola e da educação.

Esse movimento constituiu uma oportunidade de oferecer às pessoas leitoras o contexto histórico-discursivo no qual o HIV e a AIDS foram produzidos na e pela sociedade, possibilitando compreender os efeitos dessas construções nos modos de pensar, ensinar e vivenciar tais questões no campo educacional.

Os resultados que emergiram indicam que a história do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas foi construída por múltiplas mãos, mas também marcada por inúmeras negações. Ao longo desse percurso, problematizou-se a associação equivocada da AIDS às pessoas homossexuais. O risco de uma ciência tomada como portadora da “verdade”, aliada aos meios de comunicação de massa, contribuiu para a produção discursiva da AIDS como a “peste gay” ou o “câncer homossexual”, como se a infecção estivesse vinculada às pessoas homossexuais e não ao vírus ou aos mecanismos de transmissão sanguínea.

Posteriormente, a AIDS passou a ser associada às pessoas haitianas, em razão do aumento dos casos nesse grupo em determinado período histórico. Com o avanço da epidemia, a associação deslocou-se também para as pessoas hemofílicas. Em todos esses momentos, a produção discursiva da AIDS esteve sustentada por uma lógica moralizante, que culpabilizou a infecção ao vinculá-la à prostituição, ao uso de substâncias ilícitas e a comportamentos considerados desviantes em relação ao que foi socialmente instituído como “correto”.

Tais discursos desconSIDERAM o fato de que o vírus pode estar presente em qualquer corpo e que nenhuma dessas pessoas é causadora da infecção. Ao contrário, são vítimas não apenas do vírus, mas também das ações e omissões do Estado, das dinâmicas econômicas, das instituições religiosas e de outros dispositivos sociais que contribuíram para a produção do estigma e da exclusão.

Destarte, os achados conduzem à compreensão de que os regimes de verdade que historicamente produziram a AIDS são regimes que também se

encontram em disputa no espaço escolar, seja para sua reprodução, seja para sua ruptura, quando a temática é reconhecida como parte da vida humana e, portanto, passível de ser ensinada e problematizada na escola. A constatação a que se chegou é a de que, mesmo com a epidemia seguindo seu curso ora de forma mais intensa, ora mais controlada, ela continuou a dizimar vidas, enquanto a educação, em grande medida, manteve-se alheia a esse processo.

Os documentos elaborados para orientar a educação e a escola pouco ou nada abordam as questões relativas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas. Quando tais temas aparecem, fazem-no de maneira tímida, como se tratasse de um problema inexistente ou estranho ao cotidiano escolar, revelando um movimento de silenciamento. Subjaz a esse cenário uma compreensão distorcida de política educacional, segundo a qual falar sobre determinadas temáticas equivaleria a incentivá-las.

Em contrapartida a essa lógica negacionista, sustenta-se que falar é produzir subsídios, oferecendo a jovens e adolescentes bases informativas e reflexivas para orientar suas experiências, escolhas e modos de cuidado de si e dos/as outros/as.

Com a produção e a análise dos dados, ao examinarmos os materiais disponibilizados pela escola para uso em sala de aula, constatou-se que os temas relacionados ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas aparecem de forma bastante incipiente, tanto no que se refere aos conteúdos quanto ao tempo destinado a essas discussões. É como se as questões relativas ao HIV e à AIDS, bem como às pessoas soropositivas, estivessem restritas exclusivamente ao campo biomédico da existência.

Quando presentes, os discursos limitam-se, em geral, à prevenção, deixando de abordar dimensões sociais fundamentais, como os processos de exclusão, o estigma e as possibilidades de afirmação positiva. Não se discute a presença de pessoas soropositivas que são socialmente relevantes e proeminentes, passíveis de serem referenciadas como produtoras de conhecimento, cultura e cidadania.

Tampouco se fala sobre a possibilidade de viver sendo soropositivo, sobre o acesso ao tratamento, nem sobre a construção de uma vida plena, equivalente à de qualquer outra pessoa, em pleno exercício de seus direitos e deveres.

Desse modo, silencia-se a compreensão de que as vidas das pessoas soropositivas importam, integram o tecido social e fazem parte do Estado e da sociedade brasileira.

No segundo estudo, o objetivo foi compreender as percepções de estudantes matriculados/as no Ensino Médio do Estado de São Paulo acerca das questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas. Considerando que, nos documentos educacionais e nos materiais didáticos, o tema do HIV e da AIDS aparece de forma limitada e que as pessoas soropositivas praticamente não são abordadas, tornou-se relevante investigar o que esses/as estudantes sabem e compreendem sobre tais temáticas.

Para a produção dos dados, foi elaborado um instrumento a partir de um banco de enunciados e questões, tomando como referência o modelo da escala Likert. Após sua elaboração, o instrumento foi submetido à avaliação de uma banca julgadora, composta por especialistas, que contribuiu com sugestões de aprimoramento, indicando quais itens deveriam ser mantidos, reformulados ou excluídos.

Ao final desse processo, o instrumento foi constituído por cinco questões destinadas à caracterização das pessoas participantes da pesquisa e por vinte enunciados, organizados em três alternativas de resposta: *discordo*, *concordo* e *não sei dizer*.

Concluídas as etapas burocráticas e técnicas, o instrumento foi aplicado, resultando em um total de 189 respostas. A partir dos dados produzidos, foi possível organizar a análise em quatro eixos analíticos, a saber: (a) Perfil dos/as Estudantes; (b) Conhecimento Abrangente; (c) Educação Escolar, Inclusão e Diversidade; e (d) Autoconhecimento como Ferramenta de Enfrentamento ao HIV.

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística simples, tendo como critério as relações estabelecidas entre os enunciados. A organização dos eixos analíticos possibilitou a construção de interpretações diversas, permitindo compreender as percepções dos/as estudantes a partir de múltiplas dimensões.

Os dados evidenciaram dificuldades por parte dos/as estudantes em autodenominarem-se no que se refere à identidade de gênero e à sexualidade. Ao serem apresentados enunciados relacionados a conhecimentos amplamente difundidos, como a distinção entre HIV e AIDS, observou-se um número reduzido de respostas que demonstravam domínio conceitual suficiente para diferenciá-los.

Situação semelhante ocorreu em enunciados construídos como falácias, a exemplo da afirmação de que “o suor pode transmitir o HIV”, diante da qual parte dos/as estudantes afirmou concordar ou declarou não saber responder.

No que concerne ao autocuidado, enquanto eixo analítico voltado às percepções dos/as estudantes, os dados indicaram fragilidades no conhecimento acerca da prevenção, da testagem e das condutas a serem adotadas diante da possibilidade de um diagnóstico positivo para o HIV. Ao mesmo tempo, registraram-se numerosas respostas que sinalizavam o uso do preservativo, o que revelou contradições interpretadas como decorrentes da falta de informações mais consistentes e articuladas sobre o tema.

A leitura dos dados e das reflexões deles decorrentes revela que, embora alguns resultados indiquem certo nível de conhecimento sobre o HIV e a AIDS, outros enunciados e respostas contradizem essa sinalização, colocando em xeque a consistência desse suposto saber. Ao cruzar os diferentes dados, evidenciam-se lacunas significativas na compreensão dos/as estudantes, o que fragiliza a ideia de um conhecimento efetivamente consolidado sobre o tema.

De modo geral, conclui-se que há pouco conhecimento não apenas sobre o HIV e a AIDS, mas, sobretudo, sobre as pessoas que vivem com HIV. Essa ausência pode estar relacionada à omissão da escola em criar espaços sistemáticos de discussão sobre essas temáticas, espaços que poderiam, inclusive, suprir a falta de diálogo, informação e orientação que, em muitos casos, não são ofertados no âmbito familiar.

Soma-se a isso o fato de que, quando adolescentes e jovens desconhecem o que significa viver sendo soropositivo, tendem a reproduzir percepções estigmatizantes, contribuindo para a manutenção de relações excludentes na sociedade. Ademais, a inexistência de uma cultura de testagem e de informações claras sobre a possibilidade de tratamento compromete o enfrentamento da epidemia, impactando diretamente os índices de adoecimento e de óbitos em decorrência da AIDS.

Uma vez compreendidas as percepções dos/as estudantes acerca das questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas, deu-se continuidade à pesquisa com o terceiro estudo, cujo interesse e objetivo consistiram em compreender, a partir das narrativas de pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, o que aprenderam na escola sobre HIV e AIDS, bem como quais conhecimentos e experiências contribuíram para suas vidas após a confirmação do diagnóstico e no enfrentamento do convívio social.

Para a produção dos dados-falantes, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, aliadas à técnica de amostragem em bola de neve, que possibilitou a composição do grupo final de 4 participantes. Ao todo, participaram deste momento da pesquisa quatro pessoas soropositivas, cujas narrativas constituíram o corpus analítico do estudo.

Os critérios de inclusão adotados estabeleceram que todas as pessoas participantes deveriam ser soropositivas, ter realizado o processo de escolarização no Estado de São Paulo e ser maiores de 18 anos. A produção dos dados ocorreu a partir de um roteiro de entrevistas semiestruturadas, realizadas em encontros previamente agendados, nos quais as falas foram gravadas para posterior tratamento dos dados brutos, transcrição, descrição e análise.

Para a análise, adotou-se como procedimento a construção de eixos analíticos, denominados eixos-falantes, organizados a partir de uma leitura horizontal das narrativas, de modo a articular as respostas e os sentidos produzidos pelas pessoas participantes. Ao final do processo analítico, foi possível desenvolver a discussão a partir de cinco eixos-falantes, a saber:

- Eixo 1: “Seu exame deu HIV positivo: vai ser para a vida toda ou será parte da minha vida?”;
- Eixo 2: “Uma pergunta que não deveria ser feita: você é soropositivo/a?”;
- Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo; Eixo 4: Quando a aula produz medo, e não cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS na voz de pessoas soropositivas;
- Eixo 5: A arte de reinventar a si mesmo: invenções para um currículo sorotransgredir.

A partir dos resultados, foi possível evidenciar a ausência de uma formação escolar que abordasse de modo consistente as questões relativas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas no Ensino Médio. Diante dessa lacuna formativa, a vida passou a ser vivenciada, em muitos casos, como um campo da sorte, sustentado por crenças como a confiança de que o matrimônio ou os relacionamentos monogâmicos constituiriam, por si só, formas seguras de proteção.

Em outra direção, emergiu também um processo de responsabilização individual, atravessado por sentimento de culpa, nos quais as próprias pessoas atribuem a si mesmas a infecção como resultado de “escolhas erradas”. Tal percepção obscurece o fato de que a ausência ou a insuficiência de informações seja na escola,

seja na família limitou as possibilidades de prevenção, cuidado e enfrentamento do diagnóstico, ampliando o sofrimento decorrente da descoberta da sorologia.

As relações sociais mostraram-se atravessadas por saberes históricos, mitológicos e moralizantes, que se materializam no preconceito e no estigma, inclusive nos espaços de saúde. A partir das narrativas das pessoas soropositivas, torna-se possível pensar a construção de um currículo e de uma escola capazes de sorotransgredir, isto é, de incorporar outras diferenças como elementos constitutivos do processo educativo, contribuindo não apenas para a formação escolar, mas também para a vida para além dos muros da escola, reconhecendo e valorizando as vidas soropositivas.

Os dados coletados foram analisados à luz do pensamento de Michel Foucault, mobilizando diferentes obras de sua produção teórica. Compreende-se que o referencial foucaultiano oferece sustentação analítica à tese, assim como o pensamento pós-estruturalista, cujas discussões dialogam diretamente com os objetivos e problematizações desenvolvidos ao longo dos diversos momentos da pesquisa. Trata-se de aportes teóricos que permitem apreender os fenômenos investigados em sua dimensão histórica, discursiva e relacional, tal como se manifestam na realidade.

Nesse sentido, afastamo-nos de perspectivas que se apoiam em noções de naturalidade, essência ou generalização, por entendermos que tais categorias não corroboram os fundamentos teórico-metodológicos assumidos na tese. Ao contrário, privilegiam-se leituras que problematizam as formas pelas quais os sujeitos, os saberes e as verdades são historicamente produzidos, disputados e governados.

Ao lermos os dados, foi possível perceber o exercício do poder e dos saberes para a produção das subjetividades por meio da cultura, atravessado pelo cristianismo, pelo saber médico e científico e tantos outros, em vista de saciar a vontade de saber. Através das instituições-dispositivos, esses saberes se colocam como estratégias que fazem do corpo, da sexualidade, da família e da escola elementos do exercício do poder. Ainda assim, esse poder é refutado quando olhamos para as formas de produção das subjetividades soropositivas.

Essas ideias estão sob a coerência de que, ao pensar pessoas soropositivas, nos remetemos a uma desconstrução de identidades previamente fabricadas, construídas no decorrer da história e da sociedade, culminando na educação. A percepção dessas pessoas está repleta de categorizações que, pelos vários

discursos, as constroem de forma estereotipada, resultando em vivências excludentes. Na educação, o pensamento pós-estruturalista possibilita repensar as pessoas que compõem o cenário educacional e a sociedade, desfazendo a visão rígida de pessoas que a história e a cultura têm se preocupado em preservar.

Desse modo, a base teórica que utilizamos, ao nos pautarmos em Foucault e no pensamento pós-estruturalista, nos permite não disciplinar a tese como um pensamento corrente ou tradicional, visto que uma de suas marcas são as provisoriiedades e o inacabado, ambos como forma de pensar outras questões até então não pensadas ou questionadas.

Ao considerarmos os aspectos teóricos que alicerçam esta tese, somos provocados a pensar as pessoas soropositivas na educação como resultado da superação de paradigmas educacionais, estruturais e fixos. Isso implica considerar as subjetividades como algo construído pela cultura e pelos meios que a alimentam.

Assim, há a possibilidade de pensar a escola e o currículo como locais de desconstrução e reformulação das percepções estigmatizantes e limitantes, de modo a compreender as diferenças e, assim, fazer saltar os muros do preconceito.



6² CARTOGRAFIA ESTRUTURAL DA TESE: CAVALETE FOUCAULTIANO

“Toda teoria é um esforço de explicar para cabeças-duras a realidade que eles não enxergam. “Ailton Krenak (2020).

Nesta seção, procuramos elucidar as bases teóricas sobre as quais a tese foi construída. Ao utilizá-las, pensamos nas relações existentes e possíveis com o objetivo da pesquisa. A partir das leituras, discussões e do que vínhamos estudando, pareceu-nos coerente recorrer aos pensamentos e às ideias propostas por Michel Foucault, assim como às de outras e outros estudiosas/os reconhecidas/os no âmbito da perspectiva pós-estruturalista. Todas, caminham na direção de sustentar o quadro das paisagens que tentamos pintar a partir dos três estudos que caracterizam a tese.

Desse modo, não procuramos fazer comentários que fossem lidos como um manual ou compêndio sobre o pensamento foucaultiano. Propomos traçar algumas linhas para que as pessoas leitoras possam ler e perceber as relações possíveis que puderam ser balizadas com os dados produzidos e com o uso metodológico, visando a manter, o mais próximo possível, a coerência com os estudos que compõem a tese.

Destarte, ler Foucault é estranhar as palavras. Sua escrita não segue regimes regulares de verdade. São provocações que nos desestabilizam, fazem-nos voltar, ansiar por mais, realizar pausas necessárias e seguir em busca do inesperado questionamento ou da ideia produzida, no presente, pelo passado.

De início, traremos algumas informações sobre Foucault, em uma síntese biográfica. Nesse momento, procuramos situar essas informações no contexto dos acontecimentos em que as produções de Foucault foram realizadas.

Na sequência, apresentamos alguns comentadores que, com suas leituras e pesquisas, ajudam-nos a organizar os materiais produzidos por Foucault e a compreendê-los com maior profundidade, possibilitando nossa apropriação das discussões.

⁶ Ressaltamos que, quando mencionamos “bases teóricas”, estamos nos referindo ao sentido de “teorizações foucaultianas”. Tal entendimento advém de Veiga-Neto (2016, p. 18–19), ao nos ajudar a compreender que, ao se tratar de Foucault, é “muito mais interessante e produtivo perguntarmos e examinarmos como as coisas funcionam e acontecem e ensaiarmos alternativas para que elas venham a funcionar e acontecer de outras maneiras”. Nesse entendimento, tentamos nos orientar ao longo da tese.

Por fim, realizamos alguns comentários balizados pelos objetivos e pelos temas caracterizados a partir dos dados produzidos. Trata-se de leituras realizadas desde um possível ponto de vista no qual nos encontramos, imersos nas ideias e nos dados e, por meio dessa provocação, conseguimos elaborar os textos que seguem abaixo.

2.1 Foucault: nascimento e ressurreição. Sentado à esquerda dos pensamentos

Iniciamos essas palavras conferindo ao próprio Foucault que, em “cada um de meus livros representa uma parte de minha história. Por uma ou outra razão, foi-me dada a ocasião de provar ou de viver essas coisas”⁷. Entendemos que, ao ler Foucault, suas palavras não estão descoladas de suas vivências. As reflexões que foram sendo produzidas situam-se no campo do possível, entre as várias facetas de quem as lê e o perigo de interpretá-las a partir de uma perspectiva fixa.

Talvez seja por isso que, em alguns momentos de suas produções, na tentativa de enquadrá-lo em um quadro único, Foucault alerta para que “não pergunte quem eu sou e não me peça para ser sempre o mesmo” (Foucault, 2015a, p. 21). Ousamos pensar, assim, que talvez sua vida tenha sido seu próprio laboratório de estudos, do qual emergiram ideias que nos servem até hoje. Uma coerência entre escrita e realidade, que aprendemos e seguimos sem descolar nossas escritas da realidade social, política, cotidiana e existencial.

Para muitos, é conhecido como Foucault; para outras, sobretudo as mais próximas, como Paul-Michel Foucault. Nasceu no dia 15 de outubro de 1926, em Poitiers, cidade localizada no centro-oeste da França. Dos Foucaults, houve aquele que, quando criança, almejava viver em um aquário como um peixe.

Já crescido, seguiu um percurso formativo que o levou ao mundo das análises críticas, iniciando-se com a licenciatura em filosofia, no ano de 1948. Um ano depois, licenciou-se em psicologia.

Não obstante, o menino que queria ser peixe tornou-se também um combatente e militante que discordava de políticas e modos de vida que limitavam a

⁷ Trecho da entrevista dado por Foucault em 25 de outubro de 1982 à R. Martin, na Universidade de Vermont. Disponível na íntegra em: <http://1libertaire.free.fr/MFoucault240.html>

existência humana. Em 25 de junho de 1984, Foucault morreu em decorrência da AIDS, na cidade de Paris (Horrocks; Jevtic, 2013; Yazbek, 2014).

Os anos finais de Foucault podem ser conhecidos a partir da obra *Para o amigo que não me salvou a vida*, escrita por Hervé Guibert (1995), que anos depois, em 1991, veio a falecer também em decorrência da AIDS.

Guibert era amigo próximo de Foucault e, com frequência, visitava-o no hospital em Paris, o Salpêtrière, instituição que havia sido objeto de análise em pesquisas anteriormente realizadas por Foucault.

O livro segue o formato de um diário, narrando as visitas e os acontecimentos que ocorreram em torno do momento final da vida de Foucault. Nos escritos, Guibert criou um nome fictício para Foucault, chamando-o de Muzil, pois a obra não se restringe a uma autobiografia, mas apresenta traços de realidades desenhadas pela ficção.

Uma das descrições que Guibert retrata pelas palavras de Muzil mostra que, embora sentisse as inconstâncias da infecção, em um momento em que ainda não havia um tratamento eficaz para a AIDS, Foucault não desligava sua percepção crítica.

Seguia analisando os atravessamentos pelos quais seu corpo passava ao estar “lançado no circuito médico, perde toda a identidade, não passa de um pacote de carne involuntário, atirado daqui para lá, apenas uma matrícula, um nome que passa por uma máquina administrativa, exangue de sua história e de sua dignidade” (Guibert, 1995, p. 20).

Didier Eribon (1990), pessoa próxima de Foucault, ao propor uma biografia intitulada *Michel Foucault 1926–1984*, descreve-o como uma pessoa de múltiplas máscaras. O que isso vem a ser? A personalidade de Foucault é complexa e diversa. Quando iniciamos, utilizamos uma das falas do próprio Foucault, na qual afirmava que suas leituras poderiam ser autobiográficas.

Talvez seja nesse sentido que Eribon o descreve: como uma pessoa que não se enquadra em uma única verdade, mas em várias faces, ou em vários Foucaults. Acrescenta-se, ainda, que “tratando-se de um livro sobre Foucault, cuja obra inteira pode ser lida como uma insurreição contra os poderes da normalização” (Eribon, 1990, p. 12).

Paulo Veyne, outro amigo próximo de Foucault, dedicou-lhe uma obra intitulada *Foucault: o pensamento, a pessoa* (2008). Ao descrevê-lo, Veyne afirma que

Foucault não é um pensador estruturalista: suas ideias não resultavam das reflexões elaboradas em 1968, nem sobressaía nelas o relativismo historicista.

Entre as coisas que se pode dizer sobre Foucault está o fato de ser cético. Tal ceticismo visa não aceitar uma verdade que limite os acontecimentos históricos, como muitas vezes nos deparamos ao ler certos livros, muito menos uma verdade que construa uma ideia geral.

É também um pensador empirista, que enfrenta a razão defendida como superior durante séculos de pensamento. Outro ponto acertado a dizer sobre aquilo a que Foucault se propôs foi desenvolver “[...] uma concepção geral da condição humana, da sua liberdade reactiva e da sua respectiva finitude [...] cuja originalidade reside em ser fundada sobre a crítica histórica” (Veyne, 2008, p. 10).

Embora Foucault tenha morrido em decorrência da AIDS, não escreveu nada diretamente sobre a pandemia que, à época, dizimou muitas pessoas. Alguns biógrafos, ao falarem sobre sua morte, não o eximem dos discursos de verdade produzidos em torno da AIDS. Por ter uma visão cética e não moralista, Foucault vivia suas práticas sexuais como uma forma de experimentação. Popularmente, Foucault é rotulado como homossexual, mas tal identificação não é encontrada em seus escritos nem em suas entrevistas.

O fato de não “assumir” sua sexualidade tem como possível explicação seus próprios escritos, nos quais rejeita ser categorizado por uma identidade que o fixe. Outros dizeres sobre Foucault o descrevem como frequentador de saunas gays e praticante do sadomasoquismo. Práticas comuns a muitos gays e também a pessoas heterossexuais que, ao buscarem prazeres, assumem para si suas verdades como uma forma de produzir-se enquanto subjetividades que lutam entre o poder de ser do outro e o poder de ser a si.

O que se diz sobre a vida particular de Foucault, sua sexualidade e o uso de substâncias consideradas ilícitas é assumido como verdade sobre ele e encontra ressonância em seus escritos. Ao lermos e conhecermos um pouco de sua vida, torna-se possível perceber a insubmissão como um movimento de contrapoder ao sistema e às formas de sequestro dos desejos (Faubion, 2025).

Mathieu Lindon, um dos protegidos de Foucault, afirma que ele não revelou publicamente sua sorologia, assim como muitas pessoas que, à época da pandemia de AIDS, foram surpreendidas, sem muito o que fazer.

Lindon, ao falar sobre Foucault, não revela nada de novo para quem tem uma vida sexual ativa, ao mencionar que, em suas viagens para realizar palestras e seminários em diversos países, Foucault tinha predileção por frequentar clubes gays. Em uma fala ousada e questionável, Lindon afirma ainda que Foucault contraiu o HIV nas saunas de São Francisco, por meio de sexo oral (Giron, 2014).

A visão de Defert, companheiro de Foucault, que morreu em 2023, aos 83 anos, por morte natural, mostra um Foucault cotidiano. Segundo Defert, a infecção seguia silenciosa. Em 1983, apareceu uma tosse que, com o uso do antibiótico Bactrim, desapareceu. Com o medicamento, Foucault seguiu com seus trabalhos, retornando às aulas no Collège de France, como se tudo tivesse se normalizado e a tosse fosse apenas uma doença corriqueira.

No ano de 1984, Foucault recaiu e, então, foi necessário ser hospitalizado; após três semanas, faleceu. Com a morte de Foucault, Defert compreendeu o medo que a AIDS produziu na sociedade e, por isso, tornou-se uma doença silenciosa. A verdade que se tinha vinha dos discursos que circulavam ao associar a homossexualidade à AIDS. Segundo Defert, Foucault faleceu em silêncio (Nouchi, 2023). De tantas palavras já ditas, o não dito ficou como herança para o que tratamos nesta pesquisa

Dadas essas considerações, pode-se perceber que Foucault manteve coerência entre seu pensamento e suas escritas. Conhecer a vida do pensador nos mostra que a escrita nem sempre se desliga daquilo pelo que lutamos, acreditamos e, assim, vivemos. Nas linhas que seguem, faremos algumas considerações sobre o pensamento foucaultiano.

2.2 Pensamento foucaultiano

No acesso às obras e às leituras das pessoas que, ao longo de suas atuações como professoras/es, pesquisadoras/es e/ou estudiosas/os do pensamento foucaultiano, vimos interpretações e considerações, que é possível perceber a confirmação do “desejo” de infância de Foucault em ser um peixe. Diríamos como um lambari, que escorrega entre as várias tentativas de catalogar e propor uma organização de seu pensamento. Essa constatação se evidencia nos laboriosos esforços em caracterizá-lo a partir de supostos métodos e/ou formas de análise e períodos.

Em *A filosofia de Michel Foucault*, Esther Díaz (2012) descreve o pensamento de Foucault como uma ontologia histórica: ontológica por seus estudos estarem atentos às questões dos entes, ou seja, à realidade das coisas e de seus acontecimentos; histórica, por Foucault encontrar os entes nos acontecimentos históricos, na leitura e na produção de dados advindos das experiências humanas, materializadas nos arquivos e documentos produzidos ao longo do tempo. Ao partir desses dois princípios, Díaz distingue o pensamento de Foucault em três etapas, popularmente conhecidas como arqueológica, genealógica e ética:

Em sua primeira etapa, a arqueologia, Foucault procura fazer uma ontologia histórica de nós mesmos em relação à *verdade* mediante a qual nos constituímos em sujeitos de conhecimento. Em um segundo momento, o genealógico, tenta produzir uma ontologia histórica de nossos modos de sujeição em relação ao campo do *poder* por meio do qual nos constituímos em sujeitos que agem sobre os demais. Na terceira etapa, a ética pretende elaborar uma ontologia histórica de nossas subjetividades em relação aos questionamentos pelos quais nos convertemos em *agentes morais*. Nas três etapas Foucault se ocupa das formas de subjetivação como produções históricas (Díaz, 2012, p. 2).

Em síntese, Díaz (2012) descreve o primeiro momento arqueológico como a produção de uma “história dos a priori” (p. 6). O recorte temporal das produções que caracterizam esse momento situa-se entre os anos de 1961 e 1969, pautando-se no olhar do presente que se dirige ao passado. Díaz cita e reflete sobre algumas obras, como *História da loucura*, *O nascimento da clínica* e *As palavras e as coisas*, como constituintes desse primeiro momento, no qual a arqueologia é utilizada como procedimento de análise.

A arqueologia, como tal procedimento, ao ser utilizada no contexto da escola e da educação, ajuda a compreender a produção discursiva do HIV, da AIDS e das pessoas que vivem soropositivas. No desenrolar dos anos, com as descobertas, os discursos e as percepções foram sendo modificados, não como uma linha histórica tal como comumente aprendemos, marcada pela ideia de progresso, própria do discurso da modernidade. As táticas e formas de poder foram sendo transformadas, assim como as contracondutas que, na escola, também se fizeram presentes e seguem até os dias atuais, seja pelo currículo, pelas pedagogias ou pelas políticas educacionais.

No que concerne à genealogia, Díaz a descreve como um momento de mudança, a partir de alguns acontecimentos sociais que provocaram Foucault e que giraram em torno da questão do poder, especialmente as manifestações de maio de

1968, caracterizadas por protestos encabeçados por estudantes, que deram origem a uma greve que mobilizou outros setores, como o dos/as trabalhadores.

Esse movimento tinha como pautas reivindicações por melhorias na educação, no campo social, pela liberdade cultural, entre outras. Tal evento contou com a participação de Foucault, culminando em seu contato, nos anos de 1964 a 1968, com as leituras de Nietzsche. Os textos que se destacam nesse momento são *A ordem do discurso*, *Vigiar e punir*, *A vontade de saber* e *Microfísica do poder*.

A genealogia fornece meios para pensarmos as relações de vigilância, poder, conhecimento e força presentes na escola. Com a chegada do HIV e da AIDS, a produção das regulações e das aprendizagens, sobretudo no início da pandemia, ganhou mais força em razão do desconhecimento que apavorava as pessoas e que, ainda hoje, temos como herança em visões contaminadas sobre o que o HIV não é.

Se, com a arqueologia, é possível observar a produção discursiva sobre os corpos soropositivos, com a genealogia é possível ver as relações estabelecidas no âmbito institucional, travadas por estigmas, exclusões e resistências que ainda, nos dias atuais, se fazem presentes, como nos casos de estudantes hostilizados, trabalhadores demitidos e leis que asseguram sua legibilidade nesses espaços.

Por fim, o que caracteriza o último momento, descrito como ético, tem como obras principais *A história da sexualidade II: uso dos prazeres*, *A história da sexualidade III: o cuidado de si* e *A história da sexualidade IV: as confissões da carne*. Os questionamentos que orientam esse momento relacionam a sexualidade com a ética e, nesse sentido, com o emaranhado entre verdade e desejo, a forma como o ser humano se vê. Outra questão que se mostrou provocadora nesse período, segundo Díaz (2012), é a preocupação em conhecer o sexo e o prazer na Antiguidade moral.

Os trabalhos produzidos no eixo ético por Foucault e lidos por Díaz ajudam a pensar a relação da sexualidade com o HIV e seus desdobramentos no cotidiano escolar. A moralização da sexualidade funciona como um dispositivo para a produção das relações e das subjetividades, principalmente daquelas que não se posicionam dentro do quadro prescritivo que culturalmente é construído como “correto” e “normal”.

Na escola, o corpo desobediente é marcado tanto pela sexualidade quanto pela identidade de gênero não cis-heteronormativa. Embora sejam “perseguidos”, também se colocam como possibilidade de romper com a ideia de um sujeito único e universal.

Outra leitura sobre o pensamento de Foucault pode ser conferida na obra Michel *Foucault: tecnologías del yo y otros textos afines*, especialmente na introdução intitulada *La cuestión del método*, de Miguel Morey (2008). Morey tece algumas considerações que questionam as visões tripartidas do pensamento de Foucault, como as apresentadas por Díaz (2012).

Uma primeira questão levantada por Morey é que, ao considerarmos a *História da loucura* como o primeiro trabalho de Foucault caracterizado pelo uso arqueológico, como dizer que *vigiar e punir* é considerado genealógico, se, ao ser analisado, é entendido como uma reescrita arqueológica?

Para responder a tal questionamento, Morey aponta a discrepância entre a arqueologia e a genealogia. A arqueologia é um procedimento que visa **descrever**, subtraindo-se dos moldes antropológicos, como são estabelecidos os regimes que se afirmam enquanto conhecimento, considerando o recorte histórico em que a descrição se realiza. Por exemplo, em *História da loucura*, um dos contextos utilizados foi o Renascimento, descrevendo como a loucura foi resultado da produção cultural daquele momento.

No contexto da AIDS, a produção do conhecimento foi realizada pela medicina que, ao se ver surpreendida por um vírus desconhecido, utilizou a prevalência dos casos iniciais e não únicos entre pessoas homossexuais, fazendo da AIDS uma peste homossexual, na qual se produziram e se potencializaram o preconceito e a exclusão das diferenças sexuais.

Na escola, essas questões tiveram de ser aceitas pela força da lei, mas também pela inocência que desculpabiliza as crianças como agentes imorais, principalmente nos casos de crianças e adolescentes que tiveram contato com o HIV de forma vertical.

A genealogia, enquanto procedimento, busca **explicar** como são produzidas as relações de poder, acrescentando à arqueologia a tarefa de responder ao “quem” e ao “por que” determinada coisa ficou estabelecida como tal e não como outra, igualmente possível.

Podemos tomar como exemplo o que Foucault apresenta em *A ordem do discurso* (2014a), ao mencionar que o discurso da pessoa “entendida” como louca não era aceitável para circulação, enquanto o de outras pessoas, sim. Ou seja, ele questiona por que o discurso de uma pessoa é aceitável e o de outra não? Quem estabeleceu uma coisa como verdadeira e outra não?

Foucault responde que o discurso é resultado de um desejo de verdade que vem se perpetuando há séculos e que, institucionalmente, exclui de forma legítima, pelo poder que determinado discurso detém.

A ordem em que os discursos sobre a AIDS e o HIV foram e ainda são produzidos pode ser explicada pelas forças que atuam a partir do ressentimento. A cultura tradicionalista e conservadora desempenha o papel de ser o “quem” (políticos/as) e o “porquê” (instituições) que, ao deterem o poder, regulam a produção do que pode e do que não pode circular em sociedade.

De forma particular, na escola, as questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas passam por regulações quando são associadas ao sexo, à sexualidade e ao desregramento moral. Trata-se de uma percepção presente em uma parcela da sociedade, que não as reconhece como legítimas nem aceitáveis.

Morey sinaliza, com o próprio Foucault, o que ele defende ao mencionar um diálogo descrito em *Conversation with Paul Rabinow* (1971), no qual Foucault distingue a arqueologia da genealogia. A definição apresentada por Foucault é a de que a arqueologia ocupa-se da caracterização a partir da análise dos fatos, enquanto a genealogia realiza a explicação na instância da arqueologia.

Ousamos dizer que há um trabalho cirúrgico que Foucault realiza, estabelecendo linhas nas quais cada procedimento se preocupa em atuar e que, embora sigam focos diferentes, ambos se articulam.

Na tese, a arqueologia é utilizada como procedimento que nos guia a descrever, a partir dos ditos e não ditos sobre o HIV e a AIDS, a construção de um cenário em que é possível mostrar como os corpos soropositivos foram sendo produzidos, alcançando os dias atuais e a escola.

A genealogia aparece nas análises em que buscamos explicar, a partir dos dados produzidos, as relações de poder e contrapoder, a obediência e a desobediência, entre outros pares e ímpares que nos ajudam a explicar e a criar respostas para a problematização que envolve as questões do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas no contexto escolar.

Ainda em Morey (2008), sobre as periodizações do pensamento foucaultiano, há uma sinalização de riscos. Um deles ocorre ao periodizar, subentendendo que exista uma sucessão. Ou seja, ao iniciar com a arqueologia, seguir-se-ia, em substituição, a genealogia, e depois o trabalho realizado a partir das técnicas de subjetivação (o ético, visto por Díaz).

O perigo está em pensar esses procedimentos metodológicos como substitutivos, quando, na realidade, eles circulam de forma ampla e não se anulam entre si. Penso que Morey tenta dizer, por meio do exemplo, que só conseguimos assistir a uma trilogia de determinado filme se a tivermos visto em uma ordem específica, algo que, nas leituras de Foucault, não parece ser uma exigência.

Morey, ao se pautar em *The Subject and Power*, em Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow, Michel Foucault: *Beyond Structuralism and Hermeneutics* (1982), recorda qual foi o objetivo de Foucault com os trabalhos desenvolvidos ao longo dos vinte anos que se passaram.

Nas palavras de Foucault, seu propósito não foi analisar os fenômenos do poder, tampouco criar uma base para tal empreitada. O que foi feito foi uma história que fornece modos diversos de subjetivar o/a humano/a no contexto de nossa cultura.

Pautando-se nessa premissa, foi possível pensar que há pelo menos três modos que constroem e transformam o ser humano em sujeito, a partir de formas de objetificação: o primeiro, o sujeito falante, produzido pela gramática de modo geral, incidindo na linguagem, ou o sujeito produtivo, referente àquele/a que, ao desenvolver um trabalho, coopera para a economia da cultura e dos modos de existência; o segundo, a classificação do sujeito em si e/ou dos/as outros/as, fazendo-o/a um objeto; por fim, um terceiro modo refere-se à sexualidade, isto é, à forma como o ser humano se vê enquanto sujeito da sexualidade.

No contexto da tese, tentamos realizar um duplo movimento: o primeiro, de mostrar as pessoas soropositivas objetificadas e transformadas em sujeitos para a produção de subjetividades estigmatizadas; e, ao mesmo tempo, como suas vivências podem produzir subjetividades transgressoras, como outro meio possível de existência.

Assim, “o/a sujeito falante” destaca como as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas são representadas e apresentadas na escola. Por um lado, o discurso sobre tais temas pode produzir estudantes normativos. Por outro, é possível também, por meio do currículo, das aulas, das campanhas e das conversas, criar estudantes desviantes, possibilitando a produção de subjetividades que considerem a possibilidade das várias formas de prevenção e do ser soropositivo/a.

A escola, assim, estaria a desempenhar a produção de percepções inclusivas, denunciadoras de estigmas e conspiraria contra a exclusão social a partir da naturalização do saber sobre o vírus e as vivências soropositivas.

O segundo modo, relacionado à tese, refere-se ao movimento em que as pessoas soropositivas são objetificadas, pautando-se no contexto produtivo em que alguns corpos são considerados mais produtivos do que outros. Ou seja, o corpo soronegativo é visto como aquele que possui capacidades produtivas, capaz de viver na coletividade sem imputar riscos. Excluem-se, assim, os corpos soropositivos, considerando-os/as como incapazes ou como pessoas de risco.

A percepção objetificadora denunciada na tese visa provocar a escola a reelaborar seu sistema, oportunizando que ela seja um espaço para as diferenças, rompendo com as desigualdades estruturais, sobretudo quando se trata da saúde e da sexualidade como direitos dos/as estudantes.

O modo acentuado por Morey (2008), como “sujeito da sexualidade”, na tese, aparece na provocação e na resposta que tentamos construir ao mostrar como as identidades sexuais e as sexualidades são produzidas quando colocadas no contexto do HIV e da AIDS no cotidiano escolar. Sinalizamos anteriormente que as pessoas soropositivas têm como herança uma produção discursiva pautada no moralismo sexual.

A ideia que rebatemos, de que o HIV seria consequência de atos contra a moral, produz uma cultura preconceituosa e estigmatizante, assim como a noção de que a sexualidade pode ser um risco ou um perigo quando não segue os preceitos conservadores. Um currículo que pense os cotidianos e considere as diferenças possibilita criar um currículo que sorotransgrida a partir do cuidado de si para uma estética da existência.

Voltando ao que Morey (2008) discute, ao relembrar a classificação mencionada por Foucault (2019), esta é exemplificada pela divisão criada entre o ser humano dito como louco e o racional, o/a saudável e o/a patológico/a, o normal e o anormal, o soropositivo e o soronegativo; e, por fim, pela forma como o ser humano se constitui como sujeito pertencente a uma determinada sexualidade.

Em síntese, existe a possibilidade de ver, no trabalho de Foucault, dimensões do conhecimento, do poder e da subjetividade. Essas dimensões não estão determinadas a serem reconhecidas apenas dentro dos rótulos de arqueologia ou genealogia, crítica apontada por Morey (2008).

Para Morey (2008), é possível pensar, a partir da caracterização ontológica pautada no presente como força propulsora no desenvolvimento de seus estudos, três eixos principais que organizam, de forma visível, as obras de Foucault:

Ontologia histórica de nós mesmos em relação à verdade que nos constitui como **sujeitos do conhecimento** (História da loucura, Nascimento da clínica, Palavras e as coisas); Ontologia histórica de nós mesmos em as relações de poder que nos constituem como **sujeitos que agem sobre os outros** (História da loucura, Vigiar e punir); Ontologia histórica de nós mesmos em relação a ética através da qual nós nos constituímos como **sujeitos da ação moral** (História da loucura, História da sexualidade) (Money, 2008, p. 25).

O que podemos perceber até aqui é que a divergência existente entre Díaz (2012) e Morey (2008), assim como entre outras pessoas que seguem o mesmo modelo de Díaz, refere-se à divisão do pensamento de Foucault, ao considerar tais demarcações por método ou cronologia, dividindo-o em arqueológico, genealógico e ético.

No decorrer das leituras de Díaz (2012), a filósofa segue analisando cada momento a partir do mesmo entendimento de Morey (2008), relativo ao saber, ao poder, ao sexo e à ética.

Contudo, as fundamentações do pensamento e as demais questões que rebolam na dança enigmática que Foucault realiza e que penso serem resultado do que ele próprio propôs estão em provocar, desestabilizar, fazer girar e, em cada movimento, produzir outros olhares e perspectivas.

Essas, por sua vez, são próprias do pensamento filosófico, herdeiro de seus antecessores e que, ao nosso ver, não se diferem do HIV. O HIV, em sua história, tem se mostrado um provocador, questionando as pessoas quanto ao entendimento de que as diferenças não se limitam.

Na escola, o HIV é mais uma oportunidade de se colocar no território de constante disputa produtiva: saberes e ideias que promovam percepções inclusivas e o cuidado com as outras pessoas.

Veiga-Neto (2016), na obra *Foucault & a educação*, também é uma das pessoas que seguem utilizando o pensamento foucaultiano em suas pesquisas no campo da educação. Inicialmente, ele nos chama a atenção utilizando as palavras de Bourdieu, que, à época, escreveu em homenagem à morte de Foucault, afirmando que qualquer tentativa de delimitar o pensamento de Foucault em forma de manual constitui um erro, pois não alcança aquilo que o pensador se propôs: não transformar seus pensamentos em um esquema fechado a ser seguido.

Embora considere as palavras de Bourdieu, Veiga-Neto (2016) propõe-se, com muito cuidado, a situar o pensamento de Foucault de modo que possa ser lido e compreendido de forma didática, sobretudo por tratar-se do campo da educação.

As primeiras considerações que ele tece afirmam que não existe um método ou uma doutrina exata capaz de classificar o pensamento de Foucault no campo das ciências humanas.

Todavia, se pensarmos o método fora dos aparelhos que constituem tal percepção no campo cartesiano, é possível vê-lo por uma perspectiva mais ampla, entendida como uma interrogação que direciona caminhos para analisar e descrever o campo estudado.

Do mesmo modo, ele destaca que o trabalho realizado por Foucault não esteve direcionado a se tornar um modelo ou mesmo uma escola, como tradicionalmente capturamos pelas tendências normativistas.

Contudo, o pensamento foucaultiano pode, sim, ser lido e utilizado como ferramenta, servindo-nos como instrumento para sustentar nossas ousadias em pensar o presente e, sobretudo, a educação.

Enquanto Morey (2008) entende a existência de três eixos em Foucault: ser-saber, ser-poder e ser-consigo e Díaz (2012) os apresenta como etapas — arqueológica, genealógica e agente moral, Veiga-Neto (2016) segue o entendimento de Morey, porém não em termos de eixos, e sim de domínios: o ser-saber, o ser-poder e o ser-consigo.

Veiga-Neto ainda menciona Deleuze, que, na leitura de Foucault, vê seu pensamento a partir das perguntas: que posso saber? que posso fazer? quem sou eu? Veiga-Neto, ao tratar de Foucault a partir de critérios metodológicos, problematiza o último domínio.

Este não se desenvolve por meio de um novo método, como os anteriores. Ao contrário, utiliza-se tanto da arqueologia quanto da genealogia para a realização dos estudos nesse “momento”.

A partir dos domínios propostos por Veiga-Neto (2016), a tese preocupou-se em questionar o que podemos saber sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas no contexto escolar. Nessas buscas, muitas informações e saberes foram encontrados, possibilitando que nós e as pessoas leitoras adentremos o “universo” em que a pesquisa se insere.

Nosso trabalho voltou-se a nos aproximar do que foi e ainda segue sendo produzido pelos regimes de verdade nos quais o HIV é colocado. Com a pergunta “o que podemos saber?”, muitas respostas surgem. A partir delas, preocupamo-nos também com o que podemos fazer.

A intenção não foi produzir uma receita, mas mostrar campos possíveis de atuação da escola. Sobretudo, oferecer subsídios para que a escola pense e leve as/os estudantes a reconhecerem quem são: sujeitos de sexualidades, de desejos, de direitos e de tantas outras dimensões.

Não obstante, ao entender o pensamento de Foucault por uma lógica cronológica, cai-se em erro, pois ele não seguiu uma ordem cronológica, nem houve rompimentos entre as fases.

Cada fase não se restringiu a uma teoria, muito menos ao uso de técnicas de análise que se desligassem umas das outras, como as “do discurso, do poder e da subjetivação. Ao invés de separação entre elas, o que se observa claramente é uma sucessiva incorporação de uma pela outra, em um alargamento de problematizações e das respectivas maneiras de trabalhá-las” (Veiga-Neto, 2016, p. 38).

O que tentamos trazer aqui, e para que as pessoas leitoras percebam sem desanimar, é que o pensamento foucaultiano é complexo, assim como a existência humana. Tal complexidade parece ser proposital e está em consonância com o que Foucault se propôs: um pensamento que nos desacomoda.

Ao sairmos do lugar que ocupamos e no qual culturalmente nos acomodamos a ver e a estar, que percebemos as perguntas que constituem o núcleo do que nosso pensador realizou e que, de forma muito perspicaz, Deleuze (2005) também compreendeu, assim como as demais pessoas que mencionamos.

O pensamento foucaultiano visa sair dos universalismos, não se fixar e não deixar de se movimentar em torno da história, do sujeito e dos possíveis que emergem nos acontecimentos. Considerar as observações elencadas até aqui, faz-nos ver que a vida humana está posta nos jogos de poder, de contrapoderes e em tantas outras ideias que, nas linhas seguintes, podemos ampliar, cientes de que não apreendemos o todo de Foucault, mas apenas os possíveis que buscamos.

2.3 Foucault na tessitura analítica da tese

A proposta, neste momento, foi refletir a partir das diversas obras e reflexões realizadas por Foucault que utilizamos para dialogar com os dados produzidos na tese.

O primeiro texto seguirá a partir do que trataremos no primeiro estudo. Nele, buscamos trazer algumas considerações sobre a arqueologia, de forma mais detida, a partir do que Foucault discutiu em *História da loucura* (Foucault, 2019).

O segundo texto seguirá a partir do que trataremos no segundo estudo. Nesse momento, não nos detivemos apenas em Foucault, mas nos desdobramentos que seu pensamento permite, localizados em pesquisas e pesquisadores, em escritos movimentados em livros e artigos, que se alinham ao pensamento pós-estrutural.

Na continuidade, procuramos elaborar alguns comentários balizados pelos dados produzidos no terceiro estudo. Nesse momento, as obras de Foucault tiveram maior privilégio para as discussões com os dados. Ainda assim, é possível perceber que outras obras e estudos aparecerão diretamente nas discussões com os dados.

2.4 Aproximação e correlação: entre arqueologia, HIV, AIDS e pessoas soropositivas

Propomos, aqui, criar pistas para que as pessoas que peregrinarão neste estudo não se percam. Embora perder-se também seja outra forma de achar, de fazer ciência e de filosofar. De esbarrar nas obviedades que as canseiras do olhar produzem. Nos insights que os questionamentos acendem e apagam as ideias. Um movimento devir, que nos gira, nos derruba e também nos transforma. Um nós, pois as ideias nunca estão isoladas, mas em conexões.

Nesse sentido, buscaremos trazer as considerações que encontramos em Foucault (2019) e que utilizamos para nos apoiar na utilização da arqueologia, assim como as de estudiosas e estudiosos que, ao comentarem sua obra, leram e escreveram colaborando para a ampliação do que entendemos e do que não entendemos, e sobre como utilizar, seja como procedimento, como instrumento ou, quem ouse dizer, como metodologia.

É importante pontuar que não realizaremos um estudo de análise aprofundada da obra *História da loucura* (Foucault, 2019). Isso porque não é esse o nosso objetivo,

mas, sim, elucidar algumas considerações que encontramos no que tange à arqueologia e ao fazer arqueológico que Foucault realizou nessa obra.

Ou seja, nossas leituras tiveram como pretensão perceber como foi empreendido o projeto de Foucault ao utilizar a arqueologia como meio de encontrar respostas aos questionamentos feitos no decorrer de suas pesquisas. Do mesmo modo, buscamos encontrar outros estudos que, ao utilizarem a arqueologia, colaborassem para nossa compreensão e para o possível uso em nossas buscas investigativas.

Destarte, é importante destacar também que, por mais que haja aproximações entre arqueologia e genealogia, nossa intenção não é realizar um estudo genealógico. Tal delimitação fica clara na conversa entre Foucault e Rabinow, mencionada por Morey ao traduzir a obra de Foucault, ao afirmar que “a arqueologia define e caracteriza um nível de análise no domínio dos fatos; a genealogia explica ou analisa no nível da arqueologia” (Foucault, 2008, p. 16).

Pautados nessa premissa, nossa tentativa foi analisar os aspectos e as características que foram sendo produzidos acerca do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas, no intuito de verificar e confrontar o que foi dito e omitido, encontrando, na educação e na escola dos tempos atuais, a última camada de escavação e de achados.

O primeiro contato com a obra *História da loucura* (Foucault, 2019), de Foucault, ocorreu no ano de 2012, no curso de Filosofia, na disciplina de História da Filosofia Moderna II. A abordagem utilizada pelo professor era bastante provocadora, a ponto de despertar em mim o interesse em seguir outras análises e discussões propostas por Foucault, que apareceram posteriormente na pesquisa de mestrado (2018) e seguiram em outros estudos e discussões realizadas.

A *História da loucura* retorna quando, em 2024, eu participava de um evento na Universidade Aberta de Portugal que celebrava os 40 anos da morte de Michel Foucault. Entre as várias falas, houve uma que me despertou para retomar o contato com essa obra. No evento, o Professor e Doutor Gianfranco Ferraro, proferiu uma conferência intitulada *O Atlas do Conhecimento: Arqueologia a partir de um debate italiano no final dos anos sessenta*. A partir dessa fala e das discussões com as pessoas participantes, percebi uma possível relação entre o tema da pesquisa e a arqueologia de Foucault em *História da loucura*.

A ideia se concretizou dias depois, ao entrar em contato com Gianfranco. Ao nos reunirmos na biblioteca da universidade, apresentei-lhe as ideias que estavam me provocando. Em suas considerações, ele percebeu como possível a presença da arqueologia no que eu buscava realizar. Gianfranco indicou-me várias obras e convidou-me para participar, como ouvinte, de uma conferência que trataria sobre Foucault, no Centro de Estudos Globais.

Com as ideias borbulhando, comprei a obra em uma livraria próxima à Universidade Aberta, chamada Livraria da Travessa, e segui lendo-a no metrô até chegar em casa. No decorrer da leitura, pensei que a arqueologia utilizada por Foucault seguiria, no primeiro estudo da tese, como um mapa, indicando-nos pistas que nos ajudariam a consolidar os dados que almejávamos produzir.

Vasculhando o dicionário Houaiss (2011), a palavra arqueologia deriva do grego *arkhaiología*, que, em tradução ampla, sinaliza a junção entre a leitura de algo antigo, do passado, com estudo e/ou ciência. Em síntese, o propósito da arqueologia é buscar, na história do passado, algo de interesse para a compreensão ou ampliação de determinada questão, problema ou assunto no tempo presente.

Horrocks e Jevtic, em sua obra *Entendendo Foucault: um guia ilustrado* (2013), propõem explicitar vários conceitos do pensador em pauta de forma ilustrada e simples, visando ao entendimento de um público geral. Segundo o professor de História da Arte e o ilustrador e autor multimídia, a arqueologia corresponde a uma escavação voltada a investigar o pensamento de um determinado tempo do passado.

Tal empreendimento não considera apenas as pessoas e suas histórias, mas também busca, nas profundidades da escavação, conhecimentos objetivos e, por meio deles, os discursos que posteriormente produzirão aquilo a que serão aplicados, como, por exemplo, a loucura e a pessoa tida como louca enquanto produções sociais. Ou seja, trata-se de compreender como a loucura e a pessoa considerada louca foram entendidas nos mais diferentes tempos da história europeia.

O psicólogo Baltazar (2017), na releitura de Foucault (2019), contribui para o entendimento de que a arqueologia cumpre a função de questionar os perigos da atualidade, ao revisar o que não foi dito e colocar ao lado o que foi dito.

O que ambas podem nos dizer, no campo da ciência, sobre a forma como entendemos o fazer científico, a partir de uma lógica dita linear, estrutural e viciosa, que possibilita a constituição de conhecimentos que alienam e fragilizam. “Trata-se de

forçar essa fragilidade ao invés de buscar cobri-la e remendá-la; trata-se de atingir seu limite e dilaceramento ao invés de jurar sua verdade” (Baltazar, 2017, p. 876).

Em Foucault (2019), há pelo menos dois momentos da obra *História da loucura* em que a palavra arqueologia é mencionada e que foram considerados para embasar o que pretendemos realizar neste estudo.

No primeiro, ele a menciona ao afirmar que “refazer a história desse processo de banimento é fazer a *arqueologia de uma alienação*” (Foucault, 2019, p. 81). O processo de banimento ao qual ele se refere diz respeito às pessoas consideradas loucas, à forma como a sociedade foi organizada, de modo sistêmico e estrutural, para captar essas pessoas que, discursivamente, foram produzidas e, a partir daí, legitimadas para serem banidas e alienadas dos espaços sociais, encaminhadas a navios e a clínicas de internamento.

O que se apresenta é um trabalho de compreender como o banimento e a alienação são realizados, quais passos, mãos e instituições são responsáveis por esse empreendimento, aos quais a arqueologia consegue chegar.

Em outro momento, Foucault menciona a arqueologia como uma oportunidade de “interrogar-nos sobre a obscura memória que acompanha a loucura, condena suas invenções a serem apenas retornos e designa-a frequentemente como a *arqueologia espontânea das culturas*” (Foucault, 2019, p. 107).

A memória que se perpetua sobre a loucura é aquela envolta em uma nebulosidade que impossibilita ver para além do que nos foi dito e/ou ensinado. O pensador nos mostra que o evento da loucura não é algo inédito, mas uma produção resultante da cultura, construída em bases morais que, no decorrer da história, é ressignificada, seja pela lepra, pelas doenças venéreas⁸ e, onde queremos chegar, pelas pessoas soropositivas.

No entanto, em outro momento, a leitura nos alerta que “não se trata de localizar o erro que autorizou semelhante confusão, mas de seguir a continuidade que nosso atual modo de julgar rompeu” (Foucault, 2019, p. 112). Chamam a atenção as palavras *continuidade e rompimento*.

⁸ O termo utilizado não corresponde à nomenclatura utilizada no tempo atual, que é “infecção” e não “doença”. A modificação ocorreu em novembro de 2016, a partir de novas percepções e diretrizes que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a seguir e que o Ministério da Saúde no Brasil passou a adotar. O termo diz respeito a infecções que ocorrem principalmente em relações sexuais que envolvem a vagina, o pênis, o ânus ou a boca. A troca busca ressignificar, por meio da linguagem, o foco na infecção, que representa menos estigma e preconceito. Em outro momento da tese, trataremos de forma mais aprofundada.

No processo de busca sobre a loucura, Foucault identifica, a partir da ideia de continuidade, a prática de marginalização e exclusão, pela sociedade, das pessoas tidas como loucas, em detrimento da percepção de que essas pessoas sinalizavam um risco para a ordem social.

No que tange ao rompimento, marcado de forma mais evidente entre os séculos XVII e XVIII, antes havia os navios que expatriavam as/os loucas/os pelos mares e, depois, passam a ser construídas arquiteturas institucionalizadas com a intenção de internar e confinar, como um modo de higienizar a sociedade.

Outro ponto que marca esse rompimento é a inserção do papel da medicalização da loucura e a sua compreensão como uma doença que pode ser tratada pela medicina. Soma-se a isso o binário razão e desrazão. A loucura passa a ser o espaço da não existência da razão, ou seja, da ausência de “luz”, do ordenamento e, sobretudo, da civilização.

Com o rompimento, a loucura deixa de ser lida como uma característica comum da vida humana e passa a ser entendida como uma escolha, resultando em um desvio criado que deve ser corrigido.

Mais à frente, ele acrescenta que “aproximando-os, agrupando-os conforme suas linhas de semelhança, tem-se a impressão de que duas experiências da loucura se justapuseram nos séculos XVII e XVIII” (Foucault, 2019, p. 117).

As duas experiências mencionadas pelo filósofo dizem respeito à *experiência trágica*, localizada na Idade Média e no Renascimento, e à experiência clínica. O trágico é conjugado ao divino, ao sobrenatural, em que a loucura era uma característica do indivíduo dotado de sabedoria, advinda de uma verdade revelada pela divindade oculta.

A outra é a *experiência clínica*, que estabelece, a partir da medicina, o diagnóstico que classifica a pessoa tida como louca, a qual também é tratada e, então, curada. A loucura passa, assim, a ser entendida como o antônimo da razão.

Em outro momento, no contexto da arqueologia, Foucault (2019) sinaliza pontos que, ao longo da leitura e da reflexão, foram tecendo uma teia de sentidos para o entendimento do uso da arqueologia como um caminho de descobertas que a história talvez tenha ocultado. Ao ler as palavras do arqueólogo, escutei-as como um conselho, indicando que, para o empreendimento que estávamos interessados em realizar, seria importante olhar para a história,

isolando as cronologias e as sucessões históricas de toda perspectiva de ‘progresso’, restituindo à história da experiência um movimento que nada toma emprestado do conhecimento ou da ortogênese do saber – trata-se de deixar aparecer o desenho e as estruturas dessa experiência da loucura [...] Essa experiência não é nem um progresso, nem um atraso em relação a alguma outra (Foucault, 2019, p. 125).

Alguns aspectos da fala de Foucault são pertinentes para ampliarmos o sentido da arqueologia: a *rejeição da linearidade*, ou seja, de narrar a história como um processo em linha reta e contínuo, no qual os fatos e acontecimentos seguem na direção de um progresso, como se a história avançasse sempre para frente.

A partir da leitura, percebe-se uma *crítica a essa ideia de progresso* aplicada à história. Isso implicaria dizer que a história dos acontecimentos caminharia, necessariamente, para a melhoria da humanidade e da vida em sociedade, o que não se confirma. No caso da loucura, essa ideia torna-se evidente: não houve uma melhora em seu entendimento.

Outro ponto diz respeito à forma como o pensamento é estruturado. As instituições, como a Igreja, o governo, a jurisdição, a medicina, utilizam-se de seu poder para moldar a experiência da loucura, rompendo com o modelo cronológico que tradicionalmente orienta o fazer histórico da humanidade.

Ao lado do pensamento estruturado, é colocada em discussão a noção de episteme, que visa elaborar conceitos e práticas aplicados nos diferentes períodos da história. Para Foucault (2019), a episteme funciona como um quadro que emoldura a loucura a partir dos conceitos e/ou pressupostos criados em torno da ideia que se produziu sobre ela.

Outros dados importantes que complementam a compreensão da arqueologia, e que Foucault (2019) sinaliza, são tratados por ele a partir das leituras dos acontecimentos da história da loucura, identificando, por um lado, a complexidade e as indefinições dos próprios conceitos e ideias formulados nos diferentes tempos da experiência da loucura, como elucidamos anteriormente.

A crítica à objetividade histórica, rejeitada em sua empreitada, leva-o a constatar que a formulação do que temos como história parte de um modelo de construção amparado pelo presente, reafirmando a perspectiva de progresso defendida pela historiografia.

O professor e filósofo Roberto Machado, em sua obra *Foucault: a ciência e o saber* (2006), faz considerações sobre a obra de Foucault (2019) que nos ajudam a compreender a proposta arqueológica.

Machado afirma que a arqueologia é uma proposta de conhecimento mais aprofundada do que a ciência. Isso se deve ao fato de não ser seguida como um método nos moldes aos quais estamos acostumadas/os, com princípios direcionadores que conduzem a um resultado previamente estabelecido.

Sobretudo no contexto em que a pessoa considerada louca era discursivamente produzida, a percepção do que se tinha como sendo a/o louca/o determinava seu banimento ou sua internação.

Nesse sentido, o que se realiza é uma *arqueologia da percepção*, pautada naquilo que as instituições sociais criaram em relação à loucura e em como isso estava relativamente associado às questões sociais e culturais daquela época, e não propriamente à experiência da loucura em si.

Ressalta-se que não se deve restringir a arqueologia a um método. Contudo, se a considerarmos como tal, a arqueologia se caracterizará “pela variação constante de seus princípios, pela permanente redefinição de seus objetivos, pela mudança no sistema de argumentação que a legitima ou justifica” (Machado, 2006, p. 51).

De forma mais direcionada em sua obra, no primeiro capítulo, intitulado *Uma arqueologia da percepção*, Machado (2006) dialoga com alguns dos pontos apresentados por Foucault (2019) e que trazemos aqui.

Quando Foucault menciona o processo de alienação e, por meio dele, a arqueologia, Machado explica que a história, ao ser escrita pelos moldes do progresso e ao considerar o mundo como palco das ações sociais que o ser humano realiza e das quais se constitui, ao afastá-lo/a desse mesmo mundo, cria-se um caminho possível para a produção da loucura.

Isso porque, se antes a loucura era entendida como falta de razão, com a alienação cria-se o afastamento da própria natureza humana enquanto ser social, desconfigurado/a de suas características sensíveis, de seus desejos e de sua imaginação.

Do mesmo modo ocorre com a experiência trágica, vista como a primeira experiência que o ser humano tinha consigo mesmo. Suas características ligadas ao sagrado inserem um território de mistério, não capturado pela razão.

O trágico em relação com a loucura desafia o oculto que ela guarda e que a razão não consegue alcançar. O fato é que essa experiência tornou-se alvo da razão ao ser colocada dentro do rol das classificações que caracterizam a loucura (Machado, 2006).

Pensando ainda com a ajuda de Machado (2006, p. 77), “em História da loucura, ‘arqueologia’ tem o sentido preciso e restrito de investigação de condições de possibilidade mais profundas do que as dadas no nível do conhecimento, da ciência”. Tal proposição nos indica mais um ponto de atenção: o distanciamento do fazer histórico sob os moldes epistemológicos.

A loucura é o ponto de chegada que Foucault busca, e sua análise direciona-se à condução dos discursos heterogêneos que a produzem. O que interessa a Foucault é a percepção, e não o conhecimento produzido sobre a loucura. Ou seja, a percepção “é um lugar aquém do ‘conhecimento’; lugar que não só lhe é anterior e sobre o qual ele repousa, como é superior, isto é, prioritário para desvendar sua verdade, para descobrir seus reais objetivos” (Machado, 2006, p. 77).

Por fim, sem esgotar as contribuições de Machado (2006), cabe-nos observar o que Foucault (2019) sinalizou em História da loucura sobre a descontinuidade histórica, que insere o que apontamos anteriormente acerca da rejeição do progresso, da linearidade e da objetividade. A história da loucura elaborada por Foucault recorta os períodos Renascentista, Clássico e da Modernidade. Nesse recorte da história humana, observam-se, ao menos, dois momentos de ruptura, que em Machado (2006) são apresentados por meio de três características.

A primeira é descrita por Machado (2006) como uma época marcada pela heterogeneidade. Isso se evidencia ao ilustrar, com o exemplo já elucidado, a experiência trágica que é substituída pela consciência crítica em torno da loucura no período do Renascimento.

Outros fatos que potencializam essa heterogeneidade, apontados nas obras, são as formas como se institucionaliza a reclusão da loucura. Para isso, há o hospital e o chamado Grande Enclausuramento (Machado, 2006, p. 79) e, antes, as *Stultifera Navis*, os navios que levavam as pessoas ditas loucas a perderem-se nos mares.

A segunda característica elucidada por Machado (2006) é descrita como rupturas verticais. O trabalho arqueológico que Foucault (2019) empreende não visa separar a ciência e seu funcionamento no que tange aos procedimentos, de forma específica, entre o que é interno e o que é externo às análises realizadas.

Ao contrário, mostra a existência de relações em diversos níveis que incidem sobre a produção da loucura, como, por exemplo, as práticas sociais e econômicas. Anteriormente, sinalizamos a relação do internamento com o trabalho e como as instituições executam a tarefa de imprimir uma economia que exclui e, nos espaços de exclusão, utiliza o trabalho como forma de purificação, de tratamento, de retorno ao eu racional.

A terceira característica apontada por Machado (2006) diz respeito ao fato de não haver uma ruptura absoluta entre as diversas épocas no que foi produzido sobre a loucura. Ou seja, “as teorias e práticas de uma época dependem do que passou, no sentido de que há sempre condições de possibilidade antecedentes” (Machado, 2006, p. 79–80).

O que temos hoje, o controle social da pessoa tida como louca, é resultado das tentativas fracassadas de épocas passadas, da desrazão à doença mental.

Em suma, o que se buscou fazer em História da loucura foi evidenciar uma *história do encobrimento*, e não do descobrimento, ao sinalizar a loucura como ameaça e perigo à sociedade, a partir de seus moldes morais.

Não se trata de uma história delimitadamente da ciência, no horizonte de uma proposta epistemológica, e, por isso, não se considera, na História da loucura, com a arqueologia, um fazer histórico linear, contínuo e baseado em rupturas (Machado, 2006).

Outra contribuição para ampliarmos o entendimento sobre a arqueologia em História da loucura vem com a filósofa Díaz (2012). Ao comentar os escritos de Foucault (2019), ela destaca alguns pontos que consideramos relevantes.

A primeira ideia apresentada é a de que, pelo trabalho arqueológico, é possível perceber outros modelos que formaram diferentes épocas e contextos históricos. São camadas que podem ter sido encobertas e que, na escavação arqueológica, permitem perceber continuidades e ligações entre diferentes períodos da história.

Contudo, ela ressalta que a existência dessas camadas e de suas ligações não diz respeito à ideia de progresso, a partir de uma percepção histórica pautada na linearidade, como temos acompanhado com Foucault (2019) e Machado (2006), mas, sim, a uma história caracterizada por tensões, que visa perceber o não dito, o silenciado.

A leitura que Díaz (2012) faz de História da loucura é a de que Foucault (2019) realiza uma “*história do diferente*”. Ou seja, ela entende que a história elaborada por Foucault é a história da produção do/a outro/a, da exceção, da representação do que é considerado diferente.

No espaço social constituído por regras, assentadas em bases morais, a loucura aparece como a fuga de toda regra. Isso se evidencia por não seguir o fazer histórico pela superfície característica da história da ciência.

A arqueologia cumpre o sentido de fazer vir à tona o visível e o dizível. O visível é aquilo que se pode ver da loucura, por exemplo, a reclusão. O dizível está associado ao que determinada época postula como conhecimento; no caso da loucura, trata-se do que se produziu sobre ela, e não do que ela é.

Implica, pois, em “camadas sedimentadas que constituem positivamente a serem desenterradas” (Díaz, 2012, p. 18), nas quais a arqueologia se interessa em cavar e ver o que não foi visto, percebido ou que permaneceu escondido.

O historiador Veyne, em sua obra *Foucault: o pensamento, a pessoa* (2008), no capítulo “*Arqueologia*”, colabora com a proposta de Foucault ao afirmar que a história humana é a história das discontinuidades.

Cada época coloca questões pertinentes a seu contexto, do mesmo modo que as respostas que damos ou encontramos são próprias de cada contexto em que foram produzidas. Isso implica pensar que aquilo que entendemos como real está sempre na possibilidade de não ser o mesmo.

Ao ler Veyne (2008), encontro em suas palavras um alento: o desejo de apreender as coisas em sua totalidade é uma tarefa impossível. Por mais que a ciência tente, a leitura que temos sobre as coisas como foi o caso da loucura e dos escritos de Foucault está e estará no campo da modificação, ao descrever a partir do que já foi descrito.

Em suma, o que Veyne nos diz é que “as palavras não se reduzem ao seu sentido, à função de serem espelhos: a sua matéria sonora era mais que um detalhe, mais do que um grão espesso na fotografia verbal das coisas” (Veyne, 2008, p. 62).

O estudo e a leitura de Foucault nos aproximam das relações entre o que o pensador desvelou sobre a loucura e a construção da/o louca/o, e as questões do HIV/AIDS e das pessoas soropositivas. Essa percepção se evidencia quando Foucault menciona, por exemplo, o papel da Igreja Católica e do governo no século XIII, ao lerem a lepra como algo que “apraz ao Senhor que estejas infestado por essa doença,

e te faz o Senhor uma grande graça quando te quer punir pelos males que fizestes neste mundo” (Foucault, 2019, p. 6).

A lepra é sinal de um marcador no corpo para a exclusão, o preconceito e o estereótipo. Na tentativa de produção de iguais, a lepra fissa a heterogeneidade. Não pela possível doença que a caracterizaria, mas por uma consequência pecaminosa da transgressão do livre-arbítrio, em que Deus julga, mas também perdoa, desde que o corpo retorne às condições de obediência.

Um castigo que o pai impõe a seu filho quando ele não obedece às suas regras. Um deus-pai-homem, repleto de sadismo, de um desejo de criar, pelo sofrimento (a lepra), uma forma de reparação, pela satisfação de perdoar e produzir o sujeito submisso.

Com o passar dos anos, no decorrer do século XVI, a lepra desaparece, seja por uma possível cura, seja pela eliminação desses corpos, abrindo espaço para que outra personagem apareça em sociedade: as doenças venéreas.

Embora tenham se passado séculos, a percepção mantém certa linearidade, mesmo utilizando-se de práticas de tratamento para lidar com a doença. A percepção que se tinha e que ainda hoje se mantém, em maiores ou menores proporções é a de um “conjunto de juízos morais” (Foucault, 2019, p. 8) como sintomas ou como a encarnação da doença no corpo desobediente.

Há, assim, uma ressignificação do objeto lepra para as doenças venéreas, mantendo-se os modos de lidar do passado e ampliando-os, de forma a preservar a percepção da doença como resultado do mal moral encarnado no físico.

Na substituição das doenças venéreas, a loucura ocupa o espaço de justificação dos problemas resultantes do comportamento imoral. Foucault (2019) nos possibilita ver os processos que constituem a produção da loucura.

A forma como a sociedade passou a se organizar, ao longo desses tempos, foi a de se constituir como uma arquitetura social que classifica os corpos nos espaços e tempos, nos graus e níveis, de modo a possibilitar a dispersão e a contenção dos corpos adoecidos pela transgressão moral.

As arquiteturas que antes foram construídas para abrigar essas pessoas renegadas pela sociedade, como forma de higienizar os espaços públicos e privados, passam a ser as clínicas de internamento. Nelas, seus males espirituais são purgados pelo corpo, com vistas à reinserção no mundo do trabalho, sobretudo quando essas e esses não cumpriam a função social de produção do capital.

Na concepção do contexto analisado por Foucault, a percepção da miséria era resultado da desordem social. Ou seja, a pobreza mantinha relações intrínsecas com a ideia de vício, sendo os ditos “vagabundos” uma forma de renomear todas aquelas pessoas que ocupavam o papel tanto das pessoas leprosas quanto das acometidas pelas doenças venéreas.

Foucault as descreve como “doentes venéreos, devassos, dissipadores, homossexuais, blasfemadores, alquimistas, libertinos: toda uma população matizada se vê repentinamente, na segunda metade do século XVII, rejeitada para além de uma linha de divisão [...]” (Foucault, 2019, p. 102–103).

O que acabamos de elucidar, em parceria com Foucault (2019), é que a produção da loucura é percebida como um perigo para a sociedade, que, ao tecer critérios sobre o que poderia e o que não poderia ser rompido, fez com que “a loucura e o louco tornaram-se personagens maiores em sua ambiguidade: ameaça e irrisão, vertiginosa desrazão do mundo e medíocre ridículo dos homens” (Foucault, 2019, p. 13).

As relações que mencionamos anteriormente alcançam aqui seu ponto inicial, o que posteriormente ampliaremos com os achados das escavações. O HIV e a AIDS constituem a continuidade do que foram a lepra e as doenças venéreas.

O problema não se centra na doença enquanto um mal que ocasiona sofrimento ao corpo individual e social, mas, sim, em um problema de cunho moral, de transgressão às regras que, historicamente, buscaram-se preservar para manter o *status quo* na disciplinarização do corpo e das subjetividades humanas.

As pessoas que vivem soropositivas revelam certas verdades, assim como a loucura revelou na sociedade daquela época: um desejo de poder amparado pelo discurso da verdade sob a razão, em contraposição à desrazão.

O corpo humano é suscetível à sua limitação, pode ser afetado e estar corrompido e, por mais que “fuja”, o desejo produz uma verdade que negamos: todos somos e estamos passíveis de vivenciar a experiência da loucura, assim como de ser soropositivos/as.

Não há verdade que se sustente na possibilidade enquanto futuro, em um ser devir que nos transforma no outro que negamos, do qual fugimos e que não aceitamos como realidade possível de nos alcançar.

Ora, as pessoas que vivem soropositivas nos colocam, enquanto seres humanos, diante da fragilidade, da miséria e da maldade humanas. Tal verdade tem

seu peso diminuído pela alienação produzida por categorias religiosas falaciosas, que ilusoriamente despistam a consciência na aceitação de que há vidas nas mais diversas formas, inclusive as soropositivas.

Nossa atenção à obra e ao que a arqueologia pode produzir em nós está no fato de que Foucault (2019) nos aponta dois lados da história: um que narra os fatos da história relacionada à loucura, à pessoa tida como louca e às suas relações, no sentido de nos fazer ver como, naquele tempo, a loucura e a pessoa louca eram percebidas; e outro que nos permite ver como a loucura e a pessoa louca constituem a possibilidade de um outro olhar, para além dos fatos descritos como verdadeiros.

A construção da verdade é erigida por conceitos e ideias pré-definidas que emolduram as pessoas, subtraindo a experiência enquanto condição de toda pessoa vivente, em vista de um universal, por vezes, compulsório.

Foucault perspicazmente percebe que as bases que constroem a verdade da loucura advêm da herança moral. Pela moral, constrói-se a verdade do/a louco/a como uma forma de castigo, em que todas aquelas pessoas que subvertem as prescrições da ordem ou seja, que questionam a verdade ao se desmoralizarem das condutas são alcançadas pelo enquadramento do mal, do patológico, do anormal, como causa ou consequência do ato-ação do viver.

Não muito diferentes, essas relações podem ser percebidas quando vistas no contexto da epidemia de AIDS. As pessoas que inicialmente levaram a culpa, criando sobre elas a gênese do mal que se eternizou na sociedade, foram aquelas que desobedeciam ao poder exercido que, historicamente, perpetuou a concepção do que é razão e desrazão e, agora, do que é soronegativo e soropositivo.

A busca por fazer com que o/a “diferente” seja controlado/a, no intuito de transformá-lo/a em um/uma “mesmo/a”, permite pensar que a AIDS encontra aqui seu problema: não pode transformar-se no mesmo, mas, sim, implodir o mesmo em uma nova concepção do que seja o/a mesmo/a.

Até aqui, a proposta foi situar as pessoas leitoras no contexto em que a utilização da arqueologia não foi aleatória. Ela precede da experiência, das leituras e da pesquisa, ao nos depararmos com possibilidades de busca que fogem do comum, não pelo ineditismo ou pela novidade.

Nossa intenção se dá pela aventura de tentar contar por outras perspectivas, mostrar outros achados, ver e analisar por outros ângulos, sentimentos, anseios e, até mesmo, novas saídas e estratégias para campos possíveis de fazer pesquisa.

O que propusemos aqui foi criar um horizonte de possibilidades sobre a arqueologia a partir da obra *História da loucura*, de Foucault (2019). Por meio dela, traçamos rotas possíveis tanto pela leitura da obra quanto pelas leituras de outras pessoas que também a estudaram e cujos entendimentos, ao serem somados, clarificam como seguimos no primeiro estudo.

Não estamos aqui tentando criar um método, mas utilizar as pistas deixadas por Foucault (2019) e por suas/seus comentadoras/es. Entendemos que, ao se tratar de Foucault, a regra é não ter uma regra e isso não significa ausência de rigor. Nas páginas seguintes, continuamos a apresentar às pessoas leitoras alguns conceitos e ideias elaborados por Foucault, juntamente com o pensamento pós-estrutural, que nos serviram para análise e discussão no segundo estudo da tese.

2.5 O fio e a dobra: por uma leitura pós-estrutural⁹

Propomos tecer, aqui, algumas linhas que possam dar um panorama do que vem a ser uma possível caracterização pós-estruturalista, que, junto ao pensamento foucaultiano, balizamos nas discussões com os dados produzidos no segundo estudo.

Ao lermos sobre as produções que tratam do pós-estruturalismo, é possível percebê-lo mais pelo que não é do que pelo que é. Isso não implica negação, mas mudança nas direções ao problematizar e analisar o mundo, a pessoa e o contexto em que os acontecimentos ocorrem.

Na direção do que não é, o pensamento pós-estrutural não segue o caminho de um entendimento pautado na universalização da verdade. A verdade é como um zoom feito em determinado recorte de uma região, considerando o contexto cultural e histórico em que é produzida.

Ao lado dessa lista do que não é, o pensamento pós-estrutural rejeita o postulado da pessoa como um conceito único, herança da modernidade. Além disso, outras negativas se destacam: o não uso de perspectivas dicotômicas e binárias, hierarquizadoras, que resultam em exclusões. Soma-se a isso a linguagem como produtora do múltiplo; logo, não há um único significado capaz de descrever a totalidade.

⁹ Estamos tentando utilizar os termos pós-estrutural e/ou pós-estruturalista para fugir dos ismos como sufixo que acenam para ideias associadas a noções de doença.

Nessa rede, o pós-estrutural considera a história como um campo em que são produzidos saberes, dados por regimes de verdade, nos quais se constroem os discursos e, por meio deles, as relações de poder e as subjetividades.

Assim, o pós-estrutural não é algo fixo, mas uma linha de pensamento que compreende as diferenças, o múltiplo e a possibilidade de estar em constante modificação, seja nas identidades, nas subjetividades ou no que significa o mundo e tudo o que nele possa existir.

É nesse sentido que se liga a nossa pesquisa, por “entender” e criar campos possíveis de problematização sobre o contexto do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas na escola e na educação.

Um dos primeiros trabalhos que acessamos e que nos subsidiou foi a tese de doutoramento de Dentz (2015), intitulada *As tendências pós-críticas na pesquisa em educação: análise filosófica e crítica ontológica*. A parte que nos interessou foi a discussão estabelecida sobre a questão pós-estrutural e as referências utilizadas, que serviram para ampliar nosso entendimento.

Em síntese, para o autor, a vertente pós-estruturalista centra-se no modo como as questões linguísticas, somadas às discursivas, advindas do pensamento estruturalista, estão inseridas nas questões culturais e sociais da vida humana.

A linguagem, na produção discursiva do contexto pós-estrutural, é instável. Cada pessoa está atravessada por relações de poder advindas de estruturas que a moldam. O discurso produzido sobre o HIV/AIDS e sobre as pessoas soropositivas não é neutro; ao contrário, é permeado de intenções que visam produzir, a partir dos discursos, meios e formas capazes de criar uma visão distorcida da realidade vivenciada pelas pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Não obstante, a própria percepção social produz discursos e organiza as relações entre os corpos/pessoas, estabelecendo proximidades e distanciamentos, a depender dos propósitos nos quais o contexto social esteja interessado. O ser que as pessoas soropositivas são passa a ser aquilo que o contexto social produziu como cultura que as naturaliza, e não aquilo que realmente elas são. A escola, nesse jogo, é desafiada a romper com as possíveis reproduções que espelham a sociedade (Dentz, 2015).

No debruçar da obra de Peters (2000), *Pós-estruturalismo e filosofia da diferença: uma introdução*, observa-se que um dos possíveis movimentos que deram início ao pós-estruturalismo ocorreu na França, em meados dos anos de 1960. As

bases para a elaboração do que ousamos chamar de pensamento pós-estrutural estão presentes nas obras de filósofos como Nietzsche e Heidegger.

O fato de dizermos que ousamos chamá-lo de pensamento deve-se a compreendê-lo como algo em movimento, não estático. Isso porque Peters destaca que o pós-estrutural não deve ser visto como homogêneo nem como um complexo teórico fechado; tampouco como uma escola ou uma realidade que antecede, muito menos como algo restrito a um método.

O pós-estrutural situa-se na linha de um pensamento peculiar, tanto no modo de filosofar quanto no de materializar a escrita. Isso resulta do fato de estar inserido em uma rede interdisciplinar que produz olhares múltiplos, por reunir diversos modos de ver e pensar a realidade, materializados em análises originais que buscam romper com produções universalizantes delegadas como verdades.

Logo, entre os interesses do pensamento pós-estrutural está o de propor críticas, de forma particular, a instituições como “a família, o Estado, a prisão, a clínica, a escola, a fábrica, as forças armadas, a universidade e até mesmo a própria filosofia” (Peters, 2000, p. 34).

Nas teias tecidas por Peters, o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, ao estarem presentes de formas diversas nas várias instituições, provocam o olhar a ver para além dos campos possíveis já projetados. São novos corpos, com outras subjetividades, em tempos diversos, mas que, ainda assim, podem estar sob o mesmo jogo dos regimes de verdade produzidos ao longo do tempo.

A análise e a crítica funcionam como ferramentas do pensamento pós-estrutural, possibilitando ver os rompimentos, as continuidades e as brechas para instaurar novos regimes de verdade, produzidos não sobre os corpos soropositivos, mas por eles, em seus ditos e escritos, no e para o contexto escolar.

Moraes (1996), ao tratar do pensamento pós-estrutural, destaca que a posição generalista não consegue se sustentar por considerar o conhecimento como resultado de produções feitas ao longo da história. Em cada período histórico, há uma cultura, uma verdade, um saber, um poder e intenções que se materializam no discurso.

O campo em que o pós-estrutural se insere é diverso. Não há uma visão única e fixa que possa dizer e determinar o resultado daquilo que se pretende analisar. As mudanças ocorrem e, no transcurso, se modificam, e com elas o olhar também.

Silva (2000) defende que a teorização baseada no pós-estrutural movimenta-se na busca de significados, considerando processos inflexivos, incertos, que não sejam deterministas e/ou que possam ser inconstantes.

Veiga-Neto (1995) reitera que a retirada do/a sujeito/a do centro da análise implica entendê-lo/a no interior das relações sociais, políticas e culturais. Isso resulta, pois, em demolir uma ideia anteriormente fabricada do/a sujeito/a.

Nas palavras dos teóricos e comentadores, no contexto do HIV/AIDS e das pessoas soropositivas, a generalização constitui um pensamento único que engaveta as singularidades produzidas em cada sorovivência. A generalização opera como uma estratégia de acorrentar as vivências e, ao não considerá-las em suas singularidades, limita-as aos discursos pré-fabricados.

Esse desentendimento que o pensamento pós-estrutural estabelece com a forma de pensar generalista é o entendimento que nos une ao nos propor considerar a multiplicidade dos contextos do HIV/AIDS, das pessoas soropositivas e das escolas.

Algumas ideias que somam e nos ajudam a compreender e/ou a assumir posições que colaboram com a leitura a partir do pensamento pós-estrutural também são desenvolvidas por Williams, na obra *Pós-estruturalismo* (2012).

A ideia que Williams defende é a de que, para o pensamento pós-estrutural, não há um dado prévio que se insira como limite para o conhecimento. Cada pessoa soropositiva, por exemplo, é, por si só, um conhecimento que independe de repetições, comparações ou quantificações que resultem em dados capazes de dizer sobre ele/ela de forma concluída, única e verdadeira.

Questionando a corrente de pensamento “tradicional”, o pensamento pós-estrutural problematiza as normas pré-estabelecidas. Aceita e considera os desvios como parte dos conhecimentos que podem ser produzidos por estarem na “realidade” e que podem muito nos ensinar.

Ou seja, o limite do conhecer está inserido no interior do que conhecemos e, por isso, há a limitação de não poder apreender o todo nem criar uma verdade que possa universalizar as pessoas soropositivas.

Williams (2012) ainda afirma que o limite, para o pensamento pós-estrutural, é aberto e não pode ser plenamente compreendido, pois estamos formados em uma cadeia de modelos que fixa nosso olhar a uma base aplicada. O que pode ser feito é conhecer na condição de estarmos no tempo.

Aquilo que sabemos enquanto identidade, história, saber e linguagem muda, por não estar amparado no que é fixo, inteligível, progressivo, entre outros. A ruptura que pode caracterizar o pensamento pós-estrutural não se dá no sentido que comumente lhe atribuímos, como algo negativo.

O pensamento pós-estrutural não se coloca sob a balança em que, de um lado, estaria a favor e, de outro, contra aquilo que se propõe analisar. Antes, afirma a existência de um poder que visa produzir, de forma inflexível, limites; por isso, é subversivo, ao também realizar oposições às formas estabelecidas, seja pelos sujeitos, pelas visões de mundo ou por tantas outras.

Isso nos permite afirmar que o conhecimento “legítimo” sobre as pessoas soropositivas não está naquilo que foi externamente construído, pautado em percepções estereotipadas, preconceituosas e em tantas outras que apagam os próprios ditos das pessoas soropositivas.

Costa (2007), ao tratar do pós-estrutural, compreende-o como uma ferramenta que nos auxilia a romper com o modo como analisamos aquilo que pretendemos estudar. A visão binária, quando aplicada como modelo, cria uma fronteira que não aceita aquilo que escapa aos limites impostos.

São os valores de bem e mal, as identidades homem e mulher cis, o verdadeiro e o falso, o soronegativo e o soropositivo, entre outros, que produzem hierarquizações, resultando em relações de exclusão, preconceito e subalternização.

Veiga-Neto (2007) menciona o pensamento pós-estrutural como uma possibilidade de ver o não visto. A forma estabelecida de conhecimento, dada por regras e por contornos gerais previamente definidos, ao se impor, exclui outros saberes pela via da inteligibilidade. Há uma relação entre o que olhamos e o que produzimos. Aquilo que conhecemos, sobretudo no campo do social, são fabricações. O que podemos conhecer é, no máximo, um recorte, pontos específicos que nos ajudam a ampliar nossas visões sobre o mundo.

A perspectiva do pensamento pós-estrutural no campo da educação possibilita questionar a forma como a educação e a escola são compreendidas, por criarem certos padrões que excluem as diferenças, e, aqui, destacamos as questões do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Ao construir políticas e currículos de modo compulsório, estes são erigidos sob critérios tradicionalmente postulados por saberes considerados “legais” e, assim, a mesma linha que cria essa noção é também aquela que exclui.

O corpo que não se adequa, a subjetividade que questiona, os assuntos tratados em sala de aula que não correspondem à realidade das vivências de jovens e adolescentes, entre tantos outros, constituem interesses do pensamento pós-estrutural, ao indagar e perceber os sistemas de poder que operam em torno da escola, como o muro que a resguarda e que, ao mesmo tempo, exclui.

Desse modo, ao pensar as questões do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas balizadas pelo pensamento pós-estrutural, encontramos a possibilidade de pensar um novo sujeito e outras formas de subjetivação.

A escola, assim como a educação, podem operar com o entendimento de pensar aquilo que antes não foi pensável: o corpo como um campo político ilimitado, sem silenciar as sexualidades e as identidades de gênero e/ou generalizar as realidades e omiti-las por meio de discursos rarefeitos sobre o que a escola pode e o que não pode. O currículo e a escola são locais que produzem e dão existência às relações de poder que coexistem na sociedade e nas instituições a ela ligadas.

Na continuação, seguiremos com algumas ideias de Foucault. Nossa intenção não é realizar um tratado sobre o pensamento foucaultiano, mas apresentar alguns comentários para que, a partir das ideias de Foucault e de autores e autoras que com ele se alinham, possamos balizar as discussões com os dados produzidos no terceiro estudo.

2.6 Isso não é um manual: retalhos que costuram a colcha de possibilidades dos dados-falantes para o terceiro estudo da pesquisa

As considerações que realizamos aqui referem-se a algumas ideias de Foucault em diálogo com os dados do terceiro estudo. Na leitura dos dados, foi possível remediar as falas-dados entre as falas-teorias.

Essas conversas acontecem a partir de assuntos que perpassam as construções de identidades, de corpos, da pessoa nomeada como doente, da sexualidade, da patologização realizada no uso do sexo e de tantas outras questões que emergem das problematizações em torno do HIV, da AIDS, das pessoas soropositivas, da escola, do currículo e da educação. Antes de trazermos essas reflexões, destacamos que não nos propomos a esgotar as ideias utilizadas nas discussões.

O que realizaremos neste momento é uma reflexão sumária, que será aprofundada de forma mais detida nas análises dos dados produzidos. Preocupamo-nos em fazer da teoria um amplificador dos dados-falantes, os quais se sintetizam em cinco eixos de discussão:

Eixo 1: Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?; Eixo 2: Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?; Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo; Eixo 4: Quando a aula produz medo, e não cuidado: discursos escolares na voz de pessoas soropositivas; Eixo 5: A arte de reinventar a si mesmo: invenções para o currículo sorotransgredir.

Eixo 1: Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?

É sabido que, na obra *O nascimento da clínica*, Foucault (2021) segue utilizando a arqueologia em suas análises. Parece-nos que sua preocupação não foi focar no que se entendia como loucura ou na ideia de doença mental, mas, sobretudo, analisar a produção da doença no contexto da medicina moderna, por volta do século XIX.

De antemão, deixamos claro que não realizaremos todo o percurso empreendido por Foucault. Faremos apenas alguns comentários que nos provocam a pensar o tema da tese. E, com esse “critério”, propomo-nos, de forma coesa, a prestar atenção ao que Foucault escreve sobre *o olhar médico, a doença enquanto construção social e a objetificação do corpo* (Machado, 2006).

Para isso, é necessário, antes, situarmos a produção dessas ideias em seu contexto de acontecimentos e percepções. Ao observar a obra de Foucault (2021), é possível perceber que as continuidades históricas da medicina traçam uma linha que situa a medicina natural, localizada no período clássico.

O modelo seguido baseia-se nas classificações, do mesmo modo como eram realizadas nas demais instâncias da vida. Nesse momento, a definição de doença é feita a partir do visível, daquilo que pode ser observado na superfície.

Não havia interesse em adentrar o oculto, o escuro que os tecidos do corpo protegiam. A maneira como se desenvolve a ideia de doença caminha pelas luzes

daquilo que pode ser observado na superficialidade do corpo. Podemos dizer que a verdade criada sobre a doença é construída pelas aparências e pelos sintomas.

Dada a identificação pelo que o corpo mostra (o que se vê) e pelo que ele fala (dores, febres, sintomas), torna-se possível identificar a doença como resultado da classificação do visível (Machado, 2006).

Outro ponto que é possível afirmar, nesse momento, é que a doença é sinônimo de desordem, uma vez que a saúde é compreendida como a ordem que mantém a vida. A concepção produzida sobre a doença é construída pela classificação, que, por essência, definirá a doença a partir do quadro de sintomas previamente elaborado, como, por exemplo, no Manual de Classificação de Doenças (CID).

Por meio dele, imprime-se o dispositivo visual médico que gerencia e organiza os corpos de acordo com os sintomas e o perfil da pessoa, reduzindo-a a estilos de vida e classificando-os como “normais” ou “patológicos”.

Para diagnosticar os corpos soropositivos ao HIV, estes são inseridos em processos de classificação. O visível torna-se o identificável como parte integrante da realização do exame e do diagnóstico geral.

Um corpo que se apresenta com magreza, por exemplo, pode somar-se ao conjunto de sintomas e sugerir que determinada pessoa esteja com AIDS. Ao mesmo tempo, isso também pode construir percepções de preconceito e estereotipação, ao nomear esse mesmo corpo, a partir do sintoma, como doença, nomeando-o por “aidético”.

No salto do tempo, a percepção da doença, pela medicina moderna, é construída com o nascimento da clínica. Com a clínica, torna-se possível produzir representações a partir dos casos estudados, pelos exames e análises que vão desenhando o quadro no qual o doente se encaixa.

A doença passa a ser resultado daquilo que é desenvolvido ao se subtrair da pessoa doente. A medicina, assim como o olhar médico nesse momento, tem como função reunir elementos do corpo sensível e inseri-los no quadro nosográfico. O papel da clínica não é o de ser uma ferramenta na busca de verdades ocultas, mas um espaço de aplicação da verdade anteriormente já estipulada de forma sistemática (Machado, 2006).

A pessoa doente ocupa a função de modelo da ocorrência das doenças. Isso se dá a partir das identificações apresentadas pelo corpo visível e não apenas pelas

queixas relatadas pela própria pessoa doente. Quando as queixas não representam o quadro das identificações, é possível que sejam criadas outras e novas classificações de verdades, que passarão a ser aplicáveis a outras pessoas, como ocorreu com aquela em que foram descobertas.

O corpo torna-se, assim, um espaço recortado por experiências pedagógicas. “A clínica só diz respeito à instrução, no sentido estrito, dada pelo professor a seus alunos. Não é em si mesma uma experiência, mas o resultado, para o uso dos outros, de uma experiência anterior” (Foucault, 2021, p. 65).

A percepção que Foucault elabora sobre uma das possíveis funções da clínica pode ser pensada no âmbito formativo e pedagógico da formação médica. Uma aula que trate, de forma teórica e técnica, das doenças infectocontagiosas tem como preocupação apresentar informações anteriormente capturadas a partir de um corpo soropositivo, por exemplo.

O que se faz é a apresentação de um modelo inquestionável, materializado pelo “paciente”, que pode ser compreendido também como um corpo objetificado, do qual se extraem acidentes, sinais e pavor, mas não a sua realidade enquanto pessoa. O recorte é a pele, e não quem a habita (Machado, 2006).

É de se considerar que a linguagem constitui o conjunto do que se vê para se falar. Há uma linha que liga o corpo objetificado à linguagem médica. O que importa nessa relação é a constituição de um olhar atento que produza uma linguagem que identifica e se coloca como resposta. O olhar médico é treinado a perceber o corpo, e não quem o habita.

A leitura sobre o corpo é resultado desse treinamento e da construção do visível, traduzido pela linguagem que o médico opera. Na relação entre o ver e aquilo que é construído sobre o corpo, é possível que algo seja dito. O jogo de linguagem não é algo dado, mas produzido. O que se pode dizer, com Foucault, é que se trata de

um olhar que escuta e um olhar que fala: a experiência clínica representa um momento de equilíbrio entre a palavra e o espetáculo. Equilíbrio precário, pois se baseia em um postulado: todo visível é enunciável e é inteiramente visível por que é inteiramente enunciável (Foucault, 2021, p. 127).

Em suma, a existência da doença se dá no campo do visível e, concomitantemente ao ver, torna-se possível dizer sobre ela. O olhar, por mais

treinado que esteja, atravessa o campo da subjetividade. A forma como o olhar médico, em determinado contexto, se depara com um corpo soropositivo pode, sim, tornar-se um espaço de espetáculo para sua atuação, mas também um susto que impacta esse olhar, pelo espanto que um corpo soropositivo pode provocar: o perigo de um outro se revelar para além daquilo que o olho não vê.

E tudo o que parece ser distante, ao olharmos para a medicina clássica e moderna a partir da clínica, revela-se mais próximo do que se supõe: não é difícil perceber as proximidades que a arqueologia evidencia, pois não há rompimentos, mas continuidades.

Com a clínica, no século XIX, constitui-se um novo modelo de medicina: a anátomo-clínica. Esse modelo resulta da articulação entre a clínica, em sua “nova” forma de percepção da doença, da pessoa doente e do olhar médico, e a anatomia patológica. Tanto a medicina classificatória quanto a clínica são modificadas, uma vez que o olhar passa a ocupar outro espaço de percepção. O que Foucault constata que

é nessa nova imagem que se faz de si mesma, a experiência clínica se arma para explorar um novo espaço: o espaço tangível do corpo, que é ao mesmo tempo, a massa opaca em que se escondem os segredos, as invisíveis lesões e o próprio mistério das origens. E a medicina dos sintomas pouco a pouco entrará em regressão para se dissipar diante da medicina dos órgãos, do foco e das causas diante de uma clínica totalmente ordenada pela anatomia patológica. É a idade de Bichat (Foucault, 2021, p. 135).

O papel que a anátomo-clínica passa a desempenhar na clínica é o de ser uma ferramenta que adentra os tecidos, os espaços anteriormente rejeitados pela escuridão. Abrem-se, assim, possibilidades para que os sintomas colaborem de modo mais útil, ao não se pautarem apenas naquilo que o corpo expressa na superfície, mas também no que se encontra abaixo dela. Cria-se, então, o corpo-doente. A isso, Foucault vem nos dizer que

é preciso portanto, que o olhar médico percorra um caminho que até então não lhe tinha sido aberto: via vertical, que vai da superfície sintomática a superfície tissular, via em profundidade, que, do manifesto, penetra em direção ao oculto, via que é preciso percorrer ambos os sentidos, e continuamente, para definir a rede das necessidades essenciais entre dois termos. O olhar médico, que atingia as regiões de duas dimensões dos tecidos e dos sintomas, deverá, para ajustá-las, se deslocar ao longo de uma terceira

dimensão. Assim será definido o volume anátomo-clínico (Foucault, 2021, p.149-150).

A caracterização do olhar médico, antes superficial por caminhar apenas pela superfície do corpo, passa agora, na curiosidade de conhecer o que há dentro do corpo-doente, a buscar a gênese da doença. O que antes era visto como sintoma primordial para a percepção torna-se secundário. Ao caracterizar a doença no corpo, as manifestações que este pode apresentar passam a responder ao que o sintoma expressa.

Segue-se, assim, um caminho que não se limita à superfície do corpo, que pode ou não apresentar sintomas, uma vez que agora se reconhece que podem existir alterações internas que não se expressam na superfície da percepção. Essa mudança na forma de construir a ideia de doença dá lugar ao que não é novidade: “desaparece o ser da doença” (Foucault, 2021, p. 209).

Outro fato a ser considerado, e que Foucault (2021) aponta, diz respeito às epidemias. A partir delas, sobretudo no decorrer do século XVIII, o olhar não se restringe mais apenas ao espaço do hospital. A epidemia é um acontecimento que implica toda a sociedade e faz com que a percepção médica se amplie, alcançando outros territórios e espaços. O corpo doente e a cidade tornam-se a base para a construção do saber. Isso implica pensar, como Foucault irá afirmar, que o olhar médico

[...] não é a percepção do doente em sua singularidade, é uma consciência coletiva de todas as informações que se cruzam, crescendo em uma ramagem complexa e sempre abundante, ampliada finalmente até as dimensões de uma história, de uma geografia, de um Estado. (Foucault, 2021, p. 31).

É possível observar que o olhar médico, ao encontrar a doença no indivíduo, busca no coletivo ou seja, na sociedade o local privilegiado dos acontecimentos e das informações onde a doença pode ter se originado. A doença é inscrita não como algo próprio de uma pessoa, mas como resultado do coletivo.

Essa percepção mantém-se quando olhamos para os fatos ocorridos com a pandemia de AIDS. Havia os chamados grupos de risco e, por meio deles, a doença era estigmatizada e correlacionada a esses grupos, como foi o caso das pessoas que não se enquadravam na heterossexualidade e/ou na identidade cis.

O conhecimento, então, não é regulado no “encontro do médico com o doente, nem no confronto de um saber com uma percepção; é o cruzamento sistemático de várias séries de informações homogêneas [...] mas cuja interligação faz surgir, em sua dependência isolável, o fato individual” (Foucault, 2021, p. 32). Daí as expressões: doença gay, peste gay e assim seguimos até os dias atuais.

O trabalho médico, aos poucos, institui-se para a consolidação de uma consciência que alcança o campo da política, não se limitando ao indivíduo, mas preocupando-se com a vida na coletividade. Isso resulta na inserção dos médicos no controle da saúde por meio de estatísticas e registros que, de forma minuciosa, buscavam saber e exercer poder sobre os nascimentos e as mortes, suas causas, seus gêneros, enfim, tudo o que pudesse ser conhecido para dar origem a uma topografia destinada a listar causas e explicações.

Essa percepção é coletada por Foucault a partir do médico Jean Baptiste, que a descreve como “cuidadosos sumários sobre a região, as habitações, as pessoas, as paixões dominantes, o vestuário, a constituição atmosférica, as produções do solo, o tempo de sua maturidade perfeita e de sua colheita, assim como a educação física e moral dos habitantes da região” (Foucault, 2021, p. 33).

Ainda é possível pensar os corpos objetificados pela percepção médica e hospitalar tanto para estudos quanto para o preconceito, a negação e o trato desumanizado, seja por não compreenderem, seja por, muitas vezes, serem atravessados por percepções limitantes que povoam a formação e a prática clínica desumanizada. Interessa-nos seguir pensando, a partir da sexualidade, em como ela é socialmente construída e em como se realiza a patologização das práticas sexuais que foram e ainda seguem, nos dias atuais, como base para discursos que culpabilizam as pessoas soropositivas por sua sexualidade e/ou por vivências que não se limitam aos construtos morais.

Em outro momento dos escritos de Foucault, é possível perceber os desdobramentos de seu trabalho realizado em O nascimento da clínica no conjunto de aulas organizadas no livro *Os Anormais* (2010a). De forma mais detida, destacamos as aulas de 15 e 22 de janeiro de 1975, proferidas no *Collège de France*, onde Foucault lecionou até o ano de seu falecimento, em 1984. As relações possíveis de serem observadas entre as obras dizem respeito aos temas em discussão, ao tratarem da medicina, das questões da psiquiatria e da relação entre saber médico e poder na conjuntura das práticas sociais.

Na aula do dia 15 de janeiro, algumas anotações são feitas a partir das ideias expostas pelo filósofo. A noção desenvolvida por Foucault sobre a produção do anormal é compreendida como um processo que se constitui a partir do exame médico-legal, conferindo à medicina um espaço de atuação no campo judicial.

A constituição desse exame se dá pela dominação da noção de perversidade, que aparece nos mais diversos discursos: médico, jurídico e científico em meados do século XIX. A definição de perversidade acumula termos como “preguiça, orgulho, obstinação, maldade” (Foucault, 2010a, p. 28), criando, assim, a categoria do indivíduo perigoso, que Foucault nomeia como *categoria da moralidade*. Ambas as instituições, tanto a médica quanto a jurídica, ao olhar de Foucault, fundam, desse modo, a *categoria dos anormais*.

A partir da elaboração do anormal, cria-se outro poder, que Foucault (2010) denomina de *normalização*. Uma vez realizado o exame que constata que determinado sujeito foi classificado dentro do quadro que o emoldura como pervertido e, portanto, anormal, as instituições médica e jurídica passam a atuar para que esse anormal seja corrigido, buscando sua normalização, seja pela correção, seja pelo controle. A própria ideia de normal sustenta-se na existência do anormal.

Com o trabalho genealógico, ao percorrer os séculos, Foucault compreende que a ideia de anormal é mais uma forma pela qual o poder é exercido, operando pela repressão e que, economicamente, resulta na desqualificação. Ele exemplifica essa relação na Idade Média, entre leprosos e não leprosos, realizada pela prática da exclusão, ao dividir os grupos em “contaminados” e “não contaminados”.

Àqueles/as que fossem declarados/as como contaminados/as, eram empreendidas medidas de “exclusão, práticas de rejeição, práticas de marginalização, como diríamos hoje” (Foucault, 2010, p. 37). Ao pensarmos as pessoas soropositivas, não obstante, elas também são rejeitadas, indiferenciadas por sua sorologia, privadas de certas vivências e recusadas a ocupar determinados espaços de exclusão.

Sem perder o fio do comentário, Foucault, ao seguir com a genealogia, volta-se para os acontecimentos do início do século XVIII. Uma das marcas desse período é a peste, que reativa modelos de controle já utilizados em épocas anteriores à própria lepra. O exercício do poder materializa-se pelo policiamento nas cidades empesteadas.

Enquanto o controle da lepra se dava pela exclusão, com a peste ele ocorre pela inclusão do pestífero: há a demarcação do território, que é fechado em razão da

assolação que a peste causava nos moradores daquela região. Tal situação aproxima-se de nossa experiência recente com a quarentena da Covid-19, quando não podíamos sair de casa, das cidades e dos países.

O poder exercido sobre a lepra fazia com que os corpos-leprosos fossem retirados da cidade (do centro) e marginalizados, isto é, expulsos para fora dela, em regiões destinadas a esse fim, ou lançados a perder-se em navios pelo mar. Com a peste, adota-se um procedimento de controle no qual se institui um policiamento rigoroso das casas e das pessoas.

Constroem-se bairros e, neles, quarteirões que organizam as casas, enfileiradas e separadas por ruas, para que o policiamento possa circular, assim como os agentes de saúde que entram em nossas casas para verificar a existência de água parada e a presença da dengue, a fim de nos notificar.

Em cada casa é feita uma chamada, como nas escolas. Não responder configura a falta que será verificada. Antes disso, todas as pessoas são registradas para que o controle possa exercer domínio sobre quem ali está. O doente, nesses termos, torna-se sinal de perigo. Aqueles/as que não respondiam, ao estarem em suas camas, já eram decretados/as como sujeitos a serem retirados.

Outro ponto que deve ser registrado, e que Foucault nos mostra, é uma diferença entre ambos os casos: os leprosos são distanciados pela dicotomia saudável/doente; os empesteados, ao contrário, são individualizados para estarem próximos ao controle.

Nas palavras de Foucault, “não se trata de uma marcação definitiva de uma parte da população; trata-se do exame perpétuo de um campo de regularidade, no interior do qual vai se avaliar sem cessar cada indivíduo, para saber se está conforme a regra, à norma de saúde que é definitiva” (Foucault, 2010, p. 40).

Acentua-se aqui outro ponto que dialoga com as pessoas soropositivas. A marca de conviver com um vírus coloca-as em um mundo de mudanças contínuas, no qual, ao serem descobertas pela medicina, são perpetuamente lançadas à busca de sua regularização. Tal empreendimento, embora seja importante em razão do uso de medicamentos, da realização de exames e de outras questões que hoje são necessárias, não se limita ao cuidado.

A regularidade segue também por outras linhas que estão fora do campo do cuidado. As pessoas soropositivas são expostas ao controle médico e à visão moral que pode, de fato, contaminá-las simbolicamente, estabelecendo relações de

preconceito e estigma, criando, assim, uma pedagogia do visível e, por meio dela, uma violência muda.

Essas modificações de controle, Foucault as denomina *tecnologias positivas do poder*. No caso da lepra, a forma como foi tratada é vista como negativa, por não ter sido produtiva não se conhecia a lepra em suas entrelinhas e faces. O que se saberia dessas pessoas ao serem colocadas para fora da cidade?

A peste, por sua vez, instaurou uma relação positiva, porque possibilitou a produção de conhecimentos e, por meio deles, saberes, criando múltiplos efeitos que chegam até os dias atuais, como, por exemplo, nas relações estabelecidas com as pessoas soropositivas, seus tratamentos e sua constante inserção no rol da busca pela normalização.

Nas anotações da aula do dia 22 de janeiro, Foucault (2010) propõe analisar a anomalia no recorte temporal do século XIX. Embora ele situe no século XIX a constituição da anomalia, ela já se articulava a partir de três elementos no decorrer do século XVIII. Esses elementos são descritos como: *monstro humano, indivíduo a ser corrigido e criança masturbadora*. Aqui, destacaremos os dois primeiros, deixando de lado a masturbação para outro momento.

A constituição do monstro humano tem como referência o âmbito jurídico, a partir do entendimento de que o monstro é aquele que foge à lei da natureza. A regra que faz surgir o monstro é vista pelo corpo jurídico-biológico a partir de casos que raramente existem. Nos termos atuais, entre várias pessoas, um exemplo são as pessoas transsexuais.

Ao serem colocadas sob um regime de verdade que pauta o discurso do natural-verdadeiro como homem ou mulher hetero cis, não apenas são posicionadas como uma contranatura, mas também como uma lacuna que não consegue ser preenchida.

Trata-se de um corpo inteligível. Isso se torna mais interessante quando há a escolha pela redesignação do órgão anatômico, em que é possível a invenção de um “outro sexo” como um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode ser um homem?

Outras pessoas ainda podem ser colocadas dentro do quadro da anomalia por serem “raras”, em um sentido negativo. Nas palavras do professor, “o monstro é o que combina o impossível com o proibido” (Foucault, 2010, p. 47).

Ainda na genealogia que Foucault vai desenvolvendo sobre a anomalia, o *indivíduo a ser corrigido* é mais uma das categorizações elaboradas no século XIX. Alguns distanciamentos podem ser observados entre o indivíduo a ser corrigido e o monstro: a anomalia do monstro é explicada cosmologicamente, um erro de Deus? Soma-se a isso o fato de que o monstro é raro.

Já o indivíduo a ser corrigido é localizado em um microespaço, como a família, a escola, a igreja e tantos outros sistemas. Sua existência é frequente, em muitos casos visível e até mesmo passível de confusão. O que determina o indivíduo a ser corrigido é ser incorrigível. Essa verdade só é admitida após todos os procedimentos possíveis de correção terem fracassado. O indivíduo a ser corrigido está “no exato limite da indizibilidade” (Foucault, 2010, p. 49).

O monstro e o indivíduo a ser corrigido se fundam em uma mesma categoria: a pessoa soropositiva. As pessoas soropositivas são aquelas que fogem ao que é construído como natural. Sua causa nasce no discurso contranatural das relações homossexuais. A própria homossexualidade foi (e ainda é possível ver) compreendida como um indivíduo a ser corrigido.

Com a epidemia de AIDS, ambas as categorias se ligam, fortalecendo as sanções criadas, ressignificadas e que aparecem até os dias atuais, como será possível observar por meio dos dados.

Seguindo com os comentários, outra ideia que queremos trazer é o conceito de dispositivo, que em diversos momentos aparece nas obras e falas de Foucault. Ao considerá-lo uma noção potente para seu pensamento e para mobilizar a discussão com os dados, comentaremos a partir das leituras de Deleuze (1990) e Agamben (2005) sobre o dispositivo em Foucault.

Nas palavras de Deleuze (1990), o dispositivo é composto por curvas que fazem ver e falar. O dispositivo, na leitura de Deleuze, não se apresenta como um conjunto fechado ou único; ao contrário, é diverso e distribuído. Essa multiplicidade é percebida no discurso (médico e jurídico), nas instituições (igreja e hospital), nas técnicas (provas escolares, anotações médicas), nas práticas (olhar médico, julgamento jurídico) e nos saberes (a sexualidade, a loucura).

Sua distribuição se dá em diferentes tempos, nos séculos e nos locais pesquisados por Foucault e se reconstitui a partir do que foi dito e do que não foi dito, assim como do que foi enunciado e pensado em épocas distintas.

No emaranhado de palavras e sentidos que Deleuze tenta dissecar e nos dar a ler, os dispositivos são “linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas suscitam, através de variações ou mesmo mutações de disposição” (Deleuze, 1990, p. 4).

Os dispositivos, na leitura de Deleuze, são como mapas, e ousamos vê-los como mapas topográficos. Sua composição tem por base linhas de curvas de nível, que visam mostrar a forma como a superfície da terra se apresenta: linhas que se ligam entre montanhas, vales, planícies e declives.

Deleuze, ao ler Foucault, entende as linhas como múltiplas: de visibilidade, ao possibilitar a quem pesquisa e lê as condições que determinam o que poderá ser visto (a medicina e o corpo doente); de enunciação, que controlam o que é possível ser falado e em quais condições e locais (o médico e a cura/doença); de força, na dupla relação entre saber e poder (a medicina na produção do normal/anormal); de subjetivação, na produção do sujeito, em como pode ser, pensar e estabelecer suas relações consigo e com a sociedade (homossexual, heterossexual); e de fuga, pois, embora haja força, há também resistência (pessoas soropositivas ao fissurarem o preconceito e criarem outra identidade).

Em linhas gerais, o que tentamos e ousamos pensar com Deleuze é que um dispositivo é uma máquina de produção que “está por se fazer, na medida em que o dispositivo o deixe ou o faça possível. É uma linha de fuga. Escapa às linhas anteriores, escapa-lhes. O si-mesmo não é nem um saber nem um poder” (Deleuze, 1990, p. 3).

Com vistas a dialogar com Deleuze e Foucault, Agamben contribui para pensarmos o dispositivo. Agamben é um filósofo italiano que, no ano de 2005, proferiu uma palestra no Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, posteriormente traduzida e publicada. Essa publicação recebeu o nome de Dispositivo, na qual Agamben desenvolve algumas discussões, entre elas, a ideia cunhada como dispositivo, presente em várias obras de Foucault.

Um primeiro ponto a ser considerado e que talvez explique por que, em muitas obras de Foucault, o termo dispositivo aparece é, segundo Agamben (2005), o fato de se tratar de um termo amplo, que não delimita um sujeito ou um grupo específico ao qual se direciona. Embora possa parecer um termo universal, no pensamento de

Foucault há uma recusa aos universais, pois estes encobrem as condições a partir das quais surgem os saberes e as práticas.

O dispositivo articula elementos por meio de uma rede de diferenciações na qual se insere, sendo um entre vários o dispositivo da sexualidade, o dispositivo disciplinar, o dispositivo da governamentalidade, entre outros.

Agamben nomeia o dispositivo como “qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (Agamben, 2005, p. 39-40).

Ou seja, sendo o dispositivo um entre vários, ele não se restringe a um conceito fechado, constituindo-se como uma rede diversa que alcança diferentes instâncias, localizadas tanto no dito e no não dito, quanto na ideia e na realidade. Sua função é variada: captura e controla, direciona e modifica. É como uma máquina que se movimenta em função de ser produtiva, cria subjetividades e molda a identidade do sujeito.

Seguindo com os comentários, voltamo-nos para A história da sexualidade: a vontade de saber (2015b), em que Foucault propôs investigar a história entre os séculos XVII e XIX, utilizando a genealogia como procedimento de análise, e entendeu que as sociedades desses séculos estiveram voltadas ao “saber do prazer, prazer de saber o prazer, prazer-saber” (Foucault, 2015b, p. 87).

O tema do estudo é desenvolvido a partir da sexualidade como um dispositivo histórico. Ao realizar uma contextualização histórica sobre a sexualidade, Foucault o faz com a intenção de sustentar sua hipótese de que a constituição dessa história, no que tange à sexualidade, não foi a de uma história da repressão. Sua explicação para o fato de, no passado, a sexualidade não ter sido repressiva é elaborada a partir da ideia de dispositivo. Assim, ele define que

a sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder (Foucault, 2015b, p. 115).

O que Foucault afirma é que a sexualidade não se encontra na condição da repressão, como em outros séculos, quando o sexo estava delimitado aos espaços

esquadrinhados das casas e das famílias. Ao contrário, com as transformações, sobretudo capitalistas, encontrou no sexo sua vontade de saber. Quanto mais era conhecido, mais eficazes eram as redes de poder que produzia.

O entendimento do termo dispositivo, em Foucault, diz respeito a técnicas e/ou estratégias que operam com o poder de assujeitamento do corpo e da vida. Isso se evidencia no fato de que a sexualidade é um dispositivo que as sociedades utilizavam (e utilizam) como meio de sujeitar a coletividade. A sexualidade é fabricante de verdade, e, nas várias instituições: religiosa, política, econômica e científica faz-se dela a base discursiva, seja para reprimir e/ou regular (Revel, 2005; Díaz, 2012).

A base sobre a qual se construiu a sexualidade, e que Foucault (2015b, p. 117) aponta, é que “foi em torno e a partir do dispositivo de aliança que o de sexualidade se instalou”. A ideia de aliança é, de fato, uma realidade que parte das relações sexuais no matrimônio. Ao casar-se, institui-se religiosamente uma aliança, costura-se, em uma mesma carne, duas subjetividades.

O círculo de ouro é a marca, o signo de toda uma estrutura que sinaliza: vivemos sob os critérios das regulações e do lícito, a fim de fazer funcionar aquilo que se espera, ao menos nas aparências.

Ou seja, a sexualidade tem como configuração o relacionamento entre um homem e uma mulher hetero cis que, pelo contrato firmado na igreja, presidido por Deus o panóptico invisível mais poderoso estabelece uma união que perpassa as instâncias sociais, políticas e econômicas.

Trata-se de um modo de vida considerado o correto, por estabelecer, por meio do casal, um status que culturalmente se torna uma forma de ética, na qual o desejo não é o núcleo da aliança, mas o contrato que o matrimônio prescreve.

O objetivo central do dispositivo da aliança e o da sexualidade não são os mesmos. O primeiro investe nas relações, com o intuito de reforçar a lei das prescrições que o matrimônio estabelece. O segundo se coloca para além do matrimônio: alcança casados e não casados, com a intenção de controlar e manter o domínio.

Ou seja, o dispositivo da sexualidade está voltado a “proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global” (Foucault, 2015b, p. 116).

O HIV é um dispositivo. A forma como esse dispositivo funciona se dá tanto no âmbito biológico quanto no social. Pelo vírus, o corpo é capturado a seguir as

orientações biomédicas. Preso, o corpo soropositivo é orientado a seguir os saberes que o próprio campo médico produziu e criou condições para regular. Determinam-se, assim, as condições de vida e de morte.

A vida passa a ser controlada: é preciso manter a carga viral baixa (indetectável). As condutas médicas prescrevem as condições de existência biológica que se manifestam na realidade social. A subjetividade que se produz é marcada pelo estigma social.

Isso nos remete ao fato de que, uma vez sendo a sexualidade esse dispositivo que modifica, ao ponto de se tornar mutante no contexto do HIV e da AIDS, ela opera como uma extensão do próprio dispositivo da sexualidade ou, ainda, torna-se outra mão de um mesmo corpo. O HIV e a AIDS, ao marcarem o corpo, fizeram com que houvesse também uma marcação na construção social das sexualidades ditas como desviadas.

Estas passam a ser vistas como um grupo de pessoas que, ao exercerem práticas sexuais que não deslizam sob o líquido seminal heterossexual, ao escaparem, são capturadas por essa outra mão do dispositivo. Se o dispositivo da orientação sexual e/ou da identidade de gênero não alcança, a mão do HIV e da AIDS captura. Assim como captura todos aqueles que não são regulados pelo critério da aliança, como as profissionais do sexo e tantas outras.

Em suma, algumas das características que Foucault (2015b) desenvolve sobre o dispositivo da sexualidade têm como base o discurso e o poder. Não há repressão nos moldes em que se defende que o sexo tenha sido reprimido. Ao contrário, há um poder constitutivo, formado por múltiplas correlações de forças que se imbricam sob o domínio em que se organizam, como um jogo de embates, possibilitando transformação, reforço e inversão.

Constitui-se, pois, um sistema inteligível presente nas relações sociais. “O poder está em toda parte; não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. [...] é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada” (Foucault, 2015b, p. 101).

Ao pensar o poder, a sexualidade insere-se como um catalisador instrumental, passível de ser operado por diferentes estratégias, a partir do que se produz como saber sobre o sexo. Foucault (2015b) aponta quatro estratégias.

A primeira é a histerização do corpo da mulher, desqualificado por não haver desejo e, ao mesmo tempo, responsabilizado pelo cuidado das crianças e do lar. A

segunda é a patologização do sexo da criança, entendida como portadora de desejo, mas considerada perigosa por atravessar as fronteiras da moral, sendo colocada sob o olhar de diferentes personagens, como médicas/os, psicólogas/os, educadores e a família. A terceira é a socialização das condutas de procriação, concebida como uma economia voltada à reprodução, que reforça o papel social do casal e da família, ao mesmo tempo em que se orienta para o controle dos nascimentos, definindo quem nasce e a que lugar pertence. Por fim, a quarta estratégia é a psiquiatrização do prazer perverso, por meio da patologização e da normalização das práticas e condutas sexuais.

Todas essas estratégias são amparadas por uma rede de saber que, mesmo observada ao longo dos séculos XVIII e XIX, ainda hoje funciona e permite realizar interdições, criar condutas e fazer valer o que pode e o que não pode um corpo e sua sexualidade. Nesse sentido, o que há são relações

de poder-saber: por exemplo, as relações que se estabelecem entre penitente e confessor, ou fiel e diretor de consciência; aí, e sob o signo da “carne” a ser dominada, diferentes formas de sujeição e esquemas de conhecimentos, numa espécie de vaivém incessante. Da mesma forma o corpo da criança vigiada, cercada em seu berço, leito ou quarto por toda uma ronda de parentes, babas, serviçais, pedagogas e médicos, todos atentos às mínimas manifestações de seu sexo, constituiu, sobretudo a partir do século 18, outro “foco local” de poder-saber (Foucault, 2015b, p. 107).

A genealogia, como técnica de busca utilizada por Foucault, permite olhar desde o “princípio” como foram sendo aprimoradas as formas de atuação do poder a partir do sexo e da sexualidade. Ou seja, há “mutações, seus deslocamentos, suas continuidades e rupturas, [que] não coincidem com a hipótese de uma grande fase repressiva [...] Houve, ao contrário, inventividade perpétua, produção constante de métodos e procedimentos, com dois momentos” (Foucault, 2015b, p. 130).

Daí decorre a hipótese que refuta a ideia de que exista uma história de repressão, afirmando, em vez disso, uma história de tecnologias que visam, a partir do positivo da sexualidade, constituir esse campo de poder.

No decorrer do século XVI, o procedimento utilizado é o exame de consciência, presidido pela Igreja Católica, por meio da confissão e das penitências. No que tange ao século XIX, há tecnologias operadas pela medicina, por meio do olhar médico e do que a biologia representava nesse momento, produzindo discursos que regulam o corpo e o sexo. A medicina aparece, assim, como essa continuação.

Enquanto a Igreja olhava para a carne, a medicina olhava para o organismo. Ou seja, trata-se do “dispositivo de sexualidade como nova distribuição dos prazeres, dos discursos, das verdades e dos poderes” (Foucault, 2015b, p. 134).

Outro ponto que se articula ao que podemos pensar entre sexo e sexualidade é a morte. Haveria, pois, em relação às pessoas soropositivas, uma intenção de deixá-las morrer por meio de um outro dispositivo interligado ao da sexualidade? Foucault nos responde ao afirmar que “são mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo biológico para outros” (Foucault, 2015b, p. 148).

Se antes, na concepção em que todo ato que infringia as regulações tinha como desfecho o direito de matar ou de deixar viver, na atualização desse quadro há um poder que promove e/ou restitui a vida.

O fazer viver ou o deixar viver é apresentado por Foucault (2015b) como uma forma de ultrapassar os limites que anteriormente estavam ligados ao direito de morte, resguardado pela Igreja Católica. O suicídio, por exemplo, é visto como a usurpação desse poder.

A medicina, ao se colocar como outro campo de saber, também encontrou na morte uma forma de transpor seus conhecimentos e tomar parte do poder sobre a vida, no que é chamado de biopoder.

As raízes do *biopoder*, que supostamente são apontadas por Foucault (2015b), já se sinalizavam no início do século XVII. O corpo, ao ser visto como uma máquina que pode ser regulada, é disposto em uma linha que concentra as condições de aptidão, os limites que o corpo suporta, sua qualidade para utilização e a docilização necessária para torná-lo cada vez mais eficaz e econômico. Todo esse empreendimento sobre o corpo só foi possível a partir dos processos de poder e disciplina.

No que tange ao século XVIII, o foco desloca-se para o corpo enquanto espécie. Passa-se a considerar o que a biologia poderia descrever sobre a propagação, o nascimento e a morte, as condições de saúde e o quanto estas podem garantir a vida, vistas como elementos controladores de uma biopolítica da população.

Dado todo esse percurso que Foucault (2015b) nos apresenta, é possível pensar que os efeitos do dispositivo da sexualidade são os de criar “uma sociedade normalizadora [que] é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida” (p. 156), somando-se a um poder que faz normalizar. O corpo e a vida que nele habitam tornam-se a base para a criação das regulações, e o “sexo tornou-se o alvo

central de um poder que se organiza em torno da gestão da vida, mais do que da ameaça da morte” (p. 159).

As questões que se levantam sobre o porquê dessa preocupação com o sexo e a sexualidade decorrem do fato de ambos serem “mecanismos do poder [que] se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar ou sua aptidão para ser utilizada” (p. 160).

Isso nos remete ao fato de que os possíveis problemas que emergem em torno das pessoas soropositivas decorrem do sexo, da sexualidade e de seus atravessamentos. O momento em que a AIDS chega à sociedade ocorre em um contexto em que as liberdades sexuais estavam em plena expansão.

Quanto mais as experiências sexuais se tornavam conhecidas, mais se sabia ou se criava uma ideia sobre as vivências sexuais e as sexualidades, sinalizando, assim, maior poder e também maior perigo.

Entre os diversos poderes que investiram sobre os corpos considerados deseducados, a forma de exercer o controle deu-se por meio do “dispositivo de sexualidade [que] permite às técnicas de poder investirem sobre a vida” (Foucault, 2015b, p. 170).

Eixo 2: Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?

Ao pensarmos que no momento da descoberta da sorologia das pessoas que vivem com HIV, um outro mundo de várias facetas é imposto. Emergem as questões biomédicas, sobre tratamento, os cuidados que cada pessoa deve assumir, somada as interpelações manifestadas pelas questões de preconceito e estigmatização.

Não obstante, a sociedade, ao acessar o dispositivo da sexualidade como motor da irregularidade em como a infecção é lida e por isso estigmatizada, cria relações de preconceito. Nessa mesma linha tentamos buscar em “*As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*” (2000) de Foucault, a produção dos preconceitos e estigmatização a partir de categorizações. Classificar é a fórmula e o cálculo que organiza e categoriza as pessoas, criando assim, hierarquias e exclusões.

O olhar de Foucault (2000) se volta a Idade Clássica VIII a.C. a V d.C., caracterizada pelo desenvolvimento, resultante da cultura grega e romana, que ao ter como produção, filosofias, artes, políticas e educação, possibilitou criar percepções

sobre o humano e o viver em sociedade. Do mesmo modo, seu olhar se esticou para ver o século XV ao XVIII, período nomeado como moderno.

As características em destaque neste período são os resultados das invasões e assaltos às Américas e a outros territórios, as navegações que possibilitaram ampliar suas rotas de trocas e roubos, o Renascimento e Iluminismo e com ambos, ares de contestações ao catolicismo e o nascimento de outros ismos. Culminando com a revolução industrial e tantas outras, mas que é destaque a valorização da razão enquanto critério de saber. Nesse contexto, Foucault está a ver o que

[...] os historiadores assinalam, em seguida, as formas variadas que assumiram essas ciências novas da vida e do 'espírito', por assim dizer, que as dirigiu. Elas teriam sido mecanicistas, de início, sob a influência de Descartes, e até o fim do século XVII; os primeiros esforços de uma química apenas esboçada as teriam então marcado, mas, durante todo o século XVIII, os temas vitalistas teriam assumido ou reassumido seu privilégio, para se formularem, enfim, numa teoria unitária – esse vitalismo que, sob formas um pouco diferentes, Bordeu e Barthez derot e depois Bichat, em Paris. Sob esses diferentes regimes teóricos, questões quase sempre as mesmas teriam sido colocadas recebendo a cada vez soluções diferentes: possibilidade de classificar os seres vivos – só uns, como Lineu, sustentando que toda natureza pode entrar numa taxinomia [...] (Foucault, 2000, p. 172-173).

A leitura do mundo na produção da história clássica está em de pausar o olhar nos detalhes e assim reescrever de forma a manter sua fidelidade ao que viu. Talvez seja essa a primeira maneira de elaboração da história, dada pela cumplicidade com as palavras sem utilizar de nada que possa aproximar do que se vê, que não seja o próprio olho, a retina que registra e transforma o quadro que o olho consegue fotografar.

A constituição dos materiais que compõem essa história são as coleções de plantas, os próprios campos que são fotografados, como jardins e outros espaços que, sem nenhuma descrição anterior, mantêm sua legibilidade. Os seres, são perfilhados em linhas visíveis que combinados uns com os outros por proximidades, são dispostos como um álbum de figuras.

Não obstante, Foucault (2000) acentua o papel mecanicista e a teologia, como base de entendimento e confronto na defesa dos fenômenos, do mundo, das coisas e os seres humanos. A explicação ao funcionamento é feita pela ideia de um primeiro motor que faz funcionar todas as coisas. Há uma causalidade mecânica. A

discrepância de ambos é de que um é dado o poder a Deus (teologia) e o outro (mecanicismo) a deuses como a física, a química e a biologia.

Ao que concerne ao século XIX, era característico ao que Foucault (2000) chama de uma “*ciência da vida*”. Amparadas nas ideias do século XVIII, em que o racional e o positivo, fez com que as especificidades do ser vivo aparecessem. Isso leva a pensar que decorrido pouco mais de um século em que o saber é dado por sua repartição, ainda assim não é familiarizado.

Ou seja, “a biologia era desconhecida, o era por uma razão bem simples: é que a própria vida não existia. Existiam apenas seres vivos e que apareciam através de um crivo do saber constituído pela história natural” (Foucault, 2000, p. 175).

O que Foucault (2000) vem nos desenhando para ilustrar sobre as classificações é que a história natural ao não reconhecer sua herança, coloca-se *entre as coisas e as palavras*. Essa brecha muda, subtraída e separada se movimenta a partir de elementos que podem ser representados e nomeados.

O que vai fundamentar a história natural “é o espaço aberto na representação por uma análise que se antecipa à possibilidade de nomear; é a possibilidade de ver o que se poderá dizer, mas que não se poderia dizer depois, nem ver, a distância, se as coisas e as palavras, distintas umas com as outras” (Foucault, 2000, p. 178).

Na prática essa relação entre as coisas e as palavras é apresentado por Foucault (2000) a partir do naturalista sueco Carl Linnaeus em 1758 e 1759. A ordem de descrição que o naturalista escreveu tem como modelo a cada animal, o nome, a espécie que esse representa, o gênero e seus atributos.

A linguagem produzida para compor o arcabouço descoberto no decorrer do tempo sobre as descobertas das coisas é apagada e então, o discurso é a ordem que relata as coisas por elas mesmas. Ou seja, “antes dessa linguagem, é a própria coisa que aparece nos seus caracteres próprios, mas no interior dessa realidade que, desde o início, foi recortada pelo nome” (Foucault, 2000, p. 178).

O que esse panorama construído por Foucault (2000) nos chama a atenção a perceber é que tudo o que foi produzido e que permanece nas bibliotecas do final da Idade Clássica, como herança do tempo e da sensibilidade daquelas sociedades, foi apagado. Trata-se de produções que buscavam introjetar em nossa linguagem uma continuidade com a mesma linha que constitui os seres vivos hoje.

Esse apagamento é realizado pelos historiadores do século XIX, a partir da quadriculação e da espacialização por meio das quais se institui a chamada “história

legítima”. Ainda assim, tal processo permanece pautado na racionalidade e na ordenação de herança clássica.

A história natural contada é aquela que se faz quando se desmembra a coisa da linguagem. Nesse sentido, o trabalho realizado é o de nomear o que é visto. Isso a distancia do olhar que a Idade Clássica teve, marcado pela ausência de intervenções técnicas, como o telescópio, em que a experiência entre o objeto e o olhar não subtraía os sentidos na tentativa de captar o real do objeto da experiência. Há, assim, uma distinção: uma capta o possível pela percepção; a outra recorta o possível pela linguagem, dizendo mais do que o próprio possível.

O possível de apreender sobre o que o século XIX trouxe é a construção de arquétipos que ao especificarem as coisas, as representam a partir de descrições que então serão aceitas como um contrato universal. O que foi descrito a uma pessoa, por exemplo, as classificações biomédicas sobre o HIV e AIDS serão reconhecidas por todo o Planeta Terra.

Não obstante, as relações de estereotipação, de exclusão e preconceitos, também. Em alguns territórios mais do que outros. O reconhecimento é universal, por que a linguagem que constitui o saber “descreve certas formas bastante complexas a partir de sua semelhança muito visível com o corpo humano, que serve como que de reserva aos modelos da visibilidade e constituiu espontaneamente junção entre o que se pode ver e o que se pode dizer (Foucault, 2000, p. 185).

A questão que vai se colocando é a de que, ao observamos como a ciência foi escrita e propagada pelos historiadores naturais, constituiu o *modus operandi* que direciona a percepção coletiva. O que no passado e ainda no presente se diz sobre as pessoas soropositivas é resultado de representações superficiais e limitantes. Não há a descrição que ultrapasse o contexto social, de escolhas, os afetos a precariedade e as condições de conhecimento que essas pessoas possam ter tido.

As bases que consolidam a biologia assim como as áreas biomédicas e outras, ao pautarem-se em uma *mathesis universalis* – ou seja, uma ciência generalizante que visa explicar o mundo, as pessoas e os seres vivos as faz criando identidades. Não está no campo do possível que uma coisa possa não ser. Aliás, ela não sendo, acaba por ser. Não há o entendimento de fuga, que possa ser sem estar descrito pela generalização.

Pela sexualidade uma pessoa pode ser estereotipada por ser soropositiva. De outro modo, uma pessoa com câncer é vista como uma guerreira. O que muda isso?

A forma como foi narrada, o discurso que foi criado a partir do que se quis ver para mal se falar. Uma lógica cartesiana do vejo logo é.

Essas ideias resultam de como a história natural se estabeleceu enquanto ciência. Foucault (2000) destaca alguns pontos que fortalecem sobre como as *palavras se tornam as coisas*. Para que as coisas que são vistas possam ser ditas, é elencado o caráter. Antes, é preciso percebermos que a função da estrutura parte do que será nomeado, fazendo com que seja visível.

Um exemplo é quando vamos a uma unidade de pronto atendimento. Ao chegarmos, após pegarmos a senha, esperar sermos chamados, realizamos uma ficha. Após, somos chamados/as para passarmos por uma triagem. Ali somos lidos/as pelos códigos que apresentamos pelos sintomas – febre, dor de cabeça. Isso faz com que seja pré-estabelecido um nome próprio do que possamos ter a partir do que dissemos.

É designado a partir desse nome próprio algo que é comum a outras pessoas – a febre e a dor de cabeça são sintomas da dengue (à exemplo). Essa constatação também pode ser lida à outras pessoas, pela estrutura que apresenta, “deve, a um tempo, designar muito precisamente todos os seres naturais e situá-los ao mesmo tempo num sistema de identidades e de diferenças que os aproxime e os distingue dos outros” (Foucault, 2000, p. 190).

O caráter é a relação do nome com o que estrutura alguma parte de onde fundou o nome. É a relação do visível, ao que derivou a nomeação. De onde adveio o aidético? Ou o próprio nome do HIV e AIDS? Não são perguntas soltas e sim, comprometidas com a linguagem que quer se constituir sobre o nomeado. “Nomear-se-á não a partir do que se vê mas a partir dos elementos que a estrutura já fez passar para o interior do discurso. Trata-se de construir uma linguagem segunda a partir dessa linguagem primeira, mas certa e universal” (Foucault, 2000, p. 191).

O que faz funcionar o caráter é o sistema como gestor de todo o trabalho. Como um juiz, o sistema é a técnica que controla qualquer diferença e identidade a partir da estrutura que denominará determinado ser. Não há meio-termo entre o que é e o que não é. Este terceiro, seria então apagado ou por ele, criado uma outra categoria. Aceitar o que foge, comprometeria o caráter ao qual foi designado a ser.

Todavia, o método é inserido como outra técnica que se propõe “resolver” o problema de um possível terceiro excluído. Ele não recorta o todo que é descrito dos

elementos, aqueles que são raros ou de altas quantidades. A função do método é diminuir tais elementos ao passo que avança.

Foucault (2000) utiliza como exemplo “A história natural de Senegal” (1757), do botânico francês Michel Adanson. A princípio, é escolhido uma espécie sem regras. Após ser escolhida é realizada uma descrição detalhada, por exemplo, uma planta, descreve sua cor, folhas e caule.

A descrição está em vista a detalhar minuciosamente a planta, concomitante, atribui valores a partir de variáveis que possam aparecer. Assim é feito com uma outra espécie, seguindo os mesmos passos, contudo, sem poder repetir o que já foi descrito da anterior. Então, essa segunda será descrita tão somente as diferenças em relação à anterior.

Uma vez coletado as diferenças, junta-as e é esboçado o quadro amplo das familiaridades. Isso resolve o problema da quantidade que não é alcançada para ser capturada (descrita, nomeada) e assim, serão generalizadas como o grupo de famílias de determinadas espécies.

Em síntese, é com as familiaridades que compulsoriamente se determina uma outra espécie. “O método é imposto de fora, pelas semelhanças globais que aproximam as coisas; transcrevem imediatamente a percepção no discurso; permanece, em seu ponto de partida, o mais perto possível da descrição” (Foucault, 2000, p. 197).

Não obstante é percebido o uso da ideia de *familiaridades* para criação do estigma das pessoas soropositivas. A princípio, eram as pessoas gays e travestis, seguiu-se com as pessoas que trabalhavam com o sexo, depois, com as pessoas haitianas, usuários de substâncias tidas como ilícitas, hemofílicos/as e então, foi criado a nomeação de grupo de riscos.

Ou seja, é colocado compulsoriamente em um mesmo quadro as semelhanças que são baseadas pela sexualidade, pelo sexo, pelas transgressões, pelas diferenças, pelo negativo que constitui o duplo falho que organiza a sociedade. Tal qual é possível observar, como essa organização forma as mentalidades na busca de criar identidades para fixá-las, nomeando-as e então, alcançando-as.

Com a leitura da história natural e sua produção teórica, Foucault (2000) vê um espelhamento com a teoria da linguagem. A forma como o saber da história natural se fundamenta, dá-se a partir do estabelecimento de sistemas e representações que

direcionam o conhecimento com o intuito em dar o nome à vida, e aos conjuntos do que foi possível ver.

O resultado investido para se chegar à ideia de vida, passa pela taxonomia, na qual a classificação foi essencial, na medida que, o que é construído, foi pelos recortes da diferença e identidade que repousam a um a *priori* histórico.

Tal a *priori* é o recorte da experiência de uma determinada época que “define o modo de ser dos objetos que aí aparecem, arma o olhar cotidiano de poderes teóricos e define as condições em que se pode sustentar sobre as coisas um discurso reconhecido como verdadeiro” (Foucault, 2000, p. 2018).

Feito esse percurso junto a Foucault (2000), é possível perceber que, a partir da história natural, é estabelecido uma ordem de carácter lógico e racional na qual construiu e ordenou o mundo.

Para isso, diversos meios foram utilizados, como a classificação e a categorização dos seres vivos em gêneros, fazendo vigorar, a partir daí, o funcionamento de todo um sistema pautado em relações de semelhança e diferença.

Tal processo repercute, pois, em uma concepção de mundo e de pessoa pautada no essencialismo e/ou de natureza – ambos compreendidos como uma ordem que fixa e concebe o mundo como um espaço que não muda, excluindo outras possibilidades de entendimento do mundo e de pessoas, como a experiência.

Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo

Ao nos perguntar qual seria o significado da palavra família, buscamos no dicionário, cujo o resultado que encontramos é de ser um “grupo de pessoas, formado especialmente por pai, mãe e filhos/as, que vivem sob o mesmo teto; grupo de pessoas ligadas entre si pelo casamento ou qualquer parentesco; grupo de pessoas unidas por crenças, interesses ou origem comum” (Houaiss, 2011, 424-425).

É perceptível que o conceito de família surge a partir da visão naturalista e que se inscreve dentro dos padrões pré-estabelecidos pelas religiões cristãs, assim como o utilitarismo burguês, no que tange à economia e produção de pessoas para o trabalho. Buscamos em algumas obras de Foucault, elementos que nos permitem pensar a família, em algumas obras como *A História da Sexualidade III o cuidado de si* (2024b), *A História da Sexualidade II o uso dos prazeres* (2024a) e *a História da sexualidade I a vontade de saber* (2015b) e por fim, *Os anormais* (2010a).

Começemos pela constituição do casamento ao voltarmos o olhar para a era Clássica da Grécia e da Roma antigas, tal como Foucault analisa na História da sexualidade III sobre o cuidado de si. As descrições que Foucault (2024b) apresenta acerca do casamento indicam-no como uma união que tem, entre suas características, a liberdade assumida entre as partes que constitui o casal. O casamento a princípio tinha como “forma” ser um contrato que “eram feitos simplesmente entre um homem e uma mulher, concordando em compartilhar suas vidas” (Foucault, 2024b, p. 98).

Pensar o casamento como um contrato implica que ambas as partes assumem papéis e responsabilidades definidas. Foucault (2024b) explica essa configuração ao mencionar os escritos de Vatin, em “Pesquisas sobre o casamento e a condição das mulheres casadas no período helenístico” (tradução nossa), ao analisar o Egito helenístico como uma forma evoluída sobre a ideia de casamento. O recorte temporal situa-se ao término dos séculos IV e III antes de Cristo.

Segundo a leitura de Foucault (2024b), cabia à mulher ser obediente ao marido, ausentar-se de casa, seja durante o dia ou à noite apenas com autorização prévia, além de lhe ser vedada qualquer prática sexual com outro homem. Tais restrições visavam não manchar a honra do marido e, assim, não prejudicar a ordem e relação da casa.

Diferentemente, o marido era autorizado a manter outras relações sexuais, seja com outros homens ou com outras mulheres. A restrição que lhe era imposta consistia na proibição de ter filhos com outras mulheres que não seja a de sua casa, bem como trazê-las para residir junto à sua família, ou de manter vínculos que o afastassem de sua casa.

Destaca-se, ainda, que o marido não poderia ser grosseiro com sua esposa. Sua responsabilidade para com ela parecia implicar maiores rigores a serem observados, tais como prover o necessário àquilo de que a esposa precisasse, não manter fora de casa alguém que ocupasse o status de pessoa predileta ou amante. “É a liberdade sexual do marido que está em causa; a mulher será agora tão exclusiva como o homem” (Foucault, 2024b, p. 99).

A leitura que Foucault (2024b) realiza indica que o casamento, neste contexto, colocam tanto a mulher quanto o homem sob o seguimento de regras que, embora não sejam igualitárias, são compartilhadas por ambos. A função da existência dessas regras não se vincula ao fato de pertencerem a famílias que precisam manter determinado status, mas, à sustentação de cada pessoa que compõe o casal.

O casamento tem como objetivo constituir-se como um modo de vida que consiste na boa convivência entre o homem e a mulher. Entretanto, o fato de haver mais privilégios atribuídos ao homem não implica que ele esteja isento de se sustentar nas regras que lhe cabem.

O papel do homem no casamento é, assim, um “papel relacional com respeito à sua mulher; mostram, finalmente, que esse papel não é somente uma função governamental de formação, de educação, de direção, mas que se inscreve num jogo complexo de reciprocidade afetiva e de dependência recíproca” (Foucault, 2024b, p.105).

Chama a atenção o modo como os papéis atribuídos ao homem e à mulher, enquanto entes que compõem a família, têm como base uma concepção cultural fundada na responsabilidade sobre as próprias ações. Tal concepção não se encontrava regulamentada sob a forma de regras ou leis às quais as pessoas deveriam obedecer, mas operava como um princípio que orientava o pensar e o agir, não fazendo prevalecer o status social, e sim a soberania sobre si mesmo.

Não se trata, portanto, de uma relação de poder de um sobre o outro. Há, antes, uma estética da existência que constrói a vida e conduz o sujeito a seguir uma ética em suas ações. Toda essa racionalidade inscreve-se na “importância assumida pelo tema do retorno a si ou da atenção que é preciso prestar a si mesmo, no pensamento helenístico e romano, como alternativa que se propunha para a atividade cívica e para as responsabilidades políticas” (Foucault, 2024b, p. 112).

O que Foucault (2024b) procura evidenciar, ao mobilizar os escritos antigos, seja de Pluturgo, filósofo da Antiguidade, seja de Marco Aurélio, imperador romano, entre tantos outros, é o cultivo de uma cultura do pensamento voltado ao cuidado de si, tal como se constitui nas relações, com forte presença da política, a qual repercute em todas as demais posições, como por exemplo, nas relações entre o casal.

Isso se torna explícito quando Foucault destaca a importância da “arte de governar a si próprio se torna um fator político determinante [...] arte de bastar-se a si próprio sem perder a serenidade” (Foucault, 2024b, p. 117-118). Todo esse trabalho de cuidado de si, que se expressa nas ações do sujeito, está em vista em tudo aquilo que o homem exerce, não para ocupar um status, mas como prática ética.

Ao contrário, quanto maior o lugar de poder ocupado, maior deve ser a atenção voltada a si mesmo. Por isso, o espaço da política não é, como diz Criolo “para meninos mimados”, mas um lugar de dedicação, compromisso e gosto pela

responsabilidade. Tal lógica parece refletir-se também na vida conjugal, particularmente no papel atribuído ao homem.

No que tange ao matrimônio, essas questões se apresentam-se como uma forma de reciprocidade e de igualdade que resulta da relação consigo mesmo que o homem estabelece. Uma vez compreendido que o poder no âmbito doméstico não deve seguir uma lógica de dominação, o uso racional de si faz com que as ações no interior da casa sejam moderadas, não se exercendo sobre a esposa aquilo que se faria em outras relações extra domésticas, como nas decisões políticas.

Assim, a constituição da família e do casal é orientada por esse princípio de busca de um bem comum. Trata-se, portanto, de uma elaboração “ética que permite constituir o próprio sujeito enquanto sujeito moral em relação a essas atividades sociais, cívicas e políticas, nas diferentes formas em que elas podiam se revestir e a qualquer distância que delas tomasse (Foucault, 2024b, p. 122).

Ao tratar o corpo como um lugar de existência do cuidado de si, algumas observações se impõem. Foucault (2024b) utiliza o termo grego *aphrodisia* para referir-se às práticas sexuais e aos prazeres delas derivados. Tal termo permite compreender como as pessoas na Grécia Antiga, faziam uso da sexualidade, das práticas sexuais e dos desejos. Contudo, nesse momento de História da Sexualidade 3, a investigação realizada concentra-se no cuidado de si articulado às questões que orbitam a sexualidade e, de modo particular, às pessoas que compõem a família.

Uma primeira observação refere-se à idade do sujeito no ingresso às práticas sexuais. A orientação vigente apontava para a busca de um certo equilíbrio: nem muito velho, nem muito jovem para realização sexual.

Quando muito velho, considerava-se haver um esgotamento do corpo, por se tratar de uma fase da vida em que já não haveria tanta energia vital. Quando muito jovem, entendia-se que a prática poderia ser prejudicial aos primeiros sinais e movimentos que anunciam a puberdade.

O que nos interessa observar é a forma como essas questões são tratadas, e, ao que tudo indica, não há um silenciamento no sentido de negar a existências da sexualidade entre as/os adolescentes, mas sim, uma preocupação com o cuidado, por exemplo, em relação ao momento adequado para o início da vida sexual.

Para os meninos, a vida sexual era situada após o aflorar da puberdade, indicando-se como referência a idade em torno dos 14 anos. Trata-se do momento em que os primeiros sinais, expressos pela produção inicial de líquidos seminais, fase

em que a prática sexual deveria ser contida, por ser considerada potencialmente violenta ao corpo e seu desenvolvimento, bem como suscetível de ocasionar doenças que poderiam vir a prejudicá-lo.

Para tanto, os médicos que seguiam a tradição prescreviam a recomendação de diversas atividades físicas. Isso por que, nos escritos da Grécia Antiga mencionado por Foucault (2024b), a idade dos 14 anos marca o início da produção de esperma e, nesse período, surgem os “apetites muito ardentes que os excitam às relações sexuais, os exercícios corporais devem ser bem numerosos, a fim de que, cansado logo a alma e o corpo, eles possam desde o começo reprimir seus desejos” (Foucault, 2024b, p.161).

No que tange às meninas, a preocupação recai sobre o casamento em idade muito precoce. Com o casamento, pressupunha-se a ocorrência de relações sexuais e, delas, a possibilidade de geração de filhos/as.

Nesse sentido, entendia-se que não se deveriam ter relações sexuais antes do início da menstruação e do estabelecimento de seu ciclo natural, pois isso implicaria riscos. O conselho era o de que deveria “fixar a idade do casamento, em critérios orgânicos e não no sentimento das próprias jovens; este entretanto, por causa da educação, pode se despertar antes do corpo” (Foucault, 2024b, p. 161).

Outras perspectivas indicavam que a idade mais adequada para a gravidez seria após os 18 anos, em razão das preocupações com a saúde da futura mãe e de seu/sua filho/a. Ainda que em alguns escritos a mulher era descrita como mais ativa do que o homem, o que se atribuía ao excesso de alimentação e o descanso, fatores que, segundo tais discursos, lhe confeririam maior propensão a transgredir as regras antes do casamento.

Acrescenta-se, entre os cuidados prescritos, que se considera adequado permitir que as meninas convivam com os meninos durante a infância. Em determinada idade, que não é especificada, elas são retiradas desse convívio e passam a um regime descrito como cuidadoso: “sem carne, sem pratos nutritivos, com pouco ou nenhum vinho, longos passeios, exercícios. Deve-se ter em mente que a ociosidade é para elas o que há de mais prejudicial [...] é vantajoso usar exercícios para pôr o calor em movimento” (Foucault, 2024b, 162).

As prescrições tem em vista ao cuidado de si e pauta-se como premissa de que as relações sexuais devem estar interligadas ao corpo e a alma, ambas ao manifestarem a necessidade para o desejo. Equivale a dizer que há uma “ética do

desejo que se molda sobre uma física das excreções; e a tendência para um ponto ideal, onde a alma, purificada de todas as suas representações vãs, só dirige a atenção à economia austera das evacuações orgânicas” (Foucault, 2024b, p. 168-169)

O que pode ser observado é que não há, nesse contexto, uma regra imposta de forma homogênea a toda a sociedade, mas, antes, uma tentativa de incitar nas pessoas um modo de viver no qual o prazer não ocupe o lugar das proibições ou das patologizações, sendo, ao contrário, resultado de uma conduta que se estabelece inicialmente na relação consigo mesmo. A leitura do cuidado de si no período grego da época clássica possibilita o funcionamento de relações que, ao se pautarem nesse cuidado de si, articulam-se ao cuidado dos/as outros/as.

Como aponta Revel, “para o homem livre, incluir na sua boa conduta uma justa maneira de governar sua mulher, suas crianças ou sua casa. O *ethos* do cuidado de si é, portanto, igualmente uma arte de governar os outros e, por isso, é essencial [...] para poder bem governar a cidade” (Revel, 2005, p.34).

Ressalta-se, ainda, que o ponto central que orienta a sociedade e as relações que nela se estabelecem, como a família, não se confunde com o ascetismo empregado pela pastoral cristã. Trata-se, antes, de uma busca ao “amor a si” como caule a partir do qual diferentes galhos podem crescer, sem a imposição da renúncia ao corpo àquilo que ele pode oferecer no mundo terreno, como os prazeres, conforme será discutido mais adiante.

Em outro momento de análise, Foucault debruça-se sobre História da sexualidade II o uso dos prazeres (2024a). Embora o foco da obra recaia sobre o modo como os prazeres são utilizados a partir das práticas sexuais no contexto da Grécia Antiga, compreendidas, nesse período, como uma forma de conduta moral. Tal percepção faz com que essa conduta se torne uma referência na produção de subjetividades, com a finalidade de possibilitar uma *estética da existência*. A partir dessa perspectiva, continuaremos a direcionar o olhar para a família.

A pergunta que orienta a reflexão acerca do casamento é: “como, sob que formas e a partir do quê, as relações sexuais entre marido e mulher, no pensamento grego, constituíram um problema? (Foucault, 2024a, p. 176). A resposta oferecida por Foucault indica que há, na verdade, muito pouco que se configure como um problema propriamente dito. Nos escritos reunidos para análise, são diversas as descrições e

manifestações que oferecem um panorama de como essas relações eram constituídas.

Observa-se a existência de papéis distintos atribuídos às mulheres em uma configuração social específica: as cortesãs, vistas como aquelas que garantiam o prazer; as concubinas, responsáveis pelo cuidado cotidiano; e as esposas, que ocupavam o lugar mais valorizado, tanto por seu status quanto por desempenharem o papel de assegurar a continuidade hereditária por meio das/os filhas/os e de zelar pela casa. A distribuição desses papéis, ainda que possibilitasse diferentes formas de realização dos prazeres, não configurava aquilo que se poderia compreender como poligamia.

A poligamia caracteriza-se por uma relação em que mais de uma mulher assume o estatuto de esposa de um mesmo marido. O que se observa, nesse contexto, é que o papel das demais mulheres não se confunde com o da esposa, estando ligado à realização e à satisfação do prazer, sem interligação à relação conjugal. O objetivo, portanto, é a busca do prazer sem centralizá-lo na esposa e, ainda assim, sem implicar prejuízo à relação do casal.

Diferentemente dessas mulheres, as esposas encontravam-se “circunscritas por seu status jurídico e social; toda a sua atividade sexual deve se situar no interior da relação conjugal e seu marido deve ser o parceiro exclusivo. Elas se encontram sob o seu poder; é a ele que devem dar filhos que serão seus herdeiros” (Foucault, 2024a, p. 178). A questão de hereditariedade revela-se central, uma vez que uma das condições para o reconhecimento da cidadania, como no caso ateniense, era ser filho de homens cidadãos.

As interdições impostas ao homem casado restringem-se à possibilidade de constituir outro casamento, uma vez que já se encontra casado. Contudo, não há proibições quanto às suas relações sexuais extraconjugais, seja com outras mulheres, seja com outros homens, “ele pode ter uma ligação, pode frequentar prostitutas, pode ser amante de um rapaz – sem contar os escravos homens ou mulheres que tem em sua casa à sua disposição. O casamento de um homem não o liga sexualmente” (Foucault, 2015b, p. 180).

Para a mulher, em virtude da manutenção de seu status de esposa, não é permitido a busca dos prazeres com outros homens que não seja o seu marido. O adultério, nesse contexto, consiste na quebra do contrato conjugal apenas por parte

mulher, e não do homem. Não há, portanto, uma a ideia romântica sobre a fidelidade entre os cônjuges, pautada em premissas religiosas do futuro.

A mulher é concebida como pertencente ao seu marido. Quanto a ele, tem a si próprio como dono e proprietário de seu corpo e da forma como utiliza para os prazeres. Isso, contudo, não equivale afirmar que o ciúme não estivesse presente por parte das mulheres, como descreve por Foucault (2024a) ao analisar os escritos de Xenofonte em *O Banquete*.

Há passagens que indicam que a liberdade sexual não se configurava como uma regra válida para todos os homens. Durante a juventude, a busca por prazeres sexuais era intensa e variável, ocorrendo antes do casamento e estendendo-se, em geral, até aproximadamente os 30 anos, período em que os homens comumente se casavam.

Ainda assim, as questões relativas à busca pelos prazeres não pareciam constituir uma preocupação central da sociedade, como vieram a ser no período cristão. Soma-se a isso o fato de que, ao menos em *A vontade de saber*, Foucault (2015b) menciona que o casamento não era a única forma de união legítima, embora não as descreva de modo detalhado.

Todavia, a união nos moldes aqui discutidos configurava-se como uma forma privilegiada e privada, restrita a determinados sujeitos. É somente por meio dela que se reconhecia a constituição de filhos e filhas legítimos/as. Em alguns escritos, observa-se, ainda, “o valor que se atribuía à beleza da esposa, à importância das relações sexuais que se podia ter com ela, ou à existência de um amor recíproco” (Foucault, 2024a, p. 184).

De todo modo, as questões relativas ao casamento e à busca pelos prazeres não estavam desvinculadas, mas articuladas ao “conceito” de matrimônio vivenciado na Antiguidade. Cada pessoa que compõe o matrimônio desempenha um papel específico.

Ao homem cabia o lugar de “chefe de sua família, ter uma autoridade, exercer um poder que tem na ‘casa’ seu lugar de aplicação e, dentro desse quadro, manter a obrigação que tem efeitos sobre a reputação do cidadão” (Foucault, 2024a, p. 185). Esse desempenho refere-se à boa conduta, articulada ao que foi anteriormente apontado a partir das relações entre o cuidado de si e o governo dos outros.

Para a mulher no casamento, isso sinaliza que, ao estar sob o poder do marido, suas responsabilidades não são escolhidas por si, mas imputadas por ele. A

forma de demonstração desse domínio e desse poder manifesta-se na limitação de suas relações sexuais exclusivamente ao marido. Para a mulher, tal restrição evidencia a assimetria de poder; para o homem, constitui uma forma de afirmar seu domínio sobre a esposa.

Ainda assim, Foucault (2024a) prossegue mostrando como a relação do matrimônio e a constituição da família se apresentam como problemáticas. Para isso, mobiliza os escritos de Xenofonte, que refletem sobre “a arte de comandar” no âmbito da casa.

De um lado, a esposa, por ter sob sua responsabilidade os cuidados domésticos, é reconhecida como a figura primordial na gestão da casa, de modo que “para mim, considero que uma mulher que é boa associada no governo da casa é tão importante como o homem para a causa comum” (Foucault, 2024a, p. 189).

Para que a esposa possa exercer o governo da casa, era necessário que tivesse, previamente, uma formação voltada a esses cuidados, a qual era atribuída ao próprio marido. Antes do casamento, ao que tudo indica, não havia uma formação doméstica sistemática realizada pela mãe. Cabia ao marido, portanto, “a necessidade de estabelecer com sua mulher relações que são ao mesmo tempo de formação e direção” (Foucault, 2024a, p. 189).

Considerando que as meninas se casavam muito jovens, em torno dos 15 anos, e que os homens, por sua vez, já se encontravam em idade mais avançada, por volta dos 30 anos, a casa configurava-se como uma espécie de escola, na qual o marido se inscrevia por meio de uma pedagogia voltada ao governo das condutas.

Ao marido, cabia a responsabilidade de bem conduzir esse trabalho educativo. Caso contrário, o fracasso da mulher enquanto dona de casa não recaía sobre ela, mas sobre o próprio marido.

Assim, ao assumir a responsabilidade pela casa, a mulher possibilita que o marido se dedique aos negócios fora do âmbito doméstico, exercendo o papel masculino associado ao trabalho no campo, às atividades comerciais, entre outras. “O vínculo matrimonial é, portanto, caracterizado por sua dissimetria de origem — o homem decide por si próprio, enquanto a família decide pela jovem — e por sua dupla finalidade: a casa e os filhos” (Foucault, 2024a, p. 191).

Em outros escritos, a visão de matrimônio é apresentada como uma associação constituída a partir da casa e da família. Ambos têm a função de assegurar a manutenção e o desenvolvimento do lar, criando, por meio dessa associação, uma

“comunidade”. Como afirma Foucault, “o marido é geralmente aquele que faz entrar os bens na casa; mas é a gestão da mulher que, mais frequentemente, regula seu gasto. Os dois papéis são exatamente complementares, e a ausência de um tornaria o outro inútil” (Foucault, 2024a, p. 193).

Soma-se a esses escritos a construção dos corpos a partir de uma descrição de caráter em que o homem é descrito como mais rústico, apto a suportar os contextos externos, como o calor, o frio e a chuva, em razão do trabalho que lhe cabe exercer. As mulheres, por desempenharem suas funções no interior da casa, são descritas como portadoras do medo e, a partir dele, da sabedoria e da preocupação com os assuntos domésticos.

Contudo, há um elemento comum a ambos, pois “tanto o homem quanto a mulher, cada um em seu papel, têm a dar e a receber, posto que, em sua atividade como responsáveis pela casa, eles têm, ao mesmo tempo, que recolher e distribuir; recebem igualmente a memória e a atenção” (Foucault, 2024a, p. 194).

Em *História da Sexualidade*, volume I: a vontade de saber (2015b), Foucault dedica-se a traçar linhas de análise que permitem pensar a família a partir do cenário burguês. Considerando que o foco da obra se volta à problematização da vontade de saber, buscaremos apreender esse movimento no recorte específico da família.

No século XVII, algumas características ajudam a compreender o modo como a sociedade e as instituições passam a se organizar. Trata-se de um período marcado pelas monarquias absolutistas e pela crise instaurada pela Reforma Protestante em relação à Igreja Católica, o qual Foucault descreve como um momento de repressão ao sexo, formulando, a partir disso, a conhecida hipótese repressiva.

A realidade do sexo passa a ser atenuada pela linguagem com a intenção de exercer controle sobre sua livre circulação. Desse modo, constrói-se um discurso sobre o sexo no qual aquilo que se diz é progressivamente banido, assim como as referências que lhe conferem existência e lembrança.

Trata-se de algo que não poderia ser nomeado diretamente. Instaura-se, então, um pudor caracterizado por proibições que dialogam de forma harmônica com o silêncio, o qual se populariza como censura. Tal realidade estabelece locais e momentos de interdição, produzindo o que Foucault descreve como um “silêncio absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre pais e filhos, por exemplo [...] É quase certo ter havido uma economia restritiva” (Foucault, 2015b, p. 20).

A realidade do sexo no século XVIII passa por ressignificações em relação às suas restrições, acompanhando o avanço da pastoral católica. Há uma incitação ao discurso sobre o sexo, não apenas no que diz respeito ao que contrariava as regras, como a nomeação das “depravações”, mas também porque aquilo que por muito tempo foi proibido transforma-se em força para sua própria desinterdição.

Aquilo que não era dito passa a adquirir valor, na medida em que se observa a “multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio campo do exercício do poder: incitação institucional a falar do sexo e a falar dele cada vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar [...] detalhe infinitamente acumulado” (Foucault, 2015b, p. 20).

O “deixar falar” não decorria de uma simples fraqueza de um poder que se perpetuava, mas constituía uma nova possibilidade de exercício do poder em instâncias mais profundas. A Igreja Católica, a partir do sacramento da confissão, percebeu ser uma oportunidade de coletar, por meio das falas, elementos que poderiam ser utilizados como instrumentos de controle sobre as próprias pessoas confessantes.

A curiosidade em ouvir era tão intensa quanto a exigência de detalhamento, como se observa na descrição do “posicionamento respectivo dos parceiros, atitudes tomadas, gestos, toques, momento exato do prazer — todo um exame minucioso do ato sexual em sua própria execução” (Foucault, 2015b, p. 21).

O ato de confessar, que se mantém até os dias atuais, conserva o propósito de levar as pessoas, ao relatarem aquilo que foi feito com a carne-desejo, a realizarem um exame de consciência acerca das infrações cometidas e, a partir delas, procederem à correção por meio da penitência. Trata-se do reforço do erro e do proibido, daquilo que foi discursivamente posto em circulação e naturalizado na sociedade.

O que se exige na confissão é a produção da verdade que a própria instituição busca apagar. Quanto mais se fala, mais se afirma uma verdade que se pretende eliminar, “pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, no jogo da confissão e da direção pastoral” (Foucault, 2015b, p. 21).

Foucault (2015b) analisa o século XVIII escrevendo no século XX, e eu, no século XXI, observo a permanência dessa mesma lógica em um panfleto distribuído às crianças que irão realizar a Primeira Eucaristia. O folheto tem como título: “Para

fazer uma BOA CONFISSÃO é preciso”, e apresenta as seguintes etapas: exame de consciência, para descobrir os meus pecados; arrependimento, dor sincera pelos pecados cometidos; propósito, vontade de não querer pecar mais; confissão, contar os meus pecados a um padre; satisfação, rezar ou cumprir alguma penitência determinada pelo padre. Ou seja, o ato de falar continua operando como um mecanismo de controle e de poder utilizado pela Igreja.

A formulação do casamento e da família está explicitamente impressa nos ideais de progresso que a população traz para esse novo século. Doravante, uma das formas possíveis de lidar com a quantidade de pessoas que passam a integrar a sociedade se dá por meio do sexo. Por isso, evidencia-se a necessidade de atenção aos índices de nascimento, à faixa etária em que ocorrem os casamentos, à classificação dos nascimentos como legítimos ou ilegítimos, às relações precoces e à sua frequência, entre tantas outras questões ligadas ao discurso produzido em torno do sexo.

Esse discurso reverbera na ideia de produção de pessoas virtuosas, que, concomitantemente, estarão inseridas nas famílias; daí o interesse em conhecer, por meio do sexo, a conduta da vida, esse desejo de saber. “Surge a análise das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o econômico” (Foucault, 2015b, p. 29).

Desse modo, as práticas sexuais no findar do século XVIII são reguladas por três instâncias: o direito canônico, a partir de normas elaboradas para gerir a vida em comunidade, como, por exemplo, a confissão enquanto condição para o recebimento da eucaristia; a pastoral cristã, expressa nas catequeses e celebrações litúrgicas; e a lei civil, construída com base na moral e nos costumes.

Todas essas instâncias operam no sentido de traçar a linha que classifica o correto e o incorreto, com foco em aspectos das relações matrimoniais, tais como “o dever conjugal, a capacidade de desempenhá-lo, a forma pela qual era cumprido, as exigências e as violências que o acompanhavam, as carícias inúteis ou indevidas às quais servia de pretexto, sua fecundidade ou a maneira empregada para torná-lo estéril” (Foucault, 2015b, p. 41).

Por mais que pareça que o peso do controle exercido sobre os casais, a partir da prática sexual e da sexualidade, ambos como meios de produção e exercício do poder, os filhos e as filhas não escapavam à vigilância e ao controle impostos aos corpos e aos desejos. Qualquer sinal de manifestação considerada indesejada pelos

órgãos regulatórios acionava dispositivos destinados a capturar os desvios, como se houvesse a implementação de múltiplos mecanismos espalhados por todo o espaço social, conduzindo livremente as/os pequenas/os infratoras/es à confissão de seus perigos e pecados.

Em caso de falha, a culpa poderia recair sobre seus familiares. Cabia-lhes, então, manter-se constantemente “vigilantes diante desse perigo recorrente [...] implantadas sobre o espaço familiar as bases de todo um regime médico-sexual. O ‘vício da criança’ não é tanto um inimigo, mas um suporte; pode-se muito bem designá-lo como o mal a ser suprimido” (Foucault, 2015b, p. 47).

Foucault (2015b), ao olhar para o século XIX, pergunta se a família, entendida de forma ampla, isto é, como o conjunto de pessoas que habitam a casa e participam da manutenção da vida familiar, não apenas os parentes consanguíneos, mas também empregados e outras pessoas que ali circulam, não seria, acaso, o fundamento do que conhecemos por monogamia e fidelidade.

Sua resposta jamais se apresenta como generalização, mas como abertura para o campo dos possíveis. O que se pode afirmar é que, a partir das novas percepções e descobertas do século XIX, tudo passa a ser rigorosamente dividido: não se misturam crianças e adultos; seus dormitórios são separados; meninas e meninos são diferenciados; constroem-se regras específicas para o cuidado dos bebês; instala-se uma fixação em torno da sexualidade infantil.

A masturbação surge como ameaça, a puberdade como momento de atenção redobrada sobre as/os adolescentes e, em tudo isso, estabelece-se uma vigilância constante atribuída aos familiares. Trata-se de micropoderes extraídos de macropoderes religiosos, estatais, econômicos e médicos, um tipo de zoom mais próximo que captura, de forma minuciosa, os acontecimentos relativos ao sexo e à sexualidade.

Não obstante, as sociedades caracterizadas como burguesas nos séculos seguintes, XIX e XX, não deixam de seguir linhas de perversão, o que impede que sejam compreendidas como hipócritas. Ao contrário, tais discursos e práticas estiveram presentes de modo explícito, como forma de inscrever o poder alcançado sobre o corpo e o sexo. Esse poder não se encontra diretamente inscrito nas leis, seja na forma de deveres, seja nas penas a serem pagas.

A maneira como o poder atua é mais ampla: ele se desloca, se rearranja, toma o corpo como razão de ser e como critério de classificação das pessoas. Em suma, “a

sociedade moderna é perversa, não a despeito de seu puritanismo ou como reação à sua hipocrisia: é perversa real e diretamente” (Foucault, 2015b, p. 53).

Ao tratar das formas de existência de múltiplas sexualidades, evidencia-se, aqui, a centralidade conferida à sexualidade da criança e/ou do adolescente. Nesses corpos inscrevem-se marcas, seja pela masturbação, seja pelos desejos, que passam a organizar modos específicos de exercício do poder. Essas marcas nomeiam tais sexualidades como pecado, desvio ou depravação.

Constituem, assim, meios e estratégias pelos quais o poder se faz operar com vistas à regulação. Ou seja, “tais comportamentos polimorfos foram, realmente, extraídos do corpo dos homens, de seus prazeres; ou melhor, foram consolidados neles; mediante múltiplos dispositivos de poder, foram solicitados, instalados, isolados, intensificados, incorporados” (Foucault, 2015b, p. 53).

Diretamente, a nomeação das mais diversas formas de sexualidade como perversão não resulta de um sentimento ou desejo de vingança contra comportamentos considerados de risco. Tampouco decorre de um impulso masoquista que buscava inverter posições por meio da dor imposta pelas penas e regulações.

Trata-se, antes, de um instrumento de poder que, “através do isolamento, da intensificação e da consolidação das sexualidades periféricas, faz com que as relações de poder com o sexo e o prazer se ramifiquem e se multipliquem, meçam o corpo e penetrem nas condutas” (Foucault, 2015b, p. 54).

Todo esse trabalho no qual prazer e poder se autorrelacionam visa a um ganho e/ou proveito compartilhado entre diferentes instituições. Seja a medicina, ao biologizar a sexualidade; a psiquiatria, ao patologizar os comportamentos; ou ainda a prostituição e a pornografia, ao fornecerem meios e formas de acesso ao prazer e, com isso, ampliarem os dispositivos que o regulam.

A essas relações Foucault compreende como um movimento que o “prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra o outro; seguem-se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de mecanismos complexos e positivos, de excitação e de incitação” (Foucault, 2015b, p. 54).

Outro momento em que foi possível acompanhar Foucault ao tratar da relação com a família encontra-se em *Os anormais* (2010a), especificamente na aula de 5 de março de 1975. Nessa aula, o problema que orienta a reflexão diz respeito à masturbação.

As considerações apresentadas resultam de diversos recortes históricos que abrangem os séculos XVI ao XIX e buscam observar, de modo preciso e evolutivo, como “a tecnologia cristã de governo dos indivíduos tentou controlar os efeitos dessa carne convulsiva, desse corpo em movimento, de agitação e de prazer, e isso por diferentes meios” (Foucault, 2010a, p. 201). Tal perspectiva mostra-se particularmente relevante no recorte que aqui realizamos acerca da família.

Foucault (2010a), ao analisar uma ampla variedade de materiais, consegue evidenciar a realidade da perseguição aos corpos e à sexualidade de crianças e adolescentes. Isso equivale a afirmar que existiam tratados que descreviam as formas e os modos de tratar crianças e adolescentes com o objetivo de impedi-los/as de se masturbarem.

Nesses tratados, além de textos, havia ilustrações que, por meio dos discursos produzidos, apresentavam a masturbação como algo ruim e doentio, capaz de trazer consequências drásticas ao corpo e à vida. A masturbação era compreendida como um vício passível de cura por meio de remédios. Ressalta-se que esse trabalho empreendido tinha como foco, sobretudo, as famílias burguesas.

Dentre as táticas da chamada *cruzada antimasturbatória*, não havia apenas o projeto de incutir na mentalidade de crianças e adolescentes, por meio de campanhas, propagandas e da mobilização das famílias, o sentimento de culpa, mas também a produção de discursos moralizadores que antecederiam a tentativa de patologizar o comportamento e a prática masturbatória.

Elencam-se ao menos três formas distintas na busca de produzir uma somatização do ato masturbatório como doença do corpo. A primeira, denominada ficção da doença total, é caracterizada como “uma espécie de doença polimorfa, absoluta, sem remissão, que cumulava em si todos os sintomas de todas as doenças possíveis, ou, em todo o caso, uma quantidade considerável de sintomas” (Foucault, 2010a, p. 207).

Ressalta-se que as descrições realizadas são produzidas por médicos e veiculadas em materiais considerados científicos à época. A caracterização apresentada se dá a partir dos supostos efeitos da masturbação, compreendida como uma prática que conduziria ao padecimento do corpo. Trata-se de um discurso que descreve, passo a passo, os efeitos atribuídos à masturbação como um caminho que levaria à morte.

A segunda forma é nomeada por Foucault como *fabulação científica*, que consiste em inscrever, no contexto das narrativas médicas contra a masturbação, uma descrição de cunho moral. Tais descrições estão presentes nos mais diversos livros escritos sobre diferentes doenças por médicos oficialmente reconhecidos à época, nos quais não se encontra a masturbação como origem de uma única doença fabulosa e total, mas como causa possível de todas as doenças possíveis (Foucault, 2010a, p. 207).

A terceira forma pela qual a somatização da masturbação aparece no corpo pode ser caracterizada como *delírio hipocondríaco*. O delírio, em uma perspectiva geral, representa uma confusão entre fatos e realidade, sendo uma das categorias mobilizadas na História da Loucura para a classificação dos sujeitos considerados loucos. No caso do *sujeito hipocondríaco*, trata-se de uma ansiedade e de uma preocupação excessiva com a própria saúde.

Uma vez criado esse cenário, que reforça a ideia de doença e de perigo, utiliza-se desse estado em que se encontram os/as punheteiros/as para induzi-los/as a confessar que os efeitos de tais delírios decorrem da masturbação. Ou seja, havia todo um movimento, conduzido por médicos, que levava as pessoas a narrar os efeitos do delírio como resultado da prática masturbatória.

A “confissão” aparece, por exemplo, por meio de cartas, em um “gênero literário que é a pequena autobiografia do masturbador, autobiografia inteiramente centrada em seu corpo, [...] na história de suas doenças, de suas sensações, de todos os seus diferentes distúrbios, detalhada desde a sua infância” (Foucault, 2010a, p. 208).

Todos esses acontecimentos resultam na caracterização de uma nova postura de causa e efeito, que se consolida na transição do século XVIII para o século XIX. A partir das campanhas contra a masturbação, que passaram a inscrever na sexualidade a promessa de um conhecimento seguro, isto é, científico sobretudo ao tomar a masturbação como efeito de um erotismo próprio de cada sujeito, a anatomia patológica começa gradualmente a se afirmar em seu campo de atuação, juntamente com a consolidação da clínica médica.

Isso implica que, a partir da sexualidade, torna-se possível produzir explicações para fenômenos que anteriormente não encontravam inteligibilidade. Soma-se a isso a introdução de uma “causalidade adicional”, uma vez que se sobrepõe às causas visíveis e identificáveis no corpo uma espécie de etiologia

histórica, que atribui ao próprio doente a responsabilidade por sua doença: “se você está doente, é porque quis; se seu corpo foi atingido, é porque você o tocou” (Foucault, 2010a, p. 210).

Remete aos discursos que circularam e que, ainda hoje, vez ou outra, continuam a circular nas sociedades contemporâneas, nos quais uma das questões dirigidas às pessoas soropositivas recai sobre o uso dos prazeres e das sexualidades, compreendidos como efeito e/ou como uma espécie de pagamento por escolhas consideradas “erradas”.

O que se pode dizer, diante do silêncio e do não dito sobre o sexo, a sexualidade e as escolhas, é que a família esquivou-se de dizer, ocupando-se, em contrapartida, de reprimir e perseguir, como táticas destinadas a fazer cessar o corpo, como se isso pudesse funcionar como um freio capaz de travar o comportamento, a vida e a própria existência que se dá dentro e fora do corpo.

A família, assim, nesse contexto que Foucault (2010a) denomina de *cruzadas* e não de forma inocente, é convocada como um núcleo de responsabilidade pelas causas e consequências do ato masturbatório. Para isso, exige-se que, no interior da casa, em todos os seus espaços, haja uma vigilância constante sobre todas as pessoas que ali residem, sejam familiares, pessoas funcionárias, irmãos ou irmãs; enfim, todo corpo passa a ser considerado um perigo potencial.

Por isso, “o espaço da família deve ser um espaço de vigilância contínua. Na hora do banho, de deitar, de acordar, durante o sono, as crianças devem ser vigiadas. Em torno das crianças, em suas roupas, em seu corpo, os pais devem estar à espreita” (Foucault, 2010a, p. 213).

Essa mentalidade instaurada, na qual os familiares passam a ocupar o lugar de vigilantes do corpo, faz com que o próprio corpo se torne objeto permanente de inspeção: a cor da pele que apresenta qualquer alteração, os olhos com aspecto de cansaço ou mesmo um relaxamento corporal passam a ser interpretados como sintomas atribuídos à masturbação.

Insere-se, nesse campo de vigilância, não apenas o olhar atento, mas também o uso de “armadilhas” destinadas a surpreender a criança e/ou o adolescente em flagrante. Por isso, recomenda-se que não sejam deixados/as sozinhos/as, que haja atenção redobrada nos momentos de dormir e de acordar considerados propícios para o alívio corporal, com o objetivo de flagrar, incutir o medo e evitar a reincidência do suposto erro.

As descrições de como essa mentalidade familiar passa a operar são apresentadas por Foucault como a “grande dramaturgia familiar do século XIX e do século XX: esse teatrinho da comédia e da tragédia de família, com suas camas, seus lençóis, com a noite, com os abajures, com as aproximações na ponta do pé, com os cheiros, com as manchas nos lençóis [...]” (Foucault, 2010a, p. 214).

Essas técnicas constituem formas pelas quais se cria uma ligação entre os corpos por meio de um outro tipo de cordão umbilical, agora associado ao controle do prazer e à interdição do gozo. Literalmente, há esse cordão que amarra, como nos exemplos apresentados em que o pai ata uma corda à mão do filho e a outra extremidade à sua própria mão durante o sono noturno. Qualquer movimento aciona o contato, permitindo ao pai impedir que a infração ocorra.

As táticas, como temos mencionado, nascem das produções discursivas da medicina, a qual, por sua vez, conserva traços da moral cristã. A família passa a ocupar o lugar de mais um tentáculo do poder, sobretudo a partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX. Outras práticas passam a ser exercidas sobre os corpos, especialmente sobre o corpo das meninas.

É recorrente nos escritos da época a referência à castração feminina, por meio da retirada do clitóris, apresentada como uma prática admissível. Um dos grandes teóricos do século XIX sobre as práticas de castração é mencionado nas análises realizadas por Foucault, ao citar o argumento de que tal procedimento não seria feito para “ofender o senso moral, mas, ao contrário, estaria conforme às suas exigências mais severas. Faz-se como todos os dias, quando se amputa um membro: sacrifica-se o acessório pelo principal, a parte pelo todo [...] não as impede de virem a ser boas mães e esposas-modelo” (Foucault, 2010a, p. 220).

Todo esse investimento sobre a sexualidade de crianças e adolescentes, ao atravessar a instância religiosa, articula-se com a medicina e, em seguida, alcança a família. Os discursos produzidos nesses diferentes contextos visam ao cuidado da vida dessas pessoas, com o objetivo de evitar a morte e, assim, colaborar para a economia da sociedade, seja por meio do trabalho, seja pela reprodução de outros corpos que também irão trabalhar e sustentar a estrutura do sistema. Não obstante, há aí uma intencionalidade política e econômica, na qual o papel da família torna-se imprescindível.

Cabe, então, perguntar se, hoje, as preocupações que se movimentam em torno do corpo e da sexualidade produzidas por políticas públicas, instituições

religiosas e empresas não estariam ressignificando antigas táticas de poder, utilizando as famílias como ferramentas, sobretudo diante da precariedade social. Tal movimento aparece, muitas vezes, como uma resposta positiva alimentada por promessas que, na prática, não se realizam, como a prosperidade ou o ideal de um outro mundo que não seja este.

Como se, aqui, já não houvesse espaço para que alguns ascendam, restando apenas a mitologia do céu e do paraíso como compensação simbólica de uma promessa cuja verificação empírica permanece impossível, uma vez que, como se sabe, nenhum morto retornou para atestar sua validade.

As relações que podemos traçar a partir dos escritos de Foucault indicam que, em cada período histórico, os contextos cultural e político prescrevem as formas pelas quais as instituições são criadas e vividas. Podemos considerar que, na contemporaneidade, o modelo de família carrega traços, recortes e perpetuações do passado, ao mesmo tempo em que apresenta fissuras e deslocamentos.

Ainda assim, os modelos familiares que reproduzimos hoje continuam a regular os discursos sobre a sexualidade, comprometendo, em muitos casos, tanto a formação quanto a vivência de práticas sexuais seguras.

A concepção de família tradicional, embora frequentemente corrompida na prática, orienta-se por elementos herdados do passado, ancorados em modelos antigos. As instituições movimentam-se para perpetuar e manter o status considerado “correto” do ser-família e das relações entre as pessoas que a compõem.

Nesse campo de forças, contudo, surgem fissuras. Filhos e filhas homossexuais, com sexualidades e práticas consideradas “aberrantes”, deslocam os móveis da casa e desestabilizam suas ordens simbólicas, processo que, muitas vezes, é atravessado por dores e por diversas formas de violência, quando o ideal não se realiza conforme o projeto familiar.

Tais violências se articulam aos papéis de gênero previamente atribuídos e à expectativa de continuidade que cada corpo familiar é incumbido de sustentar, seja em nome de um plano divino, da tradição ou das exigências da própria sociedade.

A família, ao desempenhar esse papel como dispositivo regulatório da sexualidade, compromete as experiências de seus filhos e filhas, colocando-as sob risco. Na busca por vivenciar o desejo e a sexualidade, para algumas pessoas, a clandestinidade torna-se uma porta cuja travessia pode conduzir ao encontro com situações de extrema vulnerabilidade, inclusive à morte.

Diante da ausência de circulação do tema da sexualidade no âmbito familiar, as experiências sexuais podem tornar-se traumáticas, atravessadas por abusos, desproteção, exposição a infecções, como o HIV, pela não realização de testes e por consequências que podem levar à morte.

O silêncio da família revela-se produtivo justamente por não tratar de determinados assuntos: ela produz experiências marcadas pelo sofrimento, muitas das quais poderiam ser evitadas, instaurando uma esfera de medo, culpa e distanciamento de si.

Pode-se pensar que a família, ao se ausentar em tratar tais temas, expõe seus filhos e filhas ao não cuidado de si. Ao não estabelecer uma ética que eduque para as práticas possíveis dos prazeres, deixa de oferecer referenciais para uma vivência responsável da sexualidade.

Do mesmo modo, ao negar a possibilidade do uso dos prazeres, desconsidera ou mesmo reforça negativamente a ideia de que o casamento não é, por si só, um espaço garantidor de fidelidade e segurança, assim como ignora que relações heterossexuais não são as únicas formas legítimas de expressão do desejo.

Sobretudo no interior do arranjo religioso-cristão, há uma recusa em reconhecer que as relações se inscrevem no campo do possível dos desejos não heterossexuais, incluindo práticas como o *chemsex* e tantas outras que existem e persistem, ainda que escapem ao quadro de saber que muitas famílias se negam a aceitar.

Eixo 4: Quando a aula produz medo e não cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS na voz de pessoas soropositivas

Nas leituras realizadas na busca por identificar o tema da educação, observa-se que este não foi tratado por Foucault de modo direto ou sistemático em uma obra específica. Contudo, em textos como *Vigiar e Punir* (2014b), especialmente na análise da disciplina, a escola aparece como uma das instituições centrais. O mesmo ocorre em outras obras, como *Microfísica do poder* (2025a) e *A ordem do discurso* (2014a), nas quais a educação emerge de forma transversal.

Além disso, em entrevistas como a concedida à rádio Radioscopie (1975) e em *Conversation with Michel Foucault* (1971), o tema aparece de maneira mais direta.

O pensamento de Foucault, contudo, não se apresenta como um manual prescritivo, mas como um campo analítico possível a partir de suas investigações.

Suas reflexões sobre as relações de poder, a constituição do sujeito, as formas de subjetivação, entre outros aspectos, oferecem ferramentas conceituais que, ao serem articuladas com o campo da escola e da educação, tornam-se potentes para a análise e problematização dos dados produzidos nesta tese.

Em *Vigiar e Punir* (2014b), ao tratar do capítulo “A disciplina”, Foucault afirma não ter a intenção de realizar uma história das diversas instituições disciplinares. Segundo o autor, um estudo particularizado de cada instituição não alteraria o fato de que as técnicas utilizadas para disciplinar mantêm um certo conjunto de meios comuns, perceptíveis em todas elas.

Ao mencionar as instituições que utiliza como exemplo para demonstrar o funcionamento da disciplina, Foucault cita os quartéis, os conventos, os colégios, as escolas primárias e os hospitais. Os períodos analisados abrangem desde o século XVII, passando pelo XVIII, até alcançar o século XIX. A disciplina, em linhas gerais, desperta interesse porque “define um certo modo de investimento político e detalhado do corpo” (Foucault, 2014b, p. 136).

Uma vez delineadas as linhas que estruturam o espaço das reflexões, a disciplina tão presente na escola, seja nas matérias, nos comportamentos ou na organização escolar coloca-se como uma questão à qual Foucault se dedica a responder. Em diversos momentos de sua obra, sua definição reaparece e, a cada formulação, amplia-se a compreensão do que ela significa.

A disciplina é entendida como “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade; são o que podemos chamar de disciplinas” (Foucault, 2014b, p. 135). Em outros momentos, é apresentada como uma forma que “fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis” (Foucault, 2014b, p. 135). Foucault também a define como “uma anatomia política do detalhe” (Foucault, 2014b, p. 137).

O corpo dócil é aquele que se apresenta como manipulável, comparável a uma massa de moldar. Trata-se de um processo de escultura orientado por intenções previamente definidas, que visam aperfeiçoá-lo e torná-lo útil dentro do contexto em que é produzido. Assim como um animal pode ser adestrado, o corpo humano também

o é, sendo transformado em um corpo inteligível, isto é, um corpo que pode ser lido sem ambiguidades, de modo que nada obstrua sua compreensão.

A sujeição, por sua vez, refere-se aos processos disciplinares. Neles, o sujeito é atravessado por relações de poder e pelos saberes que delas derivam. Esses processos têm como finalidade moldar suas especificidades, como a identidade, o comportamento, a visão de si e as relações com os outros e com o mundo. O corpo dócil e a sujeição configuram-se, assim, como efeitos produzidos pela disciplina.

Na análise, a época descrita como Clássica corresponde ao momento em que o corpo passa a receber atenção sistemática, tornando-se “objeto e alvo de poder [...] que se manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam” (Foucault, 2014b, p. 134).

Todavia, já no século XVII, essa lógica pode ser percebida a partir da figura do corpo do soldado, reconhecido como um signo universal por sua aparência, força, bravura e por outras características produzidas com a finalidade de servir, seja para matar, seja para morrer. Foucault (2014b) ressalta que o corpo foi alvo de interesse também em outras épocas, sendo submetido a proibições e obrigações. No que concerne ao século XVIII, elaboram-se técnicas derivadas do século XVII, com o intuito de produzir novas formas de dominação.

Essas novas técnicas são descritas por Foucault (2014b) como uma mecânica que faz com que tudo aquilo que o corpo produz desde os “movimentos, gestos, atitudes, rapidez” (p. 135), seja passível de transformação e controle. Por meio desse controle, estabelece-se uma economia voltada aos efeitos, seja no tempo, seja no espaço, com o objetivo de tornar os corpos produtivos.

A partir de todo esse empreendimento, torna-se possível criar definições sobre o corpo por meio do saber que se desenvolve a seu respeito. A isso pode-se dar o nome de uma “*mecânica do poder*”, que “define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros/as, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (Foucault, 2014b, p. 135).

Quando pensamos sobre o que a disciplina produz, não é difícil perceber que, embora esteja presente de forma laicizada por exemplo, nas escolas, ela se constrói a partir de técnicas religiosas, como o ascetismo. Nos cuidados minuciosos exercidos sobre as condutas “naturalizadas”, observa-se a anulação do prazer, a negação

daquilo que pode satisfazer o corpo e outras práticas orientadas, originalmente, para o alcance espiritual.

Na escola, essas técnicas podem aparecer como uma espécie de espaço religioso do corpo: as vestimentas, as formas corretas de circulação, os assuntos permitidos, entre tantos outros elementos, que se assemelham aos mecanismos da fábrica, como o sinal, as fileiras, o refeitório, as idas ao banheiro, entre outros.

Ainda que estejamos olhando para a escola em todo o seu projeto de disciplinarização, é importante destacar que outras instituições também operam na produção disciplinar dos corpos. Ou seja, não existe instituição que não discipline o corpo.

A disciplina, no contexto escolar, está materializada na arquitetura, em como é construída para dispor os corpos intencionalmente, de modo que a vigilância e a utilidade do tempo e do espaço sejam utilizadas em seu máximo. Isso está presente até os dias atuais em boa parte das escolas.

Contudo, a disciplina não consiste apenas na distribuição e alocamento e/ou no funcionamento dos corpos nos espaços. Há um “alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo a ordem de dificuldade crescente. E, nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios” (Foucault, 2014b, p. 144).

Ou seja, não se molda um corpo sem um conhecimento que opere segundo regras produzidas por políticas, interesses de mercado e moralismos religiosos. A escola se constitui pela experiência, mas também pelo modo como seu sistema funciona e espelha a ordem social que a atravessa.

Trata-se de uma herança naturalizada, que integra o próprio sistema do qual a escola faz parte e que, ao estar assentada sobre determinadas bases, sustenta a estrutura tanto da instituição escolar quanto da educação. Essa estrutura é marcada por uma tradição cultural permeada por ideias morais e religiosas presentes no modo de vestir, nas expectativas de comportamento e nos valores considerados legítimos.

A escola é, então, organizada como espaço de aprendizagem orientado por um currículo previamente definido, no qual os saberes seguem uma ordem de aparecimento e circulação. As aprendizagens são reguladas por metas e normas que classificam estudantes como aptos ou vulneráveis e produzem políticas de “bom comportamento”: não sentar com as pernas abertas, usar roupas consideradas

“adequadas”, manter relacionamentos heterossexuais entre tantas outras prescrições que regulam corpos, gestos e modos de existir.

Uma vez que as pessoas que compõem as salas são diversas, cabe à escola, como uma fábrica, ao seguir tais moldes, realizar operações de “quadros vivos que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas” (Foucault, 2014b, p. 145).

A gestão do tempo e do espaço nos afazeres que a escola propõe reflete um corpo educado, que “naturalmente” passa a executar as tarefas como se fosse algo inerente ao próprio funcionamento orgânico do corpo, como, por exemplo, a hierarquia do/a professor/a em relação ao/à estudante, os crucifixos em alguns espaços escolares e que, em sua ausência, estranha-se, e, talvez principalmente, a fila, sendo automática no momento do intervalo.

Não é preciso que alguém mande: a tarefa é automaticamente executada. Importa pensar que a escola, nesses moldes, passa a não ser um espaço do pensamento, por estar, em sua maioria, restrita a “poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais – sinos, palmas, gestos, simples olhar do mestre” (Foucault, 2014b, p. 163).

A ausência do tempo para pensar, preenchida por uma série de tarefas e de vigilâncias mútuas, mostra que a escola é uma arquitetura posta de tal modo para dispor os corpos a fim de serem vistos e reconhecidos. Por ela, tem-se o poder de atuar sobre esses corpos: diretores, coordenadores, inspetores, professores e também as/os alunas/os. O espaço para perguntas e dúvidas sobre o corpo passa “despercebido”.

Isso se liga ao que, na Antiguidade, era prescrito: ocupar o tempo para que o “fogo” dos humores seja equilibrado, ou, como a psicanálise freudiana nomeia, como “sublimação”. Todo esse trabalho visa não apenas uma intersecção política que alcança “no nível da consciência, das representações e no que julgamos saber, mas no nível daquilo que torna possível algum saber” (Foucault, 2014b, p. 181), na qual pode ser selecionado o que pode, o que não pode, qual sua utilidade, seus benefícios e muitos outros.

Outra oportunidade para refletir sobre a escola e a educação está na obra *Microfísica do poder*, de Foucault (2025a), na passagem em que trata do “*Poder-Corpo*”. Ao pensar na escola e na intenção de compreender seu funcionamento dentro dessa rede de poder da qual ela faz parte, destaca-se o papel do poder burguês e sua

estratégia de fazer com que os corpos se tornem funcionais para desempenharem funções industriais na economia capitalista.

Trata-se de um trabalho bem elaborado, no qual a escola participa ao investir em regimes disciplinares que funcionarão em função do que a sociedade capitalista espera: corpo funcional, corpo eficiente, corpo poder.

A relação de poder que é feita no corpo pode ser percebida pelos efeitos que produz. Antes de serem aplicados, esses efeitos foram testados de tal forma que é possível que os corpos, na escola, possam ser governados. A escola é resultado de uma herança cultural, um projeto planejado e que funciona até os dias atuais.

Ainda assim, vale pensar que, embora seja feito o governo dos corpos, haverá corpos desgovernados. Isso porque a escola é um espaço de disputa. As disciplinas cumprem a função de fazer com que os corpos sigam o regime biopolítico que a escola, junto ao Estado, desempenha – regulando e, algumas vezes, reprimindo. Cabe ressaltar que “a noção de repressão, à qual geralmente se reduzem os mecanismos do poder, me parece muito insuficiente, e talvez até perigosa” (Foucault, 2025a, p. 239).

O que se pode dizer é que a repressão criou, no passado, toda uma rede de poder que, pelo saber, é exercida sobre o corpo. Ao contrário da repressão, como esse mecanismo que domina o corpo, o problema pode estar no “enraizamento do poder; as dificuldades que se enfrenta para se desprender dele vêm de todos esses vínculos” (Foucault, 2025a, p. 239).

Tais vínculos podem ser lidos no formato da escola, em uma visão geral, que ainda nos remete ao passado. Embora discursivamente pareça ter mudado, o que pode ser visto são outras formas pelas quais o poder encontrou meios de atuar. Se antes (e talvez ainda hoje) não se falava sobre a sexualidade, isso é substituído pelo não falar sobre o HIV. Ao falar sobre o uso de substâncias ilícitas, entendendo-as como “drogas”, abordam-se suas proibições e perigos, pautados em uma perspectiva de medo, equivocada e moralmente enviesada, possibilitando a produção de visões preconceituosas e estereotipadas.

E, em todo esse emaranhado, não se fala sobre vários assuntos, como o fato de a alimentação estar repleta de venenos e substâncias que, discursivamente, foram licenciadas pelas instituições de poder; busca-se barrar falar sobre política utilizando o discurso de que a escola desempenha o papel de ideologização, entre tantas outras ações que estão comprometidas com o sistema que rege a sociedade capitalista.

É importante considerar que, embora tais assuntos possam circular de forma “clandestina” nas conversas entre poucos, acabam por não ser tratados de forma natural e oficial, em que dúvidas, questões e o próprio aprendizado possam ocorrer.

Ao problematizar outras vertentes de análise, Foucault questiona o entendimento de que o poder está preso ao Estado. Sua reflexão nos guia a perceber que o poder circula, não está fixo: ele está no corpo, nas relações e nas disputas na sociedade, e a escola não se exime.

A isso, o que se pode dizer é que “o poder não está localizado no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado, em um nível muito mais elementar, cotidiano, não forem modificados” (Foucault, 2025a, p. 240).

O Estado talvez participe, mas não é o responsável pelo poder em si, e sim as instituições, que são responsáveis por produzir o que o corpo pode e não pode, sobretudo no sistema em que vivemos. Isso pode sinalizar os mecanismos presentes na escola que barram o que e como são abordados assuntos como o HIV e as pessoas soropositivas.

Embora possamos dizer que as políticas fazem parte do Estado, logo, as políticas também estão atravessadas por instituições que delas se apoderam. O que são, por exemplo, a bancada evangélica e a ruralista? Não falar de forma “legítima” e inserida no cotidiano escolar seria uma forma de extensão em que esses poderes atuam, talvez como micropoderes, regulando o que pode ser falado sobre o HIV, vigiando os comportamentos sexuais não aprovados, classificando, por exemplo, nas salas e nas próprias escolas, quem vai estar.

Uma vez pensadas as questões de poder e sua relação com a escola, há outro momento em que é possível destacar algumas considerações a partir da aula inaugural realizada no Collège de France, em 1970, materializada no livro intitulado *A ordem do discurso*, que Foucault (2014a) proferiu.

Em síntese, trata-se de como a linguagem, o poder e o conhecimento se relacionam, e do papel da sociedade em controlar quais discursos podem circular e quais não. Nessa direção, queremos fazer recortes que possam ser articulados com a educação e a escola, sobretudo aqueles que tratam da exclusão de certos assuntos que não aparecem no interior escolar.

É sabido que, na escola, nem todo discurso é e/ou está em circulação. Há um certo controle, uma seleção bem realizada, em que são colocados como critérios para

seu aparecimento aquilo que pode sinalizar como “perigo” ou “dominação”. A isso se dá o nome de *procedimento de exclusão*. A escola não é um espaço em que se pode falar de tudo, embora nela haja todos os tipos de pessoas e ela seja vendida como um local das diversidades.

Foucault nomeia esse tipo de tática como “*tabu do objeto*”, em que socialmente se entendem procedimentos segundo os quais apenas determinadas pessoas podem falar. Há assuntos, em especial, que são atravessados por interdições, como as questões da “sexualidade e da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes” (Foucault, 2014a, p. 9).

Não se pode falar de tudo, inscreve-se por muitas razões: a preocupação do currículo e de sua aplicabilidade está direcionada ao rendimento, às avaliações e aos dados estatísticos. São priorizados os assuntos que atualmente estão na agenda. Podemos mencionar o reflexo neoliberal e neoconservador nas entrelinhas e nas próprias linhas dos currículos e das atuações escolares. Preocupa-se com o empreendedorismo, com o projeto de vida, mas não se fala sobre viver soropositivo como uma possibilidade do próprio projeto de vida.

Isso possibilita pensar que se restringe o que pode ser dito nos espaços e nas interações. Qual é o tempo em que a palavra dos/as estudantes pode circular? Qual tempo os/as estudantes têm para conversarem livremente? Na aula, é preciso estar em silêncio; no intervalo (15 minutos), mal se come; ir ao banheiro é sempre sozinho. O sistema cria certos impedimentos: na sala, pela vigilância da professora e dos/as estudantes; fora da sala, a inspetora está sempre a acompanhar. Claro que não há como generalizar.

Quando os assuntos sobre determinados temas aparecem, talvez não seja de forma “positiva”, livre ou duradoura. Podem durar minutos, uma aula; por vezes, de forma protocolar. Se olharmos pelas ordens dos assuntos, o tema sobre o HIV aparece como o de um cálculo de matemática? Existe uma regra de importância em que alguns assuntos estão no aparente, enquanto outros ficam no protocolar. Podemos tomar como exemplo, o dia 2 de dezembro, quando fala-se sobre AIDS. Questiona-se: quais são os critérios para que as falas aconteçam?

Assente que o discurso, em Foucault, resulta em um emaranhado de enunciados, que pode ser representado por falas, conceitos e teorias que, ao serem

produzidos, obedecem a um conjunto de regulações sobre como tal assunto deve ser tratado e que resultam no que, no passado, foi determinado. Um exemplo é o que Foucault nos mostrou sobre a produção discursiva da loucura e do/a louco/a. Desse modo, há uma “ordem do discurso própria a um período particular [que] possui, portanto, uma função normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de práticas” (Revel, 2005, p. 37).

Nesse sentido, pensar o discurso como uma ordem, e o da sexualidade nessa regulação, diz respeito não “simplesmente àquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas àquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar” (Foucault, 2014a, p. 10).

Ou seja, o discurso criado sobre a sexualidade está em disputa por aqueles e aquelas que acreditam, cada qual suas razões, estar ou não nas escolas. Em nosso caso, o que mais interessa é dado por ser uma questão que existe enquanto realidade da vida cotidiana e que, ao ser negligenciada ou silenciada, retira o direito dos/as estudantes de saber e até de questionar a forma como têm se constituído enquanto pessoas em processos de assujeitamento.

Quando pensamos em assujeitamentos, não descartamos o fato de que o poder é produtivo. Na escola, no contexto da discussão, percebemos o poder sendo produtivo ao propiciar que corpos soropositivos apareçam em discursos que não reproduzem a história mitológica da AIDS.

Ou seja, na produção de outras identidades afirmativas, mas que acabam sendo assujeitadas por não oferecerem outras opções ou por não serem tratadas como um assunto do cotidiano do corpo discente e docente.

Assujeitam-se os/as estudantes a aprender apenas o que é considerado importante e desconsidera-se que o cotidiano e a realidade dos/as estudantes podem ser o HIV, e isso, ao não ser falado, é algo que pode trazer prejuízos. Reproduz-se, então, a partir do moralismo que se atenua em relações de preconceito entre soronegativos e soropositivos.

Há, contudo, uma vontade de verdade que é expressa em práticas, como a pedagogia, presente nos materiais escolares, nos livros e em tantos outros que servem como meios para o poder atuar e, assim, direcionar o que deve e o que pode estar presente, bem como o que é válido e importante na construção da formação das/os estudantes.

Essa vontade de verdade está voltada a “exercer sobre outros discursos [...] uma espécie de pressão e como que um poder de coerção” (Foucault, 2014a, p. 17). Assim, é possível verificar na sociedade quando, constantemente, a escola é subtraída de poder tratar questões de sexualidade, atravessada pelo discurso sobre “ideologia de gênero” e pelo que, ultimamente, tem se movimentado em torno do discurso de uma “escola sem partido”.

É interessante pensar que boa parte da sociedade tem acesso à educação e ao que nela circula enquanto discurso. Ela é alvo de embates que marcam posições contrárias por divergirem sobre seu papel: para alguns, como os movimentos políticos da extrema direita e grupos cristãos conservadores, é defendida como um instrumento de ideologização; para outros, como grupos políticos da esquerda e pesquisadores, é compreendida como um espaço de formação para a consciência política, entre tantas outras percepções.

Por isso, a escola é, em certa medida, a esperança, por ser a “maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (Foucault, 2014a, p. 41).

Nessa lógica em que o discurso acontece, podemos pensar a escola, o currículo e tudo o que ela envolve como “uma ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes?” (Foucault, 2014a, p. 42). E, em tudo isso, desempenham-se relações de sujeição, como em outros sistemas com as mesmas pretensões: moldar o corpo pela palavra.

Outro momento possível, e talvez um pouco mais direto, sobre as reflexões acerca da educação pode ser visto em uma entrevista concedida por Foucault à rádio francesa Radioscopie, em 10 de março de 1975. Seu interlocutor e entrevistador foi Jacques Chancel. A entrevista pode ser acessada pelo YouTube, com duração de cerca de 54 minutos. Embora seja extensa, as questões abordadas sobre a educação ocupam apenas alguns minutos. A entrevista trata sobre a escola, a educação e os diplomas, conhecimento/poder vs. conhecimento/prazer: *Sur l'école, l'enseignement, les diplômes... Savoir/Pouvoir vs Savoir/Plaisir*.

Já de início, Foucault (1975) problematiza a ideia de professor, uma vez que, no ano em que concedeu a entrevista, trabalhava no Collège de France. Tal

problematização pauta-se na ideia de ser professor um papel exercido a partir da relação de poder entre ele e seus estudantes.

A relação de poder existe na posição do professor, que detém o saber e, por ele, esse saber deve ser ensinado, criando um espaço que coloca, de um lado, o professor e, de outro, as/os estudantes. A definição feita por Foucault sobre o papel do professor é aquele

que diz uma série de coisas que você não sabe, mas que deveria saber – é a primeira etapa – que eu chamo de culpabilização se você quiser; como segunda, essas coisas que você deveria saber, eu as sei e eu as ensino – esse o estágio da obrigação. Ao final, eu verificarei se você as sabe – é a verificação (Foucault, 1975, não paginado – tradução nossa).

A perspectiva de que Foucault trata é no contexto da universidade, mas isso não nos limita a pensar a escola. O trabalho que Foucault desempenha (1975) é o de ofertar cursos livres. Isso implica não ser uma disciplina que “obriga” estudantes a realizá-la. Logo, as pessoas que tiverem interesse em participar são bem-vindas.

Não há um critério que venha a classificar e qualificar quais pessoas podem estar em sua sala, assim como qual será a avaliação feita, dada pelas próprias pessoas que vêm e participam. Trata-se de uma espécie de seminário em que, ao final, cada pessoa busca falar para as pessoas que ali estarão presentes como um outro formato de avaliação.

O que ousamos pensar é que Foucault discorre sobre um saber que o professor e a professora detêm. Ainda que esses professores não utilizem desse poder, são tratados por ele, em uma produção cultural que vem dos familiares e passa aos seus filhos/as. A escola, assim, disputa o saber que esses e essas professores/as têm com o que as/os estudantes trazem de seus cotidianos.

Cabe a percepção de que haverá saberes que alguns professores utilizarão e que dialogarão com o que as/os estudantes esperam, assim como outros que não utilizarão, em vista de considerarem ideologias, moralismos e outros meios que possam impedir, como as pressões que podem enfrentar dos familiares, da própria gestão e das políticas de governo.

Ao tratar sobre a dinâmica do aprender, o ponto alto é que o ato de aprender está ligado ao prazer. “Há, certamente, uma maneira de erotizar o saber, de torná-lo intensamente agradável. Parece que o professor nem sequer é capaz de revelar isso.

O professor parece ter por função demonstrar como o saber é desagradável, triste, cinzento” (Foucault, 1975, não paginado).

Cumprir esse papel “cinzento” pode ter razões que se conflitam. Uma possível percepção é a de que, na escola, existam professores e professoras formados em um modelo tradicional e que desempenham um tipo de relação com o ensino que reflete uma visão autoritária. Algumas dessas pessoas podem, por assim trabalharem e contribuir para que alguns e algumas estudantes possam ser deportadas (Reis, 2020).

Contudo, a escola também terá professores que rompem com essa lógica, por terem, em algum momento de sua formação, tido algum professor que não reproduziu o formato que Foucault descreve. Ainda existe outro ponto que, nos últimos tempos, tem se colocado como um grande problema para a educação e para os professores. Professoras e professores têm sido alcançados/as pela lógica neoliberalista, fazendo com que seus trabalhos se tornem tristes, frustrantes, cansativos e, por vezes, marcados por mortes e desistências.

O sistema que opera nesse tipo de educação não realiza, de forma ingênua, esse disciplinamento e assujeitamento dos/as professores/as. Logo, estar na sala de aula e ministrar uma aula, nas condições que por vezes são precárias, pode ser um desafio e, assim, o que poderia aparecer dos cotidianos estudantis passa a ser limitado ao que os/as professores/as dão conta no fôlego que aguentam.

Ao tratar sobre o saber, em sua produção, Foucault faz uma distinção entre o conhecimento e o saber. E, na entrevista, ele menciona várias vezes o saber e sua relação com o poder. Essa questão é interessante de ser aberta aqui como um “parêntese”, por haver uma gama de sentidos e, então, entender por que há um prazer no saber, como é mencionado na entrevista.

Revel (2005) faz uma síntese sobre o saber a partir das leituras de Foucault. Segundo ela, a ideia de saber desenvolvida por Foucault remonta ao período Clássico, quando é produzido o discurso da racionalidade. O que vem a ser racionalidade? A classificação dos objetos e de tudo o que se inscreve no mundo entre o que é considerado científico e o que não é. Um pouco do que temos vivido neste tempo, em que precisamos classificar o que é verdade e o que é *fake news*, embora isso nos leve a outras discussões, mas que aqui exemplifica.

Essa classificação divide a sociedade e, ao olharmos e lembrarmos o que Foucault escreveu, estamos divididos por polos: normais e anormais, deficientes e eficientes, heterossexuais e homossexuais, soropositivos e soronegativos, entre

muitos outros pares. Ao ser criada toda essa divisão, é feita uma distribuição no mundo entre as pessoas, que é atravessada pelo governo, nas pessoas do Estado, e por todo o investimento disciplinar das instituições.

Ou seja, a disciplinarização cria saberes a partir do que ela retira do corpo por meio das mais variadas técnicas e os faz colocar em circulação pelo Estado. Ao circular pelo licenciamento que o Estado realiza, cria-se um poder. Os exemplos que Foucault elenca a partir dessa dupla poder/saber podem ser percebidos, como o saber médico que produz a loucura, o saber religioso que produz o pecado, a prisão ao produzir o sujeito dócil, assim como outros (Revel, 2005).

Podemos dizer que muito do que temos hoje como “verdades” resulta de todos esses empreendimentos do passado que, após serem coletados pelas instituições, derivam de suas vontades de saber sobre os indivíduos. O prazer em saber, no contexto da educação, no papel do/a professor/a, tem em vista o objetivo de moldar, a partir do que é pré-estabelecido pelos saberes, a verdade das coisas e das pessoas.

Isso nos leva a pensar que a ausência de tratar assuntos voltados ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas segue essa linha: de um campo que, por um lado, é o tabu que não desperta o interesse de saber da escola e, por outro, um incitador por ter ligações com a sexualidade.

Ao seguir com a entrevista, Foucault (1975) menciona a relação da família com as crianças como angustiante. Isso porque não é considerado o que as crianças sabem, mas apenas o que lhes é imposto a partir do que os adultos acumularam no decorrer de suas formações.

Isso passa a ser uma realidade em muitas escolas, quando os desejos dos familiares são transferidos aos seus filhos e filhas, de forma a pressioná-los/as a cumprirem papéis socialmente aceitos. Além de a escola não ser um local de prazer, ela também se torna um espaço de angústias que podem ser sintetizadas como um aglomerado de sofrimentos.

Não obstante a todo esse sentimento, a escola acaba por se reduzir ao diploma que, por fim, “constitui-se como uma espécie de valor de mercado do saber. Permite, igualmente, demonstrar para aqueles que não o detêm que não são capazes de saber. É isso que dá sentido pleno a um diploma: o que ele vale para aqueles que não o têm” (Foucault, 1975, não paginado).

Outro momento em que foi possível ver Foucault tratar mais de perto das questões sobre educação ocorreu em uma entrevista concedida a John K. Simon, em

1971, intitulada por *Conversation with Michel Foucault*. A entrevista pode ser encontrada na internet, em formato de arquivo PDF, na Partisan Review.

Uma das primeiras perguntas feitas a Foucault é que, embora não se direcione diretamente à educação, mas sobre uma “nova forma de análise”, à qual, supostamente, Simon, o entrevistador, deve estar se referindo à genealogia e à arqueologia. A resposta que nos interessa, dada por Foucault, é a de que olhar para o passado é uma forma de compreendermos o quanto esses fenômenos estão presentes em nossos dias.

Trata-se de uma oportunidade de realizarmos a análise do tempo presente, considerando os desfechos que o passado teve e suas possíveis consequências no hoje. Isso vale para pensar em todo o arcabouço que Foucault desenvolveu e que, mesmo passados alguns anos, ainda se faz pertinente para reavaliarmos as nossas formações.

A entrevista tem como foco conversar a partir dos acontecimentos que ocorrem nas universidades em todo o mundo. E, dada essa consideração, Foucault (1971) é questionado se Paris estava inserida em um mesmo sistema de acontecimentos. Ele responde que há uma complexidade no que tange à transmissão de conhecimento, embora ressalte não ter realizado uma análise ampla.

É perceptível que o contexto da entrevista esteja atravessado por conflitos entre estudantes e o Estado em relação ao ensino nas universidades. Foucault não se esquia de defender e utilizar seus “loucos” como meio de explicar os problemas que o sistema de ensino tem atravessado pela ausência de uma “*técnica de demolição crítica*”.

As pessoas tidas como loucas, ao estarem internadas, não têm o direito de manifestar seu posicionamento. Isso ocorre pela desconsideração que lhes é atribuída, por não terem sua racionalidade considerada como adequada para tanto. O que isso liga ao que Foucault tenta exemplificar é que os/as estudantes que estão reivindicando o sistema de ensino são aqueles que realmente conhecem os problemas que ocorrem, pois são eles/as que estão sendo atingidos/as.

O que há nessa relação de poder é que, por um lado, estão os/as “detentores do saber”, que querem manter seu espaço de poder, e, por outro, estes e estas estudantes, que percebem estar sendo prejudicados/as pela forma como o ensino acontece. Os detentores aos quais nos referimos nem sempre estão ocupando o papel

dos professores que atuam, mas estão nas secretarias de educação, nos ministérios e em tantos outros espaços de poder que visam aplicar intenções de terceiros.

Foucault (1971) segue refletindo a partir da pergunta que Simon lhe faz, ao relacioná-la a um ensaio com o título *The student as nigger*, escrito por um professor americano chamado Jerry Farber, publicado em 1967, que culminou no fato de o texto ganhar repercussão durante os Movimentos dos Direitos Civis Americanos e aparecer como uma forma de questionar a relação entre estudantes e sua exclusão pelas universidades.

Foucault diz que as pesquisas que realizou buscaram mostrar como a sociedade procurou realizar classificações e, por elas, exclusões, e que, não obstante, a universidade também se faz presente nesse processo. Segundo Foucault, as histórias de nossas sociedades recusam aceitar as diferenças e, assim, fazem com que tudo aquilo que não se insere em uma identidade caia no apagamento social e da memória, criando um sistema que reprime cancelando. O exemplo claro de como isso ocorre é com o/a aluno/a:

[...] ele é pego similarmente dentro de um circuito que possui uma função dupla, Primeiro, uma função de exclusão. O aluno é colocado fora da sociedade, em um campus. Além disso, ele é excluído enquanto recebe um conhecimento tradicional absolutamente natural e acadêmico e não diretamente vinculado às necessidades e problemas de hoje. Esta exclusão é sublinhada pela organização em torno do aluno, de mecanismos sociais que têm fictícios artificiais e quase teatrais (relações hierárquicas, exercícios acadêmicos, o "tribunal" de exame, avaliação). Finalmente, ao aluno é dado um modo de vida semelhante a um jogo; é lhe oferecido um tipo de distração, diversão, liberdade que, novamente, não tem nada a ver com a vida real; é esse tipo de sociedade artificial, teatral, uma sociedade de papelão, que está sendo construída em torno dele; e graças a isso, jovens de 18 a 25 anos são, por assim dizer, neutralizados por e para a sociedade, tornados seguros ineficazes, castrados social e politicamente. Existe a primeira função da universidade: tirar os alunos de circulação. Sua segunda função, no entanto, é de integração. Uma vez que um aluno tenha passado seis ou sete anos de sua vida dentro dessa sociedade artificial, ele se torna "absorvível": a sociedade pode consumi-lo. Insidiosamente, ele terá recebido os valores dessa sociedade. Ele terá recebido modelos de comportamento socialmente desejáveis, tipos de ambição, contornos de comportamento político, para que esse ritual de exclusões finalmente assuma? O valor da inclusão e recuperação ou reabsorção. Nesse sentido, a universidade é sem dúvida pouco diferente daqueles sistemas nas chamadas sociedades primitivas nas quais os jovens são mantidos fora da aldeia durante a adolescência, passando por rituais de iniciação que os separam e cortam todo contato entre eles: e a sociedade real e ativa. No final do tempo especificado, eles podem ser totalmente

recuperados ou reabsorvidos (Foucault, 1971, p. 193-194 – Tradução nossa).

Embora seja extensa a citação, não me furtei a manter as palavras de Foucault no intuito de mostrar que, mesmo falando sobre contextos distintos, datando o ano de 1971, na Europa e nos Estados Unidos, não são diferentes do que acontece nos modelos educacionais que temos hoje no Brasil. Seja em suas bases, nos currículos, em como a escola é entendida nas relações que cria, de exclusão ao corpo docente, que parece estar mais doente e inapto/a para seguir sua função. Os desmontes e os atentados cada vez maiores da privatização nas escolas.

Em suma, um teatro trágico que faz com que a educação e a escola sangrem, seja pelas balas perdidas, seja por estudantes que são vítimas de todo esse sistema que reivindica matando seus pares. E, em tudo isso, a realidade que está fora dos muros, como o HIV, fica excluída. O que está dentro dos muros da escola é o preconceito, a estigmatização e a desinformação total.

Outros pontos pertinentes a serem considerados aqui é a ideia que Foucault (1971) esboça sobre “*teatralidade*” nos sistemas de ensino. A teatralidade consiste em como são constituídas as relações de poder e sua apresentação, como “papéis” de um espetáculo que não rompe as estruturas existentes de poder.

No Brasil, a teatralidade não é difícil de ver. Uma simples problematização mostra, por exemplo, quem são os/as estudantes da universidade pública e quem está nas universidades privadas. Ou, ainda, pensar por que, no discurso, tem-se investido tanto no campo biomédico para as questões de HIV e AIDS e, na escola, vive-se uma falência múltipla, de negação, silenciamento e extorsão, acreditando-se que, passados mais de 40 anos, a AIDS ainda é um problema que é prometido ser resolvido e que, pelos meios que seguimos, já sinalizou que não conseguirá.

Isso, sem dúvidas, “é essencialmente a definição dos sistemas implícitos nos quais nos encontramos prisioneiros; o que eu gostaria de apreender é o sistema de limites e exclusão que praticamos sem saber; eu gostaria de tornar o inconsciente cultural aparente” (Foucault, 1971, p. 198).

Em suma, o que Foucault (1971) nos provoca a pensar é que, ao utilizarmos seus estudos no campo da educação, é feito todo um esforço, a partir das palavras, para mostrar o que acontece na realidade e o que tem seguido como um modus

operandi de nossa vida social e política e que, talvez, não estamos vendo ou nos ofuscamos em aceitar.

Buscar na gênese como é formado todo esse sistema nos faz ver um caminho que podemos escapar e/ou enfrentar. Não falar sobre sexualidades, HIV, AIDS e pessoas soropositivas é como se estivéssemos “dessexualizando” nossos/as adolescentes. E isso nos faz insistir em questionar sobre qual direito a escola e a sociedade negam ao tratar das questões de HIV e AIDS, ainda que os números de jovens não parem?

Eixo 5: A arte de reinventar a si mesmo: invenções para o currículo sorotransgredir

Ao pensarmos em uma educação para Sorotransgredir, buscamos possibilitar a reflexão para saltar os muros do preconceito em relação às pessoas soropositivas e a toda a diversidade escolar. Trata-se de uma educação que possa se orientar por elementos que estabeleçam meios para pensar o cuidado de si, no intuito de fazer da vida uma estética da existência.

Essa ideia nos veio a partir das reflexões trabalhadas por Foucault, especialmente a partir do conceito de “*cuidado de si*”, lido em algumas de suas obras, como *História da sexualidade 3 – O cuidado de si* (2024b), *A hermenêutica do sujeito* (2010b), *Ditos e escritos V* (2006), *Dizer a verdade sobre si* (2022a) e *Foucault: o que é a crítica?* (2025b).

A ideia do cuidado de si compõe parte do que foi a Antiguidade greco-romana, sendo encontrada nos escritos de vários pensadores, como Albino, Apuleu, Sêneca, Zenão, Epicteto, Marco Aurélio, Epicuro e outros, que Foucault (2024b; 2025b) lê buscando observar como o cuidado de si estava permeado e difundido no modo de vida daquele povo ao longo dos séculos a.C. e que, séculos depois, foi apropriado pelo cristianismo, não como cuidado de si, mas como negação de si.

Na leitura realizada dos textos desses autores e de outros, está presente a ideia de haver “uma intensificação da relação consigo pela qual o sujeito se constitui enquanto sujeito de seus atos” (Foucault, 2024b, p. 53).

Essa “*intensidade das relações consigo*” diz respeito às mais diversas formas pelas quais o sujeito é convidado a voltar o olhar para si, na intenção de se colocar como centro de um conhecimento que possibilita a construção de si, podendo

transformar-se na autopromoção de sua própria vida. É como se, nesse momento da história, houvesse “o desenvolvimento daquilo que se poderia chamar uma ‘cultura de si’, na qual foram intensificadas e valorizadas as relações de si para consigo” (Foucault, 2024b, p. 56).

Em vista de perceber o que vem a ser essa ideia do cuidado de si, é possível ler, com Foucault (2024b; 2025b), a explicação de que a “cultura de si” está voltada a propiciar uma “*arte da existência*”, sem a presença de um modelo fechado. A arte é a pintura que cada sujeito-artista faz a partir de seus olhares, sentidos, questionamentos, crítica e atenção ao que acontece, sem alienar-se ou contentar-se pelas formas de governo realizadas ao sujeito-artista.

É como se houvesse um inquietar que provoca a aproximação de si, por meio dos atos, dos feitos e do que deles resultam as vivências. O que guia essa cultura é, de fato, seguir os caminhos do cuidado de si, que não se traduz apenas no aspecto corporal, mas destaca a instância intelectual. Essa mentalidade direciona as necessidades, orienta, amplia e organiza a vida, tornando-se uma prática do cotidiano.

O que tudo indica é um princípio de autogoverno. Ouso dizer que se trata de uma vida na consciência de si e do mundo em nosso entorno. Em suma, a cultura de si é

o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é, em todo caso, um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver, desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu, assim, uma prática social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber (Foucault, 2024b, p. 58).

Toda essa descrição é vista por Foucault (2024b) como uma “*arte de viver*”, cujo signo de entendimento, pautado no “cuidado de si”, esteve presente durante os dois primeiros séculos do período Imperial. Trata-se de um intervalo sinalizado como anos de ouro, em que a cultura de si se configurou como um fenômeno presente na sociedade.

Contudo, não se pode deixar de observar que essa realidade possuía recortes: apenas alguns grupos sociais a experienciavam, e, dentre estes, apenas as pessoas da cultura greco-romana a tinham como parte de sua realidade.

Possivelmente os cidadãos a integravam, enquanto os escravos e outras pessoas talvez não fizessem parte desse grupo seletivo.

É importante destacar que, embora o cuidado de si esteja presente nos escritos dos filósofos, como mencionamos no início, ele não se restringia apenas a eles ou às pessoas que buscavam uma vida semelhante à deles. O cuidado de si “é um princípio válido para todos, todo o tempo e durante a vida” (Foucault, 2024b, p. 62).

Resulta, que todas as pessoas possuem seus afazeres, como o trabalho. A ideia do cuidado de si não está voltada ao abandono de tudo para uma vida monástica, como ocorre no cristianismo. Ao contrário, ela é incorporada à vida como uma conduta que agrega, inclusive, no próprio trabalho.

Desse modo, o cuidado de si está “afastado de qualquer vínculo doutrinal estrito, vivendo a carreira regular das honras, preocupado com as próprias atividades [...] contudo, não cessa de manifestar, ao longo de sua vida, os cuidados que quer ter consigo” (Foucault, 2024b, p. 62).

Outro ponto a destacar é que o cuidado de si não possui um período específico para começar. Em alguns escritos, menciona-se a adolescência e a juventude como pontos de início. Todavia, em outros, ele é apresentado sem uma idade determinada para a ocupação consigo.

O cuidado de si é um exercício que pode ser realizado ao longo de toda a vida, uma vez que a vida não está pronta nem acabada. A existência não é definida; está em devir e, assim como a idade transforma o corpo, também pode transformar e aperfeiçoar o próprio sujeito.

Foucault (2024b), atento aos escritos de vários pensadores, chama-nos a atenção ao perceber que o cuidado de si — a *epimeleia* (em grego) não resulta apenas na ideia de uma preocupação. Ele recorre a outros escritos que exemplificam a necessidade de tempo para ocupar-se com as atividades realizadas em casa, assim como se faz com uma pessoa que se encontra em situação de doença.

A palavra *epimeleia* refere-se à ocupação de si e, para tanto, demanda tempo. “Pode-se reservar, à noite ou pela manhã, alguns momentos de recolhimento para o exame daquilo que se fez, para a memorização de certos princípios úteis, para o exame do dia transcorrido” (Foucault, 2024b, p. 65).

Muito próximo do que nos é familiar, o tempo reservado ao cuidado de si destina-se a colocar-se diante de si, por meio do olhar para o passado, para o

transcurso da vida, para a leitura que provoca o pensar e para os exemplos que inspiram. Em suma, há um exame da vida pautado pela razão.

O tempo para a ocupação de si, em várias instâncias, é visto como o tempo dedicado ao cuidado do corpo, com a atenção à dieta, que resultará em uma boa saúde, e ambas no equilíbrio que afasta dos excessos.

Todo esse trabalho leva à percepção do possível e do necessário. Soma-se ao cuidado com o corpo e com a saúde, as leituras, as escritas que podem ser produzidas a partir das inspirações do que foi lido e as conversas com pessoas que possuem algum grau de experiência. “Em torno dos cuidados consigo, toda uma atividade de palavra e de escrita se desenvolveu, na qual se ligam o trabalho de si para consigo e a comunicação com outrem” (Foucault, 2024b, p. 66-67).

Embora, quando se fala em cuidado de si, o “si” possa parecer denotar um lugar de isolamento como condição para que o cuidado aconteça, o cuidado de si não implica um bem que se destina apenas à pessoa de forma individual, mas a toda a sociedade. Assim, passa a ser compreendido como uma “prática social”.

A prova disso é que “toda essa aplicação a si não possuía como único suporte social a existência das escolas, do ensino e dos profissionais da direção de alma; ela encontrava, facilmente, seu apoio em todo o feixe das relações habituais de parentesco, de amizade ou de obrigação” (Foucault, 2024b, p. 68).

As pessoas que já dispõem de certa experiência na condução do cuidado de si têm como “obrigação” colaborar com aquelas que ainda não chegaram ao mesmo grau de entendimento sobre as escolhas e a vida. Trata-se de uma busca constante, que termina com a morte. Ou talvez seja justamente aqui que se chega: a vida como um processo contínuo, para que a morte seja a consequência de um viver bem.

Há uma relação entre o cuidado de si e a medicina. Essa relação se estabelece no fato de que a função da medicina é tratar os males que atingem o corpo da pessoa, enquanto o cuidado de si, sobretudo quando desenvolvido nas escolas, funcionava como uma espécie de sala médica, na qual ocorria um trabalho voltado ao cuidado da alma.

Assim, “a prática de si implica que o sujeito se constitua face a si próprio, não como um simples indivíduo imperfeito, ignorante e que tem necessidade de ser corrigido, formado e instruído, mas sim como indivíduo que sofre de certos males e que deve deles cuidar” (Foucault, 2024b, p. 74).

Esse estar “mal” não é papel de um outro descobrir. Faz parte do que o cuidado de si promove, na busca e na averiguação dos movimentos realizados em torno do corpo e da alma, sendo identificado pela própria pessoa. Trata-se de uma autoconsciência de si, sobre aquilo que leva a padecer.

É de tal importância essa “*relação consigo enquanto doente*”, pois ela se torna ainda mais necessária na medida em que “as doenças da alma [...] não se anunciam por meio de sofrimentos percebidos; não somente elas podem permanecer insensíveis por muito tempo, como também cegam aqueles que elas atingem” (Foucault, 2024b, p. 75).

É uma prática que se realiza consigo e que traz benefícios não apenas a si, mas também a todas as relações em sociedade. A responsabilidade não é um peso que cada pessoa carrega sozinha, mas a compreensão de que o conhecimento é algo que pode ser alcançado por toda e qualquer pessoa e utilizado como ferramenta para constituir-se para o bem de si e para o bem das pessoas com quem se convive, assim como aquelas que convivem conosco.

Na terminologia grega, *excutire* é a ação de sacudir, de arrancar para fora os “erros”, que podem não ser os mesmos produzidos por nossa cultura, mas que, naquele momento, eram considerados prejudiciais a si e às relações com outras pessoas. Ressalta-se que o exame é compreendido como uma averiguação realizada ao término de um trabalho, para verificar se foi possível alcançar o êxito pretendido e esperado.

Nada disso se relaciona a uma “relação judiciária na qual o acusado se encontra em face do juiz; ela tem, ao contrário, o aspecto de uma ação de inspeção, onde o controlador quer apreciar um trabalho, uma missão realizada” (Foucault, 2024b, p. 79-80).

No exame, não cabe a produção do sentimento de culpa. Ao que parece, o teor da culpa adquire maior peso em culturas posteriores. Aqui, o que se tem como sinalizador é que determinadas ações e/ou condutas não resultaram de escolhas sábias.

Foucault (2024b) traz como exemplo uma fala de Sêneca, que, não obstante, ainda é uma realidade para muitas de nós: não demandar tanta energia para discutir com pessoas ignorantes, pois não é possível convencê-las, a não ser que elas mesmas, por seus próprios meios, empreendam o cuidado de si. É “uma forma de

assegurar-se permanentemente de que não nos ligaremos ao que não depende de nosso domínio” (Foucault, 2024b, p. 82).

Um dos principais objetivos que queremos destacar é que o cuidado de si possibilita a cada pessoa compreender a produção que foi feita sobre ela por meio das sujeições. Ao voltar-se para si, torna-se possível perceber as construções realizadas sobre a forma de ver a si mesmo, o mundo, as pessoas e a sociedade.

Em *A hermenêutica do sujeito*, Foucault (2010b), em suas aulas proferidas ao longo de seus cursos no *Collège de France*, tratou de “traduzir” os textos dos gregos antigos no que concerne ao “cuidado de si” e à “estética da existência”, em várias de suas aulas.

Parece que, nesse momento, é feita uma retomada da História da sexualidade, volume 3, ampliando algumas ideias e desenvolvendo melhor a questão da estética da existência, tema no qual queremos nos deter com mais tempo.

Na aula do dia 17 de março de 1982, Foucault (2010b) descreve a *epiméleia heautoú*, como um ocupar-se consigo, como uma forma de educação que deve estar presente ao longo de toda a vida.

Aqui, ele parte dos infortúnios como algo inerente à existência e compreende a educação, aliada às alternâncias da vida, como uma possibilidade de aprender e de utilizar o que foi aprendido por meio da ocupação de si. Um “educar a si mesmo ao longo de toda a vida e, ao mesmo tempo, viver a fim de poder educar-se. Coextensividade entre vida e formação: é essa a primeira característica da vida-prova” (Foucault, 2010b, p. 395).

A *vida-prova* caracteriza-se pelos infortúnios, como se esses acontecimentos colocassem a vida em constante provocação, sendo o sofrimento, por exemplo, compreendido como uma forma de prova. A prova cumpre, assim, um papel formativo que, ao se questionar o que se pode aprender com isso, obtêm-se respostas que possibilitam analisar as escolhas empreendidas que tiveram como fim o sofrimento.

É interessante pensar que, se por um lado a educação deve acompanhar toda a vida, por outro, as provas também a acompanham, ainda que não necessariamente de modo concomitante. São acontecimentos dos quais não se pode esquivar, como a dor, a morte, a perda, entre tantos outros.

Contudo, estabelece-se uma distinção a partir de como cada pessoa responde à prova: aquelas que respondem bem são vistas como boas, e as que não respondem, como más. Estas últimas aparecem como reflexo daquelas pessoas que “não

reconhecem na vida uma prova, como a vida para elas sequer é organizada como prova. E, se são abandonadas aos prazeres, é porque sequer são dignas de se confrontar com a prova” (Foucault, 2010b, p. 395-396).

Em suma, as coisas que acontecem na vida, qualificadas como ruins, são vistas como utilitárias, uma vez que servem como possibilidades de aprendizado e de educação de si. O sofrimento torna-se, assim, uma oportunidade de compreender a vida como um todo, sem negações, aceitando-a, sem se inclinar apenas ao que dela pode resultar.

Todo esse aprendizado ocorre por meio do exercício intelectual realizado a partir das experiências que a vida permite. “Como, por exemplo, a morte de um próximo, uma doença [...] precisamos dizer a nós mesmos que cada uma dessas situações, qualquer que seja e por mais accidental que possa parecer, na realidade faz parte da ordem do mundo e de seu encadeamento” (Foucault, 2010b, p. 397).

A reflexão racional rompe com a opinião sobre o que os acontecimentos sinalizam como coisa boa ou coisa má. No pensamento grego, não há mal naquilo de que se pode aprender; trata-se sempre de uma oportunidade de reescrever a vida. É aqui que começa a se delinear o que pode ser a estética da existência.

São, pois, movimentos reflexivos que, ao se colocarem diante de situações que nos atravessam de forma fatal, podem, por outro lado, nos dar condições de ver e seguir no mundo, sem nos prender àquilo que possa ter sido um mal. Ou seja, “a transfiguração em bem faz-se no interior mesmo do sofrimento provocado, na medida em que esse sofrimento é efetivamente uma prova, em que é reconhecido, vivido, praticado pelo sujeito como prova” (Foucault, 2010b, p. 398).

O que Foucault (2010b) mostra, a partir dos escritos dos gregos antigos, não é a anulação do mal enquanto sofrimento que pode acontecer na vida da pessoa. Há, ao contrário, um movimento no qual o mal é utilizado para ser ressignificado. O sofrimento é visto como formador.

Assim, o cuidado de si, a ocupação que cada pessoa faz de si, cria uma estética da existência na qual a vida ganha certa potência nas formas de viver. Não há uma forma única de dizer como uma vida deva ser, mas cada pessoa pode ser sua própria escrita, no momento em que passa a se conhecer e a exercer esse cuidado de si. Nesse sentido, não basta apenas cuidar de si, mas aprender a partir das técnicas investidas no cuidado de si, alcançando, então, o ápice de um saber existir.

Assim, chegamos ao topo: o empreendimento de investir no cuidado de si e de utilizar todas as provas que ocorrem na vida é formar o eu. “Devemos viver a vida de maneira tal que a cada instante cuidemos de nós mesmos e que o que encontrarmos ao termo, por certo enigmático” (Foucault, 2010b, p. 403) não nos pese, seja na velhice ou em qualquer outro momento. Aquilo que foge de nós não nos cabe castigar.

A vida, nesse contexto perceptivo, é inscrita como um constante fazer-se e, investida por meios e técnicas, nos direciona a não nos divorciarmos daquilo que somos e de nossa existência. “Vive-se para si. Como projeto fundamental da existência, vive-se com o suporte ontológico que deve justificar, fundar e comandar todas as técnicas de existência: a relação consigo” (Foucault, 2010b, p. 403).

Na obra *Ditos e escritos V* (2006), Foucault traz outra questão que amplia a noção de cuidado de si: a liberdade e a ética. O cuidado de si tem como base a busca individual. É no investimento feito em si que se desenvolve o conhecimento. Só quem pode escolher é livre.

A liberdade consiste em não estar dominado por aquilo que é exterior, como as ações irrefletidas que levam a uma “prisão”, sobretudo aos desejos, por exemplo. O que se deseja está no âmbito do necessário ou do impulso irracional? A racionalidade é uma ferramenta humana que deve ser aproveitada. E tudo isso não se trata de um enquadramento religioso, mas de uma conduta ética.

A ética é um movimento que tem por base a reflexão. Logo, o cuidado de si busca, por meio da reflexão, a melhor escolha para a vida, iniciando pela própria pessoa e beneficiando toda a coletividade. Quanto mais a pessoa se ocupa de si, mais livres são suas escolhas, por conhecer quem as realiza. Assim, cria-se um *ethos* que direciona a vida.

A liberdade, no contexto grego, é atribuída à pessoa que não é escrava. Ser ético é, também, ser livre, e isso resulta das relações com os outros. “O cuidado de si é ético em si mesmo; porém implica relações complexas com os outros, uma vez que esse *ethos* da liberdade é também uma maneira de cuidar dos outros” (Foucault, 2006, p. 270).

Se somos investidos no cuidado de nós mesmos, temos a consciência de que as outras pessoas são como uma extensão do que somos. A conduta que direciona a minha vida considera, também, a conduta que o outro direciona à sua. Ambas, embora diversas, não se excluem, pois a conduta ética consiste no bem geral.

Só é possível alcançar a liberdade e a ética no investimento que se faz em si mesmo. Isso possibilita pensar uma rachadura nas relações de poder que podem se estabelecer na ausência do cuidado de si e, por consequência, da conduta ética.

Uma vez que determinada pessoa, por exemplo, ao conhecer seus direitos, devido a ter dedicado atenção à sua vida e à sua condição humana, um tirano não poderá apoderar-se dela. O poder não é algo de uma única parte; é um movimento. A busca pelo cuidado de si nunca deve ultrapassar a liberdade coletiva. Trata-se de uma fórmula sem desvio.

Se você sabe qual é o seu papel e qual é a sua relação com as outras pessoas, a relação de escravidão não acontece. Ou seja,

mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode dizer que um tem todo poder sobre o outro, um poder só pode se exercer sobre o outro à medida que ainda reste a esse último a possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso significa que, nas relações de poder, há necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência - de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação -, não haveria de forma alguma relações de poder. Sendo esta a forma geral, recuso-me a responder à questão que às vezes me propõem: "Ora, se o poder está por todo lado, então não há liberdade." Respondo: se há relações de poder em todo o campo social, é por que há liberdade por todo lado. Mas há efetivamente estados de dominação (Foucault, 2006 p. 277).

Toda essa relação nos direciona a pensar os processos formativos como um poder que reage, que subverte e que só pode acontecer a partir da consciência do que se é. A esse respeito, Foucault (2006) afirma não haver soberania nem algo que funda um sujeito como modelo universal.

Constituímo-nos a partir das várias formas pelas quais somos assujeitados, e isso pode ser percebido, por exemplo, nas famílias e na escola, que trazem consigo toda uma base moral que fixa e limita o humano, como ocorre no cristianismo.

Todavia, se olharmos para o contexto grego, há, de certa forma, outra possibilidade de subjetividade: aquela construída a partir da individualidade de cada pessoa, do investimento que faz em si e do uso de sua liberdade. Cada pessoa realiza, a partir da razão, a escolha de sua própria existência.

Uma educação que vise sorotransgredir teria como princípios os apresentados aqui: uma escola e currículo que exerçam a função de possibilitar

espaços e elementos que permitam que jovens e adolescentes possam se autoconstruir. O cuidado de si possibilitaria essa outra cultura, ampliando as relações de igualdade de poder e tendo como princípio a liberdade e a ética como conduta social.

Estar soropositivo é mais uma das várias condições da vida humana. A diferença não consiste no sentido biológico, mas, sobretudo, em como podemos nos constituir enquanto subjetividades que podem se formar a partir desse investimento no cuidado de si.

Consideramos, nesse último eixo, olhar a condição soropositiva como um elemento possível da vida, assim como a morte e tantas outras experiências que nos atravessam pelo fato de sermos seres humanos. A escola e o currículo que sorotransgridem podem considerar, como matérias básicas de reflexão, a crítica como um princípio que direciona a vida e leva cada pessoa a perceber os possíveis meios de estar menos governado pelas instituições e relações de subjetivação (Foucault, 2025b).

Tantas questões podem ser levantadas a partir de ideias que possibilitem exercermos nossa criticidade, com vistas a nos constituirmos como subjetividades por nossas próprias escolhas, e não como produto cultural que nos molda e nos inviabiliza enquanto corpos dóceis, prazeres negados e tudo aquilo que pode servir ao controle, à colocação em um espaço de servidão.

Procuramos, neste momento da pesquisa, mobilizar alguns conceitos e ideias no campo teórico para nos provocar a pensar com os dados e, assim, seguir respondendo à nossa pergunta investigativa: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

A contribuição de Foucault e de outros estudos nos ajuda a ampliar a leitura dos dados e a nos direcionar a outros conceitos, ideias e provocações que não se limitam ao que esboçamos nas linhas anteriores. Pensamos ter realizado um exercício no qual nos colocamos no jogo das relações de poder, disputando a favor da escola, de um currículo sorotransgressor, para, assim, possibilitar uma escola das diferenças.



3 PRIMEIRO ESTUDO: UMA POSSÍVEL HISTÓRIA SOROPOSITIVA PARA A EDUCAÇÃO

“Eu me constituo como pós pela minha ansiedade – um depois, um devir, vários desassossegos” Rafael Reis

3.1 Considerações sobre o que pretendemos com o primeiro estudo

A proposta deste estudo é direcionada pelo primeiro objetivo específico da tese. Buscamos analisar documentos, diretrizes e produções enquadradas como científicas e não científicas, que embasam as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no Ensino Médio, sobretudo no Estado de São Paulo.

Com esse estudo, buscamos uma primeira resposta à nossa pergunta investigativa: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

A história que buscamos escrever e contar é inscrita no plural, por entendermos, no decorrer da produção dos dados, não haver uma única versão sobre o que é dito a respeito do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. As histórias que trazemos são marcadas por campos de forças e desejos que sinalizam um “eterno retorno do mesmo” (Nietzsche, 2013).

O texto não segue uma estrutura “harmoniosa”, em que os parágrafos estejam em constante ligação. O propósito é provocar e criar sentidos com os acontecimentos, mostrando, em cada período, os regimes de verdade que foram sendo produzidos em torno da AIDS e das pessoas soropositivas, e como essas produções apareciam no contexto educacional e escolar. Trata-se de um caminho um tanto longo, percorrido desde antes do aparecimento da AIDS até os dias atuais.

Ressaltamos que não buscamos fazer uma história da totalidade dos acontecimentos relacionados ao HIV/AIDS e às pessoas soropositivas. Contudo, com os dados produzidos, é possível encontrar muitas respostas, sobretudo para sustentar a tese. Outros regimes de verdade podem produzir percepções distintas ou até as mesmas que defendemos, questionamos e contestamos.

A organização que seguiremos considerará os procedimentos utilizados para a produção dos dados. Iniciamos com uma possível antecessora do HIV/AIDS, ao pensarmos a não linearidade e a continuidade da história que Foucault (2019) nos apresentou.

Seguimos com a possível história do HIV/AIDS e das pessoas soropositivas, organizada por períodos, e concluímos o primeiro estudo com os dados produzidos no tempo presente.

3.2 Procedimentos de escavação para o trabalho arqueológico

O trabalho arqueológico demanda que alguns pontos sejam delimitados, os quais entendemos como necessários para que nossa expedição ocorra de forma direcionada aos objetivos propostos. Desse modo, consideramos ao menos três pontos para orientar as escavações: os materiais, o tempo e o lugar.

Ao lermos História da loucura (Foucault, 2019), fomos conferindo as referências utilizadas por Foucault. Chamaram-nos a atenção os materiais que serviram de base para suas buscas e achados. São materiais considerados tanto científicos quanto não científicos: obras literárias de diversos autores e épocas, pinturas, artistas, relatórios de cirurgias, documentos arquivados de casas de internação, processos civis e criminais, diários, dicionários, jornais, portarias e regulamentos policiais, dissertações, tratados, pesquisas em diversas áreas da medicina, cartas, regulamentos administrativos de hospitais, além de obras (livros), artigos, a Bíblia católica, discursos religiosos, entre outros.

Os materiais utilizados por Foucault ajudam a perceber que ele não se apoiou apenas na reprodução do que a história descrevia a partir dos modelos científicos vigentes. Ao propor olhar de outro lugar, com outros olhares, fez-se necessário recorrer a outros materiais.

O que buscamos seguiu, em parte, esse movimento: encontrar em notícias, reportagens, livros biográficos, documentários em que pessoas, em diferentes tempos da AIDS, estiveram à frente, artigos científicos, na intenção de mostrar as contradições, mas também de resgatar as percepções produzidas nos contextos em que foram escritas.

Recorremos, ainda, a obras artísticas, para compreender como as pessoas estavam lendo e relendo a AIDS e tudo o que a envolvia, às músicas, ao teatro e às

novelas como meios de produção e provocação, criando um cenário sobre o que foi e refletindo sobre o que temos hoje, principalmente nos documentos educacionais.

O segundo ponto considerado é o tempo. Em vários momentos, na leitura de Foucault (2019), observa-se a demarcação temporal de sua pesquisa, localizada entre a Idade Média, passando pelo Renascimento e seguindo até o período Clássico. A justificativa para esse recorte deriva da busca que o filósofo se propõe a realizar: compreender a loucura na transição da experiência trágica para a medicalização na sociedade ocidental.

Na mesma intenção, buscamos olhar para os primeiros achados identificados pela história e para o que dela se escapou sobre a AIDS, retomando algumas considerações a partir do século XVIII, quando as doenças venéreas são estabelecidas como um problema, avançando para os séculos XIX e XX, quando a AIDS é “descoberta”.

O terceiro ponto considerado é o lugar. Foucault (2019) teve como foco a Europa Central, especialmente a França. Contudo, em suas análises, observa-se que ele também menciona outros países, como Inglaterra e Itália. O possível propósito ao recorrer a esses contextos é compreender como se dava a experiência da loucura nesses diferentes lugares. A França, por sua vez, ganha centralidade por ter sido um dos primeiros países a se interessar em cuidar da loucura por meio de instituições específicas, como, por exemplo, o Hospital Geral de Paris.

Para esta empreitada arqueológica, partimos inicialmente de uma leitura internacional, considerando as primeiras publicações e relatos sobre a AIDS. Interessou-nos observar não apenas o Ocidente e as Américas, mas também a percepção que foi sendo construída sobre a AIDS em alguns países da Ásia. Em seguida, voltamo-nos de forma mais detida ao Brasil, buscando compreender mais de perto o contexto do Estado de São Paulo.

O recorte temporal não busca alcançar uma percepção total, mas, sim, observar proximidades e distanciamentos. Interessa-nos perceber, por meio de questionamentos, se o construto cultural reivindica a forma de ser do HIV e das pessoas soropositivas.

O tempo é um movimento, e importa observar se, nas transições, a forma como o HIV foi sendo construído, suas relações com a sociedade e a percepção da pessoa soropositiva seguiram um mesmo modelo, se atualizaram, se reconstruíram ou se apenas se ressignificaram.

Junto ao tempo, o lugar é o espaço em que os acontecimentos referentes ao HIV ocorrem. Tempo e lugar se correlacionam sem hierarquia ou valor sobreposto. São instâncias necessárias de localização da memória que, ao serem inscritas nos diversos sentidos humanos, resultam em materiais que, no tempo presente, nos indicam possibilidades de perceber o passado como um parente próximo, ainda que nunca nos tenha sido apresentado.

Nesse sentido, nosso propósito, ao considerar o tempo, o lugar e os materiais, é marcar e delimitar o sítio possível que queremos escavar.

3.3 Uma propedêutica do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas

A história é como uma viagem de trem. Segue os trilhos que atravessam diferentes cenários e paisagens que se modificam, mas que se mantêm em uma mesma lógica: a das continuidades. Em uma viagem de alguns dias de mochilão, aventurei-me a ir à Itália. Das cidades por que passei, fui de Firenze a Roma de trem. Sentado ao lado da janela, observava que, conforme o trem seguia, havia uma consistência de padrões: das casas, das pastagens, das estações. Como se, na multiplicidade, houvesse uma regularidade.

Isso tem a ver com a multiplicidade anatômica dos corpos e a regularidade de seu funcionamento, assim como com as arquiteturas escolares, diversas, mas regulares em seus sistemas e funcionamentos. E essas relações, as das continuidades e regularidades, podem estar presentes entre HIV, AIDS e as pessoas soropositivas.

Podemos começar aqui nos perguntando: o que conhecemos sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas? Quais são as bases para esse conhecimento? Seriam as dos livros, da internet, do que ouvimos outras pessoas falarem, dos telejornais, dos filmes ou da igreja? Relembrando o problema de nossa tese: quais regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

Antes de ingressar nos acontecimentos que foram marcando e construindo o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, pareceu-me necessário buscar algumas ideias anteriores ao contexto do HIV. Para isso, passei a me perguntar se houve, em algum momento da história brasileira, alguma epidemia que estivesse voltada às questões da sexualidade. Do que eu já vinha lendo, uma possível hipótese levantada

foi a de que o problema do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas tinha como alicerce a sexualidade.

Foi então que, vasculhando, encontrei algumas referências sobre a sífilis — infecção provocada por meio de relações sexuais quando alguma das pessoas envolvidas na relação está sob posse de uma bactéria chamada *Treponema pallidum* (Brasil, 2026b). Tal achado pareceu-me uma propedêutica para refletir sobre o HIV.

No decorrer dos anos que compõem o século XVIII no Brasil, houve uma frequência significativa de casos de sífilis, sobretudo no Rio de Janeiro. A resposta dada ao “mal” que vinha assolando uma parcela da sociedade decorria do suposto rompimento dos preciosos costumes que direcionavam as condutas sociais da população. A sífilis colocava em causa não tanto o possível agravamento da infecção e/ou seus efeitos sobre o corpo biológico e a saúde, mas, sobretudo, a moral e os bons costumes (Carrara, 1997).

Nessa mesma época, em 1798, havia certa preocupação por parte das autoridades governamentais com os problemas ocasionados pelas doenças classificadas como endêmicas e epidêmicas, que poderiam sinalizar algum perigo para toda a sociedade. Foram solicitados inquéritos aos médicos responsáveis pela saúde, que atuavam na linha de frente. Unanimemente, respondiam que as doenças venéreas apresentavam a maior incidência entre todas.

O resultado apontado pelos médicos era a constatação, talvez empírica, de que o problema das infecções venéreas, assim como a origem de outras doenças de cunho sexual, estava relacionado à imoralidade, predominante na ostentação de riquezas, na obsessão sexual e nos populares puteiros, locais de encontro dos jovens heterossexuais (Araújo, 1928).

A proporção que as doenças venéreas foram tomando no Brasil é percebida em publicações em periódicos médicos, mais conhecidos como Gazeta Médica da Bahia, ao descreverem que, entre os anos de 1801 e 1806, no Rio de Janeiro, do total das internações, aproximadamente 33,33% correspondiam a pessoas que se encontravam internadas na Santa Casa da Misericórdia por causa de doenças venéreas (Anônimo, 1987).

Nos anos de 1851 a 1899, na Bahia, entre os destaques das doenças com maiores incidências estavam os casos de sífilis (Caldas, 1986). Em 1901, em São Paulo, havia aproximadamente 30 mil pessoas com sífilis. Esse número, pelos

cálculos da época, representava um percentual de 10% ao ano de pessoas que adquiriam a sífilis (Souza, 1909).

Carrara (1997), ao escrever em “*The symbolic geopolitics of syphilis: an essay in historical anthropology*”, questionava as estatísticas desses períodos, atribuindo-lhes uma possível margem duvidosa. Isso porque a base que construía os números que compunham as estatísticas provinha do trabalho dos médicos, ao estarem em contato com as pessoas hospitalizadas, que forneciam as informações. Encontra-se aqui um problema das ciências positivistas, como se, em outros inquéritos, a participação das pessoas não fizesse parte dos estudos e dos conhecimentos que temos.

Todavia, outras explicações encontradas, sobretudo nos anos de 1920, referiam-se à cultura que foi sendo construída em torno do corpo brasileiro: o exagero das práticas sexuais, a estereotipação do corpo preto, descrito como sensual, prematuro, ilimitado, desprovido de civilidade e educação.

Algumas respostas, por meio de campanhas, indicavam como “solução” a popular abstinência sexual, como uma forma de higienizar e reconstituir a moral dos bons costumes (Peixoto, 1987). Não obstante, difundia-se o discurso de que as infecções venéreas eram uma ameaça à saúde e que cabia a todas as pessoas, como patriotas, esquivar-se delas, sinalizando a prática sexual com profissionais do sexo. Houve também a proposta de criar uma profilaxia comportamental, por meio da moral, propagada pelos padres jesuítas (Carrara, 1997).

As campanhas acabavam por ser direcionadas aos homens e, talvez, aos heterossexuais. As mulheres que não trabalhavam com o sexo eram excluídas, como se seus corpos não tivessem desejos nem perigos. Do mesmo modo, não havia atenção às grávidas, mas sim a seus filhos e filhas, com o temor de que, como consequência das doenças venéreas, pudessem resultar crianças com deformidades (Carrara, 1997). Tratava-se de uma preocupação eugênica, machista e sexista, apontada naquela época.

Esse pequeno recorte não diz tudo sobre as doenças venéreas, nem outros, pois não há como apreender o todo. Mas, por eles, há possibilidades que podem ser pensadas. Eles nos dão alguns pontos para refletirmos sobre as raízes dos problemas estruturais que, com o colonialismo, foram plantados. E, talvez, aqui já se tenha mais uma problemática a ser estudada em outras pesquisas: a relação entre pandemias e endemias de doenças em bases sexuais, por exemplo.

De qualquer forma, é visível perceber que os problemas de saúde, ao centrarem-se na sexualidade, têm como resposta, comumente, a/o outra/o como culpada/o. Uma relação de um eu-o-mesmo com vocês-outras/os. As/os patriotas, cristãs/ãos etc. são as/os mesmas/os — civilizadas/os, educadas/os, a norma. A/o outra/o são todas as pessoas que se encaixam nas produções “patologizantes” ocasionadas pelo sexo e pela sexualidade as sexualidades não heterossexuais, não cristãs/ãs, imorais, entre muitas outras.

Destarte, a culpa é a estratégia para construir ferramentas e práticas que moldam as formas de ser em sociedade por meio de algumas instituições. De modo intencional e consciente, constrói-se a ideia de culpa para domesticar a/o outra/o para ser a/o mesma/o. Cabe distinguir a culpa da justificativa dos problemas voltados à sexualidade, por se tratarem de percepções que se distanciam.

A culpa situa-se no campo moral, em segmentos postulados como corretos. A justificativa explica e até denuncia as vulnerabilidades sociais, como podemos ler acima, a exemplo do corpo preto, das mulheres trabalhadoras do sexo e, pouco ou quase nada para não universalizar, dos ditos homens héteros. Esta última, sinteticamente, explica o sistema social racista, sexista e machista, pelo menos.

As considerações que trouxemos sobre a sífilis estiveram voltadas a mostrar às pessoas leitoras o que Foucault (2019) sinaliza ao dizer que não vivemos uma história dos progressos, mas, sim, de rupturas e descontinuidades. Mudam-se os regimes que produzem as verdades sobre as coisas nos diferentes tempos históricos.

Assim, não há um progresso dos acontecimentos da sífilis para a AIDS, mas uma mudança da emergência que possibilitou a criação de novos regimes de saber-poder inscritos sobre a sexualidade. Cada período histórico elabora diferentes formas de controlar as condutas e os comportamentos. Utilizam-se discursos que falam sobre o risco, pautam-se em comportamentos moralizadores e mostram os avanços do olhar que possibilitam à medicina ser reformulada enquanto um dispositivo biopoderoso.

A produção da percepção do contágio da sífilis é feita sob a culpa como um processo de alienação, ao inserir as pessoas “causadoras” como aquelas a serem banidas da sociedade, estigmatizadas e destinadas a ocupar espaços subalternos. Nesse processo, desconsidera-se a experiência trágica das pessoas acometidas pela sífilis. Não se fala sobre o sofrimento, o sentimento de proximidade da morte, de perda, nem sobre a ausência de formação, pela catequização do uso dos desejos.

De outro modo, há a presença da experiência clínica, nas explicações médicas, como discursos de verdade. Essas percepções podem ser caras para que possamos compreender como a história do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas foi construída e como a sociedade, pensada a partir das relações entre as pessoas e as instituições, se preocupou em lidar com ela.

A proposta que trazemos considera dois pontos: o tempo e os temas. A partir das décadas, foi possível relacionar as formas discursivas em que o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas foram sendo produzidos, mencionando as instituições que participaram dessa elaboração, com destaque para a escola e a educação. Esse movimento possibilita olhar para os regimes de verdade que construíram a percepção social do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas e como essa percepção passou e permanece na escola, no currículo e na educação.

3.4 HIV, AIDS e pessoas soropositivas: uma história de vários nomes, faces e significações

Na obra de Gabriel García Márquez, *Cem anos de solidão*, há um diálogo provocativo entre Melquíades e Úrsula: “No mundo estão acontecendo coisas incríveis”, dizia Úrsula. Ali mesmo, do lado de lá do rio, existe tudo que é tipo de aparelho mágico, enquanto nós continuamos vivendo feito burros” (Marquez, 2017, p. 14–15).

Em uma possível tentativa de adentrar o universo das significações que a arte nos provoca, quantas coisas no mundo acontecem e fogem da razão e do saber humano? Quantas delas estão do lado de lá de nossas percepções, confusas e perdidas pela inteligibilidade e, ainda assim, existem? Um pouco disso tem a ver com o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

Neste momento, trazemos os resultados das escavações realizadas. Organizamos os achados por períodos: um primeiro, caracterizando o contexto e os acontecimentos antes do aparecimento da AIDS na sociedade, alcançando até a década de 1980. Seguimos com os achados em um segundo período, datado da década de 1990. O terceiro período corresponde ao recorte temporal dos anos 2000. Continuamos com um quarto período, datado de 2010 a 2024.

Os achados não buscaram a totalidade dos acontecimentos nos diferentes períodos. Buscamos com eles, trazer alguns acontecimentos que vinham

caracterizando cada período. Ao nos pautarmos na arqueologia de Foucault (2019), propomo-nos a ver os discursos de verdade em torno do HIV/AIDS e das pessoas soropositivas pelas várias instituições que participam dessa produção. Isso, com vistas a criarmos um panorama do que foi e do que é a epidemia de HIV/AIDS e de como ela aparece na escola.

3.5 Antes do aparecimento da AIDS e a década de 1980

Das primeiras aparições da AIDS, o contexto que a antecede é marcado pelo dia 4 de outubro de 1957. Nesse dia, o ser humano conseguiu, pela primeira vez, enviar um satélite ao espaço não apenas um ser humano, mas os soviéticos. Dadas as conjunturas pelas quais o mundo passava, marcadas pela Guerra Fria¹⁰, o satélite Sputnik foi uma das primeiras vitórias no embate com os Estados Unidos, colocando o sistema soviético à frente.

O avanço tecnológico sinalizado pelo satélite impulsionou o campo educacional dos americanos, emergindo em mudanças e demandando um olhar mais ambicioso para a ciência, principalmente nas disciplinas de física, biologia, química e matemática. O desenvolvimento educacional dessas áreas do saber daria forma aos projetos tecnológicos que os Estados Unidos almejavam (Gesser, 2002).

Saviani (2021) descreve que, em meados dos anos de 1958, a Igreja Católica investiu em campanhas acirradas contra a defesa da escola pública, defendida por Anísio Teixeira, responsável pela direção da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES.

Líderes do catolicismo no Brasil, como arcebispos, bispos e padres, ao interpretarem as palavras de Anísio Teixeira, ao propor uma “escola pública, universal e gratuita”, tendo como responsável o Estado, passaram a associar tal projeto à ideia de implementação do comunismo no Brasil. Isso porque, se a escola pública estivesse ao alcance de todas as pessoas, não restariam escolas privadas.

¹⁰ Segundo as memórias da ditadura ([200?]), “a Guerra Fria foi, ao mesmo tempo, um conflito ideológico, econômico, científico, cultural e militar. Mesmo sem embates diretos entre as duas superpotências, muitas das guerras civis por independência, sobretudo na Ásia e na África, acabaram se tornando verdadeiras batalhas da Guerra Fria. Cada bloco tentava aumentar, ou pelo menos consolidar, suas áreas de influência. Buscava ter mais armas, mais prestígio entre artistas e intelectuais, mais poder econômico”.

Diga-se de passagem que muitas escolas particulares estiveram sob a posse da Igreja e, com ela, o catequismo conservador empreendido desde os primórdios da invasão das terras resididas pelas pessoas indígenas.

A corrida espacial entre URSS e EUA foi a “origem” do sonho de modernidade que se espalhou pelo mundo. No Brasil, segundo a Memória da Ditadura¹¹, esse sonho esteve presente nos anos de 1960, com a inauguração da cidade de Brasília e do Planalto Central que, nos dias atuais, se reafirma como símbolo brasileiro da democracia.

Para algumas pessoas, a modernidade sinalizava um sonho; para outras, sobretudo para grupos que sofriam com a extrema precariedade socioeconômica, era o próprio pesadelo em vida. Na época, quem estava à frente da presidência era o então presidente Juscelino Kubitschek — PSD. A materialização da modernidade eram as propostas de industrialização, que resultariam em empregos e, para alguns grupos, em riqueza.

No seguir dos anos, em 1961, o resultado do sonho veio com a crise financeira para o Brasil, impulsionando a saída do então presidente Juscelino. Em sua saída, entra João Goulart — PTB, que, ao assumir o cargo, assumiria também a crise política que se instaurava no país.

O sonho de indústrias e trabalho fez com que a massa responsável pelo trabalho no país, ao deparar-se com a situação, se movimentasse por meio de greves e reivindicações. Em resposta, João Goulart propôs as Reformas de Base, que, entre as 16 propostas, tiveram maior destaque aquelas que tratavam da reforma agrária, da educação, das questões eleitorais, da reforma tributária, entre outras.

A implementação das reformas quebraria certos monopólios e privilégios que alguns grupos possuíam, como os latifundiários, empresários e indústrias internacionais, retirando a concentração de bens e possibilitando melhorias a outros grupos, como os/as trabalhadores/as. Logo, as reformas não favoreciam alguns grupos, principalmente os opositores políticos de Goulart e aqueles que perderiam o monopólio de terras e a concentração de rendas.

¹¹ Site que reúne informações sobre a história do Brasil, tratando sobre os antecedentes do golpe, a ditadura entre outros ocorridos, tendo como responsável o Instituto Vladimir Herzog (<https://memoriasdeditadura.org.br/o-golpe-civil-militar-no-brasil/>)

Essa situação fez com que grupos de pessoas da sociedade saíssem às ruas em defesa das reformas. Em resposta, grupos conservadores protestavam utilizando o discurso de que as reformas seriam a oportunidade para o comunismo ser instalado no Brasil.

Muitos entraves foram travados para a implementação das reformas. As medidas anunciadas por João Goulart o colocavam no alto das pesquisas como favorito para ser candidato a novas eleições. Isso fez com que o grupo conservador de parlamentares no Congresso se armassem. Ainda assim, Goulart seguia resistente, sancionando, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases, por meio do Decreto nº 4.024 (LDB), a Universidade de Brasília (UnB) e a Eletrobras.

As reivindicações seguiam na intenção de paralisar as Reformas de Base. No Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964, Jango reafirmou a importância das reformas. Em resposta, no dia 19 de março do mesmo ano, aconteceram as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, em várias regiões do país, contando com pessoas de denominações religiosas, civis, entre outras, que se identificavam com o conservadorismo.

As marchas eram lideradas por grupos e pessoas conservadoras do país, que utilizavam a pauta do bloqueio do comunismo no Brasil. Para uma melhor noção do que eram essas marchas, nos dias atuais, poderíamos pensar na Marcha para Jesus, tendo como um de seus organizadores o pastor Silas Malafaia.

O início de 1964 foi marcado por um conjunto de movimentos liderados por vários setores do país: empresários, empresas internacionais automotivas, latifundiários e forças armadas que, unidos, tinham um mesmo interesse: ir contra João Goulart. A Igreja Católica teve papel importante nessa colaboração, ao contaminar a sociedade com o discurso do medo, propagando a *fake news* de que, se o presidente João Goulart continuasse, traria, a partir do comunismo, terrores para a liberdade brasileira.

Com todas essas ações, em um conjunto de aplicações estratégicas, o cenário brasileiro tornou-se vulnerável, preparado para que o golpe fosse instalado. A força final veio com o embaixador americano Lincoln Gordon, à época em que John Kennedy, do Partido Democrata dos EUA, era o presidente.

Em 9 de abril de 1964, foi declarada a “revolução vitoriosa”, com o Ato Institucional I, ao elegerem outro presidente, que passou a deter maiores poderes

concentrados em suas mãos, configurando, assim, o regime ditatorial pelo qual o Brasil passaria por longos e difíceis anos.

Embora as forças militares tenham assumido o poder para governar, nos primeiros dias muitas pessoas contrariaram o regime. A resposta às reivindicações resultou em prisões, torturas e assassinatos; políticos tiveram seus direitos cassados; artistas e intelectuais que eram contrários ao regime tiveram de sair do país. As pessoas que estivessem contra o novo sistema político eram colocadas na lista de “inimigos” e não passariam impunes.

Outro destaque dos primeiros anos da década de 1960 foi o trabalho de alfabetização em massa realizado por Paulo Freire. O método utilizado visava alfabetizar adultos a partir da participação dos/as educandos/as na construção do conhecimento. O diálogo era o meio empregado para o desenvolvimento desse conhecimento, presente nos círculos de cultura. Rompia-se, assim, com o método tradicional bancário que vigorava há tempos no sistema educacional brasileiro.

Em 1964, havia mais de 20.000 círculos espalhados por todo o território brasileiro. A alfabetização, desse modo, possibilitava que a massa populacional, ao se tornar alfabetizada, passasse a ter consciência das formas e dos meios pelos quais o sistema em que estava inserida oprimia e subalternizava suas vidas a condições de precariedade social, possibilitando o exercício político por meio do voto¹² em políticos alinhados a políticas progressistas (Scocuglia, 1999).

Ainda na década de 1960, a Igreja Católica desempenhou papel forte para impedir que a educação sexual ocorresse em âmbito escolar. Antes de se instaurar o período autoritário, o sistema educacional brasileiro já imprimia valores repressivos à sociedade e aos estudantes quando se tratava de assuntos que abordassem a sexualidade.

A influência que o catolicismo tinha na educação fazia com que uma possível “cultura sexual” ocorresse por meio de múltiplas formas de opressão a visão perturbadora sobre a masturbação, criando sentimento de vergonha; os uniformes que as/os estudantes utilizavam, fabricados com o propósito de cobrir e esconder o corpo.

¹² Apenas a partir de 1985 o Brasil passa a permitir que pessoas que não fossem alfabetizadas pudessem votar (Westin, 2016). Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/04/por-100-anos-analfabeto-foi-proibido-de-votar-no-brasil>.

Com a conclusão do Concílio Vaticano II, em 1965, as questões sobre educação sexual não foram totalmente “impedidas”. Assim, alguns colégios católicos passaram a adotar programas que visavam à orientação sexual¹³. A orientação, ensinava a sexualidade a partir dos valores prescritivos que a bíblia realizava, reforçando o binarismo e a sexualidade como meio apenas de reprodução (Rosemberg, 1985).

Mortatti (2001) descreve que, durante o regime ditatorial no Brasil, o modelo de educação era pautado no tecnicismo. Tal modelo seguia os projetos e as perspectivas do regime, marcado pela necessidade de formação e qualificação de pessoas para o trabalho. A escola tinha como papel colaborar com o projeto político, fazendo ascender o capitalismo e distanciando-se do fantasma do comunismo.

Saviani (2008a), ao escrever sobre a pedagogia tecnicista, descreve-a como uma proposta que visava, de forma racional, organizar o conhecimento de tal modo que distanciasse qualquer proximidade subjetiva que impedisse garantir a eficiência do ensino a ser empreendido pelo público ao qual era destinado. A anulação de qualquer subjetividade decorre de um dos traços da proposta educacional técnica, a neutralidade, que muitas vezes encontramos nas discussões sobre a validade da ciência enquanto processo metodológico, quantitativo e voltado a resultados aplicáveis.

O modelo de educação nesses moldes tornava o sujeito apto e eficiente para desempenhar as atividades que a ele/ela fossem designadas.

Não há o olhar para estudantes marginalizados, mas, sim, para incapazes e/ou improdutivos. A proposta tecnicista ganha força pelo fato de ocupar-se da produção de habilidades das massas, não cabendo o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, que o regime ditatorial não aceitava. As escolas tornam-se extensões de fábricas.

Cada estudante inserido na arquitetura escolar é formatado a partir de esquemas pré-organizados, cabendo aos professores a função de aplicá-los, sem qualquer intermediação, para a garantia neutra e eficaz de resultados. Planilhas,

¹³ Importante ressaltar um cuidado que pode gerar confusão a partir do significado das palavras. A orientação pode significar instruções e conselhos que determinam validades, características e legalidades sobre o universo da sexualidade. A educação, por sua vez, trata de propiciar condições para pensar o corpo e a sexualidade como caminhos pessoais, em que cada pessoa deve conhecer, respeitar e estabelecer seus limites e condutas de forma respeitosa, livre e positiva.

burocratizações e formulários eram os meios pelos quais professores eram controlados e controlavam seus estudantes (Saviani, 2008a).

Com o passar dos anos, embora os militares estivessem no governo, forças políticas e movimentos sociais reivindicavam o retorno do regime democrático. Em resposta aos movimentos que discordavam da ditadura, em 13 de dezembro de 1968, foi promulgado o Ato Institucional nº 5 (AI-5), consolidado em maio de 1970. A proposta do AI-5 era silenciar as pessoas que discordavam do regime e, para manter o sistema funcionando, o mecanismo utilizado foi as diversas formas de censura.

No contexto da educação, a censura veio por meio da proibição de certos livros e jornais, sobretudo aqueles que fossem contra a moral e os bons costumes. O máximo que se poderia ter era uma educação da pureza, que imprimisse nas/os estudantes a castidade e a inocência. Com o Ato Institucional nº 5, as pessoas que desobedeciam às novas regras impostas eram torturadas, presas e mortas (Brasil, 2002).

O contexto educacional e escolar nos anos de 1970 pode ser conhecido a partir de algumas memórias descritas pela educadora popular Traspadini (2019). Esse contexto é marcado por milhares de pessoas não alfabetizadas, sem haver a obrigatoriedade da escola para algumas pessoas e grupos populacionais. A formação escolar tinha como objetivo educar para o trabalho técnico, sem qualquer inserção reflexiva no que tange à política.

O trabalho, além de subsidiar o projeto de modernidade, era impulsionado pelo discurso de vida melhor que ele proporcionaria. Quanto mais se trabalhava, maior era o cansaço do corpo, e a mente ficava dispensada de pensar e questionar o sistema. Nesse sistema, inculcia-se na população a responsabilidade pelo fracasso ou pelo sucesso. A lógica do Estado mínimo e do máximo de esforço populacional para que Deus também pudesse ajudar era representada no ditado frequentemente utilizado: “Deus ajuda quem cedo madruga”.

O papel da escola era desligar o cotidiano vivenciado nos bairros onde a massa residia, desviando o olhar social das condições precárias que, ao não serem questionadas, passavam a ser naturalizadas. A proposta educacional seguia os padrões militares¹⁴: não questionar; quando perguntado, as respostas já estavam

¹⁴Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a Escola Cívico-militar é “um tipo de escola e educação que tem se colocado nos dias atuais, sobretudo, nas escolas Estaduais de São

previamente decoradas; o disciplinamento era construído e reforçado por filas, uniformes e pela exaltação com o canto do hino nacional.

A função da escola era criar modelos que poderiam ser reforçados na igreja, na família e no trabalho. As aprendizagens pautavam-se em memorizar, e não em aprender; em ser um bom ouvinte e pouco falar; em concordar e não discordar. O que se aprendia era o que havia sido estipulado como necessário.

O/A aluno/a que questionava, mesmo que de forma ingênua, movido/a pela curiosidade que crianças e adolescentes têm por sua natureza, era visto/a como um ato de indisciplina. Para isso, aplicavam-se castigos. As torturas que aconteciam nos centros e órgãos, como o DOI (Destacamento de Operações de Informações), de certa forma inspiravam as correções na escola, como o castigo atrás da porta, ajoelhar no milho e a palmatória.

A educação, nesse momento, pode ser caracterizada como uma educação alienante. As pessoas que passaram por esse período educacional talvez sejam algumas daquelas que vimos no dia 8 de janeiro de 2023.

Durante o regime militar, propriamente em 1978, a censura alcançava outros âmbitos da educação, de forma especial as discussões realizadas sobre a educação sexual. O desacordo em torno da educação sexual nas escolas ficou marcado pela menção feita pelo ministro da Educação, Euro Brandão, durante o governo do general do Exército Ernesto Geisel, do partido ARENA.

A fala realizada pelo ministro em um programa televisivo de grande audiência no Brasil deixou clara sua posição contrária. O ministro era favorável a uma educação formativa para a família. Nesse mesmo ano, com algumas resistências e afrouxamentos da ditadura, foi possível a realização, em São Paulo, do 1º Congresso sobre educação sexual nas escolas.

Paulo como um programa que propõe um modelo de gestão escolar de excelência direcionado para escolas com baixo IDEB e com alunos em situação de vulnerabilidade social. A Escola Cívico-Militar é mais uma alternativa a contribuir com a qualidade do ensino na educação básica, além de propiciar aos alunos, professores e funcionários um lugar mais seguro, com a melhoria do ambiente e da convivência escolar” (SED SP, 2025). (<https://atendimento.educacao.sp.gov.br/knowledgebase/article/SED-07842/pt-br#:~:text=O%20programa%20prop%C3%B5e%20um%20modelo,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20vulnerabilidade%20social.>)

Nos anos que seguiram, principalmente em 1980, com a revogação do AI-5, houve a abertura do regime militar a partir da pressão social. Com isso, foi possível que outros eventos, como congressos sobre educação sexual, ocorressem (Rosemberg, 1985; Brasil, 2002).

Uma das aberturas para o processo de redemocratização e de resistência ao sistema que vinha sendo imposto, especialmente para as pessoas homossexuais, foi o jornal *Lampião da Esquina*. O jornal era liderado por homossexuais que assumiram essa responsabilidade no decorrer de sua circulação (1978–1981) em todo o território nacional. Dentre as propostas do jornal, estava refazer a imagem estereotipada criada sobre as pessoas homossexuais.

Em sua publicação nº 0, em março de 1978, o jornal apresentou-se como um processo de “saída do gueto”. Sair do gueto sinalizava uma motivação para as pessoas gays, trans, lésbicas e outras não se esconderem nas sombras e nas margens da sociedade com seus afetos e desejos.

As características das publicações eram diversas e marcadas por muita criatividade, desde textos, poemas, artes e imagens. Por meio de todas essas linguagens, o jornal teceu críticas à sociedade, cumprindo um outro lado do poder que se impunha, ao delegar nomeações como “doença do machismo”, e não como um problema próprio da homossexualidade.

Somando-se ao *Jornal Lampião*, em 1979 foi criada uma organização em defesa dos direitos homossexuais na cidade de São Paulo. Nomeada como SOMOS, o grupo tinha como pauta principal a afirmação da homossexualidade, inspirada nas publicações que vinham acontecendo no *Jornal Lampião*.

Em 1980, na cidade de Salvador, foi formado o Grupo Gay da Bahia (2025) — GGB. Sua criação teve como finalidade desenvolver ações que pudessem reivindicar a legitimidade das pessoas homossexuais e o reconhecimento de suas existências, para além dos guetos e das subalternidades.

Um dos resultados desses movimentos ocorreu em 1985, quando se iniciou o processo de supressão do reconhecimento, pelo Conselho Nacional de Saúde, da homossexualidade como um transtorno passível de ser curado (Brasil, 2002).

Perlongher, ao realizar uma pesquisa publicada em 1987, ao tratar da prostituição sexual no ano de 1979 na cidade de São Paulo, descreve o *Largo do Arouche* como um espaço democrático. Segundo ele, o *Arouche* era distribuído por

bares em frente ao lago, frequentados por gays, nos lugares mais distanciados da praça, sinalizando um certo espaço subalternizado.

De outro lado, estavam as travestis que, em algumas vezes, dividiam o espaço com as profissionais do sexo. Nas várias descrições, destaca que, em 1980, foi realizada a “operação limpeza” por meio de abaixo-assinados levantados pelas vizinhanças, que pediam a saída dessas pessoas desses locais.

Outros relatos que descrevem o Brasil na década de 1980 podem ser conhecidos a partir do documentário *Cartas para além dos muros*, lançado em 2019, por meio de vários/as personagens que vivenciaram o que foi a pandemia de AIDS. Antes de tudo acontecer, antes de o cenário de mortes pairar sobre o solo brasileiro, André Canto descrevia o Rio de Janeiro, a região de Ipanema, em 1982, como o verão do romantismo.

A saudosa professora Jaqueline Rocha Cortes descrevia o cenário brasileiro antes da AIDS como um momento no qual as pessoas queriam ser felizes, beijar, amar e ter prazer. Veriano Terto Júnior descreve esse período como um momento de abertura, entre o que havia passado com o período da ditadura militar e aquela época, marcado por um ar de celebração, de festa e alegria.

Forstein (2012), ao escrever o livro *AIDS: a history, psiquiatra e homossexual*, descreve o cenário antes da chegada da AIDS nos Estados Unidos a partir do relato de um de seus pacientes que, naquela altura, vivia com AIDS, como um paraíso. Segundo ele, o paraíso era caracterizado pelo fato de que seus corpos, desejos e afetos poderiam ser conjugados em um mesmo tempo e espaço social. Isso se devia aos efeitos do movimento social e político que, em meio às dores, encontrou forças para criar legitimidade e, sobretudo, liberdade para viver em sociedade.

A chegada da AIDS foi como uma tempestade: fez com que toda a liberdade conquistada tivesse de voltar ao seu armário, agora com mais uma gaveta, para não sofrer as dores de uma sociedade que a nomeava como praga ou, até mesmo, como a mão de Deus sobre as “distorções” homotranssexuais.

Moreira (2000), ao descrever os anos 1980 no contexto educacional, afirma que houve a preocupação em renovar o currículo. O Sudeste e o Sul do país foram as regiões que concentraram esse movimento de renovação, sobretudo por terem governos que não compactuavam com o regime militar. O interesse era melhorar a qualidade do ensino das escolas públicas. Para isso, era preciso diminuir as taxas de

reprovação e evasão escolar, principalmente entre os grupos sociais mais desfavorecidos.

Com a busca pela redemocratização, a escola passou a inserir a comunidade escolar, rompendo com a estrutura autoritária que não colocava as pessoas envolvidas como parte das decisões escolares.

Lopes e Macedo (2010), ao falarem sobre a década de 1980, descrevem-na como um momento em que novas propostas pedagógicas surgem com o desenrolar do processo de redemocratização. As pedagogias mencionadas pelas autoras são a histórico-crítica e a pedagogia do oprimido. Ambas ganham destaque por buscarem romper com a hegemonia americana que colonizava o Brasil e, com isso, pavimentar novos discursos políticos no campo da educação. Não estavam mais inscritas como meras reproduções do que internacionalmente vinha sendo traduzido e aplicado.

A marca das discussões dessas novas propostas assenta-se principalmente na teoria marxista, que considera a educação uma ferramenta para desvelar as contradições que o capitalismo pregava, por meio do desenvolvimento do pensamento crítico. Assim, a pedagogia histórico-crítica propõe integrar o ensino ao contexto social e político a partir do desenvolvimento do conhecimento. Já a pedagogia do oprimido, desenvolvida por Paulo Freire, entende que a educação é um ato de liberdade, ao considerar as experiências, o diálogo e a conscientização dos educandos como parte da produção do conhecimento, resultando em pessoas socialmente emancipadas e humanizadas.

Na década de 1980, na cidade de São Paulo, o campo educacional é descrito por Silva (2017) como um momento de reorganização curricular, dada a redemocratização do país. Uma das ações ocorreu a partir do governo de André Franco Montoro — PSDB.

Uma das medidas do governador foi inserir o Ciclo Básico no ensino do 1º grau ensino primário (correspondente, nos dias atuais, ao ensino fundamental), por meio do Decreto nº 21.833, de 21 de dezembro de 1983. O decreto visava considerar o processo educativo de forma contínua, respeitando as singularidades de cada estudante, abrindo flexibilidade na formulação curricular e em suas incumbências. Destacava a fase de alfabetização, respeitando o ritmo das/os estudantes. Essa reorganização visou à não exclusão que vinha ocorrendo em decorrência das reprovações no modelo seriado.

Ainda em 1980, foi exposto um painel apresentado na I Conferência de Educação Brasileira, com o título “A educação sexual que gostaríamos de ter”. Um ano depois, em 1981, foi realizado o 18º Congresso de Escola de Pais, no qual ficou decidido como tema “Educação e sexualidade hoje”. Em 1982, aconteceu outro evento no mesmo contexto, que teve como tema “Sexualidade e a Deficiência”.

Embora tenham ocorrido esses e outros movimentos favoráveis, que defendiam a educação sexual nas escolas, ainda assim houve movimentos contrários que contestavam o espaço escolar como um local legítimo para tratar da sexualidade (Rosemberg, 1985).

No desenrolar dos anos e de seus acontecimentos, o “aparecimento” do HIV e da AIDS na sociedade talvez não tenha ocorrido apenas em meados dos anos 1980, como foi e ainda é apresentado. Em 1959, há relatos do que seria o caso mais antigo conhecido, a partir de uma amostra de sangue coletada de um homem residente no continente africano, de etnia Bantu, na cidade de Leopoldville, hoje mais conhecida como Kinshasa (Infoaids, [2020?]).

Há outro relato, o de uma médica conhecida como Grethe Rask, de origem norueguesa, que atuava em um hospital em Kinshasa em meados de 1976. Ela veio a óbito por pneumonia e septicemia, resultado de vários sintomas de uma infecção desconhecida e de comprometimento de sua imunidade. Passados os anos, com as diversas descobertas e a realização de exames de sangue, foi possível afirmar que Rask faleceu em decorrência da AIDS (Shilts, 1997).

Segundo o site Info Aids, em 1978 há relatos de que, nos Estados Unidos, homossexuais apresentavam sintomas que hoje se reconhecem como resultantes da AIDS, assim como no Haiti e na Tanzânia, com pessoas reconhecidas como heterossexuais. Em 1981, mais precisamente no mês de junho, é registrado um possível caso na Dinamarca, e, em dezembro, o primeiro caso de AIDS no Reino Unido.

No Brasil, em 1982, foi identificado o possível primeiro caso. A identificação foi realizada pela dermatologista Valéria Petri. No ano de 1981, em 5 de junho, o imunologista americano Michael Gottlieb publicou um artigo no Centro de Controle de Doenças, descrevendo uma “nova doença” que se caracterizava por levar à falência o sistema imunológico.

Na medida em que o vírus foi sendo desvendado, ficou claro que sua circulação já acontecia, possivelmente, há séculos. O fato de não termos

conhecimento sobre o vírus e a doença deveu-se aos poucos casos que, timidamente, foram se aproximando e alcançando as proporções observadas nos anos iniciais da pandemia (Grmek, 1989).

Uma das explicações para o desencadeamento da AIDS foi o contato do vírus símio, presente em macacos da região africana, que teria interagido com o corpo humano. Considerando o estilo de vida e a cultura de alguns povos africanos, é comum a prática da caça desses animais para uso na alimentação, podendo esse ser um meio de contato do vírus com o ser humano, seja durante o processo de preparação da carne, por meio do corte e/ou da limpeza.

Contudo, ainda há lacunas que não se preenchem, assim como questionamentos que limitam a ciência, ao não se saber explicar por que razão o HIV e a AIDS não se tornaram devastadores no momento inicial de seu conhecimento (Gallo, 1991).

Outras explicações aparecem com a bióloga Primrose (2022), que defende a ideia de que o vírus do HIV foi transmitido por primatas, conhecidos também como chimpanzés, a uma pessoa residente no país da África Central Camarões, nos primeiros anos do século XX. A circulação do vírus ocorreu por meio de relações sexuais, alcançando trabalhadores que se dirigiram para Kinshasa, sendo também propagado por relações sexuais, seguindo para o Haiti, país caribenho da América Central, e que, por meio do turismo sexual, chegou, em 1970, aos Estados Unidos.

A percepção criada sobre o vírus vincula-o à sexualidade a partir de fatores comportamentais, e não biológicos.

Embora o vírus, no passado da ciência, fosse estranho e estranho aqui é proposital, pelo fato de a ciência médica, ao colocar-se como um “vice-deus”, que a tudo sabe, vê e tem solução, ter recorrido a apelações morais na tentativa de dar respostas, justificava-se pelo fato de a AIDS ser uma doença “nova”, sobre a qual pouco se sabia. Um dos perigos foi eleger alguns grupos como “as chaves” que teriam aberto as portas do inferno da pandemia de AIDS para o planeta Terra.

Mesmo na contradição das bases que consolidam seu modo de operacionalizar buscar evidências e, a partir delas, criar classificações e diagnósticos, a ciência, no escuro e na provisoriedade dos acontecimentos, estigmatizou a relação do vírus com as pessoas, sobretudo na instância sexual.

Um dos primeiros locais em que a AIDS foi enquadrada registra cinco casos nos Estados Unidos. Segundo matéria publicada pela CNN Brasil (2021), no dia 5 de

junho de 1981 houve a divulgação de um relatório de saúde pública, realizado semanalmente pelo Centro para Controle de Doenças — CDC, na cidade de Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos.

Diferentemente do que o relatório comumente trazia como informações, nesse dia apontava-se que cinco jovens gays estavam doentes, e dois deles haviam morrido. A causa da doença era uma infecção pulmonar que não era comum de se observar, sobretudo em jovens. A enfermidade identificada e diagnosticada pelo Centro foi uma pneumonia causada por um fungo, conhecido na área das doenças como *Pneumocystis carinii*.

Desde o aparecimento da AIDS, o jornalista Shilts (1987) dizia que uma das formas pelas quais o HIV era conhecido foi como “síndrome do intestino gay”, devido ao fato de que alguns dos sintomas eram a diarreia. O mais interessante de perceber é que nenhuma outra doença que tem como sintoma a diarreia leva como base a orientação heterossexual. A explicação é óbvia: as infecções são humanas, e não de orientação sexual nem de identidades de gênero.

Antes de ser conhecida como AIDS, a síndrome também foi nomeada como GRID — sigla em inglês para *Gay-Related Immune Deficiency* (Deficiência Imunológica Relacionada aos Gays). O nome associava a doença aos gays, devido à prevalência dos casos, no início da pandemia, ter maiores notificações entre homossexuais. Outras nomeações também lhe foram atribuídas, como peste gay e câncer homossexual (Rodrigues, 2020).

O conhecimento sobre o HIV e a AIDS, não se restringia mais aos tubos de ensaio, ou a intervenção dos microscópios, dos saberes médicos e das pessoas cientistas. Aos poucos ele avança na sociedade, levando a conhecimento pelos meios de comunicação, em destaque, a televisão, os jornais, as rádios em uma espécie de catequização. As falas massificadas que os vários meios de informação e desinformação, colaborou para a produção dos corpos soropositivos associados a morte. A AIDS era a encarnação da morte em vida soropositiva (Fonseca, 2022).

Finkelstein (2017), em sua obra *After Silence: A History of AIDS Through Its Images*, descreve a imagem das pessoas soropositivas como a de imigrantes no contexto dos Estados Unidos. Segundo ele, no início da pandemia, via seus amigos sobretudo ele e seu companheiro serem expulsos de forma forçada de suas casas. Utiliza a metáfora de serem enviados ao mar, postos à margem não apenas da

sociedade, mas, principalmente, uns/umas dos/das outros/as. Na época, seu companheiro havia sido diagnosticado com AIDS.

Em seu relato, descreve não apenas a vivência do processo de despedida do amor de sua vida, seu companheiro de toda uma história que estava em processo de morte, mas também a despedida de um mundo. O mundo que ambos haviam vivido não seria mais o mesmo e, naquele momento, ele não imaginava que a transformação seria tão trágica quanto a que assistiria anos depois.

Os traumas de ser gay e/ou uma pessoa trans, ou qualquer pessoa não heterossexual, seriam agora interseccionados pelo medo de ter HIV e morrer de AIDS. Dois pesos em uma mesma medida para as pessoas não heterossexuais.

Com o movimento dos acontecimentos, os casos da síndrome passaram a aumentar e começaram a ser vistos não apenas entre homossexuais. Logo, ela passou a ser conhecida como a doença dos 5 Hs.

Os Hs correspondiam a: homossexuais — homens que têm relações sexuais com outros homens; as/os hemofílicos/as, devido à condição de algumas pessoas apresentarem dificuldades de coagulação sanguínea, passando, assim, constantemente por transfusões de sangue; pessoas haitianas, marcadas pelo racismo e pela visão de que a AIDS era uma doença africana; os heroinômanos, caracterizados como pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas injetáveis e que, nas trocas não descartáveis de agulhas, favoreciam o processo de contágio; e, também, as/os *hookers*, que, em tradução para o português, são pessoas que trabalham com o sexo.

Em 1983, no dia 27 de março, um dos programas mais assistidos da televisão aberta¹⁵ brasileira transmitiu a primeira informação sobre o que hoje é conhecido como HIV e AIDS. A reportagem foi dirigida pelo repórter Hélio Costa, direto de Nova York (EUA).

A matéria trazia como emblema “uma doença misteriosa” e apresentava a mensagem com características de filme de terror, pois, inclusive, ao narrar os fatos, utilizava como fundo a música *The Water Kit*, de John Williams, da trilha sonora do filme Tubarão 2. O filme, característico de suspense dos anos de 1978, acompanhava

¹⁵ Tais informações foram coletadas no arquivo digital “Globo memórias” disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/descoberta-e-desdobramentos-da-aids/noticia/descoberta-e-desdobramentos-da-aids.ghtml>

a narrativa aterrorizante sobre o que vinha acontecendo, ao menos nos recortes que eram selecionados sobre o HIV.

A reportagem dividia a abordagem e a transmissão da informação. De um lado, colocava a AIDS como a “epidemia mais violenta do século”, entrevistando o médico Richard Sillick, que mostrava a evolução da infecção em 1978, quatro casos; em 1979, nove casos; e, em 1982, mais de 700.

Por outro lado, apresentava imagens que ilustravam o que a ciência já sabia sobre a infecção, a forma de contágio e seu desenvolvimento no corpo humano.

Na reportagem, o repórter Hélio Costa entrevista Phil Lantaratta, um homem cis, branco e americano que vivia com HIV e que já havia passado pelas experiências características da infecção, no que tange às questões imunológicas próprias da evolução do vírus no corpo humano. No comentário, o repórter menciona a evolução da infecção como uma “bomba-relógio”.

A reportagem traz como destaque as transfusões de sangue e os riscos que, até então, não eram considerados. Na época da matéria e naquele ano, apenas nos Estados Unidos havia cerca de 10 milhões de transfusões de sangue. A população que recebia as transfusões era variada, como foi o caso de um garoto que recebeu sangue de um homem que, meses depois, morreu em decorrência da AIDS. A origem desse homem não foi revelada, pois não havia um exame específico para constatar a aptidão do sangue para ser comercializado.

Muitos dos bancos de sangue, no contexto dos Estados Unidos, eram de instituições privadas que pagavam pelas doações. Havia certa relação de exploração, devido ao fato de que muitas pessoas que vendiam seu sangue estavam em situações de vulnerabilidade. As que recebiam não tinham noção do que estavam recebendo (Memória Globo, 2021a).

Na tangente da transferência do problema “médico” de volta aos “5 Hs”, foram criados critérios estabelecidos para assegurar quais sangues estavam aptos a serem utilizados e quais não. Essa classificação não deixou de fora o grupo classificado como de “risco” os 5 Hs, considerados não aptos a serem doadores.

Essa visão, no Brasil, perdurou até 2020, após decisão do Supremo Tribunal Federal permitir que pessoas homossexuais pudessem ser doadoras, desde que estivessem saudáveis, assim como as demais pessoas.

O problema, nos Estados Unidos, em relação à transfusão de sangue, não tinha como principal preocupação a AIDS, mas sim a sua comercialização. A “máquina sangue-suga” não poderia parar.

No girar do tempo, um dos movimentos políticos que buscou investir contra a epidemia ocorreu em São Paulo, no ano de 1983, quando foi criado o Programa Estadual de DST/AIDS, no governo de Franco Montoro, do MDB. O programa visava a um trabalho com enfoque na vigilância epidemiológica, levando à população conhecimento e informação, buscando esclarecer e distanciar o pânico e a discriminação, sobretudo em relação aos grupos mais atingidos e vulnerabilizados pela epidemia, conforme muitas narrativas construídas no decorrer dos primeiros casos de AIDS.

O programa realizava atendimentos às pessoas diagnosticadas com HIV ou AIDS e oferecia orientações às pessoas responsáveis pelo trabalho realizado com esses sujeitos.

Ainda no mesmo ano, no dia 28 de dezembro, o governador André Franco Montoro instituiu o Decreto nº 21.833, que passou a implantar, nas escolas, o Ciclo Básico no ensino de 1º grau em todas as escolas paulistas. O 1º grau corresponde, hoje, ao ensino fundamental.

A instituição do decreto previa alguns pontos: a aprendizagem como um processo contínuo; a singularidade das/os estudantes; e a flexibilidade curricular. Tal postura visava diminuir as reprovações, partindo do entendimento de que cada estudante tem seu próprio tempo para aprender.

Souza (2006) lê o decreto como uma forma política que buscou acompanhar o contexto pelo qual o país e o Estado passavam, assumindo o compromisso com a redemocratização. O projeto indicava a ruptura com a cultura escolar seletiva, sobretudo nos anos iniciais, e com os impactos pedagógicos no processo de alfabetização.

Ou seja, a percepção e a prática pedagógica apoiavam-se na/o professor/a, que deveria dominar os conteúdos que iria ensinar e, ao mesmo tempo, considerar se a/o estudante, no decorrer do processo de produção do conhecimento, estaria apto/a a seguir para outros anos.

Nos anos seguintes, em 1985, no dia 19 de agosto, o Jornal Nacional apresentou a entrevista conduzida por Lucas Mendes com o cientista Roberto Gallo, responsável por identificar o vírus da imunodeficiência humana nos bancos de sangue

no Brasil. Nessa época, a ausência de conhecimentos que possibilitassem o manejo da infecção contribuiu para que ela se alastrasse, alcançando grandes proporções.

Só se percebia a presença do vírus nas pessoas quando o sistema imunológico já havia sido alterado de forma negativa, tornando, em sua maioria, impossível a reconstituição. Apenas nos tubos de ensaio dos laboratórios era possível conhecer a presença do vírus no sangue humano. Ao final da entrevista, Gallo conclui sua fala dizendo que “quem tiver AIDS não terá outra saída, senão a morte” (Memória Globo, 2023).

Enquanto o mundo vivia sob o reforço constante da morte e, para alguns, do sofrimento, o Brasil conhecia outro vírus: o “Vírus do amor”, música de Lee e de Carvalho (1985). A canção trata o HIV de forma poética e contextualizada ao Brasil.

A letra transmite a ideia da condição humana enquanto turistas de uma terra cercada por edifícios e por um calor que se assemelha à febre que nos consome enquanto mortais. Um vírus que não tem rosto, mas que é amor, por estar nas pessoas e não na estereotipação construída pelas diversas narrativas preconceituosas.

Os anos que se seguiram, entre 1985 e 1991, ainda foram marcados fortemente por campanhas que potencializavam o preconceito e o estigma sobre o HIV e a AIDS. O medo era instaurado a partir da ideia de que “se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar”.

Ainda assim, entre as várias lacunas, sobretudo as educacionais, ONGs e grupos sociais posicionaram-se a favor de levar conhecimento à sociedade por meio de campanhas que abordavam as questões da AIDS de forma interseccionalizada com gênero, sexualidades, educação sexual, redução de danos, entre outras. Todas tinham em vista diminuir as desigualdades, valorizando as diferenças como estratégia para avançar nas formas de prevenção e cuidado (Seffner *et al.*, 2008).

No decorrer dos anos, o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas ampliaram sua percepção no panorama social. O jornalismo desempenhou a tarefa de produzir essa percepção, transmitindo uma série de reportagens.

Em 1987, no dia 12 de fevereiro, o programa Globo Repórter exibiu uma reportagem tratando sobre o HIV e a AIDS. A apresentação do programa era de responsabilidade do apresentador Sérgio Chapelin. Em uma de suas falas, Chapelin

faz uma analogia da AIDS com a peste bubônica¹⁶. A reportagem segue com a repórter Sandra Passarinho, informando as formas e os meios de contágio do HIV e entrevistando uma pessoa que vivia com AIDS (Memória Globo, 2021a).

No decorrer da entrevista, a pessoa entrevistada lembra que a morte está para todas as pessoas e que o fato de ter AIDS não a restringia a fechar a vida em um quarto, abdicando de viver como toda e qualquer outra pessoa.

Passarinho concluiu sua entrevista chamando a atenção dos telespectadores para o fato de que a AIDS não estava no ar ou no meio da rua, mas na vida das grandes cidades, e descreveu que, até o momento de sua reportagem, havia 1.012 casos notificados somente no Brasil (Memória Globo, 2021a).

No campo artístico, a AIDS foi sendo apresentada em vários papéis televisivos. A arte tornou-se uma forma de interpretar a realidade, fazendo de novelas, filmes e músicas uma pedagogia. Seu trabalho foi ensinar por meio de informações e, assim, sensibilizar os/as telespectadores/as, colocando as pessoas soropositivas como protagonistas na desconstrução da visão preconceituosa e estigmatizante que a sociedade vinha construindo sobre elas.

Um forte exemplo ocorreu em 1987, com a novela *Corpo Santo*. Escrita e dirigida pelo trio José Louzeiro, Cláudio Mac Dowell e Wilson Aguiar Filho, foi a primeira novela transmitida em televisão aberta a tratar da questão da AIDS. A trama retrata o papel da educação como um mecanismo de prevenção, ao naturalizar o uso de preservativos.

A atriz Eliene Narduchi, que interpretou o papel de uma mulher com HIV, trabalhadora do sexo, chamada Mari, na vida real sentiu na pele o peso do preconceito e da discriminação, ao sair às ruas e ser hostilizada (Rede Manchete, 1999–2024).

Em 1988, no dia 5 de outubro, foi promulgada a Constituição Federal, que marcaria a materialização da redemocratização do país. Com a promulgação da Constituição Federal, foi possível que a nação passasse a ter a saúde como

¹⁶ Segundo o Centro de Informação em Saúde Silvestre da da FioCruz (2022) “A bactéria do gênero *Yersinia* pertence a família *Enterobacteriaceae* e possui 11 espécies, mas apenas três causam doença para os humanos: *Y. pestis* que causa a peste, *Y. pseudotuberculosis* e *Y. enterocolitica*. A peste bubônica é a mais comum e a transmissão da bactéria é feita pela picada da pulga que inocula a bactéria na pele. Uma vez na corrente sanguínea, esta migra até chegar aos linfonodos que inflamam e incham formando bubões (acúmulo de pus), dando o nome característico da doença. Se a doença não for tratada rapidamente, as bactérias livres na corrente sanguínea podem atingir os pulmões, causando a forma pneumônica da doença, que passa a ser eliminada pela respiração e tosse, infectando outras pessoas de maneira direta, a forma mais grave da doença. A forma septicêmica (disseminada) é geralmente uma consequência das outras formas” (s/p).

prioridade, abrindo as portas para o Sistema Único de Saúde (SUS), que contribuiu significativamente para os avanços no cuidado com as pessoas soropositivas, chegando até os dias atuais.

Da mesma forma, no campo da educação, o artigo 210 considerou a necessidade de um currículo nacional. Segundo a Constituição Federal, era importante a definição de conteúdos mínimos que subsidiassem a educação básica, considerando valores e culturas tanto em âmbito regional quanto nacional. Tratava-se da ideia de um currículo mínimo que orientasse a educação, repercutindo em outros movimentos no campo educacional e alcançando os dias atuais.

Antes da Constituição ser promulgada, no dia 28 de janeiro de 1988, o Diário Oficial publicou a reunião da Assembleia Constituinte. Das falas, recortamos aquelas que diziam respeito à AIDS.

Uma delas foi proferida pelo deputado Jorge Arbage, PDS — PA. No uso da palavra, o deputado faz menção ao artigo “AIDS e a moral sexual”, de autoria do arcebispo D. Eugênio Sales. Segundo o deputado, a AIDS é uma questão que envolve aspectos econômicos, no sentido dos gastos, e direciona a sociedade à corrupção da moral e dos costumes.

Outra fala foi a do deputado José Elias Murad, PTB — MG. Em sua intervenção, menciona a AIDS como uma moléstia que assola o mundo inteiro. Faz uma relação da AIDS com o uso de substâncias injetáveis, como uma preocupação com a propagação da doença, vista por ele como responsabilidade do Estado no combate às drogas para o futuro do país.

Nos arquivos do Senado Federal (2023), em lembrança aos 40 anos da chegada da AIDS ao Brasil, algumas menções são apresentadas a partir das falas de parlamentares. O deputado Nelson Aguiar — PMDB/ES mencionou uma passagem da Bíblia, de autoria do apóstolo Paulo, referindo-se à relação sexual entre dois homens como algo que, no futuro, receberia uma justa retribuição, sendo esta a AIDS.

Outra fala foi a do deputado Orlando Pacheco — PFL/SC, que descreveu a AIDS como consequência da devassidão, resultado do pecado, entendido por ele como juízo de Deus. Ainda em sua fala, o deputado direciona severas críticas à campanha do governo federal, descrevendo a campanha sobre o uso de camisinha como “verdadeiras aulas de prostituição e homossexualismo”, que colocariam em risco a vida de crianças e jovens por influenciá-los à promiscuidade.

Outra fala foi a do deputado Eliel Rodrigues — PMDB/PA, que disse ser um equívoco constar na Constituição uma lei que assegurasse como punição a discriminação pelo fato de uma pessoa ter sua orientação sexual desrespeitada. Para ele, isso incidiria em uma “oficialização do homossexualismo como prática normal”.

A deputada Abigail Feitosa — PMDB/BA fez duras críticas ao Ministério da Saúde por uma propaganda que circulava com o slogan “Quem vê cara não vê AIDS”. Na campanha, havia uma mulher estampando o cartaz e que, segundo a deputada, representava discriminação às mulheres e também desinformação, por serem consideradas o “grupo de menor risco”.

O deputado José Genoino — PT/SP, em sua fala, pedia que as autoridades responsáveis e a sociedade como um todo olhassem para a AIDS com seriedade e maiores cuidados.

A fala que se soma às dos demais deputados/as é a do deputado Mário Maia — PDT/AC, discordando da posição de Genoino. Segundo o deputado, não era necessário concentrar forças para a resolução dos problemas resultantes da AIDS, pois, segundo ele, “há outros males que matam mais”.

O deputado Ivo Mainardi — PMDB/RS faz uma comparação entre a fome e a AIDS. Segundo ele, a fome mata mais do que os “aidéticos”. Chico Humberto — PDT/MG assume uma postura negacionista ao afirmar que o Estado estava investindo em uma doença que o Brasil ainda não tinha. Ressalte-se que o deputado é médico de formação.

Outro parlamentar foi o deputado Raimundo Bezerra — PMDB/CE, também médico, que, em sua fala, afirmou haver o risco de um mosquito, ao picar uma pessoa com HIV, transmitir o vírus ao picar outra pessoa, considerando o mosquito como um possível agente transmissor.

Por fim, o deputado Onofre Corrêa — PMDB/BA, em sua fala, sugeriu que houvesse testagem nas pessoas que chegassem ao Brasil vindas de outros países. Caso fossem detectadas com HIV, deveriam ser impedidas de entrar no país.

Outra fala que se somou às demais foi a do deputado Mauro Miranda — PMDB/GO, alinhado a teorias conspiratórias, que pedia que a Constituição atentasse para a criação de leis que fiscalizassem os/as cientistas, pois, segundo ele, os laboratórios seriam locais onde o vírus do HIV havia sido criado, assim como sua presença em produtos genéticos.

O deputado Amaury Müller — PDT/RS chama o governo da nova forma política (República) de “aidético”, por buscar, junto ao Fundo Monetário Internacional, meios para ajudar a desenvolver soluções para a AIDS. O deputado Maurílio Ferreira Lima — PMDB/CE também utiliza a AIDS como um xingamento hostilizador, ao dizer que o centrão compunha o grupo das pragas do Egito que acometiam o Brasil: a AIDS, a carestia (aumento dos preços) e o acidente com o césio-137 em Goiânia¹⁷.

A deputada Anna Maria Rattes — PMDB/RJ, ao utilizar de sua fala, posicionou-se contra o negacionismo, afirmando que as pessoas soropositivas são alvo de injustiças e discriminação.

O deputado Carlos Sant’Anna — PMDB/BA chamou a atenção para o fato de que o sangue humano não pode ser visto como uma arma contra nós mesmos.

O deputado Vicente Bogo — PSDB/RS salientou que outras infecções e doenças podem ser transmitidas pelo sangue, além do HIV. Segundo ele, os bancos de sangue não têm cumprido o papel de garantir a qualidade da proteção, pois, em nome do lucro, evitam realizar testes, por serem caros.

O deputado Ferreira Lima — PMDB/PE mencionou a situação como “ouro vermelho”. A solução, segundo ele, seria a estatização.

Haveria, talvez, uma boa dose de inocência em dizer que o mundo “demorou” muito para entender a realidade do que foi e é o HIV e a AIDS? Teria sido pelo fato de ser algo novo, e por não se saber lidar com a questão? Poder-se-ia dizer que a ciência médica, que sempre se colocou e até hoje se coloca à frente das resoluções dos problemas, viu-se de mãos atadas?

Ou, como disse Shilts (1987), tal negligência teria sido proposital, por ter como primeiros casos, e como prevalência, pessoas homossexuais? Cientistas, instituições, o próprio Estado, seriam vistos como agentes que, ao tratar um problema que aos poucos eliminava um grupo da sociedade que não era bem visto, optaram pelo silêncio? Como ficariam suas carreiras, a visão e a legitimidade do Estado e das instituições?

O jornalismo só se viu atento quando o alto número de mortes começou a se tornar realidade na sociedade. A preocupação deu-se pela audiência e pelo sensacionalismo? Ou porque, mais uma vez, eram as pessoas homossexuais que

¹⁷ Foi um acidente que matou 4 pessoas e deixou mais de mil pessoas prejudicadas pelo contato com a radiação (<https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2023/07/06/cesio-137-maior-acidente-radiologico-da-historia-aconteceu-em-goias-e-afetou-mais-de-mil-pessoas-relembre.ghtml>) .

estavam no centro do problema e, novamente, o peso sobre seus/suas corpos teria ainda mais recursos para o preconceito, a estigmatização, as violências e, sobretudo, a desumanização? (Shilts, 1987).

Ainda no ano de 1988, foi criado o Centro de Referência e Treinamento em AIDS (CRT-A), ligado ao gabinete do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, no governo de Orestes Quércia — MDB. As metas propostas pelo centro eram capacitar profissionais e criar normas técnicas, com o intuito de descentralizar os trabalhos desenvolvidos no que tange à prevenção, à vigilância e à assistência no âmbito do Estado de São Paulo.

Em 5 de janeiro de 1988, foi apresentada uma reportagem no Jornal Nacional, por Sandra Moreyra, sobre a morte do cartunista Henfil em decorrência da AIDS. O cartunista era hemofílico, assim como seus irmãos, que posteriormente também viriam a falecer. Naquela altura, a caracterização da AIDS ia se desconfigurando em relação ao que havia sido criado no início, como a “peste gay”.

Segundo a reportagem, 18% das pessoas que viviam com AIDS tinham adquirido a infecção por meio de transfusão de sangue. Aos poucos, a AIDS ia se modificando, ganhando novas faces e novos olhares. Em 1989, morreu também o ator Lauro Corona, que havia trabalhado em várias novelas (Memória Globo, 2021b).

O ano de 1989 é marcado pela peça de teatro Adeus, irmão, durma sossegado, escrita por Vagner de Almeida. Naquele contexto, a peça ganhou repercussão por levar os/as espectadores/as a provocações que mostravam que a AIDS estava na possibilidade de toda e qualquer pessoa.

Ao quebrar o estigma da relação criada entre a AIDS e as pessoas homossexuais, a obra levou ao debate, na sociedade, a importância de falar sobre HIV e AIDS em um momento tão crítico da epidemia (Almeida, 1988).

Outros movimentos apareceram no contexto dos acontecimentos da AIDS, sobretudo no campo da educação. Em 1989, em entrevista ao programa Roda Viva, a então coordenadora do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, Marta Suplicy — PT, discutiu e defendeu a importância de tratar as questões sobre sexualidade na escola (Youtube, 1989).

Em um momento em que a AIDS se estabelecia como um perigo para a sociedade, tanto no campo da saúde quanto na construção de estereótipos e preconceitos contra as pessoas que viviam com HIV, a escola cumpria um papel

fundamental em assegurar o conhecimento para a vida real em sociedade (YouTube, 2020).

Na educação, de forma particular em São Paulo, a Secretaria da Educação, nos anos de 1989 a 1991, esteve sob os governos de Orestes Quércia — MDB, que concluiu seu mandato em março de 1991, sendo sucedido por Luiz Antonio Fleury Filho, também do MDB.

Moreira (2000), ao descrever o contexto educacional desse período em São Paulo, caracteriza-o como um momento marcado por ideias pautadas em Paulo Freire, dialogando com estudiosas/os do âmbito da psicologia e de outras áreas, de forma interdisciplinar. A prova disso está nos documentos educacionais, com a presença de discussões sobre ideologia e poder, currículo oculto, entre outros.

No desenrolar dos anos, ao final da década de 1980, Paiva, Antunes e Sanchez (2020) descreve o Brasil como um momento de intensos obstáculos para o trabalho na promoção da saúde, que culminava com os primeiros casos de AIDS. Com o fim da ditadura e da censura, ainda havia poucos livros nas bibliotecas que abordassem questões que fugiam ao que o regime aceitava. Questões sobre sexo e sexualidade eram algumas das temáticas alcançadas pela censura.

A ausência de pesquisas e do desenvolvimento de conhecimento científico que os livros proporcionavam dificultou a compreensão do contexto da AIDS a partir de interfaces sociais e culturais pouco exploradas naquele momento.

3.6 Década de 1990

Na virada da década, mudam-se os números que a compõem, assim como as pessoas vivendo com AIDS. Uma pesquisa realizada pelos pesquisadores Rodrigues Júnior e Castilho (2004), buscou, dentro do recorte temporal dos anos de 1991 a 2000, identificar a incidência de pessoas com AIDS nos municípios brasileiros. O resultado da pesquisa mostrou um total de 197.924 pessoas notificadas ao Ministério da Saúde. Dentre esses números, mulheres e pessoas com baixa escolaridade foram as mais vulneráveis à AIDS.

A pesquisa ainda considerou algumas características, como o Estado de São Paulo, com os maiores números de pessoas com AIDS; Pernambuco, pelos casos resultarem, em sua maioria, de transmissão homossexual e bissexual, como ocorria

no início da epidemia; e Santa Catarina, pelo alto número de casos de AIDS relacionados ao uso de substâncias ilícitas injetáveis.

Em 1990, o Brasil já vivia sob os moldes do sistema democrático e, em sua maioria, escolheu para presidente Fernando Collor de Melo (PRN). A vitória se deu a partir das alianças de grupos conservadores que se opunham ao seu concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Não demorou muito: em 1993, Collor renunciou, após serem descobertos, por meio de evidências, vários esquemas de corrupção. Em seu lugar, passou a ocupar o cargo de presidente seu vice, Itamar Franco (PRN). Sua gestão, no que tange à educação, ficou marcada pelo Plano Decenal de Educação para Todos, que, de certo modo, não sinalizava uma posição clara sobre quais rumos a educação seguiria (Fernandes; Almeida, 2022).

No ano de 1990, o Ministério da Educação criou o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mais conhecido como Saeb. A proposta da avaliação, segundo Barreto (2012), foi verificar os “ganhos” que as/os alunos do ensino básico tiveram. O meio para que a avaliação pudesse obter seus resultados tinha como currículo uma referência comum e um ensino baseado nas competências que a/o estudante havia alcançado.

Outros acontecimentos que construíram os anos 90 no contexto educacional foram a entrada de outras bases de pensamento curricular para disputarem espaço no ambiente escolar. As vertentes de pensamento conhecidas pelos estudos culturais, pelo pós-modernismo e pelo pós-estruturalismo. As mudanças não retiraram a importância do conhecimento escolar. Acrescentaram-se novos temas, como a relação poder-saber inscrita no currículo, o currículo transversal, outras formas de organização curricular, a relação com o cotidiano escolar, além de questões sobre sexualidade, gênero, etnia e multiculturalismo (Moreira, 2000).

Lopes e Macedo (2010), ao localizarem as discussões no campo do currículo no contexto brasileiro dos anos de 1990, nomeiam-no como um momento de hibridismo. Segundo a leitura das autoras, o hibridismo diz respeito a uma diversidade de teorias que se propõem a discutir o campo do currículo. Não há uma generalização sobre as perspectivas curriculares, mas disputas e rejeições que dialogam entre si, possibilitando pensar o campo do currículo como um espaço de disputas, que durante anos esteve impossibilitado.

A preocupação, nesse contexto, é a descentralização do sujeito, a realidade inscrita na produção discursiva e cultural, a qual é resultado das relações entre saber

e poder, direcionando-se a novas preocupações que, no decorrer da história da educação brasileira, podem não ter sido consideradas, como as questões de gênero, de sexualidade, de raça e etnia. Em síntese, destaca-se a valorização das diferenças presentes na escola.

No que tange às teorias pós-críticas no embasamento do currículo, houve restrições à sua inserção, com destaque para as sugestões voltadas ao multiculturalismo e às questões de gênero e sexualidade. O grupo conservador já era atuante. Tais temas eram lidos como “perigosos”, por romperem com aquilo que acreditavam dever manter os valores e princípios da sociedade. O grupo que não se enquadrava como conservador, propriamente os da esquerda, também não incorporava ideias pautadas nas diferenças, demonstrando certa resistência. Preocupavam-se com temas voltados às desigualdades sociais e econômicas (Moreira, 2000).

No giro do globo, a forma como outros países foram criando a percepção sobre a experiência do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas parece ter seguido um mesmo caminho adotado pelo Ocidente. Na China, o reconhecimento do HIV adveio por meio de quatro chineses hemofílicos que receberam uma transfusão de sangue dos Estados Unidos. Na Tailândia, foi um homem que regressou dos Estados Unidos. Outro ponto é o seguimento moral que líderes asiáticos encaram como crucial. De outro modo, o HIV e a AIDS, para algumas regiões da Ásia, são resultado de comportamentos transgressores e imorais, caracterizados por pessoas não heterossexuais, profissionais do sexo e usuários de substâncias ilícitas, ou seja, por grupos que a sociedade produz para serem marginalizados. Há também uma tentativa de construir uma nova concepção sobre o HIV e a AIDS que não seja a mesma adotada pelo Ocidente (Nepal, 2007).

O relatório *Locked Doors: The Human Rights of People Living with HIV/AIDS in China* (A human rights watch, 2003), ao descrever o decorrer da década de 1990, aponta que, em todo o território chinês, havia pelo menos 1,5 milhão de pessoas soropositivas. Entre as possíveis justificativas, uma delas é atribuída às autoridades, pela despreocupação com a transmissão do vírus por meio da transfusão de sangue, que visou à lucratividade sem a devida salubridade.

As pessoas que passaram a conviver com o vírus foram discriminadas, sem qualquer responsabilização por parte do Estado ou das instituições privadas responsáveis pelo gerenciamento dos bancos de sangue. As pessoas soropositivas

foram forçadas a viver como criminosas, fugindo e isoladas, enfrentando a morte sozinhas e na precariedade. Isso porque, ao se revelarem, eram mandadas embora de suas casas, e os hospitais recusavam atendimento. Muitas eram encontradas mortas em suas próprias residências.

Na leitura de Parker *et al.* (2022), no Brasil, em meados dos anos de 1990, no que tange à administração do então presidente Fernando Collor (PRN), não diferente do governo do presidente José Sarney de Araújo Costa (MDB), as respostas à AIDS não eram satisfatórias. Embora, para algumas pessoas, o peso possa ser minimizado pelo fato de a epidemia ser uma “novidade” que surpreendeu toda a sociedade, ainda assim, quando se trata de especificidades, sobretudo na área da saúde, essas questões podem ser contestadas, uma vez que as respostas estavam centradas no campo moral.

O ministro da Saúde do governo Collor, Alcení Guerra, é um exemplo de percepções limitantes e naturalizadas. Isso decorreu do fato de ter criado campanhas e meios de informação que produziam uma visão terrorista, que releio como persecutória. Mensagens como: “Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar”. Com Sarney, o ministro da Saúde Adib Jatene propôs criar meios para lidar com a AIDS embasados nos direitos humanos, não estigmatizando como vinha acontecendo, orientação que seguiu até os anos 2000.

No ano de 1991, sob o governo de Fernando Collor de Mello (PRN), o ministro da Educação, Carlos Chiarelli, em fala no I Congresso Nacional sobre Saúde do Adolescente, ocorrido no Rio de Janeiro, defendeu a ideia de que a educação sexual não se pauta apenas em informações, mas, sobretudo, na preparação para a vida, de forma crítica, para escolhas livres e responsáveis, garantindo o potencial presente em todo ser humano. A escola, assim, seria o local preparatório. Contudo, antes, precisaria abraçar essa missão sem preconceitos e com estratégias educacionais (Pinheiro, 1997).

Ainda no ano de 1995, no dia 20 de setembro, a Igreja Católica lidava com as questões do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas a partir de uma perspectiva moral, ignorando o cenário em que as mortes vinham ocorrendo. A fala de um dos representantes da Igreja no Brasil, Dom Eugênio Sales, defendia que a resposta à AIDS seria mudar o comportamento de libertinagem. Segundo o religioso, a causa da epidemia de AIDS decorria de relacionamentos irresponsáveis. O trabalho que vinha

sendo realizado pelo Estado, por meio de campanhas de prevenção, sobretudo com o uso de preservativos, era, para Eugênio, uma hipocrisia (Souza, 1995).

Ao que tudo indica, o papel da Igreja no contexto da epidemia de AIDS, nas palavras do médico Drauzio Varella, foi criminoso. Ir contra o preservativo e propagar a ideia de que a AIDS era resultado de comportamentos ilegais foram mensagens que fortaleceram a ignorância diante de um mal que acometia sem misericórdia.

Em tudo, a AIDS mostrou o que ninguém queria aceitar como verdade: toda vida humana está na possibilidade da vulnerabilidade ao desejo sexual. Isso porque, na conjuntura que vinha sendo construída, a visão sobre a infecção como algo inerente às pessoas não heterossexuais, ou, quando heterossexuais, a comportamentos “desviantes”, usuários de substâncias, prostituição e assim por diante, revela que, não importa quem sejamos, estamos sob a condição de adoecer, independentemente de quem sejamos (Trevisan, 2007).

Em 1991, a minissérie *O Portador*, escrita por José Antônio de Souza, narra a história do personagem Léo, interpretado pelo ator Jayme Periard. O personagem é um rapaz que, ao sofrer um acidente aéreo, precisa passar por uma transfusão de sangue e, por fim, acaba contraindo o HIV. A minissérie buscou transformar, pela arte, a realidade vivida pelas pessoas soropositivas, ao mostrar os processos de preconceito que, aos poucos, vão sendo superados, e ao evidenciar que há vida para quem vive com HIV (Memória Globo, 2021c).

Aos poucos, a AIDS foi tomando corpo, e sua existência foi modificando sua face e características, desde o início, quando era considerada uma doença homossexual. A reportagem apresentada por Caco Barcellos, em 29 de junho de 1992, no *Jornal Nacional*, mostrou uma família de oito pessoas que viviam com HIV em um bairro da cidade de São Paulo, Guaianazes. Na reportagem, o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas se colocaram como uma denúncia da condição que vinha sendo imposta aos grupos mais vulnerabilizados da sociedade.

Um dos membros da família, Ivanildo Ferreira, via sua vida findar e chorava por não ter uma televisão para poder distrair as crianças da casa. Fato é que a própria emissora não se preocupou em colaborar, mesmo sabendo que a televisão seria também uma forma de retorno para ela mesma, restringindo-se a utilizar o sofrimento da família em nome da audiência (Memória Globo, 2021a).

Em janeiro de 1993, foi instituída a Portaria nº 122 pelo ministro da Educação e do Desporto, Murílio Hingel, sob o governo de Itamar Franco (PMDB), resultante do

Comitê Nacional de Educação Preventiva Integral (CONEPI) e das Diretrizes para uma Política Educacional em Sexualidade. A diretriz busca reforçar as ações direcionadas ao campo da educação preventiva, considerando a capacitação de estudantes do grupo infantojuvenil para lidarem com situações como a gravidez indesejada, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a AIDS. A proposta foi realizar uma educação sexual que se direcionasse à qualidade de vida pessoal e coletiva (Brasil, 1994).

Em 1993, no estado de São Paulo, sob o governo de Luiz Antônio Fleury (PMDB), foi realizada a união entre os programas de AIDS e DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), reformulando o Centro de Referência e Treinamento para Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Com a unificação, foi possível ampliar o alcance da formação dos profissionais da saúde, que estavam sob a responsabilidade do trabalho de atendimento e prevenção, criando novos protocolos que otimizaram a qualidade da assistência realizada ao público, entre outras melhorias.

Em março de 1993, Paulo Freire (1993) concedeu uma entrevista à Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e falou sobre a AIDS. Para o pedagogo, com forte atuação na educação brasileira, a AIDS, à altura em que a entrevista era realizada, deveria ser tratada de forma urgente e política. Pela política, constroem-se pedagogias que levam as pessoas a conhecerem.

Para Freire, a educação sexual deve estar presente na escola, de forma interdisciplinar, no currículo. Em um momento da entrevista, percebe-se certa denúncia e contrariedade em relação ao papel da Igreja Católica. Segundo Freire: *“eu acho que uma das coisas mais lamentáveis disso tudo é que a AIDS chega misturada com o pecado. Ela traz novamente uma relação trágica entre o gozo e a proibição do gozo. Uma coisa milenar que as igrejas têm trabalhado muito... Eu acho que uma das preocupações, numa tarefa pedagógica com relação à AIDS, é desnudar isso já”*.

Ainda no ano de 1994, no dia 20 do mês de maio, o repórter Aureliano Biancarelli (1994), publicou, no jornal Folha de S. Paulo, a reportagem intitulada “Nunca usei camisinha, diz padre com AIDS”. A matéria apresenta a conversa de Biancarelli com o padre João Monteiro, na cidade de São Paulo, que, em 1993, descobriu sua sorologia para o HIV. Na conversa, Monteiro afirmava que nunca havia usado preservativo nas relações sexuais com outros homens com os quais se relacionava. Monteiro relatava a Biancarelli que muitos padres morriam sem

mentonar a causa, por se tratar da AIDS. Três semanas antes, um padre conhecido dele havia falecido em decorrência da doença.

Ao ser questionado pelo repórter sobre sua vivência homossexual, Monteiro respondeu que *“o celibato acaba sendo uma forma de proteger o homossexual. As pessoas sempre desconfiam de um solteirão que não se casa, mas não desconfiam de um padre. Eu vivo o Evangelho dentro da minha sexualidade”*. Ainda na mesma reportagem, a matéria traz relatos de outro padre, Léo Pessini, de 38 anos, capelão do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo o capelão, 27 padres haviam morrido em decorrência da AIDS em hospitais de São Paulo entre os anos de 1987 e 1993. Os números afirmados pelo capelão poderiam ser maiores, sinalizando uma imprecisão.

O médico Mirko Grmek (1994), em palestra no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, intitulada *“L'énigme de l'apparition du sida”*, em 24 de novembro de 1994, posteriormente publicada, apresenta um dado pouco conhecido quando se trata de HIV e AIDS. Segundo ele, existiram duas epidemias, resultantes de dois germes diferentes: HIV 1 e HIV 2.

Ambos são parentes distintos, o que se explica pelo fato de que os genomas, ou seja, a informação hereditária presente no DNA de cada HIV, são diferentes. A difusão do HIV 1 teve três locais de origem: um na África Central e os outros dois na América do Norte, mais especificamente no litoral. No que tange ao HIV 2, o local de origem foi a África Oriental.

Entre os anos de 1994 e 1999, foi criado o Projeto Escolas. O projeto foi realizado em parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde, com ênfase na epidemia que seguia naquele período. Inicialmente, o projeto foi implantado em 16 Unidades da Federação, sendo expandido até o ano de 2000 para 27 Unidades da Federação, a partir de outro programa, Salto para o Futuro, alcançando aproximadamente 250 mil professores e 9 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio (Brasil, 2008).

No contexto midiático, em 1994, morreu o ator Wagner Bello, que interpretava o personagem ET Valdo, do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Em 1997, morreu o sociólogo Betinho. Em 2000, morreu a atriz Sandra Bréa, com atuação em diversos papéis tanto na música quanto na dança. A AIDS, aos poucos, foi ampliando sua face, mostrando estar presente em todos os setores da sociedade e possível a toda e

qualquer pessoa, inclusive ídolos e ídolas (Memória Globo, 2024; Observatório da TV, 2023; Boll, 2023).

No dia 29 de junho de 1995, a Folha de S. Paulo (1995), publicou a matéria intitulada “SP teve caso semelhante em 92”. A reportagem trata do caso de uma criança chamada Sheila, de apenas cinco anos, que vivia com HIV e que, ao ser matriculada em uma escola privada, foi barrada. A partir dessa decisão, outras escolas foram orientadas a adotar a mesma postura, por intermédio do sindicato que representava as instituições particulares. Os familiares de Sheila buscaram na Justiça o direito à matrícula da filha. Em fevereiro de 1993, Sheila faleceu. O caso ganhou forte repercussão.

Em 29 de maio de 1992, foi sancionada pelos Ministérios da Educação e da Saúde a Portaria Interministerial nº 796, que proíbe a solicitação e a realização de testes compulsórios para HIV, exige sigilo e confidencialidade e determina que, caso a escola tenha estudantes soropositivos, é proibida sua exclusão ou o encaminhamento para salas “especiais”. A medida visou coibir a discriminação de pessoas soropositivas no âmbito educacional.

Passados alguns anos, em 2 de fevereiro de 1995, ocorre mais uma mudança na construção social do HIV. Marcos Losekann, em reportagem para o Jornal Nacional, mostra a distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento do HIV. Chama a atenção o fato de que os hospitais em São Paulo, que antes não tinham vagas para acolher as pessoas com AIDS, encontravam-se vazios. O medicamento, conhecido como coquetel, constituído por cerca de 30 comprimidos diários, causava mais sofrimento do que esperança de não morrer. A ciência o descrevia como um avanço.

Os remédios ajudaram a diminuir o número de vírus no corpo, colaborando para que o organismo reagisse frente ao colapso criado pela destruição da imunidade provocada pelo HIV. Segundo os dados, sete a cada dez pessoas apresentavam resultados satisfatórios. Contudo, há ressalvas, pois as primeiras pessoas que utilizaram tais medicamentos viam-se como cobaias de um estudo inicial. Isso porque os remédios também provocavam uma série de efeitos colaterais agressivos (Memória Globo, 2021a).

No ano de 1995, no governo de Mário Covas (PSDB), o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS voltou a desempenhar o papel de Coordenação do Programa Estadual de DST/AIDS, atuando como instituição de referência técnica

dessa coordenação. O CRT havia deixado de ocupar essa função em decorrência das mudanças políticas e administrativas ocorridas sob o governo de Fleury Filho (PMDB), entre os anos de 1991 e 1994.

Durante os anos de 1995 a 2002, o Brasil teve como presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Seu governo ficou marcado como a “era FHC” pelo trabalho empreendido com o “Plano Real”, quando foi ministro da Fazenda, em 1994, ao estancar a inflação que o país enfrentava. No campo da educação, o momento foi marcado pelas privatizações. Algumas medidas ganharam destaque durante seu governo. Uma delas foi a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Brasil, 1996).

A promulgação da lei visou à consolidação de um padrão de ensino, ocorrendo por meio de avaliações externas que indicam quais intervenções a política educacional investirá. Esse perfil mostra uma continuidade em relação aos governos anteriores, que buscaram produzir uma educação a partir de modelos mercadológicos já adotados em outros países do mundo (Fernandes; Almeida, 2022).

No ano de 1996, em São Paulo, no governo Covas, foi criado o Programa Prevenção Também Ensina, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O objetivo do programa era construir, com a rede estadual de ensino, um projeto educacional de caráter permanente, propiciando meios para diminuir as vulnerabilidades dos estudantes, entre elas as relacionadas às ISTs, ao HIV e à AIDS.

O projeto alcançaria as 91 Diretorias de Ensino e aproximadamente 3,7 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio. Para a realização do projeto, foram promovidas formações aos educadores, com capacitações e orientações no campo técnico da saúde, utilizando oficinas pedagógicas e materiais que cumprissem a função de capacitar e provocar discussões sobre os temas relacionados às ISTs, ao HIV e à AIDS (São Paulo, 1996).

Um ano após, em 1996, ainda no governo de Covas, o Centro de Referência Técnica em DST/AIDS passou a ficar vinculado à coordenação dos Institutos de Pesquisa, responsáveis por determinar as políticas de saúde pública na instância da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. No mesmo ano, o cantor Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, lançou a música “A Via Láctea”. A canção, interpretada por Renato Russo (1996), faz referência ao seu estado de saúde e à solidão e, posteriormente, o cantor veio a falecer em decorrência da AIDS.

Passados 16 anos do que se convencionou a chamar de início dos casos de HIV e AIDS, as escolas ainda não sabiam lidar com a doença. A resposta para essa afirmação foi apresentada, à época, por meio de uma pesquisa em curso realizada pela Associação para Prevenção e Tratamento da AIDS (APTA), que abrangeu 98 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Os dados apontavam que apenas 32% dos municípios possuíam algum projeto que fomentasse a formação de profissionais da educação para trabalhar com crianças soropositivas. Outro dado identificado foi que a maioria das cidades, ou seja, 52% das escolas, em sua maioria com estudantes na fase pré-escolar, nunca havia desenvolvido um programa que tratasse da desconstrução do preconceito em relação a estudantes soropositivos.

A presidente da APTA, a pedagoga Teresinha Reis Pinto, questionava o fato de não haver uma política que atentasse às questões de HIV e AIDS na educação. Nesse contexto, sua fala indicava que a AIDS era tratada como uma doença de adultos, como se não alcançasse crianças (Simões, 1997).

A pesquisa realizada por Bueno, ao produzir dados com professores, diretores e pais, em 1997, no contexto de São Paulo, mostrava que assuntos que tinham como tema questões sobre sexo, DST/AIDS e drogas não possuíam uma base sólida para serem ensinados a filhos e alunos. Segundo o pesquisador, era possível perceber que diretores, educadores e familiares não estavam suficientemente formados sobre questões que giravam em torno da sexualidade, das ISTs, da AIDS e do uso de substâncias ilícitas (Bueno, 1997).

Ainda em 1997, entre os meses de janeiro e fevereiro, um seminarista maranhense, em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada em 30 de julho de 2000, relatou ter sido discriminado pelo bispo da época, Dom Fernando Legal, por ser soropositivo ao HIV. Segundo o jovem, ao ingressar no curso de Filosofia, uma das formações necessárias para seguir na formação presbiteral, era exigida a realização do teste para HIV. Ao receber o resultado, teve a notícia de que era positivo para o vírus.

Ao tomar conhecimento, o bispo “solicitou” que o jovem abandonasse o seminário. Os planos de seguir a vida sacerdotal lhe custaram a própria trajetória: após ter deixado tudo, voltou para casa sem trabalho, sem onde morar e, principalmente, com o sonho de se tornar padre transformado em pesadelo.

No dia 1º de novembro de 1998, um domingo, chegava às casas da população brasileira a matéria publicada pela Folha de S. Paulo, escrita por Biancarelli (1998), com a seguinte manchete: “Maioria dos colégios não possui nenhum preparo para receber estudantes portadores do vírus HIV: situação é mais grave nas particulares”. A realidade apontada na reportagem é que a AIDS não era uma preocupação de professores e estudantes, por acreditarem que a epidemia não estaria presente nas salas de aula.

No ano da publicação, estimava-se que havia pelo menos 6.000 crianças com o vírus HIV ou já em evolução para a AIDS frequentando escolas públicas e privadas de São Paulo. Com os medicamentos, esperava-se que estudantes soropositivos ocupassem cada vez mais as salas de aula.

Ao ler a matéria, é possível perceber que movimentos externos eram realizados, como ações de ONGs que buscavam levar formação e conhecimento para preparar a comunidade escolar e desmistificar o mito que vinha sendo construído na sociedade: o de que a AIDS e as pessoas soropositivas representariam perigo. Importante destacar que não havia um interesse amplo das escolas em buscar formação e conhecimento que auxiliassem no trabalho pedagógico ao longo dos anos. Poucas foram as escolas particulares que buscaram ajuda, conforme mencionado na reportagem.

Em 1998, foi lançado o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A avaliação tinha como proposta mensurar o rendimento que as/os estudantes desenvolveram ao longo do ensino básico. Em 2001, passou a ter validade como vestibular para o ingresso nas universidades (Brasil, s/a). As medidas de implementação de avaliações seguiam a lógica de mensurar a qualidade do ensino com vistas a alcançar as metas estipuladas por órgãos que pareciam desconhecer a realidade social de muitos grupos brasileiros.

3.7 Década de 2000

A Revista Brasileira de Epidemiologia, em maio de 2017, publicou a pesquisa realizada por Guimarães *et al.* (2017), intitulada “*HIV/AIDS Mortality in Brazil, 2000–2015: Are there reasons for concern?*”. O estudo buscou identificar se as taxas de óbitos em decorrência da AIDS, no recorte temporal de 2000 a 2014/2015, haviam aumentado ou não.

Como fonte para a produção dos dados, a pesquisa utilizou duas bases de referência: o Sistema de Informações sobre Mortalidade, mais conhecido como SIM, e a base internacional *Global Burden of Disease* (GBD). Na análise, ambos os sistemas mostraram ter ocorrido aumento em vários estados brasileiros — SIM (78%) e GBD (88%).

Em anos anteriores, foi possível observar a posição em que a Igreja Católica se colocou frente às questões da AIDS que atravessavam o Brasil. Uma das formas encontradas pela Igreja para lidar com a situação foi a implantação de testes nos seminários, com o objetivo de formar padres soronegativos. A inserção desse procedimento ocorreu no ano de 2000, com o monsenhor Javier Lozano Barragán. O sacerdote era representante do Vaticano, na função de presidente do Pontifício Conselho para a Saúde.

Segundo ele, o teste era entendido como uma forma de classificação, um processo seletivo para a entrada nos seminários, sem que houvesse relação com discriminação. Nas palavras do monsenhor, o perigo era “silenciar”. Para ele, nem todos os jovens que desejam assumir a profissão sacerdotal estavam aptos (Antenore, 2000).

No dia 1º de abril de 2001, data associada ao chamado dia da mentira, a Folha de S. Paulo publicou a reportagem intitulada “Casos de AIDS preocupam o Vaticano”. Segundo a matéria, sacerdotes da África, em busca de sexo seguro, recorriam a freiras, por associarem à pureza uma suposta segurança contra o contágio (Da Redação, 2001).

Na reportagem, a freira e também médica Maura O'Donohue afirma que a AIDS não atinge apenas padres e religiosos da África, mas também de diversos outros países. Segundo ela, sem nomear os países, em um determinado país, de um total de 320 padres, 13% haviam contraído o vírus HIV. Em outro país, foi constatado que 16 religiosos de uma ordem religiosa morreram em decorrência da AIDS.

A postura de Javier ao adotar tal procedimento parece não considerar as vivências passadas dos candidatos antes de ingressarem na vida religiosa, sendo possível que tenham tido suas experiências privadas, sexuais e de sexualidade. O discurso celibatário não é uma regra, pois, na prática, nem todos os candidatos (seminaristas) e padres vivem a abstinência sexual. Muitos, sem a devida educação sexual, na clandestinidade, seja no próprio seminário, seja fora dele, também estão vulneráveis.

Durante minha estadia em dois seminários, entre os anos de 2009 e 2013, vi e vivi muitas experiências, fossem elas românticas, sexuais ou consideradas “depravadas”, que colegas experimentaram. Lembro-me de um caso que, após a morte repentina de um colega, gerou comentários de que teria sido em decorrência da AIDS. O curioso era que se colocava o problema da sexualidade debaixo do tapete, como se o não dito e o não visto não existissem.

Após 20 anos da “descoberta do HIV”, em 5 de junho de 2001, a reportagem transmitida pelo Jornal Nacional, pela repórter Zirleide Silva, revela mais uma configuração da infecção: a de que ela também tem uma cor/etnia. A repórter destaca que, embora haja maior prevalência entre pessoas negras, a infecção é possível a toda e qualquer pessoa. Se, no início, buscava-se uma vacina, passados 20 anos, esperava-se uma possível cura. E hoje, com mais de 40 anos, espera-se que até 2030 tenhamos alcançado o número zero de casos de AIDS (Memória Globo, 2021a).

Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) no governo de Fernando Henrique Cardoso. O plano foi previsto para vigorar por dez anos e tinha, entre seus objetivos, elevar as condições e o nível de escolarização do país. Na leitura do plano, é possível observar que não houve um olhar direto, nem mesmo indireto, para propor ações educativas voltadas aos temas que dialogassem com a sexualidade, com as questões de prevenção das ISTs e do HIV/AIDS. O projeto se estrutura a partir de diretrizes gerais para a educação, sustentadas em discursos de qualidade que a educação, naquele contexto, ambicionava (Brasil, 2001).

Com a derrota nas eleições de 2002, Fernando Henrique Cardoso passou a faixa para o novo presidente, Luís Inácio Lula da Silva (PT), que governaria até 2010. O governo Lula, de forma particular no campo da educação, é marcado por uma visão mais humana, que reconhece a diversidade, os direitos e as identidades, atrelando, em alguns momentos, essa perspectiva à formação profissional (Ciavatta; Ramos, 2012).

Em 2002, na tentativa de não ampliar ainda mais a contaminação da visão eclesial, a Igreja Católica no Brasil criou a Pastoral da AIDS. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB, 2002), a pastoral tem como finalidade enfrentar, junto com a sociedade, as instituições e os governos, os desafios que a AIDS tem colocado sobre a vida. Trata-se, pois, de promover o cuidado tanto da pessoa quanto da coletividade, na humanização das relações em sociedade.

Implica pensar na exclusão que a infecção ocasiona a alguns grupos, chamando homens e mulheres, a partir do evangelho, a unirem-se à Igreja. Utiliza-se da AIDS como uma ferramenta de captação de corpos e subjetividades a partir da fragilidade e da miséria humana.

Em um caminho distinto daquele seguido pela Igreja Católica, pais-de-santo, na Bahia, em 2002, buscavam formação para lidar com a epidemia em seus terreiros. Isso porque cinco líderes haviam morrido e mais de 120 adeptos contraíram o vírus do HIV nos últimos cinco anos em Salvador. As práticas e os ritos contam com uma cerimônia na qual são feitas pequenas incisões, com uma única navalha, na cabeça, no glúteo ou no tórax, para marcar a iniciação.

A formação ocorreu a partir de um seminário nacional liderado por médicos angolanos, que buscou formar 80 pais-de-santo como agentes de saúde, para colaborar com os casos de AIDS presentes nas 5.300 casas de culto espalhadas pela Bahia. Embora se entendesse que, fora dos terreiros, as pessoas tinham suas próprias vivências, isso não as isentava de buscar o cuidado pessoal e coletivo. Além das informações e formações, foram distribuídos preservativos e navalhas descartáveis como uma das formas de prevenção (Francisco, 2002).

As escritas literárias também demonstraram interesse em tratar das questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas. Em 2002, o livro *Depois daquela viagem*, escrito por Valéria Polizzi (2002), descreve sua experiência com o HIV a partir de uma relação sexual sem o uso de preservativo com seu namorado, quando veio a descobrir que estava infectada. O escritor Caio Fernando de Abreu (2006) também foi um dos autores que utilizaram suas crônicas para escrever “cartas” que narram sua trajetória com o HIV. Em 1996, o autor veio a falecer em decorrência da AIDS.

No ano de 2002, no estado de São Paulo, sob o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), ocorreu o I Encontro das Diretorias Estaduais de Educação e Saúde: Sustentabilidade e Integração das Ações Preventivas. O evento teve como objetivo auxiliar as diversas regiões do estado na elaboração de propostas educacionais voltadas às ações preventivas, com a intenção de diminuir as vulnerabilidades de jovens.

Para isso, foram realizados treinamentos para capacitar docentes, incluindo professores, gestores, coordenadores e demais profissionais, para posteriormente criar e implementar projetos em suas respectivas unidades escolares. As pessoas

responsáveis pela capacitação foram as/os profissionais atuantes das secretarias de Saúde e Educação do Estado.

Embora já tivessem se passado anos desde os primeiros casos de AIDS na Índia, em 2003, o discurso vigente ainda estava permeado pelo “negacionismo” em relação à doença. Em reportagem da BBC News, em 24 de novembro BBC News (2003), a ministra da Saúde, Sushma Swaraj, afirmou que “nunca haverá uma epidemia de AIDS no país”. O discurso adotado pela ministra era sustentado por uma concepção mais ampla, em contraposição à centralidade da prevenção.

Segundo ela, assim como a OMS no final dos anos de 1990, estava sendo adotada a estratégia do “ABC” — *Abstinence* (abstinência), *Be faithful* (ser fiel) e *Condoms* (preservativo). A proposta visava educar e informar as pessoas sobre a AIDS, implicando, assim, a inserção do tema como parte da educação sexual no currículo escolar. Soma-se a isso a valorização de condutas que direcionavam ao comportamento fiel das esposas em relação a seus maridos.

Muitos outros movimentos foram realizados pela Secretaria da Educação de São Paulo com vistas a responder aos problemas causados pelo HIV e pela AIDS. Um dos primeiros a ser citado foi o projeto Ações Preventivas na Escola (APE), iniciado a partir de 2004, no governo de Cláudio Lembo (PSD), na mesma direção do Programa Escola da Família, lançado em 2003 pelo governo de Alckmin (PSDB).

O objetivo de ambos era fomentar atividades que provocassem as/os estudantes e toda a comunidade escolar a atentarem para a importância do autocuidado, direcionadas à prevenção das ISTs junto ao público jovem. Os trabalhos realizados eram de ordem prática e de fácil compreensão, seguindo um processo contínuo (São Paulo, 2011).

Outro movimento artístico que buscou tratar a questão da AIDS foi o filme *O Tempo Não Para*, lançado em 11 de junho de 2004. Dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, o filme buscou retratar aspectos da vida de Cazuza, sua arte, seu estilo de vida e os desafios enfrentados após o diagnóstico do HIV, bem como o impacto e a repercussão desse fato, considerando que, à época, ele era um artista célebre no Brasil (Cazuza, 2004).

Uma das possíveis ilustrações cristãs no contexto da AIDS pode ser observada em uma passagem da Bíblia Sagrada (2012), intitulada “O leproso agradecido”. Na passagem, é narrado que Jesus seguia em direção à cidade de Jerusalém, atravessando a Samaria e a Galileia, ambas regiões que fazem parte de

Israel. Ao entrar em uma aldeia, deparou-se com dez homens que vieram ao seu encontro. Esses dez homens pediram a Jesus que se compadecesse deles. A resposta de Jesus foi: “Ide, mostrai-vos ao sacerdote” (Bíblia Sagrada, 2012, p. 1371). Ao saírem, os dez leprosos perceberam que estavam limpos.

A história narrada acima é apresentada como um texto de livro didático no qual muitas/os estudantes, assim como professores, não compreenderam a lição. Em 2005, no Brasil, o jornal O Globo (2005) estampou uma de suas matérias com o título: “Contra Aids – Papa prega castidade e fidelidade”. À época, o líder religioso da Igreja Católica era Bento XVI. Suas palavras eram de condenação ao uso de preservativos.

Na perspectiva do líder, em idade avançada e possivelmente distante da vivência sexual, sustentava-se a ideia romântica de que a forma de prevenção contra o HIV seria a castidade e a santidade, ambas como ideais que nem a própria Igreja consegue, de fato, sustentar.

Em 28 de novembro de 2005, no telejornal Bom Dia São Paulo, foi transmitida uma série intitulada “AIDS”. A repórter Daniela Golfiere conversou com um homem que vivia com HIV. Na entrevista, a pessoa soropositiva contou sua história e relatou que o contato com o vírus ocorreu a partir de uma relação sexual decorrente de uma traição no casamento.

A ideia da pessoa soropositiva era de que isso nunca aconteceria com ela, por se considerar casada e heterossexual. Aos poucos, o moralismo não se sustentava diante de narrativas que sustentavam que a AIDS tinha uma única face - a homossexual (Memória Globo, 2021c).

Em 2005, sob o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), a Coordenação dos Institutos de Pesquisa passou a ser denominada Coordenadoria de Controle de Doenças, ampliando seu trabalho como instância supervisora e de monitoramento das políticas e estratégias voltadas às DST/AIDS, com foco na prevenção, na assistência e na vigilância epidemiológica em todo o território do estado de São Paulo (São Paulo, 1996).

Na 16ª Conferência Internacional sobre AIDS, realizada em Toronto, em 2006, religiosos de diversas denominações, entre as quais católicos e luteranos, reconheceram como um erro associar a AIDS a um castigo divino, no qual Deus estaria punindo determinadas pessoas. Alguns compreenderam que essa associação contribuía para a estigmatização e a marginalização, em um contexto em que já

havam morrido cerca de 25 milhões de pessoas. Nesse momento, religiosos viram-se na necessidade de pedir perdão (O Globo, 2006).

Em 2006, o jornal O Globo publicou a matéria intitulada “Campanha contra a AIDS usará atores soropositivos”. Segundo o jornal, o slogan da campanha, “A vida é mais forte que a AIDS”, foi encabeçado pelo Ministério da Saúde, no governo Lula, com a intenção de diminuir o preconceito em relação à infecção (Weber, 2006).

Na virada para o ano de 2007, o governo Lula (PT) destinou 15,8 milhões ao Ministério da Educação para tratar, nas escolas, as questões relacionadas ao HIV e à AIDS. Segundo o MEC, “a prevenção do vírus da AIDS começa nas escolas” (Brasil, 2007a). De acordo com a diretora do Departamento de Políticas de Educação Infantil e Fundamental, Jeanete Beauchamp, “os currículos das escolas precisam ser mais amplos ao contemplar o desenvolvimento humano, inclusive os assuntos relacionados à saúde” (Brasil, 2007a)

Na percepção da diretora, é papel da escola construir e difundir uma cultura que compreenda o HIV, a AIDS e demais temas como inerentes à vida humana, não ficando restrita ao espaço escolar, mas avançando para além de trabalhos pontuais e/ou isolados de caráter meramente informativo.

Outro movimento realizado no âmbito escolar foi o Programa Saúde na Escola, instituído a partir do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, pelo Governo Federal. Os objetivos do programa visavam impulsionar a cultura da saúde sexual e reprodutiva, entre outras ações, solidificando a importância da prevenção para a vida. Destaca-se a ideia de que tal programa deveria seguir como um movimento permanente, e não passageiro.

No mesmo ano, a revista *Veja* publicou a matéria intitulada “Cartilha do governo Lula estimula alunos de 13 a 19 anos a narrar suas transas”. Segundo a reportagem, o Governo Federal distribuiu uma “agendinha” com informações sobre beijo, sedução, masturbação e saúde. Acrescenta-se, ainda, que nas orientações havia uma lista a ser preenchida sobre quais “ficadas” foram as melhores.

Ainda em 2007, os ministérios da Saúde e da Educação se uniram em um projeto pedagógico com o propósito de levar preservativos às escolas. Segundo o Ministério da Educação (Brasil, 2007b), os preservativos passaram a estar mais próximos dos adolescentes no ambiente escolar (Azevedo, 2007).

Ciampi *et al.* (2009) descrevem que, em 2007, no estado de São Paulo, durante o governo de José Serra (PSDB), foi implantado o programa São Paulo Faz

Escola. O programa, em sua proposta e em seus objetivos, buscou centralizar a educação paulista a partir de um currículo padronizado, visando à contemporaneidade e às questões daquele tempo.

Na leitura de Ciampi e demais autores, observa-se que cada agente constituinte da escola passou a exercer um papel específico: as pessoas gestoras, como motivadoras para que o programa fosse aplicado; as pessoas docentes, seguindo orientações na realização do processo de ensino e aprendizagem; e, por fim, as pessoas discentes, como organizadoras do que foi aprendido no decorrer das aulas. Ressaltam ainda que o projeto visou, entre outras questões, o que denominaram de “bandeirantismo”, significando o desenvolvimento da indústria, da tecnologia e da cultura.

A Folha de S. Paulo, em 27 de junho de 2008, ao comentar a matéria da Veja, que dizia que o Ministério da Saúde colocaria 400 máquinas de camisinha em escolas. Na matéria, outro dado aparece, referente ao ano de 2006, ainda no governo Lula. A partir do Censo Escolar, no qual 174 mil escolas participaram, 100 mil afirmaram tratar com as/os estudantes as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis e à AIDS. Destas, 10 mil declararam distribuir preservativos aos estudantes (Divulgação, 2008).

Como forma de resposta, pastorais, em 2008, refutaram o posicionamento contrário ao uso de preservativos defendido por líderes católicos. Em entrevista a O Globo (2008), a freira Margaret Hosty, responsável pela ONG AVE – Apoio, Vida e Esperança, na cidade de Goiânia, afirmava que não havia contradição entre o catolicismo e o uso de preservativos.

Ao considerar os princípios defendidos pela Igreja, que ressaltam a proteção da vida, sustentava que o papel da pastoral era indicar informação, apoio e também o preservativo, pois, por meio dele, é possível preservar a vida.

Em 2008, foi lançado o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, com o objetivo de alcançar tanto o âmbito federal quanto os estaduais e municipais. O projeto visava promover a saúde sexual e reprodutiva, buscando diminuir as vulnerabilidades que jovens e adolescentes enfrentam em relação às ISTs, ao HIV e à gravidez não planejada. O projeto envolve escolas e unidades de saúde (Brasil, 2008).

Seffner e demais pesquisadores, ao escreverem o texto *Respostas religiosas à AIDS no Brasil: impressões de pesquisa*, em 2008, mencionam que a proposta da Pastoral da AIDS, desenvolvida pela Igreja Católica, foi a de “trazer a boa nova”. Em

meio ao caos provocado pela AIDS, tornou-se necessário um alento, uma narrativa que não reforçasse a morte, mas a vida. A forma encontrada pela Igreja Católica para conduzir esse processo foi por meio do evangelho, ao catequizar as pessoas.

Embora o problema da AIDS, na percepção da Igreja Católica, ainda estivesse associado a comportamentos considerados desviantes, sobretudo os de homossexuais, a instituição parecia, naquele momento, “aceitar”, porém com ressalvas. A estratégia para lidar com isso era não tocar no assunto: não dizer, como sinônimo de não existir.

Utilizavam-se de jargões como “amar o próximo”, sem, contudo, aceitar quem essas pessoas são, colonizando o corpo por meio de uma “ajuda” solidária. Entre as atividades de prevenção e as de assistência, ambas seguiam alinhadas à estrutura biomédica. As ideias contrárias ao uso de preservativos e ao chamado “comportamento homossexual” permaneciam.

Em 2009, os avanços no conhecimento sobre os HIVs tornaram-se mais evidentes. Um estudo publicado pela revista Elsevier, das/os pesquisadoras/es Lewthwaite e Wilkins, intitulado “*Natural history of HIV/AIDS*”, descreve os HIVs em subtipos. O HIV 1 é subdividido em grupos distintos, M, O e N, além de subtipos genéticos.

Foi possível identificar que, em cada subtipo, há associações relacionadas à transmissão geográfica, às taxas de progressão e aos padrões de resistência. Diferente ocorre com o HIV 2, que apresenta maior resistência aos medicamentos contra o vírus, além de cargas virais menores nas pessoas soropositivas, colaborando para que o CD4¹⁸ diminua mais lentamente, o que, conseqüentemente, retarda a evolução para a AIDS, assim como reduz os casos de transmissão de mãe para filhas/os.

No ano de 2009, o jornal Correio Braziliense (2009), realizou uma reportagem sobre pessoas soropositivas discriminadas. Segundo a matéria, um garoto de 10 anos, da região de Pernambuco, não queria mais estudar. Em conversa com o menino, foi apurado que o abandono da escola tinha como motivo vivências de rejeição no ambiente escolar.

¹⁸ “É um receptor presente, principalmente, nos linfócitos T-auxiliares (denominados por isso de Linfócitos-T CD4+) onde o HIV se liga para iniciar a infecção dessas células. Outras moléculas presentes na membrana dos linfócitos-T desempenham um papel auxiliar, mas relevante, nesse processo de ligação HIV/Linfócito-T, e são denominadas co-receptores” (Ministério da saúde, 2004, p. 29).

O preconceito iniciou-se a partir do momento em que sua mãe comunicou à direção da escola sobre o estado sorológico do estudante. Diversas foram as situações de discriminação, desde a criação de estratégias por parte de professores com a intenção de fazer com que o estudante voltasse para casa sem participar das aulas. Além da questão da sorologia, o estudante apresentava problemas de locomoção, o que dificultava suas idas ao banheiro, e, segundo o relato, a professora responsável se recusava a acompanhá-lo. Toda essa situação fez com que o estudante desenvolvesse depressão.

Em 2009, foi lançado, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Manual da Aprendizagem: o que é preciso saber para contratar o aprendiz? A partir do manual, é proposto uma formação técnico-profissionalizante de jovens e adolescentes, com a intenção de que possam ingressar no mundo do trabalho.

As instituições responsáveis por subsidiar tal formação precisavam também considerar a educação para a saúde sexual e reprodutiva, sobretudo no que tange aos direitos sexuais e às questões de gênero a eles relacionadas (Brasil, 2009).

A percepção sobre o HIV e, em consequência, sobre as pessoas soropositivas foi ocupando todos os espaços da sociedade, inclusive em um *reality show* muito conhecido no Brasil e no mundo, o Big Brother Brasil. Em 2010, a declaração de um dos participantes, durante a décima temporada, polemizou o programa. O participante Marcelo Pereira Dourado, em uma de suas falas com os demais participantes, afirmou que pessoas heterossexuais não contraíam AIDS, pautando-se em uma fala anterior que teria tido com um médico.

Dourado defendia a ideia de que um homem transmitia o HIV a outro homem, e que o contrário não ocorreria. Ao término do programa, Dourado saiu como vencedor, com o prêmio de 1,5 milhão de reais (G1, 2010).

Em meio às diversas tentativas que as instituições vinham buscando para responder aos problemas do HIV e da AIDS, em 2010, no estado de São Paulo, sob o governo de Geraldo Alckmin, foi criada uma cartilha que orientava sobre como comunicar o diagnóstico de HIV a crianças. A cartilha foi confeccionada pelo Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS de São Paulo.

A intenção ao criar o material foi colaborar com as/os profissionais de saúde no processo de notificação da sorologia às crianças. O material propunha-se a utilizar uma abordagem lúdica, como uma brincadeira em que, “brincando, você acaba dando o diagnóstico” (Xavier, 2010).

3.8 Década de 2010 ao início de 2024

No ano de 2010, o Brasil divulgava informações sobre o cenário da AIDS no país. Na redação do folder, reconhecia-se que a epidemia vinha se estabilizando. Isso decorria dos diagnósticos precoces que passaram a ser realizados. Segundo os dados, o número de pessoas com AIDS, desde o início da epidemia, em 1980, até a virada da década de 2010, somava 592.914 casos (Brasil, 2010).

Na leitura por categorias de exposição e por idade, considerando pessoas maiores de 13 anos, os dados se distribuíam da seguinte forma: homens homossexuais: 20,1%; bissexual: 11,5%; heterossexual: 30,5%; usuários de drogas injetáveis: 17,2%. Mulheres heterossexuais: 87,5%; usuárias de drogas injetáveis: 7,3%.

Ainda assim, estimava-se que, no país, havia cerca de 630 mil pessoas vivendo com HIV. Destas, havia a suspeita de que 255 mil não sabiam de seu estado sorológico, sendo uma das razões a falta de realização de testes que possibilitassem o diagnóstico e o início do tratamento.

O Globo (2011) do Distrito Federal, publicou uma notícia de que uma médica utilizou agulhas que, segundo ela, continham HIV para colocá-las no muro de sua residência, com a intenção de evitar assaltos. A percepção da médica era a de “colocar medo” em possíveis assaltantes que pudessem invadir sua casa.

Ainda no mesmo ano, em 2011, sob o governo da presidenta Dilma Rousseff (PT), foi suspensa a distribuição de materiais que continham vídeos educativos sobre diversidade sexual e combate à homofobia. A decisão veio após a insatisfação da presidenta, pois, segundo as notícias da época, a retirada se deu em razão de um clima de insegurança. A resposta adotada foi solicitar a ampliação da consulta para toda a sociedade, sobretudo aos grupos cristãos que contestaram o material, assim como à bancada evangélica de deputadas/os.

A produção do material havia sido realizada por pessoas LGBTQTs, que consideraram não haver recursos suficientes para subsidiar professoras/es no tratamento do tema no contexto escolar (BBC News Brasil, 2011).

Passados 18 anos, em 30 de novembro de 2011, em uma retrospectiva realizada pela Rede Globo, o repórter Hélio Costa relembra que, nos anos de 1983, o Brasil não acreditava que a infecção pelo HIV realmente existiria. Não havia interesse em tratar a questão, sobretudo em transmitir uma reportagem como a que ele havia

gravado. O interesse surgiu em 4 de junho de 1983, após dois anos, com a morte do estilista Markito, muito conhecido entre artistas e celebridades. E, como se não fosse suficiente, o número de pessoas com AIDS aumentava a cada semana (Memória Globo, 2021a).

Outras ações tiveram como propósito, no campo da educação, promover meios que conscientizassem a população sobre as questões do HIV e da AIDS, aproveitando o Dia Mundial contra a AIDS. Em 2012, ainda sob o governo de Alckmin (PSDB) no estado de São Paulo, foi colocado um grande laço vermelho, símbolo da campanha contra a AIDS, na fachada da Secretaria da Educação, localizada na Praça da República, com a intenção de chamar a atenção das pessoas que por ali passassem.

Junto ao laço, foram inseridos painéis com mensagens que, em conjunto, formaram um mural nas grades que cercam o edifício. No mesmo ano, também foram realizadas palestras pelo Programa Escola da Família, abordando as questões relacionadas à AIDS em referência ao Dia Mundial, dirigidas a toda a comunidade escolar (São Paulo, 2012).

Ainda no ano de 2012, na gestão do secretário da Educação do Estado de São Paulo, Herman Voorwald, foram propostas sugestões de atividades preventivas para a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e para a sala de aula. O objetivo do material era dar base às escolas para promoverem o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção.

Foi produzido um kit contendo sugestões sobre como realizar atividades nos mais diferentes temas, possibilitando uma melhor convivência escolar. Entre os diversos temas, há um tópico que trata de “adolescências e sexualidades, gêneros e preconceitos, prevenção às DSTs, HIV e AIDS” (São Paulo, 2012).

Em 2013, o grupo da Turma ganha dois novos personagens: Igor e Vitória. Ambos são crianças que vivem com HIV, esbanjando saúde, descaracterizando a imagem que vinha sendo construída pela epidemia, de pessoas apenas doentes. A publicação dos quadrinhos tinha o propósito de promover formação e desconstruir desinformações, mostrando o que a infecção era e o que não era. Sobretudo, evidenciava o viver soropositivo de crianças que conviviam com o reflexo do preconceito herdado do passado e com a percepção equivocada construída sobre o que não é a AIDS (G1, 2012).

O ano de 2015 é considerado como a “retomada” da frente conservadora na legislatura do país, desde a ditadura. Anos antes, em 2001, havia sido desarquivada e, em 2015, voltou a tramitar, de forma mais acentuada para aprovação, a lei que criminalizava a transmissão do HIV. Essa iniciativa só foi contida pela mobilização dos movimentos sociais (Siqueira, 2015).

Em 31 de agosto de 2016, o Brasil iniciou o processo de golpe, ao destituir a presidenta Dilma Rousseff (PT). No contexto da educação, tornou-se evidente o perfil ideológico conservador. Isso se deu em razão do modelo de educação básica que, aos poucos, foi sendo implementado, baseado em competências e habilidades voltadas às necessidades mercadológicas e conservadoras, imprimindo na escola um perfil ideológico específico (Fernandes; Almeida, 2022).

Em São Paulo, no ano de 2016, durante o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), a Diretoria de Ensino da região Centro-Oeste sediou o 2º Seminário Conscieduca. O seminário foi um evento que objetivou criar um espaço de diálogo acerca da sexualidade entre a população jovem, somando-se a um movimento de prevenção voltado ao mesmo grupo, ao tratar das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce.

O evento contou com a participação de estudantes líderes de grêmios estudantis, com o intuito de que levassem as discussões para as escolas nas quais eram representantes e estudavam.

Com a retirada da presidenta Dilma, seu vice, Michel Temer (PMDB), ocupou o cargo entre os anos de 2016 e 2018. No campo educacional, as mudanças ocorridas passaram a ser percebidas a partir de modelos que se enquadravam no sistema capitalista. Um dos maiores exemplos foi a aceleração da regulamentação e da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Fernandes; Almeida, 2022).

No ano de 2018, em 16 de maio, foi aprovado o Projeto de Lei nº 1095/2017, de autoria de Maria Lúcia Amary (PSDB/SP), que institui uma política voltada à inserção das questões de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV e da AIDS nas escolas do estado de São Paulo. O projeto, em sua redação, busca instituir-se como lei permanente, propondo a abordagem dessas questões de forma socioeducacional, por meio de oficinas, debates e dinâmicas, com a intenção de estimular a reflexão sobre a responsabilidade no início das relações sexuais (São Paulo, 2024).

A união de diversos programas e instituições, como a Secretaria de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Coordenadoria de Controle de Doenças e o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS, junto ao Programa Estadual de DST/AIDS de São Paulo, resultou, em 2018, no governo de Márcio França (PSB), na criação da “Estratégia Juntos na Prevenção”.

Trata-se de um documento que visa orientar profissionais da educação e da saúde para o desenvolvimento de uma educação voltada à sexualidade e à prevenção das ISTs, do HIV, da AIDS e das hepatites virais. Dentre os objetivos do programa, está a mobilização de toda a comunidade escolar em articulação com as unidades de saúde e demais instituições e pessoas interessadas nos temas alinhados à proposta, desenvolvendo atividades aos sábados, por meio do programa Escola da Família.

Em 2019, a artista, e também mulher que vive com HIV por transmissão vertical, Micaela Cyrino, buscava, por meio de pinturas e intervenções artísticas, provocar a sociedade a refletir sobre as questões relacionadas ao HIV. Uma de suas obras é Soropositiva (2019), realizada em serigrafia sobre linho. Outra obra, Era tristeza (2017), é uma pintura em tela que estabelece uma relação entre o corpo negro e o HIV (Projeto Afro, 2020).

No dia 6 de março de 2019, o então presidente Jair Messias Bolsonaro (PSL), em uma de suas aparições nas redes sociais, orientou que pais rasgassem páginas da caderneta de vacinas que, segundo ele, continham ilustrações e informações inadequadas, por tratarem, de forma didática, de assuntos relacionados à educação sexual (Ferreira; Grandelle, 2019).

No dia 12 de setembro de 2020, a cantora e pastora Ana Paula Valadão, em participação no programa Diante do Trono, que ela mesma dirige pela emissora Rede Super, afirmou abertamente que as mortes em decorrência da AIDS seriam uma punição de Deus. Segundo ela, a AIDS seria resultado da consequência de não seguir os padrões deixados por Deus. Na perspectiva apresentada, de que toda ação gera uma reação, a morte seria a consequência de uma ação considerada inapropriada. Tal posicionamento foi utilizado para sustentar sua oposição à união homoafetiva (Putti, 2020).

No auge da pandemia de Covid-19, com elevados números de mortes e a crise em torno das vacinas contra o coronavírus no Brasil, em 2020, o então presidente hoje ex-presidente e inelegível Jair Bolsonaro (PSL) realizava uma série de discursos

negacionistas, de caráter criminoso, que dificultavam a chegada das vacinas e a redução dos casos e das mortes por Covid-19. Em algumas de suas aparições, Bolsonaro afirmava que tomar a vacina contra a Covid possibilitaria contrair o vírus do HIV.

Alinhadas a essas falas, muitas ações foram direcionadas contra políticas relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas. A percepção do ex-presidente era a de que os investimentos destinados às pessoas que vivem com HIV representariam uma despesa para a nação (Diálogos da Fé, 2020).

Em 2022, a Igreja Universal publicou, em seu site Folha Universal, uma matéria intitulada “HIV: Eles receberam um laudo de morte”. No texto, são mencionados Rosimeire de Almeida Braga e Manoel Marcos de Castro, com idades de 47 e 44 anos. Segundo a redação, ambos foram surpreendidos com a notícia após realizarem exames de rotina, quando descobriram estar positivos para o HIV.

De acordo com o site, Rosimeire passou a buscar um milagre nos encontros da igreja e, “com uma ação de fé, recebeu água consagrada nas reuniões para que tomasse, determinando que ali a mudança aconteceria”. Acrescenta-se ainda que o casal fez um voto na Fogueira Santa. Após todo esse empreendimento de fé, afirmaram sentir-se curados. Para comprovar, realizaram novos testes e declararam que “estávamos realmente limpos”.

Embora o site não apresente qualquer laudo, não é possível verificar a veracidade de tal informação, sendo o suposto milagre atribuído exclusivamente à ação divina: “só por Deus” (Teodoro, 2022).

No ano de 2022, no Brasil, foi publicada a pesquisa intitulada “*Tracing the relationship among HIV-1 sub-subtype F1 strains: a phylodynamic perspective*”, realizada por Monteiro-Cunha e demais pesquisadores. O estudo identificou novas variantes do HIV 1, nomeadas como B e C. Ambas têm como hipótese de origem o cruzamento genético do HIV 1 com o HIV 2 em um paciente soropositivo, ocasionando novos padrões virais.

Os achados ocorreram em três regiões diferentes do Brasil: Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A pesquisa reitera que, em meados dos anos de 1970, ocorreu a única entrada do subtipo F1 no Brasil. Contudo, embora o estudo tenha ganhado destaque nos jornais e criado certo pânico midiático em torno de um “novo HIV”, já é sabido que os antirretrovirais atualmente utilizados são eficazes também para esses novos subtipos.

No dia 4 de outubro de 2023, o papa Francisco, em uma de suas aparições nas discussões do 16º Sínodo, pronunciou-se a favor da concessão de bênçãos a homossexuais. Em sua fala, ressaltou que o casamento continuaria sendo apenas para heterossexuais. A declaração sinalizou uma possível abertura da Igreja em relação às pessoas homossexuais, embora o matrimônio permanecesse validado apenas entre um homem e uma mulher heterossexuais cis.

Uma das possíveis explicações para tal posição é a compreensão de que o modelo homem e mulher estaria vinculado ao plano da criação do mundo. Vale ressaltar que carros, animais e objetos também são considerados dignos de bênção (YouTube, 2023).

Ainda no mesmo ano, foi publicado no Diário Oficial o Decreto nº 1.004, sob a atuação da ministra da Saúde do governo Lula (PT), Nísia Trindade Lima. O decreto visava promover incentivos financeiros para o desenvolvimento do Programa Saúde na Escola, direcionados às escolas com maiores índices de vulnerabilidade.

A medida tinha como objetivo, a partir do Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da Educação, desenvolver ações voltadas à formação integral dos estudantes da rede pública básica, com foco na prevenção e na atenção à saúde (Brasil, 2023a).

3.9 Dos achados algumas considerações para o presente

Um dos pontos que Foucault (2019), ao realizar o trabalho arqueológico em História da loucura, evidenciou foi o olhar para a história a partir dos processos que baniam e alienavam as pessoas ditas loucas e que, aqui, substituímos pelas pessoas soropositivas. Nesse olhar de banimento e alienação, alguns pontos nos ajudaram a perceber, como a experiência trágica, a experiência clínica, a ideia crítica ao progresso e à linearidade e, por fim, a função da episteme.

Ao olharmos para os achados que trouxemos, é possível perceber que as pessoas soropositivas foram produzidas sob a associação a uma categoria que, historicamente, já vinha sendo estereotipada - a homossexualidade. A AIDS, nesse sentido, passa a ser um dispositivo que aliena as pessoas soropositivas do núcleo social.

As vivências sexuais, somadas à AIDS, reforçaram o discurso religioso sobre a sexualidade, produzindo exclusões e alienações. A sexualidade, como uma

experiência trágica inerente ao ser humano, com a chegada da AIDS foi utilizada para a criação de novos discursos, reforçando os já existentes, pautados nas proibições e nas anormalidades, dentro dos regimes de verdade que foram sendo construídos com os agravos da AIDS.

Com o aparecimento da AIDS, a experiência da sexualidade é minimizada a um objeto especializado do saber médico. Por meio dela, cria-se a patologização: um discurso hegemônico que circulou nas sociedades, produzindo técnicas e protocolos que vão definindo as condições de quem é considerado doente e os riscos que ele/ela pode causar.

A partir de todo esse empreendimento, são criadas exclusões e estereotipações que dividem o doente soropositivo e o saudável-soronegativo, legitimando a exclusão pelos saberes produzidos e pautando a doença na construção do saudável. Essa relação deixa claro como a sociedade lidou com a AIDS, sendo um exemplo de como as diferenças são tratadas pelas sociedades.

Antes de iniciarmos com os achados sobre a AIDS, trouxe alguns materiais dos séculos XIX e XX sobre a sífilis. Ali foi possível ver que a infecção era uma possibilidade da vida humana e não um problema da sexualidade ou de comportamentos humanos. Uma mulher casada e grávida, que não mantém relações extraconjugais, pode adquirir a infecção. O discurso que circulava era o da moralização das práticas sexuais e dos comportamentos “transgressores”.

Com a chegada da AIDS, não houve um progresso no olhar para a infecção, mas, sim, um silenciamento e uma dominação pelos discursos que a produziam, como os saberes médicos e os discursos religiosos. No decorrer das décadas, com as descobertas e mudanças de olhares sobre a AIDS, é fato que as tecnologias e os avanços científicos colaboraram para que as mortes em decorrência da AIDS diminuíssem, e a vida das pessoas soropositivas passasse a ter melhor qualidade.

Todavia, elas não ficaram isentas de relações de poder, exclusão, normatizações e estigmatizações. Isso porque, durante toda a história da AIDS, os discursos sociais que alienavam, excluía e marginalizavam se mantiveram. Assim, o que se vê como progresso é compreendido a partir de uma ideia positiva, mas que, na verdade, não passa de um conjunto de relações que criam e estabelecem poderes, ajudando a excluir, controlar e estigmatizar.

O saber médico é definido pela episteme que ele próprio produz e utiliza, dentro do âmbito do que compreende como verdadeiro e falso, alicerçado no discurso

racional. No decorrer da história, o nome e a percepção sobre a AIDS foram alterados. O saber médico foi responsável pelas várias nomeações da AIDS. A AIDS foi um acontecimento constituído a partir da episteme médica. Em cada década, essa episteme foi alterando sua visão em relação à infecção e, concomitantemente, à própria AIDS. O saber médico atuou para produzir categorias nos diferentes tempos da história e, ainda nos dias atuais, não se limita a modificá-las.

Os discursos que a medicina produz, assim como outros discursos sociais e políticos relacionados à AIDS, não apenas descrevem a infecção e a doença. São produtivos, pois criam realidades e identidades e estabelecem o que pode e o que não pode ser dito sobre a AIDS. Eles definiram o que era risco e o que era considerado normal. Criaram divisões e, por meio delas, exclusões. Ao nomear a AIDS como uma doença homossexual, isso não parte de uma visão neutra, como a ciência positiva que a alicerça.

Inicialmente, a AIDS foi construída a partir dos discursos que circulavam em seu entorno. Pela sua não neutralidade, ela produziu não apenas a doença, mas também o estereótipo e a estigmatização. Nessa lógica, a episteme médica, a partir da AIDS, controlou o corpo e os usos possíveis que ele poderia fazer, nomeando diversas práticas sexuais como perigosas, de risco e anormais.

Embora, com o passar dos anos, a episteme médica tenha alterado sua visão sobre a AIDS não se restringindo mais aos homossexuais e, posteriormente, aos outros “4 Hs”, o discurso se modifica e, com ele, as estratégias de poder e os protocolos médicos, alcançando outros níveis sociais. Isso mostra que o saber produzido está na condição de contingência. A emergência de novos acontecimentos produzirá, em novos tempos e contextos históricos, diferentes regimes e estratégias de verdade.

Na escola e na educação, toda essa conjuntura se mantém. A educação, a partir das políticas, das instituições acadêmicas, privadas, médicas, religiosas, entre tantas outras, constitui redes que produzem saberes que chegam à escola. Ao chegar à escola, esses saberes são reproduzidos, estando também no campo do possível produzir outros saberes que possam contestá-los.

A escola é um local importante para a formação discursiva sobre o corpo e a sexualidade. Se ela reproduz saberes, e se esses saberes estão na linha de formar, é possível que sejam produzidas ideias sobre o corpo, a sexualidade e a saúde, considerando o binômio normal e anormal, correto e errado, entre tantos outros. No

cotidiano escolar, esses saberes reproduzidos repercutem em relações de preconceito, estigma e exclusões, bem como na necessidade de se propor meios de inclusão ou até mesmo de se constituir a própria escola como espaço para ensinar a incluir.

Essas relações nos mostram que os saberes que circulam na escola não são neutros. Os saberes são como redes que se sustentam no poder. As relações na escola estão constantemente atravessadas por forças. Se a escola tenta omitir, dizendo que não há AIDS, chega um estudante soropositivo e prova que ela existe. Se a escola repudia e o exclui, surgem manifestações sociais invocando o direito que legitima um corpo estudantil soropositivo a ocupar a escola. Se, no cotidiano escolar, o corpo soropositivo estiver atravessado por outras relações de força entre seus pares, esse corpo luta, seja para se reafirmar nesse espaço, seja para resistir fora dele.

O percurso que realizamos pelas décadas nos mostra que os discursos produzidos sobre a AIDS também produziram divisões. Entre soropositivos e soronegativos, o que se gera são estigmas e preconceitos. Na escola, essas divisões podem ser analisadas a partir de um exame histórico, possibilitando que a instituição promova situações que dissolvam o preconceito por meio da reflexão sobre as diferenças, olhando para a história como uma máquina que não segue uma linha de progresso. Ao contrário, trata-se de ver e reconhecer como os discursos e as práticas são resultados históricos e culturais daquilo que se diz e se reconhece sobre a AIDS e as pessoas soropositivas.

Considerar que a episteme é a materialização dos saberes que, historicamente, vêm produzindo a percepção do que é a sexualidade e sua relação com a saúde implica compreendê-los não como dados naturalizados, mas como contingências. Em cada momento, o discurso sobre determinada doença estará na emergência de seu acontecimento. Isso ocorreu com a AIDS, com a Covid-19, ocorre com a dengue e ocorrerá com outras. Os currículos são espaços oportunos para que essas questões tenham legitimidade para serem discutidas de forma crítica, nas redes interdisciplinares das matérias ensinadas na escola. Cabe à escola o exercício de ampliar e questionar as ideias produzidas sobre saúde e suas relações com a sociedade, a cultura e as políticas.

Implica pensar no papel das/os professoras, gestores e responsáveis que atuam direta e indiretamente na e com a escola. A formação, como um dispositivo,

regula os discursos e os saberes que nem sempre estão alinhados às vivências soropositivas, às sexualidades, ao respeito e às intervenções políticas negacionistas. Essas pessoas, ao se movimentarem na escola, têm a oportunidade de sair do lugar de poder que ocupam para estar no lugar da/o estudante: aquele/a que sofre as forças, assim como aquele/a que força e resiste.

Os achados, como já mencionamos, não compõem o todo dos acontecimentos. Partindo desse princípio é que nossas análises e reflexões se pautaram. O processo arqueológico fez emergir o que o currículo, os materiais didáticos e os documentos educacionais estaduais têm proposto enquanto dispositivos que produzem e reproduzem saberes e, nesse contexto, o que é falado sobre o tema do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. O próximo passo é olhar de frente para esses espaços e documentos.

3.10 Artefatos do contexto educacional para o tempo presente

Até aqui, buscamos descrever o contexto que antecedeu a chegada da AIDS e algumas considerações que alcançam os dias atuais. Ao desenterrarmos alguns fragmentos sepultados na história, e outros ainda vivos e presentes nos dias atuais, interessa-nos olhar para o contexto educacional contemporâneo e verificar se há vestígios do que foi repercutido em meio ao campo de forças entre o dito e o não dito sobre o tema do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas.

Se, por um lado, escavamos buscando compreender o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas no percurso em que foram sendo construídas e na forma como foram e continuam sendo gerenciadas, por outro, interessa-nos observar como essas mesmas questões aparecem na epiderme escolar, ou seja, nas estruturas e nos sistemas que fazem funcionar a escola, os currículos e os materiais utilizados para e com os/as estudantes do Ensino Médio, no recorte do Estado de São Paulo.

Para empreendermos a conclusão deste primeiro estudo, seguimos as pistas arqueológicas de Foucault (2019), realizando um deslocamento de arquivo e retornando a documentos-base da educação utilizados nos dias atuais. Nesse sentido, utilizamos uma pesquisa de cunho exploratório, a partir de uma abordagem qualitativa, que nos permite uma análise aprofundada dos materiais estudados (Gil, 2019).

A abordagem documental (Marconi; Lakatos, 2021) foi fundamental para a produção e a análise dos dados, por meio da seleção de documentos oficiais públicos e estatísticos, classificados como fontes primárias e contemporâneas.

Foram analisados os principais referenciais da Educação Básica no Brasil: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 2017), os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000a), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Brasil, 2013) e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018). No âmbito estadual, consideramos o Currículo Paulista (São Paulo, 2020) e os materiais didáticos utilizados no Ensino Médio paulista no ano letivo de 2024.

A seleção seguiu critérios específicos: (1) documentos legais e de domínio público; (2) normativas que fundamentam as bases da educação nacional e estadual; e (3) materiais efetivamente utilizados em sala de aula em 2024. A relevância desses materiais justifica-se por sua presença no cotidiano escolar, abrangendo diversas áreas do conhecimento. O acesso aos materiais didáticos foi realizado por meio da plataforma Centro de Mídias SP, que disponibiliza um repositório digital acessível mediante login de servidores da rede estadual.

A seleção foi pautada por três critérios: (1) Ensino Médio; (2) uso cotidiano nas aulas; e (3) atualização, com foco no ano letivo de 2024, considerando que o material completo de 2025 ainda não está disponível. A busca ocorreu de forma segmentada, utilizando os filtros: ano letivo, etapa (Ensino Médio), série (1º, 2º e 3º anos), bimestre (quatro bimestres) e componente curricular. Esse procedimento permitiu um levantamento detalhado e sistemático dos conteúdos.

Feitos os passos descritos acima, foi elaborada a definição de palavras-chave. As palavras-chave orientadoras para as buscas foram definidas com base em critérios técnico-científicos: (1) estágio docente em uma disciplina nomeada “Doenças Infectocontagiosas” (Medicina, 2022); (2) referência ao Dicionário Brasileiro de Saúde (Murta, 2017); e (3) terminologias adotadas por instituições reconhecidas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS, S/A), o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (Brasil, 2004).

As palavras-chave selecionadas foram: HIV, AIDS, VIH, SIDA, pessoas soropositivas, IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis). A inclusão de DST considerou a vigência do termo em documentos anteriores à mudança terminológica. Optamos por excluir termos mais

amplos, como “saúde”, para evitar abordagens excessivamente biologizante, priorizando a dimensão social e educativa do tema.

Os documentos e materiais analisados estavam em formato digital PDF (*Portable Document Format*). Para a busca, utilizamos o software Adobe Acrobat, que permite localizar termos específicos em todo o corpo do texto, mediante a tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR — *Optical Character Recognition*) (Adobe, 2017).

A análise dos dados foi de natureza qualitativa e documental, orientada por eixos analíticos definidos a partir do referencial foucaultiano e das contribuições das instituições de saúde. Os eixos incluíram: (1) presença ou ausência de referências ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas; (2) formas de abordagem sobre prevenção e tratamento; (3) representação das pessoas soropositivas; e (4) reflexões sobre estigma e discriminação.

O intuito foi seguir com o objetivo de analisar documentos, diretrizes e produções enquadradas como científicas e não científicas, que embasam as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no Ensino Médio, sobretudo no Estado de São Paulo. Assim, a leitura foi interpretativa, buscando identificar tanto conteúdos explícitos quanto implícitos, visando compreender como os documentos e os materiais didáticos podem contribuir para a formação de saberes e práticas relacionadas ao tema no contexto educacional paulista.

3.11 Considerações sobre os materiais que compõem a produção dos dados

Neste trecho, propomos apresentar algumas considerações sobre cada documento que fundamenta a produção dos dados deste momento da pesquisa. Ao lado dessas considerações, trouxemos as leituras de pesquisadores que, ao estudarem a área curricular, nos ajudam a ler os documentos e os materiais utilizados, preparando-nos para o terreno de discussão que realizaremos nas próximas páginas.

Essa abordagem oferece aos leitores que não atuam diretamente na área da educação a oportunidade de conhecer as bases que estruturam o sistema educacional. Além de facilitar a compreensão, essa contextualização contribui para as reflexões e provocações que este momento da pesquisa pretende suscitar, ao analisar os documentos, diretrizes e produções que embasam as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no Ensino Médio, sobretudo no Estado de São Paulo.

Ao mobilizarmos os documentos mencionados acima, não estamos considerando-os apenas como documentos técnicos e prescritivos. Por meio de Foucault (2014a), os documentos são percebidos como práticas discursivas nas quais estão presentes a produção de regimes de verdade que se fazem presentes no terreiro educacional. Deste modo, as políticas curriculares são tomadas como dispositivos de saber e poder que se relacionam de tal modo que autorizam a escola a tratar, delimitando quais saberes podem ser ditos e quais não, e quais conhecimentos são reconhecidos como legítimos para estarem na escola.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 2017), por meio de seus 92 artigos, regulamenta e define o sistema educacional brasileiro. Ela estabelece a organização da escola em níveis e etapas de ensino, detalhando os direitos e deveres de estudantes e docentes. Em consonância com a Constituição Federal (1988), que garante a educação como direito universal e responsabilidade do Estado, a LDBEN reforça o compromisso de tornar os espaços educacionais desde creches até universidades, ambientes de respeito à diversidade, segurança e inclusão.

Na leitura de Saviani (2008b), a Brasil (1996) cumpriu o papel de sistematizar e organizar a educação no Brasil a partir do que a Constituição Federal (1988) já havia sinalizado em sua construção e posterior promulgação. Essa sistematização ganha vida ao criar objetivos e meios comuns estabelecidos para os entes federativos, direcionando as instituições educacionais. Essa relação entre a instância federal, as estaduais e as municipais fez com que a lei se tornasse o mecanismo que possibilitou a criação de uma educação a partir de uma base comum, tanto para as instituições que já existiam quanto para as que passariam a existir.

A leitura de Saviani (2008b) se articula à de Macedo (2014) ao lembrar que a proposta de uma base comum a ser utilizada nacionalmente era um projeto que vinha de anos anteriores. Sendo assim, a LDBEN (Brasil, 1996) foi a consolidação de um projeto histórico que, desde 1980, vinha sinalizando sua concretização. Todavia, no decorrer dos anos, a forma como a LDBEN foi lida em sua proposição inicial também foi sendo alterada pela disputa entre diversos discursos políticos e institucionais.

Em seu início, ao criar princípios com o intuito de dar direção ao funcionamento da educação, a lei assumia um caráter estruturante. Com o passar dos anos, porém, ela se coloca em disputa nos discursos políticos e institucionais, entre o público e o privado, e segue nos contextos de avaliação, pautando a lógica tecnicista e privatizante. Ou seja, de seu projeto inicial, pensado como uma lei “fixa”, passa a se

configurar como uma base sobre a qual outros discursos e propostas políticas se apropriam, modificando seu sentido, e não de forma positiva.

A LDBEN ao se caracterizar como um documento “fixo” em que direciona os princípios educacionais, ao lermos pelo viés foucaultiano, é possível considerá-la como um campo de disputas, em que diferentes racionalidades políticas e educacionais se gladiam. A acirrada disputa dos entes educacionais e políticos estão em vista o como a educação se organiza e também e talvez este seja o ponto mais alto da disputa, que é os saberes que produzirão as/os estudantes e as formas que estes saberes serão balizados para o governo interno da escola.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2000a) têm como objetivo orientar a reformulação curricular, considerando as demandas do mundo contemporâneo, especialmente na formação para a cidadania, a vida adulta e o mercado de trabalho, marcado pelas tecnologias. Propõem novas abordagens de ensino e aprendizagem que valorizam o contexto de cada estudante e atribuem significado ao conhecimento escolar, entendendo-o como interdisciplinar e integrado. O foco está em promover o raciocínio, o pensamento crítico e a capacidade de aprender. A formação deve incentivar o desenvolvimento da pesquisa, da análise e da criação de novos conhecimentos, contrapondo-se ao modelo tradicional baseado na memorização.

A organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) por áreas — Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Brasil, 2000b); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Brasil, 2000c); e Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias (Brasil, 2000d), tem como objetivo agrupar os conhecimentos de forma a possibilitar diferentes abordagens aos objetos de estudo. A interdisciplinaridade na prática escolar reforça que a resolução de problemas com base científica está presente em diversos componentes curriculares. Cada área desenvolve conceitos que auxiliam na compreensão da sociedade e da cultura, proporcionando condições para interpretar o mundo em transformação, especialmente no contexto da sociedade tecnológica (Brasil, 2000a).

Na leitura dos PCNs, Macedo (1999) os vê como uma proposta nova, porém com pouca efetivação na prática, por permanecerem ancorados em uma matriz de estrutura tradicional. Dentre as análises que Macedo empreende, é possível afirmar que os PCNs são a prova de que as disciplinas que vinham sendo utilizadas não estavam respondendo às demandas de novas realidades. Ainda assim, ao instituir

“temas” transversais, seguem disciplinando o conhecimento. Isso porque, embora apareçam “temas” para não dizer disciplinas como saúde e orientação sexual, no intuito de propor uma integração que reflita a realidade, esses temas surgem de forma marginalizada, sendo abordados de maneira periférica.

Aqui está o trecho revisado, com ajustes mínimos de concordância, regência, pontuação e fluidez, respeitando integralmente sua autoria, estilo, densidade teórica e escolhas de vocabulário como “regimes de verdade”, “mecanismo de controle”, “transversalidade” e “saberes à margem”.

Outra leitura possível sobre a transversalidade do currículo é de que se trata de uma estratégia. O fato de alguns conhecimentos estarem à margem diz respeito ao entendimento de que as formulações curriculares consideram como importantes aqueles que devem estar no centro e aqueles com menor importância, à margem. Uma certa hierarquização lança o currículo no campo da ordem, em que alguns saberes aparecem enquanto outros estão longe de serem vistos.

A transversalidade, nessa perspectiva, aparentemente pode sinalizar uma possibilidade de abertura para o aparecimento, ainda que tímido, de alguns temas. Não obstante, ela também nos possibilita ver um mecanismo de controle em que se regula a intensidade e as fronteiras do que pode estar na escola, como objetos problematizadores a serem falados e estudados, à exemplo, de se tratar sobre pessoas soropositivas para além dos regimes de verdade produzidos.

A estrutura que compõe os PCNs segue a lógica universalista do conhecimento. Isso porque, ao dialogar com as disciplinas, acaba por deslegitimar a discussão, ao não colocar as questões das diferenças, presentes nos temas transversais, em um lugar privilegiado na hierarquia dos conhecimentos. Logo, os temas transversais passam a ser vistos como menos necessários. Essa relação de poder justifica-se dentro do discurso de qualidade. Na escola, pela lógica formativa, trata-se mais de uma operação matemática que segue o discurso aplicável ao mundo do trabalho do que, também, de números estatísticos que mostrem como as/os próprias/os estudantes são vulneráveis à AIDS, sendo igualmente aplicáveis à vida. Talvez aqui esteja o sentido — vida versus trabalho. A formação para o mundo do trabalho desligada da realidade (Macedo, 1999).

Não obstante, Moreira (2017), dentre as várias leituras sobre os PCNs, considera que eles não foram uma ideia inédita, pois vinham sendo implementados em outros países, como a Espanha e os Estados Unidos, a partir da cultura neoliberal

que atravessava a educação. Dentre os vários problemas observados, destaca-se o modelo das propostas, que não se adequa aos diferentes contextos em que os estudantes vivem. Nesse sentido, homogeneízam-se a cultura, o conhecimento e os valores, considerando apenas uma parte daquilo que, dentro da perspectiva em que foi elaborado, entende-se como necessário e útil. Embora o discurso seja de inclusão, o caminho que os PCNs propõem é acentuar as desigualdades sociais, em vista da ideia de base comum que neles está explicitamente estampada.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Brasil, 2013) têm como objetivo estabelecer um conjunto de definições e procedimentos para orientar as instituições escolares e os sistemas de ensino da Educação Básica. Embora sejam de caráter obrigatório, as diretrizes enfatizam a autonomia das escolas, oferecendo orientações consideradas fundamentais para a organização curricular. A concepção de educação presente nas DCNs valoriza a promoção da reflexão crítica em diversas formas de atuação, destacando a importância da qualidade, da diversidade e da equidade, sempre amparada pelas legislações que sustentam a educação brasileira.

Na leitura do que as DCNs se propõem, Moreira (2017) nos ajuda a vê-las como uma proposta estratégica na busca de superar os baixos padrões educacionais, disfarçada sob a bandeira da integralidade da formação humana. A resposta ao fracasso político-educacional é orientada ao que e a como se aprende, tendo em vista os resultados que se esperam alcançar. Esses resultados são indicadores e objetivos previamente definidos, que também passam a determinar o que será ensinado. De forma geral, o que se vê é mais uma estratégia materializada por políticas que utilizam a educação como instrumento de controle.

Em Foucault (2022a), as DCNs podem ser lidas como uma forma de governamentalidade. Embora as políticas educacionais rarefazem suas propostas, de forma a estetizá-las, elas não deixam de se colocar como uma maneira de operar na condução do modo de agir dos/as estudantes. O governo tende a se direcionar para responder ao que o sistema e a cultura vigentes esperam. Assim, é definido, por meio de diretrizes, práticas e metas, o como ensinar e aprender. Na era tecnológica, a governamentalidade se atualiza por meio da plataformização, das tecnologias e tantos outros dispositivos que operarão em vista de fazer com que o sistema se mantenha vivo a partir dos possíveis corpos dóceis que serão produzidos.

Não obstante as leituras feitas por Moreira (2017), Macedo (2012) aprofunda a análise ao ler as DCNs como um projeto que controla as diferenças. Isso ocorre quando as DCNs centralizam o conhecimento e reduzem a educação apenas ao ensino. Ambas, ao se movimentarem nesses discursos, quando colocadas sob suspeita, revelam o controle exercido sobre a diferença. As DCNs estão marcadas por linguagens de conhecimento pautadas no racional e, sob essa lógica, definem os saberes que serão transmitidos e que produzirão as/os sujeitos/as que fazem parte do sistema.

Nessa linguagem, a diferença não aparece, por não corresponder à inteligibilidade que a racionalidade produz. O sujeito é o produto das investidas de controle que abafam qualquer diferença que possa surgir das relações culturais e das experiências cotidianas. O que as DCNs propõem, em linhas gerais, é uma defesa alinhada a outros discursos políticos que se dizem preocupados com a igualdade socioeconômica, ao passo que limitam a educação ao ensino e reconhecem seus estudantes a partir de uma perspectiva homogeneizada.

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes da Educação Básica devem desenvolver ao longo das etapas escolares. Fundamentada nos documentos legais anteriores, a BNCC orienta a formulação dos currículos municipais e estaduais, estabelecendo competências, habilidades e conteúdos que garantem uma formação integral. Destaca-se seu papel político ao promover uma educação pautada na ética e na estética, visando formar cidadãos capazes de contribuir para uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Nas palavras de Macedo (2014), a BNCC representa mais um projeto arquitetado com vistas a dar continuidade às regulações que produzem uma educação homogeneizadora. Ela nasce como fruto de uma crise planejada, apresentada como forma de resolução para os problemas diagnosticados por perspectivas políticas ligadas a instituições de mercado, justificadas por pesquisas e estatísticas que descrevem e identificam o fracasso da educação.

O que se propõe como resposta é o discurso da qualidade. A qualidade assume como sentido os valores que devem estar impregnados nos saberes e, por meio deles, impõe-se como formas legítimas e únicas de pensar. Afirmam-se os iguais, excluem-se e marginalizam-se as diferenças, por não caberem no discurso normalizador.

Nessa direção, a BNCC pode ser percebida como mais um dispositivo produzido em vista de normalizar, feito por meio de competências e habilidades universais. A universalização opera como uma matriz de inteligibilidade que orienta, a partir de pretensões previamente calculadas, o que deve ser aprendido, como deve ser ensinado, resultando na missão da escola de produzir estudantes hábeis e competentes para servirem ao sistema ao qual a escola está em disputa.

Em outro momento, Macedo (2015) questiona: “direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem?”, no contexto da BNCC. Em sua leitura, a BNCC não está voltada às metas do Plano Nacional de Educação, mas, sim, a estratégias que visam alcançar metas em maiores proporções, reforçando a escola como um espaço de universalização. Uma das características da educação é a pluralidade dos contextos em que ela se insere. Logo, devem-se considerar estratégias flexíveis, passíveis de serem movimentadas a depender do contexto em que a educação se insere.

As estratégias não podem ser materializadas por metas, que dizem mais respeito aos discursos políticos e de quem governa, defendendo uma educação marcada pelo moralismo e pelo mercado do que pela preocupação com a educação como espaço das diferenças. Quando a visão de estratégias se fixa em metas, o que ocorre é uma perspectiva universalista, que considera todas/os as/os estudantes como iguais. Além de perder o sentido do direito à educação, faz com que a hegemonia engula toda a diferença que existe na escola. Quando se diz uma base comum a todos e educação para todos, o que, na verdade, se afirma é uma educação compulsiva, que universaliza e produz estudantes homogeneizados.

Segundo o Currículo Paulista (São Paulo, 2020), sua proposta educacional visa promover a formação integral dos estudantes do Ensino Médio, desenvolvendo um conjunto de competências e habilidades essenciais para o protagonismo, a autonomia e a tomada de decisões conscientes. Nesse contexto, o Ensino Médio é organizado em duas partes: a Formação Geral Básica, obrigatória para todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas; e os Itinerários Formativos, parte diversificada e flexível, com carga horária mínima de 1.200 horas, que permite escolhas alinhadas aos interesses e aos projetos pessoais dos estudantes. Essa estrutura busca garantir uma educação que combine conhecimentos fundamentais com possibilidades de aprofundamento e personalização do percurso formativo.

Uma das possíveis leituras sobre o Currículo Paulista (2020) é a de Ferreira e Silva(2024), ao descrevê-lo como um Currículo Empresarial. Segundo os autores, o Currículo Paulista recebe essa denominação pela característica de direcionar a formação para o trabalho, dialogando com expectativas do mercado neoliberal. Nota-se que, constantemente, o objetivo que o currículo se propõe é o de produzir empreendedores de si, aspecto claramente descrito em diversos momentos do documento e alinhado aos materiais utilizados em sala de aula.

Alinhado aos propósitos da BNCC, o currículo, ao centrar-se na lógica da educação mercadorizada, limita a educação a um caráter acrítico, diminuindo disciplinas que possibilitam o exercício reflexivo, como a Filosofia, e, em seu lugar, insere itinerários que, direta e indiretamente, tratam de questões voltadas ao mercado. A escola, nos limites em que o Currículo Paulista se institui, faz com que as unidades escolares e toda a comunidade que nelas atua passem a se colocar em uma estrutura empresarial. Nessa lógica, o currículo apaga as diferenças, desconsidera as individualidades e aquilo a elas ligado, em vista de objetivos e metas a serem alcançados na produção de sujeitos ajustáveis, recondicionados e aplicáveis ao mercado, e desligados de si mesmos.

O modo como o Currículo Paulista se figura aproxima-se daquilo que Foucault (2022a) descreve por produção de estudantes governáveis, enfileirados/as pela racionalidade neoliberal. O neoliberalismo, vê como valor a ser ensinado o empreendedorismo de si, como se cada pessoa-estudante fosse proprietária de si, assumindo as responsabilidades de uma sociedade mercadológica em que constantemente se exigem adaptações para que estejam alinhados ao que o mercado espera.

Em outra leitura sobre o Currículo Paulista, Arnaud (2024) o vê como um modelo pautado na lógica de resultados, tanto para professores e gestores quanto para as/os estudantes. Sob essa demanda, é erigida toda uma estrutura que direciona os resultados esperados e, para isso, utilizam-se como meios os materiais (os cadernos do aluno), o tempo estipulado para que estudantes e professores estejam na escola e os resultados das avaliações externas, como o SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo).

Um dos vários efeitos do currículo para a realidade escolar é percebido pelas/os profissionais da rede, ao viverem sob a incerteza. O fornecimento de informações a esses/as profissionais configura-se como uma estratégia utilizada pela

Secretaria de Educação para que não se mobilizem de forma a resistir às investidas injustas do Estado. Fato é que a forma como o currículo e a rede atuam evidencia a inexistência de uma administração pautada na democracia. Cabe ressaltar que o projeto de padronização do currículo se inicia com a criação do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, quando, no contexto da pandemia de Covid-19, as aulas precisaram ocorrer em formato remoto. Nesse momento, os materiais que as/os estudantes recebiam já estavam alinhados às propostas que o currículo almejava, sendo um período propício para sua implementação e solidificação (Arnaud, 2024).

No que tange aos materiais didáticos, estes são amplamente utilizados no cotidiano escolar. Além disso, conforme destacou o Secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, há uma ênfase crescente na utilização de recursos digitais, especialmente slides, para apoiar o trabalho dos professores em sala de aula. Segundo Feder, “o material digital e a Secretaria da Educação ajudam o professor na sala de aula” (São Paulo, 2023, não paginado).

Na leitura de Arnaud (2024), o material didático adotado pelo Estado segue um discurso alinhado ao currículo, caracterizado por ser operacional e aplicacionista dentro da lógica de mercado. Seu uso no cotidiano escolar é direto e prático, com o objetivo de ser aplicado e não refletido, o que explica a corrida para trabalhar todo o conteúdo (quantidade) e a pouca possibilidade de aprofundamento (qualidade). Para a/o professor, cabe apenas aplicar os conteúdos, sendo eximida/o de ampliá-los por meio da contextualização. Isso explica, portanto, por que os materiais já são disponibilizados prontos para uso, como os slides mencionados anteriormente.

A lógica pela qual os materiais didáticos do Estado de São Paulo se apresentam pode ser lida como tecnologias de poder (Foucault, 2025a). A padronização do material didático funcionará limitando as práticas pedagógicas, forçando o que e como devem ser ensinados(os/as) os/as estudantes, em vista de atender aos vários indicadores em que a escola-empresa se tornou. A autonomia do/a docente é perdida pelo cansaço, dado pelo excesso de burocratizações e de alimentação de sistemas e (de)formações que precisam ser cumpridas, sob a chantagem de serem penalizados/as. O sistema, assim, age como uma pista de

corrida em que, para algumas pessoas docentes, o semáforo pedagógico¹⁹ estará verde, amarelo ou vermelho.

3.12 Resultados

Os dados foram organizados em um quadro que apresenta o nome do documento, o ano de sua publicação e os resultados quantitativos das buscas realizadas. Para aprofundar a análise, incluímos também informações sobre o ano de publicação dos documentos e os números de pessoas com AIDS que concluíram o Ensino Médio, tanto no Brasil quanto no Estado de São Paulo, como as duas últimas colunas. Esses dados foram extraídos do sistema de Indicadores e Dados Básicos do HIV/AIDS ([2020?]) nos Municípios Brasileiros, na seção “Dados regionais e nacionais”. O Quadro 1 apresenta os dados produzidos:

Quadro 1 - Documentos versus número de pessoas com AIDS e escolaridade Brasil e São Paulo

Documento	Ano	Resultados da Busca	Pessoas com AIDS (Ensino Médio) – Brasil	Pessoas com AIDS (Ensino Médio) – SP
PCNEM	2000	0	21.164 (1980-2010)	6.852 (1980-2010)
PCN Linguagens	2000	0	–	–
PCN Ciências Humanas	2000	0	–	–
DCNEB	2013	0	5.800	1.528
LDBEN	2017	0	4.780	1.431
BNCC	2018	2	4.620	1.412
Currículo Paulista	2020	0	3.810	1.240

Fonte: O autor.

¹⁹ O funcionamento do Farol Pedagógico se dá da seguinte forma: “Farol Amarelo ou Vermelho (Necessidade de Aprimoramento), caberá à autoridade responsável decidir pela não permanência do avaliado/a (a/o professor) na unidade escolar atual, aulas/classes ou Programas/Projetos” (Castro, 2025). Ver mais em:

<https://www.farolpedagogico.com.br/2025/11/avaliacao-de-desempenho-final%20dos.html>

Conforme apresentado no quadro acima, as buscas encontraram dois resultados, apenas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em três menções às palavras “AIDS” e “DST”. Essas referências estão localizadas no Ensino Fundamental, especificamente no 8º ano, no componente curricular de Ciências. Mais detalhadamente, aparecem na unidade temática “Vida e Evolução”, dentro dos objetos de conhecimento relacionados aos mecanismos reprodutivos e à sexualidade. As palavras estão associadas a duas habilidades específicas da BNCC, que abordam a identificação dos principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST, com ênfase na AIDS, além da discussão de estratégias e métodos de prevenção. As palavras aparecem, então, em duas habilidades:

Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de **Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)**; e “Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas **DST (com ênfase na AIDS)**, e discutir estratégias e métodos de prevenção” (Brasil, 2018, p. 349).

O aparecimento do tema mostra-se de forma restrita à prevenção e ao diagnóstico, ambas vistas apenas por uma perspectiva biologizante, nos parâmetros de uma biopolítica (Foucault, 2015b). A perspectiva do achado evidencia o resultado de regimes de verdade que enquadram o HIV apenas em uma única dimensão biomédica.

A questão que emerge é a de que, ao estar colocado apenas no reduto biologista, silenciam-se outras possibilidades de compreensão e percepção. Trata-se de um agenciamento discursivo que regula o conteúdo e o modo como o HIV pode ser mobilizado e discutido no contexto escolar (Foucault, 2014a).

Outro ponto importante para reflexão é o uso do termo ultrapassado “Doenças Sexualmente Transmissíveis” (DST). Como mencionado anteriormente, em 2016 foi estabelecido um decreto que reconhece que o uso da palavra “doenças”, nesse contexto, pode gerar uma percepção estigmatizante, ao rotular os corpos como “doentes” ou “contaminados”, o que contribui para a perpetuação do desconhecimento e da desinformação. No entanto, abordar essas questões continua sendo fundamental, especialmente para fornecer informações que promovam a prevenção e, no contexto desta pesquisa, para ampliar o acesso ao tratamento das pessoas que vivem com AIDS (Brasil, 2016).

3.13 Materiais didáticos do ensino médio do Estado de São Paulo

Neste momento apresentamos os resultados encontrados em cada ano/período do Ensino Médio.

Quadro 2 - Resultado dos materiais didáticos dos três anos do Ensino Médio

Ano do Ensino Médio	Número de disciplinas analisadas	Total de materiais/slides	Resultados encontrados
1º ano	13 (Artes, Biologia, Educação Financeira, Física, Eletivas, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Projeto de Vida, Química)	724	Nenhum resultado encontrado
2º ano	18 (Artes, Biologia, Biotecnologia, Educação Financeira, Educação Física, Empreendedorismo, Filosofia, Física, Geografia, História, Liderança, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Oratória, Projeto de Vida, Química, Sociologia)	896	Biologia: 32 menções (HIV: 19; AIDS: 13) Biotecnologia: 5 menções (HIV: 4; AIDS: 1)
3º ano	18 (Aceleração, Artes, Biotecnologia, Educação Financeira, Educação Física, Empreendedorismo, Filosofia, Física, Geografia, Geopolítica, História, Liderança, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Oratória, Projeto de Vida, Química Aplicada)	792	Nenhum resultado encontrado

Fonte: O autor.

Conforme os resultados apresentados no Quadro 2, observamos que, no 1º ano do Ensino Médio, após a realização de todo o processo de busca, não foi encontrada nenhuma palavra ou menção relacionada ao tema em questão. Um professor, ao ser consultado para ajudar a compreender melhor o material, afirmou que “literalmente, este é o material que os professores utilizam em sala, assim como os estudantes, tanto para leitura quanto para cópia”.

No entanto, não é possível generalizar que o tema nunca seja abordado; em momentos informais, como durante uma aula ou conversa, o assunto pode ser tratado de forma mais flexível. O fato é que, se houver uma dependência estrita do material didático, a discussão sobre questões relacionadas ao HIV dificilmente ocorrerá nesse contexto.

Nas buscas realizadas nos materiais do 2º ano do Ensino Médio, encontramos menções em dois componentes curriculares: em Biologia, 32 ocorrências — sendo 19 da palavra HIV e 13 da palavra AIDS; e em Biotecnologia, 5 ocorrências — sendo 4 da palavra HIV e 1 da palavra AIDS.

No primeiro bimestre, na disciplina de Biologia, durante a primeira aula do 3º bimestre, houve menção às palavras “HIV” e “AIDS” uma vez cada. A aula, intitulada “Células HeLa: a importância da bioética em biotecnologia”, tem como objetivo desenvolver, junto aos estudantes, a habilidade de analisar e debater situações controversas relacionadas à aplicação dos conhecimentos da área de Ciências da Natureza.

Entre os temas abordados estão tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa e estratégias de controle de pragas, sempre com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, considerando diferentes pontos de vista. Conforme o Currículo Paulista (São Paulo, 2024), a aula visa especificamente “analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza com base em argumentos consistentes, legais e éticos”.

O contexto em que as palavras “HIV” e “AIDS” aparecem relaciona-se ao uso das células HeLa, destacadas em uma publicação de 2001 no periódico *Science*. O estudo revelou que tanto o vírus do HIV quanto o vírus Ebola compartilham um mecanismo semelhante de entrada nas células, o que contribui para o desenvolvimento de vacinas (São Paulo, 2024).

A segunda ocorrência deu-se na primeira e na segunda aula de Biologia do 4º bimestre. Na primeira aula, foram mencionadas quatro vezes a palavra HIV e sete vezes a palavra AIDS, sendo duas dessas ocorrências nas referências da aula. A aula tem como título “Saúde e bem-estar dos adolescentes (IST)”.

A habilidade a ser desenvolvida busca “identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar”.

Dois são os objetivos que a aula propõe trabalhar com as/os estudantes: “conhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis (IST)” e “desenvolver ações de prevenção das IST”, com conteúdo voltado às IST (São Paulo, 2024).

O contexto em que as palavras aparecem refere-se ao tratamento da importância da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, mencionando a fala de uma médica sobre a falta do uso de preservativos. Ainda sobre as ISTs, destaca-se o uso desse termo em substituição a DST, trazendo uma série de informações sobre meios de prevenção e formas de transmissão, além de enfatizar a importância de, diante de qualquer sinal que possa indicar alguma IST, buscar atendimento médico em serviços de saúde, entre outras orientações pertinentes sobre o assunto.

O HIV e a AIDS aparecem primeiramente em orientações para a realização de uma pesquisa, a ser posteriormente apresentada em um seminário pelas/os estudantes. Dentre as orientações, a apresentação será em grupo, e cada um ficará incumbido de uma IST, que possivelmente será sorteada, devendo apresentá-la em, no máximo, cinco minutos. Na apresentação, devem constar, no mínimo, as seguintes informações: “agente causador; sintomas; formas de transmissão; se há tratamento ou cura; métodos de prevenção” (São Paulo, 2024).

As demais vezes em que as palavras HIV e AIDS aparecem ocorrem no contexto em que ambas são explicadas de forma técnica. O seminário é organizado para acontecer na aula seguinte; assim, previamente, a/o docente responsável fornece mais informações e disponibiliza os slides como material de apoio, com outras fontes que podem ser acessadas por meio de QR code. Na explicação, há um slide que diferencia AIDS de HIV, utilizando como referência uma reportagem disponibilizada no site do médico Drauzio Varella.

A segunda aula menciona a palavra HIV 14 vezes, das quais três estão nas referências, e a palavra AIDS cinco vezes, sendo duas também nas referências. O título da aula é “Seminários sobre IST”, mantendo a mesma habilidade trabalhada na aula anterior, assim como os objetivos e o conteúdo. No material de exposição para a sala, destaca-se a importância de as/os estudantes conhecerem seus corpos para a identificação das infecções.

Na parte sobre HIV e AIDS, alguns pontos são apresentados: a lei que proíbe a divulgação não autorizada da sorologia de qualquer pessoa e a realização de testes rápidos para identificar a “contaminação”. Ao final, é proposto que a turma crie uma campanha voltada à prevenção das ISTs entre adolescentes e jovens (São Paulo, 2024).

Em outro momento, na disciplina de Biotecnologia, o tema aparece na segunda aula do 3º bimestre, com uma menção à palavra HIV, e na quarta aula, com três menções à palavra HIV, sendo duas nas referências, e uma menção à palavra AIDS.

Na segunda aula, intitulada “Biotecnologia no diagnóstico de doenças — Bacteriose”, propõe-se desenvolver, com os estudantes, a habilidade de selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais.

Os objetivos da aula incluem reconhecer doenças causadas por bactérias, relacionar sintomas, diagnósticos, tratamentos e formas de prevenção das bacterioses, além de identificar a aplicação da biotecnologia nos processos de diagnóstico, tratamento e prevenção dessas doenças. O conteúdo abordado concentra-se nas doenças bacterianas (São Paulo, 2024).

O contexto em que o HIV aparece é na comparação com doenças causadas por novas cepas, que se tornam mais resistentes aos medicamentos comumente utilizados no tratamento. Sendo assim, essas doenças apresentam números mais elevados do que os casos de HIV no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a menção ocorre apenas como referência, sem oferecer maiores ou melhores informações.

Os dados produzidos reforçam a centralidade do discurso científico como único e legítimo. Não obstante, o foco dado ao discurso biomédico exclui as dimensões sociais e subjetivas nas quais o HIV está inserido, fazendo, assim, um recorte da realidade como um conhecimento fragmentado e fragilizado. Os dados reforçam a hierarquização dos saberes, presente no interior do currículo.

Na 4ª aula, com o tema “Doenças e infecções: a importância do diagnóstico para o tratamento de doenças e infecções”, propõe-se desenvolver a habilidade de “investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais”, além de alcançar os objetivos de “reconhecer a aplicação da biotecnologia no desenvolvimento de testes rápidos e diferenciar doenças e infecções”. O tema da aula se propõe a discorrer a partir de “testes rápidos, doenças e infecções” (São Paulo, 2024).

O contexto em que o HIV aparece refere-se aos testes rápidos, sinalizando o Sistema Único de Saúde como o local apto e com disponibilidade para a realização de testes de ISTs, sobretudo o de HIV. Explica-se como o teste pode ser realizado, tanto por via oral, por fluido quanto por coleta sanguínea, podendo ser feito em curto tempo e com garantia de sigilo em todo o processo. As demais menções ocorrem nas referências que fundamentam o texto do slide.

No que tange ao contexto da AIDS, é proposta uma atividade de produção de um comercial, com a finalidade de criar um “marketing” dos testes rápidos, com duração máxima de 1 minuto e 30 segundos, dentre os quais a AIDS deve estar incluída como uma das infecções a serem testadas e divulgadas na propaganda.

Finalmente, no 3º ano do Ensino Médio, não foi encontrada nenhuma palavra ou menção relacionada ao tema em questão. Os dados e resultados que trouxemos não garantem uma generalização como resposta ao que a educação e a escola têm se proposto a realizar frente às questões do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Consideram-se muitas problematizações ao pensarmos nas condições pelas quais as/os professoras/es passam: a exaustiva carga horária de trabalho, se estão habilitadas/os para debater o assunto, se as aulas em slides de fato seguem como é solicitado pelas secretarias e pelo currículo, e se o tempo de 45 minutos para cada aula é suficiente para que alunas e alunos possam falar sobre o tema.

Contudo, podemos questionar se as vezes em que essas questões aparecem são suficientes para garantir alguma aprendizagem. Qual tem sido o posicionamento da educação e do Estado? Tal questionamento se ampara na resposta que obtivemos em 2023, ao entrarmos em contato com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, especificamente com o gabinete do secretário, na intenção de obter autorização para realizar outra pesquisa que tinha como objetivo produzir dados com estudantes do Ensino Médio: “No momento, não estão sendo autorizadas pesquisas na rede, em virtude da priorização de outras demandas da Pasta”.

Com a produção dos dados apresentados acima, consideramos oportuno refletir se a instância federal, por meio do Programa Saúde na Escola, poderia desempenhar alguma intervenção ao propor o diálogo entre saúde e educação.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social, em publicação de 23 de outubro de 2024, a partir do Programa Saúde na Escola (PSE) do Governo Federal, entre os anos de 2023 e 2024, o Estado de São Paulo incluiu 460.759 estudantes no

PSE. Recuperando a proposta do programa, o PSE visa colaborar para o desenvolvimento das/os estudantes das escolas públicas que seguem o percurso escolar na Educação Básica, propondo, por meio de políticas de saúde e educação, meios para que se alcance uma formação integral em saúde e educação (Brasil, 2024b).

Com vistas a conhecer os resultados do PSE no contexto do Estado de São Paulo, consultamos o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), no período de janeiro a setembro de 2025. Para ter acesso aos dados, o sistema dispõe dos seguintes filtros, que trazemos na íntegra conforme apresentados na plataforma:

Tipo de equipe: Eq. de Saúde da Família – ESF; Eq. Agente Comunitário de Saúde – EACS; NASF/e Multi; Eq. da Atenção Básica – EAB; Eq. Consultório na Rua – ECR; Eq. de Saúde Bucal – SB; Eq. AB Prisional – EABp; Eq. de Atenção Primária – eAP.

Categoria profissional: Agente comunitário de saúde; Agente de combate a endemias; Agente de saúde; Assistente social; Cirurgião-dentista; Educador social; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Médico veterinário; Nutricionista; Outros profissionais de nível médio; Outros profissionais de nível superior; Profissional de educação física; Psicólogo; Sanitarista; Técnico e auxiliar de enfermagem; Técnico e auxiliar de saúde bucal; Terapeuta ocupacional; Naturólogo; Musicoterapeuta; Arteterapeuta; Recepcionista; Terapeuta holístico.

Tipo de atividade: Reunião de equipe; Reunião com outras equipes de saúde; Reunião intersetorial / conselho local de saúde / controle; Educação em saúde; Atendimento em grupo; Avaliação/procedimento coletivo; Mobilização social.

Público-alvo: Adolescente; Profissional da educação; Temas para saúde: Saúde sexual e reprodutiva; Semana Saúde na Escola; Turno: Manhã; Tarde; Noite; Programa Saúde na Escola: Educação; Saúde; Nível: Programa Saúde na Escola; Tipo de informação: Quantidade de atividade coletiva / Número de participantes.

A seleção de todos os filtros, elucidados acima teve como finalidade conhecer, em todas as categorias possíveis e disponíveis no sistema, a quantidade de atividades realizadas, bem como o número de pessoas participantes, entre elas estudantes e professores, e em que contexto essas atividades ocorreram, na educação e na saúde. Uma vez realizado o filtro, os resultados aparecem conforme é possível observar no quadro abaixo.

Quadro 3 - Resultados do PSE no contexto do Estado de São Paulo

Programa Saúde na Escola	Quantidade de Atividades	Num. Participantes
Educação	949	47.913
Saúde	2.725	124.737

Fonte: Brasil (2025b).

Segundo o site do sistema, as atividades e ações realizadas foram conduzidas pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS). Nos dados apresentados acima, no filtro “práticas de saúde”, não há itens que tratem dos temas para a saúde, como saúde sexual e reprodutiva, o que sinaliza a inexistência de ações e/ou intervenções nesse campo. O que se observa são atividades relacionadas ao controle do tabaco (quatro sessões), às práticas corporais vinculadas à atividade física, à saúde auditiva e ocular, entre outras.

No painel de monitoramento “Divulga Saúde”, é possível conferir as ações e práticas realizadas a partir do PSE por cada município do Estado. Em busca de informações sobre as ações desenvolvidas na região onde a tese é produzida, encontramos dados referentes ao ano de 2024, os quais apresentamos na tabela abaixo.

Quadro 4 - Atividades realizadas em 2024

Tema	Ação	Nº de Escolas
Aedes aegypti	789	31
Agravos negligenciados	3	1
Alimentação saudável	1467	31
Cidadania direitos humanos	21	3
Dependência química	3	1
Prevenção violência	18	2
Saúde ambiental	48	4
Saúde bucal	7440	35
Saúde mental	66	6
Saúde sexual e reprodutiva	27	2
Antropometria	738	33
Aplicação flúor	700	21
Escovação supervisionada	2224	35
Práticas corporais atividade	288	19
Saúde auditiva	6	3
Saúde ocular	462	24
Verificação vacinação	66	8
Covid	8	1
Total	14374	34

Fonte: Divulga Saúde ([2020?]).

As atividades apresentadas acima não estão detalhadas no sistema, não sendo possível identificar quais ações foram realizadas, quais pessoas estiveram envolvidas e demais questões que poderiam nos fornecer elementos para reflexão. Contudo, o que se pode observar é que o tema saúde sexual e reprodutiva foi pouco trabalhado, aparecendo em apenas duas escolas de um total de 27 unidades escolares.

A falta de ações mostradas pelo programa pode ser lida como efeito de prioridades de determinadas políticas. Ou seja, é definido quais temas devem ter maior trabalho e investimento do que outros, produzindo, assim, silêncios que mostram que políticas públicas estão a serviço de omissões estratégicas.

3.14 Discussão com os dados produzidos desta última parte do estudo

Ao pensarmos a escola, podemos compreendê-la como um universo permeado por relações de poder que se manifestam de diversas formas e em múltiplos contextos. No âmbito do contexto da pesquisa, focamos nos documentos curriculares e nos materiais didáticos, pois eles são considerados formas concretas de poder.

Esses dispositivos têm, entre suas finalidades, prescrever modos de ser e agir, buscando moldar os corpos e as subjetividades dos/as estudantes conforme os contextos sociais, políticos e culturais nos quais estão inseridos. Essa perspectiva está fundamentada nas ideias desenvolvidas por Michel Foucault (2025a), que enfatizam como o poder se exerce por meio de práticas e discursos que regulam e orientam os comportamentos.

No terreno das políticas educacionais, os mecanismos pensados a partir de Foucault (2025a) materializam-se nos documentos curriculares, nas diretrizes e materiais didáticos, como dispositivos que funcionam para o governo tanto dos/as estudantes como dos/as professores, de forma a orientar as práticas pedagógicas. O resultado do governo empreendido será o modo de pensar e agir, implicando nas existências dentro e fora dos muros escolares.

Pensar o corpo implica perceber o poder que atua sobre ele. O biopoder constitui uma das formas de poder que incidem sobre a vida de maneira individual, enquanto a biopolítica atua sobre a vida de forma mais ampla, no nível da população. Um dos pontos possíveis de observação dessa relação é a sexualidade, por estar atravessada tanto pelo corpo individual quanto pelas populações.

Por meio dela, há o contato não apenas com o corpo, mas com a própria espécie humana. Assim, a biopolítica funciona pelas diversas formas desenvolvidas de controle, buscando regular a população. O discurso pode ser lido como uma das formas de controle utilizadas pela biopolítica. A preocupação com tudo o que possa colocar a vida em perigo nascimentos, mortes, saúde e reprodução, constitui um dos eixos centrais da biopolítica (Foucault, 2015b).

A vida humana, mais especificamente o corpo biológico da população, torna-se alvo da administração política, que regula e licencia, dentro de critérios elaborados pelos mecanismos de poder como a medicina, o direito, a escola, entre outras instituições-poder, justificativas que fazem com que a vida da população permaneça sob o domínio da governança, naturalizando relações de controle e repressão. O saber-poder desenvolve conhecimentos e discursos, fiscalizações e resistências, constituindo dispositivos de controle (Foucault, 2015b).

As novas produções do saber constroem um discurso biologizante da sexualidade, assentado em um olhar binário de duas categorias de comportamentos: o normal e o desviante (Weeks, 2023). Ambas se inserem no quadro da racionalização como supostas soluções para os problemas da sociedade, como ocorreu com a epidemia de AIDS e, também, com a Covid-19, apoiadas em discursos neoliberalistas nos quais “faz-se viver alguns e deixa-se morrer outras/os” (Foucault, 2022b).

Vicente (2024), ao analisar os documentos educacionais, afirma que os PCNs representaram um avanço ao serem propostos como uma forma transversal de tratar as questões sobre sexualidade e gênero, e aquilo que pode ser inserido nesse contexto. Ainda que com algumas problemáticas, como a ideia de uma educação que oriente a sexualidade, foi possível perceber a preocupação das políticas de governo, aliadas aos documentos que as antecederam, como a Brasil (2017), ao compreender a educação como elemento importante para a formação humana.

Não obstante, uma das leituras possíveis da BNCC é que, embora em algumas habilidades sejam mencionadas dimensões que sinalizam para a educação sexual, isso ainda ocorre no reduto biológico e sob perspectivas de retrocesso. Destaca-se a importância de estar saudável, conhecer para prevenir, formas de tratamento e testes para diagnosticar doenças e infecções.

Tal abordagem dialoga com o que Foucault (2015b; 2022b; 2025a) discute, ao afirmar que a preocupação da biopolítica é estratégica, na medida em que não olha para questões que extrapolam o biológico. Não se fala sobre viver sendo soropositivo,

nem se reconhecem, de forma inteligível, políticas que aceitem que pessoas não heterossexuais existem, fugindo da realidade de que todas/os nós estamos marcadas/os pela diferença.

Qazi e Javid. (2021), ao produzirem dados a partir de livros didáticos adotados pelo governo do Paquistão, concluem que os materiais utilizados em sala de aula pelas/os estudantes paquistaneses colaboram para formar e reforçar uma identidade feminina marcada por representações estereotipadas do corpo e do papel social das mulheres. Embora as políticas de governo defendam discursivamente a igualdade e a equidade, o que se observa são processos de desigualdade e exclusão das mulheres. Potencializa-se o papel da mulher como doméstica e reprodutora, privilegiando os homens hétero-cis.

No contexto das questões sobre HIV, AIDS e das pessoas que vivem soropositivas, o apagamento do tema em outras instâncias de aprendizagem não biologizantes revela-se como um mecanismo que produz “a vida e todo o espaço de existência” (Foucault, 2015b, p. 155) daqueles/as que são identificados como necessários e importantes para a sociedade.

Jacobi *et al.* (2020) constataram que a educação combinada com a saúde constitui o ponto inicial para que o estigma sobre o HIV, a AIDS e as pessoas que vivem soropositivas seja reduzido. No Ensino Médio, sobretudo, por se tratar de um período de escolarização em que jovens e adolescentes podem ser influenciados e produzir conhecimentos capazes de modificar comportamentos de forma positiva.

Muza e Naidoo (2023), ao estudarem o contexto africano, o currículo e as questões sobre sexualidade e HIV entre jovens e adolescentes, e ao destacarem os processos colonizadores pelos quais o continente passou, levam-nos a perceber a biopolítica atuando por meio de valores e normas produzidos por crenças religiosas que pastoreiam a sociedade, dificultando que se ensine sobre sexualidade e HIV. Ao olharmos para o contexto brasileiro, marcado pelo negacionismo e pelo conservadorismo, observamos ambos atravessados por biopolíticas que não se escondem em suas participações nos currículos.

Nos materiais que analisamos, o não aparecimento das questões de HIV, AIDS e das pessoas soropositivas fora do contexto biológico mostra o lado a que Foucault (2015b) se refere ao destacar o “fazer morrer” como uma ação que o governo pode, em “sua defesa”, realizar. Pessoas não heterossexuais, soropositivas e tantas

outras marcadas pelas diferenças constituem o outro lado do poder para o qual a biopolítica opera.

Simões de Miranda *et al.* (2024) apontam que é possível pensar o currículo, bem como os demais documentos e materiais que constroem a escola e a educação, como estratégicos. Cada estudante é produzido dentro dos padrões que politicamente são estipulados como os esperados e, assim, pode ser governado. Naturalizam-se as condutas, partindo do pressuposto de que são criadas classificações entre “normais” e “anormais” no discurso biologizante, enquadrando os corpos para que estejam obedientes à gestão de suas vidas.

Há que se considerar que existem vidas que desobedecem, como as de pessoas não heterossexuais e não cisgênero. No discurso biopolítico, essas pessoas, ao não colaborarem com o projeto de serem mantidas vivas, são deixadas para morrer sem que pese a culpa. A existência de meios de fazer viver (prevenção, testes, antirretrovirais, PrEP etc.) não alcança a amplitude da vida, que é muito mais do que o biológico.

Algumas respostas ao questionamento sobre a ausência dos temas HIV, AIDS e pessoas soropositivas na relação direta com a escola podem estar relacionadas ao que Louro (2011) já sinalizava: o não dizer como uma estratégia de vertentes políticas e públicas, funcionando como um mecanismo que resguarda, no campo moral, a construção do entendimento de “normalidade”. Nesse processo, a escola passa a ser utilizada para produzir e reforçar ideias fixas, limitadas e homogêneas, marcadas por exclusões.

O fato de se associarem as questões de HIV e AIDS às questões de sexualidade impede aceitar a realidade do desejo, que é humano, real e necessário para a constituição do que somos e do que podemos ser sem uma identidade fixa, mas com desejos múltiplos e possibilidades que nos potencializam na afirmação, e não na negação.

A não existência das questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas alinha-se ao que Caetano (2016) constata ao mencionar as questões gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais como identidades político-sexuais não reconhecidas como conhecimentos a serem universalizados nas dinâmicas pedagógicas das escolas. Ocultar essas questões é não aceitar a existência das diferenças, como se, ao não existirem, fossem enfraquecidas pela deslegitimação.

O não aparecimento desses temas nos documentos educacionais e nos materiais didáticos de uso cotidiano das/os estudantes tem como tentativa reforçar a hegemonia sexual, identitária, étnica, econômica, de saúde, entre tantas outras.

Uma possível resposta, que compartilhamos com Moreira e Tadeu (2013), está em considerar o contexto que o HIV produziu na sociedade. Torna-se perceptível que a ausência desses temas no currículo e em outros materiais funciona como uma forma de negar a realidade da existência do HIV e das relações sexuais vividas por jovens.

Ao mesmo tempo, afirma-se uma perspectiva de políticas negacionistas, sustentadas por mentalidades invertidas, segundo as quais falar seria estimular ou ensinar ao sexo e à sexualidade. Diferentemente disso, falar pode significar formar para o exercício do poder de escolha, considerando as realidades em que as/os estudantes estão inseridos.

O HIV e a AIDS tornam-se ameaçadores não apenas para o campo da saúde biológica, mas também para a ordem na qual os discursos são produzidos, ao considerar as vidas dentro de um reduto moral, religioso e perigoso.

Quando as questões relacionadas ao HIV/AIDS são abordadas no currículo do Ensino Médio, a percepção das/os estudantes torna-se mais favorável, gerando conhecimentos importantes. Esses conhecimentos abrangem formas de prevenção, os riscos de transmissão em relações sexuais desprotegidas com parceiros soropositivos, a transmissão vertical de mãe para filho, além da promoção de atitudes livres de estereótipos e preconceitos em relação às pessoas que vivem com HIV (Habib *et al.*, 2024).

Soma-se a isso o que Rua e Abramovay (2001) refletiram ao utilizarem, a partir de Mann (1992), o conceito de empowerment, que, em linhas gerais, refere-se à relação entre o aprendizado e a resposta. As autoras defendem a ideia de que o empoderamento ocorre quando as/os estudantes estão em posse de conhecimentos e, trazendo para o contexto deste estudo, quando detêm conhecimentos sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas, o que, em suas escolhas, pode configurar-se como outra forma de prevenção e de saber lidar caso venham a ter o vírus.

A educação e a escola cumpririam, assim, o papel de promotoras do empoderamento, não apenas por meio de projetos, palestras e outras ações que se limitam a seguir “protocolos” e “evidências”, mas que, superficialmente, podem não

dar conta de desenvolver, de forma integral, os conhecimentos necessários para as respostas cotidianas nas relações entre as/os estudantes e a sociedade.

Britzman (2013) colabora com a ideia de que o currículo, assim como a educação e a escola, devem estar inseridos em um propósito de aproximar a/o estudante do cuidado de si, e não da negação de si. O fato de esses temas não aparecerem como conteúdos e/ou nos materiais didáticos não anula o fato de serem objetos da curiosidade estudantil.

Trata-se de um movimento que deve partir dessa curiosidade, em diálogo com as/os professoras/es, e, a partir disso, conduzir os/as estudantes não a um campo fechado de respostas prontas, mas a um espaço de diálogo, fundamentado no interesse e na inquietação.

Estamos habituadas/os a ver as questões sobre sexualidade na escola como proibitivas e, concomitantemente, ao falar sobre HIV e AIDS, fixa-se a visão da doença, esquecendo-se de que houve avanços: pessoas não morrem mais como no passado, pessoas soropositivas podem constituir famílias, entre tantas outras questões que se tornaram quase mitológicas, em razão do desconhecimento e da produção de discursos preconceituosos.

3.15 Considerações finais do primeiro estudo

A proposta deste primeiro estudo foi analisar documentos, diretrizes e produções científicas e não científicas que embasam as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no Ensino Médio, sobretudo no Estado de São Paulo. Tal objetivo esteve voltado a responder à pergunta da tese: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

Ao olharmos para os achados que trouxemos, é possível perceber que as pessoas soropositivas foram produzidas sob a associação de uma categoria que, historicamente, já vinha sendo estereotipada, como a homossexualidade e as pessoas que não atendiam ao discurso conservador. A AIDS, nesse sentido, passa a ser um dispositivo que aliena as pessoas soropositivas do núcleo social.

As vivências sexuais, somadas à AIDS, reforçaram o discurso religioso cristão sobre a sexualidade, produzindo exclusões e alienações. A sexualidade passa a ser vista como uma experiência trágica com a chegada da AIDS e, assim, é utilizada para a criação de novos discursos, ao mesmo tempo em que reforça os já existentes,

pautados nas proibições e nas anormalidades, dentro dos regimes de verdade que foram sendo construídos com os agravos da AIDS.

Com o aparecimento da AIDS, a experiência da sexualidade é minimizada a um objeto especializado do saber médico. Por meio dela, cria-se a patologização, pautada em um discurso hegemônico que circulou nas sociedades, produzindo técnicas e protocolos que vão definindo as condições de quem é considerado doente e os riscos que ele/ela pode causar.

A partir de todo esse empreendimento, são criadas exclusões e estereotipações que dividem o doente soropositivo e o saudável soronegativo, legitimando a exclusão pelos saberes produzidos e pautando a doença na construção do saudável. Essa relação deixa claro como a sociedade lidou com a AIDS, sendo um exemplo de como as diferenças são tratadas pelas sociedades.

Antes de iniciarmos com os achados sobre a AIDS, trouxeamos alguns materiais dos séculos XIX e XX sobre a sífilis. Com esses materiais, foi possível observar que a infecção era uma possibilidade da vida humana, e não um problema da sexualidade ou de comportamentos humanos desviantes. Uma mulher casada e grávida, que não mantém relações extraconjugais, pode adquirir a infecção. O discurso que circulava era o da moralização das práticas sexuais e dos comportamentos “transgressores”.

Com a chegada da AIDS, não houve um progresso no olhar para a infecção, mas, sim, um silenciamento e uma dominação pelos discursos que a produziam, como os saberes médicos e os discursos cristãos. No decorrer das décadas, com as descobertas e mudanças de olhares sobre a AIDS, é fato que as tecnologias e os avanços científicos colaboraram para que as mortes em decorrência da AIDS diminuíssem e a vida das pessoas soropositivas passasse a ter melhor qualidade.

Todavia, elas não ficaram isentas de relações de poder, exclusão, normatizações e estigmatizações. Isso porque, durante toda a história da AIDS, os discursos sociais que alienavam, excluíaam e marginalizavam se mantiveram. Assim, o que se vê como progresso é compreendido a partir de uma ideia positiva, mas que, na verdade, não passa de um conjunto de relações que criam e estabelecem poderes, ajudando a excluir, controlar e estigmatizar.

O saber médico é definido pela episteme que ele próprio produz e utiliza, dentro do âmbito do que compreende como verdadeiro e falso, alicerçado no discurso

racional. No decorrer da história, o nome e a percepção sobre a AIDS foram alterados. O saber médico foi responsável pelas várias nomeações da AIDS.

Assim, a AIDS foi um acontecimento constituído a partir da episteme médica. Em cada década, essa episteme foi alterando sua visão em relação à infecção e, concomitantemente, à própria AIDS. O saber médico atuou para produzir categorias nos diferentes tempos da história e, ainda nos dias atuais, não se limita a modificá-las.

Os discursos que a medicina produz, assim como outros discursos sociais e políticos relacionados à AIDS, não apenas descrevem a infecção e a doença. São produtivos, pois criam realidades e identidades e estabelecem o que pode e o que não pode ser dito sobre a AIDS. Eles definiram o que era risco e o que era considerado normal, criaram divisões e, por meio delas, exclusões. Ao nomear a AIDS como uma doença homossexual, isso não parte de uma visão neutra, como a ciência positiva que a alicerça.

Inicialmente, a AIDS foi construída a partir dos discursos que circulavam em seu entorno. Pela sua não neutralidade, produziu não apenas a doença, mas também o estereótipo e a estigmatização. Nessa lógica, a episteme médica, a partir da AIDS, controlou o corpo e os usos possíveis que ele poderia fazer, nomeando diversas práticas sexuais como perigosas, de risco e anormais, entre outras classificações.

Embora, com o passar dos anos, a episteme médica tenha alterado sua visão sobre a AIDS não se restringindo mais aos homossexuais e, posteriormente, aos outros “4 Hs”, o discurso se modifica e, com ele, as estratégias de poder e os protocolos médicos, alcançando outros níveis sociais. Isso mostra que o saber produzido está na condição de contingência. A emergência de novos acontecimentos produzirá, em novos tempos e contextos históricos, diferentes regimes e estratégias de verdade.

Durante todo esse percurso arqueológico, foi possível perceber que as instituições estavam preocupadas, cada qual, com suas próprias intenções. O Estado, na busca de encontrar, junto à ciência biomédica, soluções como a cura, vacinas, medicamentos, prevenções e demais questões consideradas importantes.

As religiões tiveram a intenção e ainda têm de fazer com que a percepção do HIV e das pessoas soropositivas permanecesse sob o limbo da consequência do pecado e da imoralidade, atentando até mesmo contra si mesmas, quando muitos dos casos estavam em seus próprios territórios eclesiásticos. Há também aquelas

religiões que utilizaram essa condição como propaganda, na divulgação do espaço curador; outras, como forma de propagação do ódio; e outras ainda, como oportunidade de ensinamento.

As políticas e os/as políticos/as que buscaram colaborar para fomentar a importância de encontrar meios e soluções, propondo emendas, decretos, derrubadas de liminares e tantas outras ações em prol do entendimento de que há vidas e representatividades que não pertencem ao reduto moral, mas às próprias pessoas. Outras, impregnadas de moralismo, já davam as primeiras evidências de um futuro negacionista.

Na escola e na educação, toda essa conjuntura se mantém. A educação, a partir das políticas, das instituições acadêmicas, privadas, médicas, religiosas, entre tantas outras, constitui redes que produzem saberes que chegam à escola. Ao chegar à escola, esses saberes são reproduzidos, estando também no campo do possível produzir outros saberes que possam contestá-los.

A educação, em suas tentativas, buscou criar meios para que a escola, assim como outras instituições, participasse da responsabilidade coletiva na criação de estratégias que nos colocassem acima do vírus e junto às pessoas soropositivas. Todavia, há que se questionar se o papel investido na educação, principalmente por meio de projetos como os apresentados, colaborou, de fato, para a formação de gerações que sabem sobre o vírus e sobre o viver soropositivo, e não por meios terroristas. E, se houve essa força em outros tempos, a ausência dela nos dias atuais se justifica por quais razões?

A escola é um local importante para a formação discursiva sobre o corpo e a sexualidade. Se ela reproduz saberes, e se esses saberes estão na linha de formar, é possível que sejam produzidas ideias sobre o corpo, a sexualidade e a saúde, considerando o binômio normal e anormal, correto e errado, entre tantos outros. No cotidiano escolar, esses saberes reproduzidos repercutem em relações de preconceito, estigma e exclusões, bem como na necessidade de se propor meios de inclusão ou até mesmo de se constituir a própria escola como espaço para ensinar a incluir.

Essas relações nos mostram que os saberes que circulam na escola não são neutros. Os saberes são como redes que se sustentam no poder. As relações na escola estão constantemente atravessadas por forças. Se a escola tenta omitir, dizendo que não há AIDS, chega um estudante soropositivo e prova que ela existe.

Se a escola o repudia e o exclui, surgem manifestações sociais invocando o direito que legitima um corpo estudantil soropositivo a ocupar a escola.

Se, no cotidiano escolar, o corpo soropositivo estiver atravessado por outras relações de força entre seus pares, esse corpo luta, seja para se reafirmar nesse espaço, seja para resistir fora dele.

Ainda assim, foi possível compreender que o que é tratado nos documentos e nos materiais didáticos utilizados com as/os estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo são propostas que, quando raramente aparecem, atendem ao reduto biologizante, considerando prescrições voltadas ao campo da prevenção, do diagnóstico e do tratamento. Não se fala sobre a possibilidade de uma vida soropositiva, nem sobre a convivência com estudantes soropositivos na escola ou fora dela. Uma diferença, talvez, negada?

Ao analisarmos os documentos e os materiais didáticos utilizados pelas/os estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo, foi possível perceber uma certa preocupação em tratar de temas voltados à educação financeira, ao empreendedorismo, à liderança e à oratória, alinhados à ideia de trabalho e à dissolução do pensamento crítico, histórico e artístico, quando esses componentes passam a ocupar o espaço de disciplinas como Filosofia, Sociologia, Artes e outras que poderiam oferecer às/aos estudantes uma visão não alienante das dinâmicas que o capitalismo pode propiciar.

A educação e a escola que percebemos até aqui são aquelas que escondem e silenciam, que não se colocam como descolonizadoras capazes de romper com as epistemologias dominantes. Estas, por sua vez, direcionam-se de forma privilegiada, única e central, marcadamente nos currículos e nos espaços educacionais, substituindo e deslegitimando outros saberes que vivem marginalizados, histórias não contadas ou descritas pelo colonizador, eurocêntrico e/ou americanizado.

Tais saberes não emergem como potentes, capazes de possibilitar outras formas de ver o mundo por diferentes epistemologias, e que, na escola, estejam presentes para além de conteúdos, festas comemorativas e campanhas (Gomes, 2012).

Assim, se a escola não tem tratado as questões de HIV, AIDS e das pessoas soropositivas, buscamos compreender como está a percepção de estudantes do Ensino Médio sobre esses temas. A tese vai, aos poucos, sendo construída em partes que nos permitirão uma visão horizontal para afirmar que, ao não tratar dessas

questões, a escola e a educação não colaboram para a prevenção de novos casos de HIV, para a redução de mortes e para a compreensão do viver soropositivo, possibilitando, ao contrário, outras mortes, sofrimentos e uma percepção limitada sobre o ser humano.



4 SEGUNDO ESTUDO: SILÊNCIOS QUE MATAM, VOZES QUE TRANSFORMAM: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES BRASILEIROS ENTRE MITOS, ESTIGMA E EDUCAÇÃO SOBRE HIV/AIDS E PESSOAS SOROPOSITIVAS

“Quando somos ensinados que a segurança está na semelhança, qualquer tipo de diferença parece uma ameaça”. bell hooks

4.1 Considerações sobre o que pretendemos com o segundo estudo

A proposta que buscamos neste segundo estudo é compreender a percepção que estudantes matriculados/as no Ensino Médio do Estado de São Paulo têm sobre as questões de HIV, AIDS e pessoas soropositivas. Com os dados produzidos e as conclusões a que chegamos com o primeiro estudo, foi possível observar que, nos documentos que direcionam a educação básica e o Ensino Médio, assim como no Estado de São Paulo e, principalmente, nos materiais que as/os estudantes utilizam em aula, raramente aparecem temas que tratem sobre HIV, AIDS e nada sobre a possibilidade de vidas de pessoas soropositivas para além dos muros do preconceito e do estereótipos.

Logo, pareceu-nos importante buscar conhecer a percepção dos/as estudantes que estão no Ensino Médio sobre o tema em questão. Para isso, seguiremos como estrutura para este segundo estudo o formato de artigo. A proposta de organizar o segundo estudo em formato de artigo surgiu no decorrer do estágio sanduíche, por sugestão da supervisão que me acompanhou durante os seis meses.

Algumas considerações nos parecem importantes de elencar neste segundo momento da pesquisa. Somente em 2024, o Brasil registrou 313 casos de AIDS na faixa etária de 15 a 19 anos, sendo 216 em indivíduos do sexo masculino e 97 do sexo feminino. Quanto aos registros de AIDS por categorias de exposição de pessoas com mais de 13 anos de idade, considerando o gênero e a orientação sexual, foram identificadas 1.898 pessoas homossexuais, 434 homens bissexuais, 1.921 homens heterossexuais e 1.594 mulheres heterossexuais (Brasil, 2024a).

Em relação à distribuição racial/étnica geral, entre os homens os casos foram: 1.731 brancos, 605 pretos, 47 amarelos, 2.753 pardos e 22 indígenas; entre as mulheres, 584 brancas, 223 pretas, 19 amarelas, 964 pardas e 7 indígenas.

Considerando a escolaridade, 1.641 homens e 488 mulheres possuíam Ensino Médio completo. No que se refere aos óbitos na faixa etária de 15 a 19 anos, em 2023, foram registradas 30 mortes de homens e 25 mortes de mulheres (Brasil, 2024a).

Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2023b), no Brasil, os/as jovens e adolescentes são um dos grupos mais vulneráveis ao HIV e à AIDS. Nos últimos dez anos, mais de 52 mil jovens entre 15 e 24 anos que viviam com HIV evoluíram para AIDS. Uma possível explicação é que, embora esse grupo reconheça o risco da infecção, a preocupação com o HIV ainda é secundária quando comparada a outras questões, como a gravidez, tema mais frequentemente abordado nas escolas ao longo da formação dos jovens (Knauth; Pilecco, 2024).

A gravidez tem maior visibilidade em comparação com as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e, consequentemente, os jovens, principalmente do gênero feminino, são expostos ao estigma da gravidez na adolescência (Vieira, 2012; Decker *et al.*, 2022).

No contexto dos documentos oficiais da educação brasileira, sobretudo na BNCC, o aparecimento de temas voltados a tratar questões sobre sexualidade não aparece (Reis, 2020). Não obstante, ao olharmos para os documentos e materiais do Estado de São Paulo, o tema sobre sexualidade não é algo presente, podendo ser observado pelos achados que realizamos com os dados produzidos no primeiro estudo da tese.

Outro aspecto observado é que parte da atividade sexual dos adolescentes ocorre no contexto de relacionamentos românticos, e essa situação influencia a tomada de decisão sobre o uso de proteção (Vieira, 2012; Ewing; Bryan, 2015). Nesse contexto, a relação sexual acontece junto com a ideia de “imunidade”, no sentido de não correr risco de IST, a partir do que designam por “relação séria”, nomeadamente a classificação dada à relação de namoro, com o pressuposto de que há confiança mútua entre os parceiros (Vieira, 2012; Power *et al.*, 2024; Arruda; Pedrosa *et al.*, 2024). Esse pensamento não é muito diferente na população adulta, tal como mostram as investigações realizadas com mulheres adultas (Vieira *et al.*, 2003; Vieira, 2012) e com homens adultos (Almeida; Vilar, 2008).

Contudo, observa-se que as propostas de políticas públicas e legislações não facilitam a prevenção, uma vez que não consideram adequadamente os riscos específicos do grupo de adolescentes e jovens. Essas normas frequentemente

limitam o acesso a testes, dificultam a oferta de informações adequadas sobre HIV e AIDS e impõem restrições relacionadas à idade para a prática sexual, afastando-os da realidade da infecção e prejudicando a prevenção efetiva (Govender *et al.*, 2018; Knauth; Pilecco *et al.*, 2024).

Ainda que a preocupação com o HIV seja secundária, a falta de conhecimento sobre a convivência com o HIV pode gerar múltiplas formas de vulnerabilidade. Pavinati *et al.* (2023) destacam que jovens soropositivos frequentemente ocultam seu diagnóstico devido ao estigma e à discriminação, o que resulta na não adesão ao tratamento antirretroviral e em sofrimento emocional significativo. Essa ocultação está associada ao medo do preconceito em diferentes contextos sociais, afetando negativamente a saúde física e mental desses jovens. O estigma relacionado ao HIV impacta a vida cotidiana, as relações familiares e sociais, além do acesso e da continuidade do cuidado, gerando sentimentos de solidão, medo e rejeição.

O contexto em que jovens e adolescentes estão inseridos pode tanto favorecer quanto criar barreiras para o acesso ao conhecimento sobre saúde sexual, especialmente no que se refere ao HIV e à AIDS. Muitos desses jovens vivem em famílias que, devido à falta de formação adequada e a determinantes culturais e sociais, mantêm a visão equivocada de que adolescentes não têm vida sexual ativa, o que dificulta o fornecimento de informações básicas essenciais para o início seguro das relações sexuais. Esse tema é frequentemente tratado como um tabu e raramente é abordado nas conversas cotidianas familiares (Inayat *et al.*, 2025).

Diante disso, torna-se fundamental a implementação de estratégias de educação sexual abrangente nas escolas, que incluam informações claras e acessíveis sobre HIV e AIDS, envolvendo também os familiares. Essa abordagem contribui para romper estigmas e preconceitos, criando espaços acolhedores e abertos ao diálogo, nos quais adolescentes e jovens possam tomar decisões informadas e conscientes sobre sua saúde sexual (Inayat *et al.*, 2025).

Para Karimi *et al.* (2025), o conhecimento insuficiente sobre as formas de transmissão do HIV decorre, em grande parte, de uma conscientização educativa limitada acerca do tema, bem como do estigma cultural, que impõe barreiras ao desenvolvimento de um entendimento aprofundado sobre HIV e AIDS. A falta de informação adequada aumenta a vulnerabilidade ao contágio, dificulta a realização de testes e compromete o acesso ao tratamento. Esse cenário contribui para uma

cascata epidemiológica na qual indivíduos soropositivos desconhecem seu status sorológico e, inadvertidamente, podem transmitir o vírus a outras pessoas, perpetuando a disseminação do HIV.

Evidências científicas do continente americano indicam que programas de prevenção ao HIV, implementados no contexto escolar, têm alcançado resultados positivos, atingindo níveis elevados de eficácia na prevenção da infecção. Esses programas são inicialmente direcionados aos professores, que recebem formação e suporte contínuo de coordenadores e mentores ao longo de um período de dois anos, garantindo o acompanhamento adequado durante toda a execução. Após essa capacitação, os professores repassam o conhecimento aos estudantes, promovendo um envolvimento amplo de toda a comunidade escolar. Essa abordagem contribui para a construção de percepções mais abertas e informadas sobre o HIV, favorecendo a naturalização do tema no ambiente educacional (Schieber *et al.*, 2024).

Uma abordagem educativa no contexto escolar sobre HIV/AIDS desempenha papel fundamental na percepção dos estudantes. Pesquisa realizada por Qin *et al.* (2024) com universitários chineses entre 18 e 20 anos revelou que 91,6% (ou seja, 85.145) dos participantes compreendiam o que é o HIV. Embora esse índice ainda esteja abaixo das metas das autoridades de saúde da China, os principais obstáculos identificados são fatores econômicos, nível cultural e a abrangência da educação sobre o tema. Os estudantes relataram ter recebido educação sexual relacionada ao HIV durante o ensino básico, mas destacaram a necessidade de aprofundar essas discussões para promover comportamentos mais saudáveis.

Além disso, os autores apontaram que, no ambiente familiar, o assunto é tratado de forma conservadora, frequentemente associado à abstinência ou envolvimento em vergonha, mantendo o sexo como um tabu. Esse cenário reforça a importância de estratégias educativas que integrem a escola e a família, promovendo espaços de diálogo abertos e contextualizados, capazes de desmistificar o HIV e a AIDS e incentivar práticas preventivas efetivas (Qin *et al.*, 2024).

Propostas como a realização de workshops em ambientes escolares, que relacionam arte e prevenção ao HIV, demonstraram eficácia ao promover percepções positivas entre adolescentes sobre a importância da prevenção nas relações sexuais. Esses encontros ajudam os jovens a compreender os riscos

associados à falta de conhecimento e à ausência de práticas preventivas adequadas (Lys *et al.*, 2024).

Contudo, a pesquisa realizada por Lys *et al.* (2024) destaca a necessidade de realizar esses workshops com maior frequência ao longo do ano, a fim de reforçar continuamente a conscientização sobre a prevenção e os métodos para a prática do sexo seguro. Além disso, a inclusão de temas relacionados ao HIV/AIDS na educação em saúde escolar oferece aos jovens e adolescentes conhecimentos essenciais que favorecem a prevenção da transmissão do vírus (Nina; Rosa, 2022).

Ao refletirmos sobre o papel da escola no enfrentamento das questões relacionadas ao HIV e à AIDS, bem como sobre as possibilidades de viver soropositivo, destaca-se a importância de abordagens sobre como realizar o autoteste. Muitos estudantes desconhecem essa ferramenta ou possuem conhecimento superficial sobre ela, o que limita seu acesso e uso. Essa falta de informação contribui para que poucas pessoas realizem o autoteste, dificultando o diagnóstico precoce do status sorológico e, conseqüentemente, aumentando o risco de transmissão do HIV em diferentes tipos de relações (Akweh *et al.*, 2025).

Diante de todo esse panorama contextual, buscando destacar aspectos de jovens e adolescentes estudantes localizados no período do Ensino Médio, seguimos com os próximos passos com vistas a contemplar o objetivo deste segundo estudo. As páginas que se seguem contemplarão os passos que seguimos para a produção, análise e discussão dos dados produzidos para este segundo estudo.

4.2 Processos metodológicos

Trata-se de um estudo caracterizado como exploratório, com características mistas quanti-quali. O desenho exploratório está voltado a compreender, o mais próximo possível, a percepção e o conhecimento que as/os adolescentes têm sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem soropositivas no contexto educacional escolar (Gil, 2019; Cervo *et al.*, 2007). Optou-se por esse desenho ao considerarmos que o conhecimento sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no contexto educacional é escasso (Reis; Santos, 2023a).

As características quanti-quali foram compreendidas pela junção proposital de dados e análises com abordagens quantitativa e qualitativa, com a intenção de

alcançar uma compreensão mais ampla da proposta investigativa em um mesmo estudo (Johnson; Onwuegbuzie; Turner, 2007; Tanoamchad, 2023). Outro fator considerado sobre o uso da abordagem mista é o fato de possibilitar a diversidade de meios para a produção dos dados, integrando tanto uma abordagem quanto outra de pesquisa, sem a necessidade de autoexclusão e com o objetivo de melhor compreender a proposta investigativa empreendida (Creswell; Plano Clark, 2018).

Inicialmente, produzimos os dados quantitativos por meio de um banco de perguntas semiabertas e enunciados fechados, considerando sua funcionalidade, alinhada ao que os/as diversos/as estudiosos/as, como Laville e Dionne (1999), Marconi e Lakatos (2021), Gil (2019), descrevem em seus estudos, por se tratar de um instrumento que possibilita, entre inúmeras vantagens, alcançar um contingente expressivo de pessoas e localidades, obter respostas rápidas e garantir o sigilo, permitindo tratar de temas tabu, como HIV, AIDS e pessoas soropositivas.

Do mesmo modo, consideramos as desvantagens sinalizadas por esses/as estudiosos/as ao mencionarem as pessoas que não sabem ler. Porém, pouco ou quase nada disso nos alcança, considerando o grupo ao qual o instrumento foi direcionado, composto por estudantes já alfabetizados/as, que compreendem, em níveis mais altos ou mais baixos, os enunciados descritos de forma simples, visando a uma melhor qualidade das respostas.

O questionário seguiu o formato proposto por Likert (1932), com o objetivo de medir as percepções, opiniões e atitudes dos/as estudantes. Na mesma compreensão, e como apoio para a produção do questionário, utilizamos os estudos realizados por Omote (2005), ao criar a Escala Likert de Atitudes Sociais para a Inclusão (ELASI), e outras escalas, como a de Barbosa (2005), Inventário Geral de Atitudes quanto à Educação Inclusiva (IGAEI), e a de Tanaka (2007), Escala de Atitudes Sociais frente ao Trabalho da Pessoa com Deficiência (ELART), que, ao serem construídas, tiveram como intenção medir opiniões e atitudes em diferentes contextos. No nosso caso, buscamos conhecer a percepção e as atitudes de estudantes dentro do tema HIV, AIDS e pessoas soropositivas.

Para a construção das questões e enunciados, buscamos apoio em diversas produções disponibilizadas, como as do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), que realiza trabalhos voltados à epidemia de SIDA e AIDS. Também recorremos à Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA, 2010), que disponibiliza em seu site informações e uma biblioteca com diversos estudos de

pesquisadores, dentre os quais destacamos a revista “Mitos vs. Realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e AIDS” (ABIA, 2016), bem como os boletins informativos e a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa que Vive com HIV ou AIDS, da ABIA.

Outra fonte utilizada para a construção dos enunciados foi o Projeto Diversidade Sexual [2020?], Saúde e Direitos entre Jovens, que dispõe de uma biblioteca digital com boletins, pesquisas e informativos, com literatura voltada ao HIV e à AIDS entre jovens. Também realizamos o curso “Zero discriminação HIV/AIDS”, com carga horária de 90 horas, disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela UNAIDS, que tem como proposta abordar o tema HIV/AIDS em vários âmbitos médico, educacional e social, com a participação de pesquisadores/as das mais diversas áreas do conhecimento e da pesquisa, visando ao enfrentamento do estigma e da discriminação.

Por fim, o estágio docente na disciplina de Doenças Infectocontagiosas – Infecção pelo HIV/AIDS, código 124354, no curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, com a professora responsável pela disciplina, Dra. Maria Aparecida da Silva, e ministrada pelo médico infectologista e professor Alexandre Martins Portelinha Filho, no 5º termo, período vespertino, do ano letivo de 2022. A participação no estágio se mostrou importante pelo fato de que, no contexto da aula, o professor apresentou questões técnicas e clínicas sobre o HIV e a AIDS, estendendo-se a indicações de literaturas da área que posteriormente foram acessadas e aprofundadas, ligando-se à exposição da aula e à discussão de casos clínicos entre os grupos dos/as estudantes participantes da disciplina.

Após a elaboração do banco de questões e enunciados, selecionamos quatro pessoas que compuseram uma “banca examinadora”. O entendimento que tivemos ao escolhê-las decorre do fato de serem especialistas em pesquisas sobre sexualidade, direitos humanos, área da saúde e estatística. Assim, a função de cada pessoa julgadora foi realizar uma análise quanto aos conteúdos, à rigorosidade metodológica e à capacidade de o instrumento atingir os objetivos almejados pela pesquisa, colaborando tanto na reflexão sobre a atuação do pesquisador quanto no desenvolvimento do estudo, indicando o que pode ser repensado ou o que pode ser mantido.

Soma-se a isso o fato de estarem “de fora” e, portanto, não terem sido “contaminados/as” pelo que estávamos convencidos de estar na direção “certa”.

Assim, as pessoas juízas tiveram, como tarefa crítica de nossa confiança, propor considerações que estivessem na direção dos seguintes critérios contemplados pelo instrumento: organização, objetividade, clareza, facilidade de leitura e compreensão (Herminda; Araújo, 2006; Varanda *et al.*, 2019).

Após passar por todas essas instâncias, utilizamos o Google Forms, por ser um aplicativo que, entre suas funcionalidades, auxilia na coleta e no gerenciamento dos dados. Soma-se a isso o fato de ser de fácil acesso e ter se popularizado com a pandemia da Covid-19, período em que professores e estudantes passaram a utilizá-lo e se familiarizar com a ferramenta. Ao considerarmos todas essas informações, inserimos o Termo de Assentimento para que os estudantes solicitassem a autorização de seus familiares e, posteriormente, para que eles/elas próprios/as dessem seguimento à participação na pesquisa.

As perguntas e os enunciados foram inseridos em uma ordem: quatro questões iniciais de caracterização das/os estudantes. Optamos por deixá-las fechadas; todavia, em algumas perguntas que poderiam não contemplar todas as possibilidades, como, por exemplo, a identidade de gênero, incluímos uma continuidade para que a própria pessoa pudesse responder. Uma vez inseridas as questões de caracterização, acrescentamos os enunciados, totalizando um conjunto de 20, com três opções de resposta: discordo, não sei dizer e concordo²⁰.

O próximo passo foi enviar um e-mail à chefia do gabinete do Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, e obtivemos a resposta de que “*no momento, não estão sendo autorizadas pesquisas na rede, em virtude da priorização de outras demandas da Pasta*”. Diante disso, seguimos com o contato junto à Diretoria de Ensino da região onde coletamos os dados, buscando a autorização para a realização da pesquisa.

Por telefone, ao falarmos com a dirigente Alice Maria de Aguiar Filgueiras Correa, responsável no período de 2023, fomos instruídos sobre os trâmites que deveríamos seguir para obter a autorização. Ela nos solicitou uma cópia do pré-projeto, o instrumento de coleta de dados, com destaque para o objetivo da pesquisa, a possibilidade de riscos e sua descrição, bem como se haveria algum impacto na

²⁰ O instrumento de produção dos dados pode ser conferido na seção – Resultados, e no final do trabalho no Anexo.

rotina escolar. Após o envio desses documentos, fomos autorizados sob o número de despacho do Processo nº 015.00320658/2023-61, após alguns dias (Anexo C).

A dirigente encaminhou os dados e o despacho de autorização às escolas, juntamente com o link para a coleta dos dados. Após alguns dias de espera, não obtivemos quase nenhuma resposta. Demos continuidade ao trabalho realizando ligações para as 33 escolas estaduais que ofertam a modalidade de Ensino Médio, a fim de confirmar o recebimento e a tomada de conhecimento sobre o conteúdo da pesquisa. A observação que tivemos foi a de que, em muitas escolas, as pessoas responsáveis, tanto gestoras quanto coordenadoras, não haviam tomado conhecimento do material.

A justificativa apresentada foi a de que havia muitas demandas, tanto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), com diversos questionários a serem respondidos, quanto problemas escolares e excesso de trabalho decorrente das demandas institucionais, sendo esses fatores dificultadores para a produção de um maior volume de dados.

Outra questão observada foi que a percepção sobre a pesquisa é borrada, ou seja, não é vista como algo importante, o que colabora para o desinteresse na participação. Além disso, identificamos que, para uma responsável escolar, o questionário era considerado apenas da área das Ciências da Natureza, por acreditar que as questões e o tema da pesquisa se restringiam à Biologia e a áreas afins.

O período de produção dos dados coincidiu com a aplicação de diversas provas, descritas por alguns diretores e coordenadores, como o ENEM, a Prova Brasil, entre outras. Nos contatos realizados, percebemos que, devido à falta de funcionários, alguns gestores precisavam assumir outras funções, como, por exemplo, a inspeção de estudantes durante o intervalo, o que dificultava o atendimento às nossas solicitações.

Uma vez analisadas todas essas questões, tomamos a decisão de ir presencialmente às escolas que aceitaram nossa entrada para a produção dos dados. Previamente a nossa ida à essas escolas, enviamos o Termo (ver no apêndice A na página 427) para que os familiares tomassem nota sobre a pesquisa e autorizassem seus/suas filhos/as. Tivemos como intermediários/as professoras e professores que, por também realizarem pesquisa, sabiam o quanto esse processo é difícil. Por meio deles/as, foi então que conseguimos produzir os dados.

Antes de adentrarmos as salas, conversamos com as diretoras das escolas. Uma, em especial, fez uma espécie de triagem. Fomos até sua sala, junto com o coordenador que gentilmente nos recebeu, repassando algumas instruções. Em sua fala, a diretora, sem perceber, disse: “*na sala X tem uma aluna que a mãe é aidética*”. Essa fala da diretora inicialmente nos sinalizou a importância de pesquisar a percepção do corpo docente, por possivelmente ser estrutural a má compreensão existente sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas na escola.

Após todos esses trâmites, passamos nas salas correspondentes ao Ensino Médio, no 1º, 2º e 3º anos, tanto no período da manhã quanto no período noturno. Pedimos licença às/aos professoras/es responsáveis naquele momento da aula, que prontamente nos aceitaram, com um olhar de agradecimento, pelo cansaço estampado em suas faces — eram dias do final do ano letivo.

Ao entrar, a/o professor/a que nos acompanhava nos apresentou e, em seguida, explicamos o objetivo da pesquisa. Informamos que, para aceitarem participar da pesquisa era preciso que lessem o termo e aceitar (Apêndice B). Informamos que as pessoas que aceitaram participar da pesquisa, não poderiam solicitar ajuda nas respostas e que, caso houvesse alguma dúvida, após toda a turma concluir, poderíamos realizar uma conversa a partir dos questionamentos levantados.

A/O professor/a da sala recebia o link e o enviava para o grupo de WhatsApp e/ou disponibilizava um QR Code para que acessassem o formulário da pesquisa, agilizando o processo e garantindo mais tempo para as respostas. Após a conclusão, ouvimos questões e comentários muito interessantes, que se somaram aos resultados, como uma extensão ou complemento do escrito ao verbal.

Concluído o processo de produção dos dados, seguimos para o tratamento dos dados brutos e os procedimentos de análise.

4.3 Procedimentos de análise dos dados

O Google Forms ([2020?]), ferramenta on-line na qual os dados foram obtidos a partir das respostas dos estudantes, disponibiliza as seguintes opções: download em planilha Excel e geração de gráficos por questão. Diante dessas possibilidades analíticas da própria ferramenta, inicialmente foi realizada a leitura integral das respostas obtidas pelos estudantes em cada questão.

Após a leitura dos dados, eles foram organizados considerando os eixos presentes no próprio questionário, gerado para a análise final, em quatro eixos: 1. perfil dos/as estudantes; 2. conhecimento abrangente; 3. educação escolar, inclusão e diversidade; e 4. autoconhecimento como ferramenta contra o HIV.

4.4 Resultados

Os resultados obtidos referem-se a uma população de estudantes do Ensino Médio matriculados em duas escolas públicas de um município do interior do Estado de São Paulo, Brasil. O N válido definido previamente para fins estatísticos e que buscamos foi de 100. Participaram 207 estudantes, dos quais foram considerados para a análise final 189 participantes que atenderam aos critérios de terem assinado o termo de assentimento e respondido a todas as questões.

A partir da análise descrita na seção anterior, foram obtidos os seguintes resultados em cada um dos eixos.

4.5 Eixo 1: Perfil dos/as estudantes

Os/As participantes responderam a sete perguntas relacionadas ao seu “perfil sociodemográfico e identitário”, referentes à identidade de gênero, orientação sexual, raça/etnia e idade. As respostas a essas perguntas contribuíram para a caracterização da amostra, permitindo análises comparativas e garantindo a representatividade do grupo, conforme o Quadro 5:

Quadro 5 - Síntese quali-quantitativa do perfil dos/as estudantes

Aspecto	Resultado	Observação
Identidade de gênero		
Homem cis	60 (31,7%)	Maioria dos participantes
Mulher cis	104 (55,0%)	Grupo predominante
Mulher trans	2 (1,1%)	Baixa representação
Não sei dizer	13 (6,9%)	Representação significativa
Outro	6 (3,2%)	Diversidade presente
Pessoa Não-binária	4 (2,1%)	Baixa representação
Orientação sexual		
Assexual /Queer / Outro	1 (0,5%)	Baixa representação
Bissexual	13 (6,9%)	Baixa representação
Gay	4 (2,1%)	Baixa representação

Heterossexual	155 (82,0%)	Maioria significativa
Lésbica	4 (2,1%)	Baixa representação
Não sei dizer	7 (3,7%)	Baixa representação
Pansexual	5 (2,6%)	Representação limitada
Etnia/Raça		
Amarela	9 (4,8%)	Baixa representação
Branca	81 (42,9%)	Grupo predominante
Indígena	2 (1,1%)	Baixa representação
Outra	0	Categoria sem representação
Parda	75 (39,7%)	Maioria significativa
Preta	22 (11,6)	Baixa representação
Idade Média	16,84 anos $\pm 0,928$	Faixa etária jovem
Idade Mínima	15 anos	Limite inferior
Idade Máxima	20 anos	Limite superior

Fonte: O autor.

4.6 Eixo 2: Conhecimento abrangente; Eixo 3 Educação escolar, inclusão e diversidade; Eixo 4 Autoconhecimento como ferramenta contra o HIV

Os/As participantes responderam a vinte enunciados em escala Likert (discordo, não sei dizer e concordo), relacionados às suas percepções sobre eixos temáticos gerados a partir da literatura e de outros indicadores descritos na metodologia, que se referem ao conhecimento abrangente, à escolarização e ao autoconhecimento. Assim, foram gerados os Quadros 2, 3 e 4, que resumem os dados quantitativos e qualitativos obtidos em cada uma das categorias estabelecidas.

Quadro 6 - Síntese quali-quantitativa da categoria conhecimento abrangente

Enunciados	Discordo	Concordo	Não sabe dizer	Resultado	Observação
1) O HIV e a AIDS não são as mesmas coisas.	77 (40,7%)	65 (34,4%)	47 (24,9%)	Maioria discorda	Confusão entre HIV e AIDS.
2) O HIV é o vírus e a AIDS é a evolução do vírus, desencadeando a síndrome e então acarretando a morte quando não tratada.	22 (11,6%)	104 (55,0%)	63 (33,3%)	Maioria concorda	Compreensão correta sobre a relação entre HIV e AIDS.

3) O HIV é transmitido pelo suor, saliva, aperto de mão, compartilhamento de talheres e roupa de banho.	96 (50,8%)	50 (26,5%)	43 (22,8%)	Maioria discorda	Mitos sobre a transmissão do HIV.
4) Não existe tratamento para o HIV.	110 (58,2%)	35 (18,5%)	44 (23,3%)	Maioria discorda	Desinformação sobre tratamento do HIV.
5) Se uma pessoa ao descobrir que está com HIV começar a tomar seus medicamentos, em alguns meses, ela não transmite o vírus do HIV a outras pessoas.	56 (29,6%)	49 (25,9%)	84 (44,4%)	Maioria não sabe	Incerteza sobre a eficácia do tratamento.
6) As pessoas que morreram em decorrência da AIDS, foram castigadas por não seguirem os princípios religiosos que direcionam para os bons costumes para a vida.	122 (64,6%)	12 (6,3%)	55 (29,1%)	Maioria discorda	Estigmatização e crenças errôneas.
7) Pessoas que vivem com HIV devem ter garantido seus direitos enquanto cidadãos.	18 (9,5%)	110 (58,2%)	61 (32,3%)	Maioria concorda	Reconhecimento dos direitos das pessoas vivendo com HIV.
8) Pessoas que vivem com HIV ao estar em tratamento, podem ter filhos como qualquer outra pessoa.	62 (32,8%)	54 (28,6%)	73 (38,6%)	Maioria não sabe	Incerteza sobre a capacidade reprodutiva.

Fonte: O autor.

Quadro 7 - Síntese quali-quantitativa da categoria educação escolar, inclusão e diversidade

Enunciados/Perguntas	Discordo	Concordo	Não sabe dizer	Resultado	Observação
1)A escola disponibiliza preservativos aos estudantes, professores/as, gestores/as e demais funcionários/as.	152 (80,4%)	13 (6,9%)	24 (12,7%)	Maioria discorda	A escola não oferece preservativos adequadamente.
2)Na minha escola, há informativos para conscientizar sobre a importância da prevenção e sexo seguro.	106 (56,1%)	53 (28,0%)	30 (15,9%)	Maioria discorda	Informativos insuficientes sobre prevenção.
3) Na minha escola, há momentos de campanha e/ou palestras, sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.	104 (55,0%)	58 (30,7%)	27 (14,3%)	Maioria discorda	Campanhas e palestras são escassas.
4) Nas aulas, são tratados temas que falam de sexualidade em relação ao HIV, AIDS e pessoas com HIV.	110 (58,2%)	49 (25,9%)	30 (15,9%)	Maioria discorda	Temas de sexualidade não são abordados.

5) Quando se fala de pessoas que vivem com HIV, o tema é abordado abertamente, sem qualquer medo.	78 (41,3%)	52 (27,5%)	59 (31,2%)	Maioria discorda	Abordagem do tema é tímida.
6) Se na sua escola, existir um/uma estudante que vive com HIV, acha que será bem tratado/acolhido?	52 (27,5%)	40 (21,2%)	97 (51,3%)	Maioria não sabe	Insegurança sobre acolhimento de estudantes.
7) A escola não deve ser um espaço que fale sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.	139 (73,5%)	18 (9,5%)	32 (16,9%)	Maioria discorda	Necessidade de discutir HIV e AIDS na escola.
8) Existe uma falta de informação na escola sobre sexualidade, HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.	24 (12,7%)	124 (65,6%)	41 (21,7%)	Maioria concorda	Falta de informação é evidente.

Fonte: O autor.

Quadro 8 - Síntese quali-quantitativa da categoria autoconhecimento como ferramenta contra o HIV

Enunciados	Discordo	Concordo	Não sabe dizer	Resultado	Observação
1) Se em algum momento de sua vida, descobrir que tem HIV, seria tranquilo lidar com a questão, por saber que existe tratamento e que pode ter uma vida comum como as demais pessoas.	87 (46,0%)	41 (21,7%)	61 (32,3%)	Maioria discorda	Insegurança em lidar com a descoberta do HIV.
2) Quando eu tenho alguma relação sexual, uso alguma proteção pela consciência de vivenciar minha sexualidade de forma segura e saudável.	19 (10,1%)	115 (60,8%)	55 (29,1%)	Maioria concorda	Consciência sobre a importância da proteção.
3) Não acredito que ter relação sexual desprotegida pode me trazer algum problema sexual.	144 (76,2%)	18 (9,5%)	27 (14,3%)	Maioria discorda	Percepção de risco em relações desprotegidas.
4) Se você já teve alguma relação sexual, responda se realizou ao menos uma vez ao ano o teste para saber sobre alguma IST (infecções sexualmente transmissíveis).	129 (68,3%)	39 (20,6%)	7 (3,7%)	Maioria discorda	Baixa taxa de realização de testes para ISTs.

Fonte: O autor.

4.7 Discussão

Para a discussão dos resultados obtidos, considerou-se a necessidade de interpretar os dados de forma aprofundada. Nesse sentido, também foram trazidas

para a análise as percepções do próprio pesquisador desde o início da produção dos dados, referentes a gestos, falas, expressões, inquietações e tantos outros movimentos (Bogdan *et al.*, 2008), bem como os referenciais teóricos da pesquisa. Diante disso, foram elaborados os metatextos apresentados a seguir, que descrevem, interpretam e argumentam sobre as categorias analisadas.

4.8 Eixo 1: “Perfil dos/as estudantes”

Na leitura dos dados que caracterizam os 189 participantes da pesquisa, a identidade de gênero predominante é de homens e mulheres cis e heterossexuais (86,7%), seguida por “não sei dizer” (10,6%) e, por fim, “outro” (3,2%). Esses dados sinalizam uma possível diversidade que destoa do padrão cisheteronormativo. Os números que se descreveram como gênero fluido, trans/travesti no início da transição (3,2%) mostram baixa representatividade.

Os dados refletem a percepção dos participantes sobre sua própria identidade de gênero como uma construção social e performativa. Ao nascer, o corpo recebe, a partir de uma lógica preexistente, a atribuição de uma essência fixa e natural, baseada no órgão genital que cada pessoa apresenta. No entanto, tornamos pessoas de gênero ao longo do tempo. A performance refere-se aos nossos comportamentos e à maneira como cada corpo-sexo reproduz as normas culturais e sociais que lhe foram atribuídas. Somos (ou não) binários, interpretados e inscritos pelos códigos tradicionais e cis-heterossexuais.

Contudo, essa percepção é instável. As identidades de gênero são amplas, flexíveis e ultrapassam as barreiras que historicamente tentaram se impor (Butler, 2015; Connell, 2016). Nos dados, essa realidade se explica pelo fato de os estudantes se perceberem diversos, materializados em suas respostas.

No que se refere à orientação sexual, a maioria afirma ser heterossexual (82%), seguida por bissexuais (6,9%), depois por aqueles/as que não sabiam com qual orientação sexual se identificavam (5,3%) e, por último, pansexuais (2,6%).

Nesse contexto, podemos inferir que, para essa população, o processo de produção da sexualidade não é uma realidade natural, mas um resultado das construções sociais e culturais desenvolvidas ao longo do tempo, histórica e socialmente situadas (Foucault, 2015b). As respostas sinalizam que a sexualidade é um dispositivo que, na prática, reproduz discursos regulatórios sobre o corpo e a

sexualidade. Essa regulação ocorre dentro dos parâmetros considerados legítimos, aceitáveis e corretos em diferentes contextos históricos e culturais (Foucault, 2025a).

Nas respostas às questões abertas sobre a orientação sexual, obtivemos enunciados como “*não sentir atração por ninguém*” e “*sou mulher trans hétero*”, que sinalizam que a percepção e o conhecimento desses jovens e adolescentes sobre identidade de gênero e sexualidade estão atravessados por relações de poder pautadas pela cis-heteronormatividade. Ao adotar essa lógica como parâmetro, todas as outras identidades e sexualidades são excluídas por fugirem ao que é considerado válido e/ou aceitável.

Essa exclusão implica a sensação de ausência de pertencimento, gerando insegurança e marginalização entre estudantes que não se enquadram no modelo cis-heteronormativo no ambiente escolar, sensação que não é vivenciada pelos/as estudantes cis-heteros, por estarem inseridos/as em um espaço de validação (McGlashan; Uasike, 2024).

A quantidade significativa de pessoas que não souberam responder sobre sua identidade de gênero (10,6%) pode revelar que há, nesse grupo, uma ausência de conhecimentos que extrapolam a binaridade e a heterossexualidade. É possível que, na escola, as discussões que versam sobre sexualidade e orientação sexual não ocorram de modo a problematizar visões únicas, perpetuadas por gerações. Espera-se que os estudantes se comportem conforme as normas estabelecidas pela escola, que, em sua maioria, baseiam-se na cisheteronormatividade (Llewellyn, 2024).

Dependendo do contexto em que a instituição está inserida, certas identidades serão mais aceitas do que outras. Dessa forma, os espaços escolares marcados pela hetero-cis-normatividade permanecem, em geral, incontestados. Já no caso de pessoas homossexuais e transsexuais, sua presença tende a ser contestada, pois é interpretada como uma sexualidade que se desvia do padrão. Assim, não saber dizer sobre a própria identidade de gênero e orientação sexual pode também se configurar como uma forma de escapar das “brincadeiras maldosas”, caracterizadas pelas violências homotransfóbicas naturalizadas nas relações do cotidiano escolar (Reis, 2020).

Durante a aplicação dos questionários, observamos a dificuldade de compreensão dos participantes em relação ao termo “cis”. Entre risadas e

brincadeiras, percebia-se certo desconforto e vergonha. Esse desconforto pode demonstrar que o tema é pouco ou nada desenvolvido pela escola no âmbito de seu plano curricular. O silenciamento desses assuntos remete à falta de informação e ao acesso a informações falsas, que se colocam como obstáculos (Orcasita *et al.*, 2020).

Nesse sentido, percebe-se que persistem lógicas familiares assentadas no primado naturalizante da heterossexualidade e do cisgênero, alimentando diversos problemas ao sustentar uma ideia que não corresponde ao que os sujeitos sentem e percebem sobre seu desejo e sua identificação enquanto pessoas (Santos *et al.*, 2023).

Outras respostas, incluindo afirmações assertivas, curiosas e até confusas, como: “*Sou uma mulher/travesti no início da minha transição*” ou “*Sou Hetero*” (com maiúscula), possivelmente reforçam a heterossexualidade e a cisgeneridade associadas à identificação como “homem”, “mulher” ou “gênero fluido”.

Essas respostas alinham-se ao modo como, estruturalmente, são produzidas as noções de gênero e sexualidade, ao naturalizarem os indivíduos na sociedade. Ao estarem inscritas no universo de produções que vinculam políticas à criação de leis, reforçam a percepção binária de gênero como única, associando-a a papéis normativos. Isso normaliza a ideia de que os meninos devem obedecer a certos critérios de elegibilidade, assim como as meninas devem cumprir regras específicas de atuação que as validem, limitando o acesso a outras possibilidades (Caetano, 2016).

Por outro lado, é importante considerar que estudantes que não se enquadram na cultura escolar cis-heteronormativa rompem com modelos preestabelecidos, possibilitando a reflexão sobre outros corpos e sujeitos. Isso amplia a percepção dos estudantes acerca de diversas formas possíveis de desejo, afeto e identificação, criando novas formas discursivas para compreender os indivíduos (Francis, 2023).

Embora jovens queer, ao estarem no espaço escolar e saírem da linha esperada pela instituição, sejam frequentemente marcados por violências e abusos, essas sanções podem ser entendidas como dispositivos de realinhamento, ao utilizarem a violência homotransfóbica (Reis, 2020).

Os dados, em uma análise geral, e as reações dos estudantes em sala ao longo da produção dos dados, sobretudo entre meninas e meninos cis-heteros,

mostraram o quanto a produção social pautada em valores patriarcais, machistas e sexistas interfere em suas percepções. As reações variaram entre falas como “hetero somos nós normais” e brincadeiras misturadas a risos ao ler em voz alta a alternativa gay, como em “fulano fala de você aqui”.

Também foi possível perceber que a percepção que os meninos têm sobre as meninas influencia a forma como elas devem se comportar, vestir e falar para serem consideradas meninas decentes e respeitáveis.

Além disso, para muitas meninas, esse modelo é aceito devido à naturalização desses valores no meio em que estão inseridas. Quanto mais conservadores e tradicionais forem os valores da sociedade, mais essas relações se refletem também na escola, que não é diferente, perpetuando desigualdade, exclusão, desempoderamento e diversas formas de violência (Qazi *et al.*, 2021).

Por outro lado, quando esse modelo é rompido, quebrando o mito de como os corpos devem se posicionar, esses corpos, ao desobedecerem às regras, passam a ser lidos e acessados de diversos modos, desde meninas com roupas curtas, classificadas como “putas”; meninos afeminados, como “gays passivos”; até meninos brutos, como “machos legítimos” (Reis; Santos, 2023b).

Na escola, a sexualidade e a identidade de gênero são dispositivos organizados por meio de espaços e códigos que indicam o que cada corpo-gênero-sexualidade pode ou não fazer. A estrutura pela qual isso é erigido tem como objetivo criar padrões que definem as posições que os corpos devem ocupar. Trata-se de uma fabricação intencional, que muitas vezes passa despercebida (Louro, 2013).

A escola é um espaço em que os corpos circulam, trazendo consigo sexualidades e suas significações. No contexto em que estão inseridos, o corpo que for desaprovado pela significação que lhe foi atribuída tenderá a gerar um sentimento de frustração, resultando em estudantes infelizes.

Por outro lado, corpos que se encontram dentro do lócus considerado e legitimado como “normal” tendem a experimentar felicidade. Essas percepções de corpos normais e anormais são, em parte, construídas pela própria escola, que exerce controle sobre os espaços, os tempos e os saberes nos quais as verdades sobre os corpos são produzidas. A compreensão que os estudantes desenvolvem sobre seus próprios corpos e os de seus pares torna-se superficial, pois se baseia na perpetuação da ideia de corpo restrito à prática sexual (Probst; Kraemer, 2020).

Com relação à raça/etnia, o espaço escolar no contexto da pesquisa é formado por 42,9% de estudantes brancos. Observa-se que uma parte significativa de pessoas brancas ainda predomina no espaço escolar formal, resultado de um processo histórico, estrutural e sistêmico que colabora para essa configuração. Não obstante, as condições de infraestrutura às quais têm acesso nas escolas possibilitam o ingresso e a permanência, favorecendo a continuidade para cursos e universidades renomadas e com maiores condições de concorrência (Elacqua *et al.*, 2024).

Observou-se, no entanto, uma baixa representatividade de estudantes pretos (11,6%), o que pode ser explicado por uma dinâmica social que força esses estudantes a não permanecerem na escola (Gonçalves; Gonçalves; Ferreira, 2018). Somam-se a isso as intersecções que as estudantes pretas vivenciam, implicando em sua não presença nos espaços escolares, como a hipersexualização e a naturalização dos papéis das mulheres (Davis, 2016), as violências sexuais contra mulheres pretas (Hooks, 2019) e as discriminações ocorridas entre pares em sala de aula (Okiihiro, 1994), todos mecanismos que fazem com que esses estudantes não consigam permanecer na escola, ocupando o espaço que, por direito, lhes caberia.

A quantidade de estudantes que se declararam pardos foi de 39,7%, percentual próximo ao de estudantes brancos. As discussões sobre cor e etnia no Brasil configuram a identidade parda como uma estratégia para o embranquecimento populacional (Pasqualotto, 2025). Ao somarmos pessoas pretas e pardas, a predominância aparece nessa população (51,3%).

Uma das possíveis explicações reside no fato de que as relações discriminatórias no contexto escolar podem variar a partir do olhar que considera as condições sociais e econômicas em que cada estudante está inserido. Estudantes pardos que vivem em condições econômicas e sociais precárias, assim como estudantes pretos, sofrem discriminações semelhantes. O cenário muda quando estudantes pardos vivem em condições socioeconômicas elevadas, aproximando-se de estudantes brancos e distanciando-se de relações que os discriminam (Daflon; Carvalhaes; Feres, 2017).

4.9 Eixo 2: “Conhecimento abrangente”

O Conhecimento Abrangente foi identificado a partir de oito enunciados que tiveram como proposta conhecer a percepção dos estudantes quanto ao conhecimento científico produzido e compartilhado pela comunidade científica sobre HIV e AIDS. Dos oito enunciados, cinco (1, 2, 5, 7 e 8) foram construídos com base em descobertas e comprovações científicas, e três enunciados (3, 4 e 6) apresentaram ideias ultrapassadas, vistas como mitos e expressões de desconhecimento, sob um viés preconceituoso.

Desde o aparecimento das mortes em decorrência da AIDS nas diversas sociedades do mundo, os discursos e os conhecimentos que circularam foram organizados por regimes que, em diferentes tempos, caracterizaram distintas formas de verdade sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas. Trata-se de uma ciência descontínua, que gerenciou as regras produtoras das “verdades” socializadas, normalizando e anormalizando os corpos e, por meio delas, produzindo subjetividades marcadas pelo preconceito e pela estigmatização (Foucault, 2025a).

Se pensarmos a partir de uma contextualização sócio-histórica, o surgimento da epidemia de AIDS resultou em saberes que foram utilizados como mecanismos de poder (Foucault, 2025a). Jodelet (1999) refere que, antes de qualquer investigação biológica que esclarecesse algumas das dúvidas sobre a doença, as pessoas criavam um conjunto de “*teorias*” sobre as pessoas soropositivas (toxicodependentes, homossexuais, hemofílicos). A “*praga gay*”, como também era conhecida, aparecia entendida como a doença dos impuros, um castigo divino contra a crescente liberalização dos comportamentos sexuais.

É nesse contexto de *pânico moral* criado em torno da doença que, frequentemente, se culpabilizam as pessoas que vivem com HIV (Weeks, 1985). Nos dias atuais, com os diversos avanços tecnológicos, a AIDS, em alguns países, já não é vista apenas como sinônimo de morte, possibilitando discursos alinhados a melhores condições de vida biológica para as pessoas soropositivas.

No enunciado (1), “O HIV e a AIDS não são as mesmas coisas”, a maioria das respostas foi de discordância (39,6%). Contudo, ao observar as respostas que concordam (35,3%) e as que não sabiam dizer (25,1%), percebe-se uma alternância. Ou seja, embora a maior porcentagem dos estudantes discorde, as demais

alternativas se fragmentam, não havendo uma predominância clara em uma única opção. Assim, é possível perceber certa confusão na percepção que distingue o que é o HIV e o que é a AIDS.

Essa mesma realidade aparece na pesquisa de Agu *et al.* (2020), ao evidenciarem a confusão na percepção que distingue o HIV e a AIDS. Segundo os dados do estudo, a limitação apresentada por jovens e adolescentes se deve, em parte, ao acesso a informações pelo YouTube, onde encontram respostas falsas, como, por exemplo, a ideia de que “o HIV e a AIDS podem ser tratados por antibióticos”. Outro fator que contribui para essa confusão é a transmissão de concepções errôneas das gerações que os antecederam, tornando necessária a reconstrução da percepção biológica sobre o vírus e a infecção.

Kanyama e Lyakurwa (2025) indicam que há obstáculos para a compreensão do que é o HIV e a AIDS, como fatores culturais implicados em normas e tabus que limitam os jovens a uma percepção ampla. Ressaltam que as meninas estão “*mais atravessadas*”, por terem menos acesso às informações do que os meninos. Ambas as pesquisas reforçam a importância de uma educação e de um currículo que incorporem ideias atualizadas e pensamento crítico, pautados em possibilitar que jovens possam acessar conhecimentos que lhes permitam vivências e saúde sexual seguras.

Quanto ao enunciado (2), “O HIV é o vírus e a AIDS é a evolução do vírus, desencadeando a síndrome e então acarretando a morte quando não tratada”, a maioria das respostas (53,6%) foi de concordância, sinalizando uma possível compreensão do conteúdo apresentado. Contudo, ao relacionarmos esses dados com os do enunciado (1), que também tratava da diferença entre HIV e AIDS e no qual a maior parcela dos estudantes (39,6%) discordou, torna-se novamente perceptível a confusão na percepção.

Ainda assim, ao somarmos a porcentagem dos estudantes que não sabiam dizer (34,8%) com a daqueles que discordaram (11,6%), observa-se que é pequena a porcentagem (7,2%) que efetivamente distingue os estudantes que sabiam, de fato, a diferença entre HIV e AIDS daqueles que não sabiam.

Dados recentemente produzidos por Ratnawati *et al.* (2024) mostraram que escolas que adotam programas educacionais conseguem propiciar maiores conhecimentos, atitudes e comportamentos relacionados ao HIV e à AIDS, quando comparadas às que não os adotam. Esses programas estão presentes nos

currículos, nas abordagens teóricas e em intervenções que utilizam tecnologias, contam com profissionais habilitados nas mais diversas áreas, promovem o trabalho em grupo e destinam maior tempo ao tratamento dessas questões.

No que se refere ao enunciado (3), “*O HIV é transmitido pelo suor, saliva, aperto de mão, compartilhamento de talheres e roupa de banho*”, a maior parte das respostas (50,2%) foi de discordância. Ainda assim, é possível observar que, embora haja discordância, sinalizando que essa maioria entende que o enunciado não procede, ao somarmos a porcentagem dos estudantes que concordam (25,6%) com a daqueles que não sabem dizer (24,2%), temos praticamente a outra metade das respostas (49,8%), o que indica a presença de percepções ainda envoltas em mitos sobre as formas de transmissão do HIV.

Outras descobertas também evidenciaram percepções de estudantes pautadas em visões “*errôneas*”. Choruma; Choruma; Pasirayi (2021) explicam que ideias como a de que o HIV pode ser transmitido por picadas de mosquito e de que o HIV e a AIDS têm cura resultam da construção de percepções baseadas em colegas e mídias sociais, possibilitando interpretações e compreensões imprecisas.

Javed *et al.* (2025) salientam que os mitos derivam de uma série de fatores, sobretudo entre meninas e mulheres. Os principais apontados são: baixo nível socioeconômico, ausência de educação, má interação com as mídias, tabus e estigmas. Knauth e Pilecco (2024) apontam como mitos a ideia de confiança no parceiro sexual, o baixo nível de informação causado pela crescente onda conservadora, a ausência de políticas e a incredulidade, sobretudo entre jovens heterossexuais que, ao praticarem sexo desprotegido, não acreditam haver risco.

No enunciado (4), “*Não existe tratamento para o HIV*”, a maior porcentagem das respostas foi de discordância (56%). Se considerarmos os estudantes que não sabem dizer (25,1%), a porcentagem restante é pequena (18,8%) entre aqueles que concordam que não existe tratamento para o HIV. Ao somarmos os números dos estudantes que não sabem dizer com os que concordam, temos quase a metade de todas as respostas (43,9%).

Os números reforçam a desinformação sobre a possibilidade de tratamento do HIV. O desconhecimento acerca da existência de meios de tratamento e prevenção ao HIV decorre de toda uma estrutura e sistema, como foi apontado até aqui a ausência de programas nas escolas que tratem essas questões sem tabu

(Ratnawati *et al.*, 2024) e o avanço de visões conservadoras, que criam obstáculos para a formação sobre prevenção e tratamento (Knauth; Pilecco, 2024).

Outras evidências são apresentadas por Orji *et al.* (2025), ao destacarem que as tecnologias de prevenção e tratamento produzidas não têm alcançado os jovens, seja porque a informação não chega, seja porque os custos não são acessíveis. Ainda é desconhecido entre os estudantes o uso de antirretrovirais, utilizados por pessoas soropositivas no tratamento do HIV.

Além disso, também há desconhecimento sobre a PrEP (profilaxia pré-exposição) e a PEP (profilaxia pós-exposição) como meios de prevenção, o que expõe os estudantes a maiores riscos e perigos devido à ausência de conhecimento.

Ao analisar os dados obtidos a partir do enunciado (5) “*Se uma pessoa, ao descobrir que está com HIV, começar a tomar seus medicamentos, em alguns meses ela não transmite o vírus do HIV a outras pessoas*”, observa-se que a maior porcentagem das respostas foi de estudantes que não sabiam responder (45,4%).

Considerando, ainda, a porcentagem dos estudantes que discordaram (28,5%), a fragilidade do entendimento sobre a relação “*Indetectável é Intransmissível*” torna-se ainda mais evidente, sinalizando uma percepção marcada pela incerteza quanto ao tratamento do HIV e à sua eficácia. A menor porcentagem correspondeu aos estudantes que concordaram com o enunciado (26,1%).

Orji *et al.* (2025) associam esse cenário a fatores contextuais nos quais os estudantes estão inseridos. A incerteza decorre da ausência de conhecimento sobre o HIV e a AIDS. Não obstante, outras barreiras que dificultam a percepção são o estigma, uma vez que ele pode produzir a negação do problema, levando, assim, à desinformação (Sharma *et al.*, 2024).

Outro fator que pode levar os estudantes a acreditar que pessoas soropositivas não transmitem o HIV quando estão em tratamento é o fato de conhecerem pessoas vivendo com HIV e perceberem essa condição como algo invisível, desconstruindo a ideia de que a AIDS é uma sentença de morte, como era concebida no passado (Methazia; Bessenaar; Baum, 2024).

No enunciado (6) “*As pessoas que morreram em decorrência da AIDS foram castigadas por não seguirem os princípios religiosos que direcionam para os bons costumes para a vida*”, a maior porcentagem das respostas foi de discordância (64,3%). Contudo, deve-se considerar que a porcentagem de estudantes que não

sabiam dizer (30%), somada à daqueles que concordaram (5,8%), evidencia a presença de percepções marcadas por estigma e crenças preconceituosas.

A mentalidade ainda carregada de preconceito e estigma pesa sobre a percepção dos estudantes em relação às pessoas soropositivas, ao associarem o HIV a relações sexuais consideradas “*erradas*” e às abordagens de alguns professores, pautadas na ideia de que o HIV é resultado de relações desaprovadas (Njugunda *et al.*, 2023). Soma-se a isso o que outros estudos já sinalizaram: o peso que a religião pode representar ao disseminar ideias pautadas no moralismo e no patriarcado, nas quais há “*verdadeiros*” sexos e momentos “*corretos*” para que a prática sexual aconteça (Knauth *et al.*, 2024).

Vale lembrar que a reprodução de ideias do passado, marcada nas décadas de 1980 e 1990 pela expressão “doença dos impuros” (Weeks, 1985), ainda se faz presente ao pautar a AIDS e o HIV como castigo, culpabilizando, frequentemente, as pessoas soropositivas.

No enunciado (7) “*Pessoas que vivem com HIV devem ter garantidos seus direitos enquanto cidadãos*”, a maior parte das respostas foi de concordância (56,5%). Todavia, chama a atenção a porcentagem de estudantes que não sabiam dizer (34,3%), restando a menor porcentagem entre aqueles que discordaram (9,2%).

Embora haja uma parcela significativa que demonstra falta de percepção sobre os direitos das pessoas soropositivas, é possível afirmar que, para muitos estudantes, há o reconhecimento desses direitos.

A partir dessa perspectiva, Ogunbanjo (2022) reconhece que a educação, ao se pautar nos direitos humanos, possibilita que os estudantes desenvolvam uma percepção mais ampla, sobretudo no que tange à empatia e à inclusão. Todavia, na ausência de uma educação que considere os direitos humanos, o autor compreende esse processo como um “projeto” no qual, uma vez que os estudantes não detêm conhecimentos sobre direitos humanos, passam a não reconhecer seus próprios direitos, assim como os de outras pessoas, como no caso das pessoas soropositivas.

Manyerere (2025) ressaltam que é possível que o aprendizado sobre os direitos humanos ocorra fora da escola, a partir de experiências e contatos diretos com as diferenças. Somam-se a isso as influências da família, que pode cumprir um papel potencial, desde que tenha a percepção do respeito e de valores que não

distingam uma pessoa da outra. Assim, tratar essas questões no período educacional é um momento propício para a formação de valores humanos.

Por fim, no enunciado (8) *“Pessoas que vivem com HIV, ao estarem em tratamento, podem ter filhos como qualquer outra pessoa”*, a maior parcela dos estudantes não sabia responder (38,6%). Em seguida, aparecem aqueles que discordaram (33,3%). Os estudantes que concordaram apresentaram a menor porcentagem (28%).

Os dados mostram que, em sua maioria, os estudantes possuem uma visão incerta sobre a possibilidade de pessoas que vivem com HIV gerarem filhos, estando aptas à reprodução, caso assim desejem.

Mereu *et al.* (2022) atribuem a incerteza na percepção dos estudantes à falta de conhecimento e à visão negativa sobre o HIV e as pessoas soropositivas. Outro ponto destacado é que a idade e as vivências cotidianas ainda não fazem parte do horizonte de reflexão desses estudantes. Ou seja, a falta de conhecimento implica não apenas na percepção sobre os cuidados, como, por exemplo, no entendimento de que mulheres soropositivas não podem amamentar, mas também no desconhecimento dos benefícios para a saúde e a qualidade de vida que as pessoas soropositivas têm ao seguirem corretamente o tratamento.

A análise geral desse eixo revela que a percepção dos estudantes é majoritariamente pautada na incerteza, na confusão, na desinformação, no estigma e no mito. Por meio dos referenciais teóricos da pesquisa, podemos compreender que a escola e o currículo podem possibilitar a ampliação dessas percepções limitadas sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

4.10 Eixo 3: “Educação escolar, inclusão e diversidade”

As perguntas elaboradas para a caracterização desta categoria compreenderam sete enunciados, dos quais um também buscou conhecer a percepção dos estudantes sobre a relação da escola com as questões referentes ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas.

O enunciado (1) tratou de *“A escola disponibiliza preservativos aos estudantes, professores, gestores e demais funcionários”*. A maior parcela das respostas das/os estudantes foi de discordância (78,7%), seguida pelos que não

sabiam dizer (14,5%) e, por fim, pela menor parcela (6,8%), que concordou que a escola disponibiliza preservativos.

Os dados sinalizam que a escola não está aberta a práticas relacionadas às vivências sexuais dos estudantes. Pesquisas têm apontado possíveis explicações, como a de Junck *et al.* (2022), ao indicarem o medo de professores e gestores de serem mal interpretados, associando a disponibilização de preservativos a um incentivo à prática sexual.

Não obstante, outros obstáculos também podem ser observados a partir das crenças desses profissionais. Castro *et al.* (2024), ao ouvirem os jovens, identificaram a necessidade de profissionais na escola que possam orientar sem medo e sem julgamentos, possibilitando visões mais amplas para colaborar com os anseios que os estudantes têm sobre suas sexualidades e práticas sexuais.

Lawrence *et al.* (2025) ressaltam a importância de a escola considerar a inclusão como um fator que alcance as interseccionalidades dos estudantes. Pessoas LGBTQI+ e o recorte de raça precisam estar na agenda das discussões, com a intenção de que essas pessoas não sejam borradas pelo estigma e pelo preconceito, mas, sim, reconhecidas em sua relação com todos os demais direitos, como o acesso a programas de saúde, testes gratuitos, meios de prevenção, consultas, acompanhamento médico e psicológico e medicamentos antirretrovirais, disponibilizados, no contexto brasileiro, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O enunciado (2) “*Na minha escola, há informativos para conscientizar sobre a importância da prevenção e do sexo seguro*” apresentou como maior porcentagem de respostas a discordância (55,6%). Em seguida, apareceram os estudantes que concordaram (29%) e, por fim, aqueles que não sabiam dizer (15,5%).

Somando-se as respostas de discordância com as de “não sei dizer” (71,1%), é possível afirmar que a escola não tem proposto informativos sobre prevenção aos estudantes.

Os dados sinalizam uma insuficiência nas formas e na disponibilidade de informações. Pesquisas anteriores já apontaram lacunas que explicam por que as informações sobre HIV e AIDS não se fazem presentes no contexto escolar. Arruda *et al.* (2024) descrevem a escola como um local privilegiado para a disseminação de informações sobre HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mas que

tem se ausentado desse papel, deixando para a internet uma função formativa que pode imprimir perspectivas estigmatizantes sobre a prática sexual.

Choruma *et al.* (2020) apontam que a escola e a mídia podem ser espaços importantes para o acesso dos estudantes ao conhecimento sobre HIV e AIDS. Todavia, as informações veiculadas pelas mídias podem não estar presentes em alguns lares, seja pela falta de recursos, seja porque o assunto não circula em famílias com crenças religiosas tradicionais. Assim, a escola e o currículo podem desempenhar o papel de romper vulnerabilidades decorrentes da falta de conhecimento e de formação familiar.

O enunciado (3) buscou saber se *“Na minha escola, há momentos de campanha e/ou palestras sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV”*. A maior porcentagem concentrou-se na alternativa que discordava (52,7%), seguida pelas que concordavam (30,4%) e, por fim, pela menor porcentagem, daqueles que não sabiam dizer (16,9%).

Contudo, ao somarmos as respostas que concordavam com as que não sabiam dizer (47,3%), observa-se, mais uma vez, que a escola não tem proposto de forma consistente a realização ou o recebimento de campanhas e/ou palestras sobre o tema.

Gao *et al.* (2012) concordam que palestras podem ser um meio de intervenção que possibilita a aquisição de conhecimentos básicos. Isso foi evidenciado após a realização de um trabalho que contou com palestras, vídeos e outros recursos que, ao tratarem questões sobre HIV e AIDS, obtiveram resultados significativos quanto à percepção dos estudantes, comparando-se testes aplicados antes e depois da intervenção.

Chan CT *et al.* (2022) também corroboram ao destacar a importância da educação no tratamento desses temas, considerando-a essencial para práticas sexuais saudáveis entre estudantes do ensino médio. Tal afirmação resulta do estudo que realizaram ao comparar diferentes estados de um país, alguns com políticas sexuais pautadas na abstinência e outros com políticas educacionais que tratam o HIV de forma abrangente. Os estados que se baseiam em políticas de abstinência sexual apresentaram maiores potenciais de comportamentos de risco entre os estudantes, em comparação àqueles que possuem políticas educacionais que abordam o HIV de forma mais ampla.

Oliveira *et al.* (2023) veem que campanhas nas escolas podem auxiliar o trabalho pedagógico e se colocar como um meio para que os estudantes sanem dúvidas. Segundo o estudo, tratar de questões relacionadas ao HIV possibilita criar um espaço de diálogo e de desconstrução de percepções ultrapassadas, rompendo com tabus e ajudando os estudantes a conhecerem as diversas formas e meios de prevenção. Tais conhecimentos, desenvolvidos na escola, diminuem as vulnerabilidades que colocam os estudantes sob riscos decorrentes do desconhecimento.

No enunciado (4), procuramos saber se *“Nas aulas, são tratados temas que falam de sexualidade em relação ao HIV, à AIDS e às pessoas com HIV”*. A maior parcela dos estudantes discordou (56%), seguida pela opção que concordou (28%) e, por fim, pela menor parcela, que não sabia dizer (15,9%).

Ao somarmos as alternativas “concordo” e “não sei dizer” (43,9%), observa-se que quase a totalidade das respostas aponta para a possibilidade de que, na escola, assuntos voltados à sexualidade não são tratados de forma consistente.

Dimara, Yuliani e Haryati *et al.* (2024) defendem a alfabetização em saúde, destacando as questões sobre HIV como fundamentais, sobretudo para as mulheres e para todas as pessoas que, pela ausência de educação em saúde, podem estar vivenciando comportamentos de risco. Seytre (2019) aponta que livros didáticos bem elaborados podem contribuir para o enfrentamento do HIV. Por isso, ressalta-se a importância de o tema estar presente de forma positiva, pautada nas novas descobertas científicas.

Ringisai e Sutiningsih (2023) afirmam que professores que passam por formação continuada têm maiores chances de abordar tais questões do que aqueles que não passam. A justificativa de alguns docentes para não tratar do tema é a timidez, uma vez que o assunto é visto como tabu. Outros apontamentos destacados na pesquisa são a necessidade de um tempo hábil no currículo e de aulas mais interativas.

No enunciado (5), ao investigarmos se *“Quando se fala de pessoas que vivem com HIV, o tema é abordado abertamente, sem qualquer medo”*, a maioria das respostas foi de discordância (41,1%). A segunda maior porcentagem correspondeu aos que não sabiam dizer (31,4%), restando a menor porcentagem para aqueles que concordaram (27,5%).

Com esses números, é possível perceber que assuntos relacionados às pessoas soropositivas quase não são tratados no cotidiano escolar.

Não falar sobre pessoas que vivem soropositivas, segue o fluxo de outros temas atrelados, como a sexualidade, HIV, AIDS entre outros. Uma das respostas pode ser vista com a pesquisa de Zucchi *et al.*, (2010), ao entenderem que a escola pode ser um espaço para o estigma e discriminação.

A relação do estigma e preconceito foi vista a partir do cotidiano escolar, com professores, coordenadores e diretores, que manifestaram o estigma e discriminação, entre estudantes soropositivos e soronegativos. O estigma e preconceito foi visto ao relacionar pessoas soronegativas ao perigo de namorar pessoas soropositivas, visão de anormal, com dificuldades na aprendizagem, marcadores sexuais, como a homossexualidade e raça às pessoas pretas.

Chory *et al.* (2021) indicam, como meio de romper essas barreiras, a formação de professores a partir de histórias de vida de pessoas soropositivas. Por meio delas, é possível que o corpo docente se sensibilize, desenvolvendo relações pautadas na empatia.

Máximo Junior *et al.* (2019) destaca a importância de o tema estar presente no livro didático, como uma forma de ilustrar e representar pessoas soropositivas como quaisquer outras, rompendo com visões ultrapassadas e criando identidades positivas. Nyandiko *et al.* (2023) afirmam que a formação de professores sobre o tema é a chave para que ele seja tratado com os estudantes, possibilitando a transformação das percepções e favorecendo o rompimento das estigmatizações e discriminações de pessoas soropositivas, tanto no contexto escolar quanto fora dele.

No enunciado (6), perguntamos: “*Se na sua escola existir um estudante que vive com HIV, você acha que ele/ela será bem tratado/a e acolhido/a?*”. A predominância das respostas foi de “não sei dizer” (51,2%), seguida pela alternativa de discordância (26,6%) e, por fim, pela menor parcela, que concordou (22,2%).

Os resultados indicam uma possível insegurança, por parte dos estudantes, quanto ao acolhimento e à inclusão de pessoas soropositivas no ambiente escolar.

Em diálogo com os dados, Sharma *et al.* (2024) apontam que a escola pode se constituir como um espaço de “terror” para pessoas soropositivas, sobretudo quando a orientação sexual é homoafetiva. A escola, por estar estruturalmente construída a partir de valores heteronormativos e patriarcais, tende a ver pessoas

soropositivas como “amaldiçoadas”. Isso decorre da falta de formação que rompa com os estruturalismos e amplie a visão sobre a diversidade.

Pavinati *et al.* (2023) também veem a escola como um espaço de vulnerabilidade para pessoas soropositivas, em razão da ausência de conhecimentos que possibilitem a desnaturalização de percepções preconceituosas.

Chory *et al.* (2021) compreenderam que, a partir das histórias de vida de pessoas soropositivas, é possível romper essa insegurança e criar um espaço de empatia e inclusão entre os estudantes. Fonseca *et al.* (2024) veem como necessário tratar tais temas, uma vez que o conhecimento desenvolvido na escola possibilita que estudantes soropositivos possam viver sem medo, aceitar sua condição e seguir com o tratamento.

Para os estudantes soronegativos, o conhecimento de que todas as pessoas estão passíveis de ter HIV, bem como o acesso a informações sobre testes e tratamentos antirretrovirais, constitui a melhor estratégia de prevenção e conscientização.

No enunciado (7), ao mencionar que “*A escola não deve ser um espaço que fale sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV*”, a maior porcentagem das respostas foi de discordância (72%). A menor porcentagem correspondeu aos que concordaram (9,2%). As respostas de “não sei dizer” (18,8%) configuraram o segundo maior percentual.

Com esses números, é possível observar que os estudantes manifestam interesse em que a escola trate das questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas.

Javed *et al.* (2025) consideram que a educação que trata das questões sobre HIV e AIDS nas escolas funciona como uma “vacina social”, imprimindo nas atitudes dos estudantes valores de cuidado, inclusão e conhecimento. Orji *et al.* (2025) veem a escola e os professores como o espaço primordial para o desenvolvimento do conhecimento sobre HIV e AIDS, resultando em mudanças de comportamento e atitudes mais positivas em relação às práticas sexuais e aos relacionamentos.

Ngissa *et al.* (2024) afirmam que muitos estudantes não possuem conhecimentos básicos sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. Ressaltam, ainda, que os próprios estudantes percebem a importância de tratar temas

relacionados à sexualidade, possibilitando a construção de conhecimentos que os ajudem a olhar para além das crenças e culturas nas quais foram formados.

Por fim, no enunciado (8), buscamos saber se “*Existe uma falta de informação na escola sobre sexualidade, HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV*”. A maior parcela das respostas foi de concordância (64,7%), seguida pelas que não sabiam dizer (23,2%). As respostas de discordância foram menores (12,1%).

Dessa forma, é possível observar que a falta de informação na escola é latente, o que reforça os dados que demonstraram o interesse dos estudantes em relação ao tema.

Eneji *et al.* (2022) dialogam com nossa pesquisa ao constatarem que, embora alguns dados indiquem que estudantes do ensino médio aparentem ter certo conhecimento sobre HIV e AIDS, esse conhecimento ainda é pouco e insuficiente. A escola é o espaço no qual essas lacunas podem ser preenchidas, seja por meio de oficinas, seminários, do trabalho conjunto entre professores e estudantes e de um currículo direcionado nas mais diversas disciplinas.

Pinto e Telles (2000) consideram que a escola é o espaço no qual a formação sobre as questões relacionadas ao HIV e à AIDS deve ocorrer, entendendo ser um direito dos estudantes vivenciarem suas liberdades comprometidas com a saúde física e emocional. Louro (2013) nos provoca a pensar que a ausência de abordagens sobre a sexualidade e o que a circunda no contexto escolar contribui para uma formação que exclui, desconsidera as diferenças e reforça as desigualdades presentes nas relações entre sociedade, HIV e AIDS.

Os resultados obtidos nesta categoria revelam que a escola pode ser um espaço de sequestro (Foucault, 2015b) e de disputas (Arroyo, 2013). Retira os alunos da circulação no espaço social para utilizar o tempo com o intuito de estabelecer controle. O corpo e a sexualidade são alvos de uma fabricação que visa à normalização, a partir da lógica estabelecida pelo contexto cultural vigente. Para tanto, utilizam-se saberes que docilizam os corpos e as subjetividades, a fim de torná-los corpos obedientes (Foucault, 2014b).

Ainda assim, o interesse por certos assuntos, mesmo sendo ignorados, emerge na escola a partir das experiências dos estudantes, que, por vezes, podem ser vencidos ou silenciados (Arroyo, 2013).

4.11 Eixo 4: “Autoconhecimento como ferramenta contra o HIV”

Para caracterizar este eixo, foram considerados quatro enunciados. O objetivo foi conhecer a percepção que os/as estudantes tinham sobre a relação entre o conhecimento acerca do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas e a prática pessoal cotidiana.

No enunciado (1), buscamos saber se *“Em algum momento de sua vida, ao descobrir que tem HIV, seria tranquilo lidar com a questão, por saber que existe tratamento e que pode ter uma vida comum como as demais pessoas”*. A maior porcentagem das respostas foi de discordância (44%), seguida pela parcela que não sabia dizer (33,8%). A menor parcela concordou que seria tranquilo lidar com a descoberta de ser soropositivo (22,2%).

Os resultados indicam insegurança em lidar com a descoberta do HIV, evidenciada pela maior porcentagem de respostas que apontam para a dificuldade. Ao somarmos essas respostas com as daqueles que não sabiam dizer, observa-se que 77,8% dos estudantes expressam insegurança em relação a como seria viver sendo soropositivo, reforçando o impacto do desconhecimento apresentado.

Njuguna *et al.* (2023) apontam o estigma em relação ao HIV como um fator determinante na percepção dos/as estudantes ao lidar com uma possível descoberta de soropositividade. O estigma pode fazer parte do cotidiano vivenciado pelos estudantes, manifestando-se em fofocas e comentários que, no ambiente escolar, repercutem em medo, isolamento e rompimento de amizades.

Inman *et al.* (2024) assinalam o estigma internalizado como um fator que prejudica os jovens. A visão construída sobre o HIV interfere diretamente em como a pessoa acredita que será tratada, podendo gerar prejuízos à saúde física como resistência ao tratamento antirretroviral e à saúde emocional, como medo e depressão, entre outros.

Arruda *et al.* (2024) observam que, para alguns estudantes, o HIV pode não sinalizar insegurança, por saberem que a condição é tratável.

Quanto ao enunciado (2) *“Quando eu tenho alguma relação sexual, uso alguma proteção pela consciência de vivenciar minha sexualidade de forma segura e saudável”*, mais da metade das respostas foi de concordância (61,4%). Em seguida, apareceram as respostas de “não sei dizer” (29%), e uma menor parcela discordou (9,7%).

Os dados indicam a existência de uma suposta consciência e preocupação com o uso de alguma forma de proteção. Ainda assim, é possível considerar que a opção “*não sei dizer*” pode indicar incerteza quanto à constância do uso do preservativo. Somando-se esse grupo aos que afirmaram não utilizar proteção, os números aumentam, sugerindo que a utilização de métodos de proteção não é, necessariamente, uma prática consolidada na cultura dos jovens estudados.

Power *et al.* (2024) afirmam que a consciência sobre o uso de preservativos pode resultar, entre os jovens, no diálogo quanto à escolha de utilizá-los ou não na prática sexual. Considera-se que, ao utilizá-los, manifesta-se um senso de cuidado e preocupação com o outro. No entanto, há aqueles que utilizam a confiança nos relacionamentos românticos como justificativa para deixar de usar o preservativo.

Arruda e Pedrosa (2024) apontam que a parcela que não concorda com o uso de preservativos relaciona-se ao fato de os jovens não se convencerem do risco de não utilizá-los e da possibilidade de adquirir o HIV. Ressaltam, ainda, que as novas tecnologias, como a PrEP e a PEP, devem ser trabalhadas como formas atuais de prevenção, assim como o autoteste, recursos ainda pouco abordados com os jovens.

No enunciado (3) “*Não acredito que ter relação sexual desprotegida pode me trazer algum problema sexual*”, a maioria dos estudantes discordou (73,4%). Em seguida, apareceram as respostas de “*não sei dizer*” (15,9%) e um pequeno grupo concordou (10,6%).

Os dados indicam que, para a maioria dos estudantes, há a percepção de risco nas relações sexuais quando não são utilizados meios de proteção.

Knauth e Pilecco (2024) apontam que a percepção de risco que os jovens têm sobre o não uso de preservativos resulta de informações que possibilitam compreender as diferentes práticas sexuais e os possíveis riscos do contato com o HIV. Power *et al.* (2024) pontuam que há diversos fatores que implicam na escolha de utilizar ou não preservativos.

Entre esses fatores, o preservativo é mais frequentemente utilizado na prática sexual vaginal devido ao medo da gravidez indesejada. Já o não uso é pautado, muitas vezes, na percepção errônea de que a prática de sexo anal não sinaliza riscos, além da confiança na pessoa parceira como uma suposta forma de segurança.

No enunciado (4), em que buscamos saber: “*Se você já teve alguma relação sexual, responda se realizou ao menos uma vez ao ano o teste para saber sobre alguma IST (infecção sexualmente transmissível)*”, a maior parte dos estudantes respondeu que não realizou nenhum teste (75%). Em seguida, aparecem as respostas de “não sei dizer” (20,8%), o que permite supor que o teste é banalizado ou, simplesmente, não foi realizado. A menor parcela (4,2%) afirmou ter realizado ao menos um teste.

Os dados sugerem que a taxa de realização de testes para ISTs é baixa, evidenciando que a consciência e a percepção sobre a importância do cuidado não estão alinhadas à prática dos estudantes.

Estudos anteriores mostram possíveis relações que levam os estudantes a não realizarem testes. Williams Júnior, Bishop e Housman (2025) apontam que há, entre os jovens, a descrença de que possam estar vulneráveis quando não utilizam preservativos, o que repercute na baixa taxa de realização de testes. Soma-se a isso o fato de que a formação escolar não tem promovido uma cultura que naturalize a importância do teste como parte da agenda de cuidado e saúde, assim como ocorre com outras demandas cotidianas de autocuidado.

Karimi *et al.* (2025) indicam, como um dos fatores, o baixo grau de escolaridade ou mesmo a ausência de alfabetização, que, pela falta de conhecimento, levam as pessoas a não realizarem o teste, repercutindo na ampliação dos casos de HIV e AIDS. Outros fatores também contribuem para a fragilidade na formação de uma cultura de testagem, como a ausência do tema no currículo escolar (Kanyama; Lyakurwa, 2025).

A cultura pautada em religiões conservadoras e tradicionais pode dificultar a aproximação com o conhecimento sobre os testes e seu uso (Ayano *et al.*, 2025). Por outro lado, espaços de palestras e campanhas na escola podem colaborar para promover uma cultura ligada à prática (Oliveira; Marques; Santos, 2023), assim como o diálogo entre a escola e os familiares (Castro *et al.*, 2024). Soma-se ainda a influência das desigualdades de gênero, que recaem sobre as mulheres no não uso do preservativo, seja pelo desconhecimento, seja por relações de subordinação (Ratnawati *et al.*, 2024).

4.12 Conclusões do segundo estudo: “precisamos falar sobre a SIDA²¹ nas escolas”

Este momento da pesquisa partiu dos dados produzidos no primeiro estudo, que mostraram haver pouco e/ou quase nada, no currículo e nos materiais didáticos dos estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo, sobre questões que tratem de HIV, AIDS e pessoas soropositivas. Uma vez que esses temas não estão tão presentes no cotidiano escolar, buscamos identificar e analisar a percepção de estudantes do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas do interior do Estado de São Paulo, Brasil.

A partir de uma perspectiva metodológica quali-quantitativa, os resultados obtidos e a análise dos dados revelaram que os jovens e adolescentes do contexto pesquisado não têm uma percepção segura sobre o que é a AIDS, o HIV e a realidade das pessoas soropositivas.

A cultura que permeia a sociedade brasileira, marcada pela influência de políticas conservadoras, tem freado e barrado iniciativas alinhadas ao que a comunidade científica propõe como forma de eliminar a AIDS até 2030. Tais políticas repercutem na escola, produzindo discursos falaciosos e criando uma cultura pautada na culpa, no medo e na negação da sexualidade.

Todos esses dispositivos atuam por meio de tecnologias que visam à manutenção da lógica pregada: abstinência sexual, casamento monogâmico, sexo apenas após o casamento, entre outras ações às quais alguns conseguem se adequar, enquanto outros não.

Nas escolas pesquisadas, infelizmente, não existe um espaço em que as questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas possam ser dialogadas. A escola, por estar no núcleo da sociedade, é atravessada por políticas que negam o direito de jovens e adolescentes de terem acesso a conhecimentos que possam utilizar em suas escolhas e vivências sexuais e de sexualidade.

Nesse sentido, é importante reforçar que a escola pode desenvolver ferramentas necessárias de conhecimentos, atitudes e competências sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade (UNFPA, 2025). Ou seja, esse espaço contribui para melhorar as vivências de uma sexualidade mais

²¹ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, termo na tradução do inglês para o português de AIDS.

informada, mais responsável, mais gratificante e menos violenta e discriminatória (Russell *et al.*, 2021).

A escola é também um espaço de forças. Por mais que esteja atravessada por políticas negacionistas, é possível perceber que, além de haver corpos-estudantis que desobedecem à lógica imperativa que a escola tenta produzir, há professores que fissuram essas estruturas. Assumem o risco de serem perseguidos, filmados, entre outros mecanismos de paralisação, que operam controlando a liberdade de ensino, por entenderem ser importante levar aos estudantes os assuntos que defendemos neste artigo.

Os dados e a análise, pautados nos mais diversos estudos e pesquisas, convergem em um mesmo caminho: a escola é o espaço primordial para que tais assuntos sejam tratados. Diversas são as formas e os meios pelos quais é possível construir um currículo que alcance o cotidiano social de jovens estudantes, seja por meio de materiais didáticos, oficinas, projetos, campanhas, rodas de conversa, palestras com a participação de pessoas soropositivas, entre outras possibilidades que a prática docente pode criar.

Mais do que conteúdos, é importante que a escola não adote uma postura apenas discursiva e protocolar. Espera-se que o espaço escolar ajude a desenvolver a consciência crítica, colaborando para a formação de sujeitos ativos e capazes de transformar a realidade social no sentido de uma sociedade assente nos princípios da igualdade e da equidade (Freire, 2013).

Realizar campanhas que falem sobre a AIDS não é suficiente para que o HIV seja efetivamente conhecido no contexto escolar. São necessários trabalhos desenvolvidos em diferentes momentos e de forma contínua, nos diversos componentes curriculares. Além disso, é fundamental estar alinhado a outras instituições que possam potencializar esse trabalho, aproximando os estudantes dos centros de atendimento, dos profissionais que atuam nesses espaços, entre outras ações que contribuam para naturalizar os serviços de saúde, fazendo com que sejam reconhecidos e ocupados por todos esses estudantes.

É importante que a escola dialogue com os meios de acesso que os estudantes podem adotar para participarem de uma cultura da não domesticação e do não depósito de conhecimentos (Freire, 1970), encorajando, assim, a visão crítica. É ultrapassado o fato de que a PrEP e a PEP ainda sejam desconhecidas e não estejam sob o uso de jovens e adolescentes.

Não obstante, observa-se também a ausência, na agenda dessa geração, de uma cultura de cuidado que incluía a realização regular de testes. Muitos jovens, ao terem contatos sexuais de forma desprotegida, não avaliam o ato de se testar como algo importante.

Ainda assim, alguns limites impossibilitaram que nosso conhecimento fosse mais amplo, nomeadamente, manifestações de desinteresse por parte de alguns estudantes em participar. Houve também situações de rejeição da participação associadas a crenças religiosas. A esse propósito, pode-se observar, por exemplo, que, quando a turma iniciou a pesquisa, uma estudante pegou um terço e começou a rezar, optando por não participar da pesquisa.

Contudo, percebemos também a importância da pesquisa e como ela abre perspectivas para o futuro. Em particular, torna-se relevante aprofundar estudos sobre onde os estudantes buscam informações e conhecimentos acerca do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas, bem como sobre como essas informações são interpretadas, a partir do crer e do não crer, considerando a cultura negacionista e conservadora.

Além disso, aprofundar o conhecimento sobre a percepção que os professores têm a respeito do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas possibilitaria uma visão mais ampla sobre o que os estudantes sabem ou deixam de saber. Os deslocamentos, as barreiras, entre outros aspectos, poderiam indicar possíveis respostas em diálogo com os resultados encontrados junto aos estudantes.

Os dados do quarto eixo, demonstra como a crença de que o HIV é algo distante e, de certa forma, silencioso, condiciona as pessoas a não procurarem os espaços de saúde e os locais que vendem ou disponibilizam gratuitamente os testes. Ao não se testarem, correm o risco de desenvolverem o HIV e, não obstante, nas trocas de parcerias sexuais, colocarem outras pessoas em contato com o vírus, mantendo elevados os índices de pessoas que vivem soropositivas sem saber que estão soropositivas.

Falar sobre as possibilidades existentes e sobre os meios que podem ser utilizados contribui para a criação de sentidos e razões que permitem redesenhar, de forma positiva, o estigma, os tabus e as visões sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

Na realidade dos jovens, muitos atravessamentos acontecem o silêncio motivado pelo medo e a ausência de um espaço seguro na família são barreiras que podem ser superadas quando se torna possível falar sem receio, vergonha ou reprovação.

Seguimos para o terceiro estudo, considerando os dados produzidos até aqui, nos quais se percebe a existência estrutural de uma ausência significativa dos temas relacionados ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas nos documentos e materiais da Educação do Estado de São Paulo.

Não obstante, as percepções das/os estudantes que seguem sua formação no Ensino Médio do Estado de São Paulo mostraram-se vulneráveis, repletas de contradições e marcadas pela ausência de saberes que possam auxiliá-los/as em seus cotidianos e experiências sexuais.

Com o próximo estudo, será possível compreender o impacto dessas ausências a partir das experiências narradas pelas pessoas soropositivas participantes da pesquisa, que passaram pelo Ensino Médio em escolas do Estado de São Paulo.



5 TERCEIRO ESTUDO: NARRATIVAS PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO

“Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história”

Hannah-arendt

5.1 Primeiras palavras que introduzem ao terceiro estudo

No ano de 2024, o Brasil e o mundo foram presenteados com a produção cinematográfica do filme *Ainda estou aqui*, produzido por Walter Moreira Salles Jr. O filme retrata a história de Eunice Paiva, que buscava incessantemente seu marido desaparecido durante o regime ditatorial no Brasil. Rubens Paiva, marido de Eunice, era deputado e não se alinhava ao regime, sendo perseguido, capturado e desaparecido.

Em um momento do filme, Eunice expressa o sentimento de ter sido assaltada pela ditadura ao dizer que a “tática do desaparecimento é uma das mais cruéis, porque mata-se uma pessoa e condena todas as outras a uma tortura psicológica eterna”. Ao dizer isso, ela se referia a si e a seus filhos e filhas. Não houve um corpo para dizer que estava morto, ou para ao menos se despedir.

A AIDS foi a ditadura encarnada pelo vírus do HIV. Tirou de cena pessoas, lançando suas memórias ao esquecimento. No tempo atual, há uma certa sensação de que a história da AIDS caiu no esquecimento. O que restou foram recortes distorcidos, repletos de inverdades, que ainda produzem sofrimento por meio das relações de preconceito e estigma. Outras permanecem lembradas por amigos e familiares, no particular de suas lembranças, e ao público aparecem como uma nota de rodapé que, vez ou outra, surge.

Na era das tecnologias e mídias, às vezes sociais, as inúmeras informações e desinformações estão direcionadas por algoritmos que ditam e entregam, a partir do interesse das pessoas consumidoras, o que saberemos, como sabemos e a qualidade que esse saber implica na realidade. Soma-se a isso o crescimento cada vez maior da invasão do Movimento Negacionista Cristão (MNC) na sociedade e nas redes não sociais, tornando territórios livres e públicos em espaços que legitimam o desrespeito,

a violência e a propagação de inverdades, desconsiderando ideias, pessoas e tantas outras percepções, superadas pelo tradicionalismo moral que conjurou a história humana às aberrações limitadas de percepções que produzem o fanatismo e o terrorismo contra a democracia e as vidas humanas.

A “meta” é retroceder as vivências gays, as pessoas trans, as questões de gênero e, de certa forma, todas as pessoas que constituem grupos desprivilegiados, a serem banalizadas como vidas não humanas, ao ressentimento de seus desejos reprimidos e sádicos. Das informações, temos as cruéis invenções sobre o vírus do HIV, pautadas mais pela relação com a sexualidade, implicando nas questões morais que estruturam a sociedade, do que naquilo que a ciência já resolveu e vem, a cada dia, se aproximando de novas e melhores formas para as pessoas soropositivas e para toda a população de soronegativos. A história já foi desmascarada, incidindo em uma epidemia de vírus social, e não mais biológico.

Fato é que pessoas soropositivas ainda seguem aqui, ali e em todo lugar. Muitas vivem sob o sigilo, pela insegurança e pelo medo de serem descobertas, como se suas vidas tivessem uma marca que repele. Outras se resguardam de assumir sua condição pela visão dos espaços em que vivem, por estarem colonizados de preconceitos. Todavia, existem muitas histórias, sobretudo as falas que ouviremos neste estudo, que nos ensinam a partir de suas vivências, proporcionando-nos exemplos e conhecimentos que mostram que há vidas para além dos muros do preconceito.

Na atual conjuntura, segundo a publicação do Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS (2024a), edição especial de dezembro, sinaliza-se que, até o mês de junho, houve 19.928 pessoas detectadas com HIV. De 2007 a junho de 2024, houve 541.759 notificações de pessoas que vivem com HIV no Brasil. No que concerne à AIDS, até o mês de junho de 2024 foram registrados 17.889 casos, totalizando, desde o ano de 1980 até junho de 2024, 1.165.599 casos.

Dito isso, podemos seguir dizendo que “ainda estamos aqui” para trazer, a partir das narrativas de pessoas que conseguiram e puderam resistir à ditadura, que no passado determinava a vida das pessoas que, ao contraírem o HIV, tinham poucas chances de seguir a vida. No tempo atual, a possibilidade de seguir vivendo, embora borrada pelo sistema social e cultural que disputa tentando impedir que sejam deflagrados os preconceitos e as estigmatizações, sobretudo no contexto educacional

escolar do ensino médio, possibilita aos estudantes o direito de reescreverem a história do HIV e da AIDS.

Primeiro, buscamos trazer a realidade da descoberta de um “mundo novo”. Nas sociedades brasileiras, a construção do que é viver soropositivo ainda é capturada por ideias de um “corpo estranho”. Seguimos, indignadas/os, relatando narrativas que comprovam as consequências da construção do “corpo estranho”. A estranheza é, por um lado, a negação de um corpo feito pela diferença e, por outro, o desconhecimento de que não há corpos estranhos, e sim percepções estranhas, contaminadas por uma cultura limitada que não forma para as diferenças.

Na continuidade, trouxemos as contribuições da família, estas como “pedagogia do medo”. O medo não apenas em criar o terrorismo sobre o sexo e a sexualidade, mas também o silenciamento. O silêncio, como o não dizer, é não existir, é não precisar adentrar o espaço do que, no passado, já vem sendo recusado.

Seguimos buscando saber o papel da escola, na ausência da família, em dar a formação necessária para o “uso dos prazeres”. As narrativas, de forma unânime, mostram que a escola, semelhante à família, não se preocupou em formar para as questões sobre HIV e AIDS, mas, principalmente, para a possibilidade de um viver soropositivo. A negação de abordar tais assuntos sinaliza, com as pessoas participantes da pesquisa, a chance de estarem em perigo e em sofrimento, por ser um mundo novo que não foi apresentado na teoria, sendo ingressado apenas na prática.

Por fim, as falas nos ajudaram a pensar em como a educação pode possibilitar um sorotransgredir. Falar sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem soropositivas não está na esfera de incentivar o uso dos prazeres, e sim de dar subsídios para a consciência crítica, formando para a autonomia nas escolhas e para a liberdade do ser e estar em sociedade, pelo cuidado de si, para uma estética do existir.

A base teórica que utilizamos para refletir sobre os dados parte do pensamento foucaultiano e de pesquisas e ideias que se compactuam, ainda que se questionem e não se homogeneízem, enquanto pensamentos que se reservam a serem singulares. Ambas entendem e dialogam com o objetivo e os dados da pesquisa. Isso, visando conduzir de forma coerente o objeto de estudo e a base a partir da qual o estudo é analisado.

Concluimos realizando as considerações do que pode ser a pedagogia soropositiva das diferenças. Partimos da ideia de que todo corpo é diferente. Tal

diferença não é restrita aos acidentes construídos culturalmente e biologicamente. O corpo é, em seu princípio, diferente, único e potente. A pedagogia, nessa direção, possibilita educar as percepções para não limitar os corpos a partir dos discursos que os determinam, sobretudo os negacionistas, os desinformados e os moralistas.

5.2 Percurso metodológico

O objetivo, nesta etapa da pesquisa, é compreender, a partir de narrativas de pessoas soropositivas egressas do ensino médio, o que aprenderam na escola sobre HIV/AIDS, principalmente o que as auxiliou em suas vidas após serem positivadas e terem que estar no convívio social. Alguns desdobramentos, feitos por meio de questões problematizadoras, aparecem na investigação, buscando ampliar e perceber se, no decorrer do percurso formativo no Ensino Médio, as questões sobre sexualidade, HIV, AIDS e a vivência de pessoas soropositivas apareceram. Caso tenham aparecido, de que forma foram abordadas? E se essas questões, ao serem tratadas, colaboraram para suas vivências com HIV?

Para tanto, optamos por utilizar a pesquisa pautando-se na caracterização qualitativa, por entendermos que o conhecimento almejado, neste momento da pesquisa, está na busca por compreender as experimentações, representações e a profundidade com que cada pessoa vivencia sua história e existência, considerando que a vida é um experimento das escolhas humanas que cada pessoa faz ao se inserir no mundo, nos diferentes contextos, sejam eles geográfico, temporal, cultural, econômico, político e social (Goldenberg, 2013).

Destacamos que em todas as escolhas há efeitos e que, no contexto metodológico, tais efeitos se colocam como recortes que podem sinalizar possíveis limitações. Ao optarmos por narrativas de pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, delimitamos um campo específico de experiências, sem a pretensão de obter respostas que possam universalizar os dados produzidos. Ainda assim, os dados produzidos possibilitam evidenciar produções situadas de saber.

Na tentativa de situar a pesquisa qualitativa, é possível entendê-la como localizada no mundo externo, como um laboratório de acontecimentos. Isso implica pensar o mundo como um espaço de acontecimentos produzidos pelo meio ambiente

e pela humanidade, ambos em relação, que são atravessados por problemas que podem ter explicações nas mais diversas abordagens.

Nesse sentido, reconhecemos que o trabalho empreendido com a pesquisa não é neutro. Isso porque o ato de pesquisar está atravessado pelas escolhas que a pessoa pesquisadora faz. O pesquisador, ao estar inserido no campo dos acontecimentos em que a pesquisa/dados se localizam, define quais destes acontecimentos serão considerados, quais vozes serão ouvidas e quais recortes serão privilegiados.

Flick (2009), ao responder à questão “o que é a pesquisa qualitativa?”, reflete sobre alguns pontos que merecem ser destacados para que entendamos o percurso metodológico da pesquisa, seguindo outros/as estudiosos/as que, ao escreverem sobre a pesquisa qualitativa como metodologia científica, contribuem com diversas compreensões, colocando a pesquisa no campo social como um devir heraclitiano²².

Segundo o sociólogo, a pesquisa qualitativa não se limita a uma identidade fixa; sua especificidade é o mundo, o múltiplo; sua explicação possibilita responder por vários olhares, sentidos, métodos e abordagens; tem interesse nas experiências dos mais variados grupos e pessoas, em como se constroem a si mesmas e o seu entorno; nas significações que produzem nas várias formas de perceber o mundo; o conflito é a ordem que possibilita a riqueza de dados a ser conhecida e explorada, podendo ser utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento.

Denzin e Giardina (2016), ao organizarem o compilado de estudos intitulado *Qualitative Inquiry through a Critical Lens*, propõem pensar a pesquisa como qualitativa crítica, ao entenderem que novas questões têm emergido na sociedade e que há urgência em repensar as diretrizes que têm estruturado a pesquisa e as metodologias, com uso político e ético, na coerência em construir um saber crítico, aliado à justiça social e à descolonização nas formas como se tem concebido o fazer e o ser pesquisa no campo social e acadêmico.

Na mesma direção, Johnson e Parry (2022), no livro *Fostering Social Justice through Qualitative Inquiry*, colaboram com vários estudos, pensando a justiça social como base para pesquisas de cunho qualitativo. A perspectiva apresentada na obra

²² O devir, neste contexto, representa o movimento que repercute em mudanças: a mesma pesquisa, ao ser realizada por outra pessoa e sob outra perspectiva, será diferente. Cada pessoa, ao se inserir no campo investigativo, é outra, não é a mesma. O próprio objeto a ser pesquisado muda, transforma-se, traz dados novos; nós somos e não somos, devido às mudanças que nos atravessam e pelas quais somos atravessados, seja por novos saberes, seja por novas perspectivas (Reali; Antiseri, 2003).

fissura a incoerência, muitas vezes presente nos discursos acadêmicos, ao pensar a realidade a partir de uma suposta neutralidade, abdicando da percepção de grupos e pessoas em situação de marginalização e/ou resultantes de relações de poder, nas quais alguns se sobrepõem a outros, culminando em relações de opressão.

Diante dessa conjuntura, a posição das pessoas pesquisadoras é a de uma postura que se alia à justiça social no processo e no resultado da pesquisa. Isso não significa que haja uma “contaminação”, mas, ao contrário, uma visão crítica na busca e no desenvolvimento dos dados e na elaboração do conhecimento.

Tal posicionamento, contudo, não diminui as tensões metodológicas. Uma vez que implica assumir uma perspectiva situada, que orienta o olhar analítico empreendido pelo pesquisador. Concomitantemente, o olhar está sob o crivo das limitações desse contexto. Resultando em outras perspectivas que podem não aparecer, por não terem sido contempladas para este estudo.

Feitas essas considerações, a pesquisa qualitativa, no contexto deste estudo, alinha-se à sua proposta, ao buscarmos saber como as pessoas que compõem esta investigação percebem, constroem e nos ajudam a entender, a partir das significações que, no decorrer do percurso, entenderam como soropositivas, os movimentos e devires que a condição sorológica e a relação com a sociedade, costuradas, puderam resultar em existências não conhecidas ou não reconhecidas, que passamos a saber.

Assim, a produção dos dados que resultaram neste terceiro estudo não visa representar todas as perspectivas das pessoas soropositivas. Cada pessoa vivencia sua experiência sorológica de forma particular, embora possa se repetir em várias outras experiências. Contudo, o que procuramos fazer é situar a produção dos dados, considerando as escolhas metodológicas e a relação entre a pesquisa, o pesquisador e as pessoas participantes da pesquisa.

5.3 Isso não é uma entrevista com um vampiro: somos soropositiva/o

O entendimento geral sobre entrevista é o de uma conversa com pelo menos duas pessoas, uma delas busca colher determinadas informações de outra, em um contexto no qual se sabe que a pessoa entrevistada pode dizer ou responder aquilo que o/a entrevistador/a busca compreender por meio de perguntas direcionadas à pessoa respondente. Na pesquisa, ela é utilizada como uma técnica de coleta de informações/dados, pautada em métodos para atingir os objetivos propostos.

Marconi e Lakatos (2021) definem a entrevista como uma conversa de ambas as faces, conduzida de maneira postulada, podendo ser verbal ou não, na busca de coletar informações almejadas pelo/a entrevistador/a em um contexto marcado por algum problema social. Gil (2019, p. 109) conceitua a entrevista como “uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”.

Definido o que é entrevista, precisamos entender uma de suas formas de caracterização: a semiestruturada. A entrevista, como já dissemos acima, comumente trata-se de uma conversa proposital que busca conhecer determinado assunto com outra pessoa. Semiestrutar a entrevista é elucidar um roteiro elaborado previamente, a partir de assuntos que objetivam saber com quem se entrevistará. Algumas/uns autores colaboram, a partir de suas experiências em pesquisa, sobre o uso de entrevistas semiestruturadas, o que, ao tomarmos nota, nos auxiliou no percurso metodológico desta pesquisa.

Belina (2023), ao realizar o estudo intitulado *Semi-Structured Interviewing as a Tool for Understanding Informal Civil Society*, buscou compreender como a sociedade civil informal, sobretudo pessoas autodenominadas ativistas, se expressa para além dos discursos que frequentemente circulam na sociedade. Segundo a autora, a entrevista semiestruturada mostrou-se eficaz por coletar percepções não reveladas no cotidiano social e que, muitas vezes, permanecem incompreensíveis, devido à falta de conhecimento sobre determinadas questões resultantes de pessoas atravessadas por problemas que pouco são visitados ou que não são colocados como pautas na busca de soluções.

O estudo de Belina e o uso da entrevista semiestruturada em sua pesquisa dialogam com a nossa investigação, ao nos colocarem frente aos desconhecimentos sobre a percepção escolar de pessoas soropositivas, podendo ser uma possibilidade de ouvir o que a sociedade, sobretudo a educação, tem ignorado.

Outro estudo que trata sobre a entrevista semiestruturada, realizado por Adeoye-Olatunde e Olenik (2021), intitulado *Research and Scholarly Methods: Semi-Structured Interviews*, atribui à entrevista semiestruturada o papel de um mecanismo que possibilita autonomia à pessoa pesquisadora, ampliando seu campo de investigação ao propor considerações e outras questões no decorrer da coleta de dados (na entrevista), mesmo estando em posse de um roteiro direcionador.

A averiguação feita por ambas as pessoas pesquisadoras nos interessa pelo fato de que, ao procurar saber sobre a trajetória escolar de pessoas soropositivas, possivelmente algumas questões podem soar de forma sensível e, assim, precisar ser ressignificadas, retomadas ou reformuladas, a fim de alcançar o objetivo da pesquisa, sem produzir qualquer situação que possa prejudicar o processo investigativo.

Na mesma direção, e com alguns questionamentos que o estudo apresenta e que nos fazem pensar o contexto da nossa pesquisa, Villarreal-Puga e Cid García (2022), ao realizarem *La aplicación de entrevistas semiestructuradas en distintas modalidades durante el contexto de la pandemia*, buscaram saber se haveria alguma implicação no formato de realização das entrevistas semiestruturadas no contexto da pandemia de Covid-19.

No presencial, a coleta das falas soma-se aos gestos e a outras linguagens que são produzidas no acionar dos temas-questões, o que, no formato on-line, poderia ser prejudicado. No entanto, as pessoas pesquisadoras do estudo deixam claro que, mesmo com algumas limitações quando se opta por utilizar recursos on-line, a forma como a entrevista é conduzida é o que ditará o êxito da pesquisa e dos dados coletados.

Postas essas considerações, trouxemos outro estudo, no intuito de avaliarmos o uso das entrevistas semiestruturadas. Kakilla (2021) realizou um estudo intitulado *Strengths and Weaknesses of Semi-Structured Interviews in Qualitative Research: A Critical Essay*. Ao considerar os pontos fortes (a) e fracos (b), o autor elenca algumas questões que sintetizamos:

a) possibilidade de conversas profundas; a entrevista, em seu percurso, pode ser analisada de forma crítica, possibilitando inflexões na busca por centrar o objetivo da pesquisa; multiplicidade de linguagens que podem ser analisadas como material de dados.

b) a timidez como uma barreira na produção de falas-dados; respostas rasas e limitadas; o descontrole na condução da entrevista pelo/a entrevistador/a; respostas limitadas resultantes de questões culturais; fragilidade do/a entrevistador/a ao se emocionar com o que ouvirá nas falas.

Contudo, podemos refutar os pontos que, ao ver de Kakilla (2021), colocam as entrevistas como fracas. A pessoa que utiliza a entrevista, antes, precisa obter uma formação. Essa formação não necessariamente precisa ser em formato de curso, mas

pode ocorrer por meio de leituras, busca de estudos, conversas com outras pessoas que utilizaram o instrumento em pesquisa e, sobretudo, pela autorreflexão.

Vejamos o exemplo de um aparelho celular: para ser utilizado, antes é preciso ter conhecimento sobre como funciona, quais são as funções de cada botão ou tecla, e assim por diante. Ou seja, observar a pessoa candidata a participar da entrevista, no primeiro contato se é tímida, se as questões culturais sinalizam pontos que podem não colaborar com a pesquisa, são alguns exemplos a serem considerados.

Dadas essas respostas, cabe ao/à pesquisador/a escolher se determinada pessoa será ou não apta a participar da pesquisa. O roteiro foi elaborado com antecedência e testado? O descontrole existe naquilo que não conhecemos. A preparação colabora para que, mesmo diante de surpresas, o controle se mantenha. As emoções podem existir, devido ao fato de sermos humanos. Contudo, colocar-se no papel de pesquisador/a é saber em quais momentos as emoções podem extravasar. Isso não quer dizer que precisamos ser frios, mas cirúrgicos, como apresentaremos mais adiante.

Em uma visão geral, é sabido que todo e qualquer instrumento utilizado na pesquisa tem suas fragilidades e potencialidades. Porém, cabe ao/à pesquisador/a avaliar previamente, dentro do contexto da pesquisa a ser realizada, se as fragilidades são maiores ou comprometem o êxito da investigação. Ao fazermos esse levantamento, entendemos que a entrevista semiestruturada é adequada para o uso no objetivo que esta pesquisa almeja.

Ainda assim, não descartamos o fato de que, ao utilizarmos a entrevista semiestruturada, nos depararíamos com limites. Tais limites são reconhecidos, como o uso da memória; o encorajamento das pessoas que participam da pesquisa em compartilhar suas experiências pessoais; as condições em que essas narrativas são produzidas. Todas essas limitações podem influenciar de algum modo os dados produzidos.

5.4 Do roteiro-coletador a performance-pesquisador: a construção do roteiro e o preparo na atuação nas entrevistas semiestruturadas

O processo de elaboração do roteiro, assim como o percurso metodológico, foi impregnado de questionamentos, no intuito de fazer pensar os desdobramentos, seja sobre como a pesquisa seguirá, seja sobre quais dados ela produzirá. Nesse

processo autorreflexivo, apareceram algumas ideias que, ao serem estudadas, materializaram o corpo que pensamos para o roteiro (as questões) e para a atuação na entrevista, no papel de pesquisador.

Dessa forma, explicaremos como nos pautamos e o que consideramos para construir o roteiro das entrevistas. Na sequência, ousamos nos apropriar de outros saberes, na intenção de construir o papel performático do pesquisador para atuar nas entrevistas, buscando na psicanálise aparatos para essa atuação.

5.5 Encontros como entrevistas semiestruturadas

Dar o nome de encontro como um dos processos que compõem a metodologia para produzir os dados da pesquisa é uma forma de criar um espaço de afeto, onde as palavras podem ser colocadas sem restrições, medo ou inseguranças. No sentido em que utilizamos, o encontro é o de encontrar-se com alguém que está disposto a ser-palavras para um outro ser-ouvidos.

Ainda que se faça toda uma tentativa de significar o espaço para a produção dos dados, não se descarta o fato da existência de assimetrias. Isso porque o pesquisador sinaliza as intenções e objetivos que seu papel representa, influenciando assim o que as pessoas participantes dirão e o que possivelmente ficará guardado, sinalizado pelos silêncios.

Nas linhas introdutórias, dissemos que a base teórica que pautamos nesta pesquisa é o pensamento foucaultiano e pós-estrutural. Ambos, por proporem um pensamento que se alinha ao que esta pesquisa busca saber. Nessa perspectiva, ao elaborar o roteiro, buscamos refletir sobre como o pensamento pós-estrutural pode nos ajudar na forma como as perguntas, intencionalmente, poderiam ser construídas, com o objetivo de alcançar os dados previamente pensados e também aqueles que podem ser esperados, considerando as diferenças e subjetividades que cada pessoa, ao produzir os dados (falas), traz consigo, sendo também interessantes como material para análise deste estudo.

Dutra (2010), ao realizar a pesquisa intitulada “Pós-estruturalismo e pesquisa: algumas pistas para investigação em educação ambiental”, possibilitou pensar a educação ambiental a partir das bases pós-estruturalistas na pesquisa. Embora o estudo faça um recorte da educação ambiental, a metodologia utilizada pela pesquisadora são as entrevistas semiestruturadas, sinalizando que pudemos obter

considerações feitas no estudo e incorporá-las ao que propomos em nossa pesquisa, partindo de questões do “como”, mais do que do “o que” e do “por que”, ao priorizar a busca por compreender como são construídos e ressignificados os movimentos humanos e na/da sociedade.

Junto à contribuição que Dutra (2010) faz, Ferraz e Mendes (2021) colaboram para pensar a construção do roteiro. Cada fala nas entrevistas representa uma das várias maneiras de saber sobre as vivências soropositivas e o contexto educacional. Ou seja, a linguagem que cada pessoa soropositiva utiliza responde a determinado tempo, espaço e contexto em que esteve inserida. Isso nos faz considerar que existe, em cada fala, um movimento que representa como cada pessoa vivenciou sua trajetória de vida soropositiva.

Outro fato que se soma é o de que não há uma visão única e universal sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas. Não há uma verdade, e sim verdades sobre essas questões, sobretudo uma não verdade hierárquica: a médico-científica sobre a soropositiva-científica. Ou seja, não são os saberes do “centro” que se impõem aos saberes “periféricos”. Saberes são a pluralidade de visões acerca do que está sendo produzido enquanto conhecimento.

Essas considerações são propositais, ao pensarmos a metodologia como uma maneira de preparar o terreno para aquilo que queremos movimentar, enquanto a dança dos movimentos das existências que cada pessoa faz e de suas falas, como uma cantoria que alude à representação de vivências-saberes que consideramos, após contextualizar e propor outra vertente de entendimento sobre o que, costumeiramente, tem-se acreditado e realizado como ciência.

Deste modo, cada fala representa um saber em movimento, autêntico e válido, e o roteiro, ao ser construído, propôs-se a ser o ímã a atrair as falas, para sabermos o como das significações que cada pessoa soropositiva construiu. Ainda assim, é possível que este espaço tenha assimetrias. A presença do pesquisador sinaliza a pesquisa, o objetivo que se almeja com o encontro, influenciando as narrativas que as pessoas soropositivas podem dizer, como aquelas que ficam omitidas.

Ao pensarmos em como poderíamos realizar as perguntas, na coerência com o que o estudo está tentando construir, a perspectiva pós-estrutural e Foucault nos ensinam que o resultado das relações não é neutro: elas estão permeadas por poderes, disputas e negociações que as pessoas, em sociedade, travam, produzindo significações que, na singularidade, toda pessoa humana constrói. Isso nos mostra

que as relações e vivências humanas em sociedade nunca são fixas, pois estão em movimento de transformações ocasionadas pelas disputas e pelas relações de poder.

No entanto, em toda relação de poder há também contrapoderes, resistências e ressignificações que, na história, produzem fissuras capazes de desmontar o imaginário das ideias prontas, universais, fixas, binárias e negacionistas, entre tantas outras.

E isso nos chama a atenção para o fato de que a pandemia de AIDS foi uma “novidade” para o mundo, que causou (e ainda causa, em menores proporções) perigo à vida humana e caos às instituições, exigindo a busca por um saber sobre a infecção, mas que se utilizou desse saber como uma estratégia de poder sobre os corpos. Ou seja, a descoberta deu-se sobre o corpo biológico, e a repercussão fez-se por uma colonização do corpo social, que ainda carece de ser desconstruída (Dutra, 2010).

Assim, ao buscarmos entrevistar pessoas soropositivas, nossa intenção não é saber o quê no sentido de interrogar, nem, da mesma forma, o porquê, ao buscar a causa. E sim o como, que busca, na ação, conhecer os modos significativos e flexíveis que acompanham e fazem da vida humana um ser-diverso e diferente, como modos de ser e estar no e com o mundo (Cegalla, 2020).

As distinções que pensamos a partir do “o que”, “por que” e “como” são para elucidar o propósito de conhecer como as pessoas soropositivas construíram o curso dos significados resultantes de suas vivências e as significações das coisas ao se relacionarem com o mundo antes e após estarem positivadas, considerando o percurso formativo como algo que possibilitou alguma intervenção.

5.6 Elementos para construir o roteiro

Uma vez delineado como nos pautamos para construir o roteiro, o próximo passo foi entrar em contato com materiais que, ao tratarem das questões de HIV, AIDS e das pessoas soropositivas, nos fizeram pensar os “comos” poderiam estar presentes nas perguntas e nas provocações no decorrer das entrevistas. A forma como classificamos quais elementos, ao serem acessados, nos impeliram a pensar os “comos” presentes no roteiro não seguiu uma ordem temporal, geográfica, de área de conhecimento ou qualquer outra. E sim o desejo e a curiosidade, como um impulso de querer adentrar em um universo de possibilidades, de fantasiar e criar realidades

a partir dos encontros e desencontros que nos inspirariam, sendo esse o nosso único critério a seguir.

Esse critério, embora potente por se colocar no campo criativo, não se exime de delimitações ao campo em que a pesquisa se movimenta. Isso é visto a partir dos repertórios que tiveram maiores privilégios, como os culturais e de experiências, e outros que poderiam ser acessados, mas por essa escolha não foram privilegiados.

Isso resultou em muitos materiais que nos colocaram em movimento de criação, como documentários, filmes, séries, cursos, livros, o estágio docente em uma disciplina da medicina e dois estudos que publicamos em periódicos. Abaixo, criamos um quadro que sintetiza o núcleo que utilizamos para a elaboração do roteiro do questionário para as entrevistas.

Quadro 9 - Material para criação das entrevistas semiestruturadas

Material	Nome	Resultado da observação
Documentários	Carta para além dos muros; Globo repórter – a explosão da Aids no Brasil.	Contexto histórico, de vivências das pessoas soropositivas, de médicos que atuaram no decorrer na história da infecção, as mudanças do passado para os dias atuais, a ausência de uma vertente educacional na colaboração com a saúde para o uso da sexualidade sem prejuízo.
Filmes	Clube de compras Dallas; The normal heart; Holding the man; Cazuza; Bhoemian rhapsody; Os primeiros soldados.	Um misto de sentimento e romantismo, o amor atravessando o tempo do passado ao presente, o quanto a aids ceifou histórias e vidas, o enfrentamento, os negacionismos sobre a infecção e as pessoas soropositivas e a importância de uma educação para minar os contágios e superar os preconceitos e estigmas.
		O processo e a trajetória de grupos mais vulneráveis que são prejudicadas pelo HIV e

Séries	Pose; Elite; Todas as flores.	AIDS, o racismo, sexismo, transhomofobia, o sofrimento em lidar com a doença e o vírus, assim como a ausência de formação educacional como uma vertente para enfrentamento.
Curso	Zero discriminação HIV e AIDS.	O curso realizado em parceria com a UNAIDS e a Universidade do Rio Grande do Sul, reunindo pesquisadores das diversas áreas e profissionais que trazem uma série de conhecimentos sobre o HIV, a aids e as pessoas soropositivas. A importância da formação para a criação de conhecimento para zerar a discriminação da HIV e AIDS.
Livro	Aids e escola	O livro datado em 2000, reuni uma série de reflexões sobre as possibilidades e importância de levar a aids como uma pauta nas discussões escolares e educacionais.
Estágio docente	Disciplina no curso de medicina – doenças infectocontagiosas.	A abordagem e conhecimentos técnicos sobre o vírus e a infecção, a realização de estudos clínicos e a operacionalização, e a observação, que resultou em não haver qualquer questão que leve a uma abordagem humanista sobre as pessoas soropositivas.
Estudos realizados	Dois artigos realizados e publicados: Políticas e relevância científica da pesquisa; Pensamento decolonial e HIV e aids: para pensar territórios sustentáveis e saudáveis no SUS.	O primeiro estudo tratou em analisar as políticas que no decorrer da história do Brasil se preocupou com as questões de HIV e AIDS, sinalizando os últimos anos de governo como os mais trágicos da história pela diminuição das investidas sejam elas em dinheiro como de

		políticas de prevenção. O outro estudo mostra como os espaços do SUS ainda são territórios de estigmas e preconceito, propondo uma formação atualizada, utilizando do pensamento decolonial como uma vertente de desconstrução e desnaturalização para as práticas em saúde.
--	--	--

Fonte: O autor.

Nesse movimento de observação, percebemos que a ausência de uma educação que promovesse conhecimentos sobre as vivências sexuais e sobre as sexualidades, sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, como uma possível forma de propiciar a preservação e a desconstrução de estereótipos, tornou-se nossa direção para a elaboração das perguntas que compõem nosso roteiro de entrevistas, como pode ser observado abaixo:

5.7 Roteiro com as perguntas

Data da entrevista ____/____/____

Participante _____

Idade _____

Como se auto reconhece sexualmente? _____

Como se auto denomina cor/etnicamente? _____

Você se lembra a data que cursou o Ensino Médio? _____

- 1- Durante o seu período de escolarização na educação básica, você se recorda o que e/ou como foram abordadas as questões sobre HIV-Aids e pessoas soropositivas?
- 2- Se sim, explique um pouco sobre o que você se lembra. Se não, como você considera que essas questões podem ser abordadas para as/os jovens dentro da escola?

- 3- O conhecimento desenvolvido nas aulas ou temas que você vivenciou na escola sobre HIV-Aids e pessoas soropositivas te auxiliou nas suas vivências antes e/ou após você receber o diagnóstico? Como foi esse processo? Caso não tenha sido desenvolvido nenhum conhecimento, como você estruturou sua aprendizagem sobre esses temas?
- 4- Na condição de pessoa soropositiva, como você percebe situações de preconceitos e estigmatizações feitas a você?
- 5- Percebia algo no período escolar? Ou, após? Como essas situações acontecem ou aconteciam? E caso não perceba nada relacionado a você, percebeu ou percebe algo relacionado a outras pessoas soropositivas? Fale um pouco sobre isso.
- 6- Você se recorda de algum momento que se sentiu muito mal devido sua soropositividade em alguma vivência com pessoas ou lugares escolares ou não? Como essas recordações, caso existam, despertam em você no sentido de uma abordagem menos agressiva sobre essa condição?
- 7- Em algum momento você atribuiu o seu diagnóstico pela ausência, tanto na escola como na família, sobre o tema HIV-AIDS? Como você pensa ser pertinente tratar esse assunto, tanto na escola como na família?
- 8- Como você vê seus maiores medos relacionados ao HIV-AIDS?
- 9- Espaço para outras considerações que julgar pertinentes.

Concluído o roteiro, o próximo passo foi levar essa elaboração a um olhar de fora, para nos ajudar a olhar para dentro com mais autenticidade e, na sequência, pensar como o pesquisador poderia se colocar no papel de entrevistador. Assim, buscamos ousar em outros saberes e nos performar como entrevistador no formato de pesquisador.

5.8 Um olhar de fora: ver o que não vimos como potência na produção dos dados

Após a construção do roteiro, surgiu a ideia de submeter o questionário à apreciação de alguém de fora da pesquisa e que trabalhasse com esse tipo de investigação. Estávamos conscientes de que, por estarmos envolvidos com a pesquisa, tínhamos uma percepção sobre o que investigávamos, mas que, em determinado momento, poderíamos estar girando em torno de um eu cego já construído, necessitando de um tu para nos reconduzir ao objeto da pesquisa e seguir na busca do “como”, que nos propomos a saber com as pessoas soropositivas.

Em uma disciplina cursada no doutorado, intitulada Seminários Avançados de Educação, Pesquisa e Produção do Conhecimento, o professor responsável trouxe a participação da professora e pesquisadora Maria Machado Malta Campos, que, em

um momento de sua fala, mencionou a professora e pesquisadora Anete Abramowicz como uma referência na realização de entrevistas, devido à sua perspicácia no interesse em conhecer o como de determinados problemas a serem investigados.

Com essa informação, entramos em contato por e-mail com Anete, que nos respondeu, sinalizando algumas observações que utilizamos na construção do roteiro. Segundo ela, “qualquer entrevista tem que ter uma metodologia, porque, caso contrário, realiza-se uma enquete, uma entrevista e não uma pesquisa”. Atentamos para isso. Contudo, ainda assim, sentimos a necessidade de outro tu problematizador. Foi então que encontramos uma pesquisa realizada pelo professor e pesquisador Eduardo José Manzini.

No estudo realizado, O uso da entrevista em dissertações e teses produzidas em um programa de pós-graduação em educação, Manzini (2012) trouxe alguns apontamentos que consideramos pertinentes e que buscamos incorporar à nossa pesquisa. Tais pontos dizem respeito aos parâmetros que, metodologicamente, é interessante que apareçam na pesquisa científica e, para nós, sobretudo, à qualidade dos dados para análise e produção de conhecimento.

Após buscarmos aplicar todo o percurso detalhado até aqui, realizamos uma entrevista piloto para, em seguida, proceder à transcrição e ao envio a três professores pesquisadores, a fim de recebermos seus questionamentos e, então, seguir com o roteiro reformulado, com maiores chances de qualidade nos dados a serem analisados posteriormente.

Ainda que haja essa preocupação visando melhor qualificar o instrumento, assumimos que todo o esforço empreendido não isenta de vieses interpretativos. Isso porque, para a realização da validação, cada pessoa acessa seus referenciais e experiências.

Para tanto, criamos um quadro avaliativo para que as pessoas pesquisadoras avaliassem nosso roteiro de entrevistas. O modelo elaborado segue um formato com três pontos de ancoragem: atende ao objetivo; não atende ao objetivo; atende parcialmente ao objetivo, como podemos observar no quadro abaixo:

Quadro 10 - Direcionador para questionar o roteiro das entrevistas semiestruturadas

Crítérios	Atende ao objetivo	Não atende ao objetivo	Atende parcialmente ao objetivo
As respostas estão claras e objetivas.			
As respostas fogem e não alcançam o que foi perguntado.			
Gera dúvidas quanto ao teor das informações.			
A pessoa entrevistada parece não saber o que está falando.			
A pessoa entrevistada tem propriedade em sua fala.			
As respostas foram completas.			
Houve relação com o que foi perguntado.			
As respostas foram curtas, porém, explicativas.			

Fonte: O autor.

Concluídas as considerações das/os professoras/es pesquisadoras/es, realizamos uma nova avaliação entre o pesquisador e a orientadora, considerando os pontos que atenderam ao nosso objetivo e os que não atenderam, propondo mudanças para que conseguíssemos o máximo de êxito na qualidade dos dados e, assim, seguir com as demais entrevistas. Ressaltamos que, com a devolutiva da banca de pesquisadores externos, consideramos manter os dados produzidos no piloto. Essa inclusão considerou o resultado da avaliação, que não indicou mudanças diretas no roteiro, mas apenas nas estratégias de utilização do roteiro para a produção dos dados.

5.9 Performar: uma arte para atuar como pesquisador-entrevistador

Ao concluirmos o roteiro, no processo de autorreflexão, percebemos que, além de ter um roteiro bem elaborado, era preciso ter uma performance na aplicação do mesmo, como possibilidade de obter dados com maior qualidade. Foi então que pensamos em performar como entrevistador e surgiu a ideia de utilizar a psicanálise, por seu uso da escuta e da busca dos “comos”, para saber sobre determinados assuntos, dores, queixas e sentimentos. A ideia é ressignificar a atuação do pesquisador e, por meio desse movimento, potencializar as condições para que os dados possam emergir.

Antes, ao pensarmos em como os encontros poderiam ser caracterizados pelas entrevistas, chamou-nos a atenção o fato de que um dos papéis imprescindíveis do entrevistador, na performance de pesquisador, é o uso da audição como um dos sentidos que captam o que as pessoas participantes querem e podem nos falar (Houaiss, 2011). Nesse sentido, escutar demanda presença e atenção ao que e a quem se ouve. Um ouvir que exige uma fonte, que, no contexto da pesquisa, a pessoa respondente constitui a centralidade, materializada pelas palavras-linguagens reproduzidas na conversa-entrevista.

Quando mencionamos a relação entre o falar e o ouvir, remetemo-nos a outra relação que encontramos na pesquisa de Panciera (2023), intitulada Aristóteles sobre a memória e a *anamnese* e os seus movimentos. A pesquisa buscou traduzir a obra original do filósofo Aristóteles (449), *Περὶ Μνήμης καὶ Ἀναμνήσεως* (Sobre a memória e a *anamnese*), no intuito de propiciar seu uso e consulta no desenvolvimento de conhecimentos.

A produção do falar remete à memória, e a *anamnese* se caracteriza, no contexto da pesquisa, como esse movimento que consiste em fazer lembrar, uma volta ao passado, com a possibilidade de descrição de fatos vivenciados a partir de uma questão que provoque esse retorno.

A memória resulta, pois, no armazenamento dos estímulos captados pelos sentidos, localizados no tempo e no espaço de algum acontecimento do passado. Cabe destacar que a memória não se caracteriza como uma percepção, nem como uma probabilidade, muito menos como um emaranhado de ideias postuladas ou resultantes do agora, localizado no presente. Diferente da memória, a *anamnese* é a capacidade humana de realizar movimentos internos do exercício mental, intelectual e deliberado, que busca revisitar o passado na intenção de produzir uma concepção, no presente, sobre algum ocorrido no passado (Panciera, 2023).

Essas questões buscam colocar as pessoas participantes como o *lócus* na produção de um conhecimento legítimo, sobre o local e o espaço em que são produzidos os acontecimentos que marcam e atravessam a vida e a existência humana. Estes são imprescindíveis quando se busca, nessa beleza, a estética das significações e ressignificações que a humanidade tem realizado e nos possibilitado a ser história, a serem contadas, propagadas e validadas, sem qualquer dúvida quanto à cientificidade que é a própria vida humana.

Ainda tratando da importância de colocar as pessoas participantes e a produção do conhecimento resultante dos movimentos realizados pela vida humana, Foucault (2022b) dialoga conosco ao pensar a escrita de si como a “arte de si mesmo”. Nossa posição não é a de nos colocarmos como ouvintes de confissões, ocasionando qualquer peso moral que possa incidir na vergonha verbal, reprimindo as palavras a serem ditas.

Mas em propiciar ao que Ribeiro (2017) refletiu: “O que é lugar de fala?”. Ao responder à questão, a filósofa discorre que existem certos grupos e pessoas que são restringidos em sociedade e que, na consonância, há a universalização das experiências, o que reduz a diversidade de vivências, uma vez que cada qual é produzida e marcada por espaços e locais de formas distintas.

Contudo, é sabido que pessoas, ao compartilharem dos mesmos grupos, vivenciam experiências similares, mas que não são determinantes, devido à individualidade que cada qual possui. Nesse sentido, “o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes, consequentemente da hierarquia social” (Ribeiro, 2017, p. 64).

Deste modo, colocamos as pessoas soropositivas em um lugar de poder, devido à autenticidade de suas falas-experiências, tidas como pessoas falantes da pesquisa e detentoras de um saber que não pode ser disputado. São delas; nós apenas nos apropriamos para refazer a história do não dito, ou daquilo que foi dito por elas.

Feitas as considerações sobre o falar e o ouvir, propomos, na continuidade, refletir sobre a performance do pesquisador enquanto entrevistador, utilizando a psicanálise. A proposta que trazemos é utilizar algumas ferramentas da psicanálise para que, nos momentos dos encontros-entrevistas, possamos alcançar o máximo possível de êxito e qualidade nos dados-falantes.

5.10 Psicanálise como aparelho de amplificação da escuta na entrevista semiestruturada

Não nos propomos a fazer uma historiografia, tampouco a criar um panorama contextual, uma vez que seguimos, de forma objetiva, aquilo que nos interessou neste

campo de conhecimento e quais foram as contribuições que poderíamos colher dessa árvore do saber.

Nos movimentos de autorreflexão, ao pensar no contexto das entrevistas, deparei-me com uma série chamada *Sessão de terapia*²³, na qual são abordados alguns casos e em que há essa relação entre uma pessoa falante e outra ouvinte, nos papéis de terapeuta e paciente. Embora não seja nossa pretensão fazer dos encontros um local terapêutico, e muito menos nos colocarmos como terapeutas, mas sim capturar alguns exemplos do ato de ouvir, cogitei a possibilidade de utilizar aportes psicanalíticos para o exercício performático na entrevista, no papel de pesquisador.

Na busca por estudos que pudessem nos embasar, deparamos com o de Macedo e Falcão (2005), *A escuta na psicanálise e a psicanálise da escuta*. O estudo traz algumas ideias e conceitos e, sobretudo, nos leva a pensar o papel da escuta. Segundo as autoras, o exercício da escuta das palavras pode ser uma possibilidade de acessar aquilo que a fala, no nosso contexto das pessoas entrevistadas, desconhece, mas que está presente como fato a ser conhecido. Ao escutar, não se deve utilizar pressupostos que possam interferir no que o discurso da pessoa entrevistada está produzindo.

Resulta, pois, em uma escuta atenta do entrevistador para com as pessoas falantes, possuidoras de seus saberes, sem o uso de rótulos, colocando a autonomia e a liberdade como caminhos a serem percorridos pela pessoa entrevistada, no sentido de acolher a singularidade que cada pessoa-entrevistada tem a falar. O papel do entrevistador, então, seria o de propiciar que a pessoa entrevistada seja a protagonista, uma vez que somente ela sabe sobre si mesma, diminuindo ao máximo a participação interventiva do entrevistador.

Ainda que haja a preocupação com a diminuição da participação do pesquisador, não resulta em total ausência de intervenção. A escuta, configura uma forma de intervenção. A partir do que se ouve, orientam-se as narrativas e provocam os sentidos que emergem no processo de fala e escuta.

De todo modo, Macedo e Falcão (2005), no decorrer de suas reflexões no texto, mencionam alguns conceitos, como *a atenção flutuante, associação livre e escuta analítica*, que buscamos ampliar com a literatura da área.

²³É uma série lançada em 2012, no Brasil, criada por Jaqueline Vargas e dirigida por Selton Mello. Pode ser acessada no streaming Globo Play.

Segundo o Vocabulário da Psicanálise, a atenção flutuante é descrita como uma forma de escutar que “consiste numa suspensão tão completa quanto possível de tudo aquilo que a atenção habitualmente focaliza: tendências pessoais, preconceitos, pressupostos teóricos, mesmo os mais fundamentados” (Laplanche, 2016, p. 40).

Sobre a associação livre, o dicionário, ao descrevê-la, referencia o livro Estudos sobre a histeria e afirma tratar-se de um método pré-analítico no qual se recorre “à sugestão e à concentração mental do paciente em uma determinada representação; a procura insistente do elemento patogênico desaparece em proveito de uma expressão espontânea do paciente” (Laplanche, 2016, p. 38).

No que concerne à escuta analítica, Fuchs e Zorning (2013), no estudo A escuta analítica: corpo, afeto e palavra, afirmam que a escuta analítica pode ocorrer nas transferências feitas ao corpo, nos afetos e na linguagem não verbal, possibilitando que sejam construídas significações e sentidos acerca do que está sendo apresentado. Outros estudos que mencionam o uso da escuta psicanalítica a descrevem como um meio de fazer reconhecer as pessoas falantes como portadoras de subjetividades e simbolização e, assim, serem reconhecidas como capazes de ser vistas para além das problematizações que são feitas a seus corpos e vidas (Cazanatto; Martta; Bisol, 2016).

Sutanto (2021), em seu estudo *Psychoanalytic Listening: between unconscious and conscious*, menciona Freud (1912) e Bion (1962), ambos teóricos de renome da área da psicanálise. Ao utilizá-los, Sutanto afirma que a escuta psicanalítica pode ser composta pela junção de ambas as abordagens: a de Freud, quando o médico desenvolve o conceito de atenção flutuante; e a de Bion, a partir de uma escuta ausente de memória e desejo.

A junção das técnicas mencionadas acima, na análise, resulta na busca por conectar o inconsciente do falante concomitantemente com o do ouvinte. Tal escuta possibilita que a pessoa que escuta “eduque” seus ouvidos para não permitir interferências, seja da ordem do próprio pensamento, seja de seus sentimentos, que podem ser criados dependendo do material que está ouvindo. Uma vez desenvolvida a técnica, o analista, na pessoa do ouvinte, consegue provocar o paciente, a pessoa falante, a falar e ampliar sua participação, revelando outras formas de expressar aquilo que as palavras não estão conseguindo.

Dado todo esse panorama da escuta psicanalítica para utilizarmos nos encontros, com a aplicação dos roteiros nas entrevistas semiestruturadas, podemos destacar sua importância em alguns pontos sintetizados:

a) permitir que a pessoa entrevistada fale, sem que o/a entrevistador/a se coloque como agente de conhecimento sobre o tema, evitando que a pessoa falante diminua sua participação ao perceber que sua contribuição pode ser considerada desnecessária; não intervir diretamente, realizando apenas intervenções provocativas a partir da própria fala da pessoa entrevistada;

b) a escuta deve estar isenta de inclinações, preconceitos ou ideias pré-concebidas, evitando manifestar um clima de separação, vergonha ou constrangimento. No caso das pessoas soropositivas, manifestar preconceito, além de contrariar o objetivo da pesquisa, faz com que as pessoas participantes cessem sua fala, devido ao bloqueio que a vergonha do preconceito provoca;

c) no decorrer das falas, a atenção é igualmente necessária, ao observar exemplos ocorridos nas vivências que sinalizam, de forma indireta, a existência de materiais a serem explorados. Isso pode ser utilizado, mas com responsabilidade, por acarretar o acesso a gatilhos de sofrimentos experienciados no passado. Os exemplos funcionam como símbolos que, ao serem verbalizados, representam algo que a pessoa ainda tem a dizer. Esses gatilhos podem ser mediados ao mencionar o processo de resiliência que as pessoas soropositivas tiveram e seu papel importante para ajudar outras pessoas em processos que elas próprias já percorreram;

d) por fim, o que a boca não diz, outras partes do corpo falam. Essa observação pode ser utilizada para explorar o que, no momento da fala, causou certos incômodos, como quando a pessoa se expressa de forma negativa, ajusta-se no assento como se estivesse incomodada, muda de assunto e inicia outro. São formas de dizer que, na entrevista, podem ser muito produtivas para o aumento e a qualidade dos dados produzidos.

Todas essas observações colaboraram de forma significativa para que pudéssemos produzir dados valiosos. Para tanto, realizamos as leituras e seguimos com a autorreflexão, no intuito de nos colocarmos em processo formativo, de modo a internalizar e não deixar que essas observações alcançadas se apresentassem como artificiais nos encontros. Seguimos, assim, buscando descrever como acessamos as pessoas soropositivas.

5.11 De bola de neve a avalanche de falas a partir de vozes soropositivas

Poucos são os estudos que adotam a técnica conhecida, em vários locais do mundo, como Bola de Neve, *Snowball* ou Bola de *nieve*. Não apenas pelo desconhecimento, mas também porque seu formato não se adequa a certas pesquisas. Em linhas gerais, a definição dessa técnica remete à metáfora de como uma avalanche acontece. A avalanche parte de um acúmulo de neve em um local acentuado, por exemplo, uma montanha com gelo; ao passo de seu movimento, ao deslizar, ela aumenta, precipitando-se em direção a algum local onde desemboca.

Na pesquisa, a Bola de Neve ganha esse nome por funcionar da seguinte forma: uma pessoa é convidada a participar da pesquisa. Esta, após participar, é solicitada a convidar outras pessoas dentro do escopo da investigação que, ao aceitarem, também participam e, assim, sucessivamente. No contexto desta pesquisa, a Bola de Neve não foi composta apenas por pessoas soropositivas que indicaram outras para participar, mas também por pessoas soronegativas que, por terem contato com pessoas soropositivas, firmaram, a partir da confiabilidade entre ambas, a indicação.

Ao observarmos os estudos que utilizaram a técnica, destacamos alguns pontos que convergem com o propósito de nossa pesquisa. Um primeiro, realizado por Bockorni e Gomes (2021), afirma que o uso da Bola de Neve apresenta vantagens quando se trata de temas tabus ou polêmicos, pois as pessoas tendem a sentir certa pressão ao falar sobre esses temas, remetendo-as a situações de constrangimento; possibilita acessar pequenos grupos como amostra e, assim, alcançar outras pessoas por meio de indicações sucessivas, resultantes de uma relação de confiabilidade; além de criar um grupo representacional daquilo que se pretende pesquisar.

Por outro lado, os autores indicam como desvantagens quando utilizada em pesquisas de cunho probabilístico, caso a intenção seja conhecer a totalidade do grupo, o que se torna impossível; o fato de as pessoas fornecerem dados semelhantes; e a ocorrência de indicações repetidas.

Considerando ambas as possibilidades, aquelas que sinalizam as vantagens aproximam-se muito do que buscamos, por se tratar de questões de HIV, AIDS e de pessoas soropositivas. Como já é sabido por nós, essas questões envolvem muitos problemas enfrentados por essas pessoas; assim, o uso da técnica Bola de Neve

mostra-se propício ao que buscamos: além de dados, confiabilidade, segurança e respeito às pessoas que participam da pesquisa.

No que tange às desvantagens, ao analisá-las, elas não nos alcançam. Nossa pesquisa não pretende ser probabilística, pois já temos uma amostra definida, que elucidaremos na sequência. As pessoas podem vivenciar as mesmas situações, mas a forma como as ressignificam é diferente umas das outras, e isso, para nós, é fundamental. Quanto às indicações repetidas, caso ocorram, teremos apenas mais um trabalho para buscar outras pessoas, utilizando essas mesmas para novas indicações.

Outro estudo que utiliza a técnica Bola de Neve, realizado por Leighton *et al.* (2021), amplia a compreensão sobre seu uso. Isso porque, segundo os resultados do estudo, a técnica, quando utilizada de forma clássica ou seja, uma pessoa acessa outra, garante bom êxito, e esse êxito é ampliado quando a técnica é utilizada como veículo de busca por meio das mídias sociais. Na disponibilização do canal de acesso, podendo ser, por exemplo, um link com um banco de perguntas ou um convite, que, ao ser compartilhado por outras pessoas, pode ampliar o campo amostral.

Outro resultado encontrado pelas pessoas pesquisadoras do estudo é que o sigilo sobre quem indica quem aumenta, possibilitando que as pessoas participem com maior segurança.

Dentro das possibilidades apresentadas, o uso da técnica Bola de Neve, para nossa pesquisa, demonstra-se viável e, nesse sentido, o processo que realizamos seguiu da seguinte forma: convidamos uma pessoa soropositiva com a qual já tínhamos contato; com ela, realizamos a entrevista piloto e, em seguida, solicitamos que colaborasse conosco, convidando outras pessoas para participarem do estudo.

Todavia, não criamos um grupo sem critérios. Assim, utilizamos uma pré-avaliação antes de realizarmos as entrevistas com as pessoas, que descreveremos na sequência.

5.12 Entre vozes e falas: quem são as pessoas soropositivas da pesquisa?

No decorrer da pesquisa, utilizamos o termo pessoas soropositivas por ser uma forma que menos produz preconceitos e estereótipos, seguindo as orientações que a UNAIDS (2017) propõe, por estar envolvida com o trabalho de desconstrução da estigmatização e do preconceito direcionados a essas pessoas.

Ao pensarmos quem seriam as pessoas que comporiam nosso estudo, delimitamos algumas questões para atender ao objetivo da pesquisa. Isso não partiu de uma ideia vaga, tampouco isolada, mas da busca, na quantidade de percepções, pela construção de subjetividades, somadas às intersecções pelas quais cada uma é atravessada e à potência que pode emergir como conhecimento.

Entendemos que cada pessoa vivencia, de forma subjetiva, os vários processos da vida. Contudo, as interseccionalidades (Vigoya, 2016; Oliveira, 2023) que marcam cada pessoa podem dizer muito sobre suas vivências, desde as marcações raciais, sexuais, de identidade de gênero, sociais, etárias, econômicas, entre outras. Isso nos impulsionou a deixar abertas todas as possibilidades de pessoas participantes que poderiam integrar a pesquisa, sem criar qualquer quadro de exclusão no que tange a essas questões interseccionais.

Antes de iniciar a produção dos dados, apresentamos a pesquisa à pessoa participante e realizamos uma conversa prévia, no intuito de observar se ela atendia aos critérios estabelecidos: ser soropositiva/o; ter concluído o Ensino Médio; e ter realizado o Ensino Médio em alguma escola pertencente ao Estado de São Paulo. Procuramos saber sua disponibilidade para o agendamento de horários, tanto no formato presencial quanto por meio do uso de tecnologias que pudessem intermediar o encontro, como, por exemplo, chamadas pelo Meet.

Também procuramos observar se a pessoa apresentava alguns entraves: dificuldade para falar; questões emocionais que poderiam ser prejudiciais tanto para ela quanto para a pesquisa; timidez, ou outras condições que não possibilitassem trazer o “como” das significações que giram em torno do objetivo da pesquisa. Destacamos, ainda, a importância do sigilo ético, sobretudo no que se refere ao armazenamento dos dados, conforme proposto no plano de gestão de dados (Anexo B).

Com a qualificação das pessoas participantes por meio da conversa prévia, solicitamos a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice C), conforme as normativas do Comitê de Ética em Pesquisa, já aprovado com o número de registro 5.947.407 (Anexo A).

Realizados todos os passos acima, foi possível produzir dados a partir de um grupo de seis pessoas. Contudo, após a qualificação, acatamos as orientações da banca, que considerou que duas pessoas participantes da pesquisa não se enquadravam nos critérios que havíamos organizado previamente.

Após realizados todos os trâmites burocráticos e de organização, seguimos com um grupo de quatro pessoas, incluindo a participante piloto. Cada pessoa participante recebeu um pseudônimo. Utilizamos como referência os nomes da minissérie “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”. A minissérie foi lançada em 2025, é transmitida pela HBO Max e retrata o contexto da epidemia de AIDS no Brasil, na década de 1980.

A história gira em torno de um grupo de comissários/as de bordo que realizam o contrabando do único medicamento disponível para o tratamento do HIV, o AZT. Assim, os pseudônimos das pessoas participantes foram: Sonia, Caio, Paka e Nando.

No quadro abaixo, elucidamos a caracterização das pessoas participantes do estudo:

Quadro 11 - Pessoas participantes da pesquisa

Participante	Idade	Raça/etnia	Identidade de gênero	Orientação sexual	Profissão	Conclusão Ensino Médio	Descoberta da sorologia
Sonia	45	Parda	Mulher cis	Heterossexual	Cuidadora	1995	2002
Caio	43	Preto	Homem cis	Homossexual	Trabalhador Rural	1999	2020
Paka	27	Pardo	Homem cis	Homossexual	Estudante	2013	2019
Nando	30	Preto	Homen cis	Homossexual	Advogado	2010	2018

Fonte: O autor.

5.13 Das falas a escrita: uma produção de palavras-vivências

Temos buscado criar um ambiente para a produção dos dados que não se colocasse de forma excessivamente formal. O intuito foi propiciar um ambiente e uma relação em que as pessoas que participaram da pesquisa se sentissem confortáveis, seguras e naturalizadas no espaço em que nos encontraríamos, para que tivéssemos o máximo possível de qualidade na produção dos dados.

Pensadas nesse âmbito, entendemos que o aparelho celular seria um instrumento popular para realizar as gravações dos encontros com as pessoas participantes, que, ao ser colocado no meio da conversa, não criaria um bloqueio, por ser familiar, e não se colocaria como um “interrogatório”. Sendo assim, utilizamos um

aparelho da marca Apple, modelo 15 Pro Max, com 256 GB de espaço de armazenamento interno, além de 50 GB de espaço de armazenamento na nuvem, com ano de fabricação em 2023.

O gravador é integrado ao aparelho celular, com capacidade de gerar som em estéreo, o que potencializa o tratamento dos dados e a leitura pelo software para redigir as falas. O microfone também está integrado ao aparelho, com capacidade de isolar a voz, ou seja, de não captar sons externos, e com alta amplitude na captação da voz, auxiliado por inteligência artificial. O armazenamento das entrevistas ficou, neste primeiro momento, no celular, sincronizado no iCloud, uma nuvem na internet, para assegurar qualquer imprevisto (Suporte Apple, 2024).

Entendemos que, por se tratar de uma tecnologia avançada e bem avaliada pelas pessoas usuárias, nos pautamos pelos mínimos problemas possíveis a toda e qualquer tecnologia, conforme apontado pelas avaliações nos mais diversos sites de vendas e utilitários. Tal critério pautou-se na impossibilidade de um novo encontro, que poderia ser difícil, e nas razões sinalizadas pelas pessoas participantes, percebidas por nós, como: problemas de disponibilidade, sentimento de angústia ao retornar a falar sobre o assunto, dificuldade de encontrar locais públicos com pouca ou quase nenhuma interrupção, entre outras. Ao final dos encontros, foi possível mostrar uma prévia às pessoas participantes de como o áudio ficou, reforçando o sigilo e a confiabilidade acordados desde o início, com os devidos meios éticos assinalados.

Os encontros foram definidos a partir das opções que fomos sinalizando às pessoas e da comunicação sobre onde elas poderiam ter maior conforto, segurança e confiabilidade. Seguindo essa lógica, os encontros aconteceram: no local de residência das pessoas, que no momento das entrevistas estavam sem nenhuma outra companhia; em um parque, local arborizado, com espaços mais reservados e no qual a pessoa participante se sentia familiar; e, por fim, por meio do Meet, em que tanto o pesquisador quanto a pessoa participante estavam em suas casas, sozinhos. O formato digital ocorreu em decorrência de uma pessoa participante ter mudado de cidade, tornando sua disponibilidade incerta. A gravação ocorreu do mesmo modo que nas demais entrevistas: utilizamos o aparelho celular para gravar as falas por meio dos alto-falantes do computador.

Os encontros ocorreram nos seguintes dias: Sonia em 9 de novembro de 2023, com duração de 48 minutos e 79 segundos. O segundo encontro foi realizado com Caio, no dia 2 de março de 2024, com duração de 35 minutos e 21 segundos. O

terceiro encontro foi realizado com Paka, no dia 5 de março de 2024, com duração de 43 minutos e 56 segundos. O último, foi realizado com Nando, no dia 13 de março de 2024, com duração de 43 minutos e 56 segundos. Todos os encontros, totalizaram 2 horas, 52 minutos e 32 segundos.

Após as gravações serem realizadas, automaticamente eram armazenadas no dispositivo celular e, logo em seguida, transferidas para o computador, para o Google Drive e para um drive externo — todos em pastas que não poderiam ter acesso aberto²⁴.

Seguimos com o tratamento dos dados brutos, utilizando o software chamado *Transkriptor (2020)*, fabricado em Middletown, Delaware, EUA, em 2020, que utiliza inteligência artificial. O trabalho do software é redigir os áudios, criando, ao final, um documento no Word. Nossa escolha se deu por ser um mecanismo que consideramos de fácil acesso, que cumpre a função de transformar os áudios em textos em curto prazo e em diversos idiomas, otimizando a descrição das falas para, então, seguir com as etapas da pesquisa.

Depois de realizar a conversão do áudio da entrevista para a escrita, passamos por um processo de leitura para buscar possíveis erros de entendimento do aplicativo. Após esse processo, já com a entrevista redigida na íntegra, refizemos a leitura no intuito de observar possíveis exposições que pudessem comprometer a pessoa participante, visando manter o sigilo e as questões éticas firmadas anteriormente. Nesse momento, refletimos se o melhor seria manter a escrita sem nenhuma intervenção ortográfica ou se realizaríamos correções.

Concluimos realizando algumas correções para melhor entendimento do contexto tratado, mas sem distorcer ou alterar o conteúdo propriamente da fala. Por exemplo, inserimos vírgulas, pontos finais, de interrogação e aspas para melhor leitura e compreensão. Outras questões, como palavras e termos, mantivemos, por serem considerados por nós interessantes para a percepção cultural dos significados atribuídos.

²⁴ Maiores detalhes ler no Plano de gestão de dados (Anexo B).

5.14 Procedimentos de análise dos eixos falantes

Concluídas as etapas de produção e tratamento dos dados brutos, fizemos mais uma leitura e fomos costurando, fala por fala, como uma colcha de retalhos. A predominância que aparecia nos dados foi sendo considerada como um eixo possível a ser analisado e discutido. Ou seja, consideramos as semelhanças, as frequências, os assuntos e as correspondências que apareciam nas falas e, então, agrupamos por eixos.

As falas que não se alinhavam e que fugiam do objetivo da pesquisa foram ignoradas, para não nos afastarmos do que nos propusemos a saber, buscando centrar-nos nos objetivos geral e específicos que nos direcionam a responder ao problema da pesquisa. Em alguns momentos das entrevistas, observamos que, por algum motivo pessoal, as pessoas entrevistadas mudavam a direção do que perguntávamos.

Percebíamos que havia um sentimento de desabafo relacionado a produções da vida particular que ocorriam no presente, bem como alguma angústia ao retomar as lembranças, o que implicava em falar sobre outras questões. Ainda assim, essas falas foram sendo aproveitadas, por também tratarem, de forma indireta, das vivências que as pessoas participantes da pesquisa relataram. Nesse movimento, os eixos foram se constituindo como um processo de criação.

Quando pensamos em eixos, é na tentativa de fugir da criação de categorias rígidas e inflexíveis, que não possam se mover em torno de uma ideia, assim representada por cada tópico que nos fala. Como um espaço no qual as palavras, as vozes e os afetos se movem em torno da criação de realidades possíveis, que não se generalizam, que podem se repetir, mas também podem transgredir a partir das diferenças que nos constituem enquanto pessoas. Com os eixos, é possível que se conversem.

Os dados produzidos apontam para uma certa linearidade dos acontecimentos. A organização por eixos nos possibilitou colocar os assuntos em recortes para que, ao serem reunidos, pudessem possibilitar outras visões, reflexões e continuações. São olhares possíveis sobre vivências possíveis.

Ao final, foi possível produzir cinco eixos de discussão. Após termos organizado os dados em eixos, o próximo passo foi conversar com os dados para

pensarmos a ordem em que eles poderiam estar na estrutura da discussão. Assim, não consideramos a ordem em que as perguntas foram feitas.

Isso porque, em cada pergunta, havia desdobramentos que distanciavam do que foi inicialmente questionado e, ainda assim, eram dados interessantes para a pesquisa. Como o roteiro não é uma técnica fechada e, no decorrer dos encontros, cada pessoa revela outras e novas possibilidades investigativas, além das perguntas previamente elaboradas, fomos, no momento das entrevistas, introduzindo e sendo reintroduzidos, pelas pessoas participantes, a outras vontades de saber.

As frases e perguntas presentes em cada eixo aparecem de forma direta e indireta ao longo das análises e discussões. Elas estão apresentadas no quadro para que as pessoas leitoras possam perceber que nos pautamos em direcionadores, a fim de nos mantermos na organização que conduz ao objetivo específico deste estudo, que é compreender, a partir das narrativas de pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, o que aprenderam na escola sobre o HIV e a AIDS, principalmente o que auxiliou suas vidas após serem positivadas e estarem em convívio social.

Cabe ressaltar que o objetivo está em dar ênfase à escola. Contudo, entendemos que a escola se localiza como um dos vários pontos das relações de poder e saber da sociedade. Com isso, consideramos as experiências da descoberta, do preconceito, da família e dos espaços de saúde como produtores e indicadores que convergem para esse núcleo que é a escola. Uma rede que funciona de forma conectada, múltipla, de saberes e poderes que se produzem (Foucault, 2015a).

Ou seja, mais uma instituição que é capaz de produzir, a partir de saberes, comportamentos e experiências e que, assim, poderia ser ampliada na compreensão do que as vivências soropositivas poderiam nos mostrar.

Para melhor ilustração, apresentamos abaixo um quadro que representa a estrutura que consideramos para cada eixo, assim como o nome no qual nos inspiramos a partir das falas e discussões.

Quadro 12 - Estrutura dos eixos e análise

Eixo 1: Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?
Como aconteceu a descoberta?
Como foi o anúncio do profissional da saúde sobre estar soropositiva/o?
Como foi o sentimento da descoberta da sorologia?
Como foi se ver em um mundo novo da sorologia?
Como foi a relação com o novo mundo soropositivo e a rotina com o espaço de saúde?
Eixo 2: Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?
Percepção de alguma relação de preconceito com alguma pessoa profissional da saúde.
Percepção de relações de estigma, preconceito e medo no espaço de saúde.
Percepção de relações de estigma e preconceito por outras pessoas.
O sigilo como uma forma de medo, segurança e meio de criar novas formas de soroviver.
Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo
O assunto sobre sexo e sexualidade aparecia?
Não se fala sobre sexo em casa.
O sexo não circula no interdito.
Como seria se a família tivesse falado?
Quando se fala é a partir de palavras que colocam medo.
O sigilo pelo medo da família saber estar soropositivo.
Quando a família sabe sobre a sorologia.
Eixo 4: Quando a aula produz medo, e não Cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS e pessoas soropositivas na voz de pessoas soropositivas
Em algum momento na escola, foi falado temas sobre o HIV, a AIDS e o viver soropositivo?
Se foi falado, como foi a abordagem?
Havia alguma frequência das falas?
O que foi ouvido na escola colaborou de algum modo depois que se tornaram soropositivas?
Percebiam alguma relação de preconceito com o tema?
Em quais locais encontraram algum referencial sobre o HIV a AIDS e o viver soropositivo?
Eixo 5: A arte de reinventar a si mesmo: invenções para o currículo sorotransgredir
Como a escola poderia ter falado sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas?
Como isso impactaria sua vida com a descoberta da sorologia?
Como acreditam que deveria ser a atuação da escola em relação ao HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas?
Exemplos de projeto e currículo que a escola pode desenvolver.
A escola como auxiliadora para diminuição de sofrimento com a descoberta da sorologia.
O que fariam para as pessoas que acabaram de descobrir a sua sorologia?

Fonte: O autor.

Uma vez organizado o quadro das análises e discussões, apresentamos abaixo os resultados da produção dos dados, assim como as análises e discussões que realizamos. A apresentação seguirá de acordo com o que foi apresentado no

quadro acima. Iniciaremos pelo primeiro eixo e seguiremos até o quinto, em ordem crescente, finalizando com as conclusões possíveis a que chegamos neste terceiro estudo.

Por fim, reafirmamos que o estudo empreendido está inscrito em uma perspectiva de produção situada do saber. Logo, os dados não foram resultado de descobertas. A partir das relações investidas no decorrer do percurso investigativo, os dados que apresentamos foram produzidos. Ou seja: foram as escolhas metodológicas, os recortes que situaram a pesquisa, as pessoas que participaram da pesquisa e a atuação do pesquisador. Todos esses movimentos se inscrevem na ordem de possibilidade que esse estudo aponta, evidenciando sua força e também seus limites.

5.15 Eixo 1: Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?

O que é que a gente sabe dessa vida? é o nome do poema de Oswald Montenegro que tomamos emprestado para iniciar as discussões aqui pretendidas. O sentido de utilizá-lo está para além do estético que suas palavras produzem. Utilizamos como sons, imagens e cheiros para criar um ambiente de aprendizado, nos ditos e ouvidos que, escritos, aqui trazemos, como mais uma oportunidade de nos perguntar: o que é que a gente sabe dessa vida?

A criança olhou pra mim e perguntou:
 "A flor tá nua ou tá bem vestida?"
 Por que que o mar dá medo se ele reflete o céu?
 O que que a gente sabe da vida?
 Eu já não sei se quero valsa ou rock.
 Eu sei que o barco vive da partida.
 Sei que o poeta virou marinheiro,
 mas o que que a gente sabe da vida?
 Não é a flauta que é mágica, é a flautista.
 A nossa alma virou avenida
 onde os carros atropelam as certezas.
 O que que a gente sabe da vida?
 O jóquei é escravo do cavalo?
 A morte é entrada ou é saída?
 O que que é hábito e o que que é vício?
 O que que a gente sabe da vida?
 A resposta não sopra no vento, Bob Dylan.
 A lucidez é a esperança perdida?
 O vento apenas venta, Bob Dylan.
 O que que a gente sabe da vida?

Ou não há milagre ou tudo é milagre.
 No exagero é que tá a medida?
 Pra um cristão, avião é cruz voando,
 mas o que que a gente sabe da vida?
 Deus está em tudo, meu amigo,
 mas a verdade tá escondida.
 O sábio sabe, mas o poeta sente.
 O que que a gente sabe da vida?

A descoberta tem como um dos possíveis significados o revelar de algo que estava encoberto, escondido ou invisibilizado pela ausência de sua possibilidade de existência. Pode ser revelada por si mesma, como uma surpresa boa ou não. Pode ser uma revelação feita por alguém que a encobriu ou que veio à tona sem planejamento.

De todas as formas, a descoberta é uma ação que faz emergir a possibilidade de realidades: a desconhecida, pelo distanciamento que há com o que se descobre; a conhecida, por meio das proximidades com o evento em que a descoberta se insere. A descoberta também pode ser a realidade dos nossos preconceitos e, por isso, descobrir é um ato de medo por se voltar contra nós. A descoberta é aquilo que nós não sabemos, mesmo acreditando que, se soubéssemos, poderíamos evitar.

Descobrir é um verbo que nos lança ao mundo dos saberes e que, para Foucault (2015a), ao pensá-los, considera como resultado de um processo atravessado pela cultura, pelo tempo e pelo discurso produzido nas relações, com efeitos que por ele e para ele convergirão.

O saber não é algo neutro; ele está permeado de “intenções” pelo que pode ser feito com ele, seja para o reforço, seja para a contestação. O saber segue como uma moeda valiosa para as nossas sociedades, tanto para reforçar os negacionismos quanto para combatê-los. Este último talvez seja a nossa pretensão.

Toda essa contextualização é para pensarmos as nossas percepções sobre o HIV, a AIDS e o viver soropositivo. Não há uma única forma de compreendê-los. Os saberes estão colocados sob regimes de diferentes lugares de produção e de causas. Trata-se de um contraditório que não se universaliza e muito menos se naturaliza. Há percepções que se pautam no desconhecimento e que aqui nomeamos como positivas, por colaborarem na produção econômica do preconceito.

Não obstante, há percepções que se pautam no conhecimento científico e que, ainda assim, se inserem na economia da produção do preconceito, como também

contra ele. Outras, embora desligadas de todo o positivismo conceitual, criam suas percepções a partir da leitura do mundo das vivências.

Os regimes em que o conhecimento sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas se inscrevem na história são atravessados por ideias que não correspondem à sua realidade. Na produção dos dados do primeiro estudo, foi possível observar como, em diferentes épocas, a percepção da AIDS teve diferentes nomeações e, ainda assim, um mesmo núcleo de ancoragem que, em Foucault (2010a), é visto como *categorias da moralidade*. É a doença gay, a peste homossexual, a doença dos 5Hs, a síndrome do intestino gay.

As categorias da moralidade são produções médico-jurídicas que nomeiam o comportamento do sujeito-doente, produzindo, por meio delas, a ideia do anormal. O/a normal é o corpo que foge das regularidades que foram construídas para o normal: sadio, heterossexual, soronegativo, entre muitas outras, como podemos ver na fala de Sonia, quando perguntamos se era possível nos dizer como foi saber sobre sua sorologia.

Olha, eu assim, no momento, *quando eu descobri eu, eu surtei, eu queria me matar* porque *eu nem entendia de onde vinha*. Como tinha acontecido aquilo comigo? Como eu não acreditei, eu falei, não é porque eu descobri na minha última gestação e eu já tinha tido 2 filhos e fiz o exame. *Tudo normal*, era casada, nunca tinha traído o meu marido, nunca tinha feito... porque *o que mais falava era tatuados e é homossexuais e pessoas que têm vários parceiros*, eu não tinha vários parceiros. De onde que tinha vindo isso? (Sonia).

A descoberta de estar soropositiva, para Sonia, foi como se algo a tivesse prejudicado. O sentimento de morte revela a vergonha que possivelmente se entrelaça à percepção que ela tinha sobre quem era uma pessoa soropositiva. Para ela, ser soropositiva era um conceito universal de anormal que é preenchido por aquilo que a sociedade despreza. Estar inserida na categoria da moralidade, para Sonia, seria uma forma de estar protegida.

O casamento monogâmico, para Sonia, seguia como uma *pedagogia do silêncio*. O casamento monogâmico, ao estar sob a jurisdição do contrato matrimonial, reforça as regras estabelecidas para que as pessoas inseridas nesse contrato as sigam. A pedagogia do silêncio opera a partir das regras e normas que estão dadas previamente ao papel social que o casamento ocupa e cada pessoa que está nele.

Não há palavras, apenas seguimentos no interdito que controlam o desejo e a sexualidade, em vista da ideia de fidelidade, mas que acaba se mostrando falha.

O anormal, para o HIV na percepção de Sonia, se traduzia em percepções estereotipadas ao falar sobre homossexuais, pessoas tatuadas e pessoas que tinham mais do que um parceiro. Sonia, por estar dentro do casamento, não se incluía na categoria que possibilitaria a exposição ao vírus. Para ela, o baque da descoberta se deu por não se enquadrar ao que socialmente é construído sobre o vírus.

O normal era o marido, por ser heterossexual; não estar em contato com os anormais (gays, tatuados, drogados e tantos outros). Estar inserida nessa categoria possibilitava uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, de estranhamento na descoberta de Sonia. A percepção que Sonia tinha cria um vazio sem respostas, pois ela percebe que o normal ao qual ela se construiu na realidade era talvez uma farsa.

A presença do/a anormal está no corriqueiro dos nossos dias, no saltar de algum xingamento, pela necessidade de atingir negativamente, por meio da palavra, quem quer que seja. Ele é a presença negativa que a palavra transporta aos ouvidos de quem se pretende atingir, produzindo sentimentos de revolta ou de distanciamento.

Está no grito da vizinha ao garoto que se arrebenta na árvore brincando: “esse menino não é normal!” (no caso, eu). Faz-se presente no aferir da pressão arterial: se estiver 12/8 (120/80 mmHg), e que, nos dias atuais, não é mais o normal. O/a normal é produzido para ser localizado.

No seu aparecimento, os processos investidos são os de normalização. Normaliza-se a pressão arterial, o comportamento da criança atentada por meio da correção, seja por medicamento, violência ou privação. Para o/a anormal nascer, antes vieram duas outras categorias que produziram novos sujeitos na história: o *monstro* e o *indivíduo a ser corrigido* (Foucault, 2010a). A descoberta de estar soropositivo, para Caio, sinaliza uma naturalidade em sua percepção.

Só que conforme *não sentia nada*, o máximo que eu sentia era uma dor de cabeça ou uma febre, tomou o remédio e passou. Era assim. Então de dipirona passou, mas chegou num ponto que não tava passando. E chegou num ponto também que febre e dor de cabeça tava vindo todos os dias em seguida. Aí foi no que chegou num ponto que minha alimentação começou a diminuir, eu tava tomando um copo de refrigerante e ia dormir, aí *chegou um dia que o corpo não aguentou, não conseguia, não estava conseguindo ficar de pé*. E nesse tempo, parece que já estava escrito. Até a irmã de Campinas estava aqui. Estava tudo aqui. Aí se juntou aquele bolo e correu comigo. Aí fez o teste rápido lá e deu. *Deu o soropositivo* e em seguida é..., já

encaminhou para o espaço lá, espaço ambulatorio, ambulatorio DST, né? E aí foram feitos os exames e acompanhamento, e aquele bate e volta, bate e volta, e eu fiquei em dois lugares, que era o HR (Hospital regional) e lá no CTA (Centro de testagem e aconselhamento). Eu tinha que escolher um lugar. Aí eu escolhi ficar lá (Centro de testagem e aconselhamento) por que na hora que eu preciso sou atendido a qualquer hora. E aí, eu saí do HR e fiquei lá com eles e assim segue (Caio).

A descoberta de estar soropositivo, para Caio, seguiu como um processo de identificação a partir dos sinais que ele vinha apresentando. Importante destacar que, durante as falas de Caio, ele deixa explícito que o HIV não era uma novidade. Logo, não havia a percepção de anormalidade.

Sua percepção vinha de outras experiências com o HIV e pessoas que viviam soropositivas. No decorrer da entrevista, ele relata que um de seus sobrinhos vivia soropositivo, trazendo uma certa naturalização sobre o seu descobrimento.

Soma-se a outro fato: no período em que ele descobriu, vivia um relacionamento amoroso com um rapaz que também era soropositivo, o que indica que ambas as experiências foram formadoras no processo de ele estar soropositivo. Ainda que, não foi significativa para uma possível prevenção.

A descoberta, para cada pessoa, e a forma como ela produz a verdade sobre seus acontecimentos possibilitam ver pontos divergentes, mas importantes para pensar a localização da ideia do monstro, como aquele que se mostra, espanta e apavora.

Assim, o monstro não está apenas no passado, quando foi criado. Ele se faz presente, atualizando seu significado em uma série apresentada pela Netflix²⁵ em três temporadas (Winkler, 2025).

A primeira temporada traz como monstro Jeffrey Dahmer, que, nos anos de 1978 a 1991, matava e abusava de homens e garotos, de formas brutais, em sua maioria homossexuais, chegando a comê-los.

A segunda temporada conta a história de dois monstros, os irmãos Menendez, Lyle e Erik, que mataram a mãe e o pai brutalmente em 1989.

²⁵ A Netflix é um serviço de streaming por assinatura paga que oferece um catálogo de filmes, séries, documentários e outras produções, que podem ser assistidos online em aparelhos com conexão à internet.

A terceira temporada traz como monstro Ed Gein, conhecido como açougueiro por matar pessoas e roubar cadáveres, fazendo utensílios para casa (abajur, assento de cadeiras, tigelas) nos anos de 1950.

Todos esses monstros foram produzidos nos Estados Unidos da América. São séries baseadas em histórias reais.

O conceito de monstro apresentado por Foucault (2010a) é construído a partir das leis da natureza. O monstro é o corpo que está contra o que a natureza produziu. São corpos fora da lei. O corpo, em seu estado natural, traz como configuração as regularidades e normalidades, as quais também foram produzidas para contrapor ou afirmar o anormal.

O monstro é aquilo que é revelado, o que espanta com sua presença. Por ele e contra ele foi construída a percepção de mal, doente, de ruim. Há também a visão de ser uma raridade, um corpo que é acolhido por ser um “coitado” maltratado pela natureza, como uma forma de pagamento aos castigos humanos. A descoberta, para Paka, mostra ter sido uma catástrofe.

Eu sei que não é uma das piores coisas da vida da gente. *Hoje eu vejo que é normal*, tô super tranquilo, mas *eu achei que eu ia morrer*. Eu *achei que eu ia morrer*. Foi *muito difícil*, é *muito difícil aceitar*. Muito difícil. *Eu sonhava, acordava assustado*, achando que eu estava no sonho, mas era a realidade. É difícil, não é fácil. *Eu sei que é uma coisa normal hoje* em dia, tem tratamento (Paka).

A reação à descoberta de estar soropositivo, para Paka, mobiliza as percepções de anormalidade e de monstro. A anormalidade por ver, em sua descoberta, a associação ao que é pior. O monstro como aquilo que, ao estar contra a natureza, era difícil de aceitar, por colocá-lo do outro lado de uma dita natureza considerada como ruim, que o classificava.

A percepção que Paka demonstra é de um desespero por acreditar que a morte, repetidas vezes, seria o resultado do que havia descoberto. Como se, pela natureza dos acontecimentos, estar soropositivo, como no passado, representasse o fim. Resgata as percepções monstruosas que descreviam realidades recortadas, como mostramos no primeiro estudo.

O monstro, em Gros (2018), na inversão das monstruosidades, é sinal da desobediência que o sujeito pratica. No projeto civilizatório, no contexto em que Foucault (2010a) encontra o monstro, a ideia que se tinha era a de civilidade. Para ser

civilizado, é preciso seguir as regras de disciplinamento, que incluem o tipo de comportamento esperado e excluem aqueles que desobedecem.

O monstro é aquele que está no impossível de ser corrigido, por subverter as regras e normas. A desobediência é o que nos constitui monstros. A anormalidade é verbo conjugado na monstruosidade. Ela pode ser como uma ferida que fede e fala. Assim foi a descoberta para Nando:

Eu estava há mais ou menos um ou dois meses com *uma ferida no ânus* e não passava. Aí eu fui no médico, no proctologista, aí ele não sabia o que era, ele mandou fazer exame. Eu lembro que eu gastei nessa época, tipo, nos exames, dois mil reais. E ele não conseguiu resolver. Aí eu pensei, ah, eu acho que eu vou na UPA, no posto, né? Lá próximo de casa. No posto de saúde, porque talvez...Eu estava buscando pra tentar me curar daquilo, *porque doía e era totalmente...Incômodo. Cheirava mal*, era bem...Aí eu fui no posto, aí o médico fez o exame, falou assim que ia passar alguns exames e fez um exame de sífilis, de tudo. *Aí acabou dando positivo* (Nando).

A descoberta, para Nando, ocorreu a partir da persistência de um sinal de anormalidade que seu corpo apresentava e o convocava a ver e resolver. A ferida tornou-se um marcador de algum possível desvio sexual, sinalizado pelo médico como uma possível sífilis. No não dito, o dito pode se expressar no sentimento de anormalidade internalizado. Pelas suas palavras, o que o incomodava não foi saber-se soropositivo, e sim o mau cheiro que o assolava.

A base na construção de Nando possivelmente não seguiu como a das demais pessoas. Não havia a percepção estereotipada como a de Sonia. No decorrer da entrevista, Nando não sinalizou alguma experiência com outras pessoas soropositivas, como a de Caio, e, de alguma forma, sua percepção também não se alinha à de Paka, por não ter o HIV como sentença de morte.

Para a descoberta, há um intermediário por meio do qual a notícia chega. Esse ou essa é representado por profissionais da saúde, médicos/as, enfermeiros/as, psicólogos/as. Especialistas da saúde que, por regra, são formados para saber, no mínimo cientificamente, sobre o universo biológico do vírus, mas isso não representa uma garantia de que esse saber possibilite o entendimento sobre o que o HIV não é na realidade social.

O saber consolidado, que dá poder para a atuação desses profissionais, possibilita o controle social a partir das doenças, como no passado foi a lepra, a peste, a AIDS e a Covid-19. Por elas também foi possível que tivéssemos meios para

prevenir, tratar e devolver à sociedade (à população) a saúde (normalidade), conforme apresentado por Foucault (2021; 2010a).

Pelas experiências das falas das pessoas participantes, é possível observar uma relação permeada pelo *olhar médico*, a objetificação que esse olhar produz no corpo, seguindo pela relação de poder que controla a partir do *saber médico* (Foucault, 2021). Por esse saber, há relações de controle e disciplina que não se limitam apenas ao espaço institucionalizado dos hospitais. Esse poder segue na vida cotidiana das pessoas, como uma forma de extensão desse poder produtivo ao criar modos de vida que, pela classificação que o saber produz, repercutem em exclusões e no poder político dessas vidas (Foucault, 2015b), e que, na prática, pode ser visto nas palavras de Sonia.

Eles me deram um papel, o *médico* que abriu meu exame, ele abriu, leu, perguntou pra mim *se eu era casada*, se eu tinha *namorado por fora* do casamento, e ele falou para mim: “olha”... colocou o papel na mesa, e falou “*seu exame de HIV deu positivo, você pode sair e conversar com a assistente social por que eu não vou mais te atender*” (Sonia).

Na materialização em palavra da experiência vivida por Sonia, o olhar médico é representado na entrega do papel. O médico ocupa a posição de quem sabe, por isso ele anuncia tanto a vida quanto a morte. Ele detém o poder de dizer a Sonia que ela estava com HIV positivo. O corpo de Sonia se torna visível ao médico pelo HIV. Ele olha classificando, buscando alguma relação com a experiência histórica que a doença pode propiciar. Ao classificar, as analogias definirão o ser-Sonia-HIV.

Ao ser questionada pelo médico sobre ser casada, é possível perceber o funcionamento do *dispositivo da sexualidade e da aliança* (Foucault, 2015b). Pela sexualidade e pela aliança, o médico apura o saber produzido que o ajuda a ler o diagnóstico. A sexualidade da mulher no matrimônio, classificada por seguir regularmente e de forma obediente a uma única vivência sexual, não se lança às aventuras do comportamento de “riscos”, abstendo-se de manter outras relações.

Ou seja, todo esse saber abre caminhos para o entendimento médico criar o diagnóstico de Sonia, a partir da possibilidade de ter havido o rompimento com as formas de constituição que o dispositivo produziu. *O golpe de vista* (Foucault, 2021) é dado pelo médico ao pedir que ela se retire. Uma vez objetificado, o corpo de Sonia

precisa passar por uma série de procedimentos para legitimar o HIV. Do olhar médico, Sonia segue para outro espaço de classificação:

Ela (a psicóloga) *começou a me perguntar se eu era casada, se tinha vários parceiros, se eu já tinha feito transfusão de sangue*. Eu falei que nunca fiz transfusão de sangue, cirurgia que eu fiz foi os meus partos e ela então falou “a gente vai ter que fazer exame nos teus filhos, e no seu marido também”. Eu falei, meu Deus, na minha gestação estava tudo normal e aí eu já comecei a me preocupar, e os meus filhos que já eram grandinhos. A mais velha tinha 4 ou 5 anos e o outro tinha um ano e seis ou sete meses por aí. Eu falei meu Deus o que eu vou fazer? Ela começou a me explicar que não era coisa de outro mundo, que tinha tratamento, que eu ia ter uma vida normal. Mas até então, você não.... desde que eu faça o tratamento certinho, mas *eu não conhecia aquele mundo*” (Sonia).

A percepção de Sonia sobre o HIV, por estar permeada por saberes históricos, faz com que, no tempo em que ela descobre, próxima da percepção dominante marcada por visões estereotipadas, ela desconheça esse “novo mundo”. As palavras da psicóloga seguem o que Foucault (2021) chama de *a ordem racional das coisas*.

Para a afirmação do HIV, não foi necessário apenas o exame sanguíneo, como já indicado no papel entregue pelo médico. Foi preciso que o diagnóstico se afirmasse a partir de um conjunto de fatos: estar casada, ter vários parceiros, ter passado por transfusão de sangue. Somente então o HIV pôde ser confirmado.

O reconhecimento do HIV passa, assim, pelos critérios questionados à Sonia. Sua razão de existir está na exterioridade. Não se cogitou que ela poderia ter sido traída, como se o problema estivesse apenas sobre ela. A visão do HIV ainda é a visão que a história produziu. Nas palavras de Nando, é possível observar a percepção histórica quando descreve a suspeita de estar soropositivo ao ver a enfermeira que o atendia:

E foi até uma enfermeira que fez o meu exame e tal. Aí *ela já me olhou com dó, sabe assim?* Aí eu já...Na hora em que ela me olhou com dó, eu tipo, aí meu Deus... É isso, tipo, *agora fazer o quê?* Eu acho que ela não...Não sei, *não passou por um curso, uma formação pra passar essa informação para os pacientes*. Ela assim, ela não falou, porque ela não poderia falar, eu acho, teria que ser o médico. Só que quando ela veio com o exame, ela já veio com uma face assim, meio...Ai, *coitado desse menino. Vai morrer*. Tipo assim, na cara dela, a gente imagina, né. Mas ela tem conhecimento de enfermagem, ela sabe que isso não acontece hoje em dia. Mas ela veio com aquela face, e *eu pensei, ai, meu Deus. É isso*” (Nando).

Nas palavras de Nando, a relação com a pessoa que anuncia sua sorologia está contaminada pela percepção de que o HIV é resultado do que Foucault (2021) nomeia como uma *construção social discursiva*. O HIV não é apenas uma realidade que se afirma por meio de exames. Ele se constitui também na forma como é percebido a partir do olhar que interroga o corpo.

Esse interrogamento já está pré-estabelecido pelas categorias normal/anormal, fazendo do espaço clínico o lócus que produz a doença. Pergunto-me se há o mesmo olhar de dó para quem descobre que é uma pessoa com diabetes. Para uma pessoa homossexual, o olhar da enfermeira é acusador. Nando confirma isso quando relata sua entrada no consultório médico:

E eu já entrei no consultório do médico já... esperando... Já com certeza quase aí ele falou ele falou que tem *ele explicou toda a situação ele foi muito.... acho que a abordagem dele foi bem positiva* e no dia, no posto cada dia vai uma especialidade, nesse dia ele era qualquer especialidade mesmo do médico que a gente passa, quando a gente vai mas nesse dia ele era infecto, então eu tive sorte de passar pelo médico infecto, no posto de saúde público, e *ele explicou perfeitamente* e eu já, como eu te falei, que eu tenho, assim, *a consciência de que eu poderia dar positivo*, poderia dar positivo, então eu entendi tudo... (Nando).

Nando nos mostra que, na relação de força existente entre ele e o médico, ainda é possível pensar que, ao considerarmos o HIV como uma construção social discursiva, como afirma Foucault (2021), capaz de estabelecer o que é normal e anormal (Foucault, 2010b), não há nada que determine que esse saber-poder deva ser utilizado para a economia do preconceito e da violência.

Na percepção de Nando, o médico rompe com esse construto social discursivo e inverte a posição do anormal. Ele age a partir de um olhar pedagógico-clínico que, embora observe e classifique, não atua para corrigir o corpo de Nando como um corpo objetificado, considerando sua experiência sexual homoafetiva.

O positivo, nas palavras de Nando, está nos possíveis que o saber crítico pode produzir ao não se submeter ao racional pelo qual o HIV foi historicamente produzido, a partir de uma percepção moral da infecção.

Da descoberta ao anúncio de estar soropositivo, existe a repercussão do resultado, como palavras que, ao chegarem aos ouvidos, carregam sentimentos marcados por uma carga social e histórica. Ainda assim, cada experiência se coloca

como única. Isso se deve à forma como cada percepção foi moldada e a como os dispositivos que a construíram mantêm suas forças.

Não existe um universal ou geral que possa enquadrar todas as reações ao saber-se soropositivo. Sonia, ao falar sobre sua reação a partir do resultado e da fala do médico, descreve que:

naquele momento *entrei em choque*, eu não conseguia perguntar pra ele (médico), não tá errado? Dizia o médico: “Olha a moça que está aí fora vai te atender”. E *não me explicou nada*, a assistente social que me levou, aí a psicóloga começou a conversar comigo, *fazer várias perguntas*, ela perguntou se queria chamar meu marido, e eu disse que quero que chamem ele sim. “Ah, vamos chamar seu marido, vamos fazer o teste no seu marido”. Aí já liga que então foi dali, ele me traiu. São dois sentimentos, *de raiva de querer saber*, pra querer fazer alguma coisa, *vou ter que me matar*, o medo da criança nascer infectada e de *achar que acabou*. *Pra mim, no momento foi como se eles tivessem decretado minha morte* (Sonia).

A reação de Sonia, ao destacar o choque ao receber a notícia, o sentimento de raiva por perceber uma suposta traição e a vontade de morrer, pode ser pensada como resultado das produções da ideia de *dispositivo* desenvolvida por Foucault (2015b). O HIV foi o dispositivo que fez Sonia ver além de sua condição soropositiva, marcada por uma série de relações, como a traição e o rompimento da aliança combinada com seu marido, dissolvendo uma identidade fixada no casamento (Silva, 2014).

Ou seja, o HIV fez com que Sonia olhasse para as relações que produziram sua subjetividade e que, naquele momento, se quebravam. Ao estar colada às ideias de um casamento sem traições e, portanto, sem riscos, o HIV, enquanto dispositivo que faz enunciar, também faz romper com as submissões dadas a partir da pedagogia do silêncio.

Essa relação do dispositivo, em que Foucault (2015b) propõe que os corpos são capturados e tornados produtivos a partir da sexualidade, dialoga com o que Silva (2014) discute ao pensar a identidade como um mecanismo de fixação, sustentado por uma matriz essencialista produzida pela cultura para significar o corpo, as relações, os papéis a serem desenvolvidos e a própria vida.

Com o HIV, é possível vê-lo como uma identidade repleta de significações que, comumente, não conseguem localizar a humanidade dentro da diferença. Nas palavras de Nando, é possível perceber essa relação entre dispositivo e identidade a partir de sua reação ao resultado do HIV positivo:

Foi um baque pra mim quando eu tive o diagnóstico. Não porque eu vivia aquela...Assim, no momento eu fiquei meio que chocado, porque não tem como não ficar, mas não foi um baque, sabe? Eu não chorei, por exemplo. Aí eu vejo pessoas que saem de lá chorando toda vez que eu vou, assim, que eu vou passar pela médica e às vezes tem uma pessoa que vai fazer um exame. E eu não fiquei desse jeito, porque eu vivia uma vida, assim, no meu meio, meio que promiscuo, que eu transava demais com outras pessoas. Então eu...Sabe quando você espera pelo resultado e você já meio que tá aguardando aquilo? É meio irresponsável, eu fui demais, mas...Não tem como voltar atrás, eu falo. Ah, não tem como voltar atrás, agora é se cuidar” (Nando).

Nas palavras de Nando, é possível perceber o papel do dispositivo (Foucault, 2015b) na forma como ele responde à notícia de estar soropositivo. Um dos pontos em destaque é o regulamento produzido pelo dispositivo da sexualidade, ao nomear sua vida como promíscua, referindo-se ao comportamento considerado “irregular”, marcado por vários parceiros sexuais.

Em Silva (2014), essa ideia descreve a identidade fixada pelos regimes culturais, que imprimem na percepção uma visão esperada, como ele atribui ao saber sobre sua sorologia. Trata-se de uma consequência atribuída a atos imorais e a comportamentos considerados transgressores, que moldam a subjetividade: seu modo de ser e agir nas experiências cotidianas. A visão de Nando se aproxima da de Caio ao falar sobre sua reação diante do resultado médico:

Então eles falaram, então não é de agora, já de lá de trás que vinha (estava avançando para AIDS). Não entrei em desespero, não entrei em desespero, porque eu já sabia o que tinha acontecido com o outro (o namorado). Então eu já sabia que provavelmente eu estava no mesmo caminho (Caio).

A fala de Caio sobre como foi sua reação ao saber-se soropositivo não manifesta desespero, por ter sido atravessada pelo dispositivo do HIV a partir da experiência com seu namorado. Isso se mostra quando Agamben (2005), ao ler Foucault (2015b) sobre o dispositivo, descreve que ele é, ao mesmo tempo, aquilo que produz e aquilo que orienta.

O dispositivo HIV, no contexto de Caio, produziu sua percepção a partir das vivências com o namorado. Para ele, o dispositivo não apenas construiu uma forma de compreender o fato de estar soropositivo, como também orientou sua reação, sem apresentar os mesmos movimentos de desespero observados em Sonia e Paka, que descreve sua reação da seguinte forma: “Ah, eu comecei a fazer um monte de

pesquisa. Não pode, né? O certo era procurar um psicólogo, pra me ajudar. Foi muito difícil. Eu tive que procurar ajuda. Eu tive que procurar ajuda!” (Paka).

As palavras que descrevem a reação de Paka mostram que, embora o saber sobre sua sorologia seja uma experiência individual, ela é resultado das linhas que convergem no funcionamento do dispositivo, como apontam tanto Deleuze (1990) quanto Agamben (2005), ao compreenderem como máquinas produtoras, controladoras, mas que também permitem fugas.

Embora capturado pelos discursos que, ao longo da história, fixam a identidade do que o HIV não é (Silva, 2014), Paka encontrou sua fuga na ajuda de um psicólogo, que o colocou em outras linhas de operação do dispositivo, produzindo outra subjetividade, capaz de auxiliá-lo a lidar com o fato de ser soropositivo.

Da descoberta nasce uma nova realidade. Embora viver seja colocar-se em diferentes cenários existenciais, inseguros e improváveis, o HIV cria um “mundo estranho”, “um mundo possível”, “um mundo de fuga”, “um mundo dos remédios”. Para que um mundo “novo” aconteça, outro morre. Morrem as expectativas e nascem as possibilidades.

Das mortes nasce o luto, seja pela violência vivenciada no corpo, pelos atravessamentos produzidos pela percepção do HIV como uma doença socialmente construída, pela objetificação criada sobre o corpo, pelos regimes de normal/anormal, e pelo nascimento do monstro que se revela a partir do olhar médico, atravessado pelos dispositivos, sobretudo o da sexualidade (Foucault, 2021; 2010a; 2015b). O luto se faz em um novo corpo falante.

As falas que descrevem a nova realidade a partir da descoberta do HIV mobilizam a pensar o luto como uma categoria analítica para compreender os corpos soropositivos, a partir de Butler (2023). A perda é o rompimento que separa duas realidades para sempre. A separação acontece quando perdemos um ente querido, mas também ocorre na transição de um corpo soronegativo para um corpo soropositivo.

Trata-se de uma separação sem volta, que traz o sentimento de perda e de desligamento, ocasionando o luto: a dor por se desvincular do corpo “normal” e de tudo o que a ele é inscrito. No deslocamento de uma sala para o corredor que leva para fora do espaço médico, o mundo transiciona.

Nas palavras de Sonia, a nova realidade soropositiva foi como se: *“todos ali olhavam pra mim já de maneira diferente. Eu não sei se era coisa da minha cabeça,*

mas parece que até na hora que eu saí da sala da psicóloga, todos me olhavam diferente. Como se todos já sabiam o que estava acontecendo, menos eu” (Sonia).

A partir da perda, vem a vulnerabilidade. Nas palavras de Sonia, seu corpo, ao não ser mais o mesmo, coloca-se exposto ao público, desprotegido por um marcador soropositivo. A vulnerabilidade, como consequência da perda, indica que nossos corpos não estão sozinhos, estamos lançados em teias que nos ligam socialmente.

Para Sonia, o sentimento da perda se dá pelo desligamento desse comum soronegativo que já não a identifica. E, por não mais estar inscrita nesse comum, seu corpo pode ser violentado por ser soropositivo (Butler, 2023).

O luto, representado pela perda de um corpo soronegativo, marca toda uma vida. Isso porque estar soropositivo não é algo facilmente aceito. A dor persiste enquanto assegura-se ao objeto que a faz doer. Butler (2023) compreende que o luto nos coloca em uma posição de submissão, ao estarmos condenados a seguir com um *corpo não desejável*.

É um corpo controlado e tratado como incorrigível (Foucault, 2010a). O luto representa a lacuna que não se preenche, pela falta de entendimento que possa assessorar a mudança de não mais habitar um corpo ao qual já se estava acostumado. Nas palavras de Paka, o resultado da descoberta de estar soropositivo é um sentimento:

que eu fiquei muito abalado, muito. Aí eu precisava...Eu não estava bem, tipo, deixei o meu corpo, meu psicológico a ponto de eu querer mudar, né, ir embora da cidade. Porque eu queria me afastar por medo das pessoas, de...alguém descobrir...Até hoje eu vejo um preconceito altíssimo”. (Paka).

Quando falei com Paka, ela já não residia mais na cidade em que descobriu sua sorologia. A cidade é um espaço de representação e, quando perdemos algo nesse espaço, ele pode se tornar um *local de servidão*, como Butler (2023) descreve nas relações que nos prendem a explicar o luto. Falar sobre estar soropositivo não é uma condição possível para todas as pessoas.

Ao estarmos inseridos e inseridas no social, somos lançados e lançadas a ser produzidos e produzidas, assim como desfeitos e desfeitas, por e para as relações. Nunca somos sozinhos. Nosso corpo não é um espaço privado. Estamos à mercê das políticas, da educação, das normas, das estéticas.

O entendimento de Paka ao mudar de cidade é uma estratégia de construir seu novo corpo a partir de novas relações, que a direcionam a sair do luto e voltar ao público. Um novo corpo aberto a novas intervenções sociais.

Como Foucault (2015b) argumenta, é pela sexualidade que somos descobertos e constituídos por saberes. O corpo soropositivo, nesse sentido, se inscreve no que Butler (2015) chama de *perpétua desintegração*. Trata-se de um corpo que se modifica continuamente e que, ao longo da história, como mostramos no primeiro estudo, ao ser inscrito nos regimes de verdade, torna-se múltiplo, oscilando no binário normal/anormal, a depender das óticas que o descrevem.

A história fez com que o corpo soropositivo fosse significado a partir de uma identidade de sujeição. Os resultados disso aparecem na forma como nos relacionamos com as modificações do nosso próprio corpo. Somos corpos infantis, corpos juvenis, corpos adultos, corpos velhos. O corpo soropositivo, em sua modificação, destoa por estar ligado ao modo como a história o produziu: como um corpo desobediente, punido por ser gay, puta ou drogado e tantos outros.

Hoje, reescrevemos essa história a partir das falas das pessoas participantes, sobretudo a de Paka, ao nos descrever que:

No começo, não adianta a gente *falar que é fácil, que não é!* Mesmo com a ajuda, eles explicaram, é assim, você vai tomar remédio, não sei o quê. No começo *foi difícil a aceitação* do remédio, *eu passava mal*. Mas, hoje eu vejo que eu tomo remédio e *isso tornou parte da minha vida*. E vai ser, né? Parte da minha vida. Eu vi um relato que dizia sobre uma cura e não é. Pra mim, *o remédio já é uma cura*" (Paka).

Pelas palavras de Paka, é possível mobilizar o conceito de *biopolítica* em Foucault (2015b), ao descrevê-la como uma máquina que, entre suas várias funções, regula o corpo. Paka, ao estar inserido no sistema de governo político por meio da medicação, passa a compreender o HIV como parte de sua vida.

O efeito da biopolítica é recolocar o corpo desregulado em uma condição de regularidade, cujo resultado é devolver a saúde e inserir o corpo soropositivo em outro regime de verdade e funcionamento. O remédio, a carga viral indetectável, os exames e a frequência das consultas são mecanismos que devolvem ao corpo sua utilidade, tal como descrito por Paka, e que também aparece nas falas de Nando:

No outro dia eu já *fui lá no ambulatório*, peguei todas as informações de *remédios que eu tinha que tomar*. O que me chocou bastante foi a

questão do remédio, sabe assim? Eu já sabia que pessoas que conviviam com HIV tinham que tomar remédios todos os dias. Aí eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir tomar todos os dias esse remédio? Será que vou lembrar? *Vai ser pra vida toda, né? Isso dá um baque na gente. É pra vida toda isso daqui.* Então foi mais isso, assim, que eu me refiro. Mas foi a questão mesmo da ferida que me levou a chegar nesse...A descobrir. E isso aí, assim que eu comecei a tomar meus remédios, a ferida passou, que era isso mesmo. O médico explicou que era uma questão do corpo querendo mostrar pra mim que eu precisava começar a tomar os remédios". (Nando).

Nas palavras de Nando, ao ser inserido nas redes de funcionamento da biopolítica (Foucault, 2015b), o remédio ainda se apresenta como um marcador da vulnerabilidade que o HIV produz em sua realidade. Para Nando, o remédio sinaliza o que Butler (2023) chama de *vulnerabilidade primária*.

O fato de existir um remédio que possibilite sua vida, impedindo a morte em decorrência do HIV, não elimina o desamparo que se mantém para além da medicação. Isso porque, em nossas sociedades, a vulnerabilidade não é uma condição partilhada. Ela é distribuída a partir de critérios que operam socialmente, classificando quais vidas importam mais e quais importam menos.

Assim, mesmo com a existência de uma série de meios e cuidados, ainda não se garante que corpos soropositivos não sejam violentados por não serem soronegativos, assim como ocorre com pessoas trans, pretas e com outras populações em sociedade.

Os corpos estão inscritos tanto por marcas que sinalizam o que somos e o que não somos, quanto por marcas de poder (Louro, 2015). Quando somos formados a partir de marcas que nos aproximam da diferença, a compreensão de ser um corpo soropositivo pode produzir experiências diversas, como as que apresentamos nas falas de Sonia e de Paka.

Uma das possíveis explicações está na forma como os corpos são lidos. Se utilizamos apenas as percepções culturais como base, sem confrontá-las, corremos o risco de manter as significações pelas quais os dispositivos descritos por Foucault (2015b) nos fazem ver apenas como corpos estranhos.

Nas falas de Caio, um corpo soropositivo não foi estranho. Foi uma forma de anúncio na qual seu corpo, em algum momento, poderia estar inscrito. Isso por ele...

já ter descoberto do parceiro há um ano antes, *é como se eu já tivesse preparado, né?* Como se eu já tivesse preparado, como se eu tivesse assim, *qualquer hora é minha vez*, qualquer hora vai sair alguma coisa. E tipo assim, como a gente se via há três meses, há seis meses ou até mais tempo, e no decorrido do tempo, quando eu descobri, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu não tenho que fazer nada. *Eu vou me matar?* Não. Simplesmente vou procurar, foi o que eu fiz, vou procurar onde resolver isso, como fazer, o seguimento que eu tenho que fazer e seguir até as condições se acertar. Aí foi o que eu fiz” (Caio).

O corpo é um estado de instabilidade, no qual não há uma segurança que o mantenha sempre o mesmo (Butler, 2015). Somos atravessados pelo tempo, pela cultura e pelos regimes que, em diferentes momentos, nos constroem e nos desmontam.

O corpo soropositivo e as vivências da descoberta mostram que as pessoas soropositivas são inscritas nas linhas dos múltiplos dispositivos descritos por Foucault (2015b) a partir da forma como seus corpos foram produzidos pelo que se tornou possível ver e não ver sobre o HIV.

As experiências da descoberta tendem a ser negativas quando o campo de acesso ao ser soropositivo foi marcado pelo que Foucault (2021; 2010a; 2015b) descreve como *anormal, monstro, corpo a ser corrigido*. Quando essas marcas são direcionadas a si mesmo, produzem impactos como sentimentos de vulnerabilidade, de morte e de perda, entre tantos outros que repercutem na vida e nas relações.

As experiências das pessoas soropositivas desta pesquisa mostraram-se mais difíceis, especialmente nas falas de Sonia e Paka, ao se inscreverem nas ideias que já tinham sobre o HIV. Eram visões atravessadas por construções estereotipadas do passado e por julgamentos morais que colaboraram para a produção de uma identidade do que o HIV não era. Nas falas de Caio e de Nando, é possível observar que, por algum conhecimento anterior, foi mais fácil lidar com a descoberta.

As dificuldades apresentadas pelas pessoas participantes da pesquisa indicam que a percepção social pautada em visões estereotipadas prejudica tanto as próprias pessoas quanto as relações nos espaços de saúde. Ao descobrirem sua sorologia, o impacto ocorre por serem lançadas ao vazio do desconhecido: a ausência de conhecimento e o excesso de saberes que, historicamente, produziram uma verdade sobre o HIV, implicando uma visão distorcida e irreal sobre o viver soropositivo.

Essas lacunas apontam para o papel que a escola pode desempenhar ao criar regimes de verdade que fissurem os saberes históricos produzidos sobre o HIV, como foi possível acompanhar no primeiro estudo. O currículo e a escola, ao tratarem dessas questões, mobilizam saberes que não funcionam apenas para a produção de conceitos, mas, principalmente, para o uso na vida real e nas experiências cotidianas.

Assim, é possível afirmar, a partir das falas de Sonia, Caio, Paka e Nando, que as experiências da descoberta do HIV evidenciam os regimes de verdade e de poder produzidos historicamente e que se mantêm presentes nas diversas relações em sociedade. A descoberta de estarem soropositivos não impacta tanto quanto os discursos que essas pessoas espelham em suas próprias vidas.

Os saberes produzidos ao longo da história são acionados, moldando principalmente as experiências da descoberta descritas como negativas, como nas falas de Sonia e Paka. Caio e Nando, ao estarem atravessados por outros regimes, não sentiram o mesmo peso, por não associarem o HIV às narrativas negativas da história.

Isso nos leva a compreender que as questões que dificultam a descoberta do HIV não são produzidas pelos saberes biomédicos, mas, sobretudo, pelo que é construído socialmente sobre o vírus, a doença e as pessoas soropositivas. Assim, é possível afirmar a importância de uma educação crítica.

Seguimos olhando para as falas de Sonia, Caio, Paka e Nando no contexto das relações com o espaço médico. Nesse eixo, algumas pistas já sinalizaram uma certa precariedade nas relações entre as pessoas profissionais da saúde e as pessoas soropositivas.

Com o intuito de buscar mais elementos para reflexão, seguimos a partir dos relatos, que muito nos mostram e nos ensinam a afirmar a importância de uma educação e de uma formação que se entendam com as diferenças e que estejam em constante movimento de desconstrução e inclusão.

5.16 Eixo 2: Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?

A memória é o meio de lembrarmos dos acontecimentos do passado que não podem ser repetidos. Essa lembrança nos faz pensar nos massacres realizados durante o período nazista, na Segunda Guerra Mundial. Segundo informações da

United States Holocaust Memorial Museum ([199?]), entre os anos de 1933 e 1945, o sistema nazista da Alemanha construiu mais de 40.000 campos que aprisionavam e matavam pessoas.

O sistema contava com uma organização que categorizava as pessoas a partir de grupos que correspondiam a judeus, testemunhas de Jeová, pessoas homossexuais, entre outras. O signo que representava cada categoria de pessoas era feito por meio de um triângulo. O das pessoas homossexuais era rosa, o das testemunhas de Jeová era roxo, e o dos/as judeus era a estrela de Davi.

As categorizações que eram feitas estavam voltadas a um padrão que tinha como critério excluir todas as características físicas, sociais, políticas, religiosas e sexuais, entre outras, por não corresponderem ao ideal nazista, a produção de uma “raça ariana”.

O mau exemplo ocorrido na Alemanha com o nazismo faz ressoar outras relações e espaços em que corpos e pessoas são colocados sob o regime que Foucault (2005) nomeia como o *exercício do racismo*. O racismo é um poder exercido inicialmente para o funcionamento dos Estados, localizado no papel do soberano e nos governos do biopoder, sob a lógica de fazer viver e deixar morrer.

Esse exercício visa intervir nos corpos e nas vidas, podendo ser lido como um mecanismo que objetiva manter a espécie humana e, ao mesmo tempo, purificar a sociedade. Ao pensar o racismo, Foucault o localiza nos séculos XVII e XVIII, com os soberanos, e o biopoder a partir do século XIX.

Entretanto, ambos mantêm relações diretas e indiretas nos diferentes tempos e espaços em que foram e são exercidos. O poder soberano se inscreve por meio de mecanismos disciplinares. O biopoder, por meio de mecanismos regulamentadores.

Ao pensar nos dias atuais, não há uma desconexão entre ambos os poderes e seus exercícios. Recordar-se que a história não segue uma linha linear e gradual de progresso. Ao contrário, ela se movimenta por novas formas e práticas em que saberes e poderes são exercidos e aplicados, como uma atualização das tecnologias utilizadas no passado.

Um exemplo próximo e possível de pensar o exercício de poder sob o regime do soberano foi a megaoperação dos policiais do Rio de Janeiro que matou 117 pessoas no Complexo da Penha e no Morro do Alemão, em novembro de 2025. No que tange ao biopoder, um exemplo foi a atuação do Estado brasileiro no contexto da pandemia de Covid-19 (2020–2022), em que se deixou morrer mais de 700 mil

peessoas. Isso sem esquecer as mortes em decorrência da AIDS (nos primeiros anos da década de 1980) e que, ainda assim, sob a regulação do Estado conseguiu-se reduzir o número de mortes para que a espécie humana não se extinguisse.

O trabalho do biopoder é estatizar o corpo biológico, operando como uma tecnologia que agrupa os corpos a partir da linha biológica (Foucault, 2005). O poder sobre a vida tem como objetivo fazer viver e, para que isso ocorra, esse poder tem como legitimidade sua intervenção na maneira como as pessoas vivem. Para fazer viver, é preciso fazer com que as vidas tenham maior tempo na sociedade e, assim, as intervenções ocorrem, seja nas pandemias, epidemias ou junto às pessoas soropositivas. Isso é observado na fala de Sonia, quando descreve o momento do parto de sua filha:

A minha terceira filha teve sofrimento fetal, lembro eles dizendo que a gente vai levar ela. Depois a gente trás, mas a gente não garante, porque ela não chorou e ela estava roxinha inteirinha. Então entrei em desespero. Eles tiraram ela com a bolsa, e tiraram ela depois, para não ter contato com o sangue. Aí eu entrei em desespero, falei meu Deus, mas hoje eu me arrependo. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me opera? Eu já vivi uma vida que não é fácil e tinha 2 crianças pequenas, mais novas, com 8 meses e a outra com 4 anos. E eu era um....Não Podia passar debaixo da cueca, que eu tava grávida. Muito fértil. Aí eu falei, doutor, por favor, me opera, pelo amor de Deus, ele falou "mais porque, você é nova, você não tem idade para operar". Falei, por favor, doutor, por favor, eu entrei na fila do SUS. Ele me perguntou, "seu marido quer?" Eu falei quer. Mas ele nem sabia. Eu tirei essa fala que depois eu mesmo ficava falando, meu Deus, como eu consegui falar isso? Ele falava, "mais porque?" Eu chorando, eu falei para o médico, eu não sou digna mais de pôr nenhuma criança no mundo. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, que existisse no mundo. Eu não sou digna mais de pôr nenhuma, nenhuma criança, no mundo. Eu não posso mais fazer isso. É botar uma criança no mundo, correndo o risco de contaminar. Aí ele andou para lá, para cá e era um médico até que jovem, ele falou, "olha, você teve uma cesárea mesmo, está aberto mesmo, você tem certeza?" Aí eu chorando, eu falei pra ele, eu tenho certeza. "Você quer mesmo, seu marido quer?" Eu falei, quer também. Mas ele nem sabia. Aí ele falou, "então tá, vou fazer uma laquiadora porque já está aberto mesmo, mas você não vai poder ter filho nunca mais". Naquele momento eu me senti aliviada. Eu falei, meu Deus. Pelo menos se eu fizesse mal pra essa criança, eu não faria mais pra nenhuma, né? Eu me senti muito, muito aliviada. Passados os anos, agora com outra mente eu falo, porque é que eu fui fazer isso, não é? Embora ter filho hoje seja muito difícil, né? Mas eu falo, por quê? Achar que eu não poderia ser mais capaz de botar nenhuma criança no mundo. Porque eu sou uma pessoa normal, eu posso ter 10, 20 crianças, posso mas não, não quero, mais... né? (Sonia).

A partir da fala de Sonia, vislumbramos o biopoder no cotidiano, em que o papel do médico exerce legitimidade dentro do sistema de saúde, instituição do Estado que estabelece normas e regras e possibilita que seja feita a decisão sobre quais mulheres podem e devem reproduzir. A princípio, podemos ler a situação como uma forma de ajuda oferecida pelo médico, durante o momento de desespero que Sonia vivenciava.

Contudo, alguns pontos devem ser destacados, como o fato de haver a autorização de outro homem sobre seu corpo, a fala do médico sinalizando a importância da intervenção de seu marido, o corpo de Sonia aberto e a decisão do médico visando não a individualidade, mas o reflexo do que a própria Sonia dizia: ao ser uma pessoa soropositiva, não ter condições para gestar outra vida, acreditando que, no contexto, sua filha teria o HIV verticalmente do mesmo modo em uma outra gravidez.

O fato de ser uma mulher na sociedade brasileira ainda é constantemente atravessado pela intervenção de homens que decidem sobre seus corpos e vidas. Soma-se a isso que, ao estar em diferentes espaços e a depender das intersecções como a de ser soropositiva e estar no espaço da saúde, marcado por uma predominância sistemática de homens, no caso de Sonia, a decisão sobre sua vida ficou nas mãos de um médico, não possibilitando uma reflexão sobre seus direitos.

A falta de conhecimento que Sonia possuía a colocou em uma situação de maior vulnerabilidade, pois o médico, ao tomar a decisão, não considerou que o próprio procedimento que estava realizando não transmitiria o HIV à filha de Sonia. A decisão tomada pelo médico repercute em outra fala, quando Sonia disse que:

logo depois, em seguida, eu perdi um filho com 9 anos e que eu poderia querer outro filho. *Não pude ter por conta dessa minha mentalidade da época, né?* Eu soube de um caso que a mulher já tinha 3 filhos e ela era soropositivo. O marido dela estava morrendo já. E ela queria ter filho, porque ela com filhos assim, ela tinha alguma, algumas vantagens, alguns benefícios, algumas coisas. Eu ficava indignada. Eu falava, meu Deus, correndo um risco de colocar criança no mundo, de contaminar. Então era isso que eu não queria. Eu acho que até por isso também que ali naquele momento eu falei, eu não sou digna, eu não posso fazer isso. E ela falava assim, num tom de quê, ela ia conseguir aposentadoria, alguns benefícios. *Para você conseguir algum benefício hoje, com o preconceito que existe, você tem que se expor. Muita gente não tem esses benefícios porque não consegue ir lá e se expor, né?* (Sonia).

O poder sobre a vida que Foucault (2005) revela nos mostra que o fazer viver, em alguns casos, não considera outros aspectos da vida além do biológico. Quando falávamos com Sonia, as lágrimas caíam de seus olhos, ao pensar na morte de seu filho e na possibilidade de ter outro, foram interrompidas pela gerência médica, que apenas olhou para o buraco aberto de sua barriga como um vazio que refletia sua própria percepção.

No exercício do biopoder, a medicina exerce um poder que gerencia a vida a partir de critérios previamente formulados e que, ao não pensar os desdobramentos que um corpo possui histórias, acontecimentos, tragédias, cumpre o papel de cuidar do corpo biológico, mas também de violentá-lo. Os espaços em que o saber opera fazem com que corpos soropositivos estejam constantemente atravessados por violências institucionais, sorofobia e tantas outras, como é possível perceber quando perguntamos sobre a existência de alguma relação de preconceito no espaço da saúde, e a resposta foi que:

Sim, teve. Quando eu fui ganhar minha filha, eu fui sentindo contração, pro hospital, eu entrei e o médico disse que estava dilatando e que teria que ser cesárea pra fazer o parto e eu sentindo as contrações. A enfermeira vinha e estava minha prancheta e tudo. *Eu não ficava comentando que sou soropositivo, eu já estava dentro do hospital, eles tinham acesso a todas as informações* e eu não sabia que eu tinha que chamar ela e falar (a enfermeira). Me colocaram em uma sala junto com outra mulher, que teve as dores foi pra ganhar o neném e eu continuei ali. Me mandaram pro quarto e teve uma hora que minha barriga endurecia hora parava, fique ali um tempo. Ai trocou de plantão e veio um médico e eu falei doutor, e já tinha falado para a enfermeira, a minha barriga endurece e de repente parece que não tem mais nada na minha barriga, como se tivesse esvaziado um saco. A minha bolsa não tinha rompido. Ai a enfermeira foi lá pegou minha prancheta, foi e voltou, a enfermeira voltou, chamou o médico, ele veio me examinou e falou “olha vamos fazer um ultrassom de urgência” levou os aparelhos e fez. Ele olhou para mim e disse que eu estava em sofrimento fetal já a algumas horas e vamos ter que fazer o seu parto com urgência e me falou do risco. Pode correr o risco de perder o bebê. Ai ele foi e voltou, *a enfermeira, veio e me falou “por que você não me falou que era soropositivo?” Muito brava comigo, por que eu tinha que ter falado para ela.* E eu sei que lá dentro do hospital se a gente for áspera eles vão tratar com mais descaso. Então eu me calei, mas fiquei com aquilo, e tinha uma outra pessoa no quarto comigo. Ela veio e falou assim comigo *“você tinha que ter me falado!”* Ela colocou as coisas, a toquinha, a meia no pé, eu já estava com a roupa do hospital, e ela foi me levando pra sala de parto falando *“é um absurdo, um absurdo!”* Toda hora questionava que eu tinha que ter falado. Quando eu estava chegando perto do elevador eu falei, olha o hospital tem todas as minhas informações, a minha prancheta estava lá, eu não sabia que tinha que falar para você que eu era uma paciente com

HIV. Ela ficou quieta, mas ela já tinha me falado bastante coisa. *Eu fiquei a todo momento me sentindo, que agora, todo mundo do hospital vai saber e ela vai começar a me tratar mal e eu fiquei com esse sentimento (Sonia).*

As falas de Sonia ressoam sobre algumas ideias que Butler (2023) desenvolve a respeito da *vida precária*. Ao olharmos a relação entre a enfermeira e Sonia, utilizamos a lente de Butler, que nomeia esse tipo de relação como *endereçamento*. Ao nascermos, somos colocados no mundo por aquilo em que aparecemos para este mundo (para os/as outros/as).

Não apenas somos produzidos para o gênero, mas para toda marcação que nosso corpo possa ter, tanto pela fisiologia quanto pela anatomia, assim como por outras classificações, descritas por transtornos e deficiências. E, por estarmos lançados e lançadas no mundo, estamos submetidos e submetidas, seja por nossas vulnerabilidades (um acidente que possa nos ocorrer), necessidades (a prática médica), pelo gesto que nosso corpo faz (andar como um homem sendo uma mulher), pelo tom da voz (um homem com uma voz afeminada) ou até pelo nosso silêncio (é muda?).

A partir de cada uma dessas formas de aparição, e de muitas outras, somos reconhecidos/as e tratados/as a partir desse reconhecimento. Nosso corpo é público, e estamos sendo governados pelo olhar.

No contexto da fala, Sonia se endereça à enfermeira de duas maneiras. A primeira é para ser acompanhada na realização do parto. A enfermeira tem a responsabilidade de cuidar de Sonia, pelo fato de ela se encontrar em um estado de necessidade e de cuidados médicos. Nesse momento, a enfermeira não sabe sobre a sorologia de Sonia.

Quando a enfermeira passa a ter esse conhecimento, Sonia é endereçada por ela não mais como uma mulher que está prestes a ter um bebê. Ela passa a ser endereçada por um novo corpo, lido a partir dos regimes específicos que a sociedade elaborou. Por isso, o constante questionamento, chamando a atenção de Sonia por não ter avisado que era soropositiva.

A fala da enfermeira mostra a violência ao produzir sobre Sonia um corpo precário, não pela fragilidade resultante do parto, mas pelo que é construído socialmente sobre ser soropositiva. Ainda assim, o endereçamento faz com que Sonia resista, devolvendo à enfermeira a resposta de que não cabe ao profissional saber

sobre sua sorologia, mas, sim, realizar seu trabalho e, em sua atuação, utilizar os equipamentos que assegurem ambas, como luvas, máscaras e demais recursos.

Outras falas mostram relações de estigma e preconceito, quando perguntamos a Paka se, em algum momento, havia observado alguma relação de preconceito com alguma pessoa da saúde:

Quando eu fui fazer a cirurgia, *eu senti preconceito pelo médico*. Na hora que eu falei... Na hora que eu fui fazer a cirurgia, no nariz, *na hora que eu falei...* Mas a minha médica (a que acompanha com o tratamento do HIV) falou que não precisava falar, que ninguém precisava saber sobre isso. Porque eu sou uma pessoa normal, mas eu falei, ah, vou falar. Falei, a médica, “você não tem que falar nada. A pessoa tem que se cuidar. Ele tem os meios pra se cuidar”. Aí, eu falei, nossa, *ele mudou o ar na hora. Todo mundo me olhava assim, diferente*. Eu vi que ele me olhava diferente. Aí, ele furou o dedo, né? Ele furou. Na hora que ele furou o dedo, ele falou, *Ah, eu preciso de um diagnóstico seu, preciso ver se os seus exames tá certo. É...Ah, eu preciso ver se tá tudo ok. Aí ele falou desse jeito pra mim: “Por que eu tenho família e preciso me cuidar”*. Nossa *eu me senti muito mal por isso*. E eu acho que eu tenho os áudios disso até hoje, mensagem, dele falando pra mim, que eu tinha que ver se eu estava tudo bem. *Eu falei, pô, tô me cuidando*. Foi muito ruim, muito ruim, muito ruim, porque *eu senti preconceito e senti que as pessoas, só porque eu tenho isso, não me tratam como uma pessoa normal*. Eu me arrependi amargamente de ter falado. Amargamente. Podia ter ficado quieto (Paka).

Ao falar sobre sua experiência em um espaço de saúde privado com um médico, Paka descreve a situação como um sentimento ruim, ao se ver, pelo endereçamento do médico, como “anormal” por ser uma pessoa soropositiva. Paka nos mobiliza a pensar com Butler (2023), ao fazer uma releitura de Lévinas por meio da *metáfora do rosto*.

O rosto, para Lévinas, não diz simplesmente respeito a algo físico, no que tange à aparência. Antes, é a manifestação da vulnerabilidade que a pessoa expõe. Como se esse outro/a que é olhado/a fizesse um apelo para não ter sua vida interferida pela morte, por ser humano como aquele/a que o/a olha. Butler (2023) segue a visão de Lévinas quanto ao entendimento ético e de responsabilidade a que o rosto pode nos chamar a atenção.

Todavia, ela tensiona a ideia de rosto ao questionar que ele não é uma categoria universal que apela igualmente à vulnerabilidade. Destaca que o rosto é produto das somas do que somos social e politicamente, uma travesti preta e soropositiva pode não ser vista com o mesmo rosto humano que uma mulher

cisgênero branca. Cada rosto está inscrito em regimes de verdades que produzem poder. Existem rostos que podem ser negados ao não serem considerados como corpos que importam, assim como o corpo de uma travesti e o de uma pessoa soropositiva.

Pelas palavras de Paka, seu rosto, ao circular em sociedade, sobretudo após o procedimento realizado em seu nariz, será aquele que as pessoas julgarão como “padrão” e que não motivará a vulnerabilidade. Isso muda quando o rosto de Paka é revelado. Ele passa a estar inscrito naquilo que é produzido socialmente pelos preconceitos e estigmas e, para o médico que o atendeu, foi um rosto que se mostrou como perigoso, não humano.

Embora o convite de Lévinas provoque a ética e a responsabilidade, assim como a conduta médica, o médico que atende Paka responde ao que Butler defende como um rosto precário. A precariedade é a condição na qual alguns rostos são produzidos em detrimento de outros. A sorologia faz com que nossos rostos mudem nossa percepção de humanos. Do amor ao próximo, vivemos o ódio ao próximo, como se ele não fosse humano como eu, que leio e decido quais vidas merecem ser reconhecidas como humanas e quais não.

O médico é formado para exercer a ética, mas opta pela precariedade, resultando em uma postura sorofóbica. A precariedade pode ser observada nas palavras de Sonia, após suas experiências em espaços e com profissionais de saúde, como locais que despertam:

medo de ir no dentista, e aí eu vou no dentista. Porque o meu medo era mais totalmente a isso, eu vou contaminar outras pessoas, então não posso ir no dentista. Cheguei a perder um dente, por medo de ir no dentista e não, não querer, e o medo de não falar e contaminar outras pessoas porque na minha cabeça eu não pensei assim, ah, não, mas isso é esterilizado depois, não é usado, eu saio dali, não vão usar em outras pessoas é, eu tinha medo de ir no posto e tomar injeção e a enfermeira que aplicar ser contaminada. Então eu tinha medo. Aí, com o tempo, conversando com esse médico para mim, doutor Paulo foi assim uma benção (Sonia).

Nas palavras de Sonia, os desdobramentos possíveis do medo em revelar a sorologia e de ser alvo de preconceito e violência podem se manifestar nos diversos momentos em que se está em um espaço de saúde, criando certa resistência em frequentar esses espaços pelo perigo que representam.

A partir do que vimos nas falas de Sonia e Paka, considerando que se tratam de espaços públicos (Sonia) e, no caso de Paka, de um hospital particular, a experiência que o endereçamento produz faz com que a percepção de ser soropositiva/o nos espaços de saúde esteja marcada pelo preconceito, pelo medo e pela exposição, em razão da forma como são tratados/as.

Logo, é possível pensar que as pessoas que atuam no espaço da saúde, no que tange à relação com pessoas soropositivas, ainda estão marcadas pelo preconceito e, nas palavras de Nando, devem ser constantemente revistas. Nando, em sua fala, considera que:

A enfermeira, eu acho que *falta mais orientação quanto a questão do HIV*. Eu acho que ela deve ser uma ótima profissional, né? Uma ótima enfermeira, *mas na questão de HIV, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que estar capacitadas para receber essas pessoas*. Não pode jogar qualquer pessoa lá *sem conhecimento nessa causa, entendeu?* Eu acho que falta ali talvez uma, e não só nela, eu acho que no geral, uma *capacitação própria para receber essas pessoas, para elas não se sentirem estigmatizadas* ou...sabe, assim, naquele momento que é muito...como eu falei, para mim não foi, mas com certeza para a maioria das pessoas são um baque ou...ou, né...é...é quando a gente pensa que não são só homossexuais que, né...A maioria hoje em dia, as pesquisas mostram, são héteros. E mulheres que foram traídas pelo seu parceiro e passaram pra elas. Então, *imagina, a pessoa receber uma notícia dessa e ser tratada dessa forma, entendeu?* Então, pra esse tipo de pessoa, elas precisam de uma capacitação. Na questão dos amigos, eu acho que com certeza, por serem próximos, tentaria mudar a forma de falar. Então é no geral, sim. Eu acho que elas poderiam mudar a forma de falar. Só que o pensamento, se elas não buscassem conhecimento e quisessem mesmo aprender, continuaria o mesmo (Nando).

A fala de Nando mostra a necessidade de que o saber que forma as pessoas que atuam no espaço da saúde seja repensado. Uma possível forma de fazer com que essa formação passe a considerar as pessoas soropositivas para além da visão estigmatizante é por meio de uma decolonização da maneira como os saberes biomédicos têm sido ensinados (Reis; Santos, 2024).

As universidades e os saberes que nelas circulam ainda estão centrados em perspectivas biomédicas e técnicas, que criam barreiras para pensar a saúde e a atuação profissional por outros olhares e saberes. A formação generalista e técnica reproduz e reforça as relações de preconceito manifestadas nas falas de Sonia, Paka e Nando.

Os espaços de saúde, ao terem como matriz de constituição regimes de verdades e saberes estabelecidos em torno do HIV no âmbito biológico, e quando não transgridem esses limites ao se colocarem em contextos sociais, culturais e das diferenças, colaboram para que a visão sobre os espaços de saúde e sobre as pessoas que neles atuam seja marcada pelo medo e pelo risco, e não pelo cuidado. Isso pode ser observado na fala de Paka, quando perguntamos sobre suas experiências no espaço de saúde que frequenta:

Uma coisa que eu sinto ainda, mesmo estando aqui (em outra cidade), e sinto das pessoas, e eu sinto, e eu acho que eu vou sentir sempre, é normal. *Quando a gente vai buscar remédio, todo mundo fica com receio, todo mundo fica com vergonha, fica cabeça baixa. O momento mais ruim, pra mim, é mais buscar remédio.* Porque, por exemplo, eu vou buscar remédio, aí tem lá, onde você vai fazer o teste e onde você vai buscar remédio. Aí tem um dia que você vai pegar um exame de CD4, né. Pra ver como que tá a infecção, se tá tudo certo, se tomou o remédio certinho. É muito difícil. *Todo mundo fica com receio, todo mundo fica com vergonha, com medo do que o outro vai pensar*, tipo, de ser visto, de alguém sair falando. *Até hoje mesmo, na cidade maior, é difícil isso. Porque o preconceito tem tudo no meio gay é maior* (Paka).

No decorrer da entrevista, Paka relatou que, ao descobrir sua sorologia, precisou mudar de cidade. O medo o consumia por ser descoberto por alguém próximo. Essa foi uma forma de resistir para seguir com a vida, ainda que fosse muito difícil ter de modificá-la por conta de um sistema social sorofóbico que opera para produzir medo nas pessoas que vivem soropositivas.

O fato é que o medo, nas palavras de Paka, demonstra que o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) segue aquilo que Foucault (2000) chama de “o mesmo e o outro”.

O mesmo é aquilo que faz com que a sorologia possa ser lida e legitimada. Ao se deslocar para um espaço em que outras pessoas vão com o mesmo fim, o CTA se coloca como um espaço institucional que organiza os corpos e lhes dá sentido por estarem ali, a partir dos regimes de saberes que o campo biomédico produziu.

O outro é aquele que olha para Paka. Ao olhar para Paka, ele não se vê como um corpo marcado pela soropositividade. Assim, coloca-se fora do ordenamento do mesmo, não se reconhecendo nele, ainda que também possa ser uma pessoa soropositiva.

A episteme sobre uma pessoa soropositiva, produz o que é o mesmo, criando normas e fixando identidades. O outro produz a fronteira que determina a exclusão a partir da ideia formulada do mesmo. Essa relação entre o mesmo e o outro também é encontrada nas falas de Nando:

quando eu vou sempre no consultório, né, passar pelo médico, a gente sempre encontra pessoas que são do nosso convívio porque a cidade não é tão grande e só tem um ambulatório, se eu não me engano, então todo mundo se concentra nesse ambulatório. Quem não consegue, né, pagar particular e remédios, comprar na farmácia e tudo mais, frequenta esse ambulatório e a gente acaba descobrindo pessoas que tem e que são do nosso convívio, da balada e tudo mais. E nunca aconteceu de a pessoa, não sei, fazer algum comentário. E tem pessoas que até tem nas redes sociais. Então, eu sempre tratei como normalidade. Se eu tô lá, a pessoa também tá. Não tem por que a gente se tratar diferente e nem fazer comentários ofensivos. Eu não sei o que a pessoa passa adiante se ela fala para outras pessoas, porque eu acho que isso também é uma forma de invadir a nossa vida pessoal. O que acontece é da minha conta. Eu não passo pra frente quando eu vejo alguma pessoa e também espero que a pessoa não passe, mas a gente não sabe o que acontece. Mas como eu escolhi não falar para os meus amigos também, por não conseguir lidar com a minha família também, então eu não sofri, assim, preconceito (Nando).

Nas palavras de Nando, o “*mesmo e o outro*” (Foucault, 2000) são colocados como efeitos do que o CTA pode produzir um local em que diferentes pessoas podem e estão presentes pela mesma condição, não havendo uma identidade fixa que determine o que é uma pessoa soropositiva a partir das características que cada corpo pode apresentar. Ao ouvir Nando falar, é possível perceber que há certa “surpresa” quando, nas idas e vindas ao CTA, encontra outros que antes pareciam ser os mesmos da sociedade, aqueles vistos na balada e nas redes sociais.

Diferentemente da visão de Paka, Nando se reinscreve a partir da lógica de que, se um conhecido está ali, é porque compartilha da mesma diferença que o faz estar ali. Nando se coloca em oposição ao que Ferrari (2009) chamou de morte e morte dos homossexuais, ao tratar com normalidade as pessoas que ali encontrava, não reproduzindo os discursos que fazem com que o outro seja capturado pelos mesmos enunciados que também o atravessam por ser homossexual e soropositivo.

A percepção de Nando não é a mesma de Sonia, quando falou sobre sua relação com o CTA. Nas palavras de Sonia:

Hoje eu vou, sou bem atendida, eu gosto de lá, mas no começo eu cheguei a abandonar o tratamento por um tempo por que eu não me via naquele lugar. Você chega ali todo mundo olha, todo mundo sabe que ali é para esse tipo de tratamento ou hepatite ou algumas outras coisas assim. Hoje não mais. Mas eu tinha muito preconceito de ir nas consultas. Eu me sentia, meu Deus o que eu estou fazendo aqui. Eu questionava por que eu peguei isso já que eu não vivo dessa maneira. Pra mim, eles viviam de uma maneira errônea. Eles discutiam por macho, essas coisas assim, as mulheres brigando lá dentro, eu via muitas pessoas tatuadas falando de drogas lá dentro, não me via naquele ambiente, não queria estar ali. Então eu abandonei. Era um preconceito e um medo de ir lá e as pessoas começarem a me apontar. (Sonia).

Sonia, ao falar sobre o CTA, sinaliza pontos que Ferrari (2018) discute acerca da possibilidade de um espaço construir sujeitos. Nas palavras de Sonia, hoje o CTA parece ter sido ressignificado a partir do convívio nas idas às consultas. Todavia, a constituição de Sonia no CTA se deu pela necessidade que a colocou entre viver ou morrer.

Essa “verdade” pôde ser percebida nos momentos em que ela abandonou o tratamento, obtendo como resultado problemas de saúde que a fizeram retornar e mantê-lo até os dias atuais. O CTA não é uma arquitetura desligada da sociedade e, ainda assim, não dialoga plenamente com as pessoas.

Fato é que um dos problemas de Sonia em ir ao CTA estava no modo como ela via esse espaço: um local frequentado por pessoas com as quais não se identificava por não viverem como ela - “viados, putas, tatuados”. Pessoas que carregam sobre seus corpos *marcas de poder* (Louro, 2015). Nas palavras de Sonia, o preconceito era algo prévio. Ao estar soropositiva, o peso que ela distribuía a outras pessoas passou a ser o peso que ela mesma carregava, quando, no decorrer da entrevista, ela disse que seu

medo maior era de falarem dos meus filhos. Olha, não brinca.....por que eu tive esse preconceito. Hoje eu falo e tenho até vergonha. Na rua onde eu morava tinha uma mulher que todo mundo sabia que ela era soropositiva e as crianças dela eram pequenininhas. Uma filha minha queria brincar com elas na rua, mas eu não deixava e também não dizia o porquê. Eu sabia o porquê, não queria que se envolvesse, meu medo era dela ir.... eu não sabia também a forma como se pegava, ou de sair algum boato. Então era um preconceito, era um preconceito sim (Sonia).

O preconceito de que Sonia fala é aquele velado, silenciado pelas palavras, mas manifesto pelo não dito. Borrilo (2010), ao tratar da homofobia interiorizada, nos

ajuda a pensar o preconceito de Sonia a partir de como o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas são representados na sociedade.

As palavras de Sonia mostram um preconceito relacionado ao medo. Em uma sociedade que faz circular visões estereotipadas sobre o HIV, não é difícil compreender o quanto essas percepções foram construídas nela. Há o preconceito externo em relação a outras pessoas, assim como há também em relação a ela mesma.

A ideia de que o HIV é algo ruim a coloca no lugar de mãe protetora, criando meios para que seus/suas filhos/as não estejam próximos ao mal materializado pela vizinha. Quando, por sua vez, ela passa a ser uma pessoa soropositiva, o mal que ela antes distanciava agora está nela, tornando-se a detentora do mesmo mal representado pela vizinha. Pela vizinha, Sonia tem a *experiência-limite da outra* (Foucault, 2000).

A experiência-limite da outra diz respeito a como passamos a nos ver a partir do contato com uma outra pessoa. Esse/essa outro/a desestabiliza em nós a forma como percebemos a/o outro/a. Sonia tinha como limite ver o HIV a partir de normas e regras que construíam a vizinha de forma preconceituosa.

Ao passar a ser soropositiva, Sonia experiencia o limite de que as verdades produzidas sobre a vizinha não eram da vizinha, mas dos regimes de verdades que foram empreendidos sobre ela e incorporados por Sonia.

Próximo da experiência-limite de Sonia, Paka relata uma história que mostra outro exemplo:

Na minha cidade tem uma mulher que a cidade inteira sabe que ela vive com HIV. Ela chama Rosana. E eu sentia, tipo assim, todo mundo, ah, ela tem HIV. Nem HIV, ela tem AIDS. *As pessoas remetem mais a AIDS, que aí fala como se fosse uma coisa abominável, entendeu?* Ela chama Rosana. Ela tem o quê hoje? Deve ter uns cinquenta e poucos anos. *Ela vive super normal, perfeitamente.* Mas eu senti aqui, tipo, *as pessoas tinham receio com ela.* Já ouvi comentar, tipo, *ah, não tenho coragem de comer comida dela...* Ah como deve ser. Ah não sei o quê....E o povo tinha preconceito. *Tem até hoje, deve ter até hoje.* A cidade inteira ficou sabendo do diagnóstico dela. Mas é um diagnóstico antigo, entendeu? (Paka).

O exemplo de Paka, em diálogo com a experiência-limite de Foucault (2000), nos fala sobre o outro, no papel de Rosana. Ela é uma mulher marcada pela diferença por ser soropositiva e, também, por fissurar a percepção construída sobre o HIV que todo o município possuía. Paka diz que Rosana é soropositiva há muito tempo,

contestando, assim, a relação entre HIV e morte que circula nas sociedades desinformadas.

A partir de Rosana, o limite que antes era imposto sobre ser soropositivo é derrubado. Logo, as ideias de normal (soronegativo) e anormal (soropositivo) perdem sua força e seu poder sobre a percepção daquela comunidade.

Para Paka, o limite não apenas a ensinou a conhecer sua sorologia, ao destacar a distinção entre o que é o HIV e a AIDS, mas também a viver sua sorologia no sigilo, por saber das condições que Rosana enfrentou para ser o limite para algumas pessoas, e não para todas.

Em uma sociedade em que a sorologia é condição para relações de estigma e preconceito (UNAIDS, 2025), não revelar sua condição sorológica pode representar muitas questões. Uma dessas questões são os valores representativos (Foucault, 2000) atribuídos às pessoas soropositivas.

A partir do HIV, a percepção que a sociedade constrói é a de que o vírus marca o corpo, possibilitando a leitura de um corpo “perigoso” por estar doente. A partir dessa leitura estereotipada, cria-se uma classificação em que há os/as iguais = saudáveis e os/as diferentes = doentes. Essa lógica fixa uma identidade e a utiliza nas relações como uma forma de ler a pessoa soropositiva como alguém perigoso.

Dizer que se é uma pessoa soropositiva, a depender do espaço em que se vive, pode acarretar muitos prejuízos, como pode ser observado na fala de Sonia ao relatar a história de sua amiga:

Eu vou contar um episódio que aconteceu com uma amiga minha. Ela fazia parte da APPA (Associação Prudentina de Prevenção à AIDS), então ela frequentava lá, e tinha uma outra amiga que vinha, nós deixávamos as crianças na creche e vínhamos andando. Então nem ela sabia de mim, mas eu sabia dela. Mas ela não comentava. A outra, tinha o mesmo nome que eu, ficava juntas e essa falou “faço faxina com fulano de tal”, aí essa menina falou, “eu passo na APPA para pega cesta básica”. Ela subiu para ir pro serviço e eu e a outra continuamos. Ela foi falando, que a pessoa que atende no APPA, não sei se é assistente social ou o que, falou para ela, e ela contando para mim, que a que buscava cesta básica, ia lá por que fazia tratamento e era soropositiva. Eu falei nossa, não fala isso não, as vezes é mentira, eu tentando disfarçar.... No outro dia, a gente vindo, pois ela chegou na menina e falou “é verdade que fulano falou de tal falou para mim, que você passa na APPA por que você faz tratamento (para o HIV)” assim.....Nossa ela ficou assim tão eu senti a dor dela. Ela ficou tão arrasada, ela encheu o olho d’água, não sabia o que responder. Eu na hora, virei e falei não fala isso, isso dá até processo, ela pode ir lá processar e essa mulher perder o serviço dela. Ela não pode fazer isso. Isso é uma coisa sigilosa, nem você pode estar fazendo isso.

Não, não pelo amor de Deus, ela falou. Eu falei assim, para saber, por que a gente é amiga, pra saber se é verdade, mas foi um comentário infeliz. *Uma pergunta que ela não deveria ter feito.* Ai então, ela ficou sem graça, pegou um ônibus e terminou de ir embora de ônibus e ela foi comigo. *Aí ela chorou bastante, chorou, ela me contou como foi desde o começo, que ela sofreu bastante preconceito e tal,* e aí no primeiro momento eu não falei para ela não, mas dei bastante força para ela, falei que não era o final do mundo, e tal. Aí ela pegou confiança em mim e não escondia mais de mim. *Ela dizia “Olha até serviço é difícil pra mim”, por que na época dela, o marido dela morreu (em decorrência à AIDS), e saiu na rádio que o marido tinha HIV, como ela era esposa, então, todo mundo associou que realmente ela tinha.* Ela tinha esse problema de arrumar serviço por que ela ficou taxada na cidade inteira. Eu arrumei um serviço para ela e eu via que ela era uma pessoa que queria trabalhar. *Ela só precisava de alguém que olhasse para ela, não com um olhar, olha ela pode fazer algum mal ou transmitir alguma doença.* Mas mesmo assim, eu indiquei para um serviço, ela foi e trabalhou bastante tempo no lugar e ela ficou muito grata. Depois de um tempo, eu falei pra ela também, que não precisava e contei para ela (Sonia).

O relato de Sonia sobre sua amiga é um dos vários exemplos em que o sigilo se torna uma forma de manter-se “segura” em uma sociedade marcada pela sorofobia. A sociedade atual é um território em constante disputa (Arroyo, 2013), em que buscamos concorrer e ocupar espaços que historicamente nos foram negados, a partir de regras e normatizações que desconsideram as experiências e vivências que têm produzido novos corpos para novas culturas.

Fato é que a disputa se dá pelo modo como *as palavras se tornam coisas* (Foucault, 2000). A percepção das pessoas soropositivas está inscrita na marca que historicamente foi sendo escrita e lida como a de um corpo que desvia do regular. Esse desvio está relacionado ao modo de vida que as pessoas soropositivas mantêm, sendo também uma forma de justificar não apenas o afastamento, mas a violência por merecimento.

É a encarnação da moralização atribuída às pessoas soropositivas, marcando-as pelos estigmas. As palavras que tornam as coisas nada mais são do que os discursos que vêm produzindo as pessoas soropositivas, para algumas, mais acentuadamente do que para outras, como podemos observar nas palavras de Nando:

Então, quando eu tive o diagnóstico, eu não falei pra ninguém, eu falei pra alguns amigos, o Rafael, por exemplo, o Rafael, e *só, naquele momento só, porque eu fiquei desesperado assim, sabe? Eu não sabia o que fazer,* eu já tinha, né, a gente tem um pouco de informação sobre isso, a gente busca na internet. Até pra falar quando a gente é agora mais adulto, 30 anos, esse assunto chega na roda e a gente quer ter

um pouco de conhecimento sobre isso pra se falar. Então eu buscava, até antes do diagnóstico, saber o básico. Mas *mesmo assim, no momento, dá um desespero. Então eu acabei não falando pra ninguém por causa disso, porque eu tinha medo de sofrer um preconceito e não conseguir lidar com isso, entendeu?* Então eu não falei nem pra melhores amigos. *Ninguém sabe.* Assim, só o Rafa, agora você. E são poucas pessoas, eu nem me recordo. Porque *as pessoas ainda convivem com o ódio, né? E eu não sei de onde vem tanto ódio, tanta raiva, e não sei se vem da ignorância ou da não formação na escola,* porque eu acho que ajudaria, com certeza, as pessoas terem pelo menos consciência naquele momento inicial de quando está começando a ter relações sexuais. Então ela vai buscar informação, tem gente que não busca nunca, então *ela cria uma ignorância e dentro dessa ignorância um ódio, E eu tenho medo, por exemplo, como eu falei, de falar por causa de sofrer algum ataque de ódio* (Nando).

Nas palavras de Nando, um homem gay cis negro, parece haver um peso maior em ser uma pessoa soropositiva. Em nossas sociedades, o HIV ainda é associado à “peste rosa”, o que cria impactos na construção das homossexualidades masculinas (Ferrari, 2023).

O ódio apontado por Nando pode ser explicado pelo ressentimento em relação à forma como as pessoas homossexuais foram sendo comparadas por terem uma vida sexual considerada profícua, desobediente às regulações monogâmicas, matrimoniais e reprodutivas. Dizer ser uma pessoa soropositiva sendo homossexual passa a ser algo esperado, como uma culpa a ser paga por nossos desejos não serem controlados.

O HIV passa a ser compreendido como uma parte que constitui a ideia do homossexual masculino. Manter o silêncio parece ser, muitas vezes, a escolha mais acertada para evitar relações de violência. Logo, viver soropositivo pode ser, em muitos casos, um processo solitário.

Nas palavras de Nando: *“É sofrido pra mim porque é uma parte do que eu sou hoje, então... e não poder partilhar isso... Não partilhar isso por escolha minha, mas também com aquele medo que eu falei de... da família e dos amigos me recriminarem, entendeu?”* (Nando).

Não obstante, para Paka, que também é um homem gay cis pardo, revelar sua sorologia igualmente não é uma opção, pelo que isso pode resultar: *“porque quase ninguém sabe, mas eu tenho certeza que, se eu falar, olha, várias pessoas vão se afastar de mim, eu acho que até minha família”* (Paka).

Não dizer sobre a sorologia, além de ser um direito que as pessoas soropositivas têm, pode ser também uma forma de se resguardarem a partir do sentimento de medo que regula quais espaços permitem ser soropositivo assumido e quais não. O medo que Nando, Paka e Sonia expressam é aquele produzido a partir do que o outro pode fazer.

Foucault (2015c) lê o medo a partir da sociedade punitiva, quando alguns corpos eram vistos como perigosos, criando, assim, o medo no restante da sociedade. Nas leituras de Foucault (2015c), em alguns momentos do século XIX, discutia-se sobre a *monomania*. Em linhas gerais, a monomania era vista como uma doença caracterizada pela obsessão que uma pessoa tinha em matar outra. A monomania foi codificada como doença pela medicina e, assim, como crime para os juízes, o que exigia a reclusão.

No contexto dessa discussão, ousou mudar as peças do jogo. Parece-me que a monomania funciona de forma inversa, sendo operada pelas pessoas que, ao reduzirem sua percepção sobre as pessoas soropositivas ao quadro do que foi propagado sobre o que o HIV e as pessoas soropositivas são, fazem da discriminação uma prática, violentando e produzindo medo.

Torna-se, com isso, um dispositivo monomaniaco: uma obsessão pelo HIV que produz medo e revela a fragilidade da percepção. Logo, temos uma sociedade monomaniaca em relação à soropositividade. Nando, em um momento de sua fala, expressa uma analogia entre não falar sobre ser soropositivo e o assumir-se gay diante da homofobia:

Eu acho que quando você *falar que é gay*, você quer se assumir como gay, eu acho que é uma questão muito mais...De você, *não vai dar pra você esconder isso, né?* Você vai ter relacionamentos, você vai aparecer com alguém, então não tem como você esconder. *Agora, você viver com HIV não tá escrito na sua testa que você é soropositivo. Você não vem com número no seu documento RG e CPF que você é soropositivo, então vai dá sua escolha você optar por falar ou não.* Mas o medo sempre vai existir, porque a gente vive numa sociedade em que muitas vezes a ignorância impera e a gente nunca sabe como a outra pessoa vai agir a partir daquilo (Nando).

Nas palavras de Nando, ser gay é uma marca por não haver como esconder, embora isso seja questionável. Há muitas pessoas que vivem “enrustidas” ou no sigilo. Há o entendimento de que algumas pessoas, por performarem uma feminilidade, são

lidas e concluídas como homossexuais. Faz-se uma associação entre o feminino e a homossexualidade masculina.

Embora essas ideias sejam contestadas e não aplicáveis de modo generalista, o que lemos nas palavras de Nando é que, para ele, ser gay pesa menos do que ser uma pessoa soropositiva. Ainda que, no contexto brasileiro, nossa sociedade seja uma das que mais matam pessoas LGBTQI+²⁶.

O medo apresentado por Nando soma-se a outros dados que mostram que mais de 50%²⁷ das pessoas que vivem soropositivas já vivenciaram algum tipo de violência e discriminação apenas por serem soropositivas. Esses dados e as falas de Nando se ligam a outras falas, como a de Sonia.

Até por que, hoje eu sei que não preciso sair por aí, falando, olha eu sou soropositivo. Até por que eu me trato e sou indetectável. Não preciso sair por aí alertando todo mundo. Mas eu perebo assim, que as vezes em alguma conversa ou alguma coisa sobre o assunto que se fala, até mesmo sobre outra pessoa, tem sim, um tom de preconceito ao falar (Sonia).

Para Sonia, o fato de estar seguindo o tratamento e de estar indetectável é uma condição que a coloca na posição de não precisar falar sobre sua sorologia. Sua fala nos faz pensar sobre as condições de vida, ao considerarmos que ter de anunciar nossas marcações — gênero, raça, etnia, sexualidade, classe e outras condições, funciona como um passaporte que nos permite ocupar determinados espaços.

Ainda assim, percebe-se que não revelar a sorologia está ligado ao preconceito que ela percebe em situações em que o assunto é o HIV. Não falar, no contexto de Sonia, é não acionar os códigos fundamentais da cultura (Foucault, 2000). A sociedade se organiza a partir do que a história da humanidade vem produzindo e, por herança, recebemos conjuntos de saberes (epistemes) que, em muitos contextos,

²⁶ Segundo o portal do Grupo Gay da Bahia (GGB, 2025), “O Brasil permaneceu, em 2024, como o país com maior número de homicídios e suicídios de pessoas LGBTQ+ no Mundo. Foram registradas 291 mortes violentas, 34 casos a mais do que em 2023, um aumento de 8,83% em relação ao ano anterior (257 mortes). Uma morte violenta de LGBTQ a cada 30 horas. Nesse total estão incluídos 273 homicídios e 18 suicídios”. Segundo o Dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Benevides, 2025), “O Brasil registrou 122 assassinatos de pessoas trans e travestis em 2024”.

²⁷ Segundo o Índice de Estigma, publicado pela UNAIDS (2025), “mostram que 52,9% das pessoas que vivem com HIV no Brasil já vivenciaram algum tipo de discriminação ao longo da vida”. Ao que tange os dados no contexto de atendimento de saúde: “11,5% sofreram tratamento discriminatório em serviços de HIV (ex.: uso excessivo de luvas, recusa de atendimento); 13,1% relataram estigma em serviços não relacionados ao HIV (ex.: odontologia, clínicas gerais).

não alcançam a realidade do humano para além do biológico, interferindo em nossa percepção sobre o que é falado, visto e ouvido.

O conhecimento sobre as pessoas soropositivas, ao estar em constante disputa, conserva a visão de como historicamente o HIV e as pessoas soropositivas foram construídos, pautando-se em discursos morais, negacionistas, sexuais e identitários. Repletos de estigmas e preconceitos, fazem com que não falar se torne uma forma de criar outras estratégias estéticas de vida. A fala de Sonia se liga a outras, como a de Paka, quando exemplifica sua experiência com um amigo:

Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, a gente conversando, não sei sobre o que, aí ele fala, ah, um amigo meu daqui pegou HIV. *Aí eu distanciei dele*, tipo, ele quebrou meu coração, porque *ele abominou o amigo. Ele não quis ficar nem perto do amigo dele. E mal sabia que eu tenho ouvindo isso, entendeu?* Foi difícil pra mim (Paka).

Não falar, nesse contexto, é acionar aquilo que há de ruim em ser soropositivo, contaminado pelo preconceito de uma sociedade monomaniaca em relação à soropositividade. Ainda assim, é possível pensar que estar próximo de pessoas como o “amigo” de Paka desperta um desprezo por compartilhar a vida com sujeitos que não pensam para além de sua cognição limitante, que não veem na diferença a constituição que nos liga como humanas.

A estratégia de assumir uma performance soronegativa, utilizando outros códigos que têm operado na cultura atual e passando despercebido, torna-se uma forma de criar rotas de fuga, como pode ser observado no relato de Caio:

Pelo menos *onde eu moro, se alguém sabe, guardaram pra elas*. Nunca ninguém pegou e jogou assim na minha cara, você é soropositivo, você, entendeu? Algo desse tipo assim. Então quero dizer, *eu passo despercebido como se eu nunca tivesse tido problema nenhum. E muita gente achou que quando eu fiquei doente, fosse depressão* (Caio).

Pelas palavras de Caio, poucas são as pessoas que sabem sobre ele. Para ele, há uma diferença entre saber ter o conhecimento para si e saber e abordá-lo a partir do código soropositivo, o que resultaria em uma resposta que Caio deixou explícita. Em vários momentos, durante a entrevista, Caio se mostrava uma pessoa religiosa, frequentador de uma igreja de denominação evangélica.

É interessante pensar que, embora Caio seja homossexual, ele construiu uma rota de fuga aos discursos e códigos fundamentadores da religião. O passar

despercebido como uma rota de fuga corresponde ao que Foucault (2000) chama de *relação entre a linguagem e o visível*. A linguagem produz a percepção a partir dos códigos estabelecidos na história.

Quando Foucault (2015b) fala da sexualidade como um dispositivo que tem vontade de saber para poder ter poder, o ser homem cis é fruto dessa produção, à qual Caio foi nomeado e pela qual a comunidade o vê. A relação da linguagem produz o corpo de Caio: ao performar um estilo típico de homem hétero cis, trabalhador do sítio, o visível deixa de ver a homossexualidade e a sorologia de Caio, e, por isso, ele se afirma como alguém que “passa batido” (Butler, 2015).

A decisão de contar ou não, implicando medo da exposição, do preconceito e da violência, constitui escolhas a partir dos cotidianos em que cada pessoa vive. Na entrevista com Paka, em determinado momento ele relatou a situação de um ex-namorado que não conseguia falar sobre sua sorologia por medo da rejeição. Como a relação seguia bem, resolveu contar sobre sua condição.

Com o passar do tempo, o namoro foi enfraquecendo e Paka decidiu terminar o relacionamento. Segundo ele: *“quando a gente terminou, ele me ameaçou. Ele não aceitou o término. Aí ele acabou contando para a irmã dele, contou para o cunhado, contou para algumas pessoas próximas, e eu pedi pra ele não contar pra ninguém, e ele contou”* (Paka).

A exposição feita pelo ex de Paka foi uma forma de prejudicá-lo. Ou seja, seu ex-namorado utilizou os códigos representativos da cultura, sabendo que, ao serem lidos pela sociedade monomaníaca em relação à soropositividade, repercutiriam de alguma forma que castigasse o fato de Paka não seguir com o namoro. A fala de Paka se une à de Nando, quando diz que:

a pessoa fala com nojo e tal e eu falo...Aí eu fico pensando, como que eu vou ter um namorado? Hoje eu não namoro, mas eu penso assim, como que eu vou ter um namorado se eu vou ter que falar pra pessoa? Porque quando você tem uma relação, você tem que falar sobre isso, porque a pessoa tem que saber e querer ou não estar com você. É um direito dela, eu acredito. E eu acho que é difícil, sabe? Pra mim é sempre, eu fico nessa insegurança, toda vez que as pessoas tratam desse assunto, sobre isso, dessa forma ridícula, assim, ridicularizando, ou ofensivo, com ó, sabe? Com raiva de pessoas que têm, ah, são pessoas porcas, porque elas, né, se dão desfrute (Nando).

O estado sorológico é uma condição que faz com que as relações amorosas adquiram outros significados, a partir das falas de Paka e Nando. Nando questiona a

possibilidade de estar em um relacionamento e sua própria percepção sobre isso, ao considerar que revelar sua sorologia é uma forma de afirmar quem ele é e de ser aceito no relacionamento a partir desse eu soropositivo.

A fala de Nando nos mostra que a sorologia é apenas mais um acontecimento na vida. Estar soropositivo e, no caso de Nando, seguir com o tratamento, garantindo certa segurança por não soropositivar uma possível parceria, evidencia um papel ético no cuidado que ele exerce. Assim como em Paka, esse cuidado não diz respeito apenas a si, mas também às outras pessoas, um cuidado coletivo.

O fato de falar, como aponta Nando, é difícil, sobretudo nos termos em que ele considera. Como dizer às pessoas que você é soropositivo para que não o leiam como uma pessoa porca ou suja? Esse dilema, que me parece soar como um problema ético, possibilita ler as relações sorodivergentes como uma questão que também precisa ser aprofundada em outras pesquisas.

Quando falamos sobre o fato de a sociedade estar em constante disputa em torno dos saberes (Arroyo, 2013) que produzem a ideia do que são e do que não são as pessoas soropositivas, consideramos aquilo que Foucault (2000) vem nos mostrando. As relações que esses saberes estabelecem, seja a partir dos valores representativos que fazem com que as palavras se tornem coisas-práticas, criam, na sociedade, uma linguagem que marca as pessoas soropositivas pelos estigmas.

Assim como apontam Ferrari e Seffner (2009), essas marcações e códigos tornam-se ainda mais visíveis quando se trata de homens homossexuais. Quando perguntamos a Paka como era a relação sorodivergente que ele vivia, ele relatou que seu novo parceiro sabia sobre sua sorologia e que optou por contar após ter encenado uma história, como podemos ler:

Quando eu falei, a gente tinha terminado. Aí eu fiz uma situação pra terminar, entendeu? Só falei, eu tentei terminar, mas ele disse, disse, disse. Aí até ali foi tranquilo. Aí depois ele aceitou, foi tranquilo. Não sei se foi tranquilo pra ele mesmo. Eu imaginava que, igual *todas as pessoas, todos os casais, a maioria dos casais geralmente transam sem camisinha. E a gente faz quatro anos e meio só com camisinha*. Aí, eu acho que lá no fundo, no fundo, no fundo, não é normal. Que ele transa só com camisinha, se você tem parceira. Eu acho. *Eu acho que lá no fundo, no fundo, ele deve ter um preconceito e medo de mim de passar pra ele*. Aí ele sempre fala, mas sempre falando de camisinha. Ah, é uma coisa minha começar com camisinha. E eu fico com vergonha de falar com as pessoas, porque...Aconteceu uma coisa na casa dele, uma vez, a mãe dele meio que sabe meio por cima da gente. A mãe dele pegou uma camisinha, um papel só, tava debaixo

da cama. *Aí a mãe dele abominou, né? Ah, ele não vai poder dormir aqui, que não sei o quê, cada um dorme na sua casa, não quero isso.* Tá, mas ele aceitou, né? É a casa dela. Aí ele contou pros amigos dele, né? Aí a mãe pegou lá a camisinha, tipo, a gente ia fazer uns três anos de namoro. E ele acha normal falar pra gente. Ai, a minha mãe pegou a camisinha, tenho certeza que o povo deve ter pensado alguma coisa. Nossa, que estranho, que estranho usar camisinha. *Eu fico com vergonha de falar. É estranho.* Eu fico morrendo de vergonha. *E eu descobri recentemente também que ele contou pro amigo dele sem me consentir* (Paka).

Ao reivindicar ter uma relação sexual com seu namorado sem camisinha, Paka expõe seus desejos: o de vivenciar uma relação que possa, dentro do construto produzido como “normal”, ocorrer sem o uso do preservativo. O namorado, ao resistir, reforça a relação entre o mesmo e o outro, por não ver ao seu lado um parceiro que não se reduz ao HIV-risco.

Ao mencionar a mãe do parceiro, Paka sinaliza, no papel da sogra, uma outra marcação e/ou reforço de um certo preconceito que se estruturaliza, também, por serem um casal homossexual. Como Ferrari (2023) menciona, as pessoas homossexuais masculinas vivem o impacto de uma identidade construída repleta de preconceitos e fragmentos do que, no passado, tinha como maior referência a chamada peste gay.

Nas palavras de Paka, há ainda um outro desejo latente expresso na questão do uso do preservativo, que Oliveira e Sales (2022) nos ajudam a pensar ao refletirem sobre a necessidade de *contestar as normas que regulam esse uso*. A prática bareback é muito difundida nas relações sexuais entre homens homossexuais. Em tradução livre, significa “montar no cavalo sem cela” — o cavalo representa a outra pessoa e, sem cela, indica a ausência do preservativo.

Nas palavras de Oliveira e Sales (2022), a cultura bareback se insere na disputa das narrativas que produzem os modos e as condutas que a prática sexual deve seguir, naturalizando uma posição única e implicando, assim, outros desdobramentos.

Ainda assim, o currículo bareback é um currículo porque não se restringe apenas aos espaços institucionalizados da educação, mas se estende para além deles (Paraíso, 2010). E, por assim ser, rompe e produz novos sentidos, significados e narrativas, ao se colocar como uma prática sexual sem camisinha como possibilidade de uma outra verdade sobre a prática sexual, à qual Paka convida seu namorado a participar.

No passado e no presente, o uso do preservativo foi e ainda é contestado, utilizando-se como argumento discursivo a religião, ao pregar que as relações sexuais deveriam existir dentro de parâmetros difundidos, como a monogamia, o matrimônio, a relação entre um homem e uma mulher, sem sexo anal e sem homossexualidade.

O acontecimento da AIDS, enquanto pandemia que dizimou muitas pessoas com maior incidência entre homens homossexuais, foi lido, em muitos discursos, como resultado dos “desagravos” das pessoas, sobretudo dos homossexuais masculinos, por descumprirem os ordenamentos que as religiões dispositivavam (no sentido de dispositivo, conforme Foucault).

Isso nos retorna à cena em que Paka fala sobre a mãe do parceiro (sogra) como a extensão desse dispositivo religioso, que produz em seu filho os receios, medos e preconceitos que podem ser institucionais, sistêmicos e estruturais, operando em um movimento que se internaliza no namorado de Paka e se externaliza nas relações. Trata-se de uma pedagogia do medo, transar sem camisinha é perigoso. Essa ideia se evidencia quando Paka fala:

Que mesmo ele aceitando, tipo, ele foi super de boa, *eu acho que lá no fundo, sim, tem medo, sim*. Porque, um exemplo, eu ejaculava na boca, aí, tipo, ele não quer fazer sexo oral, quando tá com alguma coisa, ele fala, por quê? Não vou pegar nada, não vai passar nada, por quê? Não tem medo. *Eu sinto que tem medo*. Tenho medo sim, mas não adianta falar, que tem medo sim... se eu não tenho nada, não vou passar nada pra ele (Paka).

Paka, ao falar sobre o sexo oral, mostra como a marcação soropositiva modificou sua relação com o namorado. Antes de o parceiro saber sobre sua sorologia, não havia impedimentos, a ponto de Paka poder ejacular na boca dele. Tudo muda após revelar ser soropositivo.

Como Paka afirma, o currículo bareback sinaliza um caminho que produz novos sentidos para as práticas sexuais, legitimando o desejo e o prazer, ao se deslocar da ideia única de que o preservativo opera como um *disciplinador fálico-ejaculatório*. A camisinha, na lógica da prevenção nos dias atuais, não é a única tecnologia possível para o cuidado.

Existem outras formas, como a PrEP, que, em todo o seu sistema de funcionamento, produzem muito mais do que o preservativo tradicional, ao regulamentarem a sexualidade por meio do biopoder (Foucault, 2015b). Para ter

acesso ao medicamento, as pessoas que fazem uso dele se inserem em uma lógica industrial em que os corpos passam por diferentes setores²⁸.

Primeiro, é necessário acessar um espaço de saúde habilitado, no qual a pessoa é encaminhada a um/a médico/a que avaliará sua elegibilidade. Ao ser autorizada, passa a ser acompanhada, realizando exames rotineiros que incluem a verificação de outras ISTs. Ou seja, em determinados contextos, a PrEP pode sinalizar mais segurança do que o preservativo.

A partir das falas de Sonia, Caio, Paka e Nando, é possível perceber a importância do conhecimento para operar e direcionar as relações com as pessoas que atuam nos espaços de saúde, os quais, em muitos casos, podem ser sinalizados como locais de medo e, por isso, evitados. Discute-se que a formação dessas pessoas, desde a graduação ou nos cursos técnicos, precisa ser repensada, com a intenção de promover uma atuação que considere as diferenças e a inclusão como pontos centrais para uma prática qualificada.

No que tange às relações de preconceito e estigma na sociedade, que repercutem no sigilo, observa-se que a falta de conhecimento faz com que as pessoas soropositivas construam uma visão distorcida sobre o HIV, produzindo o medo de revelar sua sorologia. Ao acumularem tantas experiências negativas, as pessoas soropositivas deste estudo nos mostram que, em muitos casos, ter a sorologia assumida não é uma opção.

Isso ocorre porque as instituições da sociedade se mostram precárias em suas formações quando pensadas no contexto do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas.

Ainda assim, os dados produzidos nos mostram a importância de pensar a educação no Ensino Médio como necessária para atuar na vida real de forma estrutural, ao atravessar a produção das percepções das pessoas participantes da pesquisa, assim como das pessoas que trabalham na saúde. Os espaços de formação, ao não considerarem um currículo para além da técnica, deixam a desejar

²⁸ Para maiores informações sobre o que é, como funciona, quem pode ter acesso e demais questões, acesso o site do Governo Federal “Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis”. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/prevencao-combinada/prep-profilaxia-pre-exposicao/prep-profilaxia-pre-exposicao>. Acesso em: 22 abr. 2026.

e acabam, inclusive, cooperando para que pessoas soropositivas não sigam com seus tratamentos.

Não obstante, as pessoas soronegativas, ao buscarem realizar testes para saber sobre alguma IST, percebem a atuação das pessoas que trabalham na saúde de forma moralizante e preconceituosa. Há uma visão de que os testes não estão ali para serem feitos: se houve a busca, é porque a pessoa estaria na linha da promiscuidade, por ser homossexual, travesti ou pessoa trabalhadora do sexo.

Como se essas pessoas fossem as responsáveis e como se os comportamentos vistos como de risco operassem unicamente nos casos de HIV. Sonia é um dos muitos exemplos de que essas classificações protocolares utilizadas pelo sistema de saúde são falhas, sendo necessário repensar e rever seu impacto na realidade das pessoas que buscam esses serviços e daquelas que desistem em função da forma de atuação e abordagem.

Seguimos com a análise e discussão dos dados produzidos, a fim de compreender o papel da família no contexto das relações das pessoas soropositivas. A família, por ser um conceito criado culturalmente e consolidado ao longo da história por séculos, traz percepções que, ao serem analisadas, nos mostram possíveis sinais de atuação como um espaço seguro ou não para que o tema da sexualidade possa circular.

Considera-se que a família é um dos espaços marcados por relações morais, patriarcais, de desigualdade de gênero, cisgênero e heterossexual, nos quais a sexualidade é colocada como um tabu: não se fala, e, quando se fala, define-se de que forma se deve falar. A família utiliza esses marcadores como dispositivos para educar e produzir comportamentos em seus filhos e suas filhas.

São percepções que atravessam gerações, consolidando-se como uma estrutura que, ao não ser rompida, se perpetua até os dias atuais.

5.17 Eixo 3: Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo



Fonte: O autor.

A imagem acima²⁹, registrada na cidade de Oshio, EUA, ilustra duas realidades um pouco distintas ocorridas na década de 1990 — um homem gay que morre no leito de um hospital, ao lado de familiares. No decorrer da pandemia de AIDS, era muito comum que pessoas, ao saberem de sua condição, fossem afastadas de seus lares, muitas vezes por solicitação da própria família.

A AIDS marcava, assim, um castigo duplo: o de Deus e o da família. A justificativa era a de que a doença seria uma punição dada por Deus e cumprida pela família, ao expulsar seus filhos para morrerem exilados do primeiro espaço possível de cuidado e afeto que a família poderia representar.

Com David Kirby, que tinha 32 anos, foi diferente. Próximo da morte, ele solicitou à sua mãe e ao seu pai que pudessem estar juntos. Seu último desejo era

²⁹ A imagem foi retirada do site da Revista Life, disponível em: <https://www.life.com/history/behind-the-picture-the-photo-that-changed-the-face-of-aids/> (Cosgrove, 2014).

terminar onde tudo começou. A família aceita Kirby e, de todas as dores que a AIDS poderia trazer, a de estar desamparado pela família em seu final ele não teve.

A foto mostra o sofrimento de um pai e de uma mãe ao verem seu filho morrer na cruz do preconceito e do estigma que marcaram e ainda marcam os dias atuais.

Falar sobre família nos remete a afetos e desafetos — uma relação de traumas e boas lembranças que, regadas a cheiros, comidas e imagens, constroem retratos do passado que retornam no presente como sintomas, ações e práticas cujos efeitos, muitas vezes, não percebemos conscientemente. Seja nas relações com outras pessoas, seja conosco mesmos.

São vínculos que, por vezes, estão redesenhados por *pedagogias do medo*, praticadas pelas diversas ações realizadas pelos familiares ao fixarem, nos/as filhos/as, meios de causar pavor. Elas aparecem como frases aparentemente inocentes, como “não mexe no pipi, isso é feio”, mas que, no interdito, produzem terrores que reaparecem na sexualidade.

É um misto de expectativas e frustrações que nos lança aos possíveis rumos da vida. Fica a pergunta: se houvesse uma fala aberta sobre sexualidade, sexo e HIV, teríamos experiências futuras mais potentes e menos atravessadas pelo medo?

Quando pensamos no conceito de família, rapidamente o atribuímos àquilo que tivemos como representação em nossas casas — um homem-pai, uma mulher-mãe. Contudo, em muitas outras realidades, o conceito de família se modifica, não sendo representado apenas pelos papéis e performances de gênero como costumeiramente é apresentado nas sociedades.

Fato é que a ideia de família nunca foi a mesma e acreditamos que, a cada dia, ela se coloca em constantes modificações. A família, no decorrer dos tempos, não se apresenta em um único e mesmo formato, seja nas pessoas que a compõem (o casal), seja nas funções no relacionamento ou nos papéis na sexualidade (Foucault, 2015b; 2024a; 2024b).

Na Antiguidade, Foucault (2024a; 2024b) analisa a família no contexto greco-romano. A caracterização da família, nesse período, é dada como um espaço de governo doméstico e de preocupação com o cuidado de si. Nesse momento, o pai e a mãe não exercem prioritariamente o papel de regular os desejos. Cada integrante da família desempenha uma função fundamental para que o governo da casa aconteça de forma adequada.

O *kyrios* (marido) ocupa o papel central, como o governador da *oikos* (casa). Ao governar a casa, sua responsabilidade reside na administração das pessoas da família, assim como dos bens que a essas pessoas garantiriam a subsistência.

Para que o governo da casa se realizasse adequadamente, era necessário que o marido soubesse dominar a si mesmo. Seguia-se a lógica de que só se pode governar a casa quem sabe, antes, governar a si mesmo. No que tange à sexualidade, ela não estava situada nos trilhos da proibição, mas, ainda assim, exigia-se moderação, preservando a família e colocando-a no centro das decisões.

Por exemplo, era permitido ao marido se relacionar com homens e outras mulheres, desde que não constituísse família com essas pessoas. A *gyne* (esposa) tinha como função manter a casa organizada por meio do trabalho doméstico, da procriação e do cuidado com os/as filhos/as. Quanto à sua sexualidade, esta se restringia apenas ao marido.

No que tange aos/às filhos/as, ao tratar da sexualidade, a formação ofertada se dava a partir do gerenciamento dos prazeres e da importância do cuidado de si.

Na Idade Média, período marcado pela forte influência cristã-católica, a família passa a ser organizada a partir da religião (Foucault, 2015b). Nesse contexto, a religião traz como modelo a família nazarena: Maria, José e Jesus. Logo, os papéis de marido e esposa são produzidos e cobrados a partir desses personagens, que, não obstante, ainda aparecem como referência nos dias atuais (Priori, 2011).

Os papéis de marido e esposa mantêm, em certa medida, aproximações com o modelo da Antiguidade greco-romana, distanciando-se de forma mais acentuada no que se refere à sexualidade, agora compreendida como um mecanismo central de controle sobre toda a família. Torna-se fortemente marcado como pecado todo ato que obstrua a fidelidade e toda prática sexual que não esteja voltada à reprodução.

Da mesma forma, para os/as filhos/as, a sexualidade se constitui como tabu, repleta de restrições e proibições que se estendem até os dias atuais, como, por exemplo, a masturbação, perseguida e condenada. Ela aparece nos manuais de confissão e nos Concílios realizados pela Igreja como prática a ser combatida.

A família, nos séculos XVII e XVIII, reconhecida como a família moderna, tem como ponto central de preocupação a sexualidade. Nesse momento, a sexualidade passa a ser algo que precisa ser vigiado, por ter sido produzida a partir de regimes de proibição, quando não tem como finalidade a reprodução.

O marido segue com o papel de guardião da casa, sendo o membro que detém o poder e a autoridade sobre as demais pessoas. No que tange à sua sexualidade, ela é vista como legítima apenas quando voltada à reprodução dentro do casamento. A esposa é responsável pela casa, pelo bom exemplo e pela fiscalização do comportamento dos/as filhos/as. Cumpre a função do cuidado doméstico em todas as suas instâncias, tanto no plano da organização quanto no da educação.

As crianças passam a ser sexualizadas, sendo nelas construídos os discursos que produzirão a sexualidade normal e a anormal, a partir de diferentes saberes — médicos, psicológicos e pedagógicos. O alvo principal desses discursos é a masturbação (Foucault, 2015b).

Ao pensarmos o conceito de família, Brown (1995) nos ajuda a olhar com maior profundidade, ao nos colocar questões que nos direcionam a refletir sobre o formato de família apresentado nos relatos de Caio, Sonia, Paka e Nando. A família resulta de um contrato que, em tese, busca colocar pai e mãe em condições de igualdade, sem haver coação sobre quem se submeterá ao se inserir na instituição do casamento. Esse é, em princípio, o discurso que o liberalismo prega.

Na realidade, a natureza do contrato que marca o casamento e a família é o consentimento, implicando posições de poder que, ao serem aceitas, passam a ser lidas como legítimas, naturais e/ou próprias. O determinante do consentimento está no interdito, nas gerações, nas palavras proferidas, nas palavras lidas da Bíblia.

Na prática, a partir do casamento, a família se constitui dentro de parâmetros que fazem executar papéis distintos: o homem sob o domínio do poder e a mulher sob a obediência. Ao ser formada dentro desses moldes, espera-se que a família produza outros cidadãos e, por isso, sua importância. Ela surge como necessidade do Estado e para o bem comum.

Os papéis que o homem e a mulher exercem são diferentes, e não por natureza. Ao homem é atribuída a autonomia. Ao prover a casa, ele passa a ter o poder de prover a si mesmo. Logo, o homem não se submete a outros, no sentido de não depender de que alguém lhe dê condições para sua sobrevivência.

É possível perceber que, dentro dessa construção, o masculino nasce e se desenvolve a partir dos códigos que determinam que um homem precisa ter condições de não se submeter a ninguém (Brown, 1995).

Quanto à mulher, seu papel é oposto ao do homem. Ela é inserida em um sistema que a coloca em condição de dependência em relação ao homem (seu

marido), não usufruindo, portanto, de autonomia. A ela cabe o cuidado da casa e dos/as filhos/as, perdendo, assim, sua liberdade e autonomia, o que produz a ideia de que as mulheres, por natureza, seriam zeladoras do lar.

Enquanto o homem usufrui de sua autonomia, podendo transitar pela sociedade, a mulher permanece encarcerada no espaço doméstico. O homem pode sair para trabalhar de forma remunerada e pagar por seus interesses de consumo, enquanto a mulher fica à mercê de pedir ao marido aquilo que ele pode lhe conceder (Brown, 1995).

A partir das falas das pessoas participantes, é possível perceber os elementos históricos e culturais que atravessam o conceito e a representação de família. Quando perguntamos a Caio se, em sua casa, o assunto sobre sexo e sexualidade aparecia, ele respondeu: *“Não, meus pais não tinham estudo, né? Então nunca tocaram nesse assunto. Meu pai, então, se falasse de sexo dentro de casa, a casa caía. Era uma pessoa que veio, tipo, do Nordeste, né? Então já mais velho... Então tem certas coisas que você não poderia falar”* (Caio).

Nas palavras de Caio, o fato de não se falar sobre sexo e sexualidade em sua casa tinha como justificativa o contexto de seu pai: uma pessoa que viveu em um ambiente interiorano, simples e mais velho, resultando em uma mentalidade conservadora. Assim, sexo e sexualidade tornavam-se palavras não ditas no cotidiano de sua casa.

A fala de Caio pode ser lida por outras lentes, a partir de Brown (2006), ao refletir sobre o “pesadelo americano”, no qual a família é produzida a partir de uma racionalidade neoliberal e neoconservadora. Nesse contexto, a família deve zelar pelas pessoas que a integram, cabendo aos progenitores a responsabilidade pelo cuidado. Essa tarefa tem como objetivo fazer com que nenhum problema, em qualquer ordem, saúde, criminal, econômica, sexual, entre outras, chegue às mãos do Estado, evitando que as políticas públicas precisem intervir.

Uma boa educação, nesse modelo, é aquela em que os/as filhos/as seguirão trabalhando, reproduzindo e mantendo a tradição dos modelos já definidos desde seus/suas avós, ligando-se, assim, ao contexto neoconservador.

A racionalidade neoconservadora tem como objetivo manter a moral que administrará os corpos para estarem em sociedade. Alguns pontos que sustentam esse modelo moral para a produção e reprodução do que se chama de família tradicional estão amparados na heteronormatividade, por papéis estabelecidos entre

homem e mulher, heterossexuais e cisgêneros e na disciplina cristã, que educará os/as filhos/as a copiarem os comportamentos de seus familiares.

A família, nesses termos, é um modelo que opera a fim de produzir os valores que o mercado e a política moral esperam. Tal modelo conserva diretrizes segundo as quais falar sobre sexo e sexualidade não compõe nenhuma das regras previstas. Por isso, a obediência é altamente valorizada, seja das mulheres, ao serem submissas a seus maridos, seja dos/as filhos/as.

Desobedecer sinaliza a transgressão dos valores, colocando a família-empresa em risco de falência e/ou corrupção: o divórcio, um filho gay, uma filha mãe solteira e até mesmo uma pessoa da família soropositiva (Brown, 2006).

O não falar sobre sexo e sexualidade também aparece nas falas de Nando. Quando perguntamos a ele qual razão atribuiria à ausência desse tema no cotidiano de sua casa, Nando respondeu: *“falta de educação mesmo. Faltou educação, faltou capacitação, porque acho que não querer buscar também a informação ou ser ignorante por si só, não sei. São duas coisas”* (Nando).

A falta de educação mencionada por Nando revela um problema estrutural que atravessa gerações, ligado à forma como a ideia de família vem sendo historicamente reproduzida. O silêncio que paira sobre a sexualidade é sustentado por discursos que afirmam que falar sobre o tema seria uma forma de incentivar a atividade sexual antes do tempo ou, ainda pior, que tratar do assunto fere a inocência da criança. Opta-se, assim, pelo silêncio como uma tática para regular a sexualidade (Ferrari; Castro, 2015).

Nas leituras de Foucault (2015b), ao discorrer sobre História da Sexualidade I: A vontade de saber, as práticas e as falas sobre a sexualidade, no decorrer do século XVII, eram livres, utilizando a metáfora de que os corpos “pavoneavam” tudo o que poderia ser mostrado. Não havia regulações rígidas sobre os corpos nem interdições sistemáticas sobre os desejos. O corpo tinha permissão para tudo o que o desejo solicitava.

Ao comparar com o século XIX, tal prática já não ocorria. A sexualidade deixa de ser livre, limitando-se à família, reduzida ao casal em função da reprodução. Sobre o sexo, instala-se o silêncio.

No que tange às crianças, elas eram lidas como assexuadas. Qualquer sinal que manifestassem sobre a sexualidade era interditado e, mais uma vez, o silêncio se impunha. Eram corpos não falantes. Segundo as leis desse tempo, caracterizadas

pela moral burguesa³⁰, não havia importância e, na visão dessa cultura, as crianças não tinham por que saber sobre sexo.

Não falar tornava-se uma estratégia para fazer desaparecer, ou para produzir estranhamento a partir das manifestações dos corpos, fazendo com que o sexo e a sexualidade se colocassem como algo estranho, escondido, inexistente. Não falar sobre sexo e sexualidade nas famílias tornou-se, assim, uma estrutura que ainda aparece em muitas delas até os dias atuais.

Isso pode ser observado quando perguntamos a Caio se, entre seus irmãos, no interdito, eles conversavam sobre sexo, e Caio responde que “*o assunto nunca tocava*”.

No decorrer da entrevista, em vários momentos, Caio manifestava sua religiosidade, deixando claro ser cristão e seu vínculo assíduo com a participação nos cultos. Quando Caio afirma que o assunto sobre sexo e sexualidade não era tocado em sua família e, de modo mais específico, em uma família de orientação cristã confessional, Rodrigues e Falcão (2021) nos ajudam a compreender esse cenário a partir da ideia de “*família de Deus*” e dos valores neoliberais, tomando como personagem pública Damares Alves.

As falas da ex-ministra e atual senadora Damares Alves (PL) desempenharam e ainda desempenham um papel significativo na sociedade ao alimentar, por meio de discursos apelativos, uma defesa da família e, simultaneamente, uma postura refratária aos direitos sexuais. Esses discursos operam dentro das lógicas do neoliberalismo e do neoconservadorismo, buscando reforçar uma ideia única, fechada e normativa de família e de suas funções perante a Igreja e a sociedade.

A ideia que fundamenta esse modelo de família faz com que alguns discursos possam circular, enquanto outros sejam silenciados.

Ao questionarmos se, com outros integrantes da casa, a conversa sobre sexo poderia aparecer, Caio reafirma que nem mesmo com seus irmãos, de forma mais privada, conversavam sobre sexo ou falavam sobre sexualidade. A ausência desse assunto não se restringia apenas a ele, mas a todos os irmãos.

³⁰ Não seria coincidência que a repressão apareça após séculos de permissões a partir do desenvolvimento capitalista. O que se tinha antes, era lido como excessos e futilidades – “o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho, geral e intensa; na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao mínimo, que lhe permitem reproduzir-se” (Foucault, 2015b, p. 10).

Quando perguntamos novamente se o tema realmente não era abordado, Caio responde: “*Nunca tocava*”. E ainda complementa, relatando sua primeira experiência sexual:

Só, igual, como eu falei para você, *como eu demorei muito, aos 23 anos que eu fui conhecer alguém, aos 23 anos*. Então quer dizer, durante esse tempo todo *nunca tive relação, então achei que não ia ter problema nenhum*. E, a partir do momento que eu conheci uma primeira pessoa, não deu certo, foram 4 anos, depois foi essa pessoa em seguida, aí era aquela coisa, sabe, assim, *logo de início também não teve sexo*. Foi ter sexo a partir de um momento, jamais, tipo assim, você veio de lá do Paraná, veio uma vez, daqui a dois meses você volta. Então, foi algo assim, entendeu? *A distância, a longo prazo, mas aí ele já tinha, desde a época que ele veio me ver, ele já tinha, só que eu não sabia* (Caio).

O contexto cultural em que Caio foi formado é o de uma família residente em território rural, na qual alguns valores são fortemente reforçados. Em sua fala, Caio evidencia não apenas a ausência de diálogos sobre as vivências sexuais a partir da performance de gênero cis masculina que ele representa, mas também a condição de uma pessoa homoafetiva.

Se a fala sobre a sexualidade no contexto heterossexual já é atravessada por dificuldades, no caso de pessoas homossexuais ela tende a ser ainda mais complexa, quando não ocorre a partir de uma perspectiva preconceituosa e apavorizante. Sobretudo quando o contexto em que se inserem é desprovido de meios de comunicação, acesso à internet, a revistas e a outros materiais que poderiam oferecer identificações e pistas sobre aquilo que se sente no campo do desejo, da performance, da prática sexual e de outras instâncias da experiência.

A homossexualidade, ao ser lida por algumas pessoas como uma *sexualidade ilegítima* (Foucault, 2015b), faz com que as vivências se coloquem na clandestinidade, longe dos olhos da família. Esse estar na clandestinidade não revela apenas repressão, mas, sobretudo, um disciplinamento que regula quais sexualidades são legíveis e quais não são, pautando-se nas bases da heterossexualidade e da reprodução.

O fato de não estar no centro das “legitimidades” produz outros regimes de verdades nos quais o sexo e a sexualidade passam a se organizar. Na atualidade,

esses espaços são variáveis e tecnológicos — o banheiro, o Grindr e o Balneário da Amizade³¹. Em cada um deles constrói-se, por e como, uma *pedagogia da cassação*.

No jogo de poder, por mais que se diga não ao sexo e à sexualidade não heterossexual, meios de contra-esses-poderes são criados, como forma de manter o jogo no qual o desejo insiste em ganhar.

Nas palavras de Caio, ele se lança nesse jogo, colocando-se sob a “sorte” de a outra pessoa ter trilhado caminhos diferentes dos seus, que tenham resultado em algum conhecimento a partir das experiências vivenciadas com outros parceiros. Ainda em sua fala, é possível perceber que o não falar sobre sexo e sexualidade também foi uma forma de não falar sobre HIV e AIDS, seja pelo discurso terrorista, seja pelo discurso da prevenção.

Todavia, Caio ressalta o aspecto da confiança na parceira, produzida por uma pedagogia do silêncio, inscrita no núcleo matrimonial, no papel atribuído à mulher, em que não se questiona. Pelo silêncio, já estão inscritas as regras, os jogos e os lugares de poder que cada pessoa ocupará.

Em Caio, a pedagogia do silêncio opera como um lançar-se ao desconhecido, sem estratégias para participar do jogo sem conhecimento das tecnologias de prevenção, sem a própria conversa sobre o HIV. O não falar, para Caio, está ligado à ausência de conhecimento. Já para o parceiro, por saber sobre sua própria sorologia, não falar é como se o HIV não existisse.

Ambos os silêncios podem ser pensados a partir do uso dos prazeres, no que Foucault (2024a) chama de *moral e prática de si*. A moral, em uma visão geral, consiste em um quadro de valores que implica nas ações que os sujeitos realizam em suas relações consigo mesmos e com o social. Esses valores são formulados a partir de instituições que se inter cruzam, como a Igreja, a família e a escola.

Em Foucault, entretanto, a moral toma outros direcionamentos. A forma como esses valores são ensinados implicará nas ações, de modo que, em alguns casos, haverá compromisso (como em Caio) e, em outros, descompromisso (como em seu parceiro, ao não falar sobre sua sorologia e pôr em risco, uma vez que não estava em

³¹ Um dos locais de pegação que ocorre às margens de um lago, localizado ao redor de um parque. Pode-se pensar que, nesse espaço, constrói-se uma *pedagogia da amizade*, em que os corpos que ali estão buscam os mesmos fins, por meios diferentes, e em que os lugares e as posturas são sinais que marcam os desejos de homossexuais, de heterossexuais casados, de toda gente. Sob a luz da lua e das lâmpadas do parque, à margem, o escuro não é lido como subterfúgio. É o retrato de um paraíso em que, como anjos, entoam-se louvores de gozo por meio de gemidos.

tratamento). Tanto Caio quanto seu parceiro se submetem às regras morais, porém de formas distintas, direcionando-se à prática de si.

Ou seja, embora estejam sob as mesmas regras morais convencionais, a maneira como cada um se constitui obedece a seus próprios critérios de seleção, que os produzirão como sujeitos. Em Caio, a produção de si é marcada pelo desconhecimento. No parceiro, a produção de si é marcada pela negação.

Ainda cabe ressaltar o papel da sociedade atual ao pautar a percepção do sexo e da sexualidade sob regimes proibitivos e permissivos, alegando haver um sexo e uma sexualidade verdadeiros, como mecanismos que fazem ver e negar as realidades em que cada pessoa vive (Foucault, 2024a).

A visão afetada pelo astigmatismo cristão e capitalista imprime, nas práticas e percepções atuais, uma reapropriação das condutas morais de nossos antecessores colonizadores, ao utilizarem o sexo e a sexualidade como dispositivos produtivos de saber para, por meio de redes de poder, controlar os sujeitos.

Ao construir a moral nesses moldes, a ausência do cuidado no uso dos prazeres passa a ser lida como “castigo”, e não como resultado da ausência de conhecimentos.

Quando perguntamos a Nando se, em casa, seus progenitores tivessem dito: “olha, filho, você está começando a sua vida sexual; se acontecer alguma coisa de ruim, conta pra mãe, conta pro pai, vai dar tudo certo”, ele acredita que teria vivido de forma diferente a experiência da descoberta de sua sorologia, a resposta foi:

Acho que sim, com certeza. Porque viver tudo aquilo...Com certeza, não era minha responsabilidade querer ensinar os meus pais. Eles que deveriam me ensinar e não me tratar daquela forma. Eu acho que eu teria me tratado com mais responsabilidade comigo e nas minhas relações. Acredito que sim (Nando).

A fala de Nando reverbera aquilo que era comum na cultura grega antiga e que Foucault (2024a) apresenta como *riscos e perigos*. A moral que direcionava a vida da sociedade grega do século V não se pautava no que temos hoje um moralismo hipócrita que exerce sobre os prazeres um peso em que muitas pessoas precisam pagar pelos riscos possíveis que o sexo pode ocasionar.

A visão sobre o sexo e a sexualidade, além de possuir outra perspectiva³², não era utilizada como dispositivo de controle moral, mas como um regime voltado ao cuidado do corpo. Buscavam-se meios e formas para que as práticas sexuais fossem seguras, de modo que os corpos não sofressem com os riscos e perigos que poderiam resultar. Ou seja, as experiências eram socializadas na pólis e indicavam caminhos seguros que possibilitavam evitar tais riscos e perigos.

Foucault (2024a) menciona, como exemplo, uma fala do filósofo Diógenes, ao afirmar ser mais propícia a atividade sexual no inverno do que no verão. Embora ele não explique essa afirmação, ainda assim é possível perceber nela uma preocupação com o cuidado, e não uma lógica de restrição.

Nando, ao falar sobre a importância que a conversa sobre a sexualidade teria representado em sua vida, no que tange à responsabilidade consigo mesmo, nos direciona a pensar o cuidado de si que Foucault (2024a) apresenta em *História da Sexualidade*. O cuidado de si representa uma relação respeitosa e racional consigo mesmo, em que os valores que orientam a vida passam por processos de olhar e examinar a si mesmo.

Esse movimento que se volta para si promove, em cada sujeito, seu próprio governo. Conhecem-se os limites e os excessos. Essa constituição de si não se dá por algo imposto, como uma regra que determina condutas e formas de ser difundidas para toda a sociedade. Trata-se de uma técnica propagada como uma “filosofia de vida”, em que outras pessoas, ao trilharem o caminho do cuidado de si, tornam-se exemplos mestres, filósofos, familiares.

Em nenhum desses casos há um papel que represente autoridade, justamente por não se tratar de algo imposto.

O cuidado de si fala sobre uma cultura que valoriza a produção da existência a partir da relação que se tem consigo mesmo. O cuidado de si também diz respeito à política, na medida em que só se pode governar bem quem é capaz de se governar. Não se trata de algo apenas individual, pois, ao cuidar de si, cuida-se também do

³² Era utilizado a palavra *aphrodisia* para designar “coisas” ou “prazeres do amor”, “relações sexuais”, “atos da carne”, “volúpias” (Foucault, 2024a, p. 46) que para a nossa referência seria a sexualidade como algo mais amplo e que também, o próprio Foucault (2024a, p. 48), adverte que a *aphrodisia* não tinha relação a “nada que se assemelhasse às longas listas de atos possíveis que serão encontrados nos penitenciais, nos manuais de confissão ou nos livros de psicopatologia; nenhum quadro que sirva para definir o legítimo, o permitido ou o normal, e a descrever a vasta família dos gestos proibidos”.

outro, em uma extensão na qual o cuidado pode alcançar diferentes dimensões da vida.

Quando Nando afirma que não é sua responsabilidade ter de ensinar seus pais, mas que sua mãe e seu pai deveriam tê-lo ensinado, evidencia-se essa relação perturbadora em que, estruturalmente, a lógica formativa familiar que vem dos avós, passa pelos pais e chega aos filhos não promove nem pratica uma cultura do cuidado de si, privando Nando de ter recebido condições para aprender a cuidar de si mesmo.

Outro ponto importante no decorrer da entrevista ocorreu quando perguntamos se, em algum momento, a família havia falado sobre sexualidade e sexo. A princípio, Sonia respondeu que não. Após um breve silêncio, ao acessar suas memórias, ela retomou a pergunta de forma enfática e respondeu: *“minto, eu tenho um primo que falavam que tinha (HIV), mas não sei se é verdade. O meu pai descobriu e meu pai falava ‘você viu o filho do fulano está com AIDS, não sei o que’... meu pai comentava assim ‘eu não quero fulano aqui em casa’, sabe?”* (Sonia).

A fala do pai de Sonia foi baseada no desconhecimento, ao colocar o HIV e a AIDS como a mesma coisa, ou ao tratar o HIV como sinônimo de AIDS. Essa percepção contribui para a produção de estereótipos. A fala do pai de Sonia representa exatamente o que estamos discutindo: a falta de conhecimento para o cuidado de si, que se estrutura e se reproduz em outras gerações, e que aparece em Sonia na ausência de uma abordagem informativa, marcada por estereótipos construídos sobre a AIDS.

Ao repreender Sonia, seu pai evidencia uma construção que podemos chamar de *pedagogia do medo*. Ao pensarmos que um dos papéis da pedagogia é criar e reforçar ideias e comportamentos, ela pode tanto auxiliar no desenvolvimento das pessoas quanto atuar na produção de violências, a depender de como determinado assunto é tratado. No caso, o medo é utilizado como forma de marcar que a AIDS é algo ruim e, assim, a presença do primo em casa passa a sinalizar algo proibido, perigoso, capaz de causar danos e problemas.

Ao pensarmos a pedagogia do medo, amparamo-nos em Foucault (2010a), quando trata do *continuum médico-jurídico* como uma técnica que visa dominar o “perverso”. Ou seja, ambos operam como um dispositivo que busca controlar, vigiar e normalizar todos os corpos que se enquadram na ideia de perversão. O discurso médico diagnostica e medica; o discurso jurídico julga e prende.

Esse continuum funciona na junção desses dois saberes. O médico passa a olhar para o perigo, para aquilo que a perversão pode causar, seja pelas condutas sexuais consideradas irregulares, seja pelas tendências que o perverso poderia cometer. Do mesmo modo, o médico passa a adotar discursos jurídicos, assim como os juízes adotam discursos médicos, quando passam a operar a partir de diagnósticos, na realização de perícias, e quando julgam com base nas classificações produzidas pela psiquiatria, que determinam o normal e o anormal.

O continuum aparece de forma mais evidente ao final do século XIX. Todavia, a prática de prender e curar já ocorria anteriormente, quando se buscava a correção dos sujeitos, sobretudo quando determinados casos ganhavam visibilidade e comoviam a sociedade, que passava a exigir punição. Não é à toa que é comum ouvirmos o discurso que Foucault (2010a, p. 29) nos lembra: “Você vai acabar na forca”. Ao ouvi-lo, somos remetidos à ideia de algo ruim que pode acontecer.

Assim, o continuum se mantém desde os primeiros suplícios apresentados por Foucault em *Vigiar e Punir* (2014b) e pode ser localizado, também, com o aparecimento da AIDS. Os discursos e as percepções produzidas passaram a construir as pessoas soropositivas como perversas, anormais e perigosas, e, no interior das famílias, esses sentidos operam como motor da pedagogia do medo. Vimos essa relação nas falas de Sonia, e ela também aparece na fala de Nando:

Na minha família eu nunca tive, pelo menos que a gente saiba. Pessoas que vivem com HIV, nunca tive essa informação. Mas meus pais sempre foram, ainda mais quando eu era jovem, minha mãe melhorou muito, mas eles sempre foram...Minha família no geral, né? Minha avó...Eles sempre foram muito preconceituosos na questão de...na questão de ser gay, porque talvez eles já soubessem que eu era, mas eu ainda não falei com as minhas próprias palavras. Então toda vez que via um gay na TV, passava um gay na novela, ela falava de gay e já lincava isso com ser sujo, poder apanhar na rua, poder pegar a AIDS. E sempre foi dessa forma mais ridicularizada, sabe assim? Aí pega AIDS e morre. Nunca teve essa informação de que...Elas nunca me passaram essa informação de que, não, você tem todo o tratamento hoje em dia e que você não vai morrer, sabe? Era sempre uma questão, ai, gay é pra isso, é pra pegar AIDS e morrer. E já teve falas assim que me deixaram bem constrangido, sabe, assim, quanto jovem. É até trauma que eu tratei durante a terapia. Mas essas questões são questões que...Mesmo ela tenha melhorado...Hoje em dia minha família melhorou quase mil por cento, minha mãe principalmente, mas mesmo assim a gente lembra daquilo e lembra com dor, porque...A gente era e ela sabia que, querendo ou não, mãe sempre sabe. Tem essa frase, mas eu acho que é verdade. E porque ela falava dessa forma já pra eu perceber que aquilo não é legal.

Aquilo não era legal, aquilo não era bem visto na sociedade, muito menos lá dentro de casa, entendeu? (Nando).

No decorrer da entrevista, perguntávamos se a conduta da mãe de Nando era a forma que ela utilizava para educá-lo. Prontamente, Nando respondeu: *“sim, eu acho que ela tentava... eu não sei se educação, mas colocar medo mesmo”* (Nando).

Questionamos, então, se essa era uma pedagogia do medo para produzir algum comportamento em sua conduta, e ele respondeu: *“é isso, naquela época eles acreditavam que poderia mudar a gente. Então, se eu colocar medo nele, talvez ele mude. Talvez tenha tempo”* (Nando).

Para a mãe de Nando, o medo foi a forma encontrada para educar. O medo aparece como um meio de marcar limites e fronteiras entre o que, para ela, é bom e mau, seguro e perigoso. E, ainda que possa parecer legítimo, esse medo diz mais sobre ela do que sobre Nando.

Ouso dizer que as coisas passam a se modificar para Nando quando o medo que sua mãe operava se materializa com a morte de seu namorado, em consequência da violência homofóbica. Pessoas gays são criadas pelo medo e, com ele, criamos nossas táticas de sobrevivência. Infelizmente, alguns conseguem atravessar esse processo com mais êxito do que outros.

Em parte, isso se deve à clandestinidade que o medo produz em nós, fazendo-nos buscar a legitimidade dos desejos em espaços onde não há leis nem regras, onde tudo parece permitido inclusive matar e morrer. Embora existam leis, ao final, muitas dessas violências acabam reduzidas a um simples crime de latrocínio.

A pedagogia do medo, além de operar nas relações diretas entre familiares e seus/suas filhos/as, também aparece em outros modos e com a mesma pretensão: causar medo utilizando a figura homossexual-AIDS. Silva e demais pesquisadores (2023), ao analisarem uma imagem divulgada por um pastor americano em 1983, descrevem a homossexualidade associada à AIDS, ambas apresentadas literalmente como uma ameaça às famílias hetero-cis, brancas e cristãs.

Essa imagem foi veiculada como uma campanha com a intenção de produzir terror e medo, colocando a população contra as pessoas homossexuais e contra a AIDS. A campanha ilustra uma estratégia pedagógica que, além de produzir o medo “a AIDS pode te pegar”, produz estereótipos e preconceitos, utilizando o medo como forma de excluir e eliminar o/a diferente.

São práticas maldosas e intencionais que, ao serem empreendidas, não estão isentas de uma finalidade: aniquilar e produzir percepções que reproduzem a crueldade e o horror, justificadas por discursos familiares e religiosos cristãos.

A fala de Nando não é a única. Paka, em um momento da entrevista, descreve uma cena de atuação da pedagogia do medo, ao relatar que, quando se falava sobre HIV, era sempre uma “fala com nojo e tal”. Quando perguntamos a Paka qual sentimento ele tinha ao ouvir essas falas, sabendo que se referiam a ele, ele respondeu que:

até em casa, minha mãe também tem esses comentários, então...quando a gente vê alguma notícia na TV, ou alguém que a gente tá vendo um vídeo e ela ouve, por exemplo, e trata dessa forma bem com nojo mesmo, sabe? Achando que as pessoas que tem, convivem com HIV, são pessoas nojentas, são pessoas que se dão desfrute, que transam com qualquer um. Às vezes é verdade, mas...Mas é o problema da pessoa, né? Tipo, não é o problema dela e ela escolheu essa vida (Paka).

As palavras de Paka trazem desdobramentos importantes quanto à leitura que seus familiares fazem sobre uma pessoa soropositiva. Quando essa leitura ocorre, ela está quase sempre referenciada ao que é considerado ruim. Trata-se de um pensamento categórico: “soropositivo, logo ruim”. Uma visão limitante, reflexo de uma construção cultural que se espalha pela sociedade como um mal a ser eliminado e não as próprias visões preconceituosas e estigmatizantes.

São essas percepções que fazem com que pessoas como Paka, Nando, Sonia e Caio não tenham tido oportunidades de saber sobre seus desejos, seus cuidados e tantas outras dimensões que favorecem uma vida compreendida como integral, e não esfarelada pela religião e pelo moralismo.

Ferrari e Castro (2015), ao falarem sobre o fantasma que a homossexualidade representa, mostram como o medo é produzido discursivamente em torno de comportamentos considerados desviantes, criando, nas escolas e nas famílias, a percepção de que há uma desordem prestes a ameaçar a organização estabelecida sobre a sexualidade e as identidades de gênero. O corpo que destoa do que é esperado incomoda. E a forma como esse incômodo opera é, muitas vezes, por meio da exclusão, em seus múltiplos sentidos.

Quando conversávamos, perguntamos a Paka se, antes da descoberta de sua sorologia, a fala em sua casa teria ajudado. Ela prontamente respondeu: “*da minha*

família, eu sei que deles não ia vir isso". Paka relata que sua experiência inicial com a sorologia foi marcada pela ideia de morte e pelo desamparo, por não ter a quem recorrer: *"Eu não podia contar pra minha família, até hoje. Sabe, é difícil. Às vezes a gente quer o apoio de alguém próximo da família, não tem. Tinha que guardar pra mim. Foi muito difícil. Porque minha família tem preconceito contra isso"* (Paka).

O fato de ter de guardar para si remete à ideia de que aquilo não é adequado (Moreira, 2008). A lógica que organiza o que é puro e o que é sujo atravessa diferentes espaços e relações, colocando-se como uma fronteira que determina o que e quando determinadas coisas podem ser ditas, enquanto outras são interditadas. Para Paka, sua sorologia já havia sido captada como um assunto que não poderia ser compartilhado com sua mãe. Assim, por mais que sejamos ensinados e ensinadas a falar tudo com a família, o HIV se coloca como a exceção.

Quando não há abertura para falar de assuntos delicados e necessários em casa, arrisca-se falar em outros lugares que parecem mais seguros. O HIV evoca, na pessoa soropositiva, um senso de defesa histórico. As histórias do passado seguem em um continuum, revelando que, embora tenhamos avançado sob o discurso do "progresso", financiado pelos medicamentos e pelas tecnologias de cuidado que permitem às pessoas soropositivas seguirem vivendo, esse discurso ainda se limita, em grande medida, a considerar a vida apenas em seu aspecto biológico.

Não temos como saber quantas pessoas, ao viverem soropositivas, são "assumidas", ou foram expostas, e ainda assim vivem bem. Contudo, isso não nos impede de pensar que a vida no interdito produz, em muitas dessas pessoas, uma espécie de vivência selvagem: vivem constantemente ameaçadas, com medo de serem capturadas pelo olhar preconceituoso do outro e pelas possíveis violências que esse outro pode cometer. Isso fica evidente quando Paka descreve uma situação vivida com seu ex-namorado:

na minha antiga relação que eu tive, o rapaz me ameaçou. Ele me ameaçou contar pra minha mãe. A gente terminou e ele me ameaçou. Ele falou ... 'eu vou contar pra sua mãe'. Ele sabia que meu maior medo era minha mãe saber. Quando a gente terminou ele me ameaçou. Ele não aceitou o término. Aí ele acabou contando para a irmã dele, contou para o cunhado, contou para algumas pessoas próximas e eu pedi pra ele não contar pra ninguém e ele contou (Paka).

Ao trazer essa experiência, Paka nos permite vislumbrar um olhar possível sobre as pessoas que temem revelar sua sorologia. O *pânico moral* (Rodrigues; Falcão, 2021) reduz as condições de escolha. Em uma sociedade marcada pela sorofobia velada, em que olhares, falas e gestos passam despercebidos porque os corpos soropositivos não estão visivelmente marcados, fala-se como se todas as pessoas fossem soronegativas.

No imaginário social e em muitos grupos, o HIV é compreendido como uma realidade distante, seja pelos espaços que as pessoas ocupam, seja pela sexualidade que vivenciam, pelas condições de relacionamento que mantêm, pela religião que professam ou pela classe econômica que ocupam.

Ainda assim, ao perguntarmos a Paka quais foram os desdobramentos do término do relacionamento e da exposição não consentida, ela respondeu:

Não fiz nada. Com medo mesmo, porque infelizmente a questão é minha família. Minha família tem uma cabeça muito pequena. Até aconteceu um caso na minha família recente. Eu perdi meu sobrinho recentemente. Foi por causa de doenças também, sexualmente transmitidas. A minha irmã pegou sífilis e passou pro bebê. A minha mãe abominou. Abominou! Ela falou, 'aí, nossa', tipo assim, como se fosse coisa de outro mundo ela ter pegado sífilis. Aí ela falou, 'ainda bem que não foi HIV senão você ia estar ferrada se não ia morrer'. E eu tenho que fazer isso, entendeu? Ficar quieto, ficar na minha. Tipo, as pessoas evoluíram demais. Se minha mãe ficou louca com uma sífilis imagina com um HIV. Ela ia ficar mais louca. A minha irmã fez o exame no postinho da cidade. A cidade inteira ficou sabendo. Ninguém guarda seu segredo. É muito difícil. Você imagina uma HIV? (Paka).

O não falar, para Paka, mostra uma maneira ainda que sofrida de se manter protegido, mas, talvez com maior predominância, revela o medo da rejeição. O que se espera de uma família é que ela seja um lugar de proteção, sobretudo em situações que nos vulnerabilizam e nos expõem ao risco (Caetano; Treyce, 2017). No caso de Paka, e possivelmente de sua irmã, isso não se concretizou.

Sua mãe, embora não apresente um modelo estritamente tradicional de família, por estar em um segundo casamento (como Paka mencionou em outro momento), mantém estruturas que buscam legitimar seus/suas filhos/as a partir de heranças morais recebidas de seus próprios pais, seja pela educação, seja pelo papel do marido, que a convoca a ocupar e representar determinadas performances e papéis de gênero.

Outras falas se somam à de Paka quando se trata do medo de ser rejeitado. Durante a conversa com Caio, ele relatou que seu namorado havia revelado sua sorologia a ele. Na ocasião, perguntamos se o fato de o namorado ter descoberto primeiro, e de a família já ter conhecimento sobre sua sorologia, teria ajudado Caio. Ele nos respondeu:

A família inteira sabe. Como eu peguei tuberculose no hospital, eles acham que eu estava com tuberculose. Não acham que eu tive outra coisa. Só quem soube foi aqueles irmãos que iam me visitar. E eu falei que não quero ninguém além de vocês. Quando chegassem lá (para visita no hospital), qualquer que fosse outra pessoa, fingia que não te conhecia. Fingia que estava no mundo da lua. Como a tuberculose tem que ficar na mesma área de quem tem HIV, então como você ia saber? Ia saber se olhasse a sua ficha. Todo mundo queria saber o que fulano tem tuberculose (Caio).

Caio não responde diretamente à pergunta. Uma forma de fuga que, ainda assim, revela a possibilidade da rejeição. No jogo de poder entre o que a família poderia dizer sobre sua sorologia e como ele responderia sobretudo em um momento de fragilidade, quando estava no leito do hospital, Caio utiliza o código da tuberculose para mascarar o motivo de sua internação. Trata-se de uma resistência por direito: sua sorologia não precisa ser compulsoriamente revelada sem sua escolha e consentimento.

Esse silêncio também está atravessado pelo medo da rejeição, considerando que os valores cristãos estão presentes em sua família. A família zela pela inteligibilidade de gênero (Caetano; Treyce, 2017), e não muito diferente ocorre em relação à sorologia para o HIV.

Pelas palavras de Caio, não havia uma aproximação significativa com os/as irmãos/ãs. Quando perguntamos sobre a reação deles/as ao saberem de sua sorologia, Caio disse que souberam em função de seu adoecimento, quando os/as irmãos/ãs foram notificados pela gravidade de seu estado de saúde. Ao perguntarmos qual foi o sentimento e a percepção deles/as, ele respondeu: *“uma parte seria culpa deles por ter me abandonado, por minha mãe ter falecido, como eles não sabiam o tempo, enfim, né, de tudo isso”* (Caio).

Limitamo-nos a seguir questionando outros pontos e a considerar como possíveis razões para o afastamento: a orientação sexual de Caio; o fato de ele ter permanecido no local em que vivia com a mãe; o fato de ser o filho mais novo e não

ter constituído família; ou, ainda, aquilo que Caio relata sobre seus/suas irmãos/ãs, de que parte da responsabilidade por sua sorologia deveria ser atribuída a ele.

O que a cena apresentada por Caio nos mostra é que “*os pais chegam tarde e aí já está tudo educado*” (Vieira, 2012). Essa chegada tardia de seus familiares pode ser compreendida pela ausência de conversas sobre sexualidade, pelo distanciamento produzido ao longo dos anos e pelos papéis assumidos: irmãos mais velhos, de outras gerações, casados; irmãs casadas; todos ocupando o lugar do não dizer, atravessados pelo tempo tomado pelos trabalhos e pelas responsabilidades domésticas.

Ainda assim, esse poderia ter sido o espaço privilegiado para que as experiências que tiveram contribuíssem para as de Caio.

Uma vez que a sorologia foi conhecida, buscamos compreender como seguiram as relações de Caio com seus familiares diante dessa “novidade”. Perguntamos se, após sua sorologia ter sido compartilhada, eles/elas o apoiaram, ajudando-o a lidar com algo que poderia ser estranho e dificultoso. Caio para, pensa e responde: “não tocam no assunto, nem falam”.

Com o intuito de aprofundar suas poucas palavras, perguntamos se o fato de não tocarem no assunto seria uma forma de fazer com que sua sorologia não existisse. Então, Caio responde: “*como se não existisse. Não toca no assunto. Só perguntam se eu estou bem. Aí conforme eu fui fazendo os exames foi baixando, baixando, baixando, baixando*” (Caio).

O não falar é a tática da inexistência. Não reconhecer a existência é uma forma de impedir que determinada questão ganhe sentido, produza leis, direitos e possibilite o respeito, o cuidado e a condição humana de existir. Esse não falar não é estranho quando pensado no contexto da sexualidade escolar e estendido às famílias. O discurso e/ou a resposta são os mesmos: *Aqui não há gays nem lésbicas*, nem pessoas soropositivos/as (Junqueira, 2010).

A fala de Caio demonstra que há, por parte de seus familiares, um estado de negação. Para negar, é necessária a ausência de palavras. Quanto mais algo é dito, maior é seu efeito de verdade. É assim que os regimes de verdade e de mentira se constroem, sobretudo no campo político como, por exemplo, no chamado “gabinete do ódio”, ao produzir e propagar *fake news*.

Ao seguirmos conversando, perguntamos se o fato de não perguntarem teria algum significado. Caio nos respondeu que:

Ah, eles já são mais reservados, por que nunca, nunca, bate em cima de um assunto. Nunca pergunta muito por que acha que vai te constranger, entendeu? Mas conforme... Ah, eu fiz o exame. Baixou tanto. Fiz o exame. Baixou tanto. Quando zerou, eu falei, zerou. Pronto. É como se, tipo assim, não tenho mais nada. E aí todo mundo ia falar, fui no médico, tá tudo certo. Tá tudo ok. Né? E aí também não... Ah, então tá bom. Só isso. Não entra num detalhe, ah, não sei o quê, não sei o quê (Caio).

Na perspectiva de Caio, o fato de seus familiares não tocarem no assunto é uma forma de não criar constrangimento, afirmando, tanto por parte dele quanto por parte deles/as, que o tema “HIV/AIDS” é um problema e, por isso, não é adequado falar. O silêncio passa, então, a representar uma ação que não é neutra, carregada de nuances envolvidas por estratégias morais e políticas que, em continuum, formam percepções e interdições que, ao serem aplicadas, funcionam como formas de exclusão.

O vazio das palavras deixa espaço aberto para a criação de sentidos. É fato que manter uma constância de perguntas e de busca por informações pode produzir um estado de indigestão. Em uma sociedade em que o viver soropositivo é carregado por camadas estigmatizantes, não se alimentar das respostas elaboradas pelos familiares pode se tornar um possível caminho para manter-se bem.

De todo modo, ao esgotarmos nossa busca para aprofundar a percepção de Caio, provocamo-lo ao perguntar se ele achava que o fato de seus familiares não entrarem em detalhes, nem desejarem conversar sobre sua sorologia, se devia ao fato de serem reservados ou se poderia existir certo preconceito. Caio nos respondeu: *“É difícil de dizer. É difícil dizer. É difícil de dizer porque eu estou colocando isso pra você na mesma família do Guga. Ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta nada”* (Caio).

Guga é o sobrinho de Caio, também soropositivo, que descobriu sua sorologia antes dele. A família também soube de sua condição. Ao seguirmos com a conversa, perguntamos a Caio se, quando soube da sorologia do sobrinho, isso teve algum impacto para ele. Caio respondeu: *“Ah, eu falei, ele pinta e borda, uma hora isso ia acontecer. Só que, igual eu falo, eu não imaginava que no meu caso ia acontecer igual. Por quê? Porque eu estava com uma pessoa só e era só aquela”* (Caio).

Ao lermos a fala de Caio, é possível perceber a reprodução de uma percepção estigmatizante sobre sexualidade e comportamentos. O fato de o sobrinho ter uma vida sexual ativa aparece como o “débito” de sua conta, tendo como consequência a

sorologia. Caio e o sobrinho são homens cis gays e, ainda assim, não compartilham do mesmo lugar de percepção.

Uma das possíveis explicações está no fato de Caio, mesmo sendo homossexual, ao estar em um relacionamento “fixo” tomado como sinônimo de segurança, compartilhar de percepções morais segundo as quais um relacionamento monogâmico funcionaria como uma ficção protetora contra o HIV. Já o sobrinho, também homem cis gay, por não manter um relacionamento fixo, passa a ocupar o perfil moralizador do “comportamento de risco”.

Ainda assim, ambos são soropositivos, o que evidencia que o HIV não é consequência de prazeres proibidos ou de comportamentos inadequados por desconfigurarem uma ordem moral conservadora. Ao contrário, ele é atravessado por uma pedagogia do medo que, ao se fixar nos discursos, nas omissões e nos não-dizeres, produz censura e exclusão afetiva.

A partir das falas de Sonia, Caio, Paka e Nando, torna-se unânime que os assuntos sobre sexualidade, HIV, AIDS e o viver soropositivo não circulavam em suas famílias de forma positiva, no sentido de oferecer condições para que os filhos e a filha exercessem suas práticas sexuais e de sexualidade de maneira afirmativa, sem medo ou constrangimento.

Quando essas falas apareciam, surgiam por meio da pedagogia do medo, que visa produzir comportamentos e condutas que asfixiam a realidade dos desejos e das sexualidades, enquadrando os corpos nos papéis de gênero e sexualidade que os familiares reproduzem.

De todo modo, observa-se a existência de uma fundação estrutural que atravessa gerações, fazendo com que os temas da sexualidade e do HIV não circulem nos lares brasileiros das pessoas participantes desta pesquisa. Ao olharmos para as falas, é possível perceber os prejuízos decorrentes dessa ausência. Também emerge a percepção de que a família poderia ter colaborado para que o HIV não se colocasse como mais um sofrimento na vida dessas pessoas.

Muitas das falas revelam a reprodução das percepções de seus familiares a visão de relacionamento, os papéis de gênero e as condutas sexuais que passam a ser lidas como punições ou irresponsabilidades naturalizadas pelos próprios participantes da pesquisa.

Assim, ao olharmos para a atuação da família, percebe-se a ausência de uma percepção real das sexualidades. A fundação que seus familiares demonstraram está

sustentada por desinformações enquadradas nos âmbitos religioso e moral. Não se fala com filhos e filhas sobre a realidade da sexualidade, mas sobre como eles e elas devem ser e como devem se comportar.

Essa conduta dialoga diretamente com os eixos anteriores. A ausência de uma formação sólida e crítica possibilitou que as pessoas participantes da pesquisa vivenciassem situações de medo ao descobrirem sua sorologia, além de experiências de preconceito nos espaços de saúde experiências que poderiam ter sido menores ou até inexistentes se a educação estivesse presente em todas as instâncias que atravessam as relações: familiares, filhos e filhas, médicos, enfermeiras, pessoas soronegativas e tantas outras.

Com os dados produzidos até aqui, foi possível perceber que, em algumas famílias, a fala sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas simplesmente não apareceu. Nas famílias em que o assunto circulou, a forma como foi abordado esteve marcada por estigmas e preconceitos, imprimindo uma percepção de erro, de medo e de perigo.

Na continuidade, com o próximo eixo, buscaremos compreender o que a escola pode ter desempenhado na vida das pessoas participantes da pesquisa: se houve alguma fala, de que forma ela ocorreu ou, caso não tenha ocorrido, quais foram as razões para sua ausência.

5.18 Eixo 4: Quando a aula produz medo e não cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS na voz de pessoas soropositivas

Quando pensamos na escola, sobretudo naquela em que estudamos, lembramo-nos dos vários e repetidos discursos que nossos familiares diziam sobre a importância de ir à escola para aprender a ler, escrever e contar.

Todavia, além de nos ensinar uma série de coisas possíveis³³, aprendemos a sentar nos lugares que nos foram delegados, a ficar em silêncio mesmo quando queremos falar, a saber o momento de ir ao banheiro e, assim, pedir permissão para isso, a esperar em filas, a respeitar as regras da escola e o uso dos uniformes, ainda que, para adolescentes, sejam considerados modelos bregas, entre tantas outras

³³Ressaltamos que a escola pública é um espaço de poder e necessário à sociedade. Todavia, questionamos os currículos e as pedagogias que se inserem na disputa entre um saber homogeneizado e um saber crítico. Consideramos que a escola precisa ser um espaço crítico, político e democrático, e não apenas de reproduções e reforços que alimentam as estruturas do capital, do poder neoliberal e conservador, que desafiam, a cada dia mais, a sociedade pela maldade e pela ganância na implementação de uma sociedade antidemocrática.

sanções que são colocadas, punindo ou gratificando, como formas de docilizar os corpos que ali estão.

Ou seja, a escola não se limita a educar para o conhecimento do mundo. Nossos corpos estão no jogo das relações de poder, nas quais a escola se compromete a disciplinar, vigiar e fazer com que entrem em constante conflito, seja no obedecer, seja no desobedecer. Na escola, há corpos obedientes e corpos desobedientes.

Nos últimos anos, no Brasil, temos vivenciado uma certa “obsessão” em transformar as escolas públicas estaduais em formato cívico-militar. Essa obsessão surge a partir de pensamentos persistentes em fazer com que o Brasil se torne mais patriota.

Na ansiedade que essa obsessão causa, entre os anos de 2019 e 2020, foi implementado, pelo Governo Federal da época, sob a presidência do ex-presidente, inelegível e agora preso, Jair Messias Bolsonaro – PL, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (PECIM), tendo como alvo as “escolas mais vulneráveis” do Brasil.

Contudo, em 2023, o projeto foi extinto pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva – PT. Ainda assim, mesmo com a extinção, muitos estados brasileiros têm adotado essa “nova” política educacional de forma própria.

No Estado de São Paulo, pelo governo de Tarcísio de Freitas – Republicanos; no Estado do Paraná, pelo governador Ratinho Júnior – PSD; no Estado de Minas Gerais, pelo governador Romeu Zema – Novo; assim como em outros Estados.³⁴

Um fato curioso, que trata desse contexto e que nos interessa, foi o ocorrido no Colégio Estadual Cívico-Militar João Turin, na cidade de Curitiba. Um vídeo viralizou nas redes sociais, no qual eram mostrados/as estudantes marchando como soldados/as e cantando uma música conhecida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais.

O BOPE, como é conhecido, é um grupo de policiais que atua em casos que, segundo eles, são vistos como situações de risco. Esses policiais (e, em número menor, mulheres) passam por um “treinamento” similar ao realizado nas Forças Armadas, composto por provas e exercícios que envolvem restrições em várias

³⁴ Segundo o Jornal Gazeta do Povo (2023) “Em reação ao governo Lula, 19 Estados decidem manter escolas cívico-militares”. Ver toda matéria em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/reacao-lula-19-estados-manter-escolas-civico-militares/>

instâncias: físicas, psicológicas, alimentares e de sono — o que é, muitas vezes, apresentado como justificativa para a menor presença de mulheres, por não conseguirem passar nos testes.

Com esse treinamento, é produzido um grupo de corpos de batalha, nomeados como “tropa de elite”. A música que as/os estudantes do colégio cantavam, em referência ao BOPE, diz em sua letra:

Homem de preto, o que é que você faz?
Eu faço coisas que assusta o satanás.
Homem de preto, qual é sua missão?
Entrar na favela e deixar corpo no chão.
O Bope tem guerreiros que matam fogueteiros.
Com a faca entre os dentes, esfolam eles inteiros.
Mata, esfolam, usando sempre o seu fuzil.³⁵

Ao fazer uma volta ao passado, é possível perceber que o formato da escola, seja em sua arquitetura, seja em seu sistema de funcionamento, mantém proximidades e ressignificações do modelo que temos nos dias atuais em relação ao passado.

Foucault (2015c) explica que o século XIX é marcado por *instituições de sequestro*, que tinham como objetivo a reclusão para a fixação de saberes, normas e produções. A referência dada por Foucault ao sequestro é feita pela forma de atuação que ainda é possível observar nas escolas nos dias atuais.

Por lei, crianças, jovens e adolescentes são retirados da circulação social durante um longo período. No sistema de ensino integral do Estado de São Paulo, chega-se a mantê-los/as por cerca de nove horas por dia, com esses sujeitos-estudantes fechados na arquitetura escolar até a conclusão do Ensino Médio, que leva, em média, três anos.

Ou seja, o tempo livre que esses e essas jovens e adolescentes poderiam ter para se divertir, seja em festas, encontros ou momentos de lazer, com o uso de seus corpos e prazeres, passa a ser homogeneizado em função da descaracterização da existência para a caracterização da vida voltada à produção do lucro.

Foucault (2014b) descreve que o sequestro opera de forma *in-discreta*, colocando vários controles simultâneos, mesmo aqueles que não dizem respeito

³⁵ A música foi retirada da matéria publicada pelo G1 Paraná escrita por Colombo, Mendonça e Pierin (2025). Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2025/12/01/video-alunos-parana-apologia-violencia-colegio-civico-militar.ghtml> Acesso em 3 dez 2025.

diretamente à sua função, como a relação do controle das aprendizagens com a produção da saúde, misturando-os a outras coisas.

Um exemplo disso é o controle exercido pelo discurso das campanhas de saúde mental, ao buscarem um sequestro das emoções e expressões; o controle realizado pelo currículo e pelo clima escolar, ao selecionar quais sexualidades e gêneros a escola trabalhará; e quais ideologias serão priorizadas, como o patriotismo, a religião cristã e, como vimos, a obsessão pela educação moral.

A disciplina na escola tem como objetivo criar *quadros vivos* (Foucault, 2014b). A/o estudante, ao ser matriculado/a na escola, passa a compor, junto a outros e outras estudantes, uma diversidade de comportamentos, resultantes da cultura e das percepções que foram formadas. A escola, então, organiza os corpos a partir dessas distribuições.

Isso ocorre, por exemplo, na organização por salas (turmas A, B e C), considerando critérios de homogeneização das competências e das indisciplinas: juntam-se os que sabem mais, distanciam-se os que são considerados indisciplinados para não atrapalhar o rendimento, agrupam-se os que são brigões com aqueles que são mais quietos.

Os banheiros também funcionam como uma forma de marcar posições e papéis de gênero. As fileiras organizam os corpos em uma ordem na qual, à frente, estará a/o professora/or.

Há ainda os espaços permitidos e os proibidos, como a sala da direção e a biblioteca, o pátio e o refeitório, compondo uma lógica de controle e hierarquização dos corpos no cotidiano escolar.

Em todo o espaço que a escola possui, há uma forma de controlar a atividade que a/o estudante vai realizar (Foucault, 2014b). O horário de chegar, que não pode ser ultrapassado com possibilidade de punição, assim como o horário de sair, ambos marcados pelo sinal que delimita o tempo de início e fim do sequestro.

Outros horários compõem esses espaços: a distribuição das aulas-disciplinas, o momento do intervalo, o controle de quantas pessoas podem ir ao banheiro, sob a supervisão da inspetora, e o cartão que habilita a/o estudante a estar fora da sala.

Esses controles são organizados estrategicamente para ocupar o tempo escolar e, por meio da disciplina, criar comportamentos a partir de vários reforços cotidianos, buscando possibilitar o menor número possível de corpos desobedientes e o maior número possível de corpos obedientes.

A escola que temos hoje não se distancia do formato do passado apresentado por Foucault (2014b; 2015c). São empreendidas várias táticas de sequestro e disciplinamento, ambas visando produzir o corpo e o sujeito social.

A escola, por se colocar como um aparelho estatal, segue operando a partir das funções de quem a governa. Nos dias atuais, é possível pensar que o trabalho de disciplinamento paira sobre a escola com as sanções do passado, agora ressignificadas por novas tecnologias de sequestro e controle.

A escola é um espaço de poder e de forças. O poder se movimenta à medida que as forças também mudam. A cultura atual tem sido marcada pelo avanço das tecnologias e das inteligências artificiais. Nessa atualização, as sanções e os sequestros precisam se readequar. São meios de controle que, embora muitas vezes não visíveis, seguem controlando e produzindo.

A “*Plataformização da educação na rede estadual de São Paulo*” (Garcia; Noronha, 2025) exemplifica como o sequestro e a disciplina atingem tanto as/os estudantes quanto as/os professores e gestores escolares.

A partir das plataformas, é possível uma vigilância *tecnopanóptica*³⁶, em que o sistema, ao ser acessado e o deve ser, por estruturar as aprendizagens por meio dele, padroniza as tarefas que as/os estudantes realizam.

Criam-se metas que devem ser alcançadas, vigiam-se e controlam-se as respostas, seu teor de verdade, pelos logins de acesso, o tempo em que devem estar logadas/os, e temporalizam-se as atividades realizadas, produzindo efeitos produtivos e econômicos com maior rapidez e precisão - uma tecnologia de poder que não atua apenas em disciplinar, mas também em produzir.

O resultado, ainda que para algumas leituras possa ser considerado positivo, revela professores exaustos, alguns infartados³⁷, estudantes angustiados, burladores e, por que não, desmotivados/as.

³⁶ O termo que utilizamos diz respeito ao entendimento de um outro modelo panóptico, que não consiste em uma estrutura física visível, mas é gerenciado por robôs e algoritmos que possibilitam que tudo seja visto, conhecido, controlado e subordinado, estagnando o tempo do pensamento pelo cansaço do tempo de tela, pelo excesso de cobranças e de resultados. Trata-se de um capturamento do pensar para o artificial, que repercute em corpos pouco pensantes e acríticos, não pela ausência de sua capacidade de pensar, mas pela ausência de tempo, pelos acontecimentos do tempo real e pela enxurrada de informações que competem entre verdades e notícias falsas. Aos poucos, cria-se um sujeito estigmatizado por não conseguir ver o real, pela ausência e pelo excesso que adoecem o olhar.

³⁷ Segundo a matéria, “No ano passado (2024), 42 mil professores foram afastados por causa de transtornos mentais e comportamentais”, entre tantos outros casos, como de professores que morreram de infarto dentro da escola. Ver mais em: <https://www.intercept.com.br/2025/12/08/pressao-escolas-governo-tarcisio/>. Acesso em 15 jan. 2026.

A esse modelo de escola, Foucault (1971) tece críticas ao imputar à escola a *função teatral da vida*, por ser uma ficção ao não trazer a realidade dos acontecimentos sociais para dentro de seus muros. Ao falar sobre a aluna e o aluno, Foucault percebe que ambos estão inseridos em um sistema que cumpre a função de excluí-los/as.

Há um processo de exclusão que se inicia desde o momento em que eles e elas saem de casa e são inseridos/as dentro dos muros fechados da escola. As escolas passam a se assemelhar a prisões.

Ao olharmos para as realidades das escolas brasileiras, muitas de suas estruturas encontram-se sucateadas, sem conforto ou condições que possam acompanhar, por exemplo, os efeitos do aquecimento global. Logo, as escolas não têm o mínimo de conforto e acabam por se tornar espaços de tortura - imaginem ficar por volta de nove horas fechados em um calor escaldante, com apenas alguns ventiladores?

A exclusão segue quando a proposta curricular não dialoga com a realidade e o cotidiano desses e dessas estudantes, os problemas de sua geração, que, por vezes, são ignorados pela visão que o jovem e o adolescente representam na sociedade, vistos como pessoas que usam roupas esquisitas, se portam de modos estranhos, não querem compromissos e, no estágio, não querem trabalhar por não produzirem o que o sistema espera de um trabalhador adulto.

O que se ouve é: “não se fazem trabalhadores como antes”. O corpo útil que a disciplina produz é também o corpo que se rebela, como a outra face do poder. Ao passo que são criticados, esses e essas jovens são pressionados/as a resolver o futuro do mundo diante da destruição que nós e alguns grupos detentores de poderes capitais temos realizado, explorando, desmatando, consumindo e poluindo.

A escola, ao se colocar dentro de regimes ficcionais em que são propostas uma série de atividades para ocupar o tempo do/a estudante produtivo/a, faz com que, por vezes, essas ações sejam organizadas em torno do lúdico, para que o tédio não ganhe maiores proporções: solta-o/a na quadra, coloca para assistir a um filme, criando um possível caminho para fugir da vida real.

Como se todo esse trabalho investido fosse intencional para que não se compreenda o que está acontecendo com a sociedade. A escola, ao seguir esses processos de exclusão impostos ao/à estudante, projeta uma sociedade que não coincide com a vida real. O/A estudante passa cerca de nove anos de sua vida sem

ter grandes condições de ler, de forma crítica, a sociedade, seu funcionamento e as relações de poder.

Foucault (1971) nos ajuda a pensar que, quando a escola não permite que certos temas sejam tratados, como a sexualidade, e quando os corpos que ali estão são proibidos de exercer o direito de serem, ela desempenha a função de dessexualizar os/as estudantes.

O fato de não se falar sobre HIV, ou a forma como esse tema foi abordado, é como se esses/as estudantes não tivessem sexualidade, ou como se houvesse um silenciamento para naturalizar um comportamento que a escola não reconhece como natural, ao pressupor que não tenham desejos, vontades e curiosidades.

A escola, assim, produz os tipos de comportamentos que lhe são interessantes. Quando perguntamos aos protagonistas da pesquisa se, durante o período em que estudaram no Ensino Médio, em algum momento na escola, foram tratados temas sobre HIV, AIDS e o viver soropositivo, dois tipos de respostas foram percebidos: a de que foi falado e a de que não foi falado, como na resposta de Nando:

*Não se falou nada. Eu nunca ouvi na escola falar sobre HIV, pessoas com AIDS. O que a gente ouvia assim e não era do corpo docente nem da própria escola, e da direção. Era dos próprios alunos, que às vezes zombavam, quando viam uma notícia dessas, brincavam e não tinham responsabilidade nenhuma sobre a questão. Não sabiam informar, o corpo docente não sabia informar. Quando a gente perguntava sobre, eles não tinham essa, não sei tão bem esse ensino de eles próprios aprenderem e ensinar e passar isso pra gente. Então, durante a escola, e eu me lembro perfeitamente, porque o ensino médio foi tipo, a melhor época da minha vida, então eu me recordo com saudades, assim, até. Mas sobre essa questão *nunca foi falada* e as pessoas eram bem ignorantes, os alunos, nunca, obviamente, porque a gente é adolescente, é jovem, a gente ainda não tem esse conhecimento. Então, o incrível é que a gente está entrando na parte sexual, a gente já está tendo as primeiras experiências e não é passado nada pra gente. Falam pra usar camisinha, só que...A gente mesmo tem que buscar isso, porque nem na escola e nem na casa dos pais, a maioria dos pais não tem essa intimidade pra falar com os filhos, então a gente mesmo tem que buscar informação na internet, em livros, e a maioria dos jovens não fazem isso, vamos concordar. Eles não buscam informação, eles querem a coisa imediata. Ah, vou ter a primeira relação sexual, o importante pra eles é uma pessoa, não sei o que, fale isso com as amigas, mas nunca se fala sobre o que pode causar uma relação sexual irresponsável, sem preservativo, sem mínimo de conhecimento (Nando).*

Nas palavras de Nando, o período de escolarização no Ensino Médio foi marcado pela ausência de abordagem dos temas sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas. Sua fala marca não apenas a escola de forma geral, mas também a ausência de atividades, palestras ou projetos que poderiam ter sido oportunidades para que o tema aparecesse. Professores e diretora também não trataram do assunto, resultando em uma ausência sistêmica.

Britzman (2013) chama a atenção para o fato de que, a todo tempo, as/os estudantes, na escola, estão sinalizando situações em que a sexualidade aparece. Ao não ser tratada de forma “oficial” pelas pessoas responsáveis pela escola, essas conversas surgem como “não oficiais”, como menciona Nando, quando os colegas brincam, sem encarar o tema com seriedade e responsabilidade.

Ou seja, por mais que a escola não trate sobre sexualidade e sobre as questões que envolvem o HIV, os corpos discentes falam. A sexualidade, nesse contexto, não implica apenas os corpos e os desejos, mas também o sentido que as/os estudantes atribuem ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas.

Não falar pode representar uma visão negativa que perpassa as sexualidades, as identidades de gênero e as condições para que as tecnologias preventivas se façam presentes como possibilidades de responsabilização das escolhas, como Nando afirma.

Outro ponto representado pela fala de Nando é a resposta das professoras, dos professores e da direção, de que a justificativa para não abordar as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas era a falta de informações.

Rua e Abramovay (2001) veem essa ausência de informações por parte das professoras e dos professores como resultado de alguns motivos que impossibilitam que tais temas sejam tratados. Segundo elas, ao buscarem respostas ao mesmo questionamento de Nando junto à comunidade escolar, muitas justificativas foram apresentadas, como a pressão moral-religiosa das famílias; a ideia de que o assunto, ao ser abordado, deveria ser tratado por uma pessoa profissional especialista, retirando do corpo docente essa responsabilidade; e a procura de familiares conservadores às direções quando, em algum momento da aula, é mencionado o uso do preservativo, o que torna professoras e professores mais resistentes a tratar do tema.

Outras justificativas são apontadas por diretores e diretoras ao assumirem que preferem evitar falar sobre tais assuntos por não serem pautas que aparecem na

agenda das famílias, alegando, em alguns casos, que professoras e professores, ao falarem sobre sexualidade, estariam ensinando sobre sexo.

O período do Ensino Médio acompanha o aparecimento das primeiras experiências sexuais e, ao chegarem a esse momento, muitas vezes as estudantes e os estudantes são pegos de surpresa, por não terem informações que os/as auxiliem.

Nando, em suas palavras, deixa clara essa angústia ao dizer que foi necessário buscar informações em outros lugares, correndo o risco de que não fossem procedentes para compreender os primeiros sinais de sua sexualidade, já que, em casa, essas discussões não aparecem. Ainda assim, muitos/as estudantes não vão atrás de nenhuma informação, deixando as situações “rolarem”.

Abramovay, Castro e Silva (2004) argumentam que a chegada das experiências sexuais dos/as jovens é vista como um marco que separa a juventude do início da vida adulta. Ainda assim, nessa transição, é perceptível encontrar muitos e muitas jovens que não têm as informações básicas para atravessar essa fronteira entre o ser jovem e o ser adulto.

Ao sermos formados/as e alicerçados/as pela cultura familiar, nossa dependência de quase tudo coloca a juventude à mercê do que será ensinado sobre essas questões, vulnerabilizando as experiências sexuais e, ao mesmo tempo, culpabilizando-os/as por já serem considerados adultos e adultas.

A mesma pergunta feita a Nando foi dirigida a Caio, buscando saber se a escola, durante o Ensino Médio, havia tratado sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas.

A resposta de Caio é curiosa por ultrapassar a percepção atual de que as possibilidades do HIV estão restritas apenas à sexualidade, mostrando que, a partir dela, é possível chegar a outros meios e caminhos que também precisam ser falados e discutidos. Uma vez que, ao estarmos envolvidos nos cotidianos sociais e domésticos, o HIV, embora não seja visível, está presente nas diferentes pessoas e situações da vida. Sua resposta à nossa pergunta foi que, na escola:

a gente ouvia, né, mas como a gente não tinha... a gente não, eu não tinha relação sexual com ninguém, então era como se ouvisse qualquer conversa normal no dia a dia, mas não se interagia, porque você não tinha o envolvimento de ter o ato sexual, entendeu? E também não pensava na situação de outras possibilidades, de você se infectar por uma seringa, entendeu? Pelo menos no meu mundo, o que eu tinha era, o que eu poderia dizer para você, eu não teria essa determinação com tudo isso, porque a vida mais em sítio, entendeu? Mais no sítio. Então, parecia que você não teria acesso à urbanização

do dia a dia, à coleta de lixo e, às vezes, de repente, estar se contaminando. Ou, às vezes, até como essas pessoas dizem, num dentista, entendeu? Não. Nunca pensei dessa forma (Caio).

A fala de Caio mostra que, ao não ter uma vida sexual ativa, não despertava interesse em saber sobre as questões de sexualidade. O assunto, ao ser abordado no cotidiano escolar, passava a ser apenas mais um tema qualquer, que não chamava sua atenção.

Sua fala reverbera o que Ferrari (2015) aponta: o corpo como resultado dos processos produtivos de poder da sociedade, que atravessam instâncias que afirmam ou negam a realidade entre a curiosidade e o desejo. Ambos aparecem como entidades que se entrecruzam na disputa entre o que é dito e o não dito sobre a sexualidade.

Na educação, essa dubiedade ganha sentido a partir do resultado das disputas entre o dizer, como dizer e quais sentidos do dizer podem produzir, nos/as estudantes, significados que despertem interesse sobre a sexualidade. Para Caio, a escola, ao abordar tais questões em torno do HIV, não foi significativa e nos mostra que, pelo fato de não ter uma vida sexual ativa, suas experiências ao morar no sítio possibilitariam o contato com o HIV por outras vias que não se restringem à sexualidade.

Caio evidencia que, ao se tratar do HIV, existe um universo amplo de possibilidades que pode convidar a curiosidade de estudantes, sem a necessidade de limitar o tema apenas à sexualidade, como um outro caminho que, por vezes, se faz necessário trilhar.

No decorrer da produção dos dados, outras respostas apareceram quando perguntamos se a escola foi um espaço que abordou as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas. As falas de cada participante contribuem para ampliar as possibilidades de pensar as condições em que estamos lançados/as no universo dos regimes de verdades e inverdades que nos produzem sobre os assuntos que circundam o HIV.

Ao direcionarmos a Paka a pergunta, a resposta obtida foi que sim, a escola falou sobre o assunto que envolve o HIV. Seguimos provocando para saber como o tema apareceu, e Paka nos respondeu que o assunto surgiu *“na aula de ciências biológicas, acho que era biologia. Eu lembro que tinha os livros, né, e também tinha*

ensinando pôr camisinha, na banana, sabe? Eu tive essa aula, sobre o cuidado” (Paka).

A resposta de Paka nos direciona a pensar a partir do conceito formulado por Foucault (2015b) sobre o *biopoder*. O bio (vida) traduz-se no poder sobre a vida que, no contexto de Paka, se manifesta na escola como a instância que pedagogiza a sexualidade, visando produzir sujeitos dentro dos parâmetros da regulação, da higiene e da autodisciplinarização por meio do uso do preservativo.

A aula apontada por Paka demonstra o exercício do governo da sexualidade, amparado no saber científico, que possui a força de produzir comportamentos, regular a saúde, gerenciar e prever os riscos que o HIV pode representar. Paka, em sua fala, menciona os livros da disciplina de Biologia, onde o assunto circulava. O fato de o tema ser tratado nessa disciplina evidencia uma abordagem da sexualidade e do HIV inserida nos regimes de verdade produzidos pelos saberes biomédicos e científicos, fundamentados nos livros.

A menção ao preservativo e ao cuidado revela uma estratégia que, embora biologizante, reconhece a importância da sexualidade e do HIV, mas o faz de maneira superficial, sem tensionar possíveis valores morais que poderiam dificultar a ocorrência da aula.

Na fala de Paka, ele menciona que, na aula, foi utilizada uma banana como material didático para exemplificar, de forma prática, a técnica de como utilizar o preservativo.

A fala realizada pelo/a docente reflete a posição de *Professor@s e Eros* (Britzman, 2009). Com a banana, foi possível erotizar o saber, a fim de criar um espetáculo que provocasse a turma a compreender, mesmo que muitos/as ainda não tivessem iniciado a vida sexual, ao menos no campo imagético.

O uso do preservativo não diz respeito apenas a uma prática sexual. Ele fala sobre uma história em que, no passado, a ausência de formação e informação levou muitas pessoas à morte em decorrência da AIDS. A geração da qual Paka faz parte não vivenciou a realidade pandêmica da AIDS. Logo, a experiência da sexualidade para essa e para outras gerações é marcada pelo desconhecimento do que a AIDS representa, tanto no campo da saúde quanto no das relações sociais.

O Eros, como pedagogia, possibilita incitar o olhar das estudantes e dos estudantes a perceber o mundo de forma ampla, não recortada de seus acontecimentos. O que antes era visto como um problema, ser gay e, por isso, ter o

armário como lugar de refúgio, dá lugar, hoje, ao HIV que segue ocupando o espaço da invisibilidade social.

Ao perguntarmos a Sonia se a escola, em algum momento, havia tratado sobre o HIV, ela nos respondeu que sim, mas poucas vezes. Ao buscarmos compreender de forma mais profunda essa abordagem, perguntamos se a fala realizada na escola havia auxiliado em algum momento de sua vida. Sonia respondeu que a fala foi direcionada ao risco, mencionando o preservativo como uma fuga do perigo.

Sonia ainda complementa: *“na época, eles entregaram uma vez, eu acho que foi no meu último ano de escola. Eles entregaram quando era próximo do Carnaval. Entregaram preservativo e falaram das doenças sexualmente transmissíveis”* (Sonia).

Sonia nos indica alguns pontos que merecem nossa atenção. Um primeiro diz respeito ao fato de ela mencionar a fala da escola, mesmo sem localizar se foi realizada por professor/a, coordenação, direção ou se ocorreu por meio de algum projeto, palestra ou pela presença de alguém externo à escola.

Todavia, a abordagem dessa fala segue a mesma linha apresentada por Paka: a perspectiva do HIV no campo da saúde e da doença, como um exercício da biopolítica (Foucault, 2015b), em que se busca criar a autorregulação para que a sociedade não amplie os limites dos riscos que o vírus sinaliza.

Ainda na mesma direção da biopolítica, a distribuição dos preservativos pode ser lida como uma forma de manter a sociedade mais higienizada. Concomitantemente, também pode ser compreendida como uma forma de retrucar na relação de poder, a partir de discursos que pavimentam a estrada por onde marcha o conservadorismo, que nega a importância do uso do preservativo, impedindo o desejo e a prática sexual de exercerem o direito democrático de ser.

A fala de Sonia demonstra um pequeno, mas significativo, movimento que a escola realizou e que, na perspectiva de Paraíso (2019), pode ser compreendido como uma maneira de se reposicionar ao utilizar o arcabouço científico, embora este, muitas vezes, seja questionado por nós, pela forma como se coloca na sociedade e se posiciona nas relações de poder, excluindo por sua inteligibilidade cenários que não permite ver.

Diante dos retrocessos que têm desqualificado o papel do professor e da professora, sobretudo frente aos atentados à escola e à educação pública brasileira, torna-se necessário nos posicionarmos contra os achismos que esses movimentos

negacionistas têm buscado disseminar nos espaços escolares, renegando os avanços alcançados e utilizando, como tática, a afirmação de inverdades transformadas em mentiras, como foi feito no passado com a AIDS e que hoje se tenta retomar.

Os discursos que circulam nas escolas, muitas vezes, estão atravessados por posicionamentos que visam dificultar que a escola continue disputando um espaço no currículo de forma mais inclusiva para as questões que tratam sobre a sexualidade.

Na escola, os discursos que estão presentes, não são neutros, nem se esquivam de alguma intencionalidade. Existe uma ordem à qual esses discursos obedecem (Foucault, 2014a).

No campo de forças, os discursos que aparecem no âmbito da sexualidade e das questões de HIV, AIDS e pessoas soropositivas passam por procedimentos nos quais se controla a matéria que será abordada, seleciona-se o que é permitido ser trabalhado e limita-se, como vimos, à esfera do biológico, regulando quais falas sobre a sexualidade podem ser feitas.

Quando possível, o HIV aparece na escola por meio de falas que têm a autorização institucional, sobretudo quando se restringem ao discurso científico e moralizador. A forma como o HIV é apresentado nos discursos escolares passa por regimes que se distanciam da realidade, produzindo outras verdades situadas na dimensão das interdições, das regulações e da produção do medo, como é possível observar na fala de Sonia: *“eu lembro que comentava assim nas aulas, né? Quando foi falado que era uma doença sexualmente transmissível e que matava, que podia matar, então esse era o medo, né? Da época: pegou, vai morrer, que não tinha cura, que uma pessoa poderia morrer”* (Sonia).

A fala de Sonia mostra que a forma como o discurso que circulou na escola, durante seu percurso no Ensino Médio, esteve associada à morte. Se, por um lado, há a existência de um currículo pautado no *biopoder* (Foucault, 2015b), por outro, a forma como esse conhecimento é aplicado passa por uma *didática necropolítica* (Mbembe, 2018).

A ideia de uma *necro* (morte) - política de morte, reside no fato de que há um posicionamento sobre alguém (o Estado, as políticas e, aqui, o/a professor/a) que detém o poder de decidir quem pode ou deve morrer. O professor e a professora, muitas vezes, retêm um poder soberano: podem decidir o que falar e como falar.

No contexto da fala de Sonia, não há uma morte física, mas cria-se e/ou reforça-se a ideia de que pessoas soropositivas estão expostas à morte, pelo símbolo

construído sobre a AIDS como algo ruim. Ao falar, o/a professor/a opta por utilizar a pedagogia do medo, que consiste em produzir, pelo medo, a relação de aprendizado do/a estudante com o tema que será ensinado.

Mbembe (2018) destaca que a política de morte funciona a partir do que o medo de morrer pode produzir. Na história da AIDS, o medo foi uma das formas de atuação utilizadas pela política e pelo governo. Ao propagar o discurso que associava a AIDS à morte, criou-se, no coletivo social, a percepção de uma sociedade ameaçada e, conseqüentemente, controlada.

O uso da pedagogia da morte produz, na escola e nas/os estudantes, a ideia de que alguns corpos devem ser evitados, como, por exemplo, os corpos soropositivos. Pensar em ter ou se relacionar com uma pessoa soropositiva remete à possibilidade de morte que foi produzida sobre a AIDS, e não à sua realidade fora da ordem discursiva que lhe foi atribuída.

Em relações de proximidade, o racismo também é utilizado como uma tecnologia para matar, resultando em uma perspectiva na qual vidas pretas são tratadas como descartáveis. A sociedade e suas instituições têm resistido a reconhecer que nossa organização social mata de forma estrutural, e seguimos aceitando isso fazendo pouco. Durante a pandemia de AIDS, para a sociedade, a morte de gays era considerada aceitável. Vivemos naturalizados por uma *sorofobia institucional*.

A escola não se isenta desse processo, como é possível observar na fala de Sonia: *“hoje, como soropositivo, eu penso que era uma maneira assim de botar medo, né? Nos estudantes, para orientar também que a doença existia e que matava e que tinha tratamento, mas ainda estava em estudo, né? Na época. Mas era assim, era um pouco preconceituosa, sim”* (Sonia).

A fala de Sonia sinaliza a possível relação tradicional entre o papel do professor e o dos alunos, problematizada por Foucault (1975) a partir de três pontos.

O primeiro diz respeito ao regime de verdade em que o professor se estabelece: ele e ela são as pessoas da sala que sabem aquilo que os/as estudantes não sabem e que, pelas regras de aprendizagem, pelos currículos nacionais e pelas políticas educacionais, os/as estudantes devem saber. Nessa posição, insere-se no/a estudante uma certa culpabilização por não deter previamente o conhecimento, criando, assim, um sentimento de falta e de incompletude.

O segundo ponto é a obrigação de saber os conteúdos que foram transmitidos pelo professor ou pela professora, pautando-se no que anteriormente foi estipulado como aquilo que os/as estudantes devem aprender. Há, nessa obrigação, uma relação de poder em que a pessoa docente, a partir do espaço que ocupa, direciona a conduta das pessoas discentes a ela destinadas.

Por último, há a verificação, materializada nos exames, nos quais as/os estudantes são colocados a testar aquilo que foram obrigados/as a aprender.

A visão que Foucault (1975) defende, e que ele exercita, é aquela em que o professor ou a professora não ocupa o papel de poder no qual tradicionalmente foi colocado e que, ainda nos dias atuais, ocorre, repercutindo em um tipo de relação em que, ao deter o saber, o/a docente exerce sobre as/os estudantes um preenchimento, visto como resposta a uma falta.

O que Foucault busca fazer em suas aulas é propor a sala de aula como um local de problematizações, em que as verdades que vêm sendo investigadas sirvam para desestabilizar as certezas até então produzidas e apreendidas no decorrer das histórias. A partir desse trabalho, possibilita-se que as estudantes e os estudantes busquem, por meio da pesquisa, “outras verdades”.

O ensino não deve se pautar em uma relação de culpa, obrigação ou medo, como foi expresso nas palavras de Sonia. O que orienta a relação de aprendizagem é o interesse que o espaço institucional deveria invocar nas pessoas que procuram a escola, na curiosidade de ouvir, de se provocar pelo que foi ouvido e de se autoavaliar, considerando o que é possível refletir a partir do que se ouviu, assim como do que as outras pessoas falaram.

Trata-se de uma troca em que não há uma única verdade, mas várias verdades produzidas por pontos de vista diferentes, que possibilitam que determinada questão possa emergir.

O formato que Foucault (1975) propõe para o funcionamento dos espaços de ensino nos possibilita pensar que, se a sexualidade é uma instância que revela o desejo e o prazer, combinada com assuntos e discussões, torna-se propício falar sobre HIV/AIDS e pessoas soropositivas. O tema, ao ser abordado, não precisa se colocar em uma linha que divida a obrigação do medo.

Muitos currículos, ao serem propostos como direcionadores do ensino, estão impregnados de profundos desgostos que não dialogam com os desejos das estudantes e dos estudantes. Parece não haver interesse pelos cotidianos de suas

realidades. E, quando aparecem, é na linha da biopolítica (Foucault, 2015b), como é possível observar em outro momento da entrevista com Caio, quando ele relata o conteúdo tratado na aula sobre sexualidade. Ele diz que: *“na época, a pessoa só falava sobre gravidez, né? Parece que naquela época só existia o ato da gravidez”* (Caio).

Provocamos Caio perguntando se era mais perigoso engravidar. Ele respondeu: *“era de você engravidar. Tipo assim, nossa, fulana tá grávida. É como se fosse algo de outro mundo. Mas, em questão de doença, quase a gente não tinha muito acesso, pelo menos nas conversas, entendeu?”* (Caio).

A fala de Caio evidencia um problema de gênero (Butler, 2015), no qual o papel social que a menina performa produz um estigma que não recai sobre o menino. A produção cultural construída sobre os corpos das mulheres e das meninas coloca em jogo os saberes mobilizados na escola e define que tipo de currículo e de educação serão ofertados: uma educação que previne para não envergonhar e desonrar a família ou para que a menina não “se comprometa”, assumindo um papel que, por vezes, é solitário, distanciando-a de ocupar espaços de poder que, supostamente, o menino seguirá ocupando.

Essa problematização possibilita pensar a escola como uma *disseminadora de rankings* (Reis; Paraíso, 2013). A partir das distinções criadas entre gêneros e da valorização atribuída a cada corpo, a mulher passa a ocupar uma posição de maior vigilância nesse ranking social. Desde cedo, busca-se produzir sobre a menina habilidades e valores considerados adequados para sua atuação na sociedade.

Quando o tema da gravidez é proposto na escola, a menina é colocada em uma posição marcada por expectativas, nas quais se naturaliza a ideia de mãe, cuidadora, associada a um tempo certo e ao casamento.

Uma questão que surge é: aos meninos, o que é falado sobre gravidez? Como sabemos, uma mulher pode engravidar de um homem, salvo casos esporádicos de outras possibilidades. Quantas mulheres um homem pode engravidar? E por que a gravidez é naturalizada como um tema mais importante do que HIV, AIDS e pessoas soropositivas?

A fala de Caio soma-se à de Paka quando perguntamos se havia alguma frequência com que o assunto da sexualidade aparecia. Paka nos responde que a fala acontecia *“uma vez ou outra, porque o pessoal não falava muito sobre o preservativo*

e AIDS. Era bem raro na escola. Eu acho que as pessoas remetiam mais o preservativo à gravidez. Era mais sobre engravidar” (Paka).

Paka, ao mencionar o preservativo e a gravidez como assuntos equivalentes, indica uma preocupação centrada na gravidez, como se esta fosse um problema a ser evitado (Abramovay; Castro; Silva, 2004). Segundo as pesquisadoras, muitos fatores podem ser indicativos de a gravidez ser vista como um problema: a possível preocupação das meninas, ao se divertirem em festas, de não se comprometerem com uma gravidez, rompendo, assim, com as projeções de papéis de gênero lançadas sobre elas; o fato de falar sobre gravidez na escola ir ao encontro do que pais e mães dizem sobre seus e suas filhas, atribuindo-lhes irresponsabilidade por praticarem sexo desprotegido ou fora do tempo considerado adequado; e, não obstante, as próprias estudantes e os estudantes apontam que a escola, ao falar sobre gravidez, supõe aquilo que seus familiares não conversaram.

Em todas as “justificativas”, o que nos chama a atenção é o fato de que não se fala sobre os meninos como coparticipantes das possibilidades da gravidez. Como se a fala estivesse direcionada apenas às meninas, tomadas como as únicas responsáveis, reforçando o papel de gênero masculino, heterossexual e reprodutor.

O fato é que, nas falas e nos dados produzidos, não há menções a possibilidades que poderiam ser exploradas, como, por exemplo, a transmissão vertical do HIV, da mãe para a criança, o que abriria a discussão sobre HIV, AIDS e a vida possível soropositiva, inclusive no contexto da gravidez, envolvendo ambas as pessoas: mãe e criança.

Os dados produzidos vão nos indicando que, ao se tratar das questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas, o tema é visto como distante, por pouco ou quase nada aparecer no cotidiano escolar.

No decorrer da produção dos dados, perguntamos às pessoas participantes da pesquisa se o que haviam ouvido na escola colaborou, de algum modo, após se tornarem soropositivas. As respostas obtidas foram diversas e, por vezes, contraditórias, mostrando que as falas trazidas pela escola não foram favoráveis para criar percepções que colaborassem no momento em que descobriram suas sorologias.

Essa realidade pode ser observada na fala de Sonia: *“acho que não. Assim, me deixou bem amedrontada, né? Pelo que eu já conhecia, li dos estudos, quando eu*

estudava, ouvia falar comentários e tal. Eu tinha preconceito, eu era uma pessoa preconceituosa. Eu tinha” (Sonia).

As palavras de Sonia demonstram que, embora, ao longo de sua trajetória no Ensino Médio, tenha tido algum contato com o tema do HIV e da AIDS, a partir de uma pedagogia do medo, a aula não colaborou nem para o momento em que soube de sua sorologia, nem para a desconstrução do preconceito que carregava sobre o HIV.

A resposta de Sonia nos direciona a pensar no impacto que a aula poderia ter caso o tema fosse proposto a partir de uma perspectiva inclusiva, que, anos depois, pudesse dialogar com sua realidade soropositiva. Schlünzen e Santos (2016) nos ajudam a pensar o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas como temas sensíveis, que, ao serem abordados a partir da construção de outros regimes de verdade, e não pautados em inverdades sobre a AIDS, poderiam criar significados e sentidos capazes de levar Sonia a repensar seu preconceito.

Não obstante, a aula se tornaria inclusiva por considerar que, naquela sala, poderia haver pessoas soropositivas ou, ao menos, por reconhecer que, no futuro, alguém daquela turma poderia vir a se tornar soropositivo/a, como ocorreu com Sonia.

A *aprendizagem significativa* (Schlünzen; Santos, 2016) poderia ter colaborado de modo mais efetivo com a experiência de Paka. Quando perguntamos a ele se as aulas que teve, ao tratarem sobre o uso de preservativos, ajudaram em algum momento de sua vivência, antes ou depois de se tornar soropositivo, ele nos respondeu que:

auxiliou, mas a questão é a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha que tá longe. Aí você fala, ah, não dá nada não. Esse é o problema”. E aí você acabava não utilizando porque você pensava assim, ah, não vai acontecer comigo. Ou talvez nem acreditava que, tipo assim, não pensava na infecção? É... é isso. Eu acho que mesmo sabendo era mais fácil de informação. E eu achava que não ia acontecer nada (Paka).

Embora Paka diga que auxiliou, é possível perceber uma contradição, na medida em que, se a aprendizagem foi significativa, por que o HIV ainda era visto como algo distante? Segundo as autoras (Schlünzen; Santos, 2016), contextualizar é colocar as pessoas discentes no contexto dos acontecimentos.

Não se trata apenas de falar sobre o preservativo, mas sobre as lutas, os desafios e as vulnerabilidades que as pessoas soropositivas enfrentam, bem como sobre a herança de um vírus social que exclui e estigmatiza. Assim, possibilita-se não

apenas uma aprendizagem que signifique o uso das tecnologias de prevenção, mas também a compreensão do viver soropositivo e das relações sorodivergentes.

Trata-se da oportunidade de fazer com que o diálogo aconteça, que as dúvidas, os erros e as ideias circulem, ocupando novas formas de fazer com que a escola liberte as pessoas discentes do cativeiro dos preconceitos, dos medos e da ausência de conhecimentos para enfrentarem a realidade social.

Quando seguimos perguntando a Paka sobre a experiência de a escola ter falado sobre preservativo e sobre as lembranças de quando descobriu estar soropositivo, ele silenciou e disse que, se a escola tivesse falado não apenas sobre preservativos, talvez isso tivesse ajudado, sim. Perguntamos, então, como seria. Ele respondeu: *“por exemplo, quando aconteceu, eu acho que não ia ter todo o impacto que eu tive. Nem me assustar tanto. Eu pensei que ia morrer. Teria sido menos sofrido”* (Paka).

O impacto mencionado por Paka refere-se, também, ao medo de que a família ou pessoas próximas soubessem. A ausência de uma abordagem que inclua a possibilidade de viver soropositivo reflete nas vulnerabilidades enfrentadas a partir da descoberta da sorologia.

O silêncio sobre determinados temas (Paraíso, 2018), como as questões relacionadas ao viver soropositivo, implica não desenvolver uma visão afirmativa sobre estar soropositivo. Caso houvesse essa abordagem, o momento de testarem e descobrirem a sorologia talvez não implicasse no sofrimento que Paka demonstra em suas palavras.

Outro ponto que Paraíso (2018) nos conduz a pensar, ao mencionar a atuação do campo do silêncio, são as brechas que ficam abertas nas relações cotidianas da escola ao não se tratar da sexualidade e das questões que poderiam fazer emergir os temas do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas.

A realidade de estudantes que vivem soropositivos, muitas vezes, permanece no interdito. Assumir-se como uma pessoa soropositiva é aceitar uma série de desafios impostos pela sociedade sorofóbica, somados à ausência de conhecimentos que possibilitem pensar essas pessoas, no contexto escolar, de forma inclusiva. Seu aparecimento ocorre, quando muito, apenas nos boletins epidemiológicos ou em campanhas de AIDS no dia primeiro de dezembro.

Assim, as brechas que são abertas passam a ser preenchidas por falas preconceituosas que não correspondem à realidade do que é viver soropositivo.

Quando perguntamos se, no período escolar, as pessoas participantes da pesquisa percebiam alguma relação de preconceito com o tema, diversas respostas emergiram. Caio disse: *“nunca percebi nada disso. Mas tinha a chacota se você era gordo, se você era afeminado, entendeu? Mas em cima de doença, porque geralmente é algo que todo mundo guarda pra si. Não sai contando. ‘Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo’, entendeu?”* (Caio).

A partir das falas de Caio, é possível perceber que o cotidiano em que ele estudava era marcado por relações de gordofobia e homofobia. Britzman (2017) pontua que os corpos, ao circularem no espaço escolar, são lidos a partir das representações pelas quais cada estudante foi formado/a. Essa leitura se acentua quando a ótica que interpreta os corpos está sob a matriz que organiza as sexualidades e os gêneros a partir de construtos culturais e biológicos, ou em classificações que os colocam nos quadros do normal e do anormal.

As relações marcadas pela gordofobia e pela homofobia, apresentadas por Caio no cotidiano de sua escola, representam uma traição à naturalidade, seja por um menino não representar a masculinidade esperada para seu corpo e comportamento, seja por não apresentar a massa corporal culturalmente esperada. Essas visões revelam a oportunidade de a escola intervir, rompendo com a lógica de que a base da representação se limita à heterossexualidade e ao corpo padrão masculinizado.

Quando perguntamos a Paka, se, no período escolar, percebiam alguma relação de preconceito com o tema? Ele nos respondeu: *“ah, na escola, tipo aquelas brincadeiras... Assim, ah, é uma pessoa muito magra. Ah, tem AIDS, é aidética, remete para a magreza, entendeu? Mas isso hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver”* (Paka).

As palavras de Paka indicam que o cotidiano escolar que frequentou era marcado por formas de tratamento entre alguns estudantes de maneira pejorativa e estigmatizante. O que Paka nos relata são *brincadeiras maldosas* (Reis, 2020) que, ao serem direcionadas, têm como alvo determinadas pessoas e o intuito de produzir algum tipo de sofrimento.

São violências naturalizadas por meio de brincadeiras que, no cotidiano escolar, muitas vezes passam despercebidas. Essas brincadeiras operam de forma estrutural, atravessando o núcleo familiar e chegando à escola. A razão de sua existência está nas relações de comparação, que recebem sentidos a partir de

símbolos históricos, como a associação do corpo magro a uma pessoa com AIDS. A percepção dessas brincadeiras maldosas também aparece nas palavras de Nando:

Então, jovens nessa idade...A maioria são ignorantes, são poucos os que procuram a mesma informação sobre tal assunto. E nessa época, época de escola, as pessoas sofrem bastante bullying. *Eu sofria muito pela minha sexualidade, mas sobre essa questão de doenças, sempre eram vistas como chacota.* Então não só o HIV, a AIDS, mas como outras doenças que os jovens pegavam assim e às vezes você falava para uma pessoa e ela transmitia para outras e isso virava um reboliço e as pessoas vinham com bullying, brincadeiras, te xingando ou falando, tratando aquilo como um adjetivo ruim seu (Nando).

As palavras de Nando mostram a ignorância como ausência de conhecimentos que impossibilitam seus colegas de turma de compreenderem determinados assuntos. Todavia, a ignorância não é uma atitude neutra, assim como uma brincadeira maldosa não está isenta de sua intencionalidade provocativa em causar algum mal a quem é direcionada.

Quando Caio diz que vivenciava relações de homofobia, reforça a ideia de que a escola tem colaborado para sustentar papéis de gênero e hierarquizar as sexualidades, legitimando a heterossexualidade em detrimento da homossexualidade, ou passando a vê-la como algo a ser perseguido.

As brincadeiras que utilizam o HIV e a AIDS como forma de ofensa revelam a percepção construída sobre o vírus e a infecção a partir de significantes estigmatizantes e preconceituosos. Por que um estudante diria, com tanta veemência, a outro que ele é “aidético”? Seria porque a AIDS é vista como algo positivo, como um elogio? Sabemos das raízes históricas que formalizam essas *brincadeiras soromaldosas*.

Essa percepção não se distancia do que Sonia também nos relatou: “*quando eu estudava, se tinha ali uma criança muito magra, as outras crianças já apelidavam de aidético, olhavam e todos riam. Mas até naquele momento tinha, sim*” (Sonia).

As falas de Sonia, de Nando e de Paka revelam o funcionamento das *brincadeiras soromaldosas*, que operam a partir de várias sanções e penalidades, rarefeitas por um humor culturalmente naturalizado como “brincadeiras”. Ao utilizarem o HIV e a AIDS como referência, essas brincadeiras fazem com que a pessoa a quem são direcionadas seja ridicularizada, imprimindo a percepção de um corpo perigoso que deve ser distanciado.

Essas brincadeiras revelam os referenciais dos quais as/os estudantes fazem uso: falas de antepassados, percepções limitantes e sentimentos perversos. A maldade que carregam nasce da banalidade com que as vidas soropositivas são atravessadas.

As brincadeiras soromaldosas operam, assim, como um dispositivo biopolítico que, por meio do riso maldoso, governa, ao mesmo tempo em que omite aquilo que a escola tem se inclinado a não abordar e a resistir em discutir.

Foucault (1971), ao realizar uma análise do passado e observar as formas como as sociedades se organizavam e se comportavam, afirmou que a constituição de nossas sociedades e instituições atuais mantém proximidades no modo como funcionam. A escola é uma dessas instituições.

Na perspectiva de Foucault, é como se a escola fosse constituída por uma natureza que a faz determinar o que é, permanecendo no tempo atual, mas funcionando como se ainda estivesse no passado. E, pelo fato de estarmos acostumados/as com esse tipo de escola, não estranhamos, a ponto de não rompermos com o modo como ela funciona, nos sequestrando e nos disciplinando.

Na ausência de abordagens que tratem, de forma afirmativa e formativa, sobre o HIV, a AIDS e o viver soropositivo na escola, perguntamos às pessoas participantes em quais locais encontraram algum referencial sobre o HIV, a AIDS e o viver soropositivo. Caio e Nando nos responderam. Segundo Caio:

o único conhecimento que você tinha era aquilo que passava então na televisão, nas propagandas, nos jornais? Ou então quando você ouvia falando na televisão, ah, um artista morreu de tal doença, né? Falaram que morreu de HIV ou morreu de AIDS. Era isso. Mais longe do que a gente tinha. É como se isso estivesse longe de você (Caio).

A fala de Caio mostra que, embora na escola os discursos sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas não circulassem e, quando apareciam, fossem apresentados de forma biologizante e biopolítica, por meio de pedagogias do medo, a televisão representou uma forma de poder que posicionava os assuntos sobre o HIV de diversas maneiras, repercutindo na produção de referências para a construção da percepção sobre a pessoa soropositiva.

A televisão, assim, representa o que Foucault (1971) chama de *demolição crítica*. Durante a história da AIDS, muitos saberes foram produzidos, assim como muitas inverdades. A televisão se colocou como uma ferramenta transgressora ao

abordar, em filmes, novelas e propagandas, outros regimes de verdade que não circulavam amplamente na população.

Ao apresentar produções artísticas, a televisão educa o olhar por meio de uma pedagogia provocativa, que ilustra a realidade de forma ficcional. Para algumas pessoas, a televisão passou a ocupar o lugar de uma escola, como Caio diz:

Às vezes a gente ouvia propaganda na televisão, falando na televisão, aí você começava a prestar um pouco mais de atenção, porque às vezes até na época da escola, finalizando o colegial, a gente tinha que fazer uma redação. E a minha redação foi baseada no jornal. Cada vez que o jornal falava sobre o assunto (HIV), eu escrevia sobre aquele assunto. E, no final, eu entreguei aqui... Ah, não tem hoje mais isso. Mas eu entreguei aquela redação em cima de um mês de jornal. Tipo, todos os dias você assistia e falava sobre o assunto. Aí você coletava as informações que você... que você coletou as informações que eram faladas no jornal e você transcrevia (Caio).

As palavras de Caio demonstram o que, em nossa época, tem se colocado como um desafio para as escolas: o celular. Uma possível diferença é que a televisão opera de forma contrária à escola, já que ambas possuem naturezas distintas. A escola busca se manter como uma instituição conservadora. A televisão, por sua vez, preocupa-se em atrair as/os telespectadores a partir de criações chamativas e de interesse da massa social.

O que não é falado sobre sexualidade na escola, na televisão, a depender do acesso, torna-se possível. Nessa perspectiva, a televisão aparece como mais atrativa para os assuntos sobre sexualidade e HIV/AIDS do que a própria escola. A televisão, a partir da fala de Caio, desempenhou um papel pedagógico ao criar e reforçar comportamentos e conhecimentos que ele utilizou posteriormente na escola (Silva; Soares, 2011).

Não obstante, a televisão também desempenhou um papel pedagógico para Nando, sendo uma referência para os assuntos sobre HIV:

Então, na época da escola, como não se falava disso, eu também nunca busquei durante o ensino médio, até os meus 17 anos. E foi nos anos que eu comecei a ter relações sexuais e tive bastante... relações sexuais irresponsáveis, que eu não usei camisinha, e eu nunca pensei nisso, porque não foi falado pra mim, nem em casa, nem na escola. Então, quando eu tinha a oportunidade de transar com alguém, até pessoas mais velhas do que eu, nunca usei, nunca foi usado, entendeu? A pessoa não usava e eu também não ia falar nada, porque, tipo, eu era meio que... eu era meio que... ia pela pessoa ia pela pessoa e não tinha nenhum conhecimento assim. *Eu sabia que tinha*

que usar, passava na TV. Ah, use preservativos. Tinha propaganda na TV, propaganda na novela, mas na escola em si...e aí (Nando)

Nando revela que a época do Ensino Médio foi um período em que não se abordavam as questões da sexualidade, assim como os temas sobre HIV. Esse também foi o momento de início de suas experiências sexuais.

Na ausência dos saberes produzidos na escola e na família, Nando descreve que seus parceiros mais velhos cumpriam a função de iniciá-lo na vida sexual. O fato de essas pessoas não proporem o uso do preservativo não o levava a questionar, pois ele não sabia a quais vulnerabilidades estaria exposto ao não utilizá-lo.

Embora Nando diga que assistia, na televisão, a propagandas que falavam sobre a importância do uso do preservativo, não as via como um alerta, mas como mais um programa qualquer que passava na televisão. Ainda assim, ele ressalta que não via, na escola, assuntos como esses sendo discutidos.

Pode-se supor, a partir de sua fala, que para Nando os saberes desenvolvidos na escola teriam mais relevância do que aqueles veiculados pela televisão.

Um dos pontos possíveis de se pensar é que, mesmo assistindo a propagandas na televisão que apontavam para o uso de preservativos nas relações sexuais, Nando pode não ter se sentido representado (Soares, 2011). Nando descreve que as aparições de temas voltados ao HIV ocorreram quando ele tinha 17 anos, um jovem gay que, possivelmente, não se via representado nos programas de televisão. Ainda assim, ele destaca que não sabia exatamente do que se tratava.

Isso sinaliza que nem tudo o que passa na televisão consegue produzir algum saber. A percepção de Nando pode diferir da de Caio pelo fato de que Nando assistia principalmente a propagandas, enquanto Caio acompanhava o jornal. Há, portanto, uma distinção na forma de transmissão dos conteúdos. O jornal tende a se posicionar a partir de fatos reais, por vezes sensacionalistas, criando sentidos pautados no medo. Já as propagandas e novelas tendem a produzir conteúdos romantizados, transmitindo uma visão mais polida, a fim de evitar reprovação.

Com as falas de Sonia, Caio, Paka e Nando, é possível afirmar que a escola, ao abordar o assunto sobre HIV e AIDS, o faz considerando apenas o âmbito biologizante, sobretudo ao tratar das possibilidades do uso do preservativo para evitar a gravidez indesejada. E, nas falas, quando há menção ao HIV, ela ocorre por meio do medo, criando e reforçando percepções estereotipadas.

O que se torna visível, a partir dos dados produzidos nesta pesquisa, é que não se fala, na escola, sobre a possibilidade de viver soropositivo.

As falas das pessoas participantes desta pesquisa indicam que, na ausência de diálogos na família, a escola poderia ter assumido esse papel. Tal abordagem teria ajudado na prevenção, nas relações sexuais e, principalmente, no viver soropositivo.

Destacamos que, ao não falar, a escola demonstra estar limitada a não considerar o cotidiano dos corpos discentes, suas práticas e, sobretudo, a restringir a percepção sobre as diferenças que estão presentes no espaço escolar.

Seguimos com o próximo eixo, buscando compreender, a partir das falas das pessoas participantes desta pesquisa, quais repercussões a escola, ao abordar esses temas, poderia ter proporcionado a Sonia, Caio, Paka e Nando.

As falas na escola não refletem apenas o cotidiano escolar, mas também repercutem, na realidade, no dia a dia das estudantes e dos estudantes. Ainda assim, as falas deste eixo podem sinalizar possíveis considerações sobre o que a escola pode adotar como pedagogias e currículos que preencham as lacunas que a têm distanciado da realidade das estudantes e dos estudantes, no que tange às sexualidades, ao HIV, à AIDS e às vivências soropositivas.

5.19 Eixo 5: É só o início da sua vida, da sua nova vida: é o que eu sou e vai ser até o dia que eu morrer.

Gostaria de iniciar este eixo de análise com um fato ocorrido no dia 5 de julho de 2023, em uma vila localizada na Índia Ocidental, chamada Pali, na cidade de Beed. Segundo a matéria publicada no jornal *The Times of India*³⁸, um grupo de 44 estudantes (30 meninas e 14 meninos) do Ensino Fundamental e Médio foi impedido de entrar nas instalações da escola pública e, em protesto, assistiu às aulas fora da escola, sentado no chão.

A causa do impedimento foi o fato de serem soropositivos/as. A ação foi realizada por moradores e moradoras de Pali, sendo uma prática recorrente. A justificativa apresentada por essas pessoas ao impedirem a entrada dos/as

³⁸ A matéria completa pode ser lida pelo seguinte link: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/hiv-students-denied-entry-to-school-in-beed/articleshow/101512926.cms> (Joshi, 2023).

estudantes baseou-se no medo de infectarem estudantes soronegativos/as, uma ação que, segundo eles/as, visa ao *cuidado*.

A percepção do cuidado em nossas sociedades tem produzido comportamentos um tanto contraditórios. Durante os anos que seguiram a pandemia de covid-19, muitas pessoas se abstiveram de tomar a vacina, ainda que todas as fases e testes tenham sido realizados para que estivesse disponível à sociedade. As justificativas apresentadas são lidas como discursos de cuidado, sustentadas por explicações por vezes bizarras, como aquelas que associavam a vacina à AIDS³⁹.

A percepção de cuidado também se expressa na busca desenfreada pela construção de um corpo padrão-magro, no uso de canetas emagrecedoras que, recentemente, chegam à sociedade sob a legenda de ações em vista do cuidado. O cuidado passa a ser significado por mitos, preconceitos, pela indústria, pelo sofrimento e pelas verdades que as pessoas assumem sobre si. Assim, transforma-se em um dispositivo moral que produz diversos discursos e comportamentos: quem não segue os padrões é considerado descuidado; quem os segue é visto como alguém que se preocupa com o cuidado.

Na escola, a percepção de cuidado segue a partir de programas que envolvem a chegada de psicólogos/as, em resposta à crescente demanda por saúde mental; de policiais, como forma de cuidado com a segurança da comunidade escolar; e da aproximação de religiosos, com o intuito de levar a fé como cuidado da alma.

O que se vê são discursos produzidos sob o rótulo de cuidado e que investem no corpo externo, como supostas soluções para problemas sociais e políticos que não têm, em suas agendas, uma preocupação efetiva com a eliminação das violências, a distribuição de renda e de poder de compra, o investimento na qualidade do trabalho e tantas outras demandas pendentes, que têm sido colocadas de lado para fixar um problema prisional que por hora, está solucionado.

Ou seja, a percepção de cuidado em nosso tempo apresenta-se como algo externo, superficial, estético-corporal e discursivo, que talvez, em outro momento, possamos analisar com mais profundidade.

A percepção do cuidado em nosso tempo pode resultar das continuidades do tempo do passado, a partir das atribuições que as sociedades ancestrais adotaram

³⁹ Mais detalhes ver com Ajunto et al., 2022 em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/policia-federal-ve-crime-em-fala-de-bolsonaro-sobre-vacina-e-aids/>

como cuidado e nas quais investiram sobre suas vidas e corpos, como uma ética de vida a serem seguidas.

Foucault (2022b; 2024b; 2025a), em alguns momentos de suas investigações, propôs a estudá-las. Um pouco do que ele encontrou traremos para dialogar com os dados produzidos. Nossa intenção é pensar e imaginar a escola como um local de possibilidade, um espaço que auxilie a prática do cuidado de si, como aquelas vivenciadas pelos gregos-romanos do passado, permitindo que as/os estudantes digam a verdade de si mesmas/os a partir de sua estética da existência - obras de arte pintadas para os futuros. Uma esperança artística.

O cuidado de si é uma tentativa de tradução grega de *epiméleia heautoú*, que depois foi traduzida pelos latinos como *cura sui* (Foucault, 2025b). A tradução para o nosso idioma leva a várias escritas e sentidos, como cuidar, ocupar e preocupar, enquanto verbos de ação implicados em atividades e posturas dirigidas ao si (o eu da ação).

O cuidado de si, nas leituras de Foucault (2024b), mostra-se como uma postura que, ao ser praticada, coloca o sujeito da ação dos verbos no mundo para si e para as outras pessoas.

O fato de ser uma cultura, um modo de vida que as sociedades greco-romanas adotavam, impele cada sujeito, de forma individualizante, a constituir-se enquanto verdade a partir dos investimentos feitos em si (alma), implicando não apenas ao si, mas também à outra pessoa, por se beneficiar do cuidado individual que cada sujeito empreende. O cuidado de si é, portanto, também um cuidado coletivo e social.

A partir da noção de cuidado de si (Foucault, 2025b), torna-se possível compreender o investimento que cada sujeito realiza sobre si mesmo, considerando o tempo como um espaço de dedicação ao olhar para suas instâncias interiores. Nesse processo, as verdades sobre si não são impostas de fora, mas produzidas pelo próprio eu por uma relação crítica estabelecida sobre o próprio pensar e agir.

Não se trata de regimes de verdade que buscam capturar corpos e subjetividades, inscrevendo-se sobre eles de modo a desconstituir o sujeito daquilo que efetivamente é. Tampouco há uma exigência de confissão, na qual as palavras proferidas serviriam à produção de um outro eu: pecador, anormal, desviante ou contaminado.

A verdade que se enuncia sobre si resulta de uma relação íntima consigo mesmo. Desejos, afetos, sentimentos, ódios e medos não são negados nem

fiscalizados. Eles emergem desse movimento de si para si, no qual cada sujeito se constitui.

A forma como o cuidado de si (Foucault, 2025b) funciona não está estritamente ligada ao externo. São os propósitos internos que operam como uma espécie de máquina, produzindo a relação de si para consigo mesmo. O que dá sentido ao investimento na busca das próprias verdades é o acolhimento das críticas que, ao produzirem conhecimentos, permitem desatar as pontas que prendem aos hábitos, às opiniões e a outras verdades e falsidades que não dizem sobre si.

Trata-se de batalhas travadas no interior do pensamento. O cuidado de si é, também, um cuidado médico: investe-se no corpo, mas, sobretudo, nos ferimentos causados na alma: a injustiça, a maldade, o desejo antidemocrático.

Outro ponto que compõe o cuidado de si é a relação com a outra pessoa. Essa relação opera como uma técnica, por meio das escolas, dos mestres e das práticas de escrita, como anotações e registros dessas trocas. Posteriormente, esses exercícios são reinvestidos no próprio sujeito, aprofundando o movimento de retorno a si.

O cuidado de si (Foucault, 2024b) inscreve-se no corpo, no uso dos prazeres, nos limites encontrados e nos efeitos que é possível sentir a partir deles. Por meio do cuidado de si, o sujeito pode governar seus prazeres e sua vivência no espaço público. Governar não é negar o prazer, mas saber utilizá-lo a partir do senso de autonomia e de liberdade.

Pelo corpo, busca-se a saúde e, em consequência, a beleza. Os treinos e os regimes tornam-se meios de exercitar o equilíbrio e de esquivar-se dos excessos. O que se busca no corpo é a satisfação de si, encontrada na necessidade de um tempo dedicado e individualizado.

Trata-se do valor da privacidade de estar consigo e, ao mesmo tempo, do valor de estar com a outra pessoa. Do tempo sozinho nasce a autonomia e, com ela, a possibilidade de construir relações consigo mesmas, tomando-se como o próprio objeto investigativo.

A estética da existência diz respeito às formas pelas quais cada pessoa se inscreve como sujeito da verdade. São as experiências vividas em diferentes contextos que possibilitam a produção de uma pessoa artística. Quando as pessoas soropositivas deste estudo se propuseram a partilhar suas experiências, elas nos ensinam outras formas de existências possíveis, que podem ser ampliadas,

provocadas e, assim, abrir novos caminhos para novos espaços na escola, no currículo e nas práticas cotidianas em que as pessoas estão inseridas.

Retomada as noções sobre o cuidado de si, olhamos para cada fala das pessoas participantes dessa pesquisa, e observamos que há uma verdade que, a partir desse investimento de si, torna-se provisória. Um si do passado que, no percurso em direção ao futuro, faz do presente a recusa de viver por verdades que não lhe pertencem. No presente, perguntamos à Sonia do passado, a partir de suas vivências, como a escola poderia ter falado sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas. Ela, então, nos responde que a escola poderia ter feito:

Uma fala que pudesse *conscientizar, né?* Explicar que *todos estão sujeitos*, todo mundo está sujeito, né? Então *que não botasse tanto medo* que hoje o preconceito maior, principalmente *eu, tinha muito preconceito por isso... porque olha, mata*, não se sabe ainda como o remédio pode tratar né? Até onde uma pessoa pode aguentar? Então na época, Ah, fulano morreu. Ele tinha HIV, ele morreu, ele pegou uma gripe, ele morreu. Então, assim *era para a gente ficar com medo, né?* (Sonia).

Na fala de Sonia, podemos observar um misto de consciência, realidade e medo. A consciência que Sonia invoca é aquela que o cuidado de si pode provocar. Na escola, a professora e o professor, operando como uma técnica, podem convocar em seus e suas estudantes o sentido de pensar sobre seus corpos e sobre o uso de seus prazeres dentro da realidade.

A realidade é que o HIV existe. Negar sua existência não a faz desaparecer. Como bem pontua Sonia, somos conduzidos à compreensão de que não existem verdades tão seguras às quais não possamos adentrar. Existe a verdade de que todas as pessoas estão possíveis de serem soropositivas, assim como podem ter dengue, câncer ou qualquer outra condição, por estarmos lançados e lançadas ao mundo das possibilidades e dos acontecimentos.

O medo, como prática pedagógica, não produziu os efeitos que talvez fossem esperados. A própria Sonia é um sinal da falha que o medo produz. Afinal, o que é o medo para quem tem cuidado de si?

Ao seguirmos conversando com Sonia, perguntamos o que ela pensava caso a escola tivesse falado com ela e com seus pares de sala sobre a possibilidade de, em algum momento da vida, tornarem-se soropositivos/os. Perguntamos, ainda, se a escola, a professora ou o professor tivessem abordado vivências possíveis de

peessoas soropositivas, sem discursos que produzissem medo, como isso teria impactado sua vida diante da descoberta da sorologia. Sonia responde que teria sido:

muito importante. Se eles orientassem assim...Até o momento, no caso de uma pessoa infectada, uma pessoa já ia se cuidar mais. Não ia ter aquele medo, né? *Porque no momento, assim da descoberta, o pessoal quer se matar porque já pensa, né, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer para quem que eu vou contar com quem eu vou contar?* (Sonia).

Com a fala de Sonia, torna-se possível pensar o currículo a partir das experiências, em vista de criar outras possibilidades de ver e imaginar, exercitando o real como prática formativa de si e de outros (Soares *et al.*, 2016). Falar sobre pessoas soropositivas romperia com o hegemônico dos saberes que falam do mundo e quase nada das pessoas que nele vivem.

Somos personagens na vida e precisamos aprender que a diferença não é o negativo do positivo. Ao sermos formados e formadas por uma lógica na qual o singular é tratado como estranho, quando nossas diferenças se acentuam, nossos medos interferem em nossas experiências.

A escola, ao utilizar o medo como pedagogia, produz sujeitos despotencializados que, na vida real, passam a ser fragmentos e recortes resultantes de experiências de dor e injustiça. Ao superar os desafios que a própria sociedade produz, ela aplaude, promovendo o discurso perverso da resiliência.

Ir à escola não deve se restringir ao sequestro e à disciplinarização. Vai-se para aprender a sofrer menos e a lidar com nossas indiferenças, não pelo medo que produz culpa, mas pela liberdade de poder se constituir a partir do cuidado que se faz de si.

Antes de dirigirmos a mesma pergunta que fizemos a Sonia para Caio, resgatamos algumas falas feitas por ele em outros momentos. Caio havia dito que, em sua família, o assunto sobre sexualidade, HIV, AIDS e pessoas soropositivas era um tabu: nunca havia circulado. A escola, segundo ele, também não havia falado. Ou seja, nunca se discutia a possibilidade de que, ao se relacionar com alguém, essa pessoa pudesse ter HIV detectável.

Ao retomarmos essas falas, perguntamos a Caio, no presente, como teria sido para o Caio do passado se a escola tivesse abordado esse tema: se isso teria ajudado

e de que forma ele percebe essa possível ajuda. Caio responde que não confiaria em ninguém e segue dizendo que, ainda assim, a escola teria ajudado:

Eu acredito, não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Porque é algo que você faz de errado e não tem mais conserto. Errou, fi, errou... Houve o contato do sangue, que é onde existe a contaminação. *Eu acho que se existisse isso desde lá de trás, as informações fossem mais favoráveis de um modo geral, eu acho que muita gente não estaria passando por isso.* Muita gente. E também, *usar a palavra, não confiar na outra pessoa.* Porque é o tal do confiar. Eu, igual, falo pra você. E eu só caí nessa porque eu confiei muito nele. E eu confio até hoje, desde que eu voltei do Paraná chorando porque eu falei, cara, eu deposei tudo de mim em cima de você. Olha como você está, olha como as coisas estão seguindo. E você não tem um limite (Caio).

A resposta de Caio soma-se à de Sonia. Ambos percebem que, na ausência de uma fala formativa e educativa na família, a escola poderia ter se colocado como um espaço de interlocução entre o cotidiano dos estudantes e das estudantes, no qual as experiências poderiam ter ganhado significados diferentes e positivos. Caio ressalta que isso não se aplicaria apenas a ele, mas a todas as pessoas.

Caio afirma que a escola pode exercer o papel de favorecer seus estudantes quando trata de assuntos da realidade em que estão inseridos. Sua fala leva-nos a pensar a escola como um espaço que incite o cuidado de si, tanto para a possibilidade de utilização das tecnologias de prevenção quanto para ensinar a dizer a verdade a si enquanto pessoas soropositivas não confiar cegamente, mas questionar; olhar para si e não apenas para o outro. Trata-se de aprender a individualidade como autonomia para vivenciar o prazer.

As práticas voltadas ao cuidado de si possibilitariam a Caio poder de escolha (Gomes Filho, 2016). Por ser um homem cis, negro e gay, Caio é atravessado por diversas intersecções que culminam em um esvaziamento das opções de escolha. Na família, não se fala sobre gays, mas sobre família, casamento e reprodução. Na escola, quando se fala, é sob o peso do medo, criando relações normatizadas.

A possibilidade de a escola ter tratado desses assuntos também aparece como algo positivo na fala de Nando. Quando perguntamos a ele, disse-nos que:

se eu tivesse conhecimento anteriormente, eu acho que não teria problemas em partilhar. Porque é uma parte de mim agora. Então, *é o que eu sou e vai ser até o dia que eu morrer.* Então, eu acho que não teria problema em falar. Por ter mais confiança, né? Em tratar sobre esse assunto com familiares e amigos (Nando).

No decorrer da entrevista, Nando havia sinalizado o receio de revelar sua sorologia, ao mesmo tempo em que reconhecia a importância de não viver no armário sorológico no perigo, na mentira, nas estratégias constantes de preservação. Saber-se soropositivo é deter consigo uma verdade que, muitas vezes, não pode ser compartilhada. Uma verdade que pode se transformar em insegurança, tanto nos relacionamentos consigo quanto nos relacionamentos com outras pessoas.

Trata-se de habitar uma zona de conforto que exige atenção máxima para não ser percebido e maltratado. Não obstante, é também um conhecimento do outro que produz o si. Não falar sobre a própria sorologia torna-se um trabalho de intensa disciplina e investimento, mas que não pode ser extrapolado para fora de si, para outras vivências (Ferrari, Castro, 2024).

A educação, ao ser considerada não apenas como um espaço fechado, mas no e para o mundo, possibilitaria a produção de sujeitos que circulam para além do espaço formal. Assim, a escola poderia colaborar para vivências soropositivas menos sofridas, como é possível perceber nas palavras de Sonia, quando reflete sobre como a escola poderia ter desempenhado um papel positivo para os estudantes que ali estão, considerando que, em casa, alguns assuntos não circulam e que há vulnerabilidades às quais podem estar sujeitos. Nas palavras de Sonia, a escola poderia:

Explicar que não pega assim, que só com contato sexual ou direto com o sangue, essas coisas... objetos perfurantes, eu me furo e a pessoa vai e também usa, tipo fazer uma tatuagem, eu uso o mesmo objeto e a outra pessoa pega e usa o mesmo objeto e faz a tatuagem. Ai sim, a pessoa estando contaminada e doente, vai contaminar. E *isso não é explicado na escola*. Só é explicado que é sexualmente transmissível, que pega, não tem cura e mata (Sonia).

Ao lermos as palavras de Sonia, fica claro que a escola não fala sobre as possibilidades de se tornar soropositivo por outros meios que não o sexual. E, ao tratar o sexo e a sexualidade como meios transmissíveis, aciona-se um juízo moral que opera pelo medo. Segundo ela, a escola poderia desempenhar a função de desmistificar os regimes de verdade produzidos em torno do que a história do passado construiu sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

O corpo, ao ser educado para o cuidado de si (Foucault, 2024b), atravessa as linhas que limitam o pensar o HIV apenas como consequência, como transgressão de algo que teria sido feito em desacordo com as regras do jogo da vida. O modelo de

escola que Sonia nos apresenta leva-nos a pensar em *currículos que não apenas narram, mas também inventam o presente* (Soares et al., 2016).

O currículo é um espaço aberto, no qual podem ser inseridas as diferenças e problematizado o mundo. Nele, criam-se meios de produzir outras formas de estar no mundo, considerando as possibilidades e realidades que habitam os *saberes-sentires* na relação entre professora ou professor e seus e suas estudantes.

Deveria ser um assunto mais aberto, para as crianças e não assim, falando que é uma doença infecciosa, por que todo mundo já sabe, mas em ensinar as crianças. Igual no meu caso, eu quando descobri o medo quando fui para casa, tinha minha filha os dois filhos e agora? Eu tinha medo de fazer comida e me cortar, de fazer carinho nos meus filhos, tinha medo da minha filha pegar alguma coisa que era minha, tipo, um prestobarba e até mesmo um baton. Por que ela gostava de pegar. Então eu tinha medo. No começo eu tinha medo. Eu mesmo sem querer infectar um filho meu. Eles tinham feito o exame, estava tudo normal. Como eu não sabia, estava no processo de descobrir como era, eu achava que eles não podiam ter contato comigo. Eu imaginava, como é que eu vou viver? O meu sofrimento maior foi por que eu sempre amamentei e ganhei a minha filha e não pude amamentar. Eu tinha muito leite. Eu pegava minha filha no colo e ela vinha se esfregando querendo mamar e eu não podia. O leite escorria eu queria dar e chorava. Então eu com medo de uma hora a noite levantar e pôr ela no peito e amamentar, eu pedi pro médico, me dá um remédio por que uma hora eu vou pôr minha filha para amamentar (Sonia).

Pelas palavras de Sonia, é possível perceber que a escola, ao não abordar as questões sobre o HIV e a AIDS para além de um discurso biologizante e ao utilizar a pedagogia do medo, deixou lacunas que, na vida real, poderiam tê-la ajudado a lidar com sua sorologia. O saber produzido pela escola em que Sonia estudou reforçou os medos que ela já carregava.

Sonia, com medo, sofre por não conhecer os limites que a infecção inscrevia sobre sua vida e sobre a vida de seus filhos. Ela não teve condições de desfazer o medo, a insegurança e a tristeza que a consumiam enquanto pessoa e enquanto mãe. Sonia é mulher-mãe, um outro marcador que, somado à sorologia, produz ainda mais sofrimentos, pela ausência de sentidos e significados que a escola não conseguiu propiciar.

O modelo de escola que não se abre a questionar “*como e até onde é possível pensar diferente?*” (Alves, Soares; Berino, 2012) reproduz interesses de grupos da sociedade que visam produzir valores capazes de normatizar os corpos segundo

lógicas que lhes convêm. O currículo funciona como um volante, capaz de direcionar o governo dos corpos que estão na escola.

A depender de quem segura esse volante, é possível pensar a escola para as diferenças e para os cotidianos, formulando e reformulando caminhos, conduzindo a um percurso incerto, mas cheio de possibilidades. Nesse trajeto, torna-se possível pensar as mães soropositivas, os filhos dessas mães e os contextos em que estão inseridos.

Embora nossas sociedades eduquem as mulheres para desempenharem papéis que supostamente lhes cabem, não ensinam a ser uma mãe soropositiva. O currículo e a escola, assim, acabam produzindo exclusões, justamente por não pensarem o diferente.

Outras falas somam-se às de Sonia ao pensarem o currículo como um espaço de produção de verdades, no qual cada sujeito-estudante, ao se apropriar dele, pode se constituir. Essas falas, a partir do lugar de *sorofala* (Ribeiro, 2017) que ocupam, possibilitam ver as estruturas e os sistemas, ao mesmo tempo em que dão pistas de como o currículo e a escola podem se posicionar a favor.

São mundos conhecidos que precisam ser partilhados. A experiência é um caminho trilhado e que, ao ser compartilhado, colabora para a criação de sentidos e significados. Em uma sociedade na qual o HIV ainda é associado à morte, ao pavor e a tantos outros predicados pejorativos, situar o currículo em outros meios torna-se um caminho que visa valorizar e expandir a vida e a existência humana para outros níveis do pensamento.

Para Sonia, *“as escolas deveriam abordar uma coisa mais ampla, explicar melhor como é o contágio, como ter os cuidados, como se prevenir, que a pessoa pode viver normal, não é necessário ter tanto preconceito. Essa parte é muito importante de ser abordada”* (Sonia).

Nas palavras de Sonia, a escola, ao abordar esses temas, deveria considerar o tempo necessário para falar sobre os cuidados e sobre essa relação consigo, na qual a professora e o professor podem atuar como provocadores não aterrorizando, mas explicando os limites entre corpo, prazer e liberdade. Trata-se de falas que colocam seus interlocutores em uma posição de autonomia crítica.

Outro ponto importante que Sonia traz é o preconceito. Se levarmos o termo ao pé da palavra, trata-se de uma ideia anterior do que é uma pessoa soropositiva. Uma ideia que, inclusive, a própria Sonia reconhece ter tido e que compartilhou conosco.

O preconceito produzido por Sonia foi construído a partir de ausências e inverdades que a escola possivelmente não interveio para desconstruir. No entanto, sua experiência, ao se produzir a partir das verdades construídas em suas vivências soropositivas, levou-a a refletir sobre como deverá ser a educação de suas filhas e de seu/sua neto/a.

Eu acho que chamar e explicar que o HIV existe, que é uma doença que contamina e não tem cura ainda, mas *que não é uma coisa que ele vai te matar*, se você fizer o tratamento certinho *você vai viver* normalmente vai poder trabalhar e fazer tudo como uma pessoa com saúde normal faz. Que não te impede a nada (Sonia).

[...] levar pessoas que têm (HIV) para a pessoa ver que é normal. Acho que as pessoas precisam ver uma pessoa que tem, que é normal ter, que vive normal. Não só falar por vídeo, foto, não. Tipo, levar. Olha gente, essa daqui é uma pessoa que vive com isso e falar sobre. Eu acho que seria muito legal" (Paka).

[...] a escola tem que colocar vídeos educativos, tem que fazer uma prova, tem que fazer uma avaliação em cima disso, para ver o que você responde, *o que você está entendendo, o que você não está entendendo*, o que você acha, se você quer se prevenir, se você não quer, mas é algo que eu vejo que não vai acabar não. É bem isso (Caio).

As falas nos apontam para a necessidade de pensar o viver soropositivo como uma condição que exige atenção à linguagem produzida sobre a infecção. A linguagem, no decorrer da história da AIDS, construiu a doença a partir de imagens negativas, estereotipadas, que ligam o vírus ao ser humano como um objeto anormal.

Existe toda uma narrativa mitológica que, oralmente, atravessa gerações por meio de ficções. Na escola, quando essas narrativas aparecem, abre-se a oportunidade de desfazê-las, criando outra linguagem, capaz de produzir um outro sujeito soropositivo na história. Sonia chama a atenção para a importância de normalizar as pessoas soropositivas como forma de contrapor o medo.

Paka sugere, como exemplo, levar pessoas para a escola para que, ao vê-las e ouvi-las, as estudantes e os estudantes, assim como toda a comunidade escolar, possam imaginar outras vidas e outros mundos, considerando o mundo de forma mais ampla do que aquilo que lhes é ensinado. Essas pessoas, ao estarem na escola, inscrever-se-iam como personagens de novas histórias possíveis de serem contadas não mais como doentes, perigosas ou até mesmo como coitadas.

Trata-se de uma visão crítica sobre como as pessoas soropositivas foram inscritas nas linhas acrílicas de um pensamento moralizador. São pessoas que o social e o cultural produziram a partir de verdades que as conjuraram à margem do

impensável, como estratégia de punir, excluir e apagar, transformando-as nos anormais que marcam o tom de muitas falas.

Caio, ao pensar em como a escola poderia tratar esses temas, recorre à ideia das aplicações pedagógicas tradicionais utilizadas em outros conteúdos. Para ele, trata-se de inscrever o tema como algo normal, assim como os demais assuntos considerados importantes no processo de ensino.

O fato de propor uma avaliação é um ponto interessante de se pensar. Embora o aprendizado não precise estar preso à lógica de disciplinar e punir, o que se lê na avaliação mencionada por Caio é a atenção que a professora ou o professor pode dedicar a seus e suas estudantes ao perceber o que foi possível desenvolver como conhecimento, o que não foi, e quais lacunas podem ser preenchidas. Trata-se de acolher a dúvida e o medo, criando um reforço para um conhecimento importante para a vida.

Se outros temas podem ser avaliados, por que o HIV e a AIDS precisam aparecer apenas como prova na prática, quando se descobre a sorologia?

As falas nos levam a pensar que, ao estar presente na escola, *a racionalidade pedagógica empreendedora, no direcionamento das formas de governo de si* (Manfré, 2023), faz com que alguns conteúdos e propostas curriculares não considerem que o viver soropositivo também pode compor um projeto de vida de estudantes.

O que se pretende com a lógica de mercado é produzir uma pessoa-corpo eficiente, que não se ocupa do cuidado de si. Uma lógica que faz pensar a vida não como mercadoria, mas como tempo e espaço para se produzir enquanto pensamento, imaginação e criação, dimensões que o empreendimento de si pode provocar.

Ao esperar que os corpos-estudantis estejam na esteira da eficiência e da eficácia, o discurso biomédico se justifica ao preocupar-se em cuidar do corpo, desconsiderando os fatores sociais, culturais e políticos que produzem, no corpo soropositivo, a precariedade que a escola de nossas/os participantes tem nos mostrado desempenhar.

Na lógica que temos discutido a partir das falas de Sonia, Caio, Paka e Nando, a escola pode pensar um projeto de vida soropositivo. Um projeto que, em sua significação, implica projetar-se na realidade, considerando as vidas soropositivas e as relações soronegativas como formas de incluir e ensinar para as diferenças. Nas palavras de Caio, o projeto que a escola pode desenvolver é:

o ensinamento é você ter pelo menos *uma aula semanal e informando sobre o futuro*. Como a gente acompanha tudo evoluindo, *a gente tem que acompanhar tudo evoluindo desde lá de trás. Mesmo que não tinha lá atrás, mas a partir de hoje ter*. É a tendência que você vê, se não começarem a se precaver, não vai ter um limite. Às vezes, além de você se contaminar conforme você vai ter objetos cortantes em sua casa, você de repente está transmitindo para quem não tem nada a ver com você. Às vezes, numa faca, num barbeador, numa gilete ou coisa parecida, que uma outra pessoa da tua casa ou de alguém que te visitar usar aquilo ali quando vai ver que está contaminado (Caio).

Nas palavras e na visão de Caio, a escola é o lugar para pensar o futuro como algo que se produz no presente. A escola que Caio menciona é aquela que possibilita que o corpo discente esteja informado. Quantos avanços, desde o passado na história da AIDS, a escola tem levado aos estudantes para que percebam as mudanças que implicam em nosso modo de nos produzir?

A fala de Caio reforça uma ideia que pode ser amplamente pensada na escola e no currículo: falar sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas não é sinônimo de falar apenas de sexo. Existem outras possibilidades em que esses temas se inscrevem. Como Caio menciona, o HIV pode ser transmitido por outras formas que não são necessariamente pelo contato sexual.

São possibilidades para pensar o currículo como *dentrofora* (Medeiros, 2018), no qual o dentro acolhe aquilo que está acontecendo fora. O fora não é um mundo desligado do dentro da escola. O currículo dentrofora não se movimenta pelo contrário de pôr para fora quem precisa estar dentro. Falar sobre pessoas soropositivas é tirar de fora e trazer para dentro da escola.

Quando Foucault (2022b; 2024b; 2025b) fala sobre o cuidado de si, refere-se a um movimento no qual a prática do cuidado considera a possibilidade de distanciar o corpo e a existência humana de sofrimentos passíveis de serem evitados. Embora viver também seja sofrer, não se trata de uma lógica masoquista. O sofrimento não é celebrado, mas compreendido como algo que pode despotencializar a vida.

A prática do cuidado de si permite que as pessoas se afastem de acometimentos que causam dor e que poderiam ter sido evitados. Com o cuidado de si, torna-se possível produzir um currículo para uma existência mais plena, ao pensar a educação como um espaço que não reduz os sujeitos por meio do diagnóstico, da eficiência ou da normalidade.

Cada pessoa-existência está inscrita nas diferenças que marcam suas vidas e nas formas como se produzem enquanto sujeitos de suas próprias verdades. Isso

implica pensar que o currículo, além de racial, sexual e de gênero, é também soropositivo e tudo aquilo que um corpo-existente pode ser.

Alguns pontos que Foucault (2022b; 2024b; 2025b) analisou, a partir do cuidado de si na cultura greco-romana antiga, ajudam-nos a pensar sua presença no currículo e na escola. Um deles é que o cuidado de si se realiza por meio de um trabalho educacional.

No cotidiano escolar, perguntamo-nos como as questões sobre o viver soropositivo podem provocar a reflexão, a conversa, a escuta que os diálogos possibilitam e a escrita, considerando outras formas de ver a vida e de se relacionar com o mundo. São práticas, exercícios, avaliações e tantos outros artefatos didáticos, como apresentados por nossas/os participantes, nesse trabalho de investimento de si.

A educação, nesses regimes, não estaria inscrita nas linhas da obediência cega, mas no exercício da liberdade para uma atuação ética e para um posicionamento responsável, no qual pessoas soronegativas e soropositivas possam estar sem medo e sem vergonha. Legitima-se, assim, o corpo soropositivo como todo e qualquer corpo, ao educar aquilo que, até então, esteve situado no impensável afirmativo.

Ao olharmos para as falas, em diálogo com as possibilidades que o currículo e a escola podem representar na vida das pessoas soropositivas, foi possível perceber que o processo de descobrir-se soropositivo/a foi marcado pelo sofrimento. Ao integrarem um mundo que, até então, permanecia no interdito das experiências dos outros e das narrativas mitológicas acerca da AIDS, a escola e o currículo poderiam representar um espaço capaz de diminuir esse sofrimento para as pessoas participantes da pesquisa.

Isso pode ser observado em todas as falas, como a de Paka: *“eu ia... acho que ia ficar super tranquilo”* (Paka). E também na de Nando: *“Com certeza. Eu acho assim, a questão aqui é a escola. Se tivesse desde o início, eu acho que no Ensino Médio é perfeito, porque os jovens estão começando a ter uma relação sexual. Se tivesse essa educação desde o início sobre sexualidade, de uma forma educativa, não chegaria a isso, sabe?”* (Nando).

O não falar, na escola, sobre assuntos que envolvem as pessoas soropositivas deixa a lacuna de que a instituição não desempenha o papel de oferecer condições para a prática dos jovens em seus cotidianos. Produz-se a ideia de que se

trata de algo desnecessário, como se houvesse uma intencionalidade em barrar esse tipo de fala oficial.

O que não é considerado e que foi possível perceber é que, assim como na vida não há uma cartilha sobre como viver, também não há uma cartilha sobre como viver sendo soropositivo/a. A inscrição da sorologia em uma sociedade que rejeita sua existência cria ainda mais barreiras e sofrimentos, sustentados por uma lógica de exclusão.

Não desenvolvemos uma cultura de si, mas uma cultura do ódio ao outro, uma ressignificação bíblica que tem sido pregada na sociedade e que se reflete, na escola e nas intolerâncias do dia a dia. Assim, o papel da escola, ao considerar as vidas soropositivas, poderia produzir melhores sentidos para a vida das pessoas da pesquisa, como podemos observar na fala de Paka:

Olha, hoje eu vejo que é normal. *Mas se eu soubesse antes como que era, eu teria agido bem diferente, bem diferente.* Porque pra mim, *quando eu tive, minha cabeça, eu morri*, não sei o que, foi muito difícil, muito difícil, *eu não sabia o que eu ia fazer*, minha cabeça estava a mil, porque eu não podia, *igual eu falei, não tinha apoio da minha família*. Era muito complicado. *Hoje, se acontecesse, eu acho que seria super normal pra mim. Eu ia me cuidar, ia tomar meu remédio. E pronto.* Igual recentemente aconteceu um caso, amigo do meu namorado. Ele tem...acho que tem quase 50 anos. Ele testou positivo. Ele contou pro meu namorado, que eles são muito amigos, né? Ele contou. E...*Ele reagiu muito mal também. Não reagiu bem.* Sabia do PrEP. E eu não sabia que existia PrEP. Até nessa época eu não sabia. Eu não sabia do PrEP. Eu acho que se eu soubesse, eu teria me cuidado melhor. Eu não sabia que existia PrEP. Também eu não fui atrás né? Mas igual esse amigo do Eduardo, ele já sabia da PrEP, e mesmo assim, pegou. *Mas ele não ia acreditar, porque ele acha que nunca aconteceria com ele* (Paka).

Repetidas vezes, a palavra morte aparece. Em seus usos, ela assume o significado de limite do estar soropositivo. Para Paka, a morte é o fim, associada à descoberta de que o vírus poderia matá-lo; é também a morte pelo desamparo. Ele se vê sozinho, desacolhido. O novo produz o sentimento de abandono em uma realidade para a qual não havia sido formado, pois sua percepção havia sido treinada para ver o mundo apenas pela ótica soronegativa.

Em sua fala, também é possível perceber que, embora se fale das tecnologias na escola, pouco se fala das tecnologias preventivas como mais um dos recursos que o corpo discente pode utilizar a seu favor. As falas de Paka abrem vários desdobramentos. Um deles aparece quando menciona o amigo de seu namorado.

Nessa passagem, é possível pensar que não somos formados para as possibilidades dos acontecimentos. Vivemos sob o limite da ideia de que somos livres.

A partir do cuidado de si, a liberdade é saber escolher bem. O bem não é um qualificativo que hierarquiza, mas a consciência de que determinada escolha não causará tantos prejuízos. A fala de Paka diz muito. O se é o condicional que a escola parece não ter possibilitado, ao negar que a fala sobre ser soropositivo ocorresse para além da performance a que Paka se refere, quando lembra das aulas sobre preservativo na banana e sobre como não engravidar.

As falas de Paka somam-se às de Nando quando, ao perguntarmos se a escola tivesse abordado tais assuntos, ele teria percebido alguma mudança em sua vivência após descobrir a sorologia.

Acho que com certeza, porque eu estou sempre disposto a aprender e quando são coisas boas, a vivenciar aquilo. Então, *se eu tivesse um conhecimento, eu acho que até seria um apoiador da causa e teria um conhecimento desde o início*, não precisaria buscar por mim próprio, mas já tem uma fonte, pegar dessa fonte e potencializar, não usar, se preservar e passar até a informação para frente para pessoas como a minha mãe, como o meu pai, que estudaram há muitos, muitos anos e não teve esse conhecimento. Então eu, como mais jovem, poderia passar essas informações pra eles, porque eles também precisam se prevenir e *saber que pessoas que convivem com HIV não devem ser estigmatizadas, que têm uma vida toda pela frente* (Nando).

Nando afirma que o conhecimento prévio sobre o viver soropositivo teria sido um diferencial para sua vivência. Um ponto importante que ele traz é o fato de estar sempre disposto a aprender exatamente a oportunidade que a escola espera de seus e suas estudantes. Ou seja, o assunto não circula por uma falta de interesse dos alunos, mas pelas escolhas da escola em que Nando estudou.

Há interesse e curiosidade, que muitas vezes têm seu direito de aprender contestado quando o tema está fora do currículo, como uma *tessitura curricular* (Morais, 2023). A fala de Nando evidencia o tipo de percepção a partir da qual a escola se organiza. As propostas elaboradas para direcionar a instituição, ao buscarem controlar seus estudantes, acabam por encarcerá-los em sentidos únicos, produzindo subjetividades que desconhecem outros saberes que não estão previstos em suas exigências.

Não se valem do cotidiano, nem de relações que extrapolam o já sabido para mergulhar no desconhecido. Assim, criam-se formas de exclusão de si, do outro e do social, como ocorre também nas relações soronegativas.

Ao seguirmos provocando Nando, perguntamos: você consegue pensar se a escola, ao não ter falado sobre o HIV, e a família, ao também não falar, poderiam, de certa forma, ser responsáveis por você talvez ter se tornado uma pessoa soropositiva?

Eu acredito que em parte, né, porque a gente tem sempre que colocar a responsabilidade nas nossas próprias escolhas, mas *se na escola tivesse tido essa educação sobre sexualidade de forma geral e até sobre o HIV, a AIDS, eu acredito que eu tenha tido um pouco mais de responsabilidade nas minhas relações*. E em casa eu poderia, com essa educação e informação que eu poderia ter recebido na escola, ter passado, ter até batido de frente com a minha mãe nesses comentários de ódio. Comentários de ódio sobre o HIV e AIDS, da forma que ela falava, e ter ensinado ela. Mas eu não poderia, porque eu não sabia também naquela época. Então, *naquela época, eu pegava o que ela falava e na minha cabeça era aquilo. Até eu começar a ter um entendimento maior* (Nando).

Nando não se coloca na posição de quem foi vítima. Talvez isso revele a forma como somos formados a aceitar as consequências como resultados naturais. Aqui, chamo a atenção para o fato de que o ato de escolha livre só existe quando há condições prévias para realizá-la, saberes disponíveis que possibilitem, então, escolher. Isso é afirmado quando Nando diz que, se a escola tivesse falado sobre a AIDS, ele teria tido mais responsabilidade em suas relações.

Nando também menciona a mãe, operadora da verdade, disciplinadora e vigilante de sua sexualidade, o que repercutiu na forma como direcionou suas escolhas e práticas sexuais.

O cuidado de si implica investimento no questionamento, algo que Nando não pôde exercer, possivelmente, pelas condições que teve para questionar a mãe sobre as próprias verdades, e não apenas as dela. Nando fala sobre responsabilidade, e isso nos leva a pensar sobre a ética que o cuidado de si imprime quando é desenvolvido no contexto escolar.

É possível afirmar que Nando não teve condições para o exercício do cuidado de si por razões relacionadas à ausência da escola em ensinar sobre as diferentes técnicas preventivas, sobre o corpo dos adolescentes, sobre as possibilidades do HIV e sobre o viver soropositivo, o que o levou a percorrer esse caminho de forma sofrida.

As falas de Sonia, Caio, Paka e Nando levam-nos a pensar que, embora suas vidas tenham sido marcadas pelo sofrimento, ainda assim *ousaram existir* (Nascimento; Caetano, 2022). Quando pensamos em produzir os dados com pessoas soropositivas, nossa intenção foi mergulhar nas múltiplas malhas das experiências

que foram constituindo aquilo que hoje elas são. Para nós, também foi importante que as narrativas nos conduzissem a pensar afirmativamente suas vivências.

Nesse movimento, fomos impelidos a pensar um *currículo para sorotransgredir*. O currículo é um campo de forças, um espaço em constante *disputa*, no qual reconhecemos o medo e o silêncio que ainda cercam o tema do viver soropositivo. Mesmo assim, esse tema pode disputar o direito de estar (Arroyo, 2013).

Na disputa, as relações de força concentradas no currículo abrem brechas para que *outras identidades* possam emergir e se afirmar enquanto soropositivas na existência (Silva, 2014). A partir das falas, recusamos que o currículo permaneça sendo um currículo de morte e afirmamos a possibilidade de transformá-lo em um currículo da diferença, no qual todas as pessoas possam ser, criar e imaginar novos modos de viver (Corazza, 2010).

O currículo para sorotransgredir diz respeito a pensar as vidas para além de suas sorologias. O positivo da vida não é o vírus, mas os movimentos artísticos que podemos pintar cada pessoa à sua maneira, com suas condições, criando suas próprias artes.

O currículo para sorotransgredir é a materialização de processos artísticos inventivos que a estética da existência revela como uma penúltima verdade, produzida pelo cuidado de si. A última verdade é a morte.

Transgredir é criar meios para pensar além dos muros que cercam o preconceito sobre ser soro. O soro é líquido da vida: escorre, circula, faz viver. Pensar o currículo para sorotransgredir é pensar nas condições das vidas vivíveis, passíveis de serem pensadas, amadas e desejadas.

Transgredir é um verbo que se abre ao trânsito direto na exigência daquilo que não se contenta com o dado e com o estipulado. Pulam-se cercas, desobedecem-se regras, violam-se invioláveis, arrebatam-se normas, fissuram-se sistemas. Sorotransgredir é permitir que os corações pulsem na medida em que se formulam palavras que podem ser de esperança e de uma nova vida.

Essas palavras surgem nos últimos momentos do encontro com Paka e, por isso, não aparecem na fala de Sonia. Ele havia mencionado o desejo de poder ajudar outras pessoas a partir de suas vivências. Disse que, se tivesse mais coragem para assumir, abriria uma página no Instagram, gravaria vídeos e ajudaria outras pessoas, atuando como um sorotransgressor.

Sua fala produziu uma gratidão múltipla: a dele, por estar participando de uma pesquisa na qual pôde falar sem ser identificado; e a minha, por suas palavras me levarem a pensar o imaginável de outras realidades e verdades.

Assim, perguntamos a Paka, na condição de uma pessoa soropositiva, o que ele diria às pessoas que acabaram de descobrir sua sorologia. Qual seria sua fala para elas, no sentido de oferecer apoio, de dar uma luz que talvez você gostaria de ter tido e não teve?

Que ia ficar tudo bem. *Que ia dar tudo certo. Que ia viver normal.* A pessoa ia viver normal, *que não era um bicho de sete cabeças*, igual a gente acha que é. E falar, olha aí, eu tô tendo minha vida normal, tô vivendo. *Vou ter meus sonhos, vou realizar meus sonhos.* E *vou viver*, Deus quiser, igual a pessoa normal. Velhinho, quero chegar na velhice, *ser um velhinho normal.* Eu sei que eu vou chegar. E agradecer, né? E falar que tem que se cuidar. E eu sou muito grato à medicina, né? Porque há uns 30 anos atrás, querendo ou não, eu sei que se eu pegasse, eu não ia sobreviver. Hoje a medicina está avançada, tem os remédios, *eu tô com uma longa vida.* Se fosse lá atrás, quantas pessoas morreram, né? (Paka).

Nas palavras de Paka, é possível perceber que, se o diagnóstico não fosse construído dentro de um quadro de inverdades e de discursos maldosos, o processo não teria sido tão sofrido. O diagnóstico não determina uma vida.

Um dos alvos do currículo para sorotransgredir é problematizar as vias de regra que diagnosticam o “anormal”. Isso pode ser representado pela metáfora do bicho de sete cabeças: discursos soromitológicos que, ao serem transmitidos oralmente no senso comum, criam camadas que escondem o real do que o HIV é.

O trabalho empreendido direciona-se a *pensar outras imagens de resistências e de criações cotidianas* (Alves; Caetano; Soares, 2020). A imagem do HIV passa a ser pintada a partir das narrativas de pessoas soropositivas e de seus cotidianos, de lutas, aprendizados e enfrentamentos.

A visão da morte ressignifica-se como pensamento para a vida na velhice, o impensável do passado. As imagens assim produzidas rompem com as continuidades das representações do passado que ainda são replicadas no presente.

A visão de Paka se multiplica na de Nando. Ao final de nosso encontro, retomei com Nando algumas de suas falas sobre o momento em que descobriu sua sorologia. Convidei-o a se colocar no lugar de seu passado, naquele instante da descoberta.

Nando havia mencionado que não lhe fora tão difícil receber a notícia. Em suas palavras, era possível perceber um sentimento de espera, mas também certa negação. Diante disso, perguntamos: o que você diria para alguém que estará lendo nosso estudo e que acabou de descobrir sua sorologia? O que você diria para essa pessoa?

Que não é o fim do mundo, que esse baque inicial vai passar e sua vida vai continuar como sempre foi. Você vai continuar estudando, trabalhando, tendo seus namorados, transando, agora com responsabilidade, usando seus remédios diariamente, vai continuar bebendo, vai continuar... Fazendo tudo como sempre foi. Não adianta permanecer nesse estado em que você fica com medo de viver. Vai continuar igual pelo resto da vida. Agora você vai continuar tomando seu remédio. Mas a vida continua como sempre foi, não vai mudar em nada o que você é, o que você faz, seu trabalho vai continuar sendo o mesmo e você vai poder ser valorizado pelos seus amigos e colegas, aí vai da sua escolha você falar ou não, aí é uma escolha de cada um, mas se você optar por falar para sua família e amigos, eu acho que, dependendo da família e amigos, aí vai depender de você. A vida continua, né? Não tem problema nenhum. Agora você só é uma pessoa que vive com HIV e isso não é uma doença terminal. É só o início da sua vida, da sua nova vida, que vai ser essa (Nando).

Com as palavras de Nando, torna-se possível pensar o currículo para sorotransgredir a partir da ideia de que a vida continua. A vida, assim como o mundo e seus acontecimentos, não é algo estático ou fixo; os acontecimentos, em constante movimento, colocam-nos em um lugar de provisoriedade.

Embora Nando, em muitos momentos, afirme ser o mesmo, talvez não perceba que já não o é. Ao falar sobre responsabilidades, há uma cisão que ele nomeia como irresponsável e, agora, responsável. A ideia que Nando atribui a si é atravessada pelo olhar da mãe, que o constituiu a partir de regimes de verdade que eram dela, e não dele.

A nova vida em movimento é aquilo que o currículo pode produzir: novas experiências, novas visões sobre si e sobre a vida e, acima de tudo, a possibilidade de assumir a própria vida como sua, e não como pertencente aos outros. Daí nasce a liberdade de dizer ou não dizer quem se é, o que se quer e também o que não se quer.

Um currículo que se reconhece como das *ruas, das instâncias efêmeras, móveis e das lutas pelo direito à cidade* (Carneiro; Paraíso, 2022). Nas palavras de Nando, ainda é possível perceber movimentos desse currículo sorotransgressor que

sai para as ruas e, com a rua, aprende a se mover entre submeter-se e ser submetido à potência das escolhas e do poder de decisão.

Um corpo soropositivo em constante trânsito de deslocamentos produz estranhamentos e deslocamentos que educam a si e às outras pessoas. Pelo corpo, narram-se memórias que, quando silenciadas pelo não poder dizer sobre si, passam a ser faladas, escutadas e verbalizadas pelo currículo, ao abordar medicamentos, tratamentos e, acima de tudo, ao afirmar que a vida continua.

Na continuidade da produção dos dados, tivemos a oportunidade de conversar com Caio. Buscamos significar o trabalho da pesquisa como uma espécie de caixa de som amplificada, capaz de transmitir suas experiências por meio das palavras. Mostramos a Caio o quanto suas histórias e memórias foram importantes e o impacto que poderiam ter nas pessoas que as escutassem, especialmente naquelas que estão iniciando um caminho que ele já trilhou.

Assim, propusemos a Caio que dissesse quais palavras diria, ou que mensagem deixaria, para as pessoas que acabaram de descobrir sua sorologia e para as professoras e os professores que, ao terem acesso ao material, pudessem utilizá-lo para mobilizar outros sons em suas escolas e currículos.

Então, eu falo assim, é algo que muitas pessoas podem querer se assustar, mas *eu acho que o HIV é como se fosse qualquer uma outra doença. Hoje, se fosse pra mim escolher de qual doença entre o HIV e o câncer, eu preferia o HIV, porque ele tem um tratamento, se você levar ele a sério*, o câncer, ele é inesperado, mesmo que o HIV no sangue, mas ainda tem um controle, ainda consegue ter um controle para você ter uma vida normal. E o câncer não, o câncer ele vem te dar uma rasteira, ele vem te dar uma rasteira. Então eu falo assim, bati muito em cima falando pra ele (namorado) a respeito disso, que ele não está preocupado. Às vezes a gente deveria parar e pensar um pouco assim, ele não se preocupa por quê? É como se todos *nós vamos morrer, vai morrer de alguma coisa*, mas eu acredito, se você tem tal doença, às vezes você não vai morrer nem dela, você vai morrer de outra coisa. Eu que tenho visto que *ninguém morre do que você tem*, morre de outra coisa. Então assim, em questão de preconceito, vamos ter tanto de cor, de situação social, então essas coisas nunca vão acabar. Enquanto a gente tiver nesse mundo globalizado que a gente vive, não vai acabar não (Caio).

A resposta de Caio é realista e provocativa. Ao afirmar que o HIV não é a pior coisa que pode acometer alguém, ele nos leva a pensar que muitas outras situações na vida também produzem sofrimento e morte. A AIDS não é um *ghostface*, uma máscara que assusta e mata as pessoas.

Caio nos faz pensar que, para sorotransgredir, é preciso desconfiar. Desconfiar das certezas da morte, das formas pelas quais se pode morrer, do outro, das verdades que nos produzem. O currículo, nesse sentido, deve considerar a desconfiança como um meio para pensar e produzir a vida a partir de seu contrário: a própria morte.

Quando pensamos a vida a partir da morte, mudamos o sentido de ver e de viver a vida. A vida só tem sentido se nela pudermos ser-consigo e ser-com-o-mundo. A morte torna-se consequência de um viver responsável, criativo e crítico.

São as *marcas inscritas nos muros da escola* (Ferrari; Castro; Bastos, 2021) que, ao serem atravessadas pela sorotransgressão, permitem romper com o preconceito, a exclusão, a sorofobia e todos os tipos de violência que diminuem nossa existência e nossa humanidade. Ao desconfiar, produzimos identidades provisórias e afirmativas e, assim, passamos a compreender a escola como espaço das diferenças e das inclusões.

5.20 Conclusões do terceiro estudo: narrativas soropositivas para o currículo das diferenças

O objetivo deste terceiro estudo foi compreender, a partir das narrativas de pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, o que aprenderam na escola sobre HIV e AIDS, principalmente o que auxiliou em suas vidas após serem positivadas e terem que estar no convívio social.

A partir do percurso metodológico e do referencial teórico adotado, foi possível, por meio dos cinco eixos analíticos, responder tanto ao objetivo específico deste momento da pesquisa quanto à questão central da tese: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização?

Os eixos permitiram analisar os regimes de verdade produzidos sobre os corpos soropositivos não apenas no contexto escolar, mas também nas relações familiares e em outros espaços atravessados pelo processo de escolarização, como os serviços de saúde e o convívio social. Tais relações mostraram-se, em muitos casos, marcadas pelo preconceito e pelo estigma.

No primeiro eixo, foi possível compreender como se deu a descoberta da sorologia das pessoas participantes da pesquisa. A ausência de conhecimentos básicos, desvinculados do estigma e do preconceito, mostrou-se determinante para a

forma como as pessoas lidaram com esse momento, frequentemente descrito como um período de intenso sofrimento, dor e medo, não decorrentes do aspecto biológico do vírus, mas das associações históricas atribuídas aos corpos soropositivos.

Para algumas pessoas, contudo, o acesso prévio a informações e a uma compreensão menos estigmatizada interferiu de modo positivo, atenuando o sofrimento da descoberta.

As narrativas evidenciaram sentimentos recorrentes de abandono, tristeza, desespero e desejo de morte, associados à ausência de saberes que possibilitassem compreender a nova condição de forma menos violenta.

As falas também revelaram relações pouco empáticas no espaço de saúde, marcadas por atitudes de pena, distanciamento ou despreparo, ainda que tenham surgido experiências pontuais que indicaram deslocamentos em relação aos regimes de verdade historicamente construídos sobre o HIV e a AIDS.

O processo de aceitação da sorologia, abordado como desdobramento da descoberta, mostrou-se igualmente atravessado pela falta de conhecimentos. Estar soropositivo/a foi frequentemente narrado como um decreto de morte, acompanhado por sentimentos de luto pela perda do corpo soronegativo.

Esse luto produziu vulnerabilidades e, em alguns casos, mudanças drásticas na vida, como a mudança de cidade. Com o tempo e a inserção em novos processos e relações, a sorologia passou a ser naturalizada para algumas pessoas, produzindo outras percepções menos marcadas pelo sofrimento.

Ficou evidente que cada participante vivenciou a descoberta de forma singular, ainda que atravessada por experiências predominantemente negativas ou menos negativas. O elemento central que diferenciou essas experiências foi o acesso ou não ao conhecimento.

A dificuldade relatada não se concentrou no campo biológico, mas no campo social, onde as representações historicamente construídas sobre o HIV e as pessoas soropositivas continuam a operar.

No segundo eixo, destacou-se o papel da medicina e dos profissionais de saúde na condução dos corpos soropositivos, evidenciando relações de poder que, em determinadas situações, desconsideraram a autonomia, os direitos e a capacidade de decisão das pessoas, especialmente das mulheres soropositivas.

Essas práticas abriram espaço para a legitimação de diversas formas de violência, somando-se aos sofrimentos já vivenciados no momento da descoberta.

As experiências no espaço de saúde revelaram que, para muitas pessoas soropositivas, esse ambiente pode se constituir como um local de sofrimento, sustentado por práticas ainda ancoradas em regimes de verdade do passado.

Tais dados suscitam questionamentos sobre a formação dos profissionais de saúde e sobre os protocolos que orientam suas práticas, apontando para lacunas que fragilizam a promoção de relações humanas, éticas e inclusivas.

O sigilo sobre a sorologia emergiu como uma estratégia de proteção diante do medo do preconceito e da discriminação. O problema, conforme evidenciado pelas narrativas, não reside na sorologia em si, mas nas percepções socialmente construídas sobre as pessoas soropositivas, reforçando a necessidade de uma formação que valorize as diferenças.

No terceiro eixo, observou-se que os temas relacionados à sexualidade, HIV e AIDS, no contexto familiar, estiveram majoritariamente ausentes ou foram abordados de forma estigmatizante.

O silêncio, sustentado por valores tradicionais e conservadores, funcionou como mecanismo de controle da sexualidade, especialmente daquelas consideradas desviantes. A ausência de diálogo levou muitas pessoas a vivenciarem suas experiências sexuais de forma insegura, marcada pelo medo e pela ocultação.

O não falar revelou-se tanto como herança estrutural das famílias quanto como estratégia de reforço de valores morais conservadores. Quando o tema era abordado, frequentemente produzia medo, perigo e rejeição, abrindo espaço para manifestações de homofobia, machismo e sorofobia.

No quarto eixo, as narrativas mostraram que, para algumas pessoas, a escola abordou o tema do HIV e da AIDS de forma predominantemente biologizante e preventiva, muitas vezes associada à produção do medo.

Para outras pessoas, o tema esteve ausente, gerando lacunas que só foram preenchidas pela experiência prática, marcada por insegurança e risco. A presença de valores morais e tradicionais na escola mostrou-se um obstáculo para o aprofundamento do tema no currículo.

As falas indicaram que uma abordagem escolar mais ampla poderia ter contribuído para que a descoberta da soropositividade e a vivência dessa condição fossem menos sofridas, reforçando o papel da escola e do currículo na promoção do cuidado, do respeito e da informação.

No quinto eixo, os dados evidenciaram que a escola poderia ter desempenhado um papel central na oferta de condições mais favoráveis para as vivências sexuais e para o enfrentamento do diagnóstico.

O acesso ao conhecimento poderia ter produzido outras formas de compreender a soropositividade, desvinculadas da ideia de morte, vergonha e medo, sentimentos que, conforme observado, ocasionaram abandono do tratamento, desejo de morte e rupturas significativas na vida das pessoas.

Por fim, os dados indicaram que a escola e o currículo podem fortalecer a confiança de si por meio do cuidado de si, possibilitando que os sujeitos se relacionem consigo e com o outro/a de forma menos vulnerável. Os temas relacionados ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas não devem ser regulados pelo silenciamento, mas tratados de modo a produzir sentidos vinculados à realidade vivida.

Com base nos cinco eixos, é possível afirmar que a ausência de conhecimentos capazes de produzir outros regimes de verdade sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas contribuiu para que as experiências das pessoas participantes da pesquisa fossem marcadas pelo medo, pela sensação de morte, pelo abandono e pela vulnerabilidade.

6 ÚLTIMAS PALAVRAS

A presente pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: que regimes de verdade são produzidos sobre os corpos de pessoas soropositivas no processo de escolarização? Com o problema delineado, o objetivo pretendido foi analisar as vivências escolares de pessoas soropositivas quanto à percepção sobre HIV e AIDS para a formação escolar das diferenças.

Como forma de nos direcionarmos, detalhamos o objetivo geral em três objetivos específicos, nos quais indicaram o “como” foi realizado o processo investigativo para que, então, fossem obtidas as respostas. Utilizamos como aporte teórico e metodológico, as produções desenvolvidas por Michel Foucault e aquelas elaboradas no âmbito do pensamento pós-estrutural.

No primeiro objetivo específico, buscamos analisar documentos, diretrizes e produções enquadradas como científicas e não científicas, que embasam as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas no Ensino Médio, sobretudo no Estado de São Paulo. Para nos direcionarmos nesse momento, baseamo-nos em Foucault (2019), na obra *História da loucura*.

Consideramos como materiais as produções organizadas como científicas, isto é, aquelas definidas e classificadas por regimes de verdade que autorizam seu aparecimento e circulação na sociedade, ao serem consideradas por conhecimento legítimo, apoiado em instituições, métodos e validações, como artigos, livros e enciclopédias.

No que tange aos conhecimentos não científicos, trata-se daqueles cuja circulação e aparição na sociedade não foram legitimados por não se enquadrarem nas ordens e regras da produção discursiva da verdade, como ocorre com algumas publicações em jornais, entrevistas, entre outros formatos, sobretudo, em tempos em que a censura opera como sistema que silencia e nos dias atuais, as narrativas negacionistas que ofuscam produções que questionam as verdades produzidos sob a base da distorção dos fatos e seu contexto de acontecimento (Foucault, 2014a).

Ao olharmos para o tempo atual, torna-se clara a afirmação de Foucault (2019) de que não há um progresso na história, mas mudanças de táticas que fazem com que os regimes de verdade continuem produzindo relações de poder e saber, como ocorre com a administração dos corpos biopolíticos (Foucault, 2015b).

Ao analisarmos os materiais base da educação Nacional, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 2017), os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000a, Brasil, 2000b, Brasil, 2000c, Brasil, 2000d), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNE, 2013) e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), bem como, no âmbito Estadual, o Currículo Paulista (São Paulo, 2020) e os materiais didáticos utilizados no Ensino Médio paulista no ano letivo de 2024, observa-se que, nos raros momentos em que aparecem, os temas HIV, AIDS e pessoas soropositivas são pouco abordados. Quando aparecem, seguem na linha da prevenção, não se ampliando para outras questões, como a possibilidade de viver com HIV.

Ao realizar a história da loucura, Foucault (2019) demonstrou que a loucura não consistia em uma condição natural, mas em uma produção histórico-cultural. Essa produção é realizada por meio de diversas práticas sociais, envolvendo dimensões morais e jurídicas que, em suas transformações, tornaram-se psiquiátricas.

O olhar arqueológico para a história possibilitou a Foucault perceber que, em cada período histórico, eram utilizadas práticas que alienavam, excluía e silenciavam grupos de pessoas que, em cada contexto, eram lidas a partir de comportamentos ditos desviantes e que, assim, passaram a ser constituídas como loucas.

A partir dos achados desta pesquisa, foi possível perceber que a produção do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas não operou apenas nos regimes de verdade dos saberes biomédicos. A verdade sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, nos diferentes tempos históricos, esteve também associada aos regimes de inverdade produzidos pela sociedade e cultura.

Assim, as pessoas soropositivas foram produzidas e lidas por visões estereotipadas, preconceituosas, negacionistas, moral-cristãs e higienistas. A história da AIDS pode ser lida como aquilo que Foucault chamou de história da alienação.

Isso porque a percepção construída sobre a infecção e sobre as pessoas soropositivas esteve associada aos homossexuais, às pessoas trabalhadoras do sexo, ao uso de substâncias ilícitas, às pessoas haitianas e às pessoas hemofílicas, assim como a todas aquelas consideradas como portadoras de comportamentos desviantes.

No decorrer dos anos, a AIDS passou a ser associada como algo característico de alguns grupos e de pessoas que, ao estarem em circulação na

sociedade, eram alienadas, de modo a serem retiradas do convívio social, de diversos espaços sociais e institucionais.

Os efeitos das descobertas biomédicas não repercutiram de forma a eliminar a circulação dos discursos e das percepções sociais hostilizadoras empreendidas sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

No tempo atual, o efeito dessas percepções diminuiu, mas não se extinguiu. Isso porque o funcionamento das medicações antirretrovirais possibilita que pessoas soropositivas não estejam, como no passado, tão expostas ao julgamento social.

Aos poucos, essas pessoas tornaram-se a identidade da AIDS e, assim, eram justificadas as formas pelas quais as relações de preconceito aconteciam e ainda ocorrem no tempo atual.

Na escola, essas identidades também apareciam como uma forma de frear que pessoas soropositivas e seus familiares pudessem ter o direito de frequentar a instituição escolar. Não obstante, os temas e assuntos sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas permanecem sob a regulação do que e de como estarão disponíveis.

A partir da AIDS, havia e, no tempo atual, ainda seguem, em menores e maiores proporções, regimes de verdade que regulam o aparecimento do assunto AIDS no interior da escola.

De outro modo, com o passar dos anos, o aparecimento da AIDS passa a ocorrer de forma esporádica, por meio de campanhas preventivas, palestras, jornais e programas de saúde, a depender das políticas e de suas intenções junto ao Estado e à sua base moral.

Muitos e muitas políticos/as eram e ainda são contrários/as a certas medidas que possam ser adotadas para o enfrentamento das vulnerabilidades que possibilitam que o HIV não seja “contido”.

No passado, houve uma história marcada por muitas mortes e sofrimentos em decorrência da falta de conhecimento e de informações seguras para a população. Por a AIDS ter sido fabricada socialmente de forma preconceituosa, a veiculação discursiva dos reais meios e formas de não se vulnerabilizar ao vírus acabava por esbarrar nos discursos estigmatizantes e moralizantes, que produziam, na mentalidade social, uma percepção contrária àquilo que é, de fato, o real.

Ao olharmos para os dados produzidos nos documentos e considerando o contexto em que foram elaborados, a AIDS não havia parado de vitimar pessoas. Os

números de pessoas que estavam no Ensino Médio e/ou que passaram pela escola também representavam o grupo de pessoas que viviam com HIV ou que já estavam com AIDS.

Ou seja, a nação produzia boletins epidemiológicos com dados de jovens e adolescentes morrendo e, quando da formulação dos documentos orientadores para os currículos e para a educação, parece não haver uma preocupação efetiva, seja com o campo biomédico, seja com as vivências soropositivas.

Os discursos que aparecem são indiretos, trazendo à luz, por vezes, apenas menções, mas não uma determinação efetiva, como ocorre quando se busca alcançar metas e índices de “qualidade para a educação”. A BNCC foi o único documento, dentre os analisados, em que o tema aparece.

Contudo, nas raras aparições, as menções são feitas por meio de linguagens ultrapassadas e estereotipadas, reforçando a visão de doença que atravessa a história. Fala-se pouco sobre prevenção e não se fala sobre a possibilidade de viver com HIV de forma positiva.

No tempo presente, ao olharmos para os dados produzidos a partir dos materiais didáticos utilizados por estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo, encontramos menções em duas disciplinas que, ao serem tratadas, são apresentadas dentro do reduto biologizante.

Como bem pontuou Foucault (2015c; 2014b), a preocupação do Estado está em não deixar que a população morra. Para que a sociedade funcione e não entre em extinção, é preciso que haja o governo sobre os corpos e, por isso, políticas que fazem com que, nos currículos, estejam presentes discursos que direcionam para a prevenção ainda que de forma precária.

Ainda assim, se o trabalho do Estado é fazer com que as pessoas não morram, é possível afirmar que isso não tem funcionado, sobretudo se considerarmos, por exemplo, o objetivo de eliminar a AIDS até 2030.

Nossa afirmação se baseia nos dados publicados pelo Boletim Epidemiológico, até junho de 2025, que denunciam o registro de 1.626 casos de HIV em adolescentes entre 15 e 19 anos, sendo 1.115 em indivíduos do sexo masculino e 511 do sexo feminino. Outros dados indicam que, em 2025, o Brasil registrou 523 casos de AIDS na faixa etária de 15 a 19 anos, sendo 348 em indivíduos do sexo masculino e 175 do sexo feminino. (Brasil, 2025a).

Ou seja, os dados produzidos nos possibilitam questionar as condições em que o currículo e a escola têm tratado ou dado conta de tratar tais temas. Soma-se a isso o fato de observarmos, a partir dos dados, que o currículo não contempla a possibilidade de que estudantes possam viver sendo soropositivos/as.

Ainda que sejam feitas algumas e poucas menções sobre HIV, AIDS e ISTs o que ressaltamos ser de suma importância, suspeitamos se essas menções dão conta de possibilitar saberes que, ao serem utilizados no cotidiano dos estudantes, ofereçam subsídios para suas vivências e práticas sexuais.

A única forma pela qual conseguimos zerar as transmissões no Brasil foi por meio da transmissão vertical, em que a mãe passa o vírus para o bebê. Não é fácil compreender que, para terem seus filhos, as mães passam pelos centros de saúde, onde, de uma forma ou de outra, são observadas. Todavia, e os/as estudantes, quando vão? Sabem sobre os testes?

Nessa suspeita, seguimos com o segundo objetivo e estudo, que foi compreender a percepção que estudantes matriculados/as no Ensino Médio do Estado de São Paulo têm sobre as questões de HIV, AIDS e de pessoas soropositivas.

Para a realização desse estudo, utilizamos como instrumento para a produção dos dados, um questionário misto, no qual estiveram presentes perguntas com opções de escolha, assim como perguntas abertas. Os dados foram produzidos com estudantes matriculados/as no Ensino Médio, em escolas de uma cidade do interior do Estado de São Paulo.

Os dados produzidos resultaram em 189 respostas. Ao analisarmos de forma exploratória e discutirmos com base em Foucault (2014b; 2015b; 2015c; 2025a), assim como em pesquisas relacionadas ao tema e ao pensamento pós-estrutural, compreendemos que o tema é precário e pouco circulado na escola.

No primeiro eixo, os resultados e as análises evidenciaram certa dificuldade das/os estudantes em compreenderem suas sexualidades. A partir da produção dos dados, constatou-se que, ao menos, 5,3% das/os estudantes não sabiam qual era sua orientação sexual, enquanto 10,6% não sabiam qual era sua identidade de gênero. Outros dados que se somaram a esse cenário de dificuldade na compreensão da sexualidade referiram-se ao termo “cis”, cuja menção foi acompanhada por risadas e brincadeiras, indicando certo desconforto e processos de banalização.

Os dados evidenciaram que, pela escassez e/ou ausência do currículo em tratar da diversidade sexual, os/as estudantes, ao responderem, demonstraram

dificuldades. Com os dados, foi possível observar que a ausência do tratamento do tema diversidade sexual e de identidade de gênero abre espaço para que a escola, assim como a sociedade, tenha dificuldades nas relações e vivências, em razão da falta de informação, o que pode repercutir em diversas formas de violência e discriminação, como a homotransfobia e o feminicídio.

No segundo eixo, os resultados apontaram que as percepções desses e dessas estudantes estavam pautadas na incerteza, na confusão, na desinformação, no estigma e em visões mitológicas. Um dos elementos que evidenciam essa constatação refere-se à questão sobre a possibilidade de transmissão do HIV pelo suor, saliva, aperto de mão, compartilhamento de talheres e roupa de banho. Entre as respostas, 25,6% das/os estudantes concordaram com o enunciado, enquanto 24,2% não souberam dizer. Ao somarmos ambas as parcelas, observa-se que 49,8% não sabiam que o enunciado era falso.

Embora, ao longo de mais de 40 anos em que a AIDS surge na sociedade e na disputa entre os regimes de verdade e os regimes de inverdade nos quais são produzidos os saberes sobre a AIDS, o HIV e as pessoas soropositivas, é notável que os conhecimentos desenvolvidos pelo campo biomédico, pautado na ciência, não tenham alcançado de forma exitosa o cotidiano dos/as estudantes. Não obstante, os conhecimentos voltados ao senso comum, contaminados por visões estigmatizantes e ultrapassadas, têm estado presentes na percepção dos/as estudantes do Ensino Médio participantes desta pesquisa.

No terceiro eixo, os dados produzidos mostraram que as escolas em que a pesquisa foi realizada não trata das questões relacionadas ao HIV, à AIDS e às pessoas soropositivas. O que se tornou perceptível é que a escola tem deixado a desejar, sinalizando uma possível hierarquização na forma como os assuntos sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas aparecem.

Quando algum movimento é feito, ocorre em ocasiões esporádicas, contrariando o desejo dos/as estudantes, que se mostraram interessados/as no tema. Com os dados, ainda é possível perceber que a escola pode não cumprir o papel de levar informações e formação sobre tais temas, assim como de preparar a comunidade escolar para a relação sorodivergente entre os/as estudantes e as demais pessoas que participam da escola, como professores/as, gestores/as e demais funcionários/as.

O quarto eixo mostrou que a compreensão que os/as estudantes possuem os/as vulnerabilizam ao HIV. Essa afirmativa é evidenciada a partir dos dados produzidos, que demonstram que os/as estudantes têm uma vida sexual ativa e certo conhecimento sobre algumas tecnologias preventivas.

Ainda que a maioria das respostas tenha sinalizado concordância quanto à importância do uso de preservativos, muitos/as discordaram ou não souberam responder. A vulnerabilidade ao HIV mostrou-se mais acentuada quando os dados indicaram uma possível falta de “hábito” ou “prática” na busca por autotestes.

Soma-se a isso o fato de que os dados apontam que, em uma possível soropositividade, os/as estudantes não saberiam como lidar, ao menos no início. A ausência de informações indica possíveis distanciamentos nas relações sorodivergentes e a reprodução de preconceitos.

Com os dados do segundo estudo é possível afirmar que a percepção apresentada pelos/as estudantes desta pesquisa é refletida pela ausência que os documentos e materiais analisados nos mostraram com os dados produzidos no primeiro estudo. Se os documentos, currículo e material didático não abrem a possibilidade de tratar tais temas que fazem parte do cotidiano das/os estudantes, na prática, as consequências da falta de conhecimento seguro mostram os vários desafios e sofrimentos, apontados pelos dados produzidos no terceiro estudo.

Com o terceiro estudo, tivemos como objetivo específico compreender as narrativas de pessoas soropositivas egressas do Ensino Médio, sobre o que aprenderam na escola acerca do HIV e da AIDS e, principalmente, sobre o que auxiliou em suas vidas após serem diagnosticadas e terem de seguir no convívio social.

Os dados desse estudo foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas com quatro pessoas soropositivas que cursaram o Ensino Médio no Estado de São Paulo. A partir das entrevistas, foi possível analisar cinco eixos para a discussão.

Com o primeiro eixo, *Seu exame deu HIV positivo: vai ser pra vida toda ou será parte da minha vida?* foi possível concluir, que as dificuldades relatadas pelos/as participantes revelam que o impacto da descoberta da sorologia não decorre apenas do diagnóstico em si, mas, sobretudo, dos regimes de verdade historicamente produzidos sobre o HIV.

Os dados produzidos no primeiro estudo mostram-se presentes como modelos que moldam as percepções sociais. A partir dessas percepções, instaura-se o medo nas pessoas que passaram a viver sendo soropositivas, criando, assim, uma distorção no sentido do viver soropositivo.

Ao serem lançados/as ao vazio do desconhecido representado pelo diagnóstico, os sujeitos enfrentam a ausência de informação sólida, ao mesmo tempo em que são atravessados/as por um excesso de discursos estigmatizantes sedimentados ao longo da história, produzindo experiências negativas, como as narradas por Sonia e Paka.

Em contraste, Caio e Nando, mobilizando outros referenciais, não reproduzem o peso simbólico do HIV tal como cristalizado socialmente, evidenciando que o sofrimento não é produzido pela dimensão biomédica, mas pelas construções sociais que se impõem ao corpo soropositivo.

Esse cenário ilumina o papel crucial da escola e do currículo na produção de regimes de verdade capazes de tensionar os saberes hegemônicos, oferecendo condições para que o HIV seja compreendido para além dos muros do estigma e da moralização.

Com o segundo eixo, *Uma pergunta que não deveria fazer: você é soropositivo/a?* os dados evidenciam a urgência de compreender o currículo no Ensino Médio como uma ferramenta capaz de produzir impactos concretos na vida social, especialmente no que diz respeito às percepções sobre sexualidade, saúde e HIV/AIDS.

Quando o currículo é reduzido a uma dimensão técnica, descolada das experiências e dos contextos que atravessam estudantes e profissionais, ele não apenas falha em sua função social, como também contribui para o afastamento das pessoas soropositivas de seus próprios cuidados e tratamentos nos espaços hospitalares.

Com os dados produzidos, foi possível observar como as vivências de pessoas soropositivas, ao estarem em espaços de saúde, ainda estão marcadas por práticas moralizantes, preconceituosas e estigmatizantes por parte de profissionais da saúde.

O HIV indica, assim, uma certa identidade marcada por percepções que o entendem como resultante de comportamentos desviantes, produzidos por regimes de verdade materializados na promiscuidade, nos desvios morais ou no pertencimento

a grupos historicamente marcados, como pessoas homossexuais, travestis e trabalhadores/as do sexo.

Tais classificações protocolares, naturalizadas no sistema de saúde, produzem barreiras simbólicas e materiais que desmobilizam usuários/as, como demonstra o caso de Sonia, que interrompeu o tratamento por um período, resultando em problemas de saúde física e emocional.

As pessoas soropositivas deste estudo mostraram que há um descumprimento da postura ética, o que nos direciona a pensar a formação desses/as profissionais como precária, por se pautar em percepções e modelos que insistem em afirmar que corpos soropositivos são riscos pré-definidos e identidades suspeitas.

Diante disso, torna-se imprescindível repensar tanto as práticas de saúde quanto os processos educativos, reconhecendo seu papel na produção de subjetividades governadas por regimes de verdade criados no passado e que se fazem valer no presente. O currículo sorotransgressor possibilita o enfrentamento do estigma e a construção de relações humanas, acolhedoras e críticas.

Com o terceiro eixo, *Entre o dito e o não dito: narrativas para a pedagogia familiar do medo* os dados produzidos a partir das falas de Sonia, Caio, Paka e Nando evidenciam que a ausência de diálogo sobre sexualidade, HIV e o viver soropositivo no âmbito familiar produziu um terreno fértil para o medo, o constrangimento e a reprodução de moralidades que limitam corpos e desejos.

A educação fornecida nos lares, marcada pela pedagogia do medo e por discursos religiosos e moralizantes, não ofereceu condições para que as práticas sexuais fossem vividas com autonomia e responsabilidade, mas sim, enquadradas em normas rígidas de gênero e sexualidade.

Essa estrutura, transmitida geracionalmente, reforçou desinformações que contribuíram para experiências de sofrimento diante do diagnóstico, para percepções distorcidas nos serviços de saúde e para a manutenção de estigmas que poderiam ter sido mitigados por uma formação crítica e afetiva.

Assim, os dados produzidos mostram que a fragilidade do diálogo familiar não é um detalhe, mas um elemento estrutural que atravessa vulnerabilidades, ampliando riscos e perpetuando violências simbólicas.

Isso nos leva a reafirmar a necessidade de um currículo que vise a uma educação integral e crítica que supera a ausência do tema em todas as instâncias: nas famílias, nas escolas, nos serviços de saúde e nas relações cotidianas.

A educação nesses moldes possibilita que a percepção sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas não esteja predominantemente governada por um passado marcado pela maldade. Com isso, torna-se capaz de produzir o cuidado de si, o acolhimento de si e de outras pessoas, possibilitando condições reais para que vidas soropositivas e soronegativas possam se relacionar em dignidade e sem violência.

Com o quarto eixo, *Quando a aula produz medo, e não cuidado: discursos escolares sobre HIV/AIDS e pessoas soropositivas* os dados produzidos revelam que, quando a escola aborda temas relacionados ao HIV e à AIDS, o faz de maneira restrita ao discurso biologizante, centrado no uso do preservativo como estratégia para evitar a gravidez e, ocasionalmente, como advertência moralizante sustentada pelo medo.

Essa abordagem reduzida não contempla a complexidade das vivências sexuais dos/as estudantes nem oferece condições para compreender o HIV para além do estigma. Os dados mostram que praticamente não se fala na escola, sobre a possibilidade de viver sendo soropositivo/a, nem sobre as dimensões sociais, afetivas e subjetivas que estruturam o cuidado e as experiências das pessoas soropositivas.

Diante da ausência de diálogo nas famílias, os/as participantes reconhecem que a escola poderia ter desempenhado um papel fundamental, tanto na prevenção quanto na construção de relações sexuais mais informadas e, sobretudo, na produção de sentidos menos violentos sobre o viver soropositivo.

Ao silenciar essas discussões, a escola revela sua limitação em acolher o cotidiano das/os estudantes. Ignora suas práticas, suas realidades e as diferenças que compõem o espaço escolar. Com isso, perpetua vulnerabilidades que poderiam ser transformadas por meio de um currículo que possibilitasse às/aos estudantes aprender a ser menos governados/as. Nesse movimento, poderiam produzir suas próprias subjetividades a partir do cuidado de si.

Os dados produzidos com o quinto eixo, *A arte de reinventar a si mesmo: invenções para o currículo sorotransgredir* tornam evidente o papel indispensável do currículo e da escola como espaços capazes de promover o cuidado de si a partir da estética da existência.

O currículo pautado no cuidado de si possibilita que a escola seja um espaço que aceita as diferenças e reconhece a complexidade das vidas soropositivas. Quando a escola assume a responsabilidade de falar sobre o viver soropositivo, ela amplia horizontes e não ensina pelo medo.

A escola e o currículo, pautados nessa lógica, passam a considerar os cotidianos reais dos/as estudantes, produzindo saberes que não apenas informam, mas transformam, abrindo caminhos para uma cultura escolar do cuidado de si.

Pelo cuidado de si, o ser estético nasce como resultado de uma autoprodução que cada estudante elabora, ao considerar sua vida como uma obra de arte, constantemente atravessada pelo desafio de refletir e de se produzir, de modo a estar vigilante ao cuidado e à atenção em todas as instâncias da vida e do viver.

Isso é possível quando a escola oferece elementos que permitam olhar o mundo sem silenciá-lo, considerando o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas como partes constitutivas do mundo.

O diálogo com os demais eixos mostra uma linha contínua: nas famílias, a ausência de conversas sobre sexualidade e HIV abriu vazios que geraram medo e desinformação; nas escolas, discursos moralizantes ou biologizantes pouco contribuíram para as vivências e práticas sexuais; nos serviços de saúde, condutas colonizadas por preconceitos reiteraram sofrimentos já conhecidos.

Destarte que, esses e essas profissionais também passaram pela escola. Isso evidencia que o currículo escolar atua tanto na produção quanto na perpetuação de visões negativas sobre o viver soropositivo. Por isso, imaginar currículos que tratem o tema de forma clara, ética e descolonizada é reconhecer o potencial da escola como agente de mudança.

Trata-se de um espaço capaz de desmontar estruturas e sistemas de medo, estigma e preconceito, favorecendo relações mais humanas, conscientes e cuidadosas, seja consigo, seja com as outras pessoas.

Não descartamos a importância do papel que a indústria farmacológica desempenha, ainda que seja questionado o uso do HIV para fins de enriquecimento e de manutenção da desigualdade social. Mesmo assim, ela segue, por meio de altos ganhos econômicos, entregando à sociedade mais opções de tratamento e prevenção ao HIV.

Ao olharmos para o passado e compararmos com o presente, saímos dos coquetéis para um comprimido, injeções semestrais, PrEP, PEP e tantas outras tecnologias que ainda estão por vir e, ainda assim, não temos a cura. O papel biomédico e preventivo representa, em linhas gerais, o trabalho de não colocar ou de diminuir o risco ao qual as pessoas podem estar expostas.

Todavia, que vida está isenta de riscos? Quais escolhas não podem resultar em consequências potencialmente perigosas? Viver é perigoso.

Em suma, no primeiro estudo, vimos que pouco é tratado, nos documentos e materiais destinados aos/às estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo, sobre essas temáticas. Ao olharmos para os dados produzidos nas escolas do interior do Estado de São Paulo, é possível perceber que a ausência desses temas nos currículos e nos materiais didáticos repercuti de forma negativa na percepção dos/as estudantes sobre o HIV, a AIDS e o viver soropositivo, observado no segundo estudo.

Embora se saiba que, na escola, esses assuntos podem circular em sala de aula e em outros espaços, ainda assim, os dados produzidos nesta pesquisa, indicados pelo segundo estudo, mostram que a percepção que os/as estudantes têm é limitada, o que vulnerabiliza suas práticas sexuais e seus cotidianos.

De posse desses dados, é possível observar, com o último estudo, como a ausência do currículo, ao não tratar de forma inclusiva as questões sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas, pode repercutir no viver soropositivo.

Ao olharmos para os dados dos três estudos, podemos defender a tese de que os regimes de verdade produzidos sobre os corpos soropositivos no processo de escolarização amparam-se na história do aparecimento do HIV e da AIDS no Brasil. Trata-se de uma história marcada por um conjunto de discursos e regimes que produziram exclusões, estigmas e divisões entre soropositivos e soronegativos, repetindo mecanismos de banimento e alienação como ocorridos em outros momentos da história.

O saber médico, ao produzir nomeações, categorias, riscos e protocolos, não apenas descreveu a infecção, mas criou realidades, identidades e fronteiras que legitimaram estigmatizações sociais.

Mesmo com o avanço científico, a AIDS não se deslocou da lógica de poder, exclusão e normalização. Os discursos sociais que alienavam e marginalizavam no passado, permanecem no presente, operando e constituindo a percepção do que é a sexualidade, a saúde e o corpo soropositivo.

Na escola, esses discursos chegaram como redes de saberes atravessadas por instituições biomédicas, religiosas, políticas e culturais, reproduzindo o binômio normal/anormal e produzindo práticas de preconceito, estigma e exclusão.

Os dados mostram que a escola, enquanto instituição formativa, regula os discursos quando se trata de sexualidade e HIV/AIDS. Quando aparecem, esses

temas ficam restritos ao campo biologizante da prevenção e do diagnóstico, omitindo a possibilidade de viver soropositivo e negligenciando a complexidade das experiências estudantis.

A escola e o currículo colocam-se como entidades não neutras que, pelas disputas políticas e educacionais, veem-se invadidas em seu direito de serem laicas, públicas e críticas. Por essa invasão, seguem reforçando o silenciamento e afastando-se da responsabilidade de ensinar sobre as questões que atravessam a vida dos/as jovens. Isso nos leva a chamar a atenção para a importância da defesa da escola pública e laica e de seu direito ao ensino para além dos negacionismos.

Essas interferências reafirmam o que Arroyo (2013) e Silva (2014) sinalizam: que o currículo é um campo de disputas e de poder. O currículo, ao se tornar um campo de disputas, funciona de forma não neutra. A ausência de tais temas não estar presente no currículo não significa apenas a ausência, e sim uma produção de silêncio sobre os temas.

Assim como o dito nos ensina, o não dito é educador. A ausência é uma forma de nos dizer que no currículo aparecem apenas as vidas que importam serem conhecidas. É uma operação atenta de poder que, nessa pesquisa, alinha-se ao que Butler (2023) já havia mencionado ao perguntar: quais vidas importam? No contexto curricular, observamos a haver a regulação que barra o conhecimento sobre quais vidas são dignas de conhecimento.

Os resultados também evidenciam que as famílias participam dos regimes de verdade ao não fazerem circular conversas sobre sexualidade e HIV, por outras percepções, reforçando estereótipos, moralizações e preconceitos que reaparecem entre profissionais de saúde, igualmente formados por esses discursos e que os reproduzem nos atendimentos.

Com os dados, é possível afirmar que o currículo tem operado como uma tecnologia da biopolítica (Foucault, 2015b). Ao preocupar-se em não “deixar as pessoas morrerem”, o Estado limita-se a dar subsídios para que as pessoas aprendam a viver. O currículo vigente é inscrito sob os regimes da racionalidade biopolítica, que restringe o olhar apenas para os riscos, negligenciando a importância dos saberes sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas como vidas possíveis.

Esse percurso confirma que os problemas relacionados ao HIV nunca se restringiram ao campo biológico, mas foram organizados por regimes de verdade que

circulam amplamente na sociedade, pelas narrativas de risco, pela construção do “outro” e pelo não reconhecimento do HIV como possível parte da vida humana.

Com essa pesquisa foi possível ver que os discursos produzidos sobre a AIDS também produziram divisões entre pessoas soropositivos e pessoas soronegativos, gerando assim, estigmas e preconceitos.

Na escola, essas divisões podem ser analisadas a partir do exame histórico, possibilitando que a instituição promova situações que dissolvam o preconceito por meio da reflexão sobre as diferenças, ao olhar para a história como uma máquina que não segue uma linha de progresso.

Ao contrário, trata-se de ver e reconhecer como os discursos e as práticas são resultados históricos e culturais daquilo que se diz e se reconhece sobre a AIDS e sobre as pessoas soropositivas.

Considerar que a episteme é a materialização dos saberes que, historicamente, vêm produzindo a percepção do que é a sexualidade e sua relação com a saúde implica compreendê-los como dados não naturalizados, mas contingenciais.

Em cada momento, o discurso sobre determinada doença estará na emergência de seu acontecimento. Isso ocorreu com a AIDS, com a Covid-19, ocorre com a dengue e ocorrerá com outras doenças e contextos históricos.

Os currículos são espaços de produção de subjetividades. Por meio deles, é possível produzir o medo, o estigma e a ignorância, como também o cuidado, a autonomia e o pensamento e a conduta ética. Ou seja, o currículo é oportuno para que essas questões tenham legitimidade para serem discutidas de forma crítica.

O currículo não apenas atua na transmissão de conteúdos, mas também produz modos de existir, regulando como as pessoas estudantes compreendem seus corpos, desejos e suas relações com outras pessoas.

Cabe à escola o exercício de ampliar e questionar as ideias produzidas sobre saúde e suas relações com a história, a sociedade, a cultura e as políticas.

A pesquisa permite reforçar a necessidade de uma educação crítica, capaz de intervir nessas lacunas históricas e de produzir conhecimentos que tenham efeito real nas vidas e experiências dos/as estudantes.

Isso implica refletir sobre o papel das/os professoras/es, gestoras/es e responsáveis que atuam direta e indiretamente na e com a escola. A formação,

enquanto dispositivo, regula discursos e saberes que nem sempre dialogam com as vivências cotidianas das/os estudantes.

Temas como pessoas soropositivas, sexualidades, respeito e intervenções político-negacionistas evidenciam esse distanciamento. Ao longo da história, tais temas emergem na criação de novas táticas e tecnologias de poder.

Ao se movimentarem na escola, essas pessoas têm a possibilidade de deslocar-se do lugar de poder que ocupam para aproximar-se do lugar da/o estudante, onde os acontecimentos cotidianos efetivamente se produzem.

Outras instâncias são necessárias para que se desenvolva um conhecimento que atravesse os muros do biológico. Após mais de quatro décadas, avançamos no campo farmacêutico, criando possibilidades para a saúde.

Contudo, o HIV e a AIDS ainda seguem fazendo vítimas, seja por óbitos, seja pelas diversas formas de preconceito e violência, como foi constatado na pesquisa sobre preconceito e estigma com pessoas que vivem com HIV (2025), bem como por ideação, tentativas e suicídio consumado (Tsai *et al.*, 2022).

Tal realidade revela que, sozinho, o campo biomédico não tem conseguido dar conta de manter algumas pessoas vivas, enquanto outras seguem morrendo. Isso porque, apesar da multiplicidade de tecnologias existentes, nem todas as pessoas têm acesso a elas.

Existem muitas outras realidades além daquelas apresentadas nos dados, nas quais pessoas não conseguem acessar tecnologias farmacológicas, realizar testes, consultas e demais ações necessárias para a manutenção da saúde, seja pela falta de conhecimento, por questões econômicas, políticas, climáticas, entre tantos outros entraves que impedem o acesso (UNAIDS, 2025).

Ainda assim, as indústrias seguem em movimentos que fazem crescer seus lucros, como pode ser observado no Relatório Anual da Gilead Sciences (Gilead Sciences, 2024), no qual foi registrado um total de US\$ 19,6 bilhões em vendas de antirretrovirais para o HIV.

O que provocamos a ver é que o problema do HIV, durante um bom tempo no Brasil, restringiu-se ao campo biológico, mas que, no tempo atual, não mais, como ocorreu no passado.

Ousamos dizer que a raiz dos problemas do HIV está nos regimes de verdade que sobre ele foram produzidos. A percepção construída sobre o vírus e sobre as pessoas soropositivas está na ideia de um outro, de um não eu.

De forma clara, é como se o HIV fosse um vírus de algumas pessoas, e não da vida humana. Essa epidemia sorosocial, no decorrer dos anos da AIDS, não encontrou sua cura. E, nesta tese, entendemos ser o currículo e a escola uma possível vacina para a cura da epidemia sorosocial.

Alinhamos-nos às pessoas que defendem que a escola é um espaço de forças e entendemos, com Foucault (2025a), que o poder não está fixo, mas em constante disputa. A escola não é um espaço homogeneizado; é diversa, marcada pelas diferenças. Produz corpos que, embora sejam lançados à padronização, também são corpos desobedientes.

Ou seja, a escola não é passiva, mas, muitas vezes, manipulada por sistemas que corrompem sua natureza produtiva e desconstrutiva. Uma jovem que é formada sobre seu corpo, seus desejos, o peso e a leveza das escolhas e de suas consequências, como criará sua existência?

Assumindo a visão filosófica, somos marcados/as pela liberdade. Ao considerar a liberdade como uma condição que nos dota de possibilidades, as experiências são resultados daquilo que escolhemos. Embora estejamos inseridos/as em contextos culturais que produzem percepções, as escolhas podem ser mais acertadas e as experiências podem nos potencializar.

Haverá também aquelas escolhas que são povoadas por artefatos conservadores, que nos enfraquecem. Nessa relação, não há bem ou mal, mas acontecimentos que nos permitem perceber repetições ou modificações como processos autoformativos.

Nesse entendimento, a reflexão liga-se ao currículo. Quando pensamos a educação, extrapolamos a ideia de vê-la apenas como uma forma de transmissão de saberes que historicamente se acumulam e poucas vezes se atualizam.

O que percebemos com essa pesquisa é que a educação pode colaborar para as vivências cotidianas, para os acontecimentos, para as escolhas sem pecado, para o desejo sem medo e sem arrependimento. Uma educação que não catequiza nem culpa. A educação se colocaria com um dispositivo que fortalece, e o currículo, o meio para alcançá-lo.

Assim, a educação e a escola podem desempenhar uma potência ao se articularem com o campo biomédico. No início da epidemia, pessoas gays soropositivas impulsionaram a sociedade a enfrentar os desafios impostos pela AIDS. Esse movimento revelou tanto o lado perverso quanto outras possibilidades do poder,

produzindo deslocamentos na forma de pensar a sexualidade, o ser humano e as diversas formas de existência, sobretudo aquelas possíveis com HIV (Caetano; Silva, 2019).

O HIV/AIDS pode provocar as pessoas a uma memória da existência trágica que deslocamos pelo esquecimento dos acontecimentos do passado. Não existe qualquer vida que não esteja entrelaçada ao trágico.

O trágico pode ser compreendido como um artefato curricular que possibilita produzir pertencimento ao sofrimento, funcionando como uma bússola que nos remete à história, ao passado e à percepção do que não precisa ser repetido. O trágico provoca o pensamento e o questionamento sobre o funcionamento do sistema que nos orienta. Trata-se de um sistema limitado, mas também atravessado pela possibilidade de ruptura, sobretudo quando nos afasta do viver e de fazer da vida uma existência poética.

O trágico também se constitui como uma condição que humaniza em tempos de tanta insensibilidade, marcados por guerras, mortes, extermínio do planeta e pela consciência da finitude da vida. Não é apenas um acontecimento. É uma condição que nos convoca a pensar e a elaborar outros modos de compreender a vida e o viver.

Reiteramos que a educação e a escola são fundamentais para desestabilizar os regimes de verdade que, historicamente, produziram estigmas sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

Os currículos, ao assumirem a indisciplinaridade e ao romperem com epistemologias dominantes, podem constituir espaços de reflexão crítica sobre saúde, sexualidade, poder e cultura, deslocando a percepção do vírus do campo moralizante para o campo das vidas possíveis.

Os resultados desta pesquisa mostram, portanto, que a escola é necessária e urgente para desmontar estruturas de medo, ódio e preconceito que moldam a experiência soropositiva. Ao articular saberes, a escola pode colaborar para diminuir sofrimentos, evitar exclusões e possibilitar que jovens construam existências menos vulnerabilizadas.

Nesse horizonte, propõe-se um currículo para sorotransgredir, rompendo com a lógica que fixa o ensino de tais temas apenas na perspectiva biologizante, com estruturas morais-cristãs e de prevenção restrita. Em seu lugar, afirmamos um currículo ético que se alinha às experiências estudantis e à crítica. O currículo

sorotransgressor é capaz de produzir saberes positivos sobre viver com HIV, o cuidado de si e por relações humanas distanciadas de percepções estigmatizantes.

Ao afirmarmos um currículo sorotransgressor que tenha características anti-biologizantes, está em vista produzir saberes que atravessem os muros da prevenção, colocando para dentro dos muros da escola o viver soropositivo a partir de relações afetivas e dimensões sociais que desconstruam e desnaturalizem as relações de estigma e preconceito relacionados ao HIV e à AIDS.

Outra característica do currículo sorotransgressor é ser anti-moralizante. A educação não deve estar pautada sob a culpa e o medo. O uso do medo como pedagogia do terror opera como mecanismo que distancia da realidade do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Produz, assim, a desinformação e a vulnerabilidade, direcionando jovens e adolescentes ao sofrimento e à morte, contrárias à promoção da vida e da saúde que o currículo sorotransgressor almeja.

Ao longo dos três estudos foi possível afirmar que, quando a educação silencia, ao não propor situações de aprendizagem que abordem o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas, o estigma passa a falar. Essa fala do estigma manifesta-se nas experiências evidenciadas pelos dados, a partir das narrativas das pessoas soropositivas participantes da pesquisa e com a percepção das/os estudantes, ao acentuar a omissão da escola, por meio da qual o preconceito se consolida.

A partir dessas evidências, o currículo sorotransgressor tem como característica ser desestigmatizador. O currículo sorotransgressor possibilita ser um espaço que oportuniza que as/os estudantes questionem os regimes de verdade produzidos no entorno do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Com os questionamentos, é possível desnaturalizar a percepção de grupos de risco e corpos desviantes, ambos colaborando para a produção de estigmas e preconceito.

O currículo sorotransgressor que propomos é o currículo que se centra no cuidado de si. A partir do cuidado de si, as/os estudantes se autoproduzem de forma autônoma, ética e reflexiva. Ao cuidarem de si, também estarão cuidando de outras pessoas, que fazem parte, direta e indiretamente, de suas relações sociais.

O cuidado de si não se coloca apenas no âmbito do cuidado com o corpo. Ele se inscreve a todas as instâncias da vida, como a sexualidade, os desejos, a saúde física e mental e tantas outras que colaborem para que as/os estudantes tenham condições de autogovernarem sem prejuízos que os vulnerabilizem e os coloquem sob o risco do que o desconhecimento pode produzir.

O currículo e a escola operam como um ambiente cultural do cuidado de si, no qual cada aluno e cada aluna se tornam responsáveis pela produção de suas subjetividades e pela constituição de existências estéticas e de potência.

Não obstante, ao pensarmos e defendermos o currículo sorotransgressor, estamos assumindo o currículo da experiência. Ou seja, parte da realidade e do cotidiano das/os estudantes. Considera-se a sexualidade vivenciada por estes e estas jovens e adolescentes, suas dúvidas reais em vista de operacionalizar no espaço escolar, para a vida real, práticas concretas. Visa-se, a partir das experiências e cotidianos, significar o currículo como algo real e de acontecimentos.

Na prática, o currículo sorotransgressor pode ser uma possibilidade de se colocar nas práticas pedagógicas, ao sair das linhas instrutivas que tratam o HIV apenas no âmbito de disciplinas centradas no biológico e/ou em campanhas pontuais.

Passa-se a assumir a responsabilidade, no qual determinados componentes curriculares assumem a centralidade do tema, garantindo continuidade, profundidade e compromisso formativo, ao mesmo tempo em que se abrem possibilidades de articulação com outras áreas, de forma situada e intencional.

Alguns exemplos práticos podem ser pensados: na sociologia, as questões de estigma e poder; com a filosofia, questões éticas e cuidado de si; na história, a produção social da AIDS; na biologia, a prevenção, mas também sobre o viver soropositivo.

A forma como esses temas podem ser trabalhados nos diferentes componentes curriculares pode variar. Alguns exemplos podem ajudar a pensar: análise de discursos midiáticos sobre o HIV, discussão de narrativas feitas por pessoas soropositivas, debates sobre quem pode amar quem? Entre tantas outras possíveis e necessárias.

O possível bom funcionamento do currículo sorotransgressor ampara-se em uma didática que deixa de ser uma aula expositiva, amparada no medo, e passa a considerar a problematização, a escuta, o diálogo. Por meio de várias estratégias didáticas, é possível que os assuntos sobre HIV, AIDS e pessoas soropositivas possam acontecer.

Rodas de conversa, em que todas/os os estudantes participem; estudo de casos; o uso de dados estatísticos, como os dos boletins epidemiológicos; documentários, filmes e tantos outros que temos produzido.

Em linhas gerais, o currículo sorotransgressor atua de forma ética e política. O currículo, assim, não aguarda uma autorização normativa para existir. O currículo sorotransgressor fissa os muros que cercam o que pode e o que não pode ser conhecido. Abre brechas, utiliza as oportunidades e se autoriza a ser e dizer a partir de deslocamentos possíveis que vêm de fora dos muros da escola, inserindo no interior da escola.

A partir dos dados, podemos afirmar a necessidade de mudanças, aqui pensadas a partir do currículo sorotransgressor. O currículo pode constituir-se como uma ferramenta de enfrentamento ao HIV, ao contribuir para a remodelação de uma cultura em que vidas juvenis são marcadas e, muitas vezes, perdidas em decorrência da AIDS.

A educação crítica, enquanto possibilidade de que corpos e subjetividades sejam menos governados e, nesse desgoverno, exerçam o cuidado de si, não é apenas desejável: trata-se de uma exigência ética diante da realidade histórica e social que esta pesquisa se propôs a evidenciar a partir dos dados produzidos.

Lembramos que a proposta desta pesquisa não esteve voltada a responder o problema investigativo de forma única ou generalista. A partir dos dados, outros problemas emergem, abrindo espaço para novas investigações, as quais, nesta pesquisa, permaneceram como limites.

Uma dessas possibilidades refere-se à compreensão das percepções das/os professoras/es acerca do HIV, da AIDS e das pessoas soropositivas. Outro ponto de partida para pesquisas futuras consiste na análise dos currículos da formação médica e das/os profissionais que atuam no campo da saúde, bem como de suas percepções sobre o HIV, a AIDS e as pessoas soropositivas.

Por fim, esta tese não se encerra como resposta definitiva, mas como provocação, denuncia mas também à caminhos possíveis que podem atravessar os muros que cercam as escolas ao não tratar temas como o HIV, a AIDS e pessoas soropositivas e tantos outros que fazem parte do cotidiano dos/as estudantes e escolas.

Ao evidenciarmos silenciamentos, estigmas e disputas de saber e poder que atravessam a escola e os corpos soropositivos, reafirmamos a urgência de uma educação comprometida com a vida, com o cuidado de si e com a promoção das diferenças.

Se os currículos têm funcionado como dispositivos que produzem silêncios sobre determinados temas, cabe à escola reinventá-los por espaços que promovam a vida para todas as pessoas. O currículo sorotransgressor não está colocado como uma prescrição e com intenção de ser um instrumento que apenas ensina a evitar o HIV, mas a viver com o HIV, a compreender e produzir práticas e relações menos violentas.

Nos propomos com esta pesquisa, contribuir para deslocar certezas, tensionar currículos e inspirar práticas pedagógicas que não apenas informem, mas também transformem, reconhecendo nas pessoas soropositivas não objetos de discurso, mas sujeitos de direitos, de saberes e de existência possíveis.



REFERÊNCIAS

“Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”. Caio Fernando Abreu

ARENDT, H. **Homens em tempos sombrios**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

ARAÚJO, O. S. **Alguns comentários sobre a syphilis no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Empresa Gráfica Editora Paulo Pongetti & Cia, 1928.

ANÔNIMO. Da frequência das moléstias syphiliticas no Rio de Janeiro e da necessidade de adoptarem-se medidas que attenuem seus estragos. **Gazeta Médica da Bahia**, Salvador, v. 5, n. 99 a 101. 1987.

A HUMAN RIGHTS WATCH. **Locked doors**: the human rights of people living with HIV/AIDS in China. 2003. Disponível em: <https://www.hrw.org/report/2003/09/02/locked-doors/human-rights-people-living-hiv/aids-china> Acesso em 1 agost. 2024.

ALMEIDA, V. J. B. de. Adeus Irmão, Durma Sossegado. **Biblioteca Nacional**. Rio de Janeiro, 1988. Disponível em: http://hshjovem.abiaids.org.br/wp-content/uploads/2017/08/AIDS_Peca1989.pdf Acesso em 22 nov. 2024.

ALMEIDA, A. N.; VILAR, D. **Literacia e práticas contraceptivas masculinas**. 2008. https://apf.pt/wp-content/uploads/2023/08/sex.plan_familiar_50_51.pdf#page=36

ABREU, C. F. de. **Pequenas epifanias**. Rio de Janeiro, Agir, 2006.

ADOBE. **Adobe Acrobat**. Software. [2017]. Disponível em: <https://helpx.adobe.com/br/acrobat/using/searching-pdfs.html#:~:text=Localizar%20e%20substituir%20texto%20em%20um%20PDF&text=O%20texto%20%C3%A9%20substitu%C3%ADdo%20uma,na%20barra%20de%20ferramentas%20Localizar>. Acesso em 5 dez. 2024.

ABIA. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. **Observatório Nacional de Políticas de AIDS**. [2010?]. Disponível: <https://abiaids.org.br/prevencao-tratamento-e-assistencia-visao-geral>. Acesso em 29 maio 2023.

ABIA. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. **Mito vs Realidade**: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e AIDS em 2016. 2016. Disponível e: http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Mito-vs-Realidade_HIV-e-AIDS_BRASIL2016.pdf Acesso em 20 mai. 2023.

ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M. G.; SILVA, L. B. da **Juventude e sexualidade**. Brasília: UNESCO Brasil, 2004.

ADEOYE-OLATUNDE, O. A.; Olenik N. L. Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. **J Am Coll Clin Pharm**, [S.l.], v. 4, p. 1358 - 1367,

2021Disponível em:

<https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jac5.1441> Acesso em 25 out. 2023.

ADJUNTO, Daniel. HIRABAHASI, Gabriel. Polícia Federal vê crime em fala de Bolsonaro sobre vacina e Aids. **CNN Brasil**. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/policia-federal-ve-crime-em-fala-de-bolsonaro-sobre-vacina-e-aids/> Acesso em 10 dez. 2025.

AGAMBEN, G. O que é um dispositivo? **Outra Travessia**, [S.l.], n. 5, 2005. DOI: <https://doi.org/10.5007/%25x> Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576> Acesso em: 10 dez. 2025.

ALVES, N. G.; SOARES, M. da C. S.; BERINO, A. de P. “Como e até onde é possível pensar diferente?” micropolíticas de currículos, poéticas, cotidianos e escolas-. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 27, 2012. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/24251>. Acesso em: 4 dez. 2025.

ALVES, N. G.; CAETANO, M.; SOARES, M. da C. S. IMAGENS: RESISTÊNCIAS E CRIAÇÕES COTIDIANAS. REMEA. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 04–07, 2020. DOI: 10.14295/remea.v0i0.11625. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/11625> Acesso em: 4 dez. 2025.

AGU, I. C. *et al.* Conceitos errôneos sobre transmissão, sintomas e prevenção do HIV/AIDS entre adolescentes no estado de Ebonyi, sudeste da Nigéria. **BMC Res Notes**, [S.l.], v. 13, n. 244, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05086-2>.

ANTENORE, Armando. Soropositivo diz que bispo o discriminou. **Folha de São Paulo**. São Paulo, 30 jul. 2000. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3007200016.htm>. Acesso em: 13 jun. 2024.

ALMIRANTE, J. Barreira de poder e intolerância: são 6 regiões separadas por muro no mundo. **Uol**, 20 set. 2022. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/09/20/uma-barreira-entre-nos-conheca-os-paises-separados-por-muros.htm> Acesso em 14 fev. 2025.

ARNAUD, A. A. Currículo paulista em transição: um estudo comparativo de sua implementação em 2008 e 2020. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 50, e278930, 2024. DOI <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202450278930>.

ARRUDA, D. C. B.; PEDROSA, L. G. B. Prevenção de hiv/aids na adolescência: revisão integartiva da literatura. **Revista foco**, São Paulo, v. 17, n. 11, p. e6598, 2024. DOI: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n11-238>.

ARROYO, M. G. **Currículo, território em disputa**. 5. ed. Petrópoles: Vozes, 2013.

AZEVEDO, R. Cartilha do governo Lula estimula alunos de 13 a 19 anos a narrar suas “transas”. **VEJA**. 7 fev. 2007. Disponível em:

<https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/cartilha-do-governo-lula-estimula-alunos-de-13-a-19-anos-a-narrar-suas-transas> Acesso em 19 nov. 2024.

AKWEH, T. Y. *et al.* Prevalência e fatores associados ao conhecimento do kit de autoteste de HIV e do autoteste de HIV entre mulheres ganenses: análises multiníveis usando a pesquisa demográfica e de saúde de Gana de 2022. **BMC Public Health**, [S.l.], v. 25, n. 1161, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21694-8>.

AYANO, K. *et al.* Conhecimento, atitude, prática e comportamentos de risco relacionados a infecções sexualmente transmissíveis entre estudantes de escolas preparatórias no oeste de Adis Abeba, Etiópia. **Discov Saúde Pública**, [S.l.], v. 22, n. 139, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00522-9>.

BBC NEWS BRASIL. **Índia x Paquistão: 3 questões para entender divisão dos 2 países há 75 anos e as consequências até hoje**. 15 ago. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62546859> Acesso em 14 fev. 2025.

BBC NEWS. **India minister vows to beat Aids**. 24 nov. 2003. Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3283895.stm Acesso em 01 agost 2024.

BBC News Brasil **Dilma determina suspensão de material de kit contra a homofobia**. 2011. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/05/110525_brasil_homofobia_rp Acesso em 15 set. 2025.

BALTAZAR, T. H. Os Saberes “Psi” No Diagnóstico De História Da Loucura De Michel Foucault. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 23, n. 3, p. 860-881, dez. 2017. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1677116820170003&lng=pt&rm=iso Acesso em 15 mai. 2024.

BENEVIDES, B. G. **Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2025**. Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2025. Disponível em: <https://antrabrasil.org/wp-content/uploads/2025/01/dossie-antra-2025.pdf> Acesso em 13 marc. 2025.

BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Ave Maria, 2012.

BIANCARELLI, A. 'Nunca usei camisinha', diz padre com Aids. **Folha de São Paulo**, 20 de abril de 1994.

BIANCARELLI, A. Maioria dos colégios não possui nenhum preparo para receber estudantes portadores do vírus HIV; situação é mais grave nas particulares - Escola não sabe conviver com criança com Aids. **Folha de São Paulo**. 1998. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff01119823.htm> Acesso em 10 set. 2025.

BOLL, J. Betinho: especialistas analisam causas do sociólogo e como ele faria a diferença hoje. **GSHOW**, São Paulo, 19 dez. 2023. Disponível em:

<https://gshow.globo.com/cultura-pop/series/noticia/betinho-especialistas-analisam-causas-do-sociologo-e-como-ele-faria-a-diferenca-hoje.ghtml> Acesso em 27 ago. 2024.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. São Paulo. Porto Editora, 2008.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Projetos Educacionais Especiais. **Diretrizes para uma política educacional em sexualidade**. Brasília, DF: MEC/SEPESE, 1994. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/725129/186688-me001753.pdf>. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais**: ensino médio – parte I: bases legais. Brasília, DF: MEC, 2000a.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais**: ensino médio – parte II: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, DF: MEC, 2000b.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais**: ensino médio – parte III: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília, DF: MEC, 2000c.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais**: ensino médio – parte IV: ciências humanas e suas tecnologias. Brasília, DF: MEC, 2000d.

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano nacional de educação**. Brasília, DF: MEC, 2001. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf>. Acesso em: 11 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. **Guia de prevenção das DST/Aids e cidadania para homossexuais**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Glossário do Ministério da Saúde**: projeto de terminologia em saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 6 dez. 2007a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 17 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Adolescentes receberão preservativos nas escolas**. Brasília, DF, 2007b. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/202-noticias/264937351/7548-sp-76895187>. Acesso em: 19 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. **Diretrizes para implantação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_implantacao_projeto_saude_prevencao_escolas.pdf. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Manual da aprendizagem**: o que é preciso saber para contratar o jovem aprendiz. Brasília, DF: MTE, 2009. Disponível em: https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/socioeducacao/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais. **Dados epidemiológicos de HIV/Aids no Brasil**: 1980 até junho de 2010. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://antigo.aids.gov.br/sites/default/files/campanhas/2010/45946/dados_aids_2010.pdf. Acesso em: 5 nov. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 13 dez. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>. Acesso em: 10 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica**. Brasília, DF: MEC, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Departamento passa a utilizar nomenclatura “IST” no lugar de “DST”**. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst>. Acesso em: 3 dez. 2024.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN)**. Brasília, DF: Senado Federal, 2017.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN)**. Brasília, DF: Senado Federal, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base nacional comum curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. **[Informação institucional]**. 2023a. Disponível em: <https://shre.ink/e8Le>. Acesso em: 3 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.004, de 21 de julho de 2023. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 jul. 2023b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.004-de-21-de-julho-de-2023-498447570>. Acesso em: 20 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim epidemiológico HIV e Aids 2024**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins->

[epidemiologicos/2024/boletim_hiv_aids_2024e.pdf/view#:~:text=O%20Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico%20de%20HIV,%2C%20regi%C3%B5es%2C%20estados%20e%20capitais.](#)
Acesso em: 10 jan. 2025.

BRASIL. Secretaria Especial de Comunicação Social. **Saúde na escola em São Paulo ganha mais de 460 mil estudantes no biênio 2023-2024**. Brasília, DF, 16 jan. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/saude-na-escola/2024/saude-na-escola-em-sao-paulo-ganha-mais-de-460-mil-estudantes-no-bienio-2023-2024>. Acesso em: 18 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim epidemiológico HIV e Aids 2025**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-hiv-e-aids-numero-especial-dez-2025.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). **Relatório de atividade coletiva na atenção básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: <https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/saude/RelSauAtivColetiva.xhtml>. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **HIV/Aids**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv>. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRITZMAN, D. P. Professor@s e Eros. **Educar em Revista**, [S.l.], n. 35, p. 53–62, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602009000300005>. Acesso em: 1 dez. 2025.

BRITZMAN, D. P. Curiosidade, Sexualidade e Currículo. *IN*: LOURO, Guacira Lopes. **O corpo educado** – pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 85-111.

BRITZMAN, D. P. O que é esta coisa chamada amor - Identidade homossexual, educação e currículo. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 21, n. 1, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71644>. Acesso em: 01 dez. 2025.

BARBOSA, A. J. G. **Inventario geral de atitudes quanto a educação inclusiva** – IGAEI. São Paulo: Autor, 2005.

BARRETO, E. S. S. Políticas de currículo e avaliação e políticas docentes. **Cadernos de Pesquisa**, [S.l.], v. 42. n. 147, p. 738-753, set./dez. 2012.

BELINA, A. "Semi-structured interviewing as a tool for understanding informal civil society". **Voluntary Sector Review**, [S.l.], v. 14, n. 2, 2023, p. 331-347. Disponível

em: <https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/vsr/14/2/article-p331.xml>. Acesso em: 25 out. 2023.

BOCKORNI, B. R. S; GOMES, A. F. A amostragem em snowball (bola de neve) em uma pesquisa qualitativa no campo da administração. **Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR**, Umuarama, v. 22, n. 1, p. 105-117, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/8346>. Acesso em 15 nov. 2023.

BORRILLO, D. **Homofobia**: história e crítica de um preconceito. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BUENO, S. M. V. Identificação dos problemas de sexualidade, DST, AIDS e drogas com diretores de escolas de 1º e 2º graus: contribuição de uma pesquisa-ação nessa área. **Brazilian Journal of Sexually Transmitted Diseases**, Niterói, v. 9, n. 2, p. 19–35, 1997. Disponível em: <https://www.bjstd.org/revista/article/view/177>. Acesso em: 10 sep. 2025.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2015.

BUTLER, J. **Vida precária**: os poderes do luto e da violência. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

BROWN, W. "CHAPTER SIX. Liberalism's Family Values". *States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton: Princeton University Press, 1995. DOI: <https://doi.org/10.1515/9780691201399-008>. Acesso em: 11 out. 2025.

BROWN, W. American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization. **Political Theory**, [S.l.], v. 34, n. 6, 690–714, 2006. <http://www.jstor.org/stable/20452506> Acesso em 11 out. 2025.

CNBB. **Pastoral da AIDS**. 2002. Disponível em: <https://cnbbeste2.org/pastoral-da-aids/>. Acesso em 13 jun. 2024.

CNN BRASIL. Há 40 anos, primeiros casos de Aids eram relatados nos EUA. **CNN Brasil**, 5 jun. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ha-40-anos-primeiros-casos-de-aids-eram-relatados-nos-eua/>. Acesso em: 17 dez. 2025.

CARRARA, S. The symbolic geopolitics of syphilis: an essay in historical anthropology. *História, Ciências, Saúde—Manguinhos*, [S.l.], v. III, n. 3, p. 391-408, nov. 1996/ Feb. 1997. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11625109/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

CARNEIRO, G.; PARAÍSO, M. A. O currículo das ruas: instâncias efêmeras, móveis e de luta pelo direito à cidade. *Série-Estudos. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB*, [S. l.], v. 27, n. 61, p. 165–185, 2022. DOI: 10.20435/serieestudos.v27i61.1730. Disponível em: <https://serie-estudos.ucdb.br/serie-estudos/article/view/1730>. Acesso em: 4 dez. 2025.

CALDAS, C. Ligeiras Considerações acerca das principaes theorias syphilographicas. **Gazeta Médica da Bahia**, Salvador, v. I, n. 5, p. 8- 14, 1986.

CASTRO, C. A. *et al.* Knowledge and attitudes regarding contraceptive methods and sex education in students and parents of eight Colombian schools 2020-2021: a mixed methods study. **Lancet Reg Health Am.** [S.l.], v. 29, n. 30, jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2024.100678>.

CANTO, A. **Cartas para além dos muros**. Direção: André Canto. Brasil: Netflix, 2019. Documentário.

CAZUZA. **O tempo não pára**. Diretores Sandra Werneck e Walter Carvalho. Produtor Daniel Filho. Brasil, Amazon Prime, 2004.

CAZANATTO, E.; MARTTA, M. K.; BISOL, C. A. A Escuta Clínica Psicanalítica em uma Instituição Pública: Construindo Espaços. **Psicologia: Ciência e Profissão**, [S.l.], v. 36, n. 2, p. 486–496, abr. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703000742014>.

CAETANO, M. **Performatividades reguladas**: heteronormatividade, narrativas biográficas e educação. 1. ed. Curitiba: Appris, 2016.

CAETANO, M. R. V. Rodrigues, A. SILVA, C. N. A mobilização social e resposta comunitária LGBT à AIDS – itinerários reflexivos. **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, Canoas, v. 8, n. 1, 2019. DOI: 10.35819/tear.v8.n1.a3405. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/3405> Acesso em: 30 maio. 2025.

CAETANO, M.; JUNIOR, P. M. da S.; TREYCE E. S. G. Quando os arranjos familiares e as masculinidades entram em questão na escola. *In*: ALÓS, Anselmo Peres (org.). **Poéticas da masculinidade em ruínas**: o amor em tempos de Aids. Santa Maria: UFSM, PPGL, 2017.

CASTRO, M. Avaliação de desempenho final dos professores estaduais de São Paulo 2025: cronograma, feedbacks e decisões cruciais na SED. **Farol Pedagógico**, [S.l.], 27 nov. 2025. Disponível em: <https://www.farolpedagogico.com.br/2025/11/avaliacao-de-desempenho-final-dos.html>. Acesso em: 31 mar. 2026.

CERVO, A. L. *et al.* **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007.

CEGALLA, D. P. **Minigramática da língua portuguesa**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2020.

CIAMPI, H. *et al.* O currículo bandeirante: a proposta curricular de história no estado de São Paulo, 2008. **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 29, n. 58, p. 361-382, dez. 2009. Disponível em: <http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/5356>. Acesso em: 13 dez. 2025.

CONNELL, R. **Gênero em termos reais**. São Paulo: nVersos, 2016.

CHAN, C. T. *et al.* Associations between state-level high school HIV education policies and adolescent HIV risk behaviors. **Journal of School Health**, [S.l.], v. 92, n. 3, p. 316–324, mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/josh.13130>.

COSGROVE, B. The photo that changed the face of AIDS. **LIFE.com**, 11 jan. 2014. Disponível em: <https://www.life.com/history/behind-the-picture-the-photo-that-changed-the-face-of-aids/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

COLOMBO, M.; MENDONÇA, E.; PIERIN, E. Vídeo mostra alunos de escola cívico-militar cantando música com apologia à violência. **G1**, 1 dez. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2025/12/01/video-alunos-parana-apologia-violencia-colegio-civico-militar.ghtml>. Acesso em: 20 out. 2025.

COSTA, M. V. Introdução: novos olhares para a pesquisa em educação. In: COSTA, M. V. (org.). **Caminhos investigativos I: novos olhares para a pesquisa em educação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
CURSO ZERO DISCRIMINAÇÃO. Disponível em: <https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=198>. Acesso em: 26 maio 2023.

CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres. **Revista Brasileira de Educação**, [S.l.], v. 17, n. 49, p. 11–37, jan. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/nDS3v6XBFdjG3jQGLRk687m/?lang=pt>. Acesso em: 10 set. 2025.

CORREIO BRAZILIENSE. **Soropositivos discriminados**. 29 nov. 2009. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2009/11/29/interna-brasil,157737/soropositivos-discriminados.shtml>. Acesso em: 20 nov. 2024.

CHORUMA, D. J.; CHORUMA, S. D.; PASIRAYI, R. M. Catch them young: knowledge and awareness levels of HIV and AIDS transmission among high school students in Harare, Zimbabwe. **African Journal of AIDS Research**, [S.l.], v. 20, n. 3, p. 224–231, out. 2021. DOI: <https://doi.org/10.2989/16085906.2021.1979060>.

CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. **Designing and conducting mixed methods research**. 3. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018. Disponível em: <http://bayanbox.ir/view/236051966444369258/9781483344379-Designing-and-Conducting-Mixed-Methods-Research-3e.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2025.

CHORY, A. *et al.* Perspectivas de partes interessadas do setor educacional sobre um módulo de treinamento de professores para reduzir o estigma do HIV/AIDS no oeste do Quênia. **BMC Public Health**, [S.l.], v. 21, p. 1281, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11331-5>.

CORAZZA, S. M. Diferença pura de um pós-curriculo. In: LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. **Currículo: debates contemporâneos**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

DA REDAÇÃO. Casos de AIDS preocupam o Vaticano. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 1 abr. 2001. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0104200105.htm>. Acesso em: 9 ago. 2024.

DAFLON, V. T.; CARVALHAES, F.; FERES, J. Sentindo na pele: percepções de discriminação cotidiana de pretos e pardos no Brasil. **Dados**, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 293–330, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/001152582017121>.

DAVIS, A. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DECKER, M. J. *et al.* Youth perceptions and concerns about sexually transmissible infections versus pregnancy: a qualitative comparative study in California. **Sexual Health**, [S.l.], v. 19, n. 5, p. 439–447, out. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1071/SH22037>.

DELEUZE, G. **Foucault**. São Paulo: Brasiliense, 2005.

DELEUZE, G. Que es un dispositivo? *In*: GOTS, Barbara; BALBIER, E. *et al.* **Michel Foucault filósofo**. Madrid: Gedisa, 1990.

DENTZ, V. V. **As tendências pós-críticas na pesquisa em educação**: análise filosófica e crítica ontológica. 2015. 393 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.

DENZIN, N. K.; GIARDINA, M. D. **Qualitative inquiry through a critical lens**. New York: Routledge, 2016.

DÍALOGOS DA FÉ. Bolsonaro e o discurso terrivelmente (anti)cristão sobre o HIV/aids. **CartaCapital**, 10 fev. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/bolsonaro-e-o-discurso-terrivelmente-anticristao-sobre-o-hiv-aids/>. Acesso em: 20 mar. 2024.

DÍAZ, E. **A filosofia de Michel Foucault**. 1. ed. São Paulo: Unesp, 2012.

DIMARA, Y. I. O.; YULIANI, Sri; HARYATI, Rina Herlina. Literature review of HIV/AIDS education literacy in Indonesia. **E3S Web of Conferences**, v. 593, p. 04001, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459304001>.

DIVULGAÇÃO. Ministério da Saúde vai pôr 400 máquinas de camisinha em escolas. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 27 jun. 2008. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2706200807.htm>. Acesso em: 27 ago. 2024.

DIVULGA SAÚDE. **Painel de monitoramento do Programa Saúde na Escola (PSE)**. [2020?]. Disponível em: <https://www.divulgasaude.com.br/pse/>. Acesso em: 7 nov. 2025.

DO ENVIADO A INDAIATUBA. Seminários podem fazer exame de HIV. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 15 jun. 2000. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1506200028.htm>. Acesso em: 13 jun. 2024.

DUTRA, M. R. O. Pós-estruturalismo e pesquisa: algumas pistas para investigação em educação ambiental. **Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental**, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 159–170, 2010. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/1142>. Acesso em: 24 out. 2023.

ERIBON, D. Michel Foucault: 1926–1984. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

EWING, S. W.; BRYAN, A. D. A question of love and trust? The role of relationship factors in adolescent sexual decision making. **Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics**, [S.l.], v. 36, n. 8, p. 628–634, out. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1097/DBP.000000000000190>.

ENEJI. Sources of awareness of HIV/AIDS prevalence among secondary school students in Southern Cross River State, Nigeria. **Journal of Educational and Social Research**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 137, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0073>.

ELACQUA, G.; DIAS, I.; NASCIMENTO, D.; PÉREZ-NÚÑEZ, G.; RODRIGUES, M. O círculo vicioso da desigualdade racial na educação do Brasil. 2024. Disponível em: <https://publications.iadb.org/pt/o-circulo-vicioso-da-desigualdade-racial-na-educacao-do-brasil>. Acesso em: 10 dez. 2025.

FAUBION, J. Michel Foucault. **Encyclopaedia Britannica**, 6 dez. 2025. Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/Michel-Foucault>. Acesso em: 10 dez. 2025.

FERNANDES, N. L.; ALMEIDA, R. B. de. A conjuntura política e embates das diretrizes curriculares nacionais e da Base Nacional Comum Curricular: contextualização histórica, social e econômica do currículo no Brasil. In: LIBÂNEO, J. C.; ROSA, S. V. L.; ECHALAR, A. **Didática e formação de professores**: embates com as políticas curriculares neoliberais. Goiânia: Cegraf UFG, 2022. p. 18–26. Disponível em: https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/edipe2_ebook/artigo_02.html.

FERRAZ, D.; MENDES, M. C. Filosofias da linguagem pós-estruturalistas e decolonialidades: contribuições para a formação docente? **Revista Odisseia**, Natal, v. 6, n. 2, p. 107–126, jul./dez. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/23227>. Acesso em: 23 out. 2023.

FERRARI, A.; SEFFNER, F. “A morte e a morte” dos homossexuais. **Revista Gênero**, [S.l.], v. 10, n. 1, 2009. DOI: <https://doi.org/10.22409/rq.v10i1.48>. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/30895>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERRARI, A.; CASTRO, R. P. de. Diferenças, sexualidades e subjetividades em jogo no contexto escolar. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 40, p. 56–71, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/24550>. Acesso em: 27 nov. 2025.

FERRARI, A. A cidade e o conservatório na construção de sujeitos. **Educação em Foco**, [S.l.], v. 23, n. 2, p. 430–451, 2018. DOI: <https://doi.org/10.34019/2447-5246.2018.v23.19892>. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/index.php/edufoco/article/view/19892>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERRARI, A. A “peste rosa” nas produções dos grupos gays e seus impactos na construção das homossexualidades masculinas. **Historiae**, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 8–29, 2023. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/hist/article/view/12856>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERRARI, A. Estranhos... abjetos... cobiçados... construídos: corpos, desejos e educação. **Educação e Pesquisa**, [S.l.], v. 41, n. esp., p. 1521–1526, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201508143139>. Acesso em: 1 dez. 2025.

FERREIRA, F. H.; SILVA, A. F. G. da. O currículo paulista (2020) como arquitetura ontológica: uma análise crítica freireana. **EccoS – Revista Científica**, [S.l.], n. 69, e25438, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n69.25438>. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/25438>. Acesso em: 10 nov. 2025.

FERREIRA, P. GRANDELLE, R. Bolsonaro sugere que pais rasquem páginas sobre educação sexual de caderneta de Saúde da Adolescente. O GLOBO, 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-sugere-que-pais-rasquem-paginas-sobre-educacao-sexual-de-caderneta-de-saude-da-adolescente-23506442>. Acesso em 10 nov. 2024.

FERRARI, A.; CASTRO, R. P. de. “Saí da minha zona de conforto pela primeira vez sem perceber”: subjetividade, verdade e cuidado de si. **Educação e Filosofia**, Uberlândia, v. 38, p. 1–26, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.v38a2024-68092>. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/68092>. Acesso em: 4 dez. 2025.

FERRARI, A.; CASTRO, R. P. de; BASTOS, F. Marcas inscritas nos muros da escola: imagens, educação e vidas precárias. **Educação & Sociedade**, [S.l.], v. 42, e231389, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES.231389>.

FINKELSTEIN, A. **After silence**: a history of AIDS through its images. Berkeley: University of California Press, 2017.

FIOCRUZ. Centro de Informação em Saúde Silvestre. **A peste**. 2022. Disponível em: <https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/peste>. Acesso em: 5 nov. 2025.

FONSECA, L. N. (coord.). **Poéticas de vida**: escritas de si(da). São Paulo: Monstra, 2022.

FONSECA, B. S. *et al.* “Uma parte de mim sabia que isso aconteceria um dia”: vivências de jovens com HIV/aids. **Saúde em Debate**, [S.l.], v. 48, n. 141, e8986, 2024. Disponível em: <https://www.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/8986>.

FORSTEIN, M. AIDS: a history. **Journal of Gay & Lesbian Mental Health**, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 40–63, 2012. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19359705.2013.740212>. Acesso em: 10 fev. 2024.

FOUCAULT, M. A conversation with Michel Foucault. **Partisan Review**, [S.l.], v. 38, n. 2, p. 192–201, 1971. Disponível em: <https://open.bu.edu/bitstreams/661b5fd5-3019-49fc-be85-d5bcd69b738/download>. Acesso em: 5 jan. 2025.

FOUCAULT, M. Michel Foucault à propos de l'école. Entrevista concedida a Jacques Chancel. **Radioscopie**, [S.l.], 10 abr. 1975. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VjsHyppHiZM>. Acesso em: 6 fev. 2025.

FOUCAULT, M. **As palavras e as coisas**. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FOUCAULT, M. **Ditos e escritos V**: ética, sexualidade e política. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

FOUCAULT, M. **Tecnologías del yo**. Buenos Aires: Paidós, 2008.

FOUCAULT, M. **Os anormais**: curso no Collège de France (1974–1975). São Paulo: Martins Fontes, 2010a.

FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. 3ªed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010b.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**. 24. ed. São Paulo: Loyola, 2014a.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2014b.

FOUCAULT, M. **A arqueologia do saber**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015a.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade 1**: a vontade de saber. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015b.

FOUCAULT, M. **A sociedade punitiva**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015c.

FOUCAULT, M. **História da loucura na Idade Clássica**. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.

FOUCAULT, M. **O nascimento da clínica**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2021.

FOUCAULT, M. **Dizer a verdade sobre si**. São Paulo: Ubu, 2022a.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da biopolítica**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2022b.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade 2**: o uso dos prazeres. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024a.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade 3: o cuidado de si**. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024b.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. 18. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2025a.

FOUCAULT, M. **O que é a crítica?** São Paulo: Ubu, 2025b.

FOLHA DE S. PAULO. **SP teve caso semelhante em 92**. 29 jun. 1995. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/6/29/cotidiano/5.html>. Acesso em: 16 set. 2025.

FUCHS, S. S.; ZORNIG, S. A escuta analítica: corpo, afeto e palavra. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 340–352, dez. 2013. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682013000300002. Acesso em: 8 nov. 2023.

FRANCISCO, L. Pais-de-santo querem evitar AIDS em candomblé da Bahia. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 31 out. 2002. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u61967.shtml>. Acesso em: 14 jun. 2024.

FRANCIS, D. A. ‘And I would ask myself, what’s being gay got to do with this anyway?’ Constructions of queer subject positions in students’ stories. **Education, Citizenship and Social Justice**, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 59–70, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1177/17461979211048670>.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, P. **Entrevista à ABIA**. 1993. Disponível em: <https://abiaids.org.br/boletim-abia-no-20-tudo-o-que-e-solido-desmancha-no-ar/>. Acesso em: 18 out. 2025.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GALLO, R. C. **Virus hunting**. New York: Basic Books, 1991.

G1. **Justiça determina que “BBB 10” esclareça como se contrai o vírus HIV**. São Paulo, 2010. Disponível em: https://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1549511-7084_00-JUSTICA+DETERMINA+QUE+BBB+ESCLARECA+COMO+SE+CONTRAI+O+VIRUS+HIV.html. Acesso em: 30 nov. 2024.

G1. **Turma da Mônica ganha dois personagens soropositivos**. 18 set. 2012. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/09/turma-da-monica-ganha-dois-personagens-soropositivos.html>. Acesso em: 19 nov. 2024.

G1. **Bolsonaro ataca vacinação infantil contra Covid e espalha desinformação sobre mortes de crianças**. G1, São Paulo, 6 jan. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/01/06/bolsonaro-ataca-vacinacao-infantil-contr>

[covid-e-espalha-desinformacao-sobre-mortes-de-criancas.ghtml](#). Acesso em: 22 abr. 2026.

GRUPO GAY DA BAHIA. **Observatório 2024 de mortes violentas de LGBTQ+ no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://grupogaydabahia.com.br/mortes-violentas-de-lgbt-no-brasil-2024/>. Acesso em: 10 out. 2025.

GAO, X. *et al.* Effectiveness of school-based education on HIV/AIDS knowledge, attitude, and behavior among secondary school students in Wuhan, China. **PLoS One**, [S.l.], v. 7, n. 9, e44881, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044881>.

GARCIA, V. da C.; NORONHA, A. M. Plataformização da educação na rede estadual de São Paulo: a perspectiva dos estudantes do Ensino Médio. **Contraponto: Discussões científicas e pedagógicas em Ciências, Matemática e Educação**, v. 6, n. 10, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.21166/ctp.v6i10.6647>. Acesso em: 23 abr. 2026

GAZETA DO POVO. **Em reação ao governo Lula, 19 estados decidem manter escolas cívico-militares**. 14 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/reacao-lula-19-estados-manter-escolas-civico-militares/>. Acesso em: 20 out. 2025.

GESSER, V. A evolução histórica do currículo: dos primórdios à atualidade. **Revista Contrapontos**, Itajaí, v. 2, n. 4, p. 69–81, jan./abr. 2002. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rc/article/view/135>. Acesso em: 13 abr. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GONÇALVES, A. S.; GONÇALVES, E. S.; FERREIRA, S. A. Dialogando com as questões étnico-raciais nas escolas do ensino fundamental II de Rio Branco: nas vozes dos alunos. **Revista Em Favor de Igualdade Racial**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 2–16, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/R FIR/article/view/1986>. Acesso em: 9 set. 2025.

GOMES FILHO, M. **(Homo)sexualidades e Foucault: para o cuidado de si**. Curitiba: Appris, 2016.

GOVENDER, K. *et al.* Prevenção do HIV em adolescentes e jovens na região da África Oriental e Austral: uma revisão dos principais desafios. **Open AIDS Journal**, [S.l.], v. 12, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.2174/1874613601812010053>.

GUIBERT, H. **Para o amigo que não me salvou a vida**. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995.

GUIMARÃES, M. D. C. *et al.* Mortalidade por HIV/Aids no Brasil, 2000–2015: motivos para preocupação? **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S.l.], v. 20, p. 182–190, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/pgSCPk9DBgTpvK7mrTTjH4j/>. Acesso em: 4 nov. 2015.

GOOGLE FORMS. **Google Forms**. [2020?]. Disponível em: <https://sites.google.com/view/forms-workspace/home>. Acesso em: 15 jun. 2023.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar**: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record, 2013.

GRMEK, M. D. **Histoire du sida**. Paris: Payot, 1989.

GRMEK, M. D. O enigma do aparecimento da AIDS. **Estudos Avançados**, [S.l.], v. 9, n. 24, p. 229–239, 1994. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/brJ7VxNXZn9FYByb6QCGsdj/>. Acesso em: 6 nov. 2024.

GROS, Frédéric. **Desobedecer**. São Paulo: Ubu, 2018.

GIRON, L. A. **Michel Foucault**: trinta anos de influência. Instituto Humanitas Unisinos, 21 jul. 2014. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/noticias/533383-trinta-anos-de-influencia>. Acesso em: 10 dez. 2025.

GOMES, N. L. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. **Currículo sem Fronteiras**, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 98–109, 2012. Disponível em: <https://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.htm>. Acesso em: 11 nov. 2025.

GILEAD SCIENCES. **Gilead sciences announces fourth quarter and full year 2024 financial results**. 2024. Disponível em: <https://www.gilead.com/news/news-details/2025/gilead-sciences-announces-fourth-quarter-and-full-year-2024-financial-results>. Acesso em: 29 dez. 2025.

HABIB, A.; GOSWAMI, K.; OJAH, J. *et al.* Knowledge and attitudes about HIV/AIDS among adolescent students in 15–19 years age group based on the adolescent education programme: a cross-sectional study conducted in Kamrup (Metro), Assam. **Cureus**, [S.l.], v. 16, n. 6, e62122, 2024. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.62122>.

HERMINDA, P. M. V.; ARAÚJO, I. E. M. Elaboração e validação do instrumento de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 59, n. 3, p. 314–320, maio/jun. 2006.

HOUAISS. **Dicionário conciso**. São Paulo: Moderna, 2011.

HOLOCAUST ENCYCLOPEDIA. **Classification system in Nazi concentration camps**. [2020?]. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/classification-system-in-nazi-concentration-camps>. Acesso em: 5 jan. 2025.

HORROCKS, C.; JEVTIC, Zoran. **Entendendo Foucault**: um guia ilustrado. São Paulo: LeYa, 2013.

HOOKS, B. **E eu não sou uma mulher? Questões feministas**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2019.

INFO AIDS. **InfoAIDS**. [2020?]. Disponível em: <https://imediata.org/infoaids/>. Acesso em: 13 maio 2024.

INDICADORES E DADOS BÁSICOS DO HIV/AIDS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS: DADOS REGIONAIS E NACIONAIS. [2020?]. Disponível em: <https://indicadores.aids.gov.br/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

INMAN, E. M. *et al.* Estigma, saúde e violência do HIV: um estudo longitudinal entre adolescentes do sexo masculino com HIV em Soweto, África do Sul. **AIDS and Behavior**, [S.l.], v. 28, p. 3197–3204, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10461-024-04407-x>.

INAYAT ALI, A.; AZAM, I.; TIKMANI, S. S.; SALEEM, S. Sexual and reproductive health knowledge, attitudes and practices among adolescents in rural Thatta, Pakistan: a cross-sectional study. **BMJ Open**, [S.l.], v. 15, n. 4, e096404, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-096404>.

JACOBI, C. A. *et al.* “My friend with HIV remains a friend”: HIV/AIDS stigma reduction through education in secondary schools—A pilot project in Buea, Cameroon. **Journal of the International Association of Providers of AIDS Care**, [S.l.], v. 19, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1177/2325958219900713>.

JAVED, S. *et al.* Conhecimento e atitude em relação ao HIV/AIDS no Paquistão: uma revisão sistemática. **Discover Public Health**, [S.l.], v. 22, p. 387, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00798-x>.

JOHNSON, R. B.; ONWUEGBUZIE, A. J.; TURNER, L. A. Toward a definition of mixed methods research. **Journal of Mixed Methods Research**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 112–133, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>.

JOHNSON, Corey W.; PARRY, Diana C. **Fostering social justice through qualitative inquiry: a methodological guide**. 2. ed. New York: Routledge, 2022.

JODELET, D. **Les représentations sociales**. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

JOSHI, P. HIV+ students denied entry to school in Beed. **The Times of India**, 2023. Disponível em: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/hiv-students-denied-entry-to-school-in-beed/articleshow/101512926.cms>. Acesso em: 5 dez. 2025.

JUNQUEIRA, R. D. “A homofobia não é um problema. Aqui não há gays nem lésbicas!” 2010. Disponível em: <https://revpsico-unesp.org/index.php/revista/article/view/114>. Acesso em: 29 nov. 2025.

KAKILLA, C. **Strengths and weaknesses of semi-structured interviews in qualitative research: a critical essay**. Preprints, 2021, 2021060491. Disponível em: <https://www.sciencegate.app/document/10.20944/preprints202106.0491.v1>. Acesso em: 24 out. 2023.

KARIMI, K. *et al.* Assessing HIV transmission knowledge and rapid test history among the general population in Iran. **Scientific Reports**, [S.l.], v. 15, p. 4944, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-88844-1>.

KANYAMA, A. Y.; LYAKURWA, S. E. Self-awareness life skills and risky sexual behaviours among primary schools adolescents in Tanzania. **Health Education**, [S.l.], v. 125, n. 4, p. 507–534, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1108/HE-01-2025-0013>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965428325000063>.

KNAUTH, D. R.; PILECCO, F. B. Aids e prevenção do HIV entre adolescentes e jovens em seis municípios brasileiros. **Saúde e Sociedade**, [S.l.], v. 33, n. 1, e230789pt, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/MKQTf5z7KLwZM9wYBYHgMdF/>. Acesso em: 5 jan. 2025.

KRENAK, A. **A vida não é útil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

LAVILLE, C.; DIONNE, J. **A construção do saber**: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

LAWRENCE, S. E.; WATSON, R. J.; GOWER, A. L.; RIDER, G. N.; MACAPAGAL, K.; RUSSELL, S. T.; EISENBERG, M. E. HIV prevention behaviors among LGBTQ+ adolescents: the protective role of LGBTQ+-inclusive school resources. **Preventive Science**, [S.l.], v. 26, n. 3, p. 438-448, abr. 2025. DOI: 10.1007/s11121-025-01799-7.

LAPLANCHE, J. **Vocabulário da psicanálise**. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

LEWTHWAITE, P.; WILKINS, E. Natural history of HIV/AIDS. **Revista Elsevier Medicine**, [S.l.], v. 37, n. 7, p. 333-337, jul. 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1357303909001297>. Acesso em: 15 mai. 2024.

LEE, R.; CARVALHO, R. de. **Vírus do amor**. EMI Records Ltda / Universal Music International Ltda, 1985.

LEIGHTON, K.; KARDONG-EDGREN, S.; SCHNEIDEREITH, Tonya; FOISY-DOLL, Colette Faan. Using social media and snowball sampling as an alternative recruitment strategy for research. **Clinical Simulation in Nursing**, [S.l.], v. 55, p. 37-42, 2021. DOI: 10.1016/j.ecns.2021.03.006. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876139921000360>. Acesso em: 15 nov. 2023.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, [S.l.], v. 140, p. 1-55, 1932.

LYS, C. L.; LOGIE, C. H.; LAD, A.; SOKOLOVIC, N.; MACKAY, K. I.; HASHAM, A.; MALAMA, K. Human immunodeficiency virus prevention outcomes associated with arts-based sexual health workshop participation among Northern and Indigenous

adolescents in the Northwest Territories, Canada. **International Journal of STD & AIDS**, [S.l.], v. 35, n. 6, p. 438-445, maio 2024. DOI: 10.1177/09564624241226995.

LOURO, G. L. Currículo, gênero e sexualidade – o ‘normal’, o ‘diferente’ e o ‘excêntrico’. In: LOURO, Guacira Lopes; FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre. **Corpo, gênero e sexualidade** – um debate contemporâneo na educação. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista**. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

LOURO, G. L. **Um corpo estranho**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

LOPES, A. C.; MACEDO, E. O pensamento curricular no Brasil. In: LOPES, A. C.; MACEDO, E. **Currículo: debates contemporâneos**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

LLEWELLYN, A. ‘Sir, if I let you blow me, will you not put a behaviour point on?’ The working-class, gay teacher and the limits of neoliberal inclusion. **Education, Citizenship and Social Justice**, [S.l.], out, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/17461979241290159>.

MANN, J.; TARANTOLA, D. J. M.; NETTERS, T. W. **Aids in the world: a global report**. 1. ed. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992.

MARQUEZ, G. G. **Cem anos de solidão**. 97. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MACHADO, R. **Foucault a ciência e o saber**. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

MACEDO, M. M. K.; FALCÃO, C. N. de B. A escuta na psicanálise e a psicanálise da escuta. **Revista Psychê**, São Paulo, v. IX, n. 15, p. 65-76, jan./jun. 2005. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-11382005000100006. Acesso em: 8 nov. 2023.

MACEDO, E. F. de. Parâmetros Curriculares Nacionais: a falácia de seus temas transversais. In: SILVA, A. F. B. (org.). **Currículo: políticas e práticas**. Campinas, SP: Papirus, 1999.

MACEDO, E. Currículo e conhecimento: aproximações entre educação e ensino. **Cadernos de Pesquisa**, [S.l.], v. 42, n. 147, p. 716–737, dez. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742012000300004>.

MACEDO, E. Base Nacional Comum para Currículos: direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem?. **Educação & Sociedade**, [S.l.], v. 36, n. 133, p. 891–908, out. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015155700>.

MACEDO, E. Base Nacional Curricular Comum: novas formas de sociabilidade produzindo sentidos para educação. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 12, n. 03, p. 1530-1555, out./dez. 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/21666>. Acesso em: 9 nov. 2025.

MANZINI, J. E. Uso da entrevista em dissertações e teses produzidas em um programa de pós-graduação em educação. **Revista Percurso**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 149-171, 2012. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/49548>. Acesso em: 21 out. 2023.

MANFRÉ, A. H. A educação no governo dos corpos: empreendedorismo e projeto de vida: Education in the governance of bodies: entrepreneurship and life project. **Revista Cocar**, [S. l.], v. 18, n. 36, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/6108>. Acesso em: 20 dez. 2025.

MANYERERE, D. J. Juventude da Tanzânia e mídias sociais: percepções, experiências e implicações para violações de direitos humanos. **Revista Internacional de Adolescência e Juventude**, [S.l.], v. 30, n. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2506665>.

MÁXIMO JUNIOR, N.; ORLANDI, R.; BRONDANI, P. B.; OLIVEIRA, A. S. A temática HIV/AIDS e os medicamentos antirretrovirais no Ensino Médio: o entretecer da educação sexual e o ensino de química. **Revista de Ensino de Bioquímica**, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 52–78, 2019. DOI: <https://doi.org/10.16923/reb.v17i2.842>.

MEDEIROS, C. S. de. #DIFERENÇA: imagens dentrofora da escola. **e-Mosaicos**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 15, p. 115–127, 2018. DOI: 10.12957/e-mosaicos.2018.34200. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/e-mosaicos/article/view/34200>. Acesso em: 4 dez. 2025.

MEREU, A.; LIORI, A.; FADDA, L.; PUDDU, M.; CHESSA, L.; CONTU, P.; SARDU, C. What do young people know about HIV? Results of a cross sectional study on 18-24-year-old students. **J Prev Med Hyg**, [S.l.], v. 63, n. 4, E541–E548, 2022. DOI: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.4.2555.

METHAZIA, J. J.; BESSENAAR, T. P.; BAUM, S. E. “Nós nos concentramos principalmente na prevenção da gravidez, não na prevenção do HIV ...”: percepções e prioridades dos jovens na prevenção da gravidez não planejada e do HIV. **African Journal of AIDS Research**, [S.l.], v. 23, n. 1–2, p. 1–11, 2024. <https://doi.org/10.2989/16085906.2023.2279646>.

MANUAL MSD. **Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)**. [2020?]. Disponível em: [https://www.msdmanuals.com/pt/professional/searchresults?query=infec%a7%a3o+pelo+v%a3adrus+da+imunodefici%a3aancia+humana+\(hiv\)&icd9=042%3bv01.79%3bv08%3bmm462](https://www.msdmanuals.com/pt/professional/searchresults?query=infec%a7%a3o+pelo+v%a3adrus+da+imunodefici%a3aancia+humana+(hiv)&icd9=042%3bv01.79%3bv08%3bmm462).

MCGLASHAN, F. H.; UASIKE, A. J. M. Māori and Pacific student’s resistance to colonial cis-heteronormative discourse within high schools in Aotearoa, New

Zealand. **Curriculum Studies in Health and Physical Education**, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 234–253, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/25742981.2024.2355467>.

MEMÓRIA GLOBO. **Descoberta e desdobramentos da AIDS**. 2021a. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/descoberta-e-desdobramentos-da-aids/noticia/descoberta-e-desdobramentos-da-aids.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MEMÓRIA GLOBO. **Lauro Corona**. 2021b. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/perfil/lauro-corona/noticia/lauro-corona.ghtml>. Acesso em: 27 ago. 2024.

MEMÓRIA GLOBO. **Séries que marcaram o “Bom Dia São Paulo”**. 2021c. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/bom-dia-sao-paulo/noticia/series.ghtml>. Acesso em: 17 dez. 2025.

MEMÓRIA GLOBO. **Sandra Bréa**. 2024. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/perfil/sandra-brea/noticia/sandra-brea.ghtml>. Acesso em: 27 ago. 2024.

MEMÓRIA GLOBO. **Aids: primeiras reportagens no país**. 2023. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/fantastico/reportagens/noticia/aids-primeiras-reportagens-no-pais.ghtml>. Acesso em: 10 jun. 2024.

MEMÓRIAS DA DITADURA. **Guerra fria (S/A)**. [200?]. Disponível em: <https://memoriasdeditadura.org.br/guerra-fria/>. Acesso em: 6 nov. 2025.

MEMÓRIAS DA DITADURA. **O Golpe civil-militar no Brasil**. [200?]. Disponível em: <https://memoriasdeditadura.org.br/o-golpe-civil-militar-no-brasil/>. Acesso em: 6 nov. 2025.

MORAIS, J. S. Aprendizagens narrativas na tessitura de outros currículos possíveis com professoras/es iniciantes: movimentos de uma pesquisa formação. **Revista e-Curriculum**, [S. l.], v. 21, p. e59682, 2023. DOI: 10.23925/1809-3876.2023v21e59682 Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/59682> Acesso em: 20 dez. 2025.

MOREIRA, A. F. B. Propostas curriculares alternativas: limites e avanços. **Educação & Sociedade**, [S.l.], v. 21, n. 73, p. 109–138, dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/z6LyF7Zs6xKpJmYxBzLFxZx/?format=html&lang=pt> Acesso em 3 set. 2025.

MOREIRA, A. F. B. IDENTIDADES, SABERES E PRÁTICAS. **Educação e Filosofia**, Uberlândia, v. 20, n. 40, p. 137–157, 2008. DOI: 10.14393/REVEDFIL.v20n40a2006-245. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/245> Acesso em: 27 nov. 2025.

MOREIRA, A. F. B.; TADEU, T. **Currículo, cultura e sociedade**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

MOREIRA, A. F. B. Os parâmetros curriculares nacionais em questão. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 21, n. 1, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71637>. Acesso em: 10 nov. 2025.

MORAES, M. C. M. Os “pós-ismos” e outras querelas ideológicas. **Perspectiva**, Florianópolis, n. 24, p. 45-59, jan./jun. 1996.

MOREY, M. Introducción. *IN: FOUCAULT, Michel. Tecnologías del yo*. 1. ed. Buenos Aires: Paidós, 2008.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. “Produção didática e de literatura infantil”. *In: MONARCHA, C.; LOURENÇO FILHO, Ruy (org.). Por Lourenço Filho: uma biobibliografia*. Brasília, INEP, 2001. p. 127-134.

ONU. Organização das Nações Unidas. **A agenda 2030**. Brasília: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, M. R. G. A cobaia agora é você! Cisgeneridade branca, como conceito e categoria de análise, nos estudos produzidos por travestis e mulheres transexuais. Caderno **Espaço Feminino**, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 157–178, 2023. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/nequem/article/view/69857>. Acesso em: 21 jul. 2023.

OLIVEIRA, F. E. S.; MARQUES, R. C. P.; SANTOS, P. C. Educação e sexualidade: percepção de escolares do ensino médio sobre infecção e prevenção do HIV. **EDUCERE - Revista da Educação da UNIPAR**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 921–939, 2023. DOI: 10.25110/educere.v23i2.2023-025. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/10489>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OMOTE, S. A construção de uma escala de atitudes sociais em relação a inclusão: notas preliminares. **Revista Brasileira de Educação Especial**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 33–47, 2005. Disponível em: <https://www.abpee.net/pdf/artigos/art-11-1-3.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2023.

ORJI, M. L. C. *et al.* Avaliação da adequação e dos determinantes do conhecimento relacionado ao HIV entre alunos do ensino médio em escolas públicas em Abakaliki, sudeste da Nigéria. **Sci Rep**, [S. l.], v. 15, p. 1254, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81582-w>.

OBSERVATÓRIO DA TV. **Triste**: Ator do Castelo Rá-Tim-Bum morreu cedo demais em meio às gravações da série. 2023. Disponível em: <https://observatoriodatv.com.br/colunas/fabio-augusto/triste-ator-do-castelo-ra-tim-bum-morreu-cedo-demais-em-meio-as-gravacoes-da-serie>. Acesso em: 27 ago. 2024.

O GLOBO. **Líderes religiosos pedem que não sejam feitos mais sermões associando Aids e castigo divino**, 17 ago. 2006. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/lideres-religiosos-pedem-que-nao-sejam-feitos-mais-sermoes-associando-aids-castigo-divino-4565740>. Acesso em: 14 jun. 2024.

O GLOBO. **Pastorais desafiam Igreja e defendem camisinha**, 2008. Disponível em: https://d2a9xce884pp5y.cloudfront.net/PDFs_XMLs_paginas/o_globo/2008/11/03/NAC/GE031108004NAC1-9423_m.jpg. Acesso em: 14 jun. 2024.

O GLOBO. **Contra aids – papa prega a castidade e fidelidade. O Mundo / Ciência e Vida**. jun. 2005. p. 34. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/390887/noticia.htm?sequence=1&isAlloved=y>. Acesso em: 30 maio 2024.

O GLOBO. **Médica que colocou agulhas com HIV no muro de casa para evitar assaltos pode ser punida**. 2011. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/df-medica-que-colocou-agulhas-com-hiv-no-muro-de-casa-para-evitar-assaltos-pode-ser-punida-2687387>. Acesso em: 30 nov. 2024.

OKIHIRO, G. Y. **Margens e centros**: asiáticos na história e cultura americana. São Paulo: Summus Editorial, 1994.

OLIVEIRA, D.; REZENDE SALES, S. Contestações às normas do uso do preservativo no currículo bareback: produção da posição de sujeito unrubberman. **Perspectiva**, [S. l.], v. 40, n. 1, 2022. DOI: 10.5007/2175-795X.2022.e85646. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/85646>. Acesso em: 20 dez. 2025.

ORCASITA, L. T.; SEVILLA, T. M.; ACEVEDO-VELASCO, V. E.; MONTENEGRO, J. L.; TAMAYO, M. C.; RUEDA-TORO, J. S. Family social support for the wellbeing of their gay and lesbian children. **Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud**, [S. l.], v. 18, n. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.11600/1692715X.18205>.

PARKER, R. G. *et al.* Políticas de HIV/Aids, ativismo e antropologia: conversando com Richard Parker. **Saúde em Debate** [online], [S. l.], v. 46, n. spe7, pp. 277-289, 2022. Disponível em: <https://scielosp.org/article/sdeb/2022.v46nspe7/277-289/> Acesso 18 Fevereiro 2025.

PASQUALOTTO, B. S. A construção da identidade parda como estratégia de invisibilização racial no Brasil. **Le Monde Diplomatique Brasil**, 17 jul. 2025. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-construcao-da-identidade-parda-como-estrategia-de-invisibilizacao-racial-no-brasil/> Acesso em: 23 abr. 2026.

PROBST, M.; KRAEMER, C. Gênero, afetividade e sexualidade: o que dizem os adolescentes das escolas públicas do Vale do Itajaí (SC) sobre isso? **Revista Práxis**, [S. l.], v. 1, p. 156–172, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25112/rpr.v1i0.1962>.

PANCIERA, M. J. J. **Aristóteles sobre a memória e a anamnese e seus movimentos**. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Programa de Pós-graduação em Filosofia, Santa Maria, RS, 2023.

PAIVA, V.; ANTUNES, M. C.; SANCHEZ, M. N. O direito à prevenção da Aids em tempos de retrocesso: religiosidade e sexualidade na escola. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, [S.l.], v. 24, p. e180625, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/SbJ4wW39xzdCHT5gnDnwxCg/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 3 set. 2025.

PAVINATI, G.; LIMA, L. V.; PAIANO, M.; JAQUES, A. E.; MAGNABOSCO, G. T. Contextos de vulnerabilidade de adolescentes que (con)vivem com HIV: uma revisão integrativa. **Revista Cuidarte**, [S.l.], v. 14, n. 2, 2023. Disponível em: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/2803>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PARAÍSO, M. A. Currículo e formação profissional em lazer. In: ISAYAMA, H. F. (Org.). **Lazer em estudo: currículo e formação profissional**. Campinas: Papirus, 2010. p. 27-58.

PARAÍSO, M. A. O currículo entre o que fizeram e o que queremos fazer de nós mesmos: efeitos das disputas entre conhecimentos e opiniões. **Revista e-Curriculum**, [S.l.], v. 17, n. 4, p. 1414–1435, 2019. DOI: 10.23925/1809-3876.2019v17i4p1414-1435. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/45925>. Acesso em: 20 dez. 2025.

PARAÍSO, M. A. Currículo, etnia e poder: o silêncio que discrimina. **Revista Temporis[ação]**, [S.l.], v. 1, n. 4, p. 9–30, 2018. DOI: 10.31668/rta.v1i4.8607. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao/article/view/8607>. Acesso em: 20 dez. 2025.

PENA, R. F. A. Os muros que dividem o mundo. **Brasil Escola**. [2025]. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-muros-que-dividem-mundo.htm>. Acesso em: 14 fev. 2025.

PETERS, M. **Pós-estruturalismo e filosofia da diferença: uma introdução**. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

PEIXOTO, A. **Elementos de higiene**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1913.

PERLONGUER, N. O. **O negócio do michê: prostituição viril em São Paulo**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

PINTO, T.; TELLES, I. S. (orgs.). **Aids e escola: reflexões e propostas do EDUCAIDS**. 2. ed. São Paulo: Cortez; Pernambuco: UNICEF, 2000.

PINHEIRO, V. M. S. dos. História recente da educação sexual na escola e da sexualidade no contexto da realidade brasileira. **Brazilian Journal of Sexually Transmitted Diseases**, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 4–8, 1997. Disponível em: <https://www.bjstd.org/revista/article/view/166>. Acesso em: 3 set. 2025.

POLIZZI, V. **Depois daquela viagem**. 18. ed. São Paulo: Ática, 2002.

POWER, J.; KAUER, S.; FISHER, C.; BOURNE, A. Acceptance and use of condoms among school-aged young people in Australia. **Sex Health**, [S.l.], v. 21, mar. 2024. DOI: 10.1071/SH23173.

PUTTI, A. Pastora Ana Paula Valadão diz que Aids é consequência do pecado dos LGBTs. **Carta Capital**, São Paulo, 12 set. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/diversidade/pastora-ana-paula-valadao-diz-que-aids-e-consequencia-do-pecado-dos-lgbts/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

PRIMROSE, S. B. **The Origins of HIV and the AIDS Pandemic**. Microbiology of Infectious Disease: Integrating Genomics with Natural History. Oxford: Oxford Academi, 2022. Disponível em: <https://academic.oup.com/book/41903/chapterabstract/354760715?redirectedFrom=fulltext>. Acesso em: 5 nov. 2024.

PROJETO AFRO. **Encruzilhadas da Arte Afro-brasileira**. 2020. Disponível em: <https://projetoafro.com/artista/micaela-cyrino/>. Acesso em: 22 nov. 2024.

PROJETO DIVERSIDADE SEXUAL, SAÚDE E DIREITOS ENTRE JOVENS. [2020?]. Disponível em: <http://hshjovem.abiaids.org.br/o-projeto>. Acesso em: 26 maio 2023.

PRIORI, M. D. **Histórias íntimas**: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2011.

QAZI, M. H.; JAVID, C. Z. Educational parlance of equity and inclusivity and students' gendered national identity constructions in public schools in Islamabad, Pakistan. **International Journal of Inclusive Education**, [S.l.], v. 27, n. 12, p. 1319–1335, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1889051>. Acesso em: 13 abr. 2025.

QIN, S.; QIN, J.; SU, Q.; HUANG, T.; ZHAN, J.; YANG, X.; YANG, Y.; HE, J.; LIN, Z.; HUANG, X.; YE, L.; LIANG, H.; TANG, H.; CEN, P.; LIANG, B. HIV knowledge, sexual attitudes, and PrEP-eligible behaviors among college students in Southwest China: a cross-sectional study. **BMC Infectious Diseases**, [S.l.], v. 24, n. 1, 827, 2024. DOI: 10.1186/s12879-024-09657-7.

RATNAWATI, D.; HUDA, M. H.; MUKMININ, M. A.; WIDYATUTI, W.; SETIAWAN, A. Meta-analysis of the effectiveness of educational programs about HIV prevention on knowledge, attitude, and behavior among adolescents. **Narra Journal**, [S.l.], v. 4, n. 2, e870, 2024. DOI: 10.52225/narra.v4i2.870.

REALI, G.; ANTISERI, D. **História da filosofia pagã antiga**. São Paulo: Paulus, 2003. v.1.

REIS, R. S.; SANTOS, D. F. Políticas e relevância científica da pesquisa. **Ensino e Tecnologia**, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 692-704, maio/ago. 2023a. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/etr/article/view/16863>. Acesso em: 3 dez. 2024.

REIS, R. S.; SANTOS, D. A. N. Desfazendo mitos sobre sexualidade e pessoas com deficiências: uma experiência formativa. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [S.l.], v. 14, n. 42, p. 105–124, 2023b. DOI: 10.5281/zenodo.8010862. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/1464>. Acesso em: 18 dez. 2025.

REIS, R. S. **Pessoas de sexualidades e identidade de gênero desviantes no CEEJA**: um olhar para a escola de ensino regular frente às experiências de homofobias. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, 2020.

REIS, R. S.; SANTOS, D. A. N. Pensamento decolonial e HIV-AIDS: reflexões para pensar territórios sustentáveis e saudáveis no SUS. **Revista Eletrônica de Educação**, [S.l.], v. 18, n. 1, p. e65901895, 2024. DOI: 10.14244/reveduc.v18i1.6590. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/6590>. Acesso em: 20 dez. 2025.

REIS, C.; PARAÍSO, M. A. **A constituição de corpos guerreiros em um currículo escolar**. **Educação & Realidade**, [S.l.], v. 38, n. 4, p. 1243–1266, out. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/4JBdpHXxSNtm9VZtmKqZvSd/?lang=pt>. Acesso em: 2 dez. 2025.

REDE MANCHETE. Momento Manchete: Especial – ‘Corpo Santo’. **Você Viu A Novela Ontem?** 1999-2024. Disponível em: <https://manchete.org/corpo-santo/videos/#submenu-1>. Acesso em: 27 ago. 2024.

REVEL, J. **Foucault**: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005.

RIBEIRO, D. **O que é lugar de fala?** Belo Horizonte, MG: Letramento: Justificando, 2017.

RINGISAI, L.; SUTININGSIH, D. Assessing the impact of teachers' training on teaching HIV/AIDS education in schools in KwaZulu-Natal, South Africa. **E3S Web Conf.**, [S.l.], v. 448, 05024, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344805024>.

RODRIGUES, K. **Lições do combate à Aids deveria ser usadas para enfrentar a Covid**. 3 dez. 2020. Disponível em: <https://coc.fiocruz.br/todas-as-noticias/licoes-do-combate-a-aids-deveriam-ser-usadas-para-enfrentar-a-covid/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

RODRIGUES J., A. L.; CASTILHO, E. A. A epidemia de AIDS no Brasil, 1991-2000: descrição espaço-temporal. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, [S.l.], v. 37, n. 4, p. 312–317, jul. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/67XPvbNsmq8zqK8RTkhzDtv/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 4 nov. 2025.

RODRIGUES, E. G. B.; FALCÃO, C. Família de Deus, valores neoliberais: Damares Alves e a depuração de direitos. **Revista Relegens Thréskeia**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 54–77, 2021. DOI: 10.5380/rt.v10i2.82436. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/relegens/article/view/82436>. Acesso em: 29 nov. 2025.

ROSEMBERG, F. Educação sexual na escola. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 53, p. 11–19, 1985. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/1372>. Acesso em: 17 dez. 2025.

RUA, M. G.; ABRAMOVAY, M. **Avaliação das ações de prevenção de DST/AIDS e uso indevido de drogas nas escolas de ensino fundamental e médio em capitais brasileiras**. Brasília: UNESCO, 2001. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125251_por/PDF/125251por.pdf.multi. Acesso em: 5 dez. 2024.

RUSSO, R. **A Via Láctea, Legião Urbana**. São Paulo: EMI Music Brasil Ltda, 1996.

RUSSELL, S. T.; BISHOP, M. D.; SABA, V. C.; JAMES, I.; IOVERNO, S. Promoting School Safety for LGBTQ and All Students. **Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences**, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 160–166, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/23727322211031938>.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. Campinas, SP: Autores Associados, 2008a.

SAVIANI, D. Desafios da construção de um sistema nacional articulado de educação. **Trabalho, Educação e Saúde**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 213–232, jul. 2008b. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462008000200002>.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 6. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2021.

SÃO PAULO (Estado). **Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Projetos Comunidade Presente e Prevenção Também se Ensina**: sugestões de atividades preventivas para HTPC e sala de aula. São Paulo: FDE, Diretoria de Projetos Especiais, 2012. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/convivasp/wp-content/uploads/2024/08/manual-prevencao-tambem-se-ensina-comunidade-presente.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2024.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. EFAPE. **Currículo Paulista**. São Paulo: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2020. Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/>. Acesso em: 23 abr. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 18.061, de 18 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a política de prevenção das IST/HIV/AIDS com jovens e adolescentes. **Diário Oficial do Estado de São Paulo**, São Paulo, 19 dez. 2024. p. 1. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2024/lei-18061-18.12.2024.html>. Acesso em: 13 set. 2025.

SEFFNER, F. S. C. G.; MAKSUD, I.; GARCIA, J.; RIOS, L. F.; NATIVIDADE, M.; BORGES, P. R.; PARKER, R.; TERTO, V. Respostas religiosas à AIDS no Brasil: impressões de pesquisa. **Urbanitas**, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 159–180, 2008. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2859840/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SENADO FEDERAL. **AIDS chegou ao Brasil há 40 anos e trouxe terror, preconceito e desinformação**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/aids-chegou-ao-brasil-ha-40-anos-e-trouxe-terror-preconceito-e-desinformacao>. Acesso em: 3 maio 2024.

SEYTRE, B. Costa do Marfim: livros didáticos desinformados sobre o HIV. **Boletim da Sociedade de Patologia Exótica**, [S.l.], v. 112, n. 2, p. 90–95, 2019. DOI: 10.3166/bspe-2019-0086.

SESSÃO DE TERAPIA. **Sessão de Terapia**. 2012. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/sessao-de-terapia/t/tKTBtZdtv/>. Acesso em: 20 dez. 2025.

SILVA, T. T. **Teoria cultural e educação**: um vocabulário crítico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SILVA, T. T. **A produção da identidade e da diferença**. In: SILVA, T. T. **Identidade e diferença**. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

SIQUEIRA, C. **Transmitir HIV deliberadamente poderá virar crime hediondo**. Agência Câmara de Notícias, 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/456869-transmitir-hiv-deliberadamente-podera- virar-crime-hediondo/#:~:text=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20analisa,doen%C3%A7a%20para%20terceiros%E2%80%9D%2C%20disse.&text=A%20proposta%20est%C3%A1%20sendo%20analisada,Depois%20ser%C3%A1%20votada%20pelo%20Plen%C3%A1rio.&text=A%20reprodu%C3%A7%C3%A3o%20das%20not%C3%ADcias%20%C3%A9,assinatura%20'Aq%C3%A2ncia%20C%C3%A2mara%20Not%C3%ADcias'>. Acesso em: 15 set. 2025.

SILVA, G. P. S. A. *et al.* Tracing the relationship among HIV-1 sub-subtype F1 strains: a phylodynamic perspective. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, [S.l.], v. 117, 220109, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mioc/a/QHFFR4XSJW8mybzDPz8Fmbt/?lang=en#>. Acesso em: 6 nov. 2024.

SILVA, O. V. Aspectos da história dos currículos oficiais do Estado de São Paulo (1980-2008). In: ANAIS DO XXIX SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH. 29., 2017. Brasília. **Anais [...]**, Brasília, 2017. Disponível em: https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502838058_ARQUIVO_2017ODAIRAN_PUHtextocompletov3.pdf. Acesso em: 17 set. 2025.

SILVA, J. R. L.; CAETANO, M. R. V.; SOUSA, N. S. “Na minha família não”: culturas e investimentos em família, homossexualidade e cishéteropatriarcado. **Revista Interculturalidad, inclusión y equidad en educación**, [S.l.], p. 69–77, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14201/0AQ03216977>. Acesso em: 27 nov. 2025.

SILVA, R. A.; SOARES, R. Juventude, escola e mídia. In: LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (orgs.). **Corpo, gênero e sexualidade**: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

SIMÕES, R. Estudo inclui dados de 98 cidades do país: escolas não sabem lidar com AIDS. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 13 jun. 1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff130623.htm>. Acesso em: 18 dez. 2024.

SIMÕES DE MIRANDA, J. A.; FIGUEIREDO, D. C. de. HIV e AIDS na literatura: uma análise do discurso de personagens do romance O tribunal da quinta-feira. **Linguagem em (Dis)curso**, [S.l.], v. 24, p. 1-18, 2024. e-1982-4017-24-08. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-4017-24-08>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ld/a/pxG5FrFqpVsw9MQKBz5qdWD/>. Acesso em: 13 mar. 2025.

SOUZA, C. **Da responsabilidade civil e criminal do syphilitico**: publicação da Liga Paulista de Prophylaxia Moral e Sanitária. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1909.

SOUZA, J. Resolvido o problema da AIDS. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 20 set. 1995. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/9/20/opinioao/6.html>. Acesso em: 18 ago. 2024.

SOUZA, R. F. Política curricular no Estado de São Paulo nos anos 1980 e 1990. **Cadernos de Pesquisa**, [S.l.], v. 36, n. 127, p. 203–221, jan. 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742006000100009>. Acesso em: 15 set. 2025.

SOARES, R. Fica comigo gay – o que um programa de TV ensina sobre sexualidade juvenil? In: LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (orgs.). **Corpo, gênero e sexualidade**: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

SOARES, M. C. S. *et al.* Diferença, identidade e ficção: tecer currículos em redes, narrar os cotidianos e inventar o presente. **Currículo sem Fronteiras**, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 163–177, 2016. Disponível em: <https://www.curriculosemfronteiras.org/vol15iss3articles/soares-silva.htm>. Acesso em: 10 dez. 2025.

SUTANTO, L. Psychoanalytic listening: between unconscious and conscious. **Jurnal Psikiatri Surabaya**, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 13–19, 2021. Disponível em: <https://e-journal.unair.ac.id/JPS/article/view/23429>. Acesso em: 8 nov. 2023.

SUPORTE APPLE. **Documentação**. 2024. Disponível em: <https://support.apple.com/pt-pt/111828>. Acesso em: 6 jan. 2025.

SHILTS, R. **And the band played on**: politics, people, and the aids epidemic. Nova York: St. Martin's Griffin, 1987.

SCOCUGLIA, A. C. Origens e prospectiva do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. **Educação e Pesquisa**, [S.l.], v. 25, n. 2, p. 25–37, jul. 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/TqdXqkcGMYXqG3xDdgRtmwv/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 28 out. 2025.

SCHIEBER, E.; DEVEAUX, L.; COTRELL, L.; LI, X.; LEMON, S. C.; ASH, A. S.; MACDONELL, K.; GHOSH, S.; POITIER, M.; ROLLE, G.; NAAR, S.; WANG, B. Maintaining program fidelity in a changing world: national implementation of a school-

based HIV prevention program. **Prevention Science**, [S.l.], 25, n. 3, p. 436–447, 2024. DOI: 10.1007/s11121-023-01614-1.

SCHLÜNZEN, E. T. M.; SANTOS, D. A. N. **Práticas pedagógicas do professor: abordagem construcionista, contextualizada e significativa para uma educação inclusiva**. 1. ed. Curitiba: Appris, 2016.

SHARMA, B. B. *et al.* Compreendendo os papéis interligados da cultura, da desinformação e dos sistemas socioecológicos no estigma e no enfrentamento do HIV. **Global Social Welfare**, [S.l.], 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40609-024-00362-6>.

TANAKA, E. D. O. **O desenvolvimento de uma escala de atitudes sociais em relação ao trabalho da pessoa com deficiência**. 2007. 187 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Marília, SP, 2007.

TANOAMCHARD, W. Understanding mixed methods research: busting common myths and misconceptions. **Journal of Mixed Method Studies**, [S.l.], v. 7, p. 28–41, 2023. Disponível em: <https://www.jomesonline.com/index.php/jomes>. Acesso em: 20 dez. 2024.

TRASPADINI, R. **A torturante função da educação na década de 1970**. 2019. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-torturante-funcao-da-educacao-na-decada-de-1970/>. Acesso em: 29 out. 2025.

TEODORO, C. HIV: eles receberam um laudo de morte. **Folha Universal**, 2 jan. 2022. Disponível em: <https://www.universal.org/noticias/post/hiv-eles-receberam-um-laudo-de-morte/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

TIEMI, R. Relatório da ONU aponta que pandemia da AIDS pode acabar até 2030. **Jornal da USP**, 4 ago. 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/relatorio-da-onu-aponta-que-pandemia-da-aids-pode-acabar-ate-2030/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

TRANSKRIPTOR. **Voz para texto instantâneo**. 2020. Disponível em: <https://transkriptor.com/pt-br/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

TREVISAN, J. S. **Devassos do paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade**. Rio de Janeiro: Record, 2007.

TSAI, Y. T.; PADMALATHA, S.; KU, H. C.; WU, Y. L.; YU, T.; CHEN, M. H.; KO, N. Y. Suicidality among people living with HIV from 2010 to 2021: a systematic review and a meta-regression. **Psychosomatic Medicine**, [S.l.], v. 84, n. 8, p. 924–939, 1 out. 2022. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001127.

UNFPA. United Nations Population Fund. **Comprehensive sexuality education**. 2025. Disponível em: <https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education>. Acesso em: 10 abr. 2025.

UNAIDS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. **Dia de zero discriminação**. [202?]. Disponível em: <https://unaid.org.br/zero-discriminacao/>. Acesso em: 15 jun. 2023.

UNAIDS Brasil. **Sobre o UNAIDS**. [202?]. Disponível em: <https://unaid.org.br/sobre-o-unaid/>. Acesso em: 25 maio 2023.

UNAIDS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. **Guia de terminologia da UNAIDS**. 2017. Disponível em: <https://unaid.org.br/terminologia/>. Acesso em: 13 jan. 2025.

UNAIDS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. **Fact Sheet 2024**. 2024. Disponível em: https://www.unaid.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf. Acesso em: 14 fev. 2025.

UNAIDS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. **Índice de estigma**. 2025. Disponível em: <https://unaid.org.br/indice-estigma/>. Acesso em: 10 out. 2025.

UNAIDS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. **Global AIDS update 2024**. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2024. Disponível em: <https://www.unaid.org/en/resources/documents/2024/global-aids-update-2024>. Acesso em: 10 abr. 2025.

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM. [199?]. **A forgotten suitcase**: the Mantello rescue mission. Collections highlights. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/classification-system-in-nazi-concentration-camps>. Acesso em: 15 fev. 2025.

UNIVERSIDADE ABERTA. **DIGENDER2Palop**: trabalhar as competências digitais na escola para promover a igualdade de gênero em países lusófonos africanos. Projeto de investigação. 2024-2025. Disponível em: <https://lead.uab.pt/digender2palop/>. Acesso em: 10 dez. 2025.

VARANDA, S. S. *et al.* O processo de validação de instrumentos em uma pesquisa qualitativa em Educação Física. **Revista Motrivivência**, Florianópolis, v. 31, n. 57, p. 1-15, jan./mar. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2019e53877>. Acesso em: 20 fev. 2024.

VEIGA-NETO, A. **Foucault & a Educação**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

VEIGA-NETO, A. Michel Foucault e educação: há algo de novo sob o sol? *In*: VEIGA-NETO, A. (org.). **Crítica pós-estruturalista e educação**. Porto Alegre: Sulina, 1995.

VEIGA-NETO, A. Olhares... *In*: COSTA, Marisa Vorraber (org.). **Caminhos investigativos I**: novos olhares para a pesquisa em educação. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

VEYNE, P. **Foucault: o pensamento e pessoa**. Lisboa: Pilares, 2008.

VILLARREAL-PUGA, J.; CID GARCÍA, M. La aplicación de entrevistas semiestructuradas en distintas modalidades durante el contexto de la pandemia. **Revista Científica Hallazgos** 21, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 52-60, 2022. Disponível em: <http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/>. Acesso em: 24 out. 2023.

VIGOYA, M. V. La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. **Debate Feminista**, [S.l.], v. 52, p. 1-17, out. 2016. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603>. Acesso em: 21 jul. 2023.

VICENTE, L. da S. A Educação sexual nas diferentes versões da Base Nacional Comum Curricular: da abertura ao silenciamento em torno da temática. **Educação em Revista**, [S.l.], v. 40, e45439, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469845439>.

VIEIRA, C. V. **Eu faço sexo amoroso**. Lisboa: Editorial Bizâncio, 2012.

VIEIRA, C.; SILVA, L.; MOURA, M.; PINTO, S. **Comportamentos de risco em mulheres portuguesas**. 2003. Disponível em: <http://aidscongress.net/pdf/180.pdf>.

ZUCCHI, E. M.; BARROS, C. R. dos S.; PAIVA, V. S. F.; FRANÇA JUNIOR, I. Estigma e discriminação vividos na escola por crianças e jovens órfãos por Aids. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 3, p. 719-734, set./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711218>.

WILLIAMS, J. **Pós-estruturalismo**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

WILLIAMS JÚNIOR, R. R. D.; BISHOP, J. M.; HOUSMAN, J. M. Disparities in HIV testing, STI testing, and associated risk factors in high school-aged youth: findings from the youth risk behavior survey. **AIDS Care**, [S.l.], v. 37, n. 4, p. 546–554, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/09540121.2025.2458637>.

WEBER, D. Campanha contra a Aids usará atores soropositivos. **O Globo**, 22 nov. 2006. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/campanha-contra-aids-usara-atores-soropositivos-4546598>. Acesso em: 27 ago. 2024.

WESTIN, R. Por 100 anos, analfabeto foi proibido de votar no Brasil. **Senado Notícias**, 04 nov. 2016. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/04/por-100-anos-analfabeto-foi-proibido-de-votar-no-brasil>. Acesso em: 17 dez. 2025.

WEEKS, J. **Sexuality and its discontents: meanings, myths & modern sexualities**. London and New York: Routledge, 1985.

WEEKS, J. **Sexuality**. 5. ed. Routledge, 2023.

WINKLER, M. Monstro. **Netflix**, 2025.

XAVIER, K. Cartilha ensina a comunicar diagnóstico de HIV a crianças. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 5 out. 2010. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd0510201004.htm>. Acesso em: 19 nov. 2024.

YAZBEK, A. C. **10 lições sobre Foucault**. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

YOUTUBE. Papa Francisco defende abençoar casais gays e maior participação de mulheres na gestão da Igreja. **Youtube**. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1637S1ZGDKg>. Acesso em: 13 jun. 2024.

YOUTUBE. Roda Viva Marta Suplicy. **Youtube**. 1989. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=78NkLXo2gT4>. Acesso em: 22 nov. 2024.

ANEXOS

ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA - UNOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: UMA ANÁLISE QUANTO AO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS SOROPOSITIVAS

Pesquisador: DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 66081422.1.0000.5515

Instituição Proponente: ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC

Patrocinador Principal: ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.002.157

Apresentação do Projeto:

Este projeto de pesquisa de doutorado faz parte do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) na Linha de Pesquisa 01: Políticas Públicas em Educação, processos formativos e diversidade. Busca-se problematizar políticas educacionais e processos formativos, desenvolvidos com base em questões de HIV-AIDS, no âmbito da rede pública estadual de educação de São Paulo e em vivências pessoais de pessoas soropositivas. A hipótese é que um processo de escolarização que inclua as questões de HIV-AIDS possibilita a desconstrução e desnaturalização dos estereótipos erigidos às pessoas soropositivas, tal como relações de exclusão, preconceito, violência e sofrimento social. O objetivo principal é analisar as políticas educacionais do Estado de São Paulo e as percepções quanto à conscientização sobre HIV-AIDS no contexto escolar, além das vivências de pessoas soropositivas, buscando uma cultura de inclusão. A pesquisa tem abordagem qualitativa e será realizada em diferentes etapas: 1) coleta e análise de dados documentais e bibliográficos; 2) aplicação de questionário on-line em redes sociais e sem a necessidade de identificação por parte dos respondentes; 3) entrevistas semiestruturadas com pessoas soropositivas, selecionadas mediante a técnica snowball; 4) grupo focal com professores da rede pública estadual, participantes do Grupo de Pesquisa "Políticas e Práticas de Educação Inclusiva – PPEI" da UNOESTE. A análise será realizada também em etapas, que envolverão desde a análise de conteúdo até a análise estatística. Espera-se contribuir com o campo da pesquisa em educação, fazendo possíveis indicadores de como podem ser abordadas

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 572

Bairro: Bairro Limoeiro

CEP: 19.067-175

UF: SP

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

Telefone: (18)3229-2079

Fax: (18)3229-2080

E-mail: cep@unoeste.br

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE



Continuação do Parecer: 6.002.157

as questões sobre HIV-AIDS no contexto escolar, de forma inclusiva.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Analisar as políticas educacionais do Estado de São Paulo e as percepções quanto à conscientização sobre HIV-AIDS no contexto escolar, além das vivências de pessoas soropositivas, buscando uma cultura de inclusão. **Objetivo Secundário:** 1-) Analisar documentos, diretrizes e produções científicas que embasam as questões sobre HIV-AIDS e pessoas soropositivas no ensino médio, sobretudo do Estado de São Paulo. 2-) Compreender como é abordado o tema HIV-AIDS no contexto escolar. 3-) Compreender a partir de narrativas de pessoas soropositivas, o que aprenderam na escola sobre HIV-AIDS, principalmente o que auxiliou em suas vidas após serem positivadas e terem que estar no convívio social. 4-) Propor possíveis mudanças nos diferentes componentes curriculares sobre o entendimento do tema e seu impacto nas práticas cotidianas em sociedade com relação ao tema HIV-AIDS.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os riscos e benefícios estão parcialmente adequados à pesquisa. Não havendo na Plataforma Brasil uma descrição do risco de quebra de sigilo, mesmo esse sendo mínimo.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os critérios de inclusão e exclusão estão descritos de forma que pareça a metodologia de inclusão. Assim, seria interessante descrever qual o perfil de avaliados que serão incluídos na pesquisa, tanto na terceira, quanto na quarta etapa.

Não há informação sobre como serão divulgados esses resultados para os participantes.

O pesquisador responsável tem amplo conhecimento na área de educação e inclusão.

O tema é de relevante para a sociedade.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

1. Folha de rosto: Adequado.
2. TCLE: Adequar os TCLE, incluindo a forma de retorno aos familiares e o risco de quebra de sigilo, mesmo que mínimo.
3. Termo de assentimento: Adequar termo, incluindo a forma de retorno aos familiares e o risco de quebra de sigilo, mesmo que mínimo.
4. Autorização do responsável pelo local a ser desenvolvida a pesquisa: não se aplica.
5. Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD): não se aplica.

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 572
Bairro: Bairro Limoeiro **CEP:** 19.067-175
UF: SP **Município:** PRESIDENTE PRUDENTE
Telefone: (18)3229-2079 **Fax:** (18)3229-2080 **E-mail:** cep@unoeste.br

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE



Continuação do Parecer: 6.002.157

6. Declaração de Pesquisadores (Termo de compromisso): adequado.
7. Ofício do HR: não se aplica.
8. HRCPP: não se aplica.
9. Termo de anuência institucional (Declaração da Instituição e de Responsabilidade do Custo da Pesquisa): adequado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1. Pendência 1 – Na Plataforma Brasil, no item "Avaliações dos riscos e benefícios", incluir a forma de retorno aos familiares e participantes, e o risco de quebra de sigilo, mesmo que mínimo. Resposta a Pendência 1: A inclusão solicitada pelo parecerista foi realizada nos itens riscos e benefícios, informando o risco de quebra de sigilo mínimo e a forma de retorno aos familiares e participantes. **PENDÊNCIA ATENDIDA.**
2. Pendência 2 – Especificar os critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo: condição, idade, gênero, local de estudo/trabalho, ambiente social, entre outros. Atentando-se que a exclusão não seria somente o oposto da inclusão. Resposta a Pendência 2: Conforme foi solicitado, os critérios de inclusão foram mais bem especificados, assim como foram inseridos os critérios de exclusão. **PENDÊNCIA PARCIALMENTE ATENDIDA** (os critérios de exclusão são simplesmente o oposto dos critérios de inclusão - observação: foram excluídos os estudantes menores de 18 anos, porém há TCLE para os pais menores de 18 anos).
3. Pendência 3 – Atualizar o TCLE e o TALE para o modelo novo disponível na página do CEP/UNOESTE e incluir o formato de divulgação do resultado para os participantes. Resposta a Pendência 3: Os TCLE para maiores e menores de 18 anos foram atualizados e foram incluídas as formas de divulgação do resultado para os participantes. **PENDÊNCIA ATENDIDA.**
4. Pendência 4 – Adequar cronograma para início após a aprovação do projeto pelo CEP/UNOESTE (por exemplo, a partir de março de 2023). Resposta a Pendência 4: O cronograma foi adequado para o início de março de 2023 conforme orientação do parecerista. **PENDÊNCIA ATENDIDA** (observação: a pesquisa iniciou em 01/03)

SEGUNDO PARECER PENDÊNCIA 01: Considerando as pendências ajustadas no projeto revisado, em relação aos critérios de Inclusão e Exclusão, é citado que os participantes da pesquisa serão maiores de idade. Porém, o objetivo aponta a análise com soropositivos no ensino médio e foi apresentado o TCLE para os pais. Indica-se: adaptar os critérios de inclusão e exclusão, e acrescentar o TALE. Ou, deixar claro que somente maiores de idade serão avaliados.

PENDÊNCIA ATENDIDA.

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 572	
Bairro: Bairro Limoeiro	CEP: 19.067-175
UF: SP	Município: PRESIDENTE PRUDENTE
Telefone: (18)3229-2079	Fax: (18)3229-2080 E-mail: cep@unoeste.br

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE



Continuação do Parecer: 6.002.157

Considerações Finais a critério do CEP:

Em reunião realizada no dia 10/04/2023, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (CEP-UNOESTE), concordância com o parecerista, considerou o projeto APROVADO.

Solicitamos que sejam encaminhados ao CEP:

1. Relatórios anuais, sendo o primeiro previsto para 30/04/2024.
2. Comunicar toda e qualquer alteração do Projeto e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Nestas circunstâncias a inclusão de participantes deve ser temporariamente interrompida até a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
3. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer Evento Adverso Grave ocorrido durante o desenvolvimento do estudo.
4. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 (cinco) anos, após conclusão da pesquisa, para possível auditoria dos órgãos competentes.
5. Este projeto está cadastrado na CPDI-UNOESTE sob o número 7846.

Obs.: O PROJETO SÓ PODE SER INICIADO (EXECUTADO) QUANDO RECEBER O PARECER FINAL APROVADO TANTO NO CEP QUANTO NO COMITÊ ASSESSOR INSTITUCIONAL DE PESQUISA (CAPI).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_2065599.pdf	21/03/2023 14:22:03		Aceito
Outros	resposta2.docx	21/03/2023 14:21:51	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tale.doc	21/03/2023 14:18:45	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Recurso Anexado pelo Pesquisador	resposta.docx	09/02/2023 14:11:18	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	tcle2corr.docx	08/02/2023 13:49:53	DANIELLE APARECIDA DO	Aceito

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 572
 Bairro: Bairro Limoeiro CEP: 19.067-175
 UF: SP Município: PRESIDENTE PRUDENTE
 Telefone: (18)3229-2079 Fax: (18)3229-2080 E-mail: cep@unoeste.br

**UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA - UNOESTE**



Continuação do Parecer: 6.002.157

Justificativa de Ausência	tcle2corr.docx	08/02/2023 13:49:53	NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcle18corr.docx	08/02/2023 13:49:38	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Outros	formlabrafa.pdf	14/12/2022 18:14:34	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Folha de Rosto	frafaass.pdf	14/12/2022 18:03:56	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Declaração do Patrocinador	decintrafa.pdf	14/12/2022 18:02:49	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	decinfrara.pdf	14/12/2022 18:01:31	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Declaração de Pesquisadores	decpesqrafa.pdf	13/12/2022 17:08:17	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_FINAL.pdf	13/12/2022 17:06:59	DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PRESIDENTE PRUDENTE, 14 de Abril de 2023

Assinado por:
Crystian Bitencourt Soares de Oliveira
(Coordenador(a))

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 572
Bairro: Bairro Limoeiro **CEP:** 19.067-175
UF: SP **Município:** PRESIDENTE PRUDENTE
Telefone: (18)3229-2079 **Fax:** (18)3229-2080 **E-mail:** cep@unoeste.br

ANEXO B - PLANO DE GESTÃO DE DADOS (PGD)

1. Identificação do projeto

Título da tese: Para além dos muros do preconceito: a produção discursiva sobre pessoas soropositivas no processo de escolarização

Autor: Rafael dos Santos Reis

Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

Orientação: Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos e Co-orientação, Dra. Cristina Pereira Vieira

Área do conhecimento: Educação.

Período de execução da pesquisa: março de 2022 a março de 2026.

2. Descrição geral dos dados

Os dados produzidos nesta pesquisa possuem natureza qualitativa e quantitativa, decorrentes da análise de arquivos documentais, de um banco de questões mistas e de entrevistas semiestruturadas. Esses dados sustentam os três estudos que compõem a tese e constituem a base empírica para as análises desenvolvidas.

3. Metodologia de coleta e produção dos dados

A produção dos dados orienta-se a partir de procedimentos metodológicos previamente organizados e definidos a priori. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme documentação apresentada no Anexo X, assegurando o cumprimento dos princípios éticos e científicos previstos na legislação vigente.

4. Formatos, padrões e organização dos dados

Os dados do primeiro estudo encontram-se em formatos digitais (.pdf) e físicos, incluindo livros, textos e artigos impressos e on-line, acessados por meio de bibliotecas, jornais e sítios eletrônicos. Esses materiais estão organizados em pastas estruturadas por períodos temporais. Os dados produzidos no segundo estudo estão armazenados em formatos .xlsx, .docx e .pdf, além de permanecerem disponíveis na plataforma Google Forms, organizados em pastas no computador pessoal do pesquisador e em ambiente de armazenamento em nuvem. Os dados do terceiro

estudo estão registrados em arquivos de áudio no formato .m4a e em documentos textuais (.docx e .pdf). Esses dados encontram-se organizados em pastas armazenadas tanto em nuvem quanto no disco rígido do computador, com acesso restrito exclusivamente ao pesquisador.

5. Documentação e metadados

A organização da tese em três estudos possibilita a produção sistemática de documentação e metadados. Cada estudo possui uma pasta específica, identificada como primeiro, segundo ou terceiro estudo, contendo os materiais utilizados em cada etapa da pesquisa, incluindo notas metodológicas, versões preliminares e finais dos instrumentos de produção de dados, bem como os dados brutos e os dados tratados utilizados nas análises.

6. Aspectos éticos, legais e de confidencialidade

A pesquisa respeita a legislação vigente, com anonimização dos participantes, uso de TCLE e restrição de acesso aos dados sensíveis.

7. Armazenamento, backup e segurança

O armazenamento dos dados ocorre de acordo com sua natureza, grau de sigilo e princípios éticos. Os dados do primeiro estudo, por não envolverem informações sensíveis, permanecem armazenados no disco rígido interno do computador do pesquisador. Os dados do segundo estudo estão armazenados tanto no disco rígido do computador quanto na plataforma Google Forms, com acesso restrito ao pesquisador e às orientadoras. Os dados do terceiro estudo, por envolverem informações sensíveis, encontram-se armazenados em arquivos de áudio em ambiente de nuvem, com acesso exclusivo ao pesquisador. As transcrições, em formato docx e pdf, são mantidas sem identificação nominal dos participantes e com acesso igualmente restrito. Todos os dados estão protegidos por senha de acesso ao computador. São realizadas cópias de segurança (backup) em ambiente de nuvem, por meio do serviço OneDrive da Microsoft, acessível apenas pelo pesquisador responsável.

8. Compartilhamento e acesso aos dados

Os dados compartilhados serão feitos de forma restrita. Por haver alguns dados sensíveis quanto a questões pessoais das pessoas que participam da pesquisa (terceiro estudo), o compartilhamento dos dados é feito a partir das publicações com os dados tratados, retirando qualquer menção que possa expor as pessoas da pesquisa. Os dados do segundo estudo pode ser acesso pela biblioteca de dados Zotero, pelo link: <https://zenodo.org/records/19241157>

9. Preservação e descarte dos dados

Em vista a nos ampararmos aos entes legais da pesquisa, consideramos a Resolução CNS nº 466/2012. Assim, os dados produzidos nesta pesquisa serão mantidos sob a guarda do pesquisador responsável, no período mínimo de guarda de cinco anos após a conclusão da pesquisa e/ou publicação dos resultados, possibilitando eventuais auditorias éticas ou científicas. Após esse período, os dados identificáveis poderão ser descartados de forma segura, permanecendo apenas dados anonimizados, quando aplicável.

10. Responsabilidades

A gestão dos dados é de responsabilidade do pesquisador, contando com o acompanhamento da orientadora.

11. Considerações finais

O Plano de Gestão de Dados explicita o compromisso ético, responsável e cuidadoso com o tratamento dos dados produzidos nesta tese, assegurando sua organização, segurança, confidencialidade e preservação, em consonância com as normativas éticas e científicas que orientam a pesquisa em Educação.

ANEXO C – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DIRETORIA DE ENSINO

**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Diretoria de Ensino Presidente Prudente**

DESPACHO

Nº do Processo: 015.00320658/2023-61

Interessado: Rafael dos Santos Reis

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PESQUISA - RAFAEL DOS SANTOS REIS

Após análises, autorizo a realização da pesquisa solicitada pelo aluno de Pós Graduação da Unoeste com a devida atenção e conveniência logística da equipe gestora da escola estadual

Pres. Prudente, na data da assinatura digital.

Alice Maria de Aguiar Filgueiras Correa
Dirigente Regional de Ensino Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Alice Maria De Aguiar Filgueiras Correa, Dirigente Substituto**, em 11/10/2023, às 22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9689951** e o código CRC **067C823C**.

APÊNDICES

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2ª ESTUDO - FAMILIARES DOS ESTUDANTES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Título da Pesquisa: “PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: UMA ANÁLISE QUANTO AO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS SOROPOSITIVAS”

Nome do Pesquisador: Rafael dos Santos Reis.

Nome da Orientadora: Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos.

1. Natureza da pesquisa: a/o sra./sr. está sendo convidada/o a autorizar a participação de seu/sua filha/o nesta pesquisa que tem como finalidade analisar as políticas educacionais do Estado de São Paulo e as percepções quanto à conscientização sobre HIV-AIDS no contexto escolar, além das vivências de pessoas soropositivas, buscando uma cultura e política de inclusão e diversidade.

2. Envolvimento na pesquisa: ao permitir a participação de seu/sua filha/o neste estudo a/o sra./sr. permitirá que o pesquisador colete informações através de um banco de perguntas (questionário) com alternativas nos quais ao respondê-las, nos ajudará a saber qual a percepção de estudantes da rede pública do Estado de São Paulo sobre HIV-AIDS e pessoas soropositivas. A/O sra./sr. tem liberdade de recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra. ou sr. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa, que é o órgão que avalia se não há problemas na realização de uma pesquisa com seres humanos.

3. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas não resultando em nenhum risco ou desconforto. Isso devido a tomada de todas as precauções para que não haja exposição da pessoa que participa e suas respostas ao questionário. Destacamos que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 e na Resolução CNS nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012). Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. **4. Confidencialidade:** todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e sua orientadora terão conhecimento das respostas obtidas pelas respostas que sua/seu filha/o responder. Ainda assim, nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.

5. Benefícios: ao participar desta pesquisa sua/seu filha/o colaborará com informações importantes sobre a percepção do que é HIV-AIDS e pessoas soropositivas, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa contribuirá para a educação e as relações entre as pessoas em sociedade. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior.

6. **Pagamento:** a sra./sr. não terá nenhum tipo de despesa para que seu/sua filho/a participe desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que seu/sua filho/a participe desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que seguem. Confiro que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para que meu(minha) filho(a) ou menor do qual sou responsável participe desta pesquisa.

Nome do Participante da Pesquisa

Nome do responsável pelo Participante da Pesquisa

Assinatura do responsável pelo Participante da Pesquisa

Assinatura do Pesquisador

Assinatura do Orientador

Pesquisador: Rafael dos Santos Reis – (18) 99784-7188.

Orientadora: Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos. Email: danielle@unoeste.br
Endereço do orientador: Rua Arthur Boigues Filho, 356 Casa 07 Parque Residencial Carandá.
CEP/UNOESTE - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNOESTE: Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda de Maria Serra/ Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Rita Guimarães Maia.
Endereço do CEP: Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI).
UNOESTE - Campus II - Bloco B2 - 1º andar. Rodovia Raposo Tavares, Km 572 - Bairro Limoeiro-Presidente Prudente, SP, Brasil, CEP 19067-175 - Telefone do CEP: (18) 3229-2079
E-mail: cep@unoeste.br - Horário de atendimento do CEP: das 8h as 12h e das 13h30 as 17h.

O Sistema CEP/Conep tem por objetivo proteger os participantes de pesquisa em seus direitos e contribuir para que as pesquisas com seres humanos sejam realizadas de forma ética.

APÊNDICE B- TERMO DE ASSENTIMENTO 2ª ESTUDO – ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

TERMO DE ASSENTIMENTO

1. Natureza da pesquisa: Você está sendo convidada/o como voluntária/o a participar desta pesquisa, que tem como finalidade analisar as percepções de estudantes sobre HIV-AIDS e de Pessoas Soropositivas, buscando uma cultura e política de inclusão e diversidade.

2. Participantes da pesquisa: As pessoas participantes da pesquisa serão as/os estudantes no ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo.

3. Envolvimento pesquisa: ao participar desta pesquisa, você permitirá que o pesquisador colete informações através de um banco de perguntas (questionário) com alternativas nos quais ao respondê-las, nos ajudará a saber qual a percepção sobre HIV-AIDS e pessoas soropositivas. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa ou esclarecer dúvidas através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa, que é o órgão que avalia se não há problemas na realização de uma pesquisa com seres humanos. Para participar deste estudo, o responsável por você precisa autorizar, assinando um termo de autorização chamado Termo de Consentimento. Você não vai precisar pagar nada para participar e também não receberá nada pela sua participação nesta pesquisa. Você pode fazer qualquer pergunta, se tiver alguma dúvida sobre sua participação, a qualquer hora que será respondida. O responsável por você pode retirar a autorização ou não querer mais sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária, ou seja, você participa se quiser, e o fato de você não querer participar não levará a qualquer castigo ou modificação na forma em que você será atendido. Seu nome será mantido em segredo, ou seja, só os pesquisadores saberão e não irão contar para mais ninguém. Você não será identificado em nenhuma publicação. Sua participação nesta pesquisa não apresenta risco nenhum para você. Não há previsões de possíveis riscos, talvez apenas algum estranhamento quando perguntado sobre questões que não seja familiar a você. Você poderá saber os resultados da pesquisa, se quiser, quando ela acabar. Sobre os benefícios, ao participar desta pesquisa você terá colaborado com o aprimoramento da educação e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Você só participará com a autorização do responsável por você e se você aceitar em participar desta pesquisa. Suas informações utilizadas na pesquisa ficarão guardadas com a pessoa responsável pela pesquisa por cinco anos e depois serão destruídas. Caso aconteça algum dano a sua saúde durante a pesquisa ou depois que finalizar, você tem o direito de ser indenizado pelo responsável por esta pesquisa. Os pesquisadores garantem a você a cobertura de despesas suas ou se seu responsável, como pagamento de custos de alimentação e transporte para participar da pesquisa.

Todas essas informações estão de acordo com a Resolução nº 466/2012 e na Resolução CNS nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Este termo tem duas vias, sendo que uma via será guardada pelos pesquisadores e a outra ficará com você.

ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, __, fui informado(a) dos objetivos desta pesquisa de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei fazer novas perguntas, e o meu responsável poderá mudar a decisão de eu participar se ele quiser. Tendo a autorização do meu responsável já assinada, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma via deste termo e me foi dada a chance de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Pesquisador: Rafael dos Santos Reis – contato – (18) 99784-7188 e-mail: raphael.zaratustra@hmail.com

Orientadora: Dra. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos. e-mail: danielle@unoeste.br

CEP/UNOESTE - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNOESTE: Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda de Maria Serra/ Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Rita Guimarães Maia. Endereço do CEP: Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI). UNOESTE - Campus II - Bloco B2 - 1º andar. Rodovia Raposo Tavares, Km 572 - Bairro Limoeiro-Presidente Prudente, SP, Brasil, CEP 19067-175 - Telefone do CEP: (18) 3229-2079 E-mail: cep@unoeste.br - Horário de atendimento do CEP: das 8h as 12h e das 13h30 as 17h. O Sistema CEP/Conep tem por objetivo proteger os participantes de pesquisa em seus direitos e contribuir para que as pesquisas com seres humanos sejam realizadas de forma ética.

Aceito ()

Não aceito ()

APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DOS DADOS DO SEGUNDO ESTUDO

Qual das seguintes opções melhor representa sua identidade e/ou expressão de gênero:

*

Homem trans

Homem cis

Mulher trans

Mulher cis

Travesti

Pessoa não-binária

Não sei dizer

Outro. Se esta for tua opção, responda com tuas palavras qual é sua identidade e/ou expressão de gênero na próxima questão.

Se nenhuma das alternativas da questão anterior corresponde a sua identidade e/ou expressão de gênero, descreva com suas palavras aqui:

Qual das seguintes opções melhor representa sua orientação sexual e/ou afetiva:

*

☐

Assexual

☐

Bissexual

☐

Gay

☐

Heterossexual

☐

Lésbica

☐

Pansexual

☐

Queer

☐

Não sei dizer

☐

Outro. Se esta for tua opção, responda com tuas palavras qual é sua orientação sexual e/ou afetiva na próxima questão.

Se nenhuma das alternativas da questão anterior corresponde a sua orientação sexual e/ou afetiva, descreva com suas palavras aqui:

Você é uma pessoa de etnia/raça:

*

☐

Preta

☐

Parda

☐

Indígena

☐

Amarela

☐

Branca

☐

Outro. Se esta for tua opção, responda com tuas palavras qual é sua etnia/raça na próxima questão.

Se nenhuma das alternativas da questão anterior corresponde a sua etnia/raça, descreva com suas palavras aqui:

Qual sua idade? (Por favor responder em números)

*

Avalie as afirmações a seguir e indique o seu nível de concordância utilizando a seguinte escala: DISCORDO; NÃO SEI DIZER SOBRE; CONCORDO;

O HIV e a AIDS não são as mesmas coisas.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

O HIV é o vírus e a AIDS é a evolução do vírus, desencadeando a síndrome e então acarretando a morte quando não tratada.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

HIV é transmitido pelo suor, saliva, aperto de mão, compartilhamento de talheres e roupa de banho.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Não existe tratamento para o HIV.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Se uma pessoa ao descobrir que está com HIV começar a tomar seus medicamentos, em alguns meses, ela não transmite o vírus do HIV a outras pessoas.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

As pessoas que morreram em decorrência da AIDS, foram castigadas por não seguirem os princípios religiosos que direcionam para os bons costumes para a vida.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Pessoas que vivem com HIV devem ter garantido seus direitos enquanto cidadãos.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Pessoas que vivem com HIV ao estar em tratamento, podem ter filhos como qualquer outra pessoa

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

A escola disponibiliza preservativos aos estudantes, professores/as, gestores/as e demais funcionários/as.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Na minha escola, há informativos para conscientizar sobre a importância da prevenção e sexo seguro.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Na minha escola, há momentos de campanha e/ou palestras, sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Nas aulas, são tratados temas que falam de sexualidade em relação ao HIV, AIDS e pessoas com HIV.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Quando se fala de pessoas que vivem com HIV, o tema é abordado abertamente, sem qualquer medo.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Se na sua escola, existir um/uma estudante que vive com HIV, acha que será bem tratado/acolhido/?

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Se em algum momento de sua vida, descobrir que tem HIV, seria tranquilo lidar com a questão, por saber que existe tratamento e que pode ter uma vida comum como as demais pessoas.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Quando eu tenho alguma relação sexual, uso alguma proteção pela consciência de vivenciar minha sexualidade de forma segura e saudável.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Não acredito que ter relação sexual desprotegida pode me trazer algum problema sexual.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre
☐ Concordo

Se você já teve alguma relação sexual, responda se realizou ao menos uma vez ao ano o teste para saber sobre alguma IST (infecções sexualmente transmissíveis).

- ☐ Não
☐ Sim
☐ Às vezes

A escola não deve ser um espaço que fale sobre HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.

*

- ☐ Discordo
☐ Não sei dizer sobre

☐ Concordo

Existe uma falta de informação na escola sobre sexualidade, HIV, AIDS e pessoas que vivem com HIV.

*

☐ Discordo

☐ Não sei dizer sobre

☐ Concordo

Agradecemos por sua colaboração!
FIM

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 3ª ESTUDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: “PARA ALÉM DOS MUROS DO PRECONCEITO: UMA ANÁLISE QUANTO AO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS SOROPositivas”

Nome do Pesquisador: Rafael dos santos Reis.

Nome da Orientadora: Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos.

1. Natureza da pesquisa: a/o sra./sr. está sendo convidada/o a participar desta pesquisa que tem como finalidade analisar as políticas educacionais do Estado de São Paulo e as percepções de docentes quanto à conscientização sobre HIV-AIDS no contexto escolar, além das vivências de pessoas soropositivas, buscando uma cultura e política de inclusão e diversidade.

2. Participantes da pesquisa: serão 5 pessoas que vivem com HIV que passaram pelo processo de escolarização.

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a/o sra./sr. permitirá que o pesquisador colete informações através de entrevistas semiestruturadas nas quais ao respondê-las, nos ajudará a saber se a trajetória escolar colaborou ou não com as questões de HIV-AIDS e a vivência enquanto pessoas que vivem soropositivas. A/O sra./sr. tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a/o sra./sr. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa ou esclarecer dúvidas através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa, que é o órgão que avalia se não há problemas na realização de uma pesquisa com seres humanos.

4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas não resultando em nenhum risco ou desconforto. Isso devido a tomada de todas as precauções para que não haja exposição da pessoa que participa e suas respostas ao questionário. Destacamos que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 e na Resolução CNS nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. **5. Confidencialidade:** todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e sua orientadora terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa. Ressaltamos que além da entrevista realizada, pedimos a autorização para gravarmos tanto em formato de áudio quanto de vídeo. O áudio é para descrição das falas e produção de dados e a imagem para a produção de um vídeo no qual passará por um tratamento na edição que a imagem e a voz não poderão ser identificadas.

6. Benefícios: ao participar desta pesquisa a/o sra. sr. terá colaborado com informações importantes sobre a percepção do que é HIV-AIDS e pessoas soropositivas, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa contribuirá para a melhora na educação e as relações entre as pessoas em sociedade. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior.

7. Pagamento: a/o sra./sr. não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. Confiro que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _____, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Pesquisador

Assinatura do Orientador

Pesquisador: Rafael dos Santos Reis – contato (18) 99784-7188.

Orientadora: Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos. Email da orientadora: danielle@unoeste.br. Endereço da orientadora: Rua Arthur Boigues Filho, 356 Casa 07 Parque Residencial Carandá.

CEP/UNOESTE - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNOESTE: Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda de Maria Serra/ Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Rita Guimarães Maia. Endereço do CEP: Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI). UNOESTE - Campus II - Bloco B2 - 1º andar. Rodovia Raposo Tavares, Km 572 - Bairro Limoeiro-Presidente Prudente, SP, Brasil, CEP 19067-175 - Telefone do CEP: (18) 3229-2079 E-mail: cep@unoeste.br - Horário de atendimento do CEP: das 8h as 12h e das 13h30 as 17h.

O Sistema CEP/Conep tem por objetivo proteger os participantes de pesquisa em seus direitos e contribuir para que as pesquisas com seres humanos sejam realizadas de forma ética.